

**RECONSTRUCCIONES
Y PAUTAS
EUNACOM
2013 - 2023**

PRIMERA PARTE

1) Paciente de 53 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento con enalapril, consulta por disnea de medianos esfuerzos asociado a palpitaciones intermitentes desde hace un mes. Al examen físico destaca ritmo irregular asociado a aumento de R1. El diagnóstico más probable es:

- a) Flutter auricular
- b) Taquicardia ventricular
- c) Taquicardia paroxística supraentricular
- d) Fibrilación auricular
- e) Enfermedad del nodo sinusal

2) Una paciente de 65 años, diabética tipo 2 en tratamiento con metformina, consulta por cuadro de dolor en fosa iliaca izquierda, asociado a fiebre y hematoquezia en una oportunidad. Al examen físico destaca Blumberg (+) en fosa iliaca izquierda y disminución de ruidos hidroaéreos. El examen de elección para establecer el diagnóstico en este caso es:

- a) Tomografía axial computada de abdomen
- b) Colonoscopia
- c) Ecotomografía abdominal
- d) Radiografía de abdomen
- e) Resonancia magnética de abdomen

3) Paciente de 65 años, diabético en tratamiento con esquema intensificado de insulina, actualmente hospitalizado por cuadro de edema generalizado en estudio, presenta dolor torácico de inicio súbito, asociado a diaforesis. Al examen físico destaca saturación de 89% con FiO2 ambiental, murmullo pulmonar con crepitaciones difusas bilaterales. En sus exámenes de laboratorio destaca proteinuria de 24 horas de 5gramos, albúmina de 2g/dL y perfil lipídico con triglicéridos de 450 mg/dL. La causa más probable de su dolor torácico es:

- a) Neumonía aguda
- b) Tromboembolismo pulmonar
- c) Infarto agudo al miocardio
- d) Pericarditis aguda
- e) Disección aórtica

4) Una paciente de 60 años, es diagnosticada de cistoadenocarcinoma seroso de ovario el cual presenta diseminación difusa en peritoneo, por lo cual no es operable. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Cuidados paliativos
- b) Radioterapia
- c) Hormonoterapia
- d) Quimioterapia
- e) Inmunoterapia

5) Se desea evaluar la efectividad de un nuevo antihipertensivo de la familia de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, para esto, ¿Qué tipo de estudio escogería?

- a) Caso control
- b) Meta-análisis
- c) Cohorte
- d) Corte transversal
- e) Estudio clínico randomizado

6) Una lactante de 2 meses con cuadro de dolor abdominal y vómitos desde hace semanas que en las últimas horas ha empeorado asociándose fiebre, taquipnea y compromiso de conciencia. Al su ingreso destaca PA: 40/20, FC 130x', examen pulmonar con crépitos difusos. Se solicitan exámenes de laboratorio donde destaca creatinina 0.9, glicemia 40, Na+ 132, K+ 5.7, hemograma con leucocitosis. Se inicia Ceftriaxona y aporte de suero fisiológico en bolo sin respuesta luego de una hora. El fármaco de elección para el manejo de esta paciente es:

- a) Vancomicina
- b) Noradrenalina
- c) Hidrocortisona
- d) Vasopresina
- e) Dopamina

7) Una paciente de 30 años, con embarazo de 35 semanas controlado, consulta al servicio de urgencias por metrorragia escasa asociada a dolor abdominal. Al examen físico destaca aumento marcado del tono uterino de forma permanente y frecuencia cardíaca fetal de 110 por minuto. El diagnóstico más probable es:

- a) Placenta previa
- b) Rotura uterina
- c) Rotura de vasa previa
- d) Síntomas de parto prematuro
- e) Desprendimiento de placenta

8) Un paciente de 50 años, diabético en tratamiento con metformina, consulta por poliaquiuria, nicturia, latencia y debilidad del chorro miccional desde hace meses, no asociado a otros síntomas. Su tacto rectal muestra próstata aumentada de tamaño de consistencia gomosa. Con respecto a este caso, ¿Cuál de las siguientes es una indicación absoluta para resolución quirúrgica en esta patología?

- a) Hematuria en una ocasión
- b) Retención aguda de orina
- c) Residuo postmiccional de 150 ml
- d) Próstata mayor a 40 cc
- e) Antígeno prostático de 5 ng/ml

9) Un paciente de 24 años, estudiante de derecho, debe rendir su examen oral final para obtener su título profesional, ha estudiado por varios meses y tiene buen dominio de los temas, pero a pesar de que se ha preparado, no ha querido presentar aún el examen, ya que según él “no puedo hacerlo”. Refiere que le ha pasado lo mismo en situaciones similares donde le ha tocado exponer presentando gran nerviosismo. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de pánico
- b) Trastorno de la personalidad evitativo
- c) Ansiedad social
- d) Trastorno de ansiedad generalizada
- e) Agorafobia

10) Una paciente de 26 años, sin antecedentes, mientras iba como copiloto sufre accidente de tránsito, resultando con dolor en extremidad inferior derecha. Al ingreso con vía aérea permeable, respiración espontánea, sin sangramientos evidentes, presión arterial de 150/90, Glasgow 15, extremidad inferior derecha en posición púdica. El diagnóstico más probable es:

- a) Luxación anterior de cadera
- b) Fractura intertrocantérica
- c) Fractura de cuello femoral
- d) Luxación posterior de cadera
- e) Fractura de pelvis

11) Un paciente de 6 años, sin antecedentes, es traído por presentar sangrado rectal fresco en gotas al final de las deposiciones, no asociado a dolor, ni otros síntomas. Al examen físico se encuentra con índice de masa corporal adecuado para su edad, abdomen blando, depresible y no doloroso, ruidos hidroaéreos presentes. El diagnóstico más probable en este caso es:

- a) Úlcera rectal solitaria
- b) Hemorroides
- c) Divertículo de Meckel
- d) Pólipos juvenil
- e) Fisura anal

12) Paciente de 27 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 3 meses de dolor epigástrico tipo urente que aumenta durante los periodos de ayuno y estrés, asociado ocasionalmente a pirosis. Se realiza endoscopia digestiva alta que objetiva úlcera duodenal activa y se realiza test de ureasa que resulta (-). La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Iniciar omeprazol, amoxicilina y claritromicina
- b) Indicar omeprazol y controlar con nueva endoscopia en 6 semanas
- c) Solicitar nueva endoscopia digestiva alta con test de ureasa
- d) Iniciar omeprazol, bismuto y metronidazol
- e) Iniciar medidas anti reflujo y omeprazol a permanencia.

13) Un paciente de 8 años, sin antecedentes, es traído por presentar múltiples pápulas de 3-4 milímetros de diámetro en manos, tórax y extremidades, algunas de ellas agrupadas en forma lineal, asociado a prurito ocasional. El diagnóstico más probable

- a) Molusco contagioso
- b) Fibromatosis
- c) Liquen plano
- d) Verrugas planas
- e) Dermatitis atópica

14) Un paciente de 80 años en cuidados paliativos por cáncer de glotis, presenta desde hace un mes tos y regurgitación alimenticia, no ha presentado neumonías aspirativas ni otras complicaciones. ¿Cuál es la vía de administración de medicamentos más adecuada para este paciente?

- a) Rectal
- b) Sublingual
- c) Intramuscular
- d) Endovenosa
- e) Subcutánea

15) Un lactante de 2 meses de edad, sin antecedentes perinatales, acude a control donde se le administran sus vacunas según el programa nacional de inmunizaciones, doce horas después presenta convulsión tónico-clónica generalizada que dura tres minutos evolucionando posteriormente en buenas condiciones. A futuro la conducta más adecuada con este paciente es:

- a) No volver a vacunar.
- b) Vacunar con DPT al año de vida
- c) Continuar calendario de vacunación de forma normal
- d) Indicar paracetamol durante la próxima vacunación
- e) Reemplazar DPT con DPT acelular.

16) Paciente de 50 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento irregular con hidroclorotiazida, consulta por dolor torácico de 30 minutos de duración, transfixante, irradiado a epigastrio, asociado a mareos y diaforesis. Al examen se aprecia pálido, sudoroso, PA 150/90, FC: 110x', saturación de oxígeno de 93% con FiO2 ambiental, ritmo regular, asociado a soplo diastólico II/VI y disminución del segundo ruido, abdomen blando, depresible e indoloro, ruidos hidroaéreos presentes. Al ingreso se solicita ECG que muestra alteraciones inespecíficas en pared anterolateral, además troponinas que están con resultado pendiente. El diagnóstico más probable es:

- a) Disección aórtica
- b) Infarto agudo al miocardio sin supradesnivel de ST
- c) Tromboembolismo pulmonar
- d) Infarto mesentérico
- e) Pancreatitis aguda

17) Una mujer de 35 años, sin antecedentes, consulta porque está segura de que todos sus compañeros de trabajo la seducen y la acosan, esto le ocurre desde hace aproximadamente 10 años y le ha traído problemas en su trabajo, por lo que ha sido despedida en otros trabajos. No refiere presentar problemas en otros ámbitos de su vida, tiene buena relación con familiares y amigos. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad paranoide
- b) Trastorno de personalidad histriónico
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Trastorno bipolar
- e) Trastorno de la personalidad esquizotípico

18) Una paciente de 29 años, sin antecedentes, consulta por disnea progresiva asociada a fatigabilidad. Al examen físico destaca mucosas pálidas, cardiopulmonar normal. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina 8.3mg/dL, hematocrito 26%, VCM 110, reticulocitos 0.3%, leucocitos 8.500/mm3 y plaquetas 200.000/mm3. El diagnóstico más probable en este caso es:

- a) Anemia falciforme
- b) Anemia perniciosa
- c) Anemia ferropénica
- d) Anemia por enfermedades crónicas
- e) Anemia por déficit de vitamina B6

19) Una paciente de 22 años, nulípara, con antecedentes de migraña a repetición y un episodio de aumausis fugax desea iniciar un método anticonceptivo. Su examen físico se encuentra normal. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos indicaría a esta paciente?

- a) Anticonceptivos combinados por vía oral
- b) Anticonceptivos combinados por vía transdérmica
- c) Salpingoligadura
- d) Dispositivo intrauterino con progestinas
- e) Anticonceptivos combinados inyectables

20) Una paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento, con cuadro de tres meses de dolor en ambas manos y muñecas, asociados a rigidez matinal de 2 horas de evolución. Al examen físico se aprecia compromiso en ambas manos de articulaciones metacarpofalángica e interfalángicas proximales. Se solicita radiografía de manos que muestra erosión de la base de la quinta articulación metacarpofalángica. Además se solicita factor reumatoideo que resulta negativo y péptido citrulinado que también resulta negativo. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis reumatoidea
- b) Artritis psoriática
- c) Osteoartritis
- d) Espondilitis anquilosante
- e) Lupus con compromiso articular

21) Acude a control una paciente de 26 años, trae el resultado de su papanicolau que es informado como “muestra satisfactoria, sin atipias”. ¿A qué tipo de prevención corresponde este examen?

- a) Prevención específica
- b) Promoción de salud
- c) Prevención secundaria
- d) Prevención terciaria
- e) Prevención primaria

22) Paciente de 80 años, con antecedente de hipertensión, diabetes insulínica dependiente con mal control metabólico y epigastria en tratamiento crónico con omeprazol, consulta por cuadro de disfagia lórica asociado a odinofagia de un mes de evolución. Al examen físico no se encuentran alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer esofágico
- b) Reflujo gastroesofágico
- c) Acalasia
- d) Candidiasis esofágica
- e) Divertículo esofágico

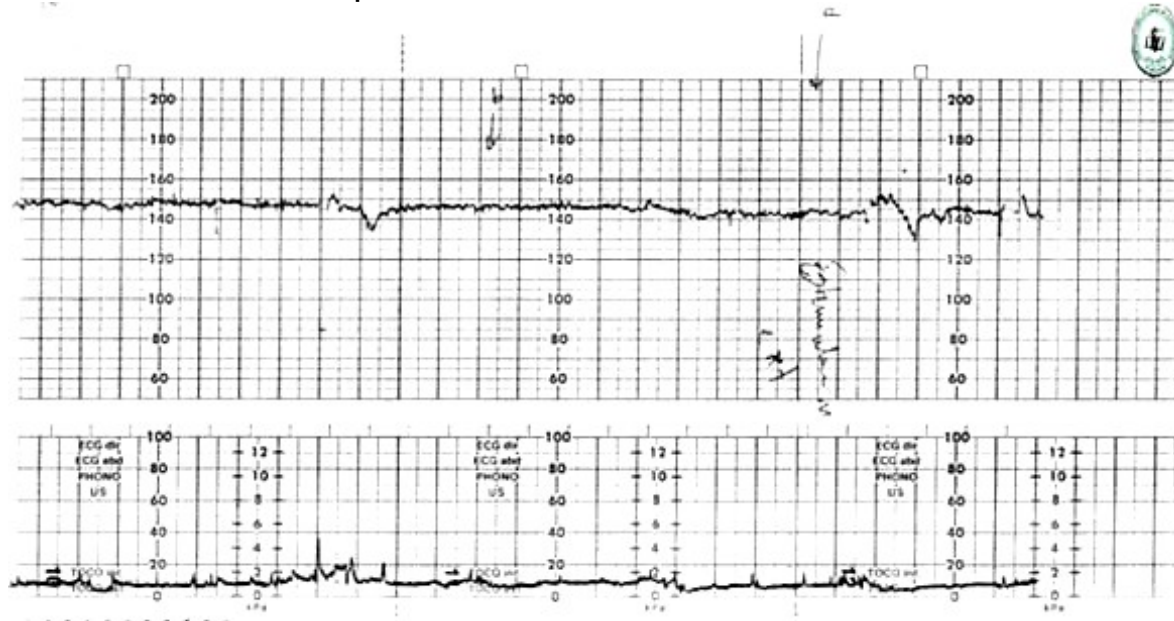
23) Una paciente de 50 años, con antecedente de colecistectomía hace varios años, presenta desde hace dos días cuadro de dolor epigástrico, ictericia fluctuante, orinas oscuras y fiebre. Al examen físico destaca frecuencia cardíaca de 100 por minuto, presión arterial de 80/50 mm de Hg, dolor a la palpación epigástrica, blumberg (+), ruidos hidroaéreos disminuidos. Se solicita ecografía abdominal que muestra vía biliar de 10mm. La conducta más adecuada en esta paciente es:

- a) Realizar colangiografía resonancia
- b) Realizar tomografía axial computada de abdomen
- c) Realizar laparotomía abierta
- d) Indicar antibióticos de amplio espectro y reevaluar en 48 horas
- e) Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

24) Paciente de 20 años, con antecedente de rinitis alérgica y usuaria de anticonceptivos orales, con historia de disnea y tos seca al realizar ejercicios, no asociado a otros síntomas. Actualmente asintomática y su examen físico es normal. El examen de elección para el diagnóstico de esta paciente es:

- a) Test de esfuerzo
- b) Test de metacolina
- c) Prick test
- d) Espirometría
- e) PEF

25) Una mujer de 28 años, con embarazo de 30 semanas, consulta angustiada por no percibir movimientos fetales, sin otros síntomas. Su examen físico es normal. Se solicita registro basal no estresante de veinte minutos que se muestra a continuación:



La conducta más adecuada en este caso es:

- Tranquilizar a la paciente e indicar que mantenga controles habituales
- Solicitar perfil biofísico
- Solicitar ecografía obstétrica
- Repetir registro basal no estresante por veinte minutos más
- Realizar test de tolerancia a las contracciones uterinas

26) Una paciente de 40 años, con antecedente de cuatro episodios depresivos tratados y usuaria de fluoxetina de forma permanente, cursa un nuevo episodio luego de separación con su marido. En su último control se encontraba de mejor ánimo ya que asistiría al casamiento de su hija. Actualmente consulta muy preocupada porque hace aproximadamente una semana atrás, su mano derecha intentó atacarla, pero se defendió con la su mano izquierda y ayuda de familiares. El diagnóstico más probable en este caso es:

- Trastorno conversivo
- Trastorno delirante
- Psicosis
- Trastorno disociativo
- Trastorno por somatización

27) Una paciente de 13 años, sin antecedentes, consulta por cefalea e hirsutismo. Al examen físico se encuentra presión arterial en percentil 99 para su edad, índice de masa corporal mayor al percentil 95 para su edad, acné inflamatorio en su rostro y estrías abdominales. El diagnóstico más probable es:

- Diabetes mellitus tipo 2
- Síndrome de ovario poliquístico
- Síndrome de Cushing
- Hipotiroidismo
- Hiperprolactinemia

28) Un paciente de 51 años, con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión en tratamiento, es traído por presentar cuadro de hemiparesia faciobraquiocrural izquierda de inicio súbito desde hace 2 horas, asociado a dificultad para articular palabras. Al examen físico se corrobora dicha paresia asociada a disminución de reflejos en lado izquierdo. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

- Punción lumbar
- Resonancia magnética
- TAC de cerebro con contraste
- TAC de cerebro sin contraste
- Angiografía de arteria cerebral media

29) Embarazada de 35 semanas, con altura uterina menor a lo esperado, es derivada a alto riesgo obstétrico donde se realiza ecografía que muestra feto de 1.800 gramos y el doppler umbilical muestra flujo reverso en diástole. La paciente está en buenas condiciones, sin dinámica uterina y su tacto vaginal no presenta cambios cervicales. La conducta más adecuada es:

- a) Inducir con misoprostol y conducir trabajo de parto
- b) Interrumpir por cesárea
- c) Hospitalizar para estudio de la unidad fetoplacentaria
- d) Solicitar estudio de líquido amniótico
- e) Indicar reposo y control en 48 horas

30) Recién nacido de 35 semanas, de 5 días de vida, con antecedente de depresión neonatal recuperada, inicia cuadro caracterizado por vómitos y distensión abdominal asociado a deposiciones con sangre. Al examen físico se palpa abdomen distendido, con tono aumentado. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

- a) Ecografía abdominal
- b) Tomografía axial computada de abdomen con contraste
- c) Radiografía de abdomen
- d) Laparotomía exploradora
- e) Colonoscopia

31) Un lactante de 6 meses, sin antecedentes perinatales, es traído por presentar epifora desde hace 2 meses, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia córnea de 15mm de diámetro en ojo izquierdo, asociado a opacidad corneal. El diagnóstico más probable es:

- a) Retinoblastoma
- b) Catarata congénita
- c) Atresia del conducto lacrimal
- d) Glaucoma congénito
- e) Persistencia del vítreo primario hiperplásico

32) Una paciente de 36 años, multipara de 3, con historia de amenorrea desde hace 4 meses, no asociado a otros síntomas. Refiere haber sido usuaria de anticonceptivos orales hasta hace 6 meses y que se realizó test de embarazo en dos oportunidades con resultado negativo. Se solicitan niveles de hormona tiroestimulante y prolactina que resultan normales, además prueba de progesterona que es negativa, por este motivo se solicita prueba de estrógeno más progesterona que resulta positiva y niveles de hormona folículo estimulante que resulta en 5 mUI/mL. El diagnóstico más probable es:

- a) Falla ovárica primaria
- b) Falla del eje hipotálamo hipofisiario
- c) Síndrome de ovario poliquístico
- d) Malformación uterina
- e) Síndrome de cushing

33) Un paciente de 17 años, obeso, se realiza chequeo con glicemia de ayuno que resulta en 130, por lo que se repite este examen obteniendo 137, no ha presentado síntomas. En el examen físico destaca presencia de acantosis nígricans en pliegue cervical y acrocordones. El diagnóstico más probable es:

- a) Diabetes mellitus tipo 1
- b) Diabetes mellitus tipo 2
- c) Diabetes mellitus autoinmune
- d) Intolerancia a la glucosa
- e) Glicemia de ayuno alterada

34) Una paciente de 40 años, con antecedente de hipotiroidismo desde la adolescencia, vitiligo y diabetes diagnosticada hace un año, en tratamiento con régimen oral, acude a control con glicemia de ayuno en 250 mg/dL y hemoglobina glicosilada en 9,0%. El diagnóstico más probable es:

- a) Diabetes mellitus tipo 1
- b) Diabetes mellitus tipo 2
- c) Diabetes mellitus autoinmune
- d) Hipopituitarismo autoinmune
- e) Neoplasia endocrina múltiple tipo 1

35) Un lactante de 10 meses de edad, sin antecedentes, mientras come su almuerzo comienza súbitamente con tos asociado a disminución del esfuerzo respiratorio e hipotonía. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Iniciar reanimación cardiopulmonar
- b) Exploración digital de su cavidad oral
- c) Iniciar presión digital en epigastrio
- d) Dar golpes en la espalda
- e) Iniciar ventilaciones boca a boca

36) Un paciente de 54 años, post menopáusica, sin uso de terapia de reemplazo hormonal, consulta por presentar metrorragia en dos oportunidades, sin otros síntomas. Se realiza especuloscopia que no muestra signos de sangramiento activo ni lesiones, el resto del examen físico resulta normal. El examen de elección en este caso es:

- a) Realizar histeroscopia
- b) Legrado biopsico endometrial
- c) Ecografía abdominal
- d) Colposcopia y biopsia
- e) Ecografía transvaginal

37) Mujer de 23 años, con cuadro de 24 horas de evolución de compromiso del estado general, fiebre y soñolencia progresiva. Al examen físico destaca con temperatura de 38,5°C, petequias y equimosis en extremidades, rigidez de nuca sin focalización neurológica. El diagnóstico más probable es:

- a) Meningitis tuberculosa
- b) Meningitis meningocócica
- c) Meningitis neumocócica
- d) Meningitis por listeria
- e) Meningitis herpética

38) Una paciente de 33 años, sin antecedentes, cursa con cuadro de dolor lumbar y fiebre desde hace un día, asociado a disuria y orinas de mal olor. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, con temperatura de 38°C y en el resto del examen solo destaca puño percusión positiva a derecha. Se solicita sedimento de orina y urocultivo, con lo que se confirma pielonefritis aguda por lo que inicia tratamiento ambulatorio con ciprofloxacino. Dos días después acude a control persistiendo sintomática. Su resultado del urocultivo muestra presencia de *E. coli* sensible a nitrofurantoina, carbapenémicos, ampicilina/sulbactam y amikacina, y resistente a cefalosporinas, gentamicina y ciprofloxacino. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el de elección para el manejo en este caso?

- a) Amikacina
- b) Nitrofurantoina
- c) Ertapenem
- d) Ampicilina
- e) Moxifloxacino

39) Un paciente de 16 años, sin antecedentes mórbidos, es traído por presentar mal rendimiento escolar y mala relación con sus padres. Sus padres refieren que esto comenzó hace tres meses, que ha estado irritable, se alimenta mal y duerme poco. Al entrevistar solo al paciente, refiere que hace aproximadamente tres meses terminó una relación amorosa que fue muy importante. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno ansioso
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno delirante
- d) Distimia
- e) Depresión

40) Se realiza un estudio donde se comparan dos grupos de personas mayores de 60 años, uno de ellos corresponde a hipertensos y el otro de características similares pero sin hipertensos, se siguen por 5 años y se evalúa la aparición de infarto agudo al miocardio o accidente cerebrovascular. Este enunciado corresponde a un estudio de:

- a) Corte transversal
- b) Caso control
- c) Estudio clínico randomizado
- d) Cohorte
- e) Ensayo de campo

41) Una paciente de 35 años, sin antecedentes, sufre fractura de diáfisis humeral izquierda, evolucionando posteriormente con hipostesia del dorso de dicha mano, asociado a imposibilidad de realizar extensión de muñeca y falanges. ¿La estructura más probablemente dañada en este caso es?:

- a) Nervio mediano
- b) Nervio ulnar
- c) Nervio radial
- d) Nervio axilar
- e) Nervio musculocutáneo

42) Un paciente de 2 años de edad, sin antecedentes, con historia de dolor abdominal difuso e intenso de inicio brusco, que luego disminuye y se asocia a deposiciones de color rojo oscuro, sin otros síntomas. Actualmente no presenta dolor y su examen físico es normal. El examen de elección en este caso es:

- a) Ecografía
- b) Tomografía axial computada de abdomen
- c) Colonoscopia
- d) Cintigrafía
- e) Radiografía

43) Una paciente de 16 años, obesa, consulta por astenia y debilidad de semanas de evolución, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se corrobora obesidad en percentil 97 para la edad, se aprecia hirsutismo, acné inflamatorio y estrías abdominales. El diagnóstico más probable es:

- a) Resistencia insulínica
- b) Síndrome de ovario poliquístico
- c) Síndrome de Cushing
- d) Diabetes Mellitus tipo 1
- e) Hiperprolactinoma

44) Un paciente de 35 años, con cuadro de ojo rojo asociado a secreción mucopurulenta desde hace un día, por lo cual se le indicó colirio de cloranfenicol cada 8 horas, sin embargo evoluciona posteriormente con aumento del enrojecimiento, edema palpebral y quemosis. El diagnóstico más probable es:

- a) Alergia al cloranfenicol
- b) Celulitis orbitaria
- c) Obstrucción lacrimal
- d) Chalazion
- e) Absceso tarsal

45) Paciente de 35 años de edad, consulta por cuadro de 2 días de palpitaciones de dos días de evolución asociado a disnea en algunas ocasiones. Al ingreso se conecta a monitor donde se observa presencia de taquiarritmia irregular de complejo angosto. Al examen físico se encuentra consciente y orientada temporoespacialmente, bien perfundida e hidratada, examen pulmonar normal. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Realizar cardioversión eléctrica
- b) Indicar enoxaparina y amiodarona
- c) Indicar acenocumarol y betabloqueo
- d) Indicar heparina de bajo peso molecular y verapamilo
- e) Indicar heparina no fraccionada y flecainida

46) Paciente de 29 años, cursando embarazo de 38 semanas, consulta por aparición de vesículas dolorosas a nivel vulvar, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecian vesículas con base eritematosa a nivel vulvar. El examen de elección para el diagnóstico etiológico en este caso es:

- a) Cultivo viral
- b) PCR para virus herpes
- c) Biopsia
- d) Inmunoglobulina G para virus herpes
- e) Tinción para virus herpes

47) Una paciente de 12 años, sin antecedentes, consulta por cuadro de hemorragia gingival al lavarse los dientes, asociado a equimosis frente a pequeños traumatismos desde hace 2 semanas. Al examen físico destacan dichas equimosis y petequias generalizadas, sin otros hallazgos. Se solicita hemograma donde destaca hemoglobina de 12mg/dL, leucocitos de 7.000/mm³ y plaquetas de 4000/mm³. El tratamiento de elección en este caso es:

- a) Transfusión de plaquetas
- b) Esplenectomía
- c) Corticoides
- d) Inmunoglobulina no específica
- e) Administrar crioprecipitado

48) Un paciente de 6 años, con historia de 5 días de odinofagia intensa asociada a secreción purulenta y sensación febril que durante el último día se acompañó de rash papular eritematoso que es más intenso en pliegues. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

- a) Hemograma
- b) IgM para virus Epstein barr
- c) Panel viral
- d) Cultivo de secreción faríngea
- e) Test pack para Streptococo grupo A

49) Paciente de 34 años, consulta por cuadro de un mes de compromiso del estado general, tos persistente con expectoración mucopurulenta y en dos ocasiones hemoptóica. Al examen físico destaca sudoroso, frecuencia cardíaca de 60 por minuto, presión arterial de 120/70, examen cardíaco normal y pulmonar con murmullo presente, crepitaciones y sibilancias difusas mayores en ápice izquierdo. El examen más adecuado para el diagnóstico en este caso es:

- a) Baciloscopías seriadas
- b) Prueba cutánea de tuberculina
- c) Radiografía de tórax
- d) TAC de tórax multicorte
- e) Hemocultivo

50) Paciente de 30 años, sufre caída de altura resultando con traumatismo contuso en flanco derecho, asociado a hematuria macroscópica. Al examen físico presenta equimosis en flanco derecho, sin otros hallazgos. ¿Cuál de los siguientes exámenes es el más indicado para el estudio de este paciente?

- a) Ecografía abdominal
- b) Tomografía axial computada sin contraste de abdomen
- c) Radiografía abdominal
- d) Tomografía axial computada con contraste de abdomen
- e) Pielografía de eliminación

51) Paciente joven de 24 años, es traído por sus padres ya que desde hace aproximadamente un año se vuelve muy solitario, no sale de su hogar, descuida su higiene y habla frecuentemente sobre el apocalipsis y el fin de la humanidad. Al entrevistarle se aprecia con marcado aplanamiento afectivo y frente a distintas preguntas habla sobre el apocalipsis. Su madre está actualmente cursando con depresión y su padre tiene trastorno bipolar en tratamiento con litio. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno bipolar
- b) Trastorno por abuso de sustancias
- c) Trastorno de la personalidad esquizotípico
- d) Esquizofrenia
- e) Trastorno delirante crónico

52) Un paciente de 23 años sufre una puñalada en región supraclavicular izquierda, dos días después consulta por disnea y tope inspiratorio. Al examen físico está en regulares condiciones y decaído, en su examen pulmonar se encuentra disminución del murmullo pulmonar izquierdo. Se solicita radiografía de tórax que es compatible con derrame pleural ipsilateral. Se realiza toracocentesis que da salida a líquido blanco. El diagnóstico más probable es:

- a) Empiema
- b) Derrame paraneumónico
- c) Hemotórax
- d) Quilotórax
- e) Neumotórax

53) Paciente de 67 años, con antecedentes de infarto agudo al miocardio hace 6 meses tratado con stent, hipertensión arterial tratada con enalapril e hidroclorotiazida, y diabetes mellitus tratada con insulina horaria, consulta por cuadro de dos meses de disnea de medianos esfuerzos, asociado a ortopnea y edema de extremidades inferiores que aumenta en las tardes. Al examen cardiopulmonar destaca ritmo regular en dos tiempos sin soplos y murmullo pulmonar presente con crepitaciones bibasales. ¿Cuál de los siguientes es el examen de elección para iniciar el estudio diagnóstico?

- a) Electrocardiograma
- b) Coronariografía
- c) Test de esfuerzo
- d) Radiografía de torax
- e) Ecocardiograma

54) Embarazada de 33 semanas, hospitalizada por preeclamsia, comienza con dinámica uterina de 3 en 10 minutos, sus últimos exámenes de control presenta creatinina 1,5mg/dL y proteinuria de 24 horas 2 gramos. Al examen físico presenta presión arterial de 150/90, reflejos osteotendíneos presentes, tacto vaginal sin cambios cervicales. Se realiza monitoreo fetal que muestra variabilidad de 3 latidos por minutos y desaceleraciones tardías. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar tocolíticos e interrumpir a las 34 semanas
- b) Administrar labetalol endovenoso y mantener conducta expectante
- c) Realizar perfil biofísico
- d) Solicitar ecografía doppler umbilical
- e) Interrupción del embarazo

55) Un paciente de 70 años, con cuadro de 2 horas de dolor y ardor en pie derecho. Al examen físico destaca eritema en primera articulación metacarpofalángica de pie derecho, sin otras alteraciones. Refiere que ha presentado este mismo cuadro en dos ocasiones en los últimos 6 meses. El tratamiento de elección en este paciente es:

- a) Probenecid
- b) Alopurinol
- c) Coritoides
- d) Paracetamol
- e) Colchicina

56) Un paciente de 27 años, sin antecedentes, consulta por dolor en flanco izquierdo de 2 horas de evolución tipo cólico, irradiado a genitales, náuseas y vómitos, sudoración y hematuria. Al examen físico se encuentra inquieto, con puño percusión positiva a izquierda. El fármaco de elección para el manejo de este paciente es:

- a) Ketorolaco
- b) Acetaminofeno
- c) Pargeverina
- d) Tramadol
- e) Clonixinato de lisina

57) Un paciente de 21 años, con antecedente de dermatitis atópica y onicomicosis en manos y pies, es diagnosticado por varicela necrohemorrágica la cual es manejada con aciclovir. ¿Cuál de las siguientes patologías de base es más probable que tenga este paciente?

- a) Inmunodeficiencia por déficit de inmunoglobulina A
- b) Inmunodeficiencia por alteración en la fagocitosis
- c) Inmunodeficiencia por déficit de inmunoglobulina G
- d) Inmunodeficiencia por déficit de complemento
- e) Inmunodeficiencia combinada adquirida

58) Un paciente de 11 años, es traído por sus padres por ser el más bajo de su curso. Ha estado creciendo en el percentil 2 para su edad desde hace años según su curva de crecimiento y al examen físico se aprecia desarrollo puberal Tanner 1, con testículos de 2cc. Sus padres tienen estatura promedio para la población. Se solicita radiografía de carpo que muestra edad ósea de 8 años y 6 meses. El diagnóstico más probable es:

- a) Talla baja familiar
- b) Hipogonadismo
- c) Acondroplasia
- d) Enanismo
- e) Retardo constitucional del crecimiento

59) Paciente de 70 años, diabético en tratamiento farmacológico y hospitalizado por neumonía desde hace 5 días, comienza desde ayer con cuadro de deposiciones diarreicas acuosas asociado a desorientación temporoespacial. Al examen físico destaca abdomen doloroso a palpación profunda, con ruidos hidroaéreos aumentados y ausencia de irritación peritoneal. Se solicita coprocultivo que se informa negativo y leucocitos fecales positivos. El tratamiento de elección en este caso es:

- a) Hidratación por vía oral abundante
- b) Metronidazol oral
- c) Ciprofloxacino oral
- d) Clindamicina ev
- e) Probióticos orales

60) Una mujer de 35 años, con embarazo de 15 semanas, sin síntomas, en exámenes de control destaca VDRL negativo, hemoglobina de 11,5 mg/dL y glicemia de ayuno 108mg/dL. Su examen físico es normal, con altura uterina sobre el pubis. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Solicitar test de tolerancia oral a la glucosa
- b) Indicar dieta y mantener control habitual
- c) Solicitar hemoglobina glicosilada
- d) Indicar insulina subcutánea
- e) Solicitar nueva glicemia de ayunas

61) Paciente de 75 años, con cuadro de disforia y anhedonia desde hace un mes, asociado a fatigabilidad, disminución de peso e insomnio, además ha presentado fallas reiteradas de memoria. Su examen físico normal, se solicita TSH que resulta en 5,4. El tratamiento más adecuado en este paciente es:

- a) Venlafaxina
- b) Fluoxetina
- c) Levotiroxina
- d) Memantina
- e) Mirtazapina

62) Un recién nacido de término, presenta cianosis desde su nacimiento, con saturación arterial de 65% con aporte de oxígeno al 100%. Al examen físico destaca murmullo pulmonar disminuido en ambos campos pulmonares, soplo sistólico y pulsos presentes. Como parte de su estudio se solicita radiografía de tórax que muestra cargiomegalia y mediastino delgado. El diagnóstico más probable es:

- a) Trasposición de grandes vasos
- b) Comunicación interauricular
- c) Coartación aórtica
- d) Canal auriculoventricular
- e) Comunicación interventricular

63) Una paciente de 30 años, nulípara, consulta por presentar reglas abundantes, asociado a astenia e hipersomnía. Al examen físico destacan mucosas pálidas, sin otros hallazgos. Se realiza hemograma donde destaca hemoglobina que resulta en 8mg/dL, y además se realiza ecografía transvaginal que muestra presencia de dos miomas intramurales. El tratamiento de elección en este caso es:

- a) Anticonceptivos orales
- b) Agonistas de las gonadotrofinas
- c) Histerectomía
- d) Miomectomía
- e) Observación

64) Mujer de 58 años, fumadora e hipertensa, consulta por historia de un año de disnea de esfuerzos moderados y tos seca, no asociado a otros síntomas. Al examen físico destaca acropaquia y al examen pulmonar murmullo pulmonar disminuido bilateral con presencia de crépitos gruesos difusos. Se solicita radiografía de tórax que muestra imagen en panal de abejas. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- b) Tuberculosis
- c) Enfermedad pulmonar intersticial difusa
- d) Cáncer pulmonar
- e) Tromboembolismo pulmonar crónico

65) Paciente de 34 años, sin antecedentes, consulta por atraso menstrual asociado a metrorragia abundante, náuseas y vómitos. Al examen físico se aprecian mucosas pálidas, útero a nivel suprapúbico y se palpan masas anexiales bilaterales no sensibles. El diagnóstico más probable es:

- a) Embarazo normal
- b) Aborto en evolución
- c) Adenomiosis
- d) Embarazo gemelar
- e) Embarazo molar

66) Un paciente de 55 años, sin antecedentes, consulta por dolor epigástrico intenso asociado a vómitos biliosos. Al examen físico destacan escleras ictéricas, sensibilidad a la palpación epigástrica. Se realiza exámenes donde destaca leucocitos 13.000/mm³, PCR 50 mg/dL, GOT 120mg/dL, GPT 140mg/dL, bilirrubina 3mg/dL, fosfatasa alcalina 400mg/dL, lipasa 100mg/dL. Ecografía abdominal con vía biliar extrahepática dilatada. El diagnóstico más probable es:

- a) Colangitis aguda
- b) Pancreatitis aguda
- c) Colecistitis aguda
- d) Coledocolitiasis
- e) Hepatitis aguda

67) Una paciente de 24 años, sin antecedentes, consulta en urgencias por cuadro de inicio brusco caracterizado por sensación de falta de aire, dolor en hemitórax izquierdo, mareos, sudoración y adormecimiento de manos, de 30 minutos de duración. Al examen físico presenta frecuencia cardíaca 120 por minuto, presión arterial 140/90, cardiopulmonar normal. Se solicita electrocardiograma que muestra ritmo sinusal, QRS angosto, sin signos de isquemia. El fármaco de elección para el manejo en este caso es:

- a) Haloperidol
- b) Diazepam
- c) Lorazepam
- d) Fenitoina
- e) Clonazepam

68) Un paciente de 80 años, autovalente, inicia cuadro de compromiso del estado general, tos y expectoración mucopurulenta, se realiza radiografía de tórax en donde se comprueba diagnóstico de neumonía basal derecha por lo que se hospitaliza para el tratamiento. Durante la hospitalización en la noche el paciente se agita, se saca sonda foley y vías venosas, durante la mañana está tranquilo. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome confusional agudo
- b) Delirio
- c) Alzheimer
- d) Meningitis bacteriana
- e) Demencia frontotemporal

69) Un paciente de 10 años, es traído por cuadro de inicio agudo de dos horas de evolución caracterizados por palpitaciones y dolor torácico. Al ingreso se conecta a monitor que muestra frecuencia cardíaca de 200 latidos por minutos, regular y QRS angosto. La primera medida para el manejo en este caso es:

- a) Realizar presión ocular
- b) Realizar cardioversión eléctrica
- c) Administrar adenosina endovenosa
- d) Realizar masaje carotídeo
- e) Administrar verapamilo endovenoso

70) Paciente de 28 años, con cuadro de 2 meses de dolor epigástrico urente, que aumenta en ayuno y al beber café, asociado a pirosis y reflujo ocasional. Al examen físico no se aprecian alteraciones. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Iniciar omeprazol
- b) Iniciar amoxicilina y claritromicina
- c) Solicitar ecografía
- d) Solicitar test de ureasa
- e) Solicitar endoscopia digestiva alta

71) Un paciente de 35 años, sin antecedentes, con cuadro de una semana de compromiso del estado general y sensación febril, que durante los últimos días se agrega cefalea y diplopía. Al examen físico destaca reflejo fotomotor conservado, parálisis del sexto par derecho y rigidez de nuca esbozada. Se solicita punción lumbar que muestra células aumentadas de predominio mononuclear, glucosa disminuida y proteínas altas, gram no visualiza gérmenes. El agente etiológico más probable en este caso es:

- a) Mycobacterium tuberculosis
- b) Neumococo
- c) Enterovirus
- d) Herpes virus
- e) Criptococosis

72) Una mujer de 34 años, multipara de dos, cursando embarazo de veinte semanas, con antecedente de dos partos prematuros a las 20 y 24 semanas, asintomática, acude a control. Su examen físico es normal, útero a nivel umbilical. Se realiza cervicometría de control, la cual muestra cuello de 20mm. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Solicitar perfil biofísico
- b) Indicar corticoides y antibióticos, manteniendo una conducta expectante
- c) Realizar cerclaje
- d) Administrar tocolisis y corticoides, manteniendo una conducta expectante
- e) Aplicar estrógenos tópicos

73) Paciente de 68 años, sin antecedentes conocidos, consulta por cuadro de dolor abdominal desde hace 6 horas, asociado a distensión progresiva, vómitos y sensación febril, además refiere que no ha eliminado gases. Al examen físico destaca ausencia de ruidos hidroaéreos y blumberg (+). Se solicita radiografía de abdomen que se muestra a continuación:



- a) Gastroenteritis aguda
- b) Vólvulo sigmoides
- c) Obstrucción intestinal
- d) Diverticulitis aguda
- e) Apendicitis aguda

74) Un paciente de 9 años, es traído por presentar cuadro de 2 días de compromiso del estado general, mialgias, artralgias, tos y fiebre, que durante las últimas horas se agregó cefalea. Al examen físico se encuentra decaído, frecuencia cardíaca de 100 por minuto, frecuencia respiratoria de 22 por minuto, examen pulmonar normal. El agente etiológico más probable es:

- a) Adenovirus
- b) Streptococo pneumoniae
- c) Mycoplasma
- d) Virus influenza A
- e) Virus respiratorio sincicial

75) Embarazada de 35 semanas, multipara de 2, refiere pérdida de líquido claro abundante por genitales, no asociado a otros síntomas. A la especuloscopia no se observa líquido saliendo del orificio cervical externo. Se realiza registro basal no estresante que se encuentra reactivo. El examen de elección para evaluar a esta paciente es:

- a) Ecografía
- b) Test de nitrazina
- c) Test de cristalización
- d) Detección de alfa 1 microglobulina placentaria
- e) Medición del pH vaginal

76) Un paciente de 46 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina, acude a control, refiere estar asintomático. Al examen físico se encuentra presión arterial de 138/83, sin otros hallazgos. Sus exámenes de control muestran hemoglobina glicosilada en 6.9%, índice proteinuria creatininuria de 0.3, creatinina 0.8 mg/mL. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Aumentar dosis de metformina
- b) Iniciar hidroclorotiazida
- c) Iniciar enalapril
- d) Suspender metformina e indicar insulina
- e) Mantener tratamiento actual y reforzar medidas como dieta y ejercicio

77) Escolar de 8 años, es traído por su madre ya que desde hace años presenta equimosis frente a pequeños traumatismos y en una ocasión presentó un hematoma en muslo al jugar en el colegio. Actualmente presenta sangramiento gingival, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia dicho sangramiento, asociado a equimosis en extremidades. Se solicitan exámenes que muestran hemoglobina 12mg/dL, leucocitos 6.000/mm³, plaquetas 230.000/mm³, tiempo de protrombina normal y tiempo de tromboplastina parcial activada prolongada. El diagnóstico más probable en este caso es:

- a) Enfermedad de Von Willebrand
- b) Enfermedad de Bernard Soulier
- c) Enfermedad de Glanzmann
- d) Hemofilia
- e) Escorbuto

78) Un paciente de 45 años, diagnosticado de diabetes hace un mes, se le indicó tratamiento con metformina, la cual suspendió por que le producía diarrea, desde entonces ha estado asintomático. Acude a control con exámenes donde destaca hemoglobina glicosilada de 8,5%, glicemia de ayuno 180mg/dL, creatinina de 1,5 mg/dL. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Indicar Insulina
- b) Indicar glibenclamida
- c) Indicar rosiglitazona
- d) Indicar acarbosa
- e) Indicar metformina de acción prolongada

79) Una paciente de 26 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por historia de tres meses de amenorrea asociada a galactorrea, sin otros síntomas, con prueba de detección de bHCG en orina negativa en dos oportunidades. Su examen físico resulta normal, su índice de masa corporal es de 20. El examen de elección para iniciar el estudio en este caso es:

- a) Hormona estimulante tiroidea
- b) Prueba de progesterona
- c) Ecografía transvaginal
- d) Prolactina
- e) Prueba de estrógeno más progesterona

80) Paciente de 18 años, sin antecedentes mórbidos, es traído al servicio de urgencias por cuadro de dolor en hemitórax izquierdo de inicio súbito irradiado a miembro superior ipsilateral, asociado a disnea leve, el cual inició mientras jugaba un partido de basquetbol. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones y a la auscultación pulmonar destaca disminución del murmullo pulmonar en hemitórax izquierdo, sin otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

- a) Angina inestable
- b) Tromboembolismo pulmonar
- c) Neumotorax espontáneo
- d) Perforación esofágica
- e) Contractura muscular

81) Una paciente de 6 años, con cuadro caracterizado por disuria, polaquiuria y orinas de mal olor desde hace 2 días, no asociado a otros síntomas. Al examen físico destaca temperatura de 36.5°C, abdomen blando, depresible y no doloroso a la palpación, puño percusión negativa. Se realiza sedimento de orina que muestra 6 eritrocitos y 15 leucocitos por campo, además se solicita urocultivo de segundo chorro en el que hay crecimiento de escherichia coli con 60.000 unidades formadoras de colonia multisensible. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Iniciar Cefadroxilo oral
- b) Iniciar Nitrofurantoina oral
- c) Solicitar Ecografía renal y vesical
- d) Solicitar cintigrafía renal estática
- e) Repetir sedimento de orina y urocultivo

82) Un paciente de 21 años, sin antecedentes, mientras jugaba fútbol sufre golpe en zona testicular tras lo cual se palpa una masa. Al examen físico se palpa masa en polo superior blanda. Se solicita ecografía escrotal que muestra lesión quística en epidídimo de 3 cm de diámetro, sin otros hallazgos. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Orquiectomía por vía inguinal
- b) Punción y aspiración del quiste
- c) Orquiectomía por vía escrotal
- d) Observación
- e) Indicar inhibidores de la 5 alfa reductasa

83) Una paciente de 25 años, es operada de apendicitis aguda hace 24 horas, actualmente se encuentra muy decaída y con dificultad respiratoria. Al examen físico destaca pálida, frecuencia cardíaca de 110 por minuto y con presión arterial de 90/60. El diagnóstico más probable es:

- a) Atelectasia
- b) Reacción adversa a medicamentos
- c) Tromboembolismo pulmonar
- d) Infección de herida operatoria
- e) Hemoperitoneo

84) Un paciente de 45 años, con historia de años de evolución de hipoacusia y supuración por oído derecho, consulta por compromiso del estado general, fiebre hasta 39°C, vértigo y secreción ótica purulenta. Al examen se aprecia nistagmus horizontal con fase rápida a izquierda, a la otoscopia solo se aprecia secreción purulenta en conducto auditivo externo, no se observa tímpano. El tratamiento más adecuado en este caso es:

- a) Antibióticos endovenosos
- b) Lavado ótico
- c) Cirugía de urgencia
- d) Corticoides endovenosos
- e) antiinflamatorios endovenosos

85) Paciente de 57 años, hipertenso en tratamiento con losartan y tabáquico, consulta por historia de 3 semanas de evolución de episodios caracterizados por dolor torácico que aparece al caminar por más de 10 minutos, el cual tiene una duración máxima de 5 minutos y luego cede al reposo, no asociado a otros síntomas. Actualmente se encuentra asintomático y su examen físico es normal. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para iniciar su estudio?

- a) Radiografía de tórax
- b) Ecocardiograma
- c) Coronariografía
- d) Electrocardiograma
- e) Test de esfuerzo

86) Un paciente de 24 años, sin antecedentes, consulta porque hace ocho meses mientras esperaba transporte colectivo, presencié un accidente automovilístico con resultados fatales, desde entonces intenta no acercarse mucho a la calle y cada vez que está en un paradero se encuentra muy inquieto, además refiere que le cuesta conciliar el sueño ya que presenta pesadillas frecuentemente. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno por estrés post traumático
- b) Trastorno de ansiedad
- c) Trastorno evitativo
- d) Trastorno por estrés agudo
- e) Trastorno adaptativo

87) Un paciente de 46 años, sin antecedentes, cursa con cuadro de disnea y palidez desde hace 2 semanas, asociado a coluria e ictericia. Al examen físico se aprecian mucosas pálidas y se palpa esplenomegalia, sin otros hallazgos. El examen de elección para el diagnóstico etiológico en este caso es:

- a) Haptoglobina
- b) LDH
- c) Coombs
- d) Hemograma con reticulocitos
- e) Bilirrubina total e indirecta

88) Una mujer de 35 años, multipara de uno, cursando embarazo de 28 semanas, consulta por dolor abdominal, sin otros síntomas. Al examen se aprecia presencia de contracciones uterinas de tres en diez minutos, al tacto vaginal se palpa cuello con un centímetro de dilatación, 50% borrado. Se realiza ecografía transvaginal que muestra cérvix de 18 mm. El fármaco de elección para el manejo de esta paciente es:

- a) Atosiban
- b) Nifedipino
- c) Fenoterol
- d) Progesterona
- e) Sulfato de magnesio

89) Paciente de 55 años, con antecedente de esteatohepatitis no alcohólica y obesidad, se realiza ecografía abdominal como parte de chequeo donde se aprecia lesión levemente hipocogénica, redondeada, sin sombra acústica ni refuerzo posterior. El diagnóstico más probable es:

- a) Hiperplasia nodular focal
- b) Hepatocarcinoma
- c) Adenoma
- d) Hemangioma
- e) Hidatidosis hepática

90) Un paciente de 8 años presenta aparición de lesiones en la cara, desde hace 3 días, las que han aumentado. Al examen físico se aprecia lo siguiente:



El diagnóstico más probable es:

- a) Acné
- b) Rosácea
- c) Erisipela
- d) Impétigo
- e) Antrax

Nombre: _____

RUT: _____

1. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
16. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
17. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
18. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
19. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
20. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
21. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
22. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
23. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
24. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
25. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
26. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
27. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
28. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
29. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
30. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

31. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
32. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
33. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
34. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
35. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
36. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
37. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
38. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
39. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
40. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
41. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
42. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
43. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
44. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
45. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
46. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
47. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
48. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
49. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
50. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
51. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
52. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
53. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
54. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
55. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
56. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
57. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
58. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
59. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
60. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

61. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
62. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
63. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
64. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
65. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
66. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
67. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
68. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
69. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
70. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
71. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
72. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
73. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
74. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
75. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
76. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
77. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
78. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
79. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
80. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
81. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
82. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
83. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
84. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
85. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
86. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
87. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
88. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
89. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
90. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

SEGUNDA PARTE

1) Un paciente de 50 años, sin antecedentes, consulta por ojo rojo izquierdo desde ayer asociado a sensación de dolor, blefarospasmo y fotofobia. Su examen físico es dificultoso por dolor, por lo que se administra anestésico local, tras lo cual se aprecia ojo rojo tipo central y al aplicar fluoresceína se tiñe la mitad superior de la córnea. La conducta más apropiada en este caso es:

- a) Evertir el párpado superior
- b) Aplicar colirio de gentamicina
- c) Poner parche ocular y controlar
- d) Aplicar colirio con atropina
- e) Realizar aseo local

2) Mujer de 37 años, sin antecedentes, consulta por aparición de aumento de volumen cervical anterior, no asociado a otros síntomas. Al examen físico destaca nódulo a nivel tiroideo de consistencia aumentada, que asciende a la deglución. Como parte del estudio se realiza TSH que resulta normal. La conducta inicial más adecuada en este caso es:

- a) Solicitar punción con aguja fina
- b) Solicitar Cintigrafía con I131
- c) Solicitar ecografía cervical
- d) Solicitar anticuerpos anti tiroperoxidasa
- e) Solicitar niveles de T3 y T4L

3) Un adolescente de 13 años, con antecedentes familiares de cáncer de mama, es traído por presentar aumento de volumen en mama derecha, asociado a hipersensibilidad local, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia mama derecha aumentada de volumen y a la palpación, destaca tumoración de consistencia gomosa y fácil de movilizar, desarrollo puberal normal para su edad, sin otros hallazgos. Se solicita ecografía mamaria que muestra nódulo de bordes lisos de 5 milímetros de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar estudio genético
- b) Tranquilizar a los padres y al paciente, y controlar en un año
- c) Indicar tratamiento hormonal y controlar
- d) Realizar mastectomía parcial
- e) Realizar biopsia estereotáxica

4) Un paciente de 19 años, sin antecedentes, hace un mes sufre golpe contuso en rodilla izquierda mientras jugaba fútbol, tras lo cual ha permanecido con dolor el cual ha aumentado en las últimas semanas, asociado a aumento de volumen duro. Se solicita radiografía de rodilla que muestra lesión de gran tamaño en metáfisis y diáfisis de fémur, asociado a compromiso cortical. El diagnóstico más probable es:

- a) Sarcoma de Ewing
- b) Osteosarcoma
- c) Osteoma osteoide
- d) Sarcoma de partes blandas
- e) Tumor de células gigantes

5) Paciente de 55 años, con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica por tabaquismo, es derivado desde servicio de urgencia rural por aumento de su disnea basal, asociado a sensación febril y luego confusión, al ingreso en nuestro centro se solicitan gases arteriales que muestran pH 7.3, PaCO2 80, PaO2 86 con FiO2 al 100%. En su examen físico destaca sopor superficial, murmullo pulmonar disminuido en ambos campos pulmonares, con sibilancias difusas y crepitaciones en base pulmonar izquierda. La medida más adecuada en este momento es:

- a) Administrar hidrocortisona en bolo
- b) Nebulizar con salbutamol
- c) Administrar ceftriaxona
- d) Intubar e iniciar ventilación mecánica
- e) Disminuir el aporte de oxígeno a 24%

6) Una mujer de 34 años, cursando su primer embarazo de 36 semanas, refiere salida de abundante líquido por los genitales, no asociado a otros síntomas. A la especuloscopia vaginal no se observa salida de líquido por el orificio cervical externo, al tacto vaginal se palpa cuello sin dilatación, de localización posterior y duro, sin borramiento. Se realiza ecografía abdominal que muestra oligoamnios. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Indicar antibióticos profilácticos y mantener conducta expectante
- b) Inducir parto con misoprostol
- c) Realizar cesárea
- d) Inducir parto con oxitocina
- e) Solicitar perfil biofísico para tomar conducta definitiva

7) El programa nacional de inmunizaciones existe en nuestro país desde el año 1978 y está orientado a la prevención de enfermedades prevalentes y que son un problema de salud pública. Además de las vacunas obligatorias existen otras que pueden ser utilizadas de forma voluntaria y pagadas de forma particular, en este contexto se encuentra la vacuna del rotavirus. Al respecto, ¿Qué ha demostrado esta vacuna?

- a) Disminuir la letalidad de la infección por rotavirus
- b) Provee inmunidad hasta los 24 meses contra el rotavirus
- c) Disminuye la tasa de hospitalizaciones secundarias a infección por rotavirus
- d) Disminuye la tasa de contagiosidad de la infección por rotavirus
- e) Disminuye la sintomatología durante la infección por rotavirus

8) Una paciente de 55 años, con antecedente de daño hepático crónico por virus hepatitis C, consulta por cuadro de malestar general, asociado a febrículas, confusión y aumento de perímetro abdominal. Al examen abdominal destaca matidez desplazable. Se realiza paracentesis diagnóstica que muestra transudado y presencia de 300 leucocitos (100% polimorfonucleares). La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Administrar albúmina endovenosa
- b) Realizar paracentesis evacuadora
- c) Observar
- d) Administrar antibióticos de forma empírica
- e) Iniciar terapia con furosemida y espironolactona

9) Recién nacido de 10 días de vida, sin antecedentes perinatales, inicia desde hace 5 horas cuadro caracterizado por fiebre cuantificada hasta 39°C asociada a rechazo alimentario e hiporreactividad, sin otros síntomas. Su examen físico resulta normal. Se solicita bioquímica de orina que muestra leucocitos ++. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Solicitar sedimento de orina y decidir conducta según resultados
- b) Hospitalizar para estudio y manejo
- c) Indicar antipiréticos orales y control en dos días
- d) Indicar antibióticos vía oral y control en dos días
- e) Solicitar ecografía renal y vesical

10) Una paciente de 65 años, con antecedente de accidente vascular encefálico con compromiso faciobraquiocrural derecho hace dos años en tratamiento con aspirina, consulta por dolor abdominal difuso e intenso de inicio agudo. Al examen físico se encuentra en regulares condiciones, ritmo irregular, abdomen levemente doloroso a la palpación profunda, blumberg (-). El diagnóstico más probable es:

- a) Isquemia mesentérica
- b) Disección aórtica
- c) Úlcera perforada
- d) Diverticulitis aguda
- e) Trombosis mesentérica

11) Se desea implementar un método de screening para una enfermedad. El nuevo examen debe ser capaz de detectar la enfermedad en el periodo:

- a) Entre los cambios tisulares y la aparición clínica
- b) Posterior a la aparición clínica de la enfermedad
- c) Previo a los primeros cambios bioquímicos
- d) Entre los cambios bioquímicos y los cambios tisulares
- e) De remisión

12) Paciente de 70 años, con antecedentes de diabetes e hipertensión en tratamiento, con historia de dolor torácico que aparece al esfuerzo y cede espontáneamente, la cual se desencadena cada vez con menor esfuerzo, no asociado a otros síntomas. Actualmente se encuentra asintomático y su examen físico muestra ritmo regular en dos tiempos sin soplos, murmullo pulmonar presente sin ruidos asociados. Se realiza ECG que muestra ritmo regular y QRS ancho compatible con bloqueo completo de rama izquierda. El examen más adecuado para continuar el estudio de este paciente es:

- a) Test de esfuerzo
- b) Ecocardiografía de estrés
- c) Enzimas cardíacas
- d) AngioTAC
- e) Coronariografía

13) La medida que mejor estima la diferencia de riesgo entre un grupo expuesto y otro no expuesto a un factor de riesgo en una misma población es:

- a) Riesgo atribuible
- b) Odds Ratio
- c) Riesgo Relativo
- d) Incidencia acumulada
- e) Razón de incidencias

14) Un paciente de 65 años, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril y diabetes mellitus en tratamiento con metformina y glibenclámda, presenta desde hace 3 meses y en forma progresiva, poliaquiuria y nicturia, asociado a latencia, chorro miccional doble y débil. Al examen físico se palpa próstata aumentada de tamaño de consistencia gomosa. Se solicita antígeno prostático que resulta en 3,5ng/ml. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Realizar prostatectomía vía resección transuretral
- b) Realizar prostatectomía por vía retropúbica
- c) Indicar alfa agonista
- d) Indicar inhibidor de la 5 alfa reductasa
- e) Indicar análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas

15) Una paciente de 16 años de edad, con cuadro caracterizado por polidipsia y poliuria desde hace aproximadamente 3 semanas, no asociado a otros síntomas. Se realizan exámenes donde destaca osmolaridad plasmática disminuida, por lo que se solicita test de la sed que muestra normalización de diuresis y osmolaridad plasmática. El diagnóstico más probable es:

- a) Polidipsia psicógena
- b) Diabetes insípida nefrogénica
- c) Diabetes insípida central
- d) Hipercalcemia
- e) Diabetes mellitus tipo 1

16) Mujer de 29 años, cursando embarazo de 33 semanas, consulta por presentar metrorragia escasa en una oportunidad no asociado a otros síntomas. Al examen físico no se aprecia sangre proveniente del orificio cervical externo, resto normal. Se realiza registro basal no estresante que resulta reactivo. El diagnóstico más probable en este caso es:

- a) Rotura de vasa previa
- b) Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera
- c) Placenta previa
- d) Rotura uterina
- e) Sinusorragia

17) Paciente de 23 años, sin antecedentes, con cuadro de 2 semanas de rinorrea y coriza, que durante los últimos dos días se asocia a compromiso del estado general, sensación febril, tos con expectoración mucopurulenta y disnea. Al examen físico presenta signos vitales dentro de rangos normales, murmullo pulmonar presente en ambos campos pulmonares asociado a crepitaciones en base derecha. Se solicita una radiografía de tórax que muestra infiltrado intersticial en base derecha. El tratamiento de elección de esta patología es:

- a) Claritromicina
- b) Amoxicilina-ácido clavulánico
- c) Clindamicina
- d) Ceftriaxona
- e) Moxifloxacino

18) Embarazada de 30 semanas, sin antecedentes, consulta por lesiones eritematosas en antebrazos, genitales, manos y tronco, asociadas a prurito. Al examen físico se aprecian lesiones eritematosas pápulares y maculares en patrón sinuoso, con signos de grataje, por lo que se decide realizar un ácaro test, que resulta positivo. El tratamiento de elección, en este caso es:

- a) Permetrina oral
- b) Puvaterapia
- c) Corticoides locales
- d) Permetrina tópica al 5%
- e) Vaselina azufrada

19) Una paciente de 55 años, en quimioterapia por leucemia mieloide aguda, inicia desde hace algunas horas fiebre alta, cefalea y dolor al movimiento ocular, refiere haber estado en contacto con su hijo que cursaba con cuadro respiratorio alto. Se realiza exámenes donde destaca hemoglobina 8.5 mg/dL, leucocitos 1.000/mm³ (10% neutrófilos 90% linfocitos) y plaquetas 80.000/mm³. La conducta más adecuada frente a esta paciente es:

- a) Indicar manejo sintomático
- b) Indicar Ceftazidima con amikacina endovenosas
- c) Indicar anfotericina B endovenoso
- d) Indicar oseltamivir endovenoso
- e) Indicar aislamiento e iniciar ceftriaxona endovenosa

20) Un paciente de 40 años de edad, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión, asintomático, acude a control con perfil lipídico que muestra colesterol total 208, LDL 127, HDL 35, triglicéridos 230. El fármaco de elección para el tratamiento en este caso es:

- a) Ácido nicotínico
- b) Gemfibrozilo
- c) Ácidos grasos omega 3
- d) Colestiramina
- e) Atorvastatina

21) Un paciente de 6 años, con historia de que hace dos semanas presentó cuadro caracterizado por rinorrea, odinofagia y tos, el cual fue manejado adecuadamente. Actualmente consulta por presencia de sangrado de encías, sin otros síntomas. Al examen físico destaca en buenas condiciones generales, con petequias en tronco y extremidades, resto normal. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina 12 mg/dL, leucocitos 8.000/mm³ y plaquetas 10.000/mm³. El diagnóstico más probable es:

- a) Purpura trombocitopénico trombótico
- b) Hemofilia A
- c) Púrpura de Schonlein Henoch
- d) Purpura trombocitopénico inmune
- e) Enfermedad de Von Willebrand

22) Un paciente de 45 años, sin antecedentes, presenta cuadro de 3 semanas de evolución de cefalea y sensación febril que durante los últimos días se ha hecho más intensa, asociado a dolor cervical. Al examen físico destaca leve rigidez de nuca y parálisis del IV par craneano derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Meningitis tuberculosa
- b) Meningoencefalitis por enterovirus
- c) Meningoencefalitis herpética
- d) Meningitis bacteriana
- e) Meningitis por hongos

23) Una paciente de 36 años, sin antecedentes, consulta porque desde hace tres meses ha presentado varios episodios caracterizados por taquicardia, sudoración, dificultad para respirar, náuseas y sensación de muerte que tienen una duración de 30 minutos máximo y que ceden espontáneamente, por lo cual está muy preocupada, ya que dos de ellos le ocurrieron cuando se encontraba en una cafetería. Refiere que hace tres meses su pareja le pidió el divorcio en un restaurant, tras lo cual, intenta no salir de su hogar por miedo a que algo le ocurra y nadie la ayude. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno por ansiedad social
- b) Trastorno adaptativo
- c) Trastorno por estrés post traumático
- d) Agorafobia
- e) Trastorno de ansiedad

24) Una paciente de 30 años, usuaria de anticonceptivos orales, consulta por cuadro de 8 días de sudoración, palpitaciones e insomnio, que durante los últimos días se ha asociado a dolor en región cervical anterior. Al examen físico se aprecia con frecuencia cardíaca de 100 por minuto, presión arterial 140/90, dolor a la palpación cervical. Se solicitan exámenes donde destaca T4 y T4L aumentadas y TSH suprimida, electrocardiograma normal. El tratamiento de elección en este caso es:

- a) Propiltiouracilo
- b) Paracetamol
- c) Metimazol
- d) Ketoprofeno
- e) Enalapril

25) Una mujer de 27 años, nulípara, usuaria de anticonceptivos orales por seis años, consulta por amenorrea de cinco meses de evolución, no asociado a otros síntomas. Su examen físico es normal. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Solicitar niveles de prolactina, tiotropina, hormona folículoestimulante y estrógenos
- b) Solicitar prueba de estrógeno y progesterona
- c) Indicar anticonceptivos orales combinados
- d) Observar evolución por un año
- e) Indicar uso de agonistas de las gonadotrofinas y controlar en un mes

26) Un paciente de 20 años, con antecedente de gastroenteritis aguda hace dos semana, consulta por dolor en tobillo derecho desde hace 1 día. Refiere haber presentado molestias similares hace una semana en rodilla y pie izquierdo. Al examen físico destaca tobillo derecho con eritema leve, sin otros hallazgos. El diagnóstico más probable en este caso es:

- a) Artritis por cristales
- b) Artritis por stafilococo aureus
- c) Artritis por neisseria gonorrhoeae
- d) Artritis reactiva
- e) Artritis reumatoídea juvenil

27) Un lactante de un mes, sin antecedentes perinatales, es traído por presentar ictericia, sin otros síntomas. Al examen físico destaca ictericia que llega hasta los muslos, resto normal. Su desarrollo psicomotor ha sido normal, al igual que su crecimiento y alimentación. Al preguntar dirigidamente, su madre refiere que también ha presentado orinas oscuras. El examen de elección frente a este paciente es:

- a) Ecografía abdominal
- b) Hormona estimuladora de tiroides
- c) Resonancia magnética abdominal
- d) Test de coombs
- e) Bilirrubinemia diferenciada

28) Hombre de 18 años, sin antecedentes, con cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, tos y coriza, que durante el último día se ha asociado a prurito generalizado. Al examen físico destaca presencia de lesiones papulares y vesículas muy pruriginosas en tronco y extremidades, no asociado a otros hallazgos. El tratamiento de elección en este caso es:

- a) Clorfenamina oral
- b) Aspirina oral
- c) Aciclovir oral
- d) Vacuna contra virus herpes 3
- e) Inmunoglobulina G no específica

29) Durante el año 2012 en Chile se presentaron 60 casos de meningitis causadas por la Neisseria Meningitidis serotipo W135, de los cuales 20 fallecieron por causa atribuible a esta enfermedad. Por lo tanto la letalidad de la N.Meningitidis serotipo W135 durante el 2013 fue:

- a) 25%
- b) 66%
- c) 50%
- d) 33%
- e) 75%

30) Paciente de 65 años de edad, fumador de 40 paquetes/año, consulta por disnea progresiva asociada a tos con expectoración escasa mucosa. Al examen físico se aprecia disminución de murmullo pulmonar en base pulmonar izquierda. Se solicita radiografía de tórax que muestra derrame pleural en lado izquierdo, el cual se punciona mostrando LDH 250 mg/dL, 300 leucocitos (95% mononucleares) y ADA en 25. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia Cardíaca
- b) Derrame pleural maligno
- c) Tuberculosis
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Enfermedad del tejido conectivo

31) Un paciente de 45 años, sin antecedentes, consulta por dolor epigástrico intenso asociado a vómitos biliosos. Al examen físico se encuentra frecuencia cardíaca en 90 por minuto, presión arterial 140/90, escleras levemente ictericas, abdomen blando, doloroso a palpación epigástrica, blumberg (-). Se solicitan exámenes que muestran GOT 100mg/dL, GPT 110mg/dL, bilirrubina total 2 mg/dL, fosfatasas alcalinas 350mg/dL, lipasa 250mg. Ecografía abdominal que muestra vesícula de paredes delgadas, sin edema, con barro biliar visible y colédoco de 8mm. El diagnóstico más probable es:

- a) Colangitis aguda
- b) Pancreatitis aguda
- c) Coledocolitiasis
- d) Colecistitis aguda
- e) Cólico biliar simple

32) Una paciente de 28 años tiene relaciones amorosas muy intensas, se viste muy provocativa y es muy coqueta, lo que le ha traído problemas con sus pares a las que ella las llama “envidiosas”. Durante la entrevista es muy exagerada al contar sus problemas. El trastorno de la personalidad más probable en este caso es:

- a) Narcisista
- b) Límitrofe
- c) Histriónico
- d) Dependiente
- e) Antisocial

33) Mujer de 29 años, sin antecedentes, con cuadro de tres semanas de dolor abdominal intermitente, de intensidad moderada, asociado a deposiciones con sangre en ocasiones y disentería. Al examen físico se aprecia levemente deshidratada, con dolor a la palpación abdominal profunda, blumberg (-). El diagnóstico más probable es:

- a) Colitis ulcerosa
- b) Giardiasis
- c) Divertículo de Meckel
- d) Colitis isquémica
- e) Enfermedad de Crohn

34) Una paciente de 23 años, nulípara, consulta por presentar metrorragia desde ayer, no asociado a otros síntomas. Se realizó prueba de embarazo en orina que resultó positiva. Al examen físico se aprecia sangre proveniente del orificio cervical externo. Se realiza ecografía transvaginal que muestra útero sin alteraciones y una masa anexial derecha solidocística de tres centímetros de diámetro. Además se solicitan niveles de gonadotropina coriónica que se encuentran en 700 mUI/mL. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Indicar tratamiento con metotrexato
- b) Controlar con niveles de gonadotropina coriónica y ecografía transvaginal en 48 horas
- c) Controlar con nueva ecografía transvaginal en siete días
- d) Hospitalizar y realizar salpingectomía derecha
- e) Indicar reposo y controlar con niveles de gonadotropina coriónica y ecografía transvaginal en siete días

35) Un paciente de 55 años, diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina 2000mg al día, glibenclamida 15mg al día y enalapril 20mg al día, acude a control con exámenes, donde destaca glicemia de ayuno de 180mg/dL y hemoglobina glicosilada de 8,8%. Se ha mantenido sin síntomas y su examen físico es normal. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Aumentar dosis de glibenclamida
- b) Aumentar dosis de metformina
- c) Iniciar insulina
- d) Reemplazar metformina con rosiglitazona
- e) Reemplazar glibenclamida con sitagliptina

36) Paciente embarazada de 26 semanas, bien controlada, consulta por cuadro de una semana de sensación de hormigueo en ambas manos de predominio nocturno, mayor en lado derecho, sin otros síntomas. Al examen físico destaca parestesia en ambas manos al mantener muñecas flexionadas por 20 segundos. El diagnóstico más probable:

- a) Mielopatía cervical
- b) Polimiositis
- c) Miastenia gravis
- d) Atrapamiento del nervio cubital
- e) Atrapamiento del nervio mediano

37) Paciente de 60 años con antecedente de hipertensión sin tratamiento, consulta por cuadro de un mes de palpitaciones asociado a disnea ocasional. Al ingreso se realiza electrocardiograma que muestra:



- a) Flutter auricular
- b) Taquicardia sinusal
- c) Fibrilación auricular
- d) Taquicardia auricular multifocal
- e) Taquicardia ventricular

38) Una paciente de 23 años, sin antecedentes, consulta muy preocupada porque desde hace un mes ha presentado en cuatro oportunidades cuadros de inicio agudo caracterizados por dolor torácico intenso, asociados a cefalea, mareos, parestesias y disnea, los cuales tienen una duración aproximada de una hora y ceden espontáneamente. Al preguntarle de forma dirigida, desconoce que puede desencadenar estas crisis. Trae electrocardiograma que le habrían tomado en el servicio de urgencias cuando consultó por una crisis el cual se aprecia normal. Los fármacos de elección para el tratamiento de esta paciente son:

- a) Fluoxetina y carbamazepina
- b) Amitriptilina y clonazepam
- c) Citalopram y risperidona
- d) Sertralina y diazepam
- e) Paroxetina y lamotrigina

39) Un paciente de 18 años, sin antecedentes, consulta por dolor en flanco izquierdo de 1 hora de evolución tipo cólico e irradiado a genitales, sin otros síntomas. Su examen físico es normal. Se solicita sedimento de orina muestra 50 eritrocitos por campo, sin dismorfia. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

- a) Tomografía axial computada con contraste
- b) Pielografía de eliminación
- c) Radiografía de abdomen
- d) Ecografía abdominal
- e) Tomografía axial computada sin contraste

40) Una mujer de 75 años, sufre caída a nivel presentando fractura de cuello femoral, por lo que se realiza prótesis total de cadera. Luego de la cirugía comienza a hablar incoherencias, se agita, se vuelve agresiva y además presenta desorientación temporoespacial. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el manejo de esta paciente?

- a) Risperidona v.o
- b) Haloperidol e.v
- c) Diazepam i.m
- d) Lorazepam e.v
- e) Midazolam e.v

41) Paciente de 3 años de edad, previamente sano, hace dos días inicia cuadro caracterizado por fiebre intensa, cuantificada hasta 39°C, no asociado a otros síntomas. Su madre le administra acetaminofeno por vía oral durante el primer día, tras lo cual evoluciona con disminución de la fiebre y hoy amanece con exantema maculopapular no pruriginoso, sin fiebre y en buenas condiciones. El agente etiológico más probable es:

- a) Citomegalovirus
- b) Virus Epstein barr
- c) Virus Herpes 6
- d) Parvovirus B19
- e) Enfermedad de Still

42) Durante el año 2012 hubo una natalidad en Chile de 13.9 por cada 1000 habitantes y en Estados Unidos de 12.5 por cada 1000 habitantes. Se desean comparar ambos índices, ¿Cuál de los siguientes parámetros es más útil para este propósito?

- a) Razón
- b) Proporción
- c) Número absoluto
- d) Índice
- e) Tasa

43) Paciente de 65 años, con antecedente de tabaquismo crónico de 30 paquetes/año, consulta por cuadro de 3 meses de compromiso del estado general, pirosis y baja de peso de 10 kg. Al examen físico se aprecia decaído, deshidratado y muy enflaquecido, con leve edema en extremidades inferiores simétrico. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer pulmonar
- b) Cáncer gástrico
- c) Cáncer de esófago
- d) Cáncer de páncreas
- e) Cáncer de duodeno

44) Embarazada de 37 semanas, primigesta, presenta contracciones uterinas desde hace dos horas, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se constata dinámica uterina de dos contracciones en 10 minutos y auscultación de latidos cardiorfetales normal. Se realiza tacto vaginal donde se aprecia borramiento del 100% y tres centímetros de dilatación. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Realizar cesárea
- b) Administrar tocolíticos
- c) Indicar antibióticos y corticoides
- d) Conducir trabajo de parto
- e) Solicitar perfil biofísico

45) Paciente de 25 años, deportista, corre una triatlón, luego de esta competencia, para evaluación de dopaje se realiza examen de orina, el cual muestra proteinuria ++, sin presencia de drogas.

¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de su proteinuria?

- a) Proteinuria funcional
- b) Rabdomiolisis
- c) Deshidratación
- d) Acidosis metabólica
- e) Glomerulopatía membranosa

46) Un paciente de 50 años, sin antecedentes, presenta cefalea de inicio súbito mientras hacía deporte, asociado a dolor en la zona cervical posterior y dorsal. Al examen físico presenta reflejo fotomotor conservado, signos meníngeos presentes, fuerza y sensibilidad disminuidas en hemicuerpo izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemorragia subaracnoidea
- b) Hematoma epidural
- c) Hematoma subdural
- d) Hemorragia cerebral intraparenquimatosa
- e) Accidente vascular isquémico

47) Un paciente de 26 años, estudiante universitario con regular rendimiento, es traído por sus padres porque desde hace tres meses no ha asistido a clases, ya que prefiere quedarse en su habitación. Ellos refieren que siempre fue solitario y que no buscaba tener amistades. Al entrevistarlos de forma dirigida se ríe sin motivo y refiere que no quiere salir de su habitación porque la voz del diablo lo amenaza. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno delirante crónico
- b) Trastorno de la personalidad esquizoide
- c) Delirium
- d) Esquizofrenia hebefrénica
- e) Trastorno Bipolar

48) Un niño de 6 años, es traído por presentar cuadro de dos días de evolución de diarrea acuosa frecuente, asociado a vómitos, rechazo alimentario y decaimiento. Al examen físico se encuentra somnoliento, frecuencia cardíaca de 110 por minuto, presión arterial de 80/50 mmHg y ojos hundidos. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Indicar suero glucosalino endovenoso en infusión continua
- b) Indicar sales de rehidratación oral 200ml luego de cada deposición
- c) Indicar sales de rehidratación oral 100 ml por kilogramo a beber en 4 horas y luego reevaluar
- d) Indicar suero fisiológico 20ml por kilogramo a pasar en bolo
- e) Indicar alimentación normal, con abundantes líquidos y control en 48 horas

49) Paciente de 60 años, fumadora de 30 paquetes año, consulta por compromiso del estado general y baja de peso. Su examen físico es normal, se solicita radiografía de tórax que muestra lo siguiente:



La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Solicitar TAC de tórax
- b) Realizar punción transpleural
- c) Instalar tubo pleural con trampa de agua
- d) Realizar toracocentesis diagnóstica
- e) Realizar broncoscopia rígida

50) Una paciente de 38 años, cursando embarazo de 36 semanas, consulta por cuadro de una hora de evolución caracterizado por epigastralgia asociada a cefalea, sin otros síntomas. En el examen físico presenta dolor a la palpación de hipocondrio derecho, asociado a exaltación de los reflejos osteotendíneos. Al tacto vaginal se palpa cuello duro y posterior. Se auscultan latidos cardíofetales con variabilidad francamente disminuida. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Realizar cesárea de urgencia
- b) Inducir con oxitocina
- c) Inducir con misoprostol
- d) Lateralizar a izquierda
- e) Hospitalizar y esperar a las 37 semanas para realizar interrupción

51) Una paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes mellitus ambas en tratamiento farmacológico, consulta por dolor en hombro derecho de varios meses de evolución, el cual aumenta de intensidad en la noche, asociado a impotencia funcional. Al examen físico sin dolor a la movilización pasiva y con dolor a la abducción y rotación externa de hombro derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Tendinopatía bicipital
- b) Osteoartritis de hombro
- c) Tendinopatía deltoidea
- d) Tendinopatía del manguito rotador
- e) Disyunción acromioclavicular leve

52) Lactante de 6 meses, es traída por cuadro de 48 horas de evolución caracterizado por rechazo alimentario, irritabilidad y decaimiento, asociado a inmovilidad de extremidad inferior izquierda. Al examen se encuentra con temperatura de 38,5°C y se aprecia cadera izquierda en flexión, con mucho dolor a la movilización. El examen inicial más adecuado en este caso es:

- a) Hemograma con VHS
- b) Radiografía de pelvis
- c) Ecografía de cadera
- d) Cintigrafía ósea
- e) Resonancia magnética de cadera

53) Un paciente de 65 años, diabético en tratamiento con esquema intensificado de insulina, presenta desde hace unas semanas úlcera en zona plantar derecha, asociado a secreción purulenta. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones y afebril, se aprecia úlcera bajo la articulación metatarsofalángica del primer dedo derecho, con compromiso de piel, tejido subcutáneo y tendones, sin signos de compromiso óseo ni articular. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Antibióticos vía oral y curaciones ambulatorias
- b) Angiografía
- c) Amputación abierta
- d) Amputación cerrada
- e) Antibióticos endovenosos y debridación quirúrgica

54) Una paciente de 50 años consulta por dolor ocular izquierdo de inicio agudo, asociado a visión borrosa. Al examen físico destaca ojo rojo periquerático y pupila midriática arreactiva, la agudeza visual es de 0,6 en ojo izquierdo y 1 en ojo derecho. El diagnóstico más probable en este caso es:

- a) Uveítis aguda
- b) Endoftalmitis
- c) Queratitis aguda
- d) Escleritis
- e) Glaucoma agudo

55) Un paciente de 65 años, con cuadro de compromiso del estado general de tres meses de evolución asociado a nicturia y en las últimas semanas dolor lumbar. Al examen físico destaca paciente enflaquecido, piel seca y mucosas pálidas. Se solicitan exámenes de orina que muestra proteinuria ++, urocultivo negativo, 2-3 glóbulos rojos por campo, creatinina 1,8mg/dL y antígeno prostático de 5,5 (VN <4). Además se realiza ecografía renal que muestra dos quistes renales en lado derecho, sin otros hallazgos. El diagnóstico más probable en este caso es:

- a) Mieloma múltiple
- b) Cáncer prostático metastásico
- c) Cáncer renal metastásico
- d) Espondilodiscitis crónica
- e) Espondilolistesis

56) Un paciente de 8 años de edad, con historia de un año de evolución de rinorrea mucopurulenta bilateral intermitente asociado a prurito y en algunas ocasiones a epistaxis, actualmente sin síntomas. El tratamiento de elección en este caso es:

- a) Antihistamínicos orales
- b) Antibióticos orales
- c) Corticoides tópicos
- d) Derivar a cirugía de adenoides
- e) Oximetazolina tópica

57) Se realiza un estudio donde se desea estudiar los factores de riesgos asociado al lupus, por esto se seleccionan dos grupos, uno de ellos con pacientes diagnosticadas de lupus y el otro de características demográficas similares pero sanos. ¿A qué tipo de estudio corresponde el diseño mencionado anteriormente?

- a) Cohorte prospectivo
- b) Prevalencia
- c) Caso control
- d) Ensayo clínico controlado
- e) Estudio ecológico

58) Paciente de 20 años de edad, sin antecedentes, con coriza, tos y odinofagia desde hace dos días manejadas con ibuprofeno, paracetamol y clorfenamina, consulta por aparición de hematuria el día de hoy, asociado a los síntomas antes descritos. Al examen físico presenta presión arterial de 120/70, frecuencia cardíaca normal, resto sin hallazgos patológicos. Se solicita examen de orina que muestra: glóbulos rojos 40-50 por campo con 20% de dismorfismo y cilindros hemáticos. El diagnóstico más probable es:

- a) Glomerulonefritis post estreptocócica
- b) Glomerulonefritis lúpica
- c) Glomerulonefritis mesangial
- d) Glomerulonefritis por IgA
- e) Glomerulonefritis por drogas

59) Una pareja joven consulta por infertilidad, refieren que llevan 15 meses intentando tener hijos pero no han tenido resultado, ambos no tienen hijos anteriormente. El hombre trae consigo espermiograma que se realizó hace dos semanas que está normal. Ella nunca ha utilizado anticonceptivos orales y refiere ciclos menstruales normales, su examen físico resulta normal. El examen de elección para continuar el estudio de infertilidad en este caso es:

- a) Repetir espermiograma
- b) Test post coital
- c) Laparoscopia
- d) Histeroscopia
- e) Histerosalpingografía

60) Paciente de 70 años, con antecedente de EPOC tabáquico, presenta cuadro de 3 meses de aumento de su disnea basal asociado a palpitaciones. Al examen físico destaca frecuencia cardíaca de 100 por minuto, ritmo cardíaco irregular con ausencia de soplos y murmullo pulmonar presente con roncus y sibilancias difusas. Se realiza electrocardiograma que muestra ausencia de onda "p", de forma irregular y presencia de QRS angosto. ¿Cuál de los siguientes fármacos estará contraindicado para el manejo de este paciente?

- a) Verapamilo
- b) Lanantósido C
- c) Losartán
- d) Amiodarona
- e) Carvedilol

61) Un paciente de 13 meses, es traído por presentar desde hace 4 días cuadro caracterizado por crisis de tos que aparecen de forma repetitiva durante el día, asociado a decaimiento, rechazo alimentario, náuseas y vómitos. Al examen físico se aprecia hemorragia subconjuntival derecha, examen pulmonar con murmullo pulmonar presente, sin otros hallazgos. El agente etiológico más probable en este caso es:

- a) Virus respiratorio sincicial
- b) Virus parainfluenza
- c) Mycoplasma
- d) Bordetella pertusis
- e) Virus sarampión

62) Una paciente de 18 años, sin antecedentes, consulta por cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, coriza y odinofagia. Al examen físico destacan amígdalas aumentadas de tamaño con exudado blanquecino adherente, adenopatías cervicales, examen pulmonar normal y abdominal con hepatoesplenomegalia. Se solicitan exámenes que muestran lo siguiente: IgM VCA (+), IgG VCA (-), IgM CMV (-), IgG CMV (+), ELISA VIH (-). El diagnóstico más probable es:

- a) Primoinfección por VIH
- b) Mononucleosis por Citomegalovirus
- c) Mononucleosis por Virus Epstein Barr
- d) Síndrome mononucleósico por estreptococo pyogenes
- e) Síndrome mononucleósico por leucemia aguda

63) Una paciente de 16 años, sin antecedentes, es traída por no presentar aún menarquia, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia talla de 1.53 metros y desarrollo puberal tanner 1, sin otros hallazgos. Se realiza test de progesterona que resulta negativo. El diagnóstico más probable en este caso es:

- a) Anovulación
- b) Malformación uterina
- c) Hipopituitarismo
- d) Hipotiroidismo
- e) Síndrome de Turner

64) Paciente de 43 años, con historia de epigastralgia desde hace 3 semanas sin otros síntomas, como parte del estudio de su patología se realiza endoscopia digestiva alta que muestra gastritis erosiva, sin presencia de úlcera péptica activa y con test de ureasa positivo, por este motivo se indica tratamiento erradicador del helicobacter pylori. Tres horas luego del procedimiento, evoluciona con dolor torácico irradiado a hombro derecho y sensación febril. El examen de elección para confirmar el diagnóstico en este caso es:

- a) Radiografía de tórax
- b) Repetir endoscopia
- c) Tomografía axial computada de tórax
- d) Radiografía baritada de esófago-estómago-duodeno
- e) Electrocardiograma

65) Una paciente de 55 años, se lava las manos recurrentemente porque siente que se encuentran sucias, el hecho de no hacerlo rápidamente le provoca gran angustia. Esto le ha provocado dermatitis en sus manos, por lo cual está preocupada. Sabe que esta conducta no tiene sentido, pero no puede evitarlo. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de ansiedad
- b) Ansiedad específica
- c) Trastorno dismórfico corporal
- d) Trastorno disociativo
- e) Trastorno obsesivo compulsivo

66) Paciente de 66 años, hipertenso en tratamiento, consulta por cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, tos y coriza, síntomas que se han hecho más intensos en las últimas horas agregándose cefalea y mialgias intensas. Su examen físico muestra temperatura de 38,5°C, examen pulmonar sin alteraciones. El fármaco de elección para el manejo en este caso es:

- a) Acetaminofeno
- b) Oseltamivir
- c) Claritromicina
- d) Zanamivir
- e) Ibuprofeno

67) Un paciente de 7 años, con historia de 8 días de tos y coriza, sin otros síntomas, presenta desde hace 24 horas aumento de su tos asociado a expectoración mucopurulenta, dificultad respiratoria y sensación febril. Al examen físico se encuentra decaído, con temperatura de 38°C, su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente de forma bilateral, asociado a estertores y sibilancias difusas. El tratamiento de elección en este caso es:

- a) Claritromicina
- b) Amoxicilina
- c) Amoxicilina con ácido clavulánico
- d) Acetaminofeno y salbutamol
- e) Cefadroxilo

68) Un paciente de 16 años, sin antecedentes, consulta por dolor testicular que inició hace una hora, asociado a náuseas, vómitos y sudoración. Al examen físico se aprecia testículo derecho ascendido respecto al contralateral y escaso eritema circundante. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Realizar ecografía testicular
- b) Indicar doxiciclina y ciprofloxacino
- c) Indicar ketorolaco endovenoso y suspensión testicular
- d) Realizar exploración quirúrgica inmediata
- e) Solicitar exámenes generales, parámetros inflamatorios y sedimento de orina, luego decidir conducta según resultados

69) Una paciente de 48 años, consulta por episodios de calor y enrojecimiento de la cara y la zona superior del tórax, que duran algunos minutos y ceden espontáneamente, no ha presentado menstruación en los últimos doce meses. Su examen físico es normal. Refiere antecedente de hermana con cáncer de mama. ¿Cuál de los siguientes fármacos indicaría como terapia de reemplazo hormonal en esta paciente?

- a) Tibolona
- b) Estrógenos y progestágenos orales
- c) Estrógenos transdérmicos
- d) Tamoxifeno
- e) Venlafaxina

70) Una mujer de 50 años, sin antecedentes, presenta cuadro de dos meses de dolor en ambas manos asociados a rigidez matinal de 40 minutos de duración que disminuye con los movimientos. Al examen físico destaca eritema en articulaciones metacarpofalángicas de ambas manos, sin otros síntomas. Se solicita factor reumatoideo que resulta positivo y péptido citrulinado que resulta negativo. El tratamiento de elección para esta enfermedad es:

- a) Metotrexato
- b) Inmunoglobulina G no específica
- c) Antiinflamatorios no esteroideos
- d) Corticoides
- e) Hidroxicloroquina

71) Un paciente de 30 años, sin antecedentes, consulta por fatigabilidad asociada a disminución de peso desde hace tres meses. Al entrevistarle de forma dirigida refiere que hace tres meses tuvo una ruptura sentimental, por lo que desde entonces además de los síntomas mencionados ha estado con pena, insomnio y desconcentración. Su examen físico resulta normal y su índice de masa corporal es 22. El examen de elección para descartar causa orgánica en este caso es:

- a) Tirotropina
- b) VDRL
- c) Hemograma
- d) Creatinina y enzimas hepáticas
- e) Glicemia de ayuno

72) Un niño de 8 años, es traído por presentar mal olor axilar desde hace semanas, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia vello púbico escaso y testículos con volumen de 4cc. Su índice de masa corporal está en percentil 50 para su edad y sexo. El diagnóstico más probable es:

- a) Pubertad precoz central
- b) Pubertad precoz periférica
- c) Pubertad temprana
- d) Hiperplasia suprarrenal
- e) Adrenarquia temprana

73) Un paciente de 17 años, sin antecedentes, presenta desde hace 1 mes dolor en muslo izquierdo asociado a impotencia funcional. Al examen físico se palpa aumento de volumen en cara interna de muslo, de consistencia aumentada, sin otros hallazgos. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

- a) Tomografía axial computada sin contraste
- b) Ecotomografía
- c) Tomografía axial computada con contraste
- d) Radiografía
- e) Resonancia magnética

74) Una paciente de 25 años, cursando embarazo de 35 semanas, acude a control ginecológico asintomática. Su examen físico es normal. Se realiza ecografía donde se estima peso fetal en percentil 8 para su edad gestacional. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Realizar perfil biofísico
- b) Medición del flujo cerebral y umbilical
- c) Medición del flujo de arterias uterinas
- d) Realizar ecografías seriadas
- e) Interrupción del embarazo

75) Un paciente de 24 años, sin antecedentes, es traído porque desde que despertó en la mañana no puede movilizar sus cuatro extremidades, sin otros síntomas. Al examen físico se corrobora fuerza totalmente disminuida en todo su cuerpo, sensibilidad normal, reflejos osteotendíneos presentes y simétricos. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Guillain Barré
- b) Miastenia Gravis
- c) Botulismo
- d) Lesión medular cervical
- e) Parálisis periódica hipokalémica

76) Un paciente de 10 años, es traído por cuadro de 2 días de odinofagia, asociado a tos seca y rinorrea, que durante el primer día se asoció a sensación febril. Al examen físico se encuentra con temperatura de 36,8°C, faringe eritematosa, amígdalas aumentadas de tamaño con escaso exudado blanquecino, examen cardiopulmonar normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Amigdalitis pultácea
- b) Influenza
- c) Rinofaringitis aguda
- d) Coqueluche
- e) Adenovirus

77) Paciente de 67 años, con antecedente de pielonefritis tratada hace dos meses, presenta dolor lumbar desde hace un mes que se ha ido intensificando, asociándose a sensación febril durante los últimos días. Al examen físico presenta temperatura de 38°C y dolor a la palpación de zona lumbar media. Se solicita radiografía lumbar que muestra aplastamiento de L2 y L3, asociados a imagen radiolúcida alrededor del disco intervertebral. El diagnóstico más probable es:

- a) Osteosarcoma
- b) Pielonefritis aguda
- c) Osteoma osteoide
- d) Espondilodiscitis
- e) Espondilolistesis

78) Paciente de 76 años, con antecedentes de HTA en tratamiento, es hospitalizado por neumonía requiriendo antibióticos endovenosos. Estando hospitalizado comienza con desorientación temporoespacial, inatención y pensamiento desorganizado, de curso fluctuante durante el día. El diagnóstico más probable es:

- a) Demencia senil
- b) Demencia frontotemporal
- c) Esquizofrenia
- d) Trastorno delirante crónico
- e) Delirium

79) Una paciente de 43 años, sin antecedentes, consulta por aparición de nódulo mamario, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se palpa nódulo pequeño, no adherido, de consistencia gomosa, sin presencia de adenopatías axilares. Se realiza mamografía inicialmente que es informada como BIRADS 0, por lo que se solicita ecografía mamaria que muestra un nódulo sólido de bordes regulares, con paredes lisas de dos milímetros. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Control con mamografía anual
- b) Realizar biopsia estereotáxica
- c) Realizar tumorectomía con biopsia rápida
- d) Indicar estrógenos orales y controlar al año con nueva ecografía
- e) Control con ecografía en seis meses

80) Desde el año 2005 existe la ley que obliga a los automovilistas a utilizar el cinturón de seguridad con el objetivo de disminuir traumatismos asociados a accidentes. Con respecto a esta ley, en términos de prevención, corresponde a:

- a) Prevención primaria
- b) Promoción de salud
- c) Prevención secundaria
- d) Prevención terciaria
- e) Control sanitario

81) Un paciente de 34 años, sin antecedentes, sufre caída mientras subía una escalera, resultando con golpe en su rostro, al ingreso se en buenas condiciones generales, pero con epistaxis. Se realiza especuloscopia nasal donde se aprecia engrosamiento septal bilateral y epistaxis anterior. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Drenaje por punción
- b) Observar y controlar en 2 semanas
- c) Drenaje quirúrgico urgente
- d) Antibióticos endovenosos
- e) Taponamiento nasal bilateral

82) Paciente de 43 años de edad, con antecedente de migraña en tratamiento con propranolol, consulta por historia de dolor torácico opresivo de 20 minutos, irradiado a miembro superior izquierdo, el cual cede espontáneamente, refiere que ha presentado dicho cuadro en dos ocasiones en su hogar luego de regresar del trabajo. Actualmente está asintomático y su examen físico es normal. Se solicita electrocardiograma que no muestra alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Infarto agudo al miocardio
- b) Pericarditis aguda
- c) Angina vasomotora
- d) Espasmo esofágico
- e) Tromboembolismo pulmonar

83) Lactante de 4 meses de edad, sin antecedentes conocidos, alimentado con lactancia materna de forma exclusiva, es traído por presentar bajo incremento ponderal, asociado a cansancio al alimentarse y decaimiento. Se aprecia decaído, saturación arterial de 90%, examen cardiaco con ritmo regular en dos tiempos, con presencia de soplo sistólico, y pulmonar que muestra murmullo pulmonar disminuido en bases, asociado a crepitaciones finas bilaterales. El manejo inicial más adecuado en este caso es:

- a) Administrar furosemida endovenosa
- b) Administrar vasodilatadores endovenosos
- c) Administrar epinefrina endovenosa
- d) Realizar intubación endotraqueal y ventilación mecánica
- e) Administrar betabloqueadores endovenosos

84) Un paciente de 40 años, sin antecedentes, con cuadro de disforia y anhedonia desde hace tres semanas, momento en el cual fue despedido de su trabajo, además presenta apetito disminuido, baja de peso e insomnio. Al entrevistarle de forma dirigida refiere que siente que no vale nada y no ha presentado intentos ni ideas suicidas. El tratamiento de elección en este caso es:

- a) Venlafaxina
- b) Amitriptilina
- c) Clonazepam
- d) Escitalopram
- e) Bupropion

85) Un paciente de 3 años, sin antecedentes, con cuadro de rinofaringitis viral de dos días de evolución en tratamiento sintomático, es traído por presentar desde hace unas horas mayor compromiso del estado general, asociado a otalgia intensa izquierda y sensación febril. Al examen físico destaca examen cardiopulmonar normal y a la otoscopia se aprecia tímpano izquierdo eritematoso y abombado con escasa secreción purulenta. El fármaco de elección en este caso es:

- a) Ibuprofeno oral
- b) Amoxicilina oral
- c) Amoxicilina con ácido clavulánico oral
- d) Gentamicina tópica
- e) Claritromicina oral

86) Una paciente de 70 años, diabética en tratamiento farmacológico y con obesidad, consulta por lesiones en el tórax, asociadas a prurito. Al examen físico de pliegues mamarios se encuentran lesiones eritematosas asociadas a rezumación con pequeñas pústulas blancas. El diagnóstico más probable es:

- a) Acrocordones
- b) Intertrigo candidiásico
- c) Impétigo buloso
- d) Tiña corporis
- e) Psoriasis

87) Un paciente de 50 años, sin antecedentes, acude a realizarse un chequeo, asintomático. Su examen físico es normal. Trae exámenes que se habría tomado la semana pasada donde destaca hemoglobina 14 mg/dL, leucocitos 7.000/mm³, plaquetas 230.000/mm³, creatinina 0.8 mg/dL, calcio 11, albúmina 4, electrocardiograma normal. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Mantener control ambulatorio anual
- b) Solicitar cintigrafía ósea
- c) Solicitar radiografía de huesos largos y huesos parietales
- d) Solicitar niveles de paratohormona
- e) Solicitar electroforesis de proteínas

88) Una paciente de 26 años, sin antecedentes, consulta por secreción vaginal asociada a prurito. Al examen físico se aprecia liquenificación y signos de grataje a nivel vulvar, a la especuloscopia se aprecia leucorrea blanquecina. El fármaco de elección para el manejo en este caso es:

- a) Metronidazol
- b) Fluconazol
- c) Miconazol
- d) Doxiciclina
- e) Ceftriaxona

89) Paciente de 17 años, sin antecedentes, es traído a la urgencia por presentar síncope mientras realizaba ejercicio, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia soplo sistólico que aumenta con maniobras de Valsalva, sin otros hallazgos. Se estudia con electrocardiograma que muestra onda Q presente en DII, DIII y AVF, además S profunda de V1 a V3. El diagnóstico más probable es:

- a) Miocardiopatía dilatada
- b) Lipotimia
- c) Soplo fisiológico
- d) Miocardiopatía hipertrófica
- e) Estenosis mitral

90) Un paciente de 12 años, consulta por cuadro caracterizado por de visión de destellos hace una hora, tras lo cual evolucionó con cefalea frontotemporal intensa, de tipo pulsátil, asociado a fotofobia y fonofobia. Refiere que desde los cinco años ha presentado cuadros similares, y que durante el último año ha presentado cinco episodios. El diagnóstico más probable es:

- a) Migraña clásica
- b) Cefalea en racimos
- c) Cefalea tensional
- d) Migraña complicada
- e) Tumor cerebral

Nombre: _____

RUT: _____

1. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
16. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
17. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
18. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
19. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
20. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
21. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
22. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
23. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
24. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
25. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
26. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
27. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
28. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
29. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
30. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

31. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
32. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
33. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
34. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
35. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
36. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
37. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
38. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
39. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
40. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
41. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
42. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
43. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
44. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
45. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
46. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
47. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
48. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
49. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
50. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
51. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
52. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
53. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
54. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
55. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
56. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
57. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
58. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
59. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
60. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

61. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
62. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
63. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
64. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
65. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
66. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
67. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
68. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
69. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
70. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
71. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
72. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
73. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
74. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
75. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
76. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
77. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
78. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
79. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
80. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
81. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
82. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
83. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
84. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
85. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
86. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
87. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
88. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
89. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
90. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Tabla 1

Pauta Eunacom 2013	Clave	Eplicación						
1	D	Tiene una Estrenosis Mitral con FA						
2	A	Es una diverticulitis						
3	B	Tiene un síndrome nefrótico, secundario a una neforpatía membranosa y complicado con un TEP						
4	D	El Cáncer de ovario metastizado se trata con QT						
5	E	Por ser un fármaco nuevo es imposible tener estudios para hacer un meta-análisis. Así que lo mejor es el ensayo clínico. Eso sí, lo que se mide es eficacia y no efectividad, pero de todos modos es la respuesta más correcta.						
6	C	Es una hiperplasia suprarrenal congénita, con una crisis adrenal (se ve por la hiponatremia, hiperkalemia y shock que no responde). Además está descompensado, probablemente por una infección.						
7	E	Metrorragia más dolor e hipertonia uterina. Además FCF en límite bajo.						
8	B	Es una HPB. La Retención urinaria aguda es indicación absoluta de Qx. Hematuria e una ocasión y residuo de 150 ml son indicaciones relativas (sobre 150 ml se opera). El APE elevado solo es indicación de Bx. Es una mala pregunta y muy discutible, pero sin duda la respuesta es B.						
9	C	Es una fobia social de libro.						
10	D	La posición púdica es característica de la luxación posterior. La fractura, en cambio tiene posición impúdica (abducción, rotación externa y acortamiento).						
11	D	Es un escolar con hematoquezia intermitente, no grave, sin más síntomas. Sospechar pólipo juvenil, que es una causa frecuente de HDB en esa edad. Son hamartomas vasculares.						
12	A	Es una úlcera duodenal Activa. Aunque el test de ureasa esté negativo, si no usa AINES, se asume que es por H. pylori, porque el 90% de las úlceras duodenales son por esa causa y el test de ureasa no es un examen tan bueno. Es una pregunta difícil. En el caso de la úlcera gástrica, es más probable que pueda ser por otra causa (solo 70% es por HP) y se tendría que estudiar. También se estudiaría si hubiese algo más que hiciera sospechar otra enfermedad, como un Cróhn o un Zollinger Ellison.						
13	D	Es la única respuesta posible, ya que las verrugas planas pueden tener fenómeno de Koebner (aparecen lesiones lineales en zona de traumatismo) y se suelen ubicar en las manos y extremidades. El liquen plano no afecta el tórax y suele ser en edades mayores (sí puede tener Koebner). Pregunta rara, ya que falta lo más importante de las verrugas planas, que es la pérdida del dibujo cutáneo.						
14	E	Pregunta muy capciosa, ya que depende del medicamento, pero en general, los cuidados paliativos reciben fármacos por vía oral y si no se puede, por vía subcutánea (ej. morfina subcutánea), dado que la dosis es más constante que en rectal y soblingual y es menos dolorosa que la intramuscular. Sigue siendo una mala pregunta.						
15	E	Fue una reacción a la Pertusis celular. Se debe cambiar por acelular. Hoy se usa la pentavalente y no la DPT, sin embargo es la única respuesta correcta.						
16	A	Disección aórtica por el soplo diastólico. La disminución del R2 y el soplo son por la insuficiencia Aórtica						
17	C	Si bien parece histriónica, ha perdido el juicio de realidad y además "está segura", por lo que es un TDC.						
18	B	Tiene una anemia con VCM 110, es decir megaloblástica, por eso es por déficit de B12, causada en primer lugar por la anemia perniciosa. El déficit de folatos también podría ser una alternativa aceptable, pero los folatos son B9.						
19	D	Pregunta muy difícil, ya que por ser nulipara tiene contraindicación relativa del DIU, sin embargo por tener jaqueca con amaurosis fugax, están contraindicados absolutamente los estrógenos, ya que los ACO están contraindicados en algunas jaquecas con mayor riesgo de AVE: la amaurosis fugax es uno de los criterios de contraindicación absoluta. Además la salpingoligadura es irreversible. Esta pregunta es muy muy difícil y debería anularse, ya que todas las opciones están contraindicadas; la del DIU medicado es la más aceptable.						
20	A	Es una AR de libro, aunque tenga negativos los marcadores.						
21	C	El PAP hace Dg precoz, para tratamiento oportuno. Por tanto es secundaria. La vacunación contra el VPH sí es primaria.						
22	A	Por la disfagia lógica y por el antecedente de probable RGE (usa omeprazol). La acalasia produce disfagia ilógica. La edad sugiere también cáncer.						
23	E	Tiene un diagnóstico de colangitis aguda clínica. Se debe hacer drenaje endoscópico de la vía biliar, lo que no aparece en las alternativas. De las opciones, la más aceptable es la CPRE (aunque en realidad lo que se hará es una papilotomía y drenaje). La presencia de Blumberg confunde, ya que podría indicarnos una Cirugía, pero el manejo de elección sigue siendo en drenaje endoscópico. De todos modos es probable que la pregunta original haya estado redactada de otra forma.						
24	B	Por ser un asma sin clínica actual, no servirá ni el PEF ni la espirometría. Esta pregunta también es muy discutible, ya que el diagnóstico de asma es clínico y los demás exámenes solo son de apoyo diagnóstico. Además en la mayoría de los libros, guías y recomendaciones se prefiere hacer espirometría y solo solicitar las demás pruebas ante la duda diagnóstica. Sin embargo, el eunacom ha preguntado esto varias veces y ante un examen totalmente normal y clínica muy leve, la espirometría resulta normal y no sirve. Además el test de metacolina es una espirometría, pero en la cual se nebuliza con dosis crecientes de metacolina, para producir la broncoconstricción y medir la reactividad bronquial.						
25	D	Es un RBNE no reactivo (solo tiene dos desaceleraciones pequeñas, con mínimas aceleraciones. Se debe alargar por 20 min más. Para ser reactivo requiere 2 aceleraciones de 15 lpm de amplitud y de 15 seg de duración.						
26	D	Hizo un trastorno disociativo grave, con despersonalización parcial. Es una pregunta muy difícil, ya que no es el cuadro clásico.						
27	C	De libro						
28	D	Si bien la RMN es el mejor examen (da más información), el TAC sin contraste es el de elección, ya que es más rápido (la RMN demora 45 min o más y cada minuto es vital en el AVE) y permite diferenciar el AVE isquémico del hemorrágico, que es lo que importa para determinar el manejo en este momento, ya que al llevar 2 horas, está en la ventana para trombolisis intravenosa con rTPA (hasta 4,5 horas, aunque su efectividad mayor es durante las primeras 3 horas). Sigue siendo una pregunta discutible, pero yo marcaría TAC. Eso sí, hay que ver cómo está redactada la pregunta en el examen original.						
29	B	Tiene un RCIU mayor a 34 semanas y cuyo Doppler umbilical está alterado, por lo que se debe interrumpir. Por tener el doppler alterado, es decir, insuficiencia placentaria no se lo debe someter al estrés del parto vaginal.						
30	C	La ECN se estudia con Rx simple.						
31	D	De libro: megalocórnea, epífora y opacidad corneal.						
32	B	Tiene un hipogonadismo (PP negativa, con PE+P positiva) hipogonadotrópico (FSH baja), por lo que es un problema hipotalámico (tendría GnRH baja) o hipofisiario (tendría GnRH alta).						
33	B	Si bien es un adolescente, la presencia de acantosis nigricans es muy sugerente de RI y por tanto de DM2. La obesidad también orienta a DM2, pero recordar que no basta, ya que un niño obeso con diabetes probablemente es tipo 1. Además al no estar tan altas las glicemias hace pensar más en DM2, porque la DM1 suelen debutar bastante descompensados.						
34	C	El diagnóstico es una diabetes LADA, que si bien es igual a la DM1, tiene un nombre distinto. Orientan el vitíligo, el hipotiroidismo (autoinmunes ambos) y la falta de respuesta.						
35	D	Es un cuerpo extraño laringeo obstructivo en un niño menor de 1 año, por lo que se deben dar 5 golpes en la espalda. Si no funciona, se hacen 5 compresiones en el pecho y luego se repiten los golpes en la espalda y así sucesivamente. Sobre el año se hace Heimlich.						
36	E	El primer examen en la metrorragia postmenopáusica es la EcoTV. Luego se hace la BEM (biopsia de endometrio), a menos que el endometrio sea menor a 5 mm (o hasta 10 mm si usa TRH).						
37	B	Tiene un cuadro sugerente de MBA. Las petequias y equimosis son de meningococcemia.						
38	C	Es una E. coli BLEE (resistente a cefalosporinas), aunque sea sensible a la amyka, por ser resistente a la genta, se prefiere el carbapenémico. La verdad que por ser BLEE ya se prefiere el ertapenem u otro carbapenémico. Recordar eso sí, que el ertapenem no sirve contra pseudomona: en ese caso se usaría imipenem o carbapenem. El ertapenem tiene además el beneficios de solo necesitar una dosis al día, por lo que incluso en algunos pacientes se los maneja de manera ambulatoria (llegan a inyectarse una vez al día).						
39	E	De libro						
40	D	Se siguen al futuro dos grupos: expuestos y no expuestos a un FR (HTA en este caso)						
41	C	De libro						
42	A	Tiene una intususcepción o invaginación intestinal. Se estudia con Eco.						
43	C	Es la misma pregunta de antes.						
44	B	Es una conjuntivitis bacteriana, que se complicó con una celulitis orbitaria o postseptal (por la quemosis). La alergia al CAF suele presentarse de otra forma y es muy rara.						
45	D	Tiene una FA rápida, mayor a 48 horas. Se debe anticoagular y controlar la FC mientras tanto. Siempre se inicia la anticoagulación con heparina (es mejor la de bajo peso). Para controlar la FC tenemos propanolol, digital y verapamilo. Aún así, esta pregunta es muy discutible, ya que por no tener ningún criterio de CHADS2, incluso se podría no anticoagular. Sin emabargo no hay que rebuscarse y hay que simplificar la pregunta a ¿cómo se maneja una FA de más de 48 horas?. También se puede criticar la pregunta porque dice 2 días y eso puede ser más o menos de 48 horas: pero en las alternativas no aparece el manejo de una FA de menos de 48 horas (cardioversión farmacológica), por lo que la pregunta debe interpretarse así. Habría que revisar cómo estaba originalmente redactada esta pregunta.						

Pauta Eunacom 2013	Clave	Eplicación						
46	B	Pregunta mala. El diagnóstico es clínico y en la vida real no hay que pedir ningún examen y hacer cesárea. El gold standard siempre ha sido el cultivo viral, pero la PCR lo ha desplazado, por ser más rápida y más sensible. Yo marcaría PCR, pero el problema es que demora y hay que actuar de inmediato, por ser un embarazo y para decidir la vía de parto, lo único inmediato es la tinción de Tzank, aunque es un examen con mucho menor rendimiento. Sin embargo, no hay que rebuscarse y hay que responder ¿Qué examen es el mejor para el estudio del herpes genital?						
47	C	Tiene un PTI agudo, pero por tener menos de 20.000 plaquetas, hay que indicarle corticoides. En general solo se observa. Si tuviese hemorragias graves (ej: HDA o hemorragia intracraneal), se debería dar IgG ev. Si fuera crónico: siempre corticoides y si fallan: esplenectomía.						
48	D	Es una escarlatina y el diagnóstico es clínico. No hay que pedir ningún examen, por lo que esta pregunta está técnicamente mala. El cultivo faríngeo es el goldstandard, pero demora. La verdad es que no estoy 100% seguro de que esta sea la respuesta correcta, ya que al igual que en el Herpes, el diagnóstico es clínico y el gold standard es el cultivo. Eso sí, el test pack tiene el resultado es inmediato y hay que iniciar antibióticos ahora (de hecho hay que iniciarlos porque ya está hecho el diagnóstico, porque es un diagnóstico clínico). Lo más razonable es simplificar la pregunta a ¿cuál es el examen para la escarlatina? y responder cultivo. Además, en algunas recomendaciones de expertos se dice que el cultivo se debe pedir siempre, sin embargo, la mayoría de las recomendaciones dicen que el diagnóstico es clínico.						
49	A	Sospechar una TBC. Se estudia con BK. La Rx hay que pedirla igual, pero BK es la respuesta.						
50	D	Es un traumatismo renal. Se estudia con el Uro-TAC, que tiene contraste IV. El pielo-TAC que viene sin contraste es para la litiasis.						
51	D	Es una familia muy disfuncional. La clínica orienta mucho a EQZ. Los antecedentes familiares confunden, porque orientan a T. bipolar, pero no hay clínica de dicha enfermedad.						
52	D	Quilotórax de libro. Su primera causa es traumático. Además el ducto torácico está en el lado izquierdo						
53	E	Tiene una insuficiencia cardíaca, secundaria a cardiopatía coronaria. Hay que pedir la Ecocardiografía, para ver la función ventricular.						
54	E	El registro está ominoso (variabilidad disminuida y desaceleraciones tardías). Es un MEFI 3 y por tanto se debe interrumpir. Lo difícil es que para interrumpirlo debe estar 20 minutos al menos en MEFI 3 o 2 minutos en bradicardia sostenida. Sin embargo, cuando se pregunte un registro malo, la respuesta a marcar es la interrupción por la vía más expedita, ya que se asume que el registro lleva al menos 20 minutos. La excepción es si se dijera que lleva pocos minutos con ese registro.						
55	E	El tratamiento de elección de la gota aguda son los AINES. La Colchicina es la opción más adecuada dentro de las que ahí aparecen. La Colchicina sí sirve en la gota aguda, aunque por tener muchos efectos adversos, se prefieren los AINES. El alopurinol está contraindicado en la gota aguda.						
56	A	Tiene un cólico renal.						
57	E	Tiene VIH, que es una ID adquirida, de tipo combinada. El déficit de IgA da diarreas y bronquitis. El déficit de IgG da infecciones por Neumococo, meningococo y haemophilus. El déficit de C ³ da infecciones por meningococo. El déficit de fagocitosis da infecciones por bacterias y aspergillus.						
58	E	Es un retraso constitucional del crecimiento. Edad ósea 2 años menor a la cronológica. Llama la atención los testículos pequeños (aún no inicia la pubertad, pero eso es acorde a su edad biológica = ósea), sin embargo el Klinefelter, no tiene talla baja. El Turner, de las niñas, sí tiene talla baja.						
59	B	Diarrea por ATB, probablemente por C. difficile. Se trata con MTZ. Eso sí, primero se debería confirmar el diagnóstico con la PCR para Clostridium difficile.						
60	E	Tiene una glicemia mayor a 105 (ahora el corte es 100). Si fuera menor a 100 se observa, si es mayor, se repite. El TTGO se pide a las 28 semanas y luego a las 32 si hay macrosomía, PHA o antecedentes de DMG en otro embarazo.						
61	B	Aunque tengan un HipoT4 subclínico, la conducta es tratar la depresión, que es el cuadro clínico. Sin embargo en la realidad también se debe tratar el HipoT4 subclínico, con la levoT4. Entre ambas respuestas, creo que la que hay que elegir es el antidepressivo ISRS, ya que en realidad el diagnóstico principal es la depresión. Además los síntomas no se explican para nada por el hipoT4, por tener apenas 5,4 de TSH. La verdad es que tampoco estamos 100% de que sea subclínico, porque no sabemos la T4. Es una pregunta mala.						
62	A	Si bien suele no tener soplos, la TGV es la única opción que muestra una cardiopatía cianótica. Además sí tiene el mediastino delgado.						
63	D	Miomas sintomáticos en mujer sin hijos: miomectomía. Cierto es que los miomas intramurales suelen ser asintomáticos, pero en este caso se debe simplificar la pregunta a ¿cuál es el tratamiento de los miomas con hipermenorrea?						
64	C	Es una fibrosis pulmonar.						
65	E	Es una mola completa, con los quistes tecoluteínicos, la metrorragia y los vómitos.						
66	D	Tiene una colédocolitiasis. Llama la atención la elevación de los blancos y la PCR, pero la clínica no está tan mal, como para ser una colangitis. La lipasa está elevada, pero menor a 180, por lo que no parece una pancreatitis.						
67	C	El lorazepam sublingual es el tratamiento de elección para las crisis de pánico. Su vida media es más corta que el diazepam y el clonazepam. Se debe dar por vía sublingual, de elección.						
68	A	De libro. También se llama delirium. Si bien delirio es la traducción al español de la palabra en latín "delirium", en Chile se suele usar "delirio" para la pérdida de juicio de realidad de los pacientes psicóticos (delirio paranoide, megalomaniaco, erotomaniaco, etc) y delirium para el síndrome confusional agudo.						
69	D	Tiene una TPSV y lo primero son las maniobras vagales, luego la adenosina.						
70	E	Puede ser una úlcera u otra cosa, pero las epigastralgias se estudian con EDA. Que aumente con el café y con ayuno orienta a úlcera.						
71	A	Es una meningitis TBC tanto por el LCR, como por la clínica, con compromiso de los pares craneales.						
72	C	Tiene cuello corto y el antecedente de los partos muy prematuros (probablemente abortos: menor a 22 semanas o menor a 500 gramos). Si no tuviera abortos previos, sino solo el cuello corto, habría que darle progesterona endovaginal (Progendo es el nombre comercial).						
73	C	Se ven las asas dilatadas y tiene el cuadro clínico. No se ve la imagen de grano de café, como para haber pensado en vólvulo.						
74	D	Tiene el cuadro de cefalea, tos, fiebre y mialgias.						
75	D	La PAMG1 es de elección hoy en día, aunque suele no estar disponible y se hace el test de cristalización. Si no apareciera en las alternativas, la respuesta sería el test de cristalización, pero la PAMG1 (altísima sensibilidad y especificidad) es mejor y es la respuesta correcta. Si la pregunta estuviese planteada en términos de costos, eficiencia o algo así, sí sería el test de cristalización.						
76	C	Tanto por la PA (mayor a 130/80 dice la guía antigua, sin embargo la nueva lo deja en 140/90), como por la proteinuria positiva (IP/ C mayor a 0,2 es proteinuria). La proteinuria hace que sea 100% segura la opción de darle los IECAS.						
77	A	Esta pregunta está muy difícil, ya que la gingivorragia puede estar en la EvW y es más frecuente en ella que en la hemofilia. Además la EvW puede alargar levemente el TTPA. Por ser niño, por tener un hematoma profundo y por tener el TTPA largo, podría ser hemofilia. Sin embargo, que no haya tenido hemartrosis y que solo haya tenido un hematoma muscular, más los otros síntomas, lo más probable es que sea un von Willebrand. Habría que ver bien cómo estaba redactada la pregunta original. Revisar el Eunacom 2015 de julio, que tenía una pregunta similar, pero que era una EvW.						
78	A	Por la crea de 1,5						
79	D	Síndrome amenorrea galactorrea, sin embarazo, es hiperprolactinemia.						
80	C	Clínica muy sugerente de neumotórax						
81	E	Urocultivo está negativo. Idealmente repetirlo por sondeo, porque el sedimento está dudoso y la clínica es sugerente. Pregunta muy rara y difícil. Probablemente venia redactada de una forma distinta en la prueba origina. De las opciones, la más aceptable, dado que el urocultivo es menor a 100 mil colonias, es la repetición.						
82	D	Es un quiste del epidídimo. Se observan.						
83	C	Por ser postQx es TEP y por el compromiso HDN es masivo problememente						
84	A	Es una laberintitis aguda. Se operan si son secundarias a un colesteatoma. Sin embargo, lo primero siempre es el tratamiento ATB ev, igual que en las mastoiditis. El nistagmo en las laberintitis va hacia la lesión en las etapas iniciales y escapa de la lesión en los casos más graves, cuando ya probablemente se perderá el oído (este es el caso). Es una pregunta muy muy discutible, pero yo marcaría el tratamiento antibiótico, por ser lo básico del tratamiento de la laberintitis aguda y porque la cirugía se evalúa caso a caso.						
85	E	Es una angina de esfuerzo. Si bien hay que pedir un ECG, el TE es el examen para la angina en sí. Además el test de esfuerzo es un ECG y si está malo al inicio, no se prosigue con el examen. En la vida real, sí se pedirá probablemente el ECG, pero se debe simplificar la pregunta, a ¿cómo se estudia una angina estable?... con Test d esfuerzo. Si viniera con soplo, se sospecharía una estenosis aórtica y la respuesta sería Ecografía.						
86	A	De libro y lleva más de 4 semanas.						
87	D	Parece una anemia hemolítica. Si bien suelen no tener coluria (ya que la Bili es indirecta), puede que sea hemoglobinuria (también oscurece la orina). Se debe empezar con el hemograma y reticulocitos. Luego se pedirá el Coombs directo.						
88	B	Parto prematuro de menos de 34 semanas, con cuello corto y con algo de modificaciones. Hay que dar corticoides y tocolíticos. Atosiban, fenoterol y nifedipino son opciones. La guía minsal dice nifedipino en primer lugar. Si no frena a las 2 horas, se hace amboctesis y si no hay bacterias, se dan tocolíticos de segunda línea: fenoterol o atosiván.						

Pauta Eunacom 2013	Clave	Eplicación						
89	C	Por ser hipoecogénica. Quistes son anecogénicos y hemangioma son hiperecogénicos. Cálculos tienen sombra acústica y quistes simples e hidatídicos tiene refuerzo posterior.						
90	D	Se ve en la foto: Las costras mielicéricas.						
Segunda Parte								
1	A	Tiene una erosión corneal por un cuerpo extraño tarsal						
2	C	Eco y PAAF son respuestas correctas. Como no dice el tamaño, primero la ecografía, para ver el aspecto y descartar adenopatías. Así lo dice la guía minsal.						
3	B	Es una ginecomastia puberal benigna						
4	B	Por la edad es osteosarcoma. El de células gigantes es entre los 40 y 55 años. El sarcoma de Ewing es de localización diafisaria, no metafisaria.						
5	D	Tiene una encefalopatía hipercárbica. Se va a VMI. El CO2 mayor a 65 también es indicación de ventilación mecánica. El BiPAP (VMNI) es una buena opción, pero si está encefalópata, se prefiere la VMI						
6	B	Tiene RPO mayor a 34 semanas y el cuello está malo (Bishop bajo), por lo que no sirve la oxitocina						
7	C	Es lo más útil que ha demostrado. Esta pregunta no debería existir.						
8	D	Es una PBE. También hay que dar albúmina (1,5 g/Kg de peso el primer día y 1,0 g/Kg de peso al tercer día), pero los ATB son lo más importante. Se da Cefotaximo.						
9	B	Es una sepsis neonatal.						
10	A	Tiene una embolia mesentérica, secundaria a la FA (ritmo irregular).						
11	D	Antes de los cambios bioquímicos no se puede detectar nada. Después de los cambios tisulares ya tengo daño. Ejemplo: glicemia de ayuno como screening de DM2. De todos modos es una mala pregunta porque depende de la enfermedad y del tipo de test: ejemplo el PAP hace el screening después de los cambios tisulares.						
12	B	El BCRI inutiliza el Test de esfuerzo y se debe pedir la Eco-dobutamina.						
13	A	Es la definición de RA = le - lo						
14	A	Primero se deben indicar alfa-ANTAgonistas, porque no hay ninguna indicación estricta de cirugía. Pero de las opciones que aparecen la RTU es la única aceptable (aunque no se dice el tamaño de la próstata, porque si es mayor a 60cc, se debe hacer cirugía abierta y no RTU). Los inhibidores de la 5 alfa reductasa no sirven. La biopsia solo está indicada si TR positivo o APE mayor a 4 o velocidad de APE mayor a 0,75.						
15	A	Sd. polidíptico-poliúrico, pero se normaliza con el test de la sed.						
16	C	Para mí es una salida del tapón mucoso (metrorragia escasa y autolimitada). Como no está dentro de las opciones marcaría la Placenta Previa, por estar todo bien, sin compromiso fetal. No habla de relaciones sexuales ni describe lesiones cervicales, como para ser sinusorragia.						
17	A	Por llevar dos semanas, sospechar mycoplasma. También por el compromiso intersticial. El moxifloxacino sí lo cubre, pero su espectro es muy amplio: cubre también anaerobios. Levofloxacino sí habría sido una respuesta correcta. Todos los macrólidos lo cubren bien y son de elección en los niños, que no pueden usar quinolonas y también en los adulto, en particular la azitromicina, que se toma por menos tiempo.						
18	E	Sarna en embarazo = vaselina azufrada						
19	B	Es una neutropenia febril. Se trata con doble cobertura para pseudomona. En los casos en que se sospeche stafilococo, además se deja cloxa y si lleva más de 10-14 días, se agrega cobertura para aspergillus.						
20	E	Por ser diabético, debe exigirse un LDL menor a 70. El LDL es la prioridad, si los TG están menores a 500. Si los TG hubiesen sido mayores a 500, ahí hubiese sido gemfibrozilo.						
21	D	PTI de libro						
22	A	Por clínica de parálisis del IV par y por lo subagudo del cuadro: 3 semanas						
23	E	Tiene un trastorno de ansiedad con agorafobia. Se debe preferir el diagnóstico de trastorno de ansiedad, por ser más completo, que el de agorafobia, que en este caso es un síntoma. De hecho el DSM IV clasifica el trastorno de pánico (o ansiedad o angustia) en con agorafobia y sin agorafobia						
24	D	Tiene una tiroiditis subaguda de Quervain, que se trata con AINEs. No se deben indicar drogas antitiroideas (PTU, metimazol) y si se puede dar propranolol si hay muchos síntomas de hipertiroidismo. El paracetamol no es suficiente.						
25	A	Prolactina, TSH es lo más importante. La FSH y estrógenos se piden después, pero es la opción más correcta. DE todos modos, el test de embarazo debería ser lo primero, luego TSH y PRL y luego la prueba de progesterona.						
26	D	Oligoartritis migratoria es probablemente una reactiva. En especial si la diarrea fue por Campilobacter.						
27	E	Tiene una ictericia tardía. Si bien las orinas oscuras orientan a atresia biliar primaria, lo primero es ver la bili diferenciada. Luego la Eco. La pregunta es difícil.						
28	C	Es una varicela en mayor de 13 años. La aspirina está contraindicada.						
29	D	20/60 = 0,33 = 33%						
30	B	Exudado mononuclear con ADA baja. Es cáncer						
31	B	Lipasa está mayor a 180. Además tiene una colédocolitiasis, pero manda la pancreatitis, por ser lo más grave.						
32	C	Tiene mezcla de narcisismo (envidia), limitrofe (intensas), pero más de histriónica (provocativa al vestir, coqueta, exagerada).						
33	A	Es una EII. No tiene ninguno de los elementos que orientan a Cröhn, por lo que hay que elegir CU. Si tuviera algo de Cröhn (abscesos perianales, malabsorción intestinal, fístulas, úlceras orales, ASCA+, compromiso de intestino delgado, compromiso en parches o discontinuo, masa, perforación, etc) sería Cröhn.						
34	B	Como la metrorragia no es grave (si fuera grave habría que operar de inmediato por EE roto), se puede pedir la BetaHCG en 2 días, junto a la Eco, ya que está menor a 1.200. El diagnóstico probable es un embarazo de menor edad gestacional, con síntomas de aborto, vs un embarazo ectópico, con metrorragia, sin estar del todo roto. Recordar que los EE producen también metrorragia por la insuficiencia lútea que tienen, dados los bajos niveles de HCG que alcanzan.						
35	C	Pregunta muy capciosa: Aún se puede elevar algo la GBC (a 20) y la MTF (a 3.000), pero probablemente tendrá poco efecto, para lo mal controlado que está. Su HbA1c es 8,8%, por lo que es poco probable que baje a 7%, con esas medidas. No estoy 100% seguro de esta respuesta, pero yo marcaría insulina sin dudarle mucho.						
36	E	Tiene un tunel carpiano						
37	C	Tanto por la HTA, como porque el ECG se ve la taquicardia irregular, a QRS angosto y ausencia de onda P						
38	D	Hay que darle un ISRS y al inicio una BDZ. La única opción que cumple con eso es la D. Los anticonvulsivantes y antipsicóticos no están indicados en el T. de angustia. Lo ideal sería empezar con fluoxetina 10 mg al día más alprazolam (no diazepam) 0,5 mg cada 8-12 horas y terminar con fluoxetina 20 mg al día, sin BDZ en un par de semanas.						
39	E	El pielotAC no tiene contraste y es el examen de elección para el cólico renal						
40	B-A	Tiene un delirium. Lo más importante es tratar la causa. La agitación, se puede tratar con haloperidol, intramuscular en la dosis más baja posible y luego, se mantiene con la mitad de la dosis, por vía oral. Idealmente no darlo ev, aunque el uptodate pone Haldol ev, como tratamiento de elección, ya que la dosis es muy bajita: 0,5 a 1 mg. La risperidona oral sirve mucho también, pero si está agitado, puede ser difícil de entregarlo. Es pregunta muy discutible, ya que ambos medicamentos han demostrado ser iguales en efectividad, aunque faltan estudios más concluyentes, por lo que el haldol sigue siendo de elección. Yo marcaría Haloperidol, como primera opción, pero al salir risperidona vo y haldol ev, no estoy seguro. Habría que revisar cómo estaba redactada la pregunta.						
41	C	Tiene un exantema súbito clásico, aunque está muy grande para tenerlo (suele ser en menores de dos años)						
42	E	Esa pregunta no se entiende en absoluto. Se comparan las tasas de natalidad y es más, las están dando. La pregunta dice "índices" y toda tasa es una razón. Además se puede calcular la razón entre ambas tasas de natalidad y así decir qué tan mayor/ menor es la natalidad de un país comparado con la del otro. Plop! Sin embargo, lo que se compara son las tasas de natalidad y por tanto esa es la respuesta.						
43	B	La pirosis y la gran baja de peso orienta más a estómago. No tiene disfagia que es lo clásico del Cáncer de esófago. El edema es por la desnutrición proteica.						
44	D	Está en trabajo de parto, pasando de la fase latente a la activa. NO tiene ningún criterio de gravedad o que contraindique el parto vaginal.						
45	A	Es normal la proteinuria con el ejercicio intenso. No tiene clínica de rabdomiolisis						
46	A	Cefalea súbita. La relación con el ejercicio puede orientar. Los signos meníngeos orientan mucho y los signos focales no son característicos, pero pueden aparecer. Si solo fuera cefalea más signos focales, tendería a marcar hematoma intracerebral, pero como está planteada la pregunta, seguro es una HSA.						

EUNACOM 2015

Esta es una reconstrucción del Eunacom de julio 2015. La redacción es lo más similar posible a las preguntas originales, sin embargo algunas alternativas y parte del enunciado fueron complementadas con información distinta a la original.

Al final está la pauta y las explicaciones de las preguntas, que valgan la pena.

Este examen estuvo muy difícil, con muchas preguntas fuera de los contenidos (Ejemplo: manejo de la hernia diafragmática, agente etiológico específico en un TORCH, clínica específica de distintas disfonías crónicas, etc) y además muchas preguntas, cuya respuesta no es un tema cerrado y por tanto es muy discutible cuál es la respuesta correcta (ejemplo: profilaxis en contacto de varicela, tratamiento de una probable influenza, etc). También hay que agregar algunas preguntas mal intencionadas, en la que se preguntaba la excepción o una presentación muy atípica de una patología (Ejemplo: Eritema infeccioso que parecía un exantema súbito, estenosis aórtica que se presentaba como angina estable, etc).

Es importante aclarar que un porcentaje de las preguntas (habitualmente el 10% del total) se anula cada año, por lo que los puntajes podrían variar considerablemente en la entrega de puntajes oficial.

Las preguntas anuladas habitualmente son las más difíciles, es decir aquellas que menos del 20% responde correctamente, pero también se eliminan aquellas preguntas que no discriminan, es decir aquellas contestadas igualmente bien o mal por los mejores y peores puntajes. Históricamente se ha utilizado a la población de médicos chilenos recién egresados para determinar las preguntas que se anularán. Sin embargo, en esta oportunidad no ha habido información sobre cómo se determinarán, dado que la gran mayoría de los médicos que dieron la prueba son titulados en el extranjero o repitentes.

Sinceramente espero que les haya ido bien, o al menos que hayan logrado aprobar. Aquellos que hayan reprobado, sepan que el Eunacom siempre se puede volver a dar y que el esfuerzo que hicieron no ha sido en vano, ya que adquirieron nuevos conocimientos, que sin duda les serán útiles, tanto en su práctica clínica, como para tener una mucho mejor base académica, que les permitirá preparar y enfrentar mejor un nuevo examen.

1) Una mujer de 45 años consulta por debilidad para tomar objetos, desde hace 3 meses. Además presenta parestesias, especialmente en la noche, que mejoran al sacudir las manos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Atrapamiento del nervio cubital
- b) Polineuropatía
- c) Síndrome de túnel carpiano
- d) Lesión del nervio radial
- e) Síndrome del opérculo torácico

2) Una mujer de 50 años consulta por parestesias en ambas manos, mayor a derecha, que la despiertan en la noche, por lo que debe sacudir las manos, para aliviarse. Además presenta dificultad para tomar objetos con las manos. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para proseguir con el estudio de esta paciente?

- a) Ecografía de mano
- b) Electromiografía
- c) Prueba de estimulación con edrofonio
- d) Resonancia magnética de cuello
- e) Radiografía de mano

3) Un paciente de 35 años consulta por debilidad del cuarto y quinto dedos derechos, es especial a la flexión, asociado a parestesias en dichos dedos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Lesión de los tendones profundos
- b) Síndrome del opérculo torácico
- c) Atrapamiento del nervio radial
- d) Síndrome de atrapamiento cubital
- e) Síndrome de túnel carpiano

4) Un paciente presenta dolor en la cara lateral de la cadera derecha, que aumenta con la marcha y al recostarse apoyado en esa cadera. Los movimientos están conservados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome de la banda ileotibial
- b) Bursitis ileopectínea
- c) Bursitis trocantérica
- d) Pinzamiento femoroacetabular
- e) Artrosis de cadera

5) Un paciente de 77 años presenta dolor inguinal derecho de 2 años de evolución, que aumenta con la marcha, limitándola. Al examen físico se aprecia pérdida de la rotación interna y la flexión de la cadera derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Necrosis avascular de la cabeza femoral
- b) Coxartrosis
- c) Hernia foraminal S1
- d) Pinzamiento femoroacetabular
- e) Estenosis raquimedular

6) Un paciente, luego de un “sueño profundo”, en relación a una intoxicación alcohólica, presenta debilidad y dificultad para tomar objetos con la mano derecha, como sostener una taza, la que se le cae. Al examen físico no tiene alteraciones en la sensibilidad, ni en los reflejos osteotendíneos, los que permanecen conservados. Sin embargo, al solicitarle que ponga los brazos en posición horizontal, se observa que la mano derecha está “caída”. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

- a) Lesión del nervio radial
- b) Lesión del plexo braquial
- c) Lesión de los nervios cubital y mediano
- d) Isquemia de los músculos del antebrazo
- e) Accidente vascular encefálico

7) Un niño de 3 meses de edad se realiza una radiografía de pelvis, que muestra displasia de cadera izquierda, con índice acetabular de 36 grados. La indicación más adecuada es:

- a) Ejercicios de rotación y compresión
- b) Bota larga bilateral de yeso, con yugo
- c) Yeso pelvipedio
- d) Uso de doble pañal
- e) Arnés de Pavlik

8) Un adulto mayor presenta gonalgia bilateral, de dos años de evolución, que aumenta con la marcha. Hace algunas horas el dolor de la rodilla izquierda se vuelve mucho más intenso, apareciendo eritema, aumento de volumen y sensación febril. ¿Cuál es el examen más adecuado para este paciente?

- a) Resonancia magnética de rodilla
- b) Radiografía de rodilla
- c) Hemograma VHS
- d) Estudio de líquido articular
- e) TAC de rodilla

9) Un adolescente de 16 años presenta dolor en la rodilla derecha, luego de haberse golpeado. Al examen físico se palpa aumento de volumen de consistencia ósea, por lo que se solicita una radiografía, que muestra una lesión ósea heterogénea, ubicada en el extremo distal del fémur, con discontinuidad de la cortical y zonas líticas, con otras de aumento de la densidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Osteocondroma
- b) Tumor de células gigantes
- c) Osteosarcoma
- d) Displasia ósea fibrosa
- e) Quiste óseo

10) Un paciente de 60 años, gastrectomizado, presenta un cuadro de astenia, adinamia, asociada a disminución de la sensibilidad distal de las extremidades y debilidad. Además ha presentado algún grado de disminución de la capacidad cognitiva. Al examen físico se aprecia disminución de los reflejos osteotendíneos, palidez y disminución de la sensibilidad de las Extremidades inferiores. Se solicitan exámenes, entre los que destaca un hemograma con Hemoglobina de 6,3 g/dl, VCM: 110 fl, plaquetas: 200.000 por mm³, blancos: 3.200 por mm³. La indicación más adecuada es:

- a) Ácido fólico
- b) Vitamina B12
- c) Hierro
- d) Biopsia de médula ósea
- e) Endoscopia digestiva alta

11) Una paciente de 25 años, vegetariana estricta, con antecedente de un hijo con mielomeningocele, presenta anemia. ¿Cuál es la indicación más adecuada?

- a) Vitamina B12
- b) Folatos
- c) Tiamina
- d) Ácidos grasos omega 3
- e) Aminoácidos esenciales

12) Un paciente de 81 años, en espera de una cirugía de cataratas, se realiza un hemograma, como parte de los exámenes preoperatorios, que muestra 140.000 blancos, con predominio de linfocitos, de aspecto redondo, con citoplasma escaso, cromatina heterogénea y sombras de Gumprecht, además tiene hemoglobina de 13,1 g/dl y 180.000 plaquetas por mm³. Al examen físico se palpa una adenopatía cervical de 3 cm, indolora. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Leucemia aguda
- b) Mielodisplasia
- c) Leucemia mieloide crónica
- d) Linfoma
- e) Leucemia linfática crónica

13) Un joven de 17 años presenta un cuadro de fiebre y baja de peso, con malestar general, de algunas semanas de evolución. Consulta ahora por un cuadro de rápida instalación de cefalea, tos, edema de extremidades superiores y de la cara, seguido de desorientación y sopor. ¿Qué examen es más adecuado para confirmar el diagnóstico en este paciente?

- a) Radiografía de tórax
- b) Ecocardiograma
- c) TAC de tórax con contraste
- d) Endoscopia digestiva alta
- e) Resonancia magnética nuclear

14) Un joven de 18 años presenta sangrado prolongado, luego de la extracción de un molar. Además refiere equimosis ante pequeños traumatismos y epistaxis frecuente. Hace unos años estuvo hospitalizado por un hematoma profundo del muslo derecho. Su hemograma es normal y su TTPA está levemente alargado, con protrombinemia de 80%. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Von Willebrand
- b) Púrpura trombopénico inmune
- c) Enfermedad de Glanzmann
- d) Hemofilia
- e) Factor V de Leiden

15) Un niño de 11 años presenta un cuadro de astenia y fiebre de algunas semanas de evolución. Al examen físico se aprecia palidez, asociado a esplenomegalia. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para continuar el estudio en este paciente?

- a) IgM para virus Epstein Barr
- b) Hemograma VHS
- c) Biopsia ganglionar
- d) IgM para Bartonella henselae
- e) Tiempos de coagulación

16) Una paciente de 50 años, con diagnóstico de artritis reumatoide, en tratamiento con prednisona 15 mg/día, presenta glicemia de ayuno de 115, y glicemias prealmuerzo y precena de 230 y 295 mg/dl respectivamente. ¿Cuál es el mejor tratamiento para esta paciente?

- a) Dieta y ejercicio
- b) Metformina
- c) Glibenclamida
- d) Pioglitazona
- e) Insulina

17) Un paciente de 12 años, diabético tipo 1, en tratamiento con una dosis de NPH matinal, despierta con glicemias de ayuno muy elevadas, asociadas a hipoglicemias frecuentes antes del almuerzo. Su hemoglobina glicosilada es de 11,7%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Reemplazar el tratamiento por insulina glargina en la mañana
- b) Dejar dos dosis de insulina NPH más tres refuerzos de insulina cristalina precomidas
- c) Agregar insulina NPH nocturna
- d) Reemplazar la insulina NPH matinal por insulina NPH nocturna
- e) Agregar metformina al tratamiento

18) Un paciente de 60 años, diabético tipo 2, en tratamiento con 500 mg de metformina al día, acude a control, con hemoglobina glicosilada de 8,8%, proteinuria (+) y clearance de creatinina de 50 ml/min. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Subir la dosis de metformina
- b) Agregar glibenclamida
- c) Agregar insulina NPH nocturna
- d) Tratar con mezcla de insulinas
- e) Agregar glipizida al tratamiento

19) Un paciente de 12 años consulta por un cuadro de malestar general, asociado a bajo de peso, que en las últimas horas se le agrega poliuria importante. Consulta porque en las últimas horas se agrega gran compromiso del estado general, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está taquicárdico, soporoso, con polipnea y signos de deshidratación. En sus exámenes presenta glicemia de 470 mg/dl, sodio de 143 mEq/L, potasio de 4,8 mEq/L, cloro de 97 mEq/L, bicarbonato de 12 mEq/L y pH de 7,05. ¿Qué fluido debe administrarse a este paciente?

- a) Suero glucosado
- b) Suerlo glucosalino
- c) Solución salina al 0,45%
- d) Solución salina al 0,9%
- e) Solución ringer lactato

20) Un adolescente de 16 años, con IMC de 33, se realiza una glicemia de ayuno, que resulta 96 mg/dl, más una insulina basal que resulta 23 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar insulina
- b) Iniciar dieta y ejercicio
- c) Iniciar metformina
- d) Solicitar un test de tolerancia a la glucosa
- e) Iniciar metformina más glibenclamida

21) Un niño de 7 años presenta episodios en los que se queda quieto, mirando fijo, los que luego no recuerda. Han aumentado en frecuencia, hasta suceder 5 veces al día. El resto de su examen físico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síncopes vasovagales
- b) Epilepsia mioclónico
- c) Crisis de ausencia
- d) Epilepsia focal
- e) Déficit atencional

22) Un niño de 4 años, con antecedente de una convulsión febril hace 2 años, presenta un cuadro de fiebre y cefalea, seguido luego de deterioro del estado general y compromiso de conciencia. Luego, convulsiona en una oportunidad. Se realiza una punción lumbar, que da salida a un líquido cefalorraquídeo, con glucosa de 68 mg/dl, 62 mg/dl de proteínas, 300 glóbulos blancos, con 80% mononuclear y 60 glóbulos rojos, crenados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Encefalitis herpética
- b) Hemorragia subaracnoidea
- c) Meningitis bacteriana
- d) Meningitis tuberculosa
- e) Convulsión febril benigna

23) Un paciente de 69 años presenta debilidad de las manos, asociados a disminución de la sensibilidad de manos y pies. Refiere además dolor tipo ardor en las extremidades inferiores. Al examen físico tiene disminución de la sensibilidad “en calcetín”, signo de Lasegue negativo y presenta abolición de ambos reflejos aquileanos. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Guillain Barré
- b) Radiculopatía S1
- c) Síndrome de cola de caballo
- d) Polineuropatía
- e) Esclerosis lateral amiotrófica

24) Un paciente de 18 años presenta debilidad progresiva de las extremidades, con dificultad para caminar. Al examen físico no puede ponerse de pie y sus reflejos osteotendíneos están disminuidos, sin afectación de la sensibilidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Polirradiculoneuritis desmielinizante
- b) Miastenia gravis
- c) Polineuropatía
- d) Parálisis hipokalémica
- e) Mielitis transversa

25) Un paciente de 37 años consulta por dolor en la mandíbula inferior de segundos de duración, muy intenso, EVA 9/10, que se gatilla al comer y al lavarse los dientes. El dolor se ubica en la mitad izquierda de la mandíbula y en la arcada dental inferior izquierda. El examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Neuralgia del trigémino
- b) Cefalea cluster
- c) Jaqueca clásica
- d) Jaqueca complicada
- e) Disfunción de la articulación temporomandibular

26) Un paciente de 70 años presenta un cuadro de dificultad para girarse y para meterse a la tina, asociado a múltiples caídas. Además presenta cambios en la escritura y temblor de reposo. No presenta deterioro cognitivo evidente. El diagnóstico más probable es:

- a) Atrofia generalizada
- b) Hidrocefalia normotensiva
- c) Temblor senil
- d) Demencia por cuerpos de Lewy
- e) Enfermedad de Parkinson

27) Una paciente de 60 años presenta aumento de volumen en la axila derecha, de 4 cm de diámetro, indolora, de consistencia dura y adherida a planos profundos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hidrosadenitis
- b) Cáncer de mama
- c) Cáncer de pulmón
- d) Lipoma
- e) Tuberculosis ganglionar

28) Un paciente alcohólico, de 50 años, en situación de calle, consulta por dolor en el antebrazo derecho, muy intenso. Al examen físico se aprecia una lesión grande en el antebrazo derecho, con áreas violáceas, que crepita a la palpación. Su frecuencia cardíaca es de 108x', con PA: 90/60 mmHg y su hemograma muestra leucocitosis de 17.000. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Loxocelismo cutáneo
- b) Celulitis
- c) Úlcera por presión
- d) Fascitis necrosante
- e) Miositis necrosante

29) Un paciente de 65 años, con antecedentes de hipertensión y dislipidemia, consulta por dolor en las pantorrillas de dos años de evolución, que aparece al caminar y que le obliga a detenerse, luego de caminar una cuadra. Al examen físico presenta pulso irregular y ausencia de los pulsos pedios de ambas extremidades inferiores. El diagnóstico más probable es:

- a) Disección aórtica
- b) Aneurisma aórtico abdominal
- c) Insuficiencia venosa
- d) Embolia bilateral de EEII
- e) Enfermedad arterial oclusiva

30) Un paciente de 28 años sufre un accidente con un vidrio, resultando con una herida cortante en el muslo izquierdo, de 10 cm de largo, que sangra profusamente. ¿Cuál es la mejor forma de manejar la hemorragia?

- a) Aplicación de torniquete
- b) Compresión directa de la herida
- c) Identificar y ligar el vaso sanguíneo sangrante
- d) Compresión de la arteria femoral
- e) Cubrir la herida con apósitos

31) Un paciente sufre una herida por arma blanca en el abdomen, hace 8 horas. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y examen abdominal sin signos de irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes. Se realiza exploración digital de la herida, con anestesia local, objetivándose laceración del peritoneo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar lavado peritoneal diagnóstico
- b) Realizar ecografía fast
- c) Suturar la herida
- d) Solicitar TAC abdominal
- e) Realizar laparoscopia exploradora

32) Un paciente de 28 años sufre una puñalada en el tórax, en el lado derecho. Al examen físico está en buenas condiciones, con dolor torácico y presenta disminución del murmullo pulmonar, asociado a hipersonoridad a la percusión en el hemitórax derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Pedir radiografía de tórax
- b) Pedir resonancia magnética de tórax
- c) Instalar un tubo pleural
- d) Solicitar TAC de tórax
- e) Realizar videotoracoscopia

33) Un paciente de 73 años presenta un cuadro de 2 días de dolor abdominal, mayor en la fosa iliaca izquierda. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda, con signos de irritación peritoneal en la zona. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Apendicitis aguda
- b) Cáncer de colon
- c) Obstrucción intestinal
- d) Diverticulitis aguda
- e) Hernia inguinal complicada

34) Un paciente se realiza una colonoscopia, para la resección de unos pólipos intestinales. Algunas horas después presenta dolor abdominal bajo, asociado a hematoquezia escasa y malestar general. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir con el estudio en este paciente?

- a) Resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis
- b) Ecografía abdominal y pélvica
- c) Colonoscopia
- d) Radiografía de abdomen y pelvis
- e) TAC de abdomen y pelvis

35) Un paciente presenta dolor epigástrico muy intenso, irradiado a ambos costados, . Tiene antecedente de una transgresión alimentaria y consumo de alcohol, el día anterior. Al examen físico se aprecia adolorido, con temperatura 38 grados, abdomen difusamente doloroso a la palpación, con disminución de los ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

- a) Úlcera perforada
- b) Isquemia mesentérica
- c) Hepatitis
- d) Colecistitis aguda
- e) Pancreatitis aguda

36) Un paciente presenta hace una semana dolor en el hipocondrio derecho, intenso, asociado a vómitos, que cede espontáneamente. Actualmente está en buenas condiciones, asintomático, sin alteraciones en el examen físico. ¿Qué examen es el más adecuado para estudiar a este paciente?

- a) Ecografía abdominal
- b) Radiografía de abdomen
- c) Amilasa / Lipasa
- d) Colangioresonancia
- e) TAC de abdomen

37) Un paciente de 67 años, diabético, hipertenso, presenta dolor torácico intenso, irradiado al dorso, EVA 9/10. Al examen físico está taquicárdico, con presión arterial es de 160/110, examen cardiaco con RR2T y se ausculta un soplo diastólico en el reborde esternal derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Pericarditis aguda
- c) Infarto agudo al miocárdico con rotura de la pared libre
- d) Infarto agudo al miocárdico con rotura del tabique interventricular
- e) Disección aórtica

38) Un paciente de 70 años, hipertenso, presenta dolor torácico de dos días de evolución, intenso, asociado a malestar general. En las últimas horas se agrega disnea y síncope ortostáticos. Al examen físico aparece un soplo holosistólico en el ápex. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Taponamiento cardiaco por rotura de la pared libre
- b) Disección aórtica
- c) Insuficiencia mitral por rotura del músculo papilar
- d) Endocarditis bacteriana
- e) Cardiopatía hipertensiva, descompensada

39) Se muestra la siguiente radiografía:



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cáncer pulmonar
- b) Neumoperitoneo
- c) Signo de Chilaiditi
- d) Absceso pulmonar
- e) Quiste hidatídico

40) Un paciente es sometido a una colecistectomía y a las 24 horas presenta fiebre hasta 38,3 grados celsius. Su examen físico muestra un paciente febril, con crepitaciones en la base pulmonar derecha, asociado a roncus. Tiene vías venosas in situ, sin eritema y su herida quirúrgica está cerrada, sin exudado ni eritema. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Neumonía
- c) Atelectasia
- d) Infección de la herida operatoria
- e) Infección asociada a catéter

41) Un hombre de 60 años presenta aumento de volumen doloroso en la zona sacra baja. Al examen físico se aprecia aumento de volumen de 4 cm de diámetro, dolorosa a la palpación, fluctuante, con signos inflamatorios. El tratamiento más adecuado es:

- a) Curación plana
- b) Drenaje quirúrgico
- c) Antibióticos orales
- d) Punción y drenaje
- e) Analgésicos

42) Un paciente consulta por dolor anal, que aparece luego de defecar y persiste, asociándose a sangrado rectal, tras la defecación. Al examen físico presenta hipertonía del esfínter anal interno. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Indicar analgésicos y baños de asiento
- b) Resolver quirúrgicamente
- c) Solicitar resonancia magnética nuclear de pelvis y periné
- d) Solicitar colonoscopia
- e) Indicar laxantes

43) Un paciente de 46 años presenta un accidente, resultando con una fractura de pelvis. Presenta dolor y salida de sangre fresca por la uretra. Además se palpa la próstata ascendida en el tacto rectal y no ha podido orinar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Pedir un TAC de abdomen y pelvis
- b) Solicitar resonancia magnética
- c) Realizar cistoscopia
- d) Instalar sonda Foley
- e) Instalar cistostomía

44) Un paciente de 16 años presenta dolor testicular derecho intenso, de inicio súbito, asociado a náuseas. Al examen se palpa el testículo derecho muy doloroso y aumentado de tamaño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Torsión testicular
- b) Torsión de la hidátide
- c) Infarto testicular
- d) Orquiepididimitis
- e) Trombosis de varicocele

45) Un paciente de 68 años, fumador de 20 paquetes-año, presenta hematuria abundante, con coágulos. Se realiza un sedimento que muestra incontables glóbulos rojos y un urocultivo que resulta negativo. Se le realiza un TAC de abdomen y pelvis que no muestra alteraciones. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir con el estudio en este paciente?

- a) Ecografía pélvica
- b) Resonancia magnética nuclear
- c) Pielografía de eliminación
- d) Cistoscopia
- e) Uretrocistografía

46) Un paciente de presenta dolor abdominal en el flanco izquierdo, por lo que se realiza una ecografía abdominal, que muestra un tumor renal sólido, de 2,5 cm de diámetro, en el polo superior del riñón derecho. Se solicita un TAC, que confirma el tumor renal de aspecto sólido y que capta contraste. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Nefrectomía radical
- b) Nefrectomía parcial
- c) Nefroureterectomía
- d) Iniciar inhibidores de la tirosinasa
- e) Realizar seguimiento ecográfico

47) Una paciente de 57 años, multipara de 5, presenta incontinencia de esfuerzos moderados. Su examen físico muestra genitales normales, sin prolapso. Tiene sedimento de orina normal y urocultivo negativo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente?

- a) Oxibutinina
- b) Suspensión uretral
- c) Terapia de remplazo hormonal
- d) Kinesioterapia pélvica
- e) Doxazosina

48) Una paciente de 69 años diabética, mal controlada, presenta escapes de orina. Además ha presentado algunas infecciones urinarias. Su urocultivo actual está negativo, pero consulta por la incontinencia urinaria. Se realiza una ecografía que muestra una vejiga de paredes lisas, con volumen urinario de 930cc y residuo postmiccional de 750cc. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Resolver quirúrgicamente
- b) Instalar una sonda Foley
- c) Realizar cateterismo intermitente
- d) Indicar anticolinérgicos
- e) Indicar colinérgicos

49) Un paciente ha presentado 5 episodios de litiasis uretral en los últimos años. ¿Cuál es la alteración metabólica más probable en este paciente?

- a) Hiper calciuria
- b) Hiper oxaluria
- c) Hiper uricosuria
- d) Hipo citraturia
- e) Hiper cistinuria

50) Un paciente presenta dolor lumbar intenso, irradiado a testículo, que se ha asociado a vómitos y a inquietud psicomotora. Su sedimento de orina muestra microhematuria. ¿Qué examen es más adecuado para confirmar el diagnóstico en este paciente?

- a) TAC de abdomen con contraste
- b) Ecografía abdominal
- c) PieloTAC
- d) Pielografía de eliminación
- e) Radiografía simple de abdomen y pelvis

51) Un paciente de 81 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer, usuario de Sonda Foley a permanencia, se realiza un urocultivo, porque sus orinas se han vuelto turbias. Dicho urocultivo resulta positivo para Escherichia coli, con más de 100.00 UFC, sensible a nitrofurantoína, gentamicina e imipenem. ¿Cuál de las siguientes actitudes es la más adecuada?

- a) Observar evolución
- b) Indicar tratamiento con imipenem
- c) Indicar tratamiento con gentamicina
- d) Indicar tratamiento con nitrofurantoína
- e) Retirar la sonda

52) Un paciente de 27 años sufre una fractura cerrada de antebrazo, que es manejada con un valva de yeso braquiopalmar. A las 5 horas presenta aumento del dolor y edema de la extremidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Trombosis venosa profunda
- b) Síndrome compartimental
- c) Distrofia simpático refleja
- d) Alergia al yeso
- e) Síndrome de túne carpiano agudo

53) Un paciente hipertenso y diabético se realiza un perfil lipídico, que muestra triglicéridos de 350 mg/dl, colesterol LDL de 230 mg/dl y colesterol HDL de 37. ¿Qué tratamiento debe indicarse?

- a) Atorvastatina
- b) Gemfibrozilo
- c) Insulina
- d) Lovastatina más gemfibrozilo
- e) Ezetimibe

54) Un paciente de 31 años presenta un cuadro de disnea de esfuerzos, ortopnea y astenia. Su presión arterial es 120/70 mmHg y su pulso es de 80x', además presenta edema en las EEII. Presenta desplazamiento del choque de la punta, a dos centímetros de la línea medio-clavicular y se ausculta galope cardiaco, con un soplo sistólico en el ápex, que no varía con la inspiración. Al examen pulmonar tiene crepitos basales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Miocardiopatía hipertrófica
- b) Miocardiopatía dilatada
- c) Insuficiencia aórtica
- d) Estenosis aórtica
- e) Estenosis mitral

55) Un paciente de 82 años ha presentado disnea de esfuerzos y ha presentado síncope, relacionado con actividad física, con recuperación total. Al examen físico presenta presión arterial 120/70 mmHg, FC: 70 x', y a la auscultación cardíaca tiene un soplo paraesternal, de tonalidad ruda, luego del primer ruido, asociada a una disminución marcada del segundo ruido. Además, el choque de la punta se palpa desplazado. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
- c) Estenosis mitral
- d) Insuficiencia mitral
- e) Cardiopatía coronaria

56) Un paciente de 79 años presenta dolor torácico opresivo, que aparece al caminar y que cede con el reposo. Al examen físico se ausculta un soplo sistólico IV de VI, irradiado a la zona baja del cuello. El examen más adecuado para proseguir con su estudio es:

- a) Prueba de esfuerzo
- b) Electrocardiograma
- c) Coronariografía
- d) AngioTAC de torax
- e) Ecocardiografía doppler

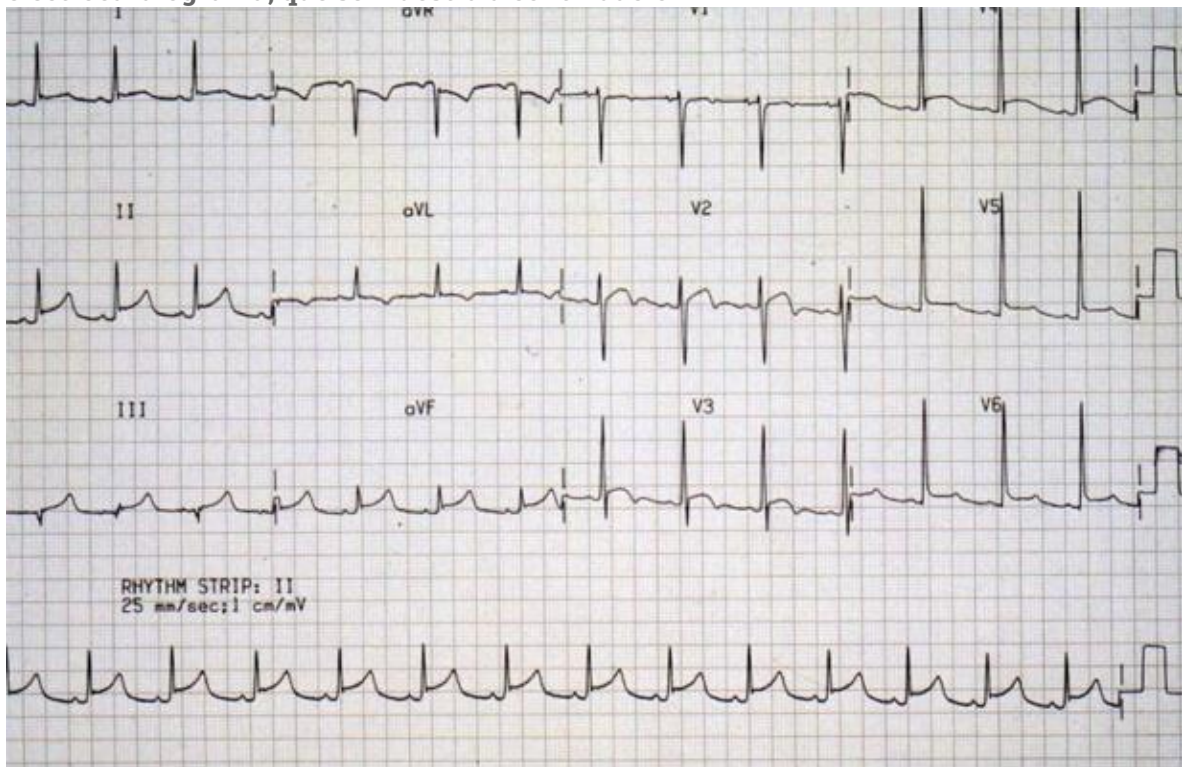
57) Un paciente de 30 años presenta un cuadro de astenia, adinamia y disnea de esfuerzos. Presenta un soplo sistólico eyectivo, con desdoblamiento del segundo ruido y algunos crépitos pulmonares. Su electrocardiograma muestra un bloqueo completo de rama derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Comunicación interventricular
- b) Comunicación interauricular
- c) Ductus arterioso persistente
- d) Tetralogía de Fallot
- e) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

58) Un paciente de 62 años, fumador de 30 paquetes años, presenta edema de extremidades inferiores, asociado a astenia, disnea y adinamia. Al examen físico presenta yugulares visibles a 45 grados y aumento de la intensidad del segundo ruido cardíaco. Su electrocardiograma muestra una onda R prominente en V1 más un bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Estenosis tricuspídea
- b) Pericarditis constrictiva
- c) Cardiopatía coronaria
- d) Cor pulmonale
- e) Cardiopatía hipertensiva

59) Un paciente de 30 años, deportista, pregunta por dolor precordial opresivo, de dos días de evolución, irradiado al cuello y al hombro izquierdo, intenso. Además presenta disnea que aumenta al recostarse. Al examen físico está adolorido, con RR2T sin soplos. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación:

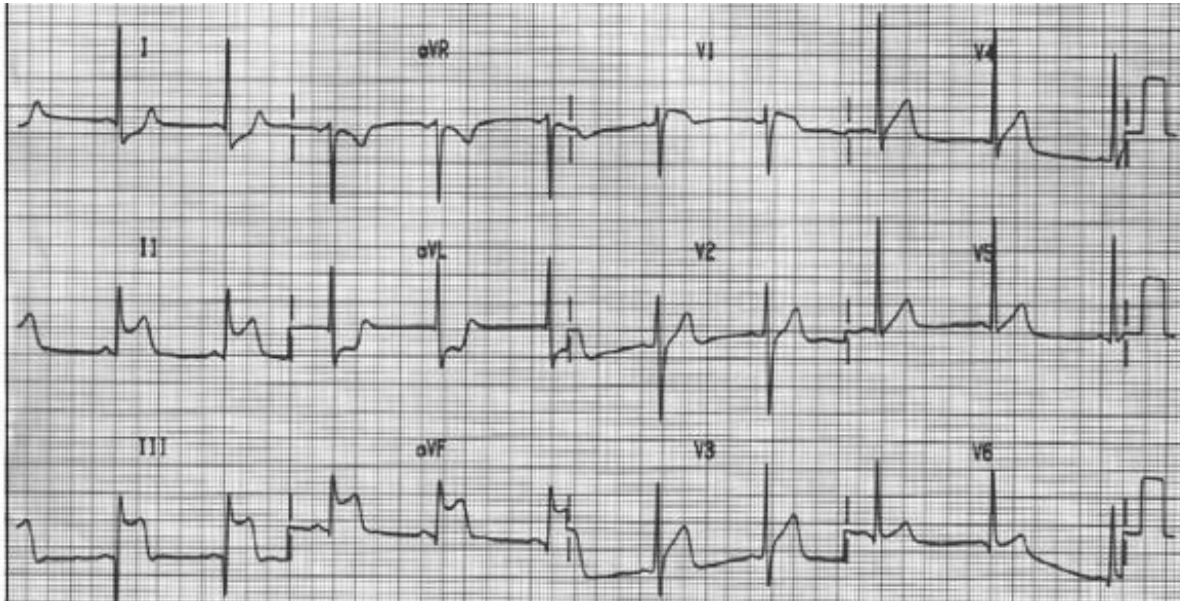


El

diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Neumotórax
- c) Pericarditis aguda
- d) Miocardiopatía hipertrófica
- e) Costocondritis del deportista

60) Un paciente de 60 años presenta dolor precordial, irradiado al cuello, de 4 horas de evolución, EVA 9/10. Al examen físico está sudoroso, disneico, con RR2T, sin soplos. Se solicita un ECG que se muestra a continuación:



¿Cuál es el tratamiento más importante en este paciente?

- a) Anticoagulantes
- b) Revascularización inmediata
- c) Administración de fuidos intravenosos
- d) Disminuir la presión arterial
- e) Oxigenoterapia y antiarrítmicos

61) ¿Cuál es el mejor examen para determinar si una insuficiencia cardiaca es de origen isquémico?

- a) Electrocardiograma
- b) Holter de electrocardiograma
- c) Contigrafi de perfusión miocárdica
- d) Ecografía bidimensional
- e) Test de esfuerzo

62) Un paciente diabético de larga data, en tratamiento con insulina, presenta presión arterial de 148/102. Además su índice proteinuria/creatininuria resulta 0,3. ¿Qué fármaco es más adecuado para el manejo de este paciente?

- a) Amlodipino
- b) Enalapril
- c) Carvedilol
- d) Hidroclorotiazida
- e) Diltiazem

63) Un paciente de 40 años, hospitalizado hace 3 días por un síndrome nefrótico, presenta disnea, de inicio súbito. Presenta desaturación arterial hasta 90%, con disminución del murmullo pulmonar a derecha y matidez, por lo que se realiza una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural. Se punciona el derrame, dando salida a un líquido hemorrágico, con LDH: 700, predominio de polimorfonucleares, pH: 7,3 y lactato de 4,0 mmol/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Empiema
- b) Derrame paraneumónico simple
- c) Tromboembolismo pulmonar
- d) Transudado pleural
- e) Compromiso pleural maligno

64) Un niño de 7 años presenta edema de párpados y de EEII, asociado a orinas oscuras. Al examen tiene edema de párpados y de ambas piernas, con presión arterial de 127/85. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome nefrítico
- b) Síndrome nefrótico
- c) Enfermedad de Berger
- d) Necrosis tubular aguda
- e) Síndrome hemolítico urémico

65) Un paciente de 32 años presenta un cuadro de dos días de odinofagia, fiebre y mialgias, a lo que se agrega hematuria. En sus exámenes destaca sedimento de orina con incontables glóbulos rojos, con 9% de dismorfia, creatinina plasmática de 0,7 mg/dl, BUN: 13 mg/dl, C3 y C4 en niveles normales y proteinuria de 500 mg/día. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Nefropatía mesangiocapilar
- b) Lupus
- c) Glomerulonefritis postestreptocócica
- d) Nefropatía por IgA
- e) Vasculitis de vaso pequeño

66) Un paciente de 62 años presenta un cuadro de varios días de evolución, de orinas espumosas, asociado a edema marcado de extremidades inferiores. Su sedimento de orina muestra 2-4 hematíes por campo, 5-10 leucocitos por campo, creatininemia de 1,2 mg/dl y proteinuria de 24 horas de 7 gramos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Nefropatía por IgA
- b) Enfermedad renal lúpica
- c) Glomerulonefritis postestreptocócica
- d) Glomerulonefritis mesangiocapilar
- e) Nefropatía membranosa

67) Un paciente de 64 años, con antecedente de haber sido tratado por un mieloma, con buena respuesta, consulta ahora por cuadro de astenia, con constipación y aumento del volumen urinario, a lo que luego se le agrega desorientación. Al examen físico se aprecia soporoso, pálido. En sus exámenes presenta hematocrito 27%, con Hb: 9 g/dl, VHS: 93 mm/h, proteínas plasmáticas: 7,8 g/dl, albúmina: 3,7 g/dl, sodio: 140 mEq/L, potasio: 4,8 mEq/L, calcio: 14,3 mg/dl. En este momento debe recibir:

- a) Calcitonina
- b) Solución salina al 0,9%
- c) Vitamina D
- d) Bifosfonatos
- e) Corticoides

68) Un paciente consulta muy angustiado, porque cree ser pedófilo. Le aterra acercarse a los niños y no sabe qué hacer, a pesar de que sabe que su idea es rara. Refiere que reza para no serlo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno delirante cónico
- b) Trastorno esquizoafectivo
- c) Trastorno psicótico agudo
- d) Trastorno obsesivo compulsivo
- e) Parafilia

69) Una mujer de 40 años pierde súbitamente la movilidad de ambos brazos. Esto sucede en relación a la reactivación de un conflicto familiar. Al examen físico se aprecia una disociación con los síntomas, por lo que se descarta patología orgánica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno somatomorfo
- b) Trastorno facticio
- c) Trastorno conversivo
- d) Trastorno disociativo
- e) Trastorno adaptativo

70) Un paciente sufre una fractura de muñeca, en relación a un accidente laboral. Presenta con mucho dolor, a pesar de haber evolucionado bien y de llevar mucho tiempo desde el accidente. Tiene antecedente de cuadros previos similares, con dolores crónicos y difíciles de tratar. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno somatomorfo
- b) Trastorno conversivo
- c) Trastorno de estrés postraumático
- d) Depresión reactiva
- e) Trastorno facticio

71) Una paciente de 82 años, con antecedente de 2 intentos de suicidio previos, presenta un cuadro de ánimo bajo, irritabilidad, problemas de memoria. Su minimental es 27/30, su GDS (escala de depresión geriátrica) es de 12/15 y presenta ideas delirantes de daño. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Terapia electroconvulsiva
- b) Iniciar sertralina
- c) Hospitalizar con mirtazapina
- d) Indicar clorpromazina
- e) Hospitalizar con amitriptilina

72) Un paciente de 24 años presenta un cuadro de ánimo exaltado e irritabilidad. Presenta verborrea y muchas ideas de éxito y negocios. Los familiares se muestran muy preocupados. Actualmente duerme dos horas al día, porque no se siente cansado. Al examen físico presenta verborrea, luego se vuelve agresivo y finalmente se agita. ¿Qué fármaco debe recibir en este momento?

- a) Olanzapina
- b) Escitalopram
- c) Ácido valproico
- d) Litio
- e) Haloperidol

73) Un paciente bipolar recibe haloperidol y tras su tercera dosis presenta contracción persistente y dolorosa del cuello y del brazo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Disonía aguda
- b) Acatisia
- c) Síndrome neuroléptico maligno
- d) Balismo
- e) Disquinesia tardía

74) Un paciente de 18 años presenta un cuadro de ánimo bajo, en tratamiento con antidepresivos por 3 meses, sin respuesta. Sus padres están muy preocupados, porque permanece encerrado en su cuarto, sin hacer nada, ni siquiera ver televisión. Al examinarlo, no se aprecia anhedonia, ni tristeza. No ha tenido alucinaciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Distimia
- b) Trastorno de personalidad esquizoide
- c) Esquizofrenia
- d) Trastorno esquizoafectivo
- e) Depresión mayor

75) Un paciente de 24 años tiene la idea de que es el enviado de Dios y que está encargado de la salvación de las almas. Se muestra convencido de ello y al confrontarlo con la realidad, reacciona algo agresivo. Es un paciente tranquilo, con pocos amigos y afectivamente plano. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno esquizoafectivo
- b) Trastorno bipolar
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Trastorno de personalidad narcisista
- e) Esquizofrenia

76) Un paciente de 56 años dice, desde hace algunos meses, que sus vecinos lo espían y que están conspirando contra él. No tiene otros problemas y tiene una vida laboral y familiar normales. La esposa se muestra muy preocupada y refiere además que el paciente es aceptado y querido por todos y que los vecinos nunca lo han espiado ni nada similar. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Depresión
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Trastorno de personalidad paranoide
- e) Trastorno obsesivo compulsivo

77) Un niño de 4 años no tiene interés en juntarse con otros niños, no habla y solo se comunica con señas. Aplauda con frecuencia, ante situaciones estresantes, no le gusta que lo toquen y juega siempre con el mismo juguete. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno global del desarrollo
- b) Trastorno del espectro autista
- c) Hipoacusia
- d) Parálisis cerebral
- e) Trastorno de conducta

78) Un niño de 5 años presenta movimientos repetitivos con las manos, estereotipados (manierismos), no habla y solo se comunica con señas, no se relaciona con otros niños y llora cuando le quitan el sombrero. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno generalizado del desarrollo
- b) Trastorno por déficit atencional
- c) Trastorno de conducta
- d) Hipotiroidismo congénito
- e) Epilepsia generalizada

79) Una paciente tiene relaciones interpersonales intensas e inestables y problemas frecuentes con las demás personas. Presenta antecedentes de dos intoxicaciones medicamentosas y autoagresiones. Además estuvo en tratamiento por bulimia hace un año. Tiene un sentimiento crónico de inutilidad y vacío. Además es impulsiva en el consumo de alcohol y compras. ¿A qué trastorno de la personalidad corresponde el cuadro?

- a) Histriónico
- b) Limítrofe
- c) Narcisista
- d) Antisocial
- e) Dependiente

80) Una paciente de 17 años ha bajado 15 kilogramos en el último tiempo. Su IMC actual es de 16. Tiene mucho miedo a engordar y de hecho quiere bajar un poco más de peso, por lo que luego de comer se induce vómitos, con mucha frecuencia. Está en amenorrea desde hace 4 meses. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno alimentario no especificado
- b) Bulimia nervosa
- c) Anorexia nervosa
- d) Depresión mayor
- e) Distimia

81) Un paciente de 54 años, alcohólico hace 20 años, que en contexto de una festividad consume abundante alcohol, con cerca de 3 botellas de vino al día. Se reintegra a su trabajo y al tercer día después de suspender el consumo, evoluciona con un cuadro de malestar general, ansiedad, temblor, seguido luego de agitación psicomotora y alucinaciones. ¿Qué fármaco debe administrarse?

- a) Diazepam
- b) Fenobarbital
- c) Fenitoína
- d) Haloperidol
- e) Tiamina

82) Una paciente de 20 años presenta mucha ansiedad ante las situaciones en que debe hacer exposiciones o presentaciones ante los demás. Presenta sudoración y palpitaciones antes de las presentaciones, con opresión cordial y disnea y esta dispuesta incluso a aumentar su carga de trabajo, con tal de evitar ese tipo de situaciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno de ansiedad generalizada
- b) Trastorno de personalidad evitativo
- c) Trastorno de personalidad dependiente
- d) Trastorno de angustia
- e) Trastorno de ansiedad social

83) Una paciente de 24 años presenta un cuadro de opresión precordial, disnea, parestesias en extremidades superiores, palpitaciones y mucha ansiedad y miedo. Los síntomas se instalan en pocos minutos. ¿Cuál es el mejor medicamento para el manejo de esta crisis?

- a) Diazepam
- b) Fluoxetina
- c) Lorazepam
- d) Haloperidol
- e) Clorpromazina

84) Una paciente que desde niña es muy tímida, tiene dificultades para relacionarse con otras personas, por temor al rechazo. No ha tenido pareja y evita las situaciones en que hay muchas personas. Le gustaría mejorar su situación y desarrollar su autoestima. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno de personalidad evitativo
- b) Trastorno de personalidad dependiente
- c) Fobia social
- d) Agorafobia
- e) Trastorno de ansiedad generalizada

85) Un paciente de 55 años ha presentado varios cambios cognitivos conductuales, como tendencia a la apatía, lenguaje coprolálico o andar desnudo. No ha tenido alteraciones en la conciencia ni en la memoria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Demencia por cuerpos de Lewy
- b) Hidrocefalia normotensiva
- c) Enfermedad de Alzheimer
- d) Demencia frontotemporal
- e) Delirium

86) Un paciente de 25 años presenta mal rendimiento en la universidad, habiendo reprobado una de las asignaturas. Refiere que no se concentra en sus estudios y que no alcanza a leer toda la materia. En la entrevista se ve verborreico, inquieto y teatral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno histriónico de la personalidad
- b) Déficit atencional
- c) Trastorno bipolar
- d) Insuficiencia intelectual leve
- e) Síndrome de Asperger

87) Un niño de 7 años perdió el año escolar. Presenta dificultades en la lectoescritura, invierte fonemas con frecuencia, es muy lento para leer y le cuesta deletrear. Su padre no terminó el colegio, porque tenía problemas similares. El diagnóstico más probable es:

- a) Coeficiente intelectual límite
- b) Trastorno oposicionista desafiante
- c) Trastorno por déficit atencional
- d) Dislexia
- e) Trastorno del desarrollo

88) Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso, consulta por aparición de placas eritematodescamativas en las rodillas y los codos. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis de contacto
- b) Psoriasis vulgar
- c) Tiña corporis
- d) Pitiriasis rosada de Gibert
- e) Dermatitis atópica

89) Adolescente de 20 años, consulta por la siguiente lesión, en el pliegue interglúteo, que presenta



prurito y ardor:

El diagnóstico más probable es:

- a) Picadura de insecto
- b) Consilomas acuminadas
- c) Herpes simplex
- d) Impétigo ampollar
- e) Erisipela

90) Un niño de 7 meses nació con una mácula eritematosa, de tres cm, en la mano izquierda, la que ha ido creciendo en tamaño y espesor. Actualmente se ve de la siguiente forma:

FOTO: No encontré fotos en internet, pero la imagen era una placa, que afectaba el dorso de la mano, de color rojo, de 1 mm de alto y de 4 a 5 cm de largo.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Observar evolución
- b) Corticoides orales
- c) Corticoides locales
- d) Propanolol
- e) Cirugía

91) ¿Cuál es la conducta más adecuada ante un hombre joven, que presenta múltiples condilomas acuminados perianales?

- a) Descartar otras enfermedades de transmisión sexual
- b) Determinar el genotipo del virus papiloma
- c) Realizar rectosigmoidoscopia
- d) Realizar tratamiento con podofilino
- e) Indicar aciclovir oral

92) ¿Cuál es el mejor tipo de estudio para enfermedades poco prevalentes?

- a) Serie de casos
- b) Estudio de cohortes
- c) Ensayo clínico
- d) Estudio ecológico
- e) Estudios de caso-control

93) ¿Para qué se utiliza la aleatorización?

- a) Para que el evaluador pueda escoger los grupos
- b) Para que el evaluador y el sujeto de estudio den información confiable, sin sesgos
- c) Para evitar sesgos de selección
- d) Para asegurar que la muestra sea representativa de la población general
- e) Para disminuir los errores causados por el azar

94) ¿Cómo se financia el seguro público de salud?

- a) El aporte estatal, desde los impuestos generales
- b) El aporte tripartito del estado, los empleadores y trabajadores
- c) El aporte de las mutuales
- d) El 7% de los trabajadores
- e) El aporte de los empleadores

95) Las instituciones de salud previsional y el seguro público de salud tienen en salud que:

- a) Administrar el seguro de cotización individual
- b) Administran el seguro público de salud
- c) Administrar los fondos para las garantías de salud, comprendidas en el plan AUGE
- d) Administran el seguro general de salud
- e) Dan prestaciones de salud

96) ¿Qué institución es la encargada de acreditar y autorizar a los prestadores individuales de salud y a los centros de salud?

- a) La superintendencia de seguridad social
- b) La autoridad regional sanitaria
- c) La superintendencia de salud
- d) Fonasa
- e) La municipalidad

97) ¿Qué instituciones están encargadas de administrar el seguro de la salud laboral, accidentes del trabajo y del trayecto?

- a) Instituciones de Salud Previsional
- b) Instituto de Salud Laboral
- c) Superintendencia de Seguridad Social
- d) Instituto Nacional de Previsión
- e) Mutualidades de empleadores

98) ¿Qué significa que una enfermedad se endémica?

- a) Que mantiene una frecuencia relativamente estable en la zona, con sus variaciones estacionales
- b) Aquella que presenta muchos más casos, a los habituales para la zona geográfica
- c) Que se extiende a todos los lugares del planeta
- d) Aquella que presenta varios casos, relacionados entre sí, en un corto periodo de tiempo
- e) Aquella que presenta casos escasos, sin poder identificar un patrón

99) ¿Qué rama de la Salud Pública se preocupa de obtener información, a través del contraste de hipótesis?

- a) Epidemiología descriptiva
- b) Bioestadística
- c) Prevención de salud
- d) Epidemiología analítica
- e) Vigilancia epidemiológica

100) ¿Cuál es el indicador que más se utiliza para reflejar el nivel de desarrollo de los países?

- a) Tasa de morbilidad general
- b) Tasa de mortalidad general
- c) Tasa de fecundidad
- d) Tasa de natalidad
- e) Tasa de mortalidad infantil

101) Un paciente de 18 años sufre un pelotazo en la cara hace 7 días, evolucionando con dolor, obstrucción nasal, rinorrea purulenta y fiebre. Está subfebril y se aprecia aumento de volumen bilateral, en relación al septo nasal. En sus exámenes destaca leucocitosis de 15.000 blancos por mm³. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar drenaje con punción
- b) Indicar antibióticos orales
- c) Poner tapón, con gasas empapadas en antibióticos tópicos
- d) Indicar corticoides y descongestionantes
- e) Realizar drenaje inmediato con bisturí

102) Un niño de 7 años presenta otalgia derecha, asociada a otorrea. Al examinarlo presenta otorrea, sin olor y a la otoscopia presenta canal auditivo estrecho, por lo que no es posible ver el tímpano. Además presenta dolor al traccionar el pabellón auricular. EL diagnóstico más probable es:

- a) Otitis media aguda
- b) Otitis media crónica
- c) Otitis externa
- d) Tapón de cerumen
- e) Otomastoiditis aguda

103) Un paciente de 30 años presenta disfonía persistente, de un mes de evolución, que inició al asistir a un concierto de Rock. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Nódulos vocales
- b) Disfonía musculotensional
- c) Cáncer de laringe
- d) Pólipos vocales
- e) Reflujo faringo-laríngeo

104) Un paciente de 59 años presenta hipoacusia bilateral, asociado a otorrea, de larga data. Consulta por un cuadro de reciente inicio, de mayor hipoacusia derecha, asociada a vértigo persistente, que ha ido en aumento. Al examen se aprecia nistagmo horizontal, con fase rápida a derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Otomastoiditis aguda
- b) Laberintitis aguda
- c) Vértigo postural paroxístico
- d) Absceso cerebral
- e) Neuronitis vestibular

105) Un paciente de 80 años, diabético, hipertenso y fumador de 30 paquetes-año, consulta por dificultades para leer, que ha empeorado lentamente. Además notó hace poco una metamorfopsia en el ojo izquierdo. Tiene agudeza visual de 0,8 en el ojo derecho y de 0,4 en el ojo izquierdo y al examen ocular, se aprecia leve disminución del rojo pupilar bilateral, con reflejos fotomotores normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Degeneración macular relacionada con la edad
- b) Glaucoma de ángulo abierto
- c) Desprendimiento de retina
- d) Glaucoma de ángulo estrecho
- e) Retinopatía diabética

106) Una paciente de 60 años está en espera de cirugía, por obstrucción crónica del conducto nasolagrimal, sin embargo presenta cuadro de aumento de volumen en la zona medial del ojo derecho, con dolor, eritema y epifora. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos orales
- b) Indicar masajes y compresiones locales
- c) Indicar corticoides tópicos
- d) Indicar antibióticos en colirios
- e) Resolver quirúrgicamente

107) Una paciente miope, usuaria de lentes de contacto blando, consulta por dolor ocular izquierdo, asociada a epifora. Al examen muestra ojo rojo periquerático en el ojo izquierdo, con lagrimeo y una zona de opacidad corneal de 2,1 mm de diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Conjuntivitis bacteriana
- b) Úlcera corneal
- c) Uveítis aguda
- d) Glaucoma agudo
- e) Blefaritis

108) Un paciente de 81 años presenta insomnio de conciliación y de mantención, que afecta sus actividades y lo tiene angustiado. Refiere que no duerme siesta. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el manejo de su insomnio?

- a) Clonazepam
- b) Diazepam
- c) Midazolam
- d) Alprazolam
- e) Zolpidem

109) Una paciente de 28 años, se realiza una histerectomía postparto, por una inercia uterina. Usted la atiende 6 meses después, sin lactancia y permaneciendo en amenorrea. Presenta un cuadro de astenia, adinamia y malestar general, asociada a debilidad. Tiene piel seca, con cabello quebradizo, palidez y su presión arterial es de 90/60 mmHg. El diagnóstico más probable es:

- a) Tiroiditis postparto
- b) Panhipopituitarismo
- c) Depresión postparto
- d) Insuficiencia ovárica
- e) Hipotiroidismo

110) Una paciente de 35 años presenta un cuadro de astenia importante. Al examen físico tiene FC: 59x', PA: 110/70 mmHg, se aprecia palidez, ictericia, vitiligo, edema de EEII, piel seca, con pelo quebradizo. En sus exámenes tiene hematocrito: 27%, con VCM: 110. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión
- b) Daño hepático crónico
- c) Déficit de vitamina B12
- d) Enfermedad de Addison
- e) Hipotiroidismo

111) Una paciente de 38 años, usuaria de anticonceptivos combinados orales, desde hace 4 meses, consulta por galactorrea de algunas semanas de evolución, sin otros síntomas. Las mamas se palpan sin nódulos y se objetiva la galactorrea al comprimir las mamas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar niveles de progesterona
- b) Solicitar niveles de prolactina
- c) Cambiar los anticonceptivos a progestágenos solos
- d) Solicitar TAC de cerebro
- e) Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, LH y FSH

112) Un paciente alcohólico, vagabundo, con antecedente de haber sido tratado por tuberculosis hace dos años, consulta por un cuadro de diarrea y baja de peso, malestar general de algunos meses de evolución. En su examen físico se aprecia IMC de 16, hiperpigmentación de pliegues y melanoplaquias. En sus exámenes tiene K: 5,5 mEq/L, Na: 132 mEq/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome paraneoplásico
- b) Desnutrición proteica
- c) Enfermedad de Addison
- d) Cáncer de sitio no precisado
- e) Pancreatitis crónica

113) Un paciente presenta astenia y aumento de tamaño de la mandíbula, con separación entre los dientes. Además refiere hipertrofia malar, de la nariz y las manos. También ha aumentado el número de sus zapatos. ¿Qué examen es más adecuado para continuar el estudio de este paciente?

- a) Niveles de hormona de crecimiento
- b) Radiografías de pies y de la arcada dentaria
- c) Radiografía de manos
- d) Niveles de IGF-1
- e) Resonancia magnética de hipófisis

114) Una paciente de 65 años, en tratamiento con calcio 2 gramos al día y vitamina D, 600 UI al día, se realiza una densitometría ósea que muestra un T score de -2,7 en la cadera derecha y de -2,8 en la columna lumbar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Indicar ejercicio aeróbico
- b) Indicar reposo relativo
- c) Aumentar dosis de vitamina D y calcio
- d) Agregar bifosfonatos al tratamiento
- e) Mantener el tratamiento

115) Una paciente de 17 años, con IMC de 34, presenta oligomenorrea, desde su primera menstruación. Además tiene acné y se observa hirsutismo en la cara, los pezones e intermamario. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?

- a) Testosterona plasmática
- b) Andrógenos totales
- c) Prueba de progesterona
- d) Índice de andrógenos libres
- e) 17 hidroxiprogesterona

116) Un paciente de 25 años consulta por diarrea, que inició hace 3 meses, que en ocasiones es sanguinolenta. Además presenta pujo y tenesmo frecuente y ha bajado 6 kilogramos de peso. Al examen físico, presenta dolor abdominal a la palpación del flanco izquierdo, ruidos hidroaéreos aumentados y úlceras orales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar endoscopia digestiva y anticuerpos antitransglutaminasa
- b) Iniciar antibióticos orales
- c) Solicitar colonoscopia
- d) Solicitar ecografía abdominal
- e) Pedir un TAC de abdomen y pelvis

117) Un paciente de 55 años, alcohólico, con daño hepático crónico, es traído al servicio de urgencia por deterioro del estado general, dolor abdominal y fiebre de 38,5 grados Celsius. Al examen físico está quejumbroso, en sopor, con dolor a la palpación abdominal y ascitis severa. Se solicita un hemograma que muestra hemoglobina 15 mg/dl, blancos de 15.000 por mm³ y plaquetas de 190.000 por mm³ y sus pruebas hepáticas muestran un daño hepático crónico en etapa C de Child Pugh . ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio de este paciente?

- a) Ecografía abdominal
- b) TAC de abdomen y pelvis
- c) Colangiografía resonancia
- d) Estudio de líquido ascítico
- e) Endoscopia digestiva alta

118) Una paciente de 40 años presenta marcada astenia y prurito intenso, en particular en las manos, que no ha respondido al tratamiento antihistamínico, indicado por el dermatólogo. En sus exámenes tiene hematocrito: 42%, blancos: 5.000, con 9% de eosinófilos, GOT: 58 UI/L, GPT: 39 UI/L, GGT: 300 UI/L, bilirrubina 2,0 UI/L, FA: 700 UI/L. ¿Cuál es el examen para continuar el estudio?

- a) Serología de virus hepatitis
- b) Anticuerpos antinucleares
- c) Ecografía hepática
- d) Parasitológico de deposiciones
- e) Anticuerpos antimitocondriales

119) Una paciente de 27 años presenta constipación de 3 años de evolución, con deposiciones caprinas, duras, que evacua una vez a la semana. Se realiza una radiografía de abdomen que muestra dolicocolon, con contenido en toda su extensión. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Laxantes osmóticos
- b) Laxantes de contacto
- c) Cambios de hábitos
- d) Proquinéticos
- e) Cirugía

120) Un paciente inicia tratamiento antituberculoso con 4 fármacos, por una tuberculosis pulmonar. Al séptimo día de tratamiento presenta vómitos y dolor abdominal luego de recibir los fármacos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Agregar omeprazol al tratamiento
- b) Retirar uno de los 4 fármacos
- c) Suspender el tratamiento y solicitar pruebas hepáticas
- d) Derivar para tratamiento secundario
- e) Mantener el tratamiento

121) Un paciente de 55 años con pirosis, que es mayor postprandial, que inició hace 2 meses y que ha aumentado en el último tiempo. Además presenta baja de peso de 4 kilogramos en dicho periodo y refiere dolor abdominal, que aumenta al palpar el epigastrio. Además en el último tiempo se han agregado vómitos postprandiales. ¿Cuál es el examen que debe solicitarse para estudiar a este paciente?

- a) Endoscopía digestiva alta
- b) pH-metría de 24 horas
- c) TAC de abdomen
- d) Ecografía abdominal
- e) Marcadores tumorales

122) Una paciente se realiza exámenes, ya que su pareja fue diagnosticada de hepatitis B. Tiene antígeno de superficie para VHB negativo y anticuerpos anti-VHBsuperficie positivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Vacunada contra la hepatitis B
- b) Hepatitis B aguda
- c) Hepatitis B crónica
- d) Hepatitis B en periodo de ventana
- e) Infección asintomática por virus hepatitis B

123) Un paciente con antecedente de daño hepático crónico por alcohol, presenta desorientación, lenguaje incoherente y tendencia a la somnolencia. Al examen físico presenta ictericia, arañas vasculares en la cara y el pecho, asterixis y compromiso cualitativo de conciencia. ¿Qué fármaco es el más adecuado para su tratamiento?

- a) Amonio
- b) N-acetil-cisteína
- c) Risperidona
- d) Donepezilo
- e) Lactulosa

124) Un paciente es diagnosticado de úlcera gástrica, con test de ureasa positiva, por lo que se inicia tratamiento con amoxicilina 1g cada 12 horas, claritromicina 500mg cada 12 horas y omeprazol 20mg cada 12 horas, por 10 días. Luego queda con omeprazol por 4 semanas más. Se controla posteriormente con antígeno de H. pylori en heces, que resulta positivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Repetir el tratamiento, pero por 14 días
- b) Realizar endoscopía digestiva alta y biopsia
- c) Indicar tratamiento erradicador de segunda línea
- d) Realizar test de ureasa
- e) Observar evolución

125) Un paciente de 23 años presenta dolor lumbar, irradiado a ambas piernas, de 2 años de evolución, y que suele ser mayor en la noche. Además presenta dolor torácico, que aumenta con los movimientos respiratorios. El dolor cede parcialmente con AINEs. Refiere un cuadro de artritis de rodilla derecha, autolimitado, hace un año. Al examen físico presenta restricción a los movimientos torácicos y a limitación de la flexión lumbar. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

- a) Factor reumatoide
- b) Resonancia magnética de articulaciones sacroiliacas
- c) TAC de columna lumbosacra
- d) Radiografía de tórax
- e) Hemograma y VHS

126) Una paciente de 45 años presenta dolor en el hombro derecho, que es mayor en la noche y que presenta impotencia funcional, que dificulta sus actividades. Al examen físico presenta dolor a la flexión y a la abducción tanto activa, como pasiva, del hombro derecho. La conducta más adecuada es:

- a) AINES y reposo
- b) AINES y kinesioterapia
- c) Cabestrillo
- d) Infiltración con corticoides
- e) Cirugía

127) Un paciente de 32 años regresa de un viaje a un país vecino. A los pocos días presenta un cuadro de 5 días de fiebre, asociado a malestar general, que es seguido luego de dolor abdominal, ictericia y orinas oscuras. Al examen físico está icterico, con dolor a la palpación del hipocondrio derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hepatitis A
- b) Hepatitis B
- c) Hepatitis alcohólica
- d) Colédocolitiasis
- e) Fiebre tifoidea

128) Una paciente está en tratamiento con ciprofloxacino por una infección urinaria. Al séptimo día inicia diarrea acuosa, abundante, asociada a dolor abdominal. Al examen físico se constata dolor a la palpación abdominal, sin irritación peritoneal, con aumento de los ruidos hidroaéreos. Los leucocitos fecales resultan positivos. ¿Cuál es el agente etiológico?

- a) Escherichia coli
- b) Clostridium difficile
- c) Shigella flexneri
- d) Rotavirus
- e) Campilobacter jejuni

129) Un niño de 7 años de edad presenta un cuadro de fiebre y odinofagia, asociado a malestar general. Al examen físico presenta faringe congestiva, con exudado amigdalino bilateral y se palpa adenopatía cervical, por lo que se inicia amoxicilina oral. Dos días después evoluciona con un exantema, que se muestra en la FOTO. El diagnóstico más probable es:



NOTA: la foto original era de un niño, pero el exantema es muy similar a este (fue la foto más parecida que hallé en Google)

- a) Escarlatina
- b) Reacción alérgica a la amoxicilina
- c) Eritema multiforme menor
- d) Artritis reumatoide juvenil
- e) Mononucleosis infecciosa

130) Una paciente de 25 años presenta un cuadro de cefalea holocránea y fiebre alta. Al examen físico presenta rigidez de nuca y signo de Brudzinsky, con petequias en extremidades inferiores, asociadas a algunas equimosis. El agente causal más probable es:

- a) Neisseria meningitidis
- b) Streptococcus pneumoniae
- c) Haemophilus influenzae
- d) Listeria monocytogenes
- e) Virus herpes simplex

131) Un paciente de 8 años presenta un cuadro de odinofagia de un día de evolución, intenso, asociado a fiebre. Al examen físico tiene faringe congestiva, con exudado amigdalino bilateral y presencia de una adenopatía cervical. Su hermano menor está en tratamiento por escarlatina confirmada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar amoxicilina oral
- b) Solicitar test pack para estreptococo
- c) Solicitar cultivo faríngeo
- d) Solicitar IgM para virus Epstein Barr
- e) Indicar tratamiento sintomático

132) Un niño de 5 años de edad presenta fiebre leve, asociada a eritema malar, que dura 2 días y luego cede. Al cuarto día aparece un exantema que afecta el tronco y las zonas extensoras de las extremidades. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Virus herpes 6
- b) Virus rubeola
- c) Virus sarampión
- d) Parvovirus B19
- e) Streptococcus pyogenes

133) Un niño de 9 años estuvo en contacto con un paciente con varicela hace 48 horas. No ha tenido varicela y no está vacunado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Vacuna antivariola
- b) Aciclovir
- c) Valaciclovir
- d) IgG antivariola
- e) Paracetamol

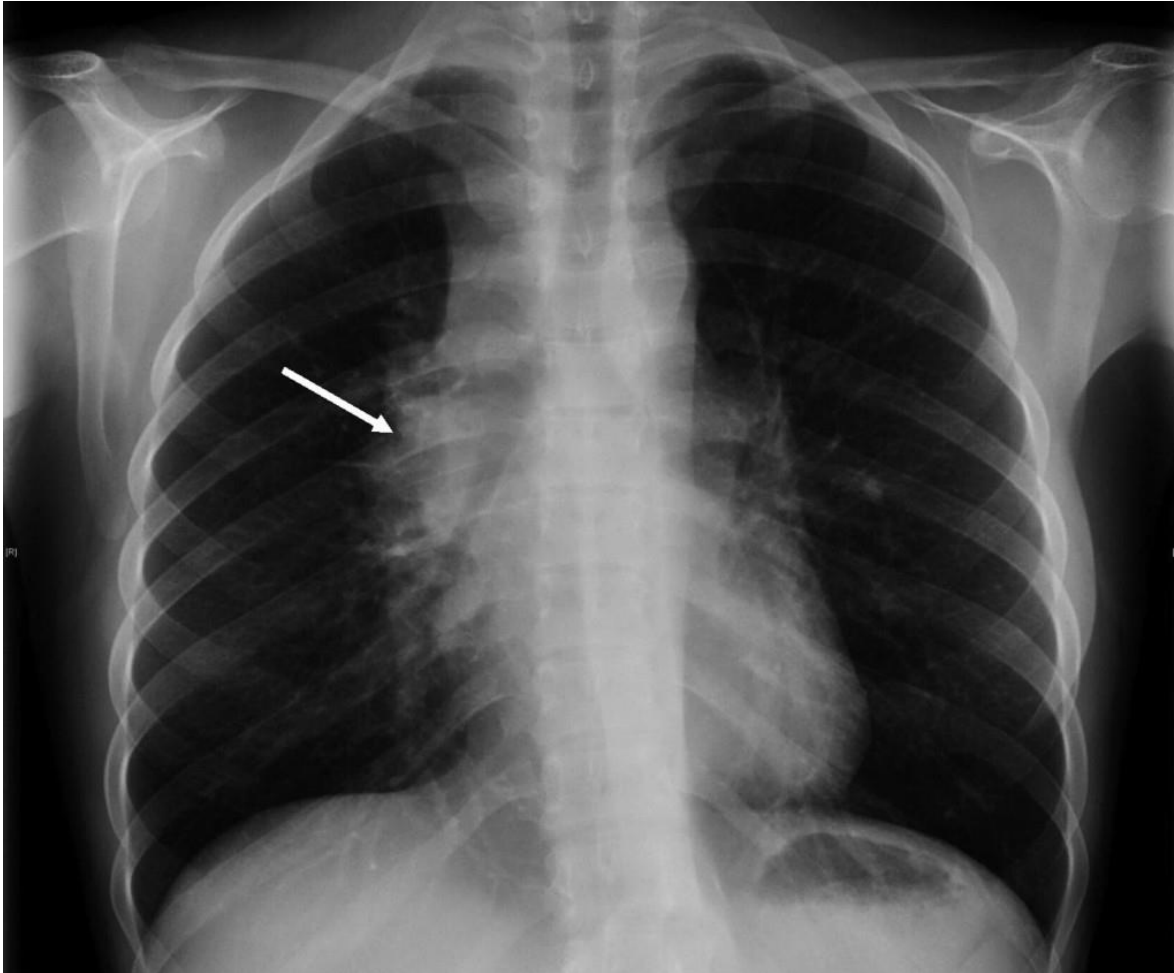
134) Un niño de 7 meses de edad es hospitalizado por una bronquitis aguda. Al quinto día de la hospitalización, presenta fiebre y diarrea acuosa abundante, de olor ácido, sin sangre, de cerca de 6 deposiciones líquidas al día. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Escherichia coli
- b) Shigella
- c) Clostridium difficile
- d) Rotavirus
- e) Enterovirus

135) Un paciente de 55 años, fumados de 30 paquetes-año, consulta por disnea de esfuerzos, progresiva. Su examen físico no muestra alteraciones. Se solicita una radiografía de tórax, que no muestra alteraciones y se realiza una espirometría, que muestra un VEF1 de 60%, que no mejora con broncodilatador. El diagnóstico más probable es:

- a) Bronquitis crónica
- b) Hipertensión pulmonar
- c) EPOC
- d) Asma
- e) Fibrosis pulmonar

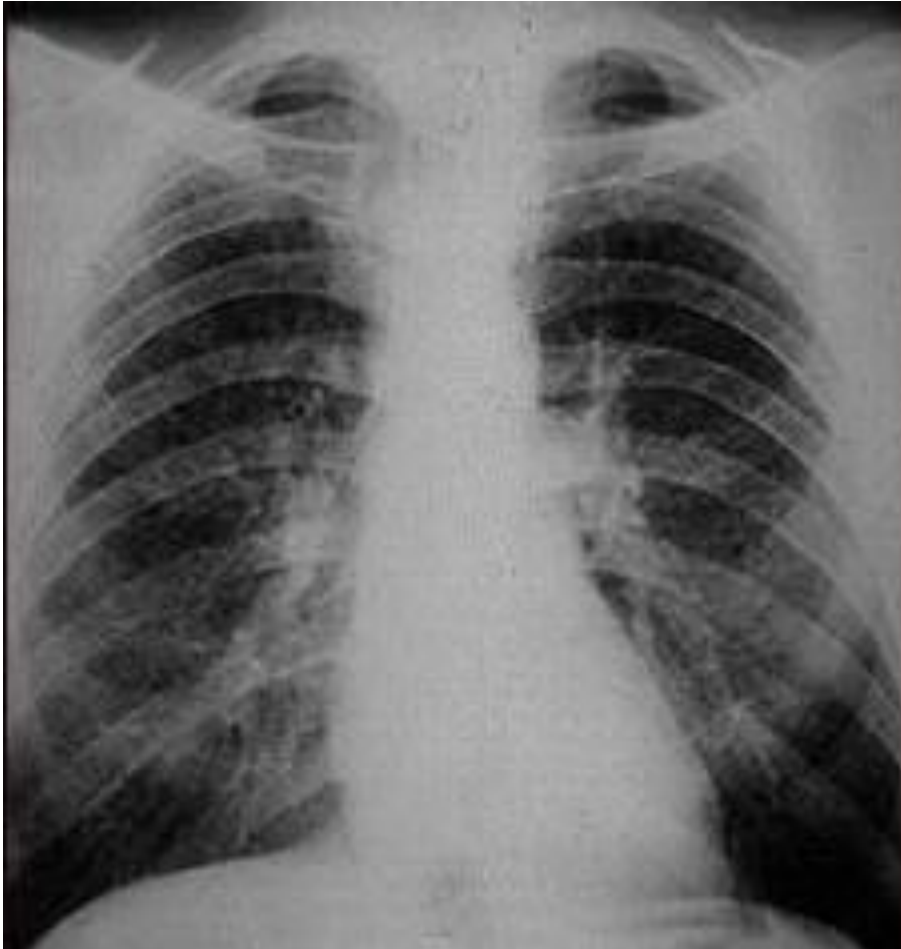
136) Un paciente de 60 años, hipertenso, fumador de 25 paquetes-año, consulta por tos de algunos meses de evolución. Su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. Se realiza radiografía que se muestra a continuación.



NOTA: la foto original no mostraba nada categórico. Era similar a la que se muestra, pero no tenía flecha.

- a) Cáncer
- b) Tuberculosis pulmonar
- c) Fibrosis pulmonar
- d) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- e) Cardiopatía hipertensiva

137) Un paciente de 67 años, fumador de 15 paquetes-año, pero que dejó de fumar hace 10 años, jubilado de la minería, consulta por disnea de esfuerzos, progresiva, de 6 meses de evolución, asociada a tos. Al examen físico presenta murmullo pulmonar globalmente disminuido, sibilancias y ronus bilaterales, asociados a crepitaciones difusas. Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación:



NOTA: la radiografía inicial mostraba infiltrados bilaterales, mayores en las zonas centrales, con imágenes verticales, onduladas de 1-2 cm en ambos campos pulmonares.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Bronquitis crónica
- b) Neumoconiosis
- c) Cáncer de pulmón
- d) Limitación crónica del flujo aéreo
- e) Fibrosis pulmonar idiopática

138) Un paciente de 50 años presenta un cuadro de tos, con expectoración mucopurulenta y fiebre. Al examen físico está se auscultan crepitaciones basales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra más abajo:

NOTA: la radiografía mostraba infiltrados en la base izquierda, que ocupaban el lóbulo inferior izquierdo, pero que permitían ver la cúpula diafragmática, con un pequeño derrame pleural, limitado al ángulo costofrénico.

Se punciona el derrame pleural, que muestra un lactato: 2,4 mmol/L, pH: 7,34, con 350 células, 90% de polimorfonucleares. ¿Qué antibiótico debe dejar?

- a) Claritromicina
- b) Clindamicina
- c) Ceftriaxona
- d) Azitromicina
- e) Amoxicilina

139) Un paciente de 70 años, diagnosticado de EPOC, presenta un cuadro de mayor dificultad respiratoria, asociada a aumento de su expectoración, la que se vuelve mucopurulenta. Además presenta fiebre y disnea de reposo. Al examen físico se aprecia respiratoriamente apremiado, con PA: 120/80, FC: 95x'. Se solicita radiografía que se muestra a continuación:



¿Qué antibiótico debe recibir?

- a) Claritromicina
- b) Amoxicilina
- c) Cefotaximo
- d) Amoxicilina más ácido clavulánico
- e) Clindamicina

140) Un paciente presenta una neumonía, con dificultad respiratoria, taquipnea, fiebre y desaturación arterial. Satura 75% a FiO2 ambiental y tiene gases arteriales, con una presión arterial de O2 de 54 mmHg y presión de CO2 de 32 mmHg. ¿Cómo debe administrarse el oxígeno a este paciente?

- a) Por naricera a 0,5 litros por minuto
- b) Por naricera a 2 litros por minuto
- c) Por mascarilla Venturi, a FiO2 de 24%
- d) Por mascarilla Venturi, a FiO2 de 40%
- e) Por ventilación mecánica invasiva

141) En contexto de un brote de influenza, durante el invierno, un paciente de 22 años presenta un cuadro de rinorrea, congestión nasal, fiebre, mialgias generalizadas y tos seca. Al examen físico presenta 39 grados celsius, con examen pulmonar normal. El tratamiento más adecuado es:

- a) Oseltamivir
- b) Zanamivir
- c) Aciclovir
- d) Valaciclovir
- e) Paracetamol

142) Un paciente fuma 5 a 7 cigarrillos al día y consulta porque quiere dejar de fumar. ¿Qué tratamiento es el más adecuado?

- a) Terapia cognitivo conductual
- b) Terapia de sustitución con nicotina
- c) Sertralina
- d) Bupropión
- e) Cigarrillo electrónico

143) ¿Cuál es la posición recomendada para que duerman los lactantes?

- a) Prono
- b) Decúbito lateral derecho
- c) Supino
- d) Decúbito lateral izquierdo
- e) Alternar decúbito lateral derecho e izquierdo

144) Un niño de 16 meses, nacido a las 34 semanas de gestación, logra la posición sentada a los 10 meses y aún no camina. Además succiona y traga muy lento, y también presenta sialorrea. Su perímetro cefálico es de 45 cm, que corresponde a -2 DS y presenta espasticidad en sus 4 extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Parálisis cerebral
- b) Hipotiroidismo congénito
- c) Alteración enzimático-metabólica
- d) Microcefalia
- e) Trastorno del desarrollo

145) Un recién nacido presenta hepatoesplenomegalia e ictericia. Tiene además calcificaciones cerebrales y microcefalia. Evoluciona con coriorretinitis y aumento progresivo del perímetro craneano. El diagnóstico más probable es:

- a) Infección por VIH
- b) Infección por Streptococcus agalactiae
- c) Rubeola congénita
- d) Toxoplasmosis congénita
- e) Sífilis congénita

146) Un niño de 8 años presenta olor axilar. ¿Qué hallazgo debe buscarse para determinar si tiene una pubertad precoz?

- a) Ginecomastia
- b) Elevación de la 17 hidroxiprogesterona
- c) Vello púbico
- d) Aumento de la velocidad de crecimiento
- e) Aumento de volumen testicular

147) Un lactante está en tratamiento por reflujo gastroesofágico con medicamento en gotas. Presenta un cuadro de trismus, nistagmus, más hiperextensión del cuello. ¿Qué fármaco es más probable que esté recibiendo?

- a) Omeprazol
- b) Cisaprida
- c) Metoclopramida
- d) Domperidona
- e) Difenhidramina

148) Un lactante de 5 meses de edad es llevado a urgencias, por presentar un cuadro de obstrucción bronquial. Al examen físico presenta taquipnea importante, satura 90%, tiene retracción intercostal, cianosis perioral y sibilancias bilaterales intensas. ¿Cuál es la primera medida que se debe tomar?

- a) Nebulizaciones con salbutamol
- b) Nebulizaciones por
- c) Dar corticoides orales
- d) Dar oxígeno por mascarilla
- e) Administrar corticoides endovenosos

149) Un niño de 6 años entra al colegio hace 4 semanas. Hace 3 semanas inicia cefalea progresiva, más intensa en la mañana. Se agregan náuseas y vómitos escasos y diplopía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno adaptativo
- b) Trastorno por ansiedad de separación
- c) Jaqueca clásica
- d) Hipertensión endocraneana
- e) Vicio de refracción

150) Un lactante de 6 meses es traído por la madre, porque presenta epistaxis. La madre, de 17 años, refiere que se cayó de la cama. Al examen está poco reactivo y presenta múltiples equimosis, algunas de color morado y otras de color verde. Además tiene dos fracturas costales posteriores. Su TAC de cerebro muestra un hematoma subdural. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?

- a) PTH y calcio
- b) Tiempos de coagulación
- c) Exámenes para descartar osteogénesis imperfecta
- d) Fondo de ojo
- e) Ecografía abdominal

151) Un niño de 8 meses de edad ha presentado 5 cuadros de bronquitis obstructiva y además ha presentado diarrea acuosa de 2 meses de evolución. No ha subido de peso en dicho periodo. ¿Qué examen debe realizarse?

- a) Anticuerpos antitransglutaminasa
- b) Niveles plasmáticos de IgA
- c) Test del sudor
- d) Elisa VIH
- e) Colonoscopia

152) Un lactante de 9 meses de edad presenta un cuadro de llanto y dolor abdominal de 10 horas de evolución, con flexión de las caderas, que luego se sigue de eliminación de sangre franca por el ano, cediendo el dolor. Se realiza una ecografía abdominal, que muestra una imagen en forma de dona. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Resección del segmento afectado por laparotomía
- b) Reducción por laparoscopia
- c) Colonoscopia
- d) Reducción neumática
- e) Observar evolución

153) Un recién nacido de 40 semanas de edad gestacional, presenta disnea importante al nacer, con taquipnea marcada, cianosis y desaturación arterial. Presenta ruidos cardiacos desplazados al lado izquierdo, con ruidos intestinales en el lado derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra asas intestinales en el hemitórax derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar cirugía de urgencia
- b) Solicitar endoscopia digestiva alta
- c) Administrar oxígeno en alta concentración, por mascarilla
- d) Administrar prostaglandina
- e) Realizar intubación orotraqueal y conectar a ventilador mecánico

154) Un niño de 13 años acude a control médico, por una infección respiratoria alta. En su examen físico se ausculta un soplo paraesternal izquierdo, sistólico, de intensidad II/VI, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Soplo inocente
- b) Ductus arterioso persistente
- c) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
- d) Estenosis aórtica
- e) Coartación aórtica

155) Una paciente se realiza un legrado por un aborto espontáneo. La biopsia es informada como "mola completa". Su HCG postlegrado es de 750 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Seguir la con niveles seriados de HCG
- b) Realizar biopsia endometrial
- c) Indicar anticonceptivos con progestágeno solo
- d) Repetir el legrado
- e) Indicar metotrexato

156) Una mujer de 65 años, cuya menopausia fue a los 57 años, consulta por metrorragia de 20 días de evolución. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra dos miomas, uno submucoso de 16 mm y el otro subseroso de 44 mm, con endometrio de 16 mm de grosor. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar miomectomía
- b) Observar evolución
- c) Realizar histerectomía
- d) Iniciar terapia de remplazo hormonal
- e) Realizar biopsia endometrial

157) Una paciente se realiza un PAP, que es informado como probable NIE-3, por lo que se realiza colposcopia, que no visualiza ninguna lesión exocervical. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Controlar con nuevo PAP en un año
- b) Realizar conización con asa LEEP
- c) Realizar curetaje endocervical
- d) Cono frío
- e) Histerectomía

158) Una paciente de 60 años consulta por dolor abdominal de 6 meses de evolución. Al examen físico se palpa una masa anexial derecha, de 8 cm de diámetro, con ascitis significativa. La ecografía transvaginal muestra una masa anexial, multiloculada, con increscencias y excrescencias. Su Ca-125 resulta 700 UI/L. Se realiza un TAC que muestra engrosamiento peritoneal, probablemente de origen tumoral y se observa un tumor adosado a la pared gástrica y hepática. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Derivar a cuidados paliativos
- b) Terapia de reemplazo hormonal
- c) Cirugía más quimioterapia
- d) Quimioterapia paliativa
- e) Tamoxifeno

159) Una mujer tiene un PAP alterado, por lo que se realiza una colposcopia y biopsia, que es informada como lesión de bajo grado/VPH. ¿A qué evolucionará con mayor probabilidad esta lesión?

- a) Involución espontánea
- b) NIE 2
- c) Carcinoma in situ
- d) Condiloma acuminado
- e) Cáncer de cuello uterino

160) Una paciente primigesta, cursando un embarazo de 37 semanas, consulta por contracciones uterinas dolorosas, 3 en 10 minutos. Tiene 8 cm de dilatación, con 100% de borramiento, con feto en posición podálica y registro fetal tranquilizador. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Tocolíticos
- b) Reversión interna
- c) Reversión externa
- d) Fórceps
- e) Operación cesárea

161) Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 37 semanas, tiene una altura uterina de 28 cm. Se realiza una ecografía obstétrica, que muestra un feto creciendo en percentil 8, con ILA de 8 cm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Inducir el parto con misoprostol
- b) Realizar registro basal no estresante
- c) Observar evolución
- d) Realizar doppler materno fetal
- e) Realizar operación cesárea

162) Una paciente de 30 años, con antecedente de absceso tubo-ovárico drenado, consulta por metrorragia y dolor pélvico. Es usuaria de DIU y tiene atraso menstrual de 5 semanas. Al examen físico presenta dolor a la palpación del hipogastrio y del fonde del saco de Douglas. Su PA es de 100/60 mmHg y su FC es de 90x'. Se realiza beta-HCG, que resulta 5.500 UI/L, hemograma con leucocitosis de 14.000 por mm³ y ecografía transvaginal, que muestra DIU in situ, endometrio engrosado y líquido libre en el fondo de saco de Douglas. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad inflamatoria pélvica
- b) Aborto incompleto
- c) Embarazo molar
- d) Endometritis
- e) Embarazo ectópico

163) Una paciente de 34 años presenta hemorragia puerperal luego del parto. Recibe 10 unidades de oxitocina por vía endovenosa, pero persiste con hemorragia. Se palpa el útero por sobre el ombligo, blando. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar 10 UI de oxitocina por vía endovenosa
- b) Administrar 0,2 mg de metilergonovina por vía intramuscular
- c) Administrar 800 µg de misoprostol por vía rectal
- d) Realizar ligadura de las arterias hipogástricas
- e) Realizar exploración manual de la cavidad endometrial

164) Una paciente, que cursa un embarazo de 30 semanas de edad gestacional, inicia contracciones uterinas de 3 en 10 minutos. Su tacto vaginal muestra un cuello con 80% de borramiento y 3 cm de dilatación. Se administra nifedipino y la primera dosis de corticoides. Se reevalúa a las 2 horas y persiste con la dinámica uterina de 3 a 4 contracciones en 10 minutos, con 4 cm de dilatación, por lo que se realiza amniocentesis, que da salida a un líquido con escasa bacterias a la tinción de Gram. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Dejar a evolución espontánea
- b) Administrar la segunda dosis de corticoides
- c) Determinar madurez fetal en líquido amniótico
- d) Realizar operación cesárea
- e) Administrar tocolíticos de segunda línea

165) Una paciente de 35 años, multipara de 1, cursando un nuevo embarazo de 35 semanas, presenta rotura prematura de membranas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar operación cesárea
- b) Realizar amniocentesis
- c) Interrumpir el embarazo
- d) Administrar tocolíticos
- e) Administrar antibióticos y mantener una conducta expectante

166) Una mujer de 25 años, primigesta, cursando su embarazo de 22 semanas, se realiza una cervicometría, que muestra un cuello de 25 mm de largo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Mantener conducta expectante
- b) Indicar progesterona oral
- c) Indicar progesterona vaginal
- d) Realizar cerclaje
- e) Administrar corticoides

167) Una paciente de 35 años, multipara de 2, tiene un embarazo de 30 semanas. Consulta porque inició contracciones uterinas dolorosas, hace pocas horas. Al examen tiene un cuello 80% borrado, con 2cm de dilatación y 3 contracciones uterinas cada 10 minutos. El registro fetal no muestra alteraciones. ¿Cuál es la medida más importante ante esta paciente?

- a) Antibióticos
- b) Tocólisis
- c) Conducir el trabajo de parto
- d) Cerclaje
- e) Interrumpir el embarazo

168) Una paciente, primigesta, presenta 4 semanas de atraso menstrual, por lo que se realiza test de embarazo, que resulta positivo. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra un saco gestacional intrauterino, con un embrión de 3 mm, sin latidos. La beta-HCG resulta 6.800 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Repetir la beta-HCG en 48 horas
- b) Indicar metotrexato
- c) Realizar nueva ecografía en 7 días
- d) Realizar legrado en 14 días
- e) Realizar legrado inmediatamente

169) Una paciente embarazada de 38 semanas, consulta por contracciones uterinas dolorosas. Al tacto vaginal tiene 3 cm de dilatación, con borramiento de 50% y presentación en vértice. Se realiza un registro cardiaco fetal, que se muestra a continuación:



¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar anestesia epidural
- b) Realizar cesárea
- c) Solicitar ecodoppler umbilical
- d) Enviar a domicilio y pedirle que reconsulte en unas horas
- e) Conducir el trabajo de parto

170) Una paciente presenta embarazo de término. Inicia trabajo de parto con 3-4 contracciones uterinas cada 10 minutos y dilatación cervical de 6 cm. El registro fetal muestra variabilidad disminuida de la frecuencia cardiaca fetal. A las 2 horas mantiene dinámica uterina, tiene dilatación de 8 cm y el registro muestra variabilidad disminuida, pero además, presencia de desaceleraciones tardías, en relación a cada contracción uterina. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar fórceps
- b) Realizar operación cesárea
- c) Administrar misoprostol
- d) Iniciar oxitocina en goteo
- e) Mantener una conducta expectante y reevaluar en 30 minutos

171) Una mujer de 36 años, multipara de 3, con su último parto hace 3 años, tiene antecedente personal de cáncer de mama, que fue adecuadamente tratado hace 1 año. ¿Qué método de planificación familiar debe utilizar?

- a) Anticonceptivos orales combinados, con microdosis de estrógeno
- b) Anticonceptivos orales con estrógeno solo
- c) Progestágeno inyectable
- d) Anillo vaginal con progestágeno
- e) Dispositivo intrauterino

172) Una paciente consulta por leucorrea, asociada a prurito vaginal importante. Al examen físico se observa vulvovaginitis, con leucorrea de mal olor, con pH de 5,8 y test de KOH positivo. ¿Cuál es la indicación más adecuada?

- a) Metronidazol a la paciente y a su pareja
- b) Tinidazol
- c) Clindamicina
- d) Fluconazol a la paciente y a su pareja
- e) Azitromicina

173) Una paciente de 65 años, nulípara, asintomática, se realiza una ecografía tranvaginal, que muestra un tumor anexial izquierdo, de 23 mm, de aspecto quístico, con paredes lisas, sin tabiques ni excrecencias y sin presencia de líquido libre en la cavidad peritoneal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar laparoscopia
- b) Iniciar terapia de reemplazo hormonal
- c) Solicitar marcadores tumorales
- d) Realizar punción del quiste
- e) Realizar control ecográfico en 3 meses

174) Una paciente se realiza un legrado por un aborto retenido, a las 11 semanas de amenorrea. Cuarto días después evoluciona con dolor hipogástrico y metrorragia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Embarazo molar
- b) Restos ovulares
- c) Embarazo ectópico
- d) Endometritis
- e) Rotura uterina

175) Una paciente de 17 años, que está en su día 16 del ciclo menstrual, consulta por dolor abdominal bajo, mayor al lado izquierdo. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda, sin signos de irritación peritoneal. Su examen ginecológico demuestra dolor a la palpación anexial izquierda y la ecografía transvaginal muestra un quiste anexial izquierdo, heterogéneo, con escaso líquido libre en el fondo del saco de Douglas. La conducta más adecuada es:

- a) Controlar con ecografía postmenstrual
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Solicitar marcadores tumorales
- d) Realizar laparoscopia
- e) Realizar laparotomía

176) Una paciente cursa un embarazo de 24 semanas y es diagnosticada de infección urinaria baja, por Escherichia coli sensible, que se resuelve adecuadamente, luego de tratamiento antibiótico por 7 días. Tiene antecedente de una bacteriuria asintomática, tratada a las 16 semanas de embarazo.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar urocultivo semanal
- b) Solicitar pielografía de eliminación
- c) Indicar aumento del consumo de agua
- d) Indicar nitrofurantoína a permanencia
- e) Indicar profilaxis, con jugo de cranberry

177) Una paciente de 34 años consulta por genitorragia y sinusorragia, por lo que se realiza una especuloscopia, que muestra una lesión cervical ulcerada, friable. La conducta más adecuada es:

- a) Colposcopia y biopsia
- b) Conización cervical
- c) Seguimiento ecográfico
- d) Citología cervical
- e) Buscar virus papiloma humano

178) Una mujer de 65 años, nulípara, con IMC de 33, sin síntomas, se realiza un PAP que muestra abundantes células endometriales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Controlar con nuevo PAP en un año
- b) Indicar estrógenos tópicos
- c) Solicitar colposcopia y biopsia
- d) Realizar curejate endocervical
- e) Solicitar ecografía transvaginal

179) Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso, mal controlado, consulta por pérdida súbita e indolora de la visión del ojo izquierda. Con el ojo izquierdo solo puede contar dedos. Al examen físico no se ven alteraciones externas, pero el rojo pupilar del ojo izquierdo está muy disminuido. El diagnóstico más probable es:

- a) Trombosis de la vena central de la retina
- b) Desprendimiento de retina
- c) Neuritis óptica
- d) Embolia de arteria central de la retina
- e) Hemorragia vítrea

180) ¿Cuál es el mejor curso de preparación para el Eunacom?

- a) El curso del Dr. Guevara
- b) Eunamet
- c) Globalmed
- d) CapMed
- e) Ese que me hizo perder mi plata

Pauta EUNACOM julio 2015

Núm Resp. EXPLICACIÓN

1 C Cuadro clásico

2 B El STC se estudia con EMG

3 D Cuadro clásico

4 C Cuadro clásico

5 B por llevar dos años orienta a artrosis (coxartrosis = artrosis de cadera). Alguien anotó 2 semanas en FB: sería la necrosis avascular.

6 A Es la historia clásica de la neuropatía radial por compresión, del borracho. Igual la dificultad para tomar objetos podría orientar a lesión del plexo braquial.

7 E Menores de 10 meses (según Minsal) o menores de 6 meses (universalmente aceptado) se manejan con correas de Pavlik

8 D Es una artritis séptica: estudiar el líquido es la forma de diagnosticarla

9 C Tumor óseo de aspecto maligno. Por ubicación y edad es osteosarcoma (adolescentes y adultos mayores). Recordar que Sarcoma de Ewing es diaisario.

10 B Gastrectomía es la causa (falta factor intrínseco y no se absorbe la B12). Tiene además la anemia megalobástica y la neuropatía, encefalopatía y probable degeneración combinada subaguda de la médula (todo causado por falta de B12).

11 B Por ser vegetariana también debe recibir B12, pero los folatos son lo más importante por el mielomeningocele (defecto del tubo neural)

12 E Cuadro clásico

13 C Es un síndrome de vena cava superior, probablemente secundaria a un linfoma. El diagnóstico es clínico (no aparece en las opciones). El TAC es la mejor imagen para ver las adenopatías mediastínicas que producen el cuadro.

14 A Pregunta muy difícil, porque tanto la hemofilia como la EvW producen epistaxis, equimosis y alveolorragia (epistaxis y alveolorragia son más de EvW). El alargamiento leve del TTPA también puede verse en ambos, aunque la palabra "leve" orienta más a EvW. El hematoma profundo orienta más a hemofilia y es el dato más fuerte como para elegirla, pero la EvW puede tener hematomas y tipo 3 se caracteriza por tenerlos. Un caso como este está límite entre ambas. La hemofilia probablemente sería más grave, con síntomas desde la infancia y con hemartrosis y más hematomas.

15 B Probable leucemia aguda. Se inicia el estudio con Hemograma

16 E Probable diabetes LADA por el antecedente de AR y por la severidad. Se trata con insulina, igual a DM1. No parece una DM por corticoides.

17 B La DM1 se debe tratar con esquema intensificado: idealmente insulina glargina basal, con refuerzos con insulina ultrarrápida. Se acepta también las dos dosis de NPH, con referzos con IC precomidas. Las demás opciones son claramente insuficientes.

18 D La insuficiencia renal contraindica los hipoglicemiantes orales: se debe dejar insulina. El tratamiento que tenía era pésimo.

19 D La cetoacidosis se hidrata con suero fisiológico. Sin embargo la opción del Ringer Lactato es una respuesta totalmente correcta. Pero suero NaCl al 0,9% será la respuesta correcta.

20 B Tiene obesidad y resistencia a la insulina ($HOMA = 96 \times 23 / 405 = 5,5$). No tiene ni diabetes, ni intolerancia a la glucosa, ni glicemia alterada de ayuno, así que solo se deja dieta y ejercicio.

21 C Cuadro clásico

22 A Tiene un LCR de meningitis viral (mononuclear con glucosa mayor a 35), además hemorrágico (hematíes crenados: no es sangrado por la punción). La clínica grave orienta a herpes.

23 D Cuadro clásico

24 A Es un Guillain Barré clásico. Otro nombre es Polirradiculoneuritis desmielinizante.

25 A Neuralgia de la rama mandibular (V3) del trigémino.

26 E Cuadro clásico

27 B El cáncer de mama es el que da metástasis ganglionares a la axila con mayor frecuencia. Que sea indolora descarta hidrosadenitis. Lipoma es blando. TBC ganglionar es rara y suele tener una clínica más inflamatoria, con fistulización: sale caseum.

28 D El dolor, las flictenas, las áreas necroticas y la crepitación orientan a fasciitis.

29 E Que tenga ritmo irregular hace pensar en fibrilación auricular y embolias (isquemia aguda), pero la clínica crónica es más sugerente de enfermedad arterial periférica.

30 B Las heridas que sangran se comprimen directamente

31 E Tiene una herida penetrante abdominal (lacera el peritoneo). La mayoría de los autores recomienda explorar, idealmente por laparoscopia. De todos modos algunos recomiendan hacer EcoFast si está en tan buenas condiciones y tiene buena evolución (como es este caso). No es un tema cerrado, sino controvertido.

32 A Tiene una probable herida penetrante de tórax, con un neumotórax traumático. No tiene clínica de neumotórax a tensión, así que no hay que puncionar el segundo espacio intercostal. Lo primero siempre es pedir la radiografía de tórax, tanto para ver el grado del neumotórax, como para descartar otras complicaciones (ej: hemotórax).

33 D Cuadro clásico

34 E Es una diverticulitis aguda post colonoscopia. Se estudia con TAC. Está absolutamente contraindicada la colonoscopia

35 E Cuadro clásico

36 A Probablemente tiene una coledocistitis (clínica de cólico biliar). Se estudia con Eco. En agudo sí debió haberse pedido la amilasa/lipasa para descartar pancreatitis, pero ahora solo hay que descartar la coledocistitis.

37 E El soplo diastólico (rotura de la válvula aórtica) y la HTA orientan a disección.

38 C Cuadro clásico (tiene soplo de insuficiencia mitral y la historia de dolor de 2 días: tuvo un IAM hace dos días y ahora se rompió el músculo papilar).

39 B foto clásica. El signo de Chilaiditi tiene el colon sobre el hígado, pero se ve con haustras y en la foto no se veían.

40 C Atelectasias son la primera causa de fiebre postoperatoria en las primeras 24 horas y la clínica es absolutamente concordante (crepitaciones localizadas, etc).

41 B Probable absceso perianal. Debe ser drenado en pabellón.

42 A Tiene una fisura anal aguda. Se trata con baños de asiento y pueden servir los analgésicos. Solo la crónica se trata con laxantes y si no responde se opera.

43 E Es una sección uretral. Está contraindicada la Sonda Foley y Nelaton. Se instala cistostomía. Se estudia con uretrocistografía retrógrada y no con los exámenes que ahí aparecían. Se resuelve luego con cirugía.

44 A Cuadro clásico. Que sea adolescente orienta aún más a torsión testicular, por sobre el de hidátide (niños más chicos).

45 D Probable cáncer de vejiga. La pregunta es difícil, porque el orden a estudiar ese tipo de hematuria es: Sedimento/ urocultivo, luego Eco y luego la cistoscopia. Sin embargo a este paciente le hicieron un TAC y con eso igual se descartan las alteraciones renales. Por tanto no es necesaria la eco.

46 B Todo tumor renal sólido (con pocas excepciones) se presume un cáncer renal. Si son menores a 7 cm (antes era 4), se tratan con nefrectomía parcial (más aún en monorrenos o insuficientes renales).

Si son más de 7 cm se tratan con nefrectomía radical. Si tienen metástasis ganglionares, van a terapia paliativa (la inmunoterapia puede servir, pero poco y es muy cara). Si es de pelvis renal, se hace nefroureterectomía.

47 D Es una incontinencia de orina de esfuerzos. El orden a tratar es: descartar ITU, luego kinesioterapia pélvica (ejercicios de Koegel) y finalmente la cirugía (suspensión uretral con TOT o TVT).

48 C Es una vejiga neurogénica (por neuropatía diabética). Se tratan con autocateterismo limpio (no estéril, sino limpio) intermitente.

49 A La hipercalciuria es la alteración más frecuente en Chile (40 a 50% de los pacientes con litiasis). De todos modos esta es una pregunta ridícula e inútil, que no debería hacerse.

50 C El pelo TAC es de elección para el cólico renal

51 A Pregunta muy muy difícil. La bacteriuria asintomática no debe ser tratada en los pacientes con sonda, de hecho ni siquiera se deben pedir urocultivos, así la respuesta sería observar. Pero el paciente tiene Alzheimer y por tanto no sabemos si tiene síntomas de infección urinaria. Si fuera una ITU baja, se debe evaluar retirar la sonda y además tratar con ATB. Creo que será correcta observar. De lo contrario, retirar la sonda, pero la verdad es que la pregunta no es para médico general y probablemente no estarán de acuerdo los mismos especialistas entre ellos.

52 B Por el corto tiempo de evolución y el dolor es síndrome compartimental. Además es clásico de las Fx de antebrazo. Falta información

53 A El LDL es la prioridad (a menos que los triglicéridos estén mayores a 500). Las estatinas están indicadas de inmediato cuando el LDL es mayor a 190 en pacientes de bajo riesgo CV o cuando es mayor a 100 en los diabéticos. Además cuando continúa alto el LDL, a pesar de 3 meses con dieta. Los médicos generales no deben indicar estatinas y gemfibrozilo juntos.

54 B Miocardiopatía dilatada clásica. El soplo que tiene es por insuficiencia mitral, por dilatación del anillo valvular. No aparece insuficiencia mitral en las alternativas (e igual es más probable que sea un MCP dilatada)

55 A Es estenosis aórtica por el síncope y el soplo. Eso sí, la cardiomegalia (desplazamiento del choque de la punta) aparece en estadios muy avanzados.

56 E Pregunta difícil. Parece una angina estable, pero en realidad es una estenosis aórtica (por el soplo) y por tanto se debe pedir ecocardio primero

57 B Cuadro clásico

58 D Cuadro clásico (insuficiencia cardíaca derecha, por HTP, por enfermedad pulmonar (EPOC).

59 C Cuadro difícil. Tiene depresión del PR. En este ECG se ven los SDST, pero en el ECG real solo se veía SDST en V2 y V4. Sí estaba la depresión del PR

60 B Es un IAM con SDST de la pared inferior. Lo más importante es revascularizar.

61 C? D? La verdad es que tanto la Ecocardiografía, como la Cintigrafía de perfusión son útiles para determinar la etiología isquémica de una ICC. La Ecocardiografía verá zonas hipoquinéticas y necrosadas o fibrosadas. La cintigrafía verá las zonas que se isquemizaban con la actividad física.

62 B Tanto por la HTA, como por la proteinuria se debe iniciar enalapril en el diabético

63 C El exudado hemorrágico orienta a TEP. También el Sd. nefrótico, que se complica con TEP. También el inicio súbito.

64 A Cuadro clásico (HTA + edema + hematuria). Esa PA es muy alta para un niño de esa edad

65 D Complemento normal más hematuria dismórfica. Lúpica, postestreptocócica y mesangiocapilar tienen C3 bajo. Membranosa es solo nefrótica, sin hematuria.

66 E Sd. nefrótico puro en adulto: membranosa. Todas las demás tienen hematuria dismórfica, porque son glomerulonefritis (nefritico o nefrótico impuro o hematuria aislada).

67 B Tiene una hipercalcemia por el mieloma. La primera medida es el suero fisiológico. Luego los bifosfonatos, para evitar que recurra. Solo si no funciona se administra calcitonina. Los corticoides sirven en la hipercalcemia por cáncer hematológicos, pero no son lo más importante.

68 D Tiene la obsesión (idea que produce angustia) y la compulsión (reza y evita los niños)

69 C Cuadro clásico (síntomas neurológicos de inicio súbito)

70 A Es un trastorno somatomorfo por dolor (no por somatización, ni hipocondriaco). No hay información para pensar que sea facticio (intencional para ganar cuidados y afecto) ni simulación (intencional, para ganar dinero o pensiones).

71 A? Tiene una depresión psicótica en el adulto mayor y no está clara la ideación suicida actual. Solo quien hizo la pregunta sabe cuál es la respuesta correcta. No es ni la amitriptilina, ni la clorpromazina, porque están contraindicadas en el adulto mayor. Está suficientemente mal, como para pensar en hacerle terapia electroconvulsiva.

72 E Lo primero en la manía agitada es el Haldol

73 A Cuadro clásico. Es distonía por antipsicóticos

74 C Aunque no tenga ni un delirio, ni alucinaciones, parece una esquizofrenia, que está debutando. Probablemente una esquizofrenia simple o también puede ser catatónica (por permanecer inmóvil tanto tiempo).

75 E Tiene síntomas positivos (delirio megalomaniaco) y negativos (aplanamiento afectivo). Es una Esquizofrenia

76 C Cuadro clásico

77 B Es un autismo

78 A Es un autismo también (recordar que el autismo pertenece a los trastornos generalizados del desarrollo o trastornos del espectro autista).

79 B Cuadro clásico

80 C La purga no es exclusiva de la bulimia. La anorexia puede tenerla.

81 A Tiene un delirium tremens (abstinencia de alcohol grave) se trata con diazepam. Si tiene daño hepático crónico, es con lorazepam

82 E Cuadro clásico

83 C La crisis de pánico se trata con benzodiacepinas de acción rápida y corta (elección: lorazepam sublingual). Los antidepresivos IRS sirven para el trastorno de pánico (prevenir las crisis), no para la crisis de pánico mismo.

84 A Cuadro clásico

85 D Cuadro clásico

86 B Cuadro clásico

87 D Cuadro clásico

88 B Cuadro clásico

89 C Imagen clásica. Es una recurrencia de herpes genital probablemente.

90 A Pregunta muy difícil. Es una malformación vascular (mácula presente al nacimiento. No ha crecido mucho). No es un hemangioma. La mayoría se observa, aunque lo más importante es pedirle un ecodoppler, para determinar qué hacer exactamente (observar, cirugía o láser).

91 A Lo más importante en toda ETS es descartar otras ETS, en particular en los condilomas, que no tienen mayores complicaciones.

92 E Casos y controles sirven para: poco prevalentes, bajo presupuesto y enfermedades que demoran mucho en aparecer.

93 C La aleatorización sirve para evitar sesgos de selección. El doble ciego sirve para obtener información confiable del sujeto y evaluados. Para reducir el error aleatorio se usa una muestra de mayor tamaño.

94 A Fonasa se financia por el aporte estatal (el estado se financia por los impuestos). En segundo lugar por el aporte de los trabajadores. Los empleadores no aportan.

95 C Tanto las Isapres, como Fonasa administran los fondos AUGE. Las Isapres administran el seguro de cotización individual y Fonasa el seguro público. No sé qué es el seguro general. Ninguna da prestaciones de salud, porque son seguros, no prestadores,

96 C Es función de la Superintendencia de salud

97 E Son las mutuales (mutual de seguridad, ACHS).

98 A Es la definición de epidemia. Pandemia se extiende al todo el mundo. Epidemia tiene aumentos mayores a lo habitual. Brote son varios casos relacionados.

99 D El contraste de hipótesis es la herramienta principal de la epidemiología analítica, que busca relaciones de causa-efecto.

100 E La mortalidad infantil refleja muy bien el desarrollo de los países, junto a la expectativa de vida.

101 E Es un hematoma septal bilateral. Debe drenarse en pabellón, de manera urgente, para evitar la necrosis del cartílago septal.

102 C Cuadro clásico (aunque pudieron haberlo descrito mejor).

103 D Los pólipos vocales se pueden producir de manera aguda, porque al forzar mucho la voz, se produce una hemorragia laríngea, que evoluciona a un pólipo. Los nódulos y la disfonía musculotensional suelen formarse por abuso vocal crónico. Nadie tiene cáncer de laringe a los 30 años

104 B Cuadro clásico

105 A La metamorfopsia, la edad y el cuadro lento, sin más información es lo característico de la DMRE

106 A Es una dacriocistitis aguda. Se trata con ATB orales

107 B Cuadro clásico

108 E? La verdad es que todos los hipnóticos se deben evitar en el adulto mayor, por el riesgo de dependencia y lo más importante es indicar medidas generales de higiene del sueño. Si hay que elegir un hipnótico en el adulto mayor, debe ser el zolpidem, sin embargo sirve más para el insomnio de conciliación y el paciente también tiene de mantención. Esta pregunta está mala, ya que sí se le pueden dejar benzodiacepinas a los adultos mayores y la evidencia no es concluyente. Igualmente creo que zolpidem será la respuesta correcta.

109 B Es un síndrome de Sheehan clásico, que cursa con hipopituitarismo.

110 E Cuadro clásico

111 B Tiene una hiperprolactinemia. No tiene la amenorrea clásica, porque usa anticonceptivos.

112 C Es una insuficiencia suprarrenal por TBC. Es la segunda causa de Addison, después de la causa autoinmune. En FB alguien puso K: 2,9 y en ese caso sería un síndrome de secreción ectópica de ACTH, que tiene una clínica totalmente distinta y que es un síndrome paraneoplásico.

113 D La acromegalia se estudia primero con somatomedina 1 o IGF1 (son sinónimos). La GH es muy errática y no se pide.

114 D Tiene osteoporosis (T score menor o igual a -2,5). Se deben iniciar los bifosfonatos. Se mantiene el calcio y la vit D

115 D Tiene un SOP ya diagnosticado (cumple 2 criterios: oligomenorrea y el hiperandrogenismo cínico), por tanto no es necesario pedir ningún examen. No aparecía como alternativa, así que hay que pedir índice de andrógenos libres, que es el examen de elección para evaluar el hiperandrogenismo en el SOP).

116 C Probablemente tiene una enfermedad de Cröhn (por las úlceras orales no es colitis ulcerosa). Se estudia con colonoscopia.

117 D Probablemente tiene una PBE, que lo descompensa. De todos modos, todo cirrótico descompensado, con ascitis, debe estudiarse para descartar la PBE (peritonitis bacteriana espontánea).

118 E Cuadro de cirrosis biliar primaria. Se estudia con anticuerpos antimitocondriales (AMA). Luego la Biopsia hepática).

119 C El dolicolon (colon largo) no ha demostrado asociarse efectivamente a constipación. La conducta es tratar la constipación en un paciente joven, es decir, mejorar los hábitos. También es aconsejable aumentar la fibra en la dieta. Los laxantes se desaconsejan, ya que producen dependencia y solo se usan en problemas transitorios o cuando fallan las medidas generales.

120 C Si bien, la información es escasa, al sospechar una reacción adversa a medicamentos, se deben suspender y confirmar la afectación, que en el caso de los fármacos antiTBC, es la hepatitis la complicación más frecuente

121 A Parece un cáncer gástrico. Siempre lo primero es confirmarlo con EDA y biopsia

122 A Tiene antígeno negativo (no tiene hepatitis B) y tiene anticuerpos antisuperficie positivos (está protegido). O está vacunado o tuvo hepatitis B y se mejoró.

123 E La encefalopatía hepática se trata con lactulosa. Sin embargo lo más importante siempre es descartar patología descompensante (infecciones). El amonio sirve para hacer el diagnóstico: se eleva la amonemia en la encefalopatía hepática

124 C Si bien la recomendación del Minsal es 14 días de tratamiento, hay suficiente evidencia que dicen que los tratamientos de 7 a 10 días son buenos. Si falla la erradicación, se debe dejar tratamiento erradicador de segunda línea. Otro problema con esta pregunta es que solo la úlcera duodenal se controla con antígeno en heces, mientras que la úlcera gástrica debería controlarse con EDA y biopsia, para observar la curación de la úlcera y biopsiar el lecho (descartar cáncer). La pregunta es muy antipática (quien la redactó)

125 B Es una espondilitis anquilosante. Si bien el mejor examen es la resonancia magnética nuclear de sacroiliacas, se suele pedir una radiografía de sacroiliacas, como primer examen, ya que tiene buen rendimiento en los pacientes con mucho tiempo con síntomas. El FR está negativo. También sirve de apoyo el HLA-B27

126 B Es un síndrome del manguito rotador. Probablemente esta evolucionando a una capsulitis adhesiva (dolor al movimiento pasivo). Se debe dar analgésicos y movilizar precozmente, para evitar la anquilosis.

127 A Cuadro clásico

128 B Diarrea post-ATB es por *C. difficile* en el 30% de los casos.

129 E Tiene la clínica de mononucleosis clásica. El rash post-ampicilina es clásico también.

130 A Cuadro clásico de meningococcemia

131 A Es una amigdalitis pultácea (por *Streptococcus pyogenes*). No tiene nada que oriente a etiología viral. La escarlatina del hermano es por el mismo agente, lo que hace sospecharla aún más. Se debe tratar, por la alta probabilidad de que sea pultácea.

132 D Pregunta muy mal intencionada. El VH6 produce exantema súbito, pero habitualmente entre los 6 y 18 meses y con fiebre alta (cercana a 40 grados). El PVB19 produce el eritema infeccioso o quinta enfermedad, que produce el eritema malar (signo de la cachetada) y el exantema con esa distribución. Afecta a escolares con mayor frecuencia.

133 A? ¿?¿? Pregunta demasiado discutible. La IgG antivariçela es la medida más efectiva, pero es muy cara y no está disponible. La guía minsal solo la recomienda en casos seleccionados. Hay estudios que dicen que la vacuna es útil hasta 4 días posteriores a la exposición (es lo que se suele hacer por no haber IgG disponible). Hay estudios que avalan el uso de aciclovir (probablemente también sirva el valaciclovir) para prevenir la varicela grave. Finalmente no es obligatorio dar profilaxis de varicela a pacientes sin factores de riesgo. Pésima pregunta

134 D Las diarreas hospitalarias en niños suelen ser virales. Además una bronquiolitis aguda no tiene por qué recibir ATB, como para pensar en *C. difficile*

135 C Si bien el Dg. de EPOC se hace con la relación VEF1/CVF (menor a 70%), el VEF1 bajo orienta mucho. Que no mejore con broncodilatador descarta asma y orienta a EPOC. La pregunta en sí está mala, pero probablemente será EPOC la respuesta correcta.

136 A La radiografía no mostraba mucho (en la Rx original no había flecha y se veía, usando la imaginación, un engrosamiento bronquial o mediastínico derecho). Casi se veía normal. Pero tos en alguien muy fumador, con examen físico normal, pensar en Cáncer (no tenía secreción como para pensar en bronquitis crónica por cigarrillo).

137 B Antecedente de minería orienta a neumoconiosis. La Rx era distinta a la que ahí se muestra.

138 C Por ser una neumonía, con derrame (paraneumónico simple en este caso), se debe manejar hospitalizada (ATS III), por lo que el ATB de elección es la ceftriaxona.

139 C Era un EPOC descompensado con una neumonía bilateral: se debe manejar hospitalizado, por lo que el ATB de elección es la ceftriaxona (no aparecía en las alternativas, por lo que cefotaximo es la opción más adecuada: tiene el mismo espectro de acción). Sin embargo la Rx original no condensaba claramente y tenía un patrón alveolointersticial (discutible si sospechar mycoplasma, que se trata con macrólidos o levofloxacino, porque la clínica no era arrastrada ni atípica)

140 E Hay evidencia de baja calidad y reciente, muy discutida, que dicen que la ventilación mecánica invasiva tendría mejores resultados en mortalidad y en tiempo de hospitalización, que la oxigenoterapia por mascarilla. Pregunta muy discutible, porque en la vida real, se evaluará primero la respuesta al oxígeno y se irá viendo cuánto necesita para saturar adecuadamente.

141 E Pregunta demasiado discutible, ya que los pacientes sin antecedentes de riesgo tienen la opción de usar oseltamivir, si así lo quieren, para disminuir el tiempo de influenza y asegurar que no será grave. La guía minsal solo da oseltamivir a pacientes con factores de riesgo o con influenza grave. Sin embargo el tratamiento sintomático es el de elección en la influenza. Se debe evitar la aspirina y el ibuprofeno, por el riesgo de síndrome de Reye. Además por la rinorrea y congestión, se puede sospechar otro virus, distinto a la influenza

142 A Fuma muy poco, como para que requiera burpopión o nicotina. Además la terapia cognitivo conductual siempre es la más efectiva para dejar de fumar.

143 C Posición supina es la de menor riesgo para muerte súbita. Solo se recomiendan las otras posiciones en caso de reflujo, ya que puede aumentarlo.

144 A Cuadro clásico

145 D Cuadro clásico. Sin embargo la pregunta es muy difícil y claramente no es de médico general, ya que basta decir que tiene un TORCH. Esa clínica además es muy probable de un citomegalovirus. La rubeola produce microcefalia, cardiopatía y cataratas. La sífilis produce exantema, perforación del tabique nasal, deformaciones múltiples.

146 E Al aumento de volumen testicular es el primer signo de pubertad precoz. Sin embargo también debe evaluarse la presencia de vello púbico, porque es un signo de pubertad precoz igualmente.

147 C Tanto metoclopramida, como domperidona pueden producir síntomas extrapiramidales, pero son más frecuentes en la metoclopramida. La cisaprida se retiró del mercado, pero por producir arritmias.

148 D Ante una hipoxia, en un trastorno V/Q, lo más urgente siempre es el oxígeno. Además hoy está demostrado que el oxígeno es lo único realmente útil en la bronquiolitis y que no sirven ni corticoides ni broncodilatadores

149 D El predominio matinal, los vómitos y la diplopia orientan a hipertensión endocraneana.

150 D Sospechar maltrato infantil. El fondo de ojo muestra las microhemorragias en el síndrome del niño sacudido (Shaking baby). Pero en realidad el diagnóstico ya está hecho y lo más urgente es operar el hematoma subdural. Pregunta mala.

151 C Sospechar una fibrosis quística. Se diagnostica con test del sudor

152 D Es una intususcepción o invaginación intestinal. La reducción neumática es el tratamiento de elección. (pregunta para especialistas, no para médico general).

153 E Es una hernia diafragmática. Produce hipoplasia pulmonar. Se debe intubar, conectar al ventilador de alta frecuencia y probablemente a la membrana de oxigenación extracorpórea y la cirugía se postpone, para cuando esté estable, con los pulmones más desarrollados. Eso es pregunta para especialistas, no para médico general.

154 A Cuadro clásico

155 A Ante un embarazo molar se debe seguir con HCG, después de sacarla. Si se eleva o mantiene sin bajar, se diagnostica neoplasia trofoblástica gestacional y se procede a la histerectomía más quimioterapia con metotrexato. Una HCG de 750 postlegrado, es bastante baja.

156 E Los miomas NO producen la metrorragia. Tiene endometrio grueso. Se debe biopsiar para descartar una hiperplasia endometrial o un cáncer de endometrio.

157 D Tiene una disociación colpocitológica. Se debe realizar un cono biopsico o cono frío, ya que el cono con asa LEEP inutiliza la biopsia, porque quema la muestra.

158 D El cáncer de ovario avanzado, fuera de alcance curativo, se trata con QT paliativa. Pregunta para especialista. No debería hacerse en el Eunacom.

159 A Las NIE 1 en su mayoría involucionan espontáneamente

160 E Trabajo de parto en podálica contraindica el parto vaginal. Cesárea.

161 D Pregunta muy específica. Tiene un RCIU leve (percentil mayor a 5), con líquido amniótico límite, aunque al término, se considera normal hasta ILA de 5. Hoy en día, se pide Doppler umbilical, porque si está normal, se puede incluso llegar a término. Antes se interrumpían todos los RCIU a más tardar a las 37 semanas (hoy solo los moderados-severos o los con doppler alterado).

162 E Tiene la eco negativa y la HCG mayor a 1.500. Además tiene factores de riesgo: PIP previo y DIU.

163 E Pregunta muy muy discutible. Se pueden dar hasta 60 UI de oxitocina. También se puede dar la metilergonovina. El misoprostol se suele usar de segunda línea. Simultáneamente se hace una revisión instrumental del canal del parto, aunque también se puede hacer una revisión manual de la cavidad uterina y está indicada actualmente en toda hemorragia puerperal, incluso en las inercias uterinas clínicas, como es este caso.

164 D Como tiene infección está contraindicada la tocolisis de segunda línea. No tiene sentido dar la segunda dosis de corticoides. Llama la atención que no aparezcan antibióticos como alternativa, ya que son la medida más importante. Está indicado interrumpir el embarazo, pero por tener 30 semanas, está contraindicado el parto vaginal (contraindicación relativa que tenga menos de 1.500 gramos), por lo que cesárea sería la respuesta más correcta. Igual es una pregunta mala. Los ginecólogos tenían un grave problema cuando hicieron esta prueba.

165 C La RPO mayor a 34 semanas se debe interrumpir, idealmente por vía vagina, a menos que tenga contraindicación del parto vaginal, en que se realiza cesárea.

166 C Si bien tiene un cuello corto, el cerclaje solo se indica cuando hay antecedente de abortos tardíos o partos prematuros muy tempranos. De lo contrario, solo se da progesterona vaginal.

167 B Tiene un parto prematuro menor a 34 semanas, por lo que se debe dar tocolíticos y corticoides.

168 C Para diagnosticar un aborto retenido, se necesita que el embrión tenga más de 5 mm. Como tiene 3, se debe controlar en 7 a 10 días, con una nueva Eco. Si continúa sin latidos, se puede legar u observar por 2 semanas, a espera de que inicie espontáneamente el trabajo de aborto (si no inicia, se legra).

169 E El registro es tranquilizador (MEFI 1), por lo que se debe observar. Aún tiene muy poca dilatación, como para ponerle la anestesia (aunque algunos ya la indican con 3 cm), sin embargo la conducción del trabajo de parto me parece la respuesta más adecuada.

170 B Tiene un MEFI III (variabilidad disminuida + desaceleraciones tardías), por lo que tiene un sufrimiento fetal, que debe ser interrumpido por la vía más expedita. No se puede hacer fórceps, porque tiene solo 8 cm de dilatación. Así que se debe hacer cesárea de urgencia.

171 E Por tener antecedente personal de cáncer de mama tiene absolutamente contraindicados todos los métodos hormonales. El DIU es la indicación.

172 A Tiene una vaginosis (KOH positivo y leucorrea con pH mayor a 4,5 y mal olor), pero también una tricomoniasis (vulvovaginitis y leucorrea de mal olor). El prurito es de candida y de tricomona. Tanto vaginosis, como tricomoniasis se tratan con metronidazol. Además la tricomoniasis obliga a tratar a la pareja y a descartar otras ETS.

173 E Pregunta demasiado específica. Es un tumor anexial en una mujer postmenopáusica (históricamente todos se tratan con anexectomía por laparoscopia). Sin embargo los quistes simples menores a 3 cm se siguen con Ecografía por 3 meses. Si persisten se piden marcadores tumorales y se operan solo si están positivos, ya que de lo contrario solo se observan. Hay estudios recientes que muestran que los quistes anexiales simples son frecuentes en las mujeres postmenopáusicas y que solo una mínima parte evolucionan a cáncer. Los ginecólogos que contrataron para este examen tienen un claro problema. Esta pregunta no debería existir.

174 D Pregunta muy difícil. Tiene una metrorragia postlegrado, cuya primera causa son los restos ovulares (después de 24 horas). Sin embargo, como tiene varios días y en especial porque tiene dolor, la respuesta más correcta es endometritis (los restos ovulares habitualmente no duelen y sangran al otro día).

175 A Es una ovulación dolorosa, aunque podría estar transformándose en un cuerpo lúteo hemorrágico. También es pregunta difícil. Se debe controlar con ecografía y administrar analgésicos. Habitualmente desaparece el cuerpo lúteo simultáneamente a la menstruación.

176 D La indicación de profilaxis antibiótica (con cefradina o nitrofurantoína) son 2 o más infecciones tratadas (independiente de si son bacteriurias asintomáticas, ITU baja, pielonefritis o mezclas de ellos).

177 A Es un probable cáncer de cuello uterino. Se debe biopsiar, idealmente en la colposcopia (aunque también se puede biopsiar directamente). El PAP (citología) ya no sirve

178 E Tiene factores de riesgo de cáncer de endometrio (obesidad y nuliparidad) y además células endometriales. Se debe descartar una hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio, partiendo por la Eco.

179 E La pérdida del rojo pupilar orienta mucho a hemorragia vítrea

180 A Obviamente es el mejor curso (además el más barato). A mis alumnos les deseo de todo corazón que les haya ido bien en esta prueba, aunque de verdad estuvo más difícil de lo usual.



PRIMERA PARTE

1) Un paciente hipertenso bien controlado, con antecedente de EPOC, presenta un cuadro de palpitaciones y disnea, siendo diagnosticado de fibrilación auricular. ¿Qué fármaco está contraindicado?

- a) Atenolol
- b) Digoxina
- c) Enalapril
- d) Acenocumarol
- e) Amlodipino

2) Una paciente de 27 años de edad, con antecedente de parto hace 9 meses, dando lactancia materna parcial, consulta porque no ha iniciado sus menstruaciones aún. Está usando medroxiprogesterona inyectable intramuscular 150 mg cada 3 meses, como anticonceptivo. Su test de embarazo ha resultado negativo en más de una oportunidad. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar prueba de progesterona
- b) Solicitar TSH y prolactina
- c) Solicitar niveles HCG en sangre venosa
- d) Mantener el tratamiento
- e) Solicitar ecografía transvaginal

3) Una paciente consulta por atraso menstrual de 7 semanas y trae test de embarazo en orina, que resulta positivo. Se realiza una ecografía transvaginal, que no visualiza embarazo intrauterino y que constata la presencia de un tumor anexial derecho, complejo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar niveles de HCG en sangre
- b) Solicitar una nueva ecografía transvaginal en 7 días
- c) Solicitar marcadores tumorales en sangre
- d) Solicitar proteína plasmática asociada al embarazo
- e) Solicitar niveles de progesterona y estradiol

4) Una paciente de 22 años presenta un cuadro de fiebre nocturna, asociada a baja de peso de 3 meses de evolución y astenia. Además refiere aumento de volumen cervical. Al examen físico se aprecia palidez de piel y mucosas y una masa de 6 cm de diámetro en la cara lateral derecha del cuello. En la radiografía de tórax, se constata ensanchamiento del mediastino. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia linfática crónica
- b) Infección por VIH
- c) Tuberculosis ganglionar
- d) Linfoma de Hodgkin
- e) Linfoma no Hodgkin

5) Una paciente de 26 años, con antecedente de esclerosis múltiple consulta por disminución de la agudeza visual derecha, de 2 días de evolución, asociado a leve dolor retroocular derecho, que aumenta con los movimientos. Al examen físico se aprecia rojo pupilar y movimientos normales, escape pupilar, con defecto pupilar aferente en el ojo derecho y presencia de un escotoma derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Desprendimiento de retina
- b) Trombosis de la vena central de la retina
- c) Trombosis de arteria central de la retina
- d) Neuritis óptica
- e) Absceso orbitario

6) Un paciente de 35 años, colecistectomizado hace meses, consulta por dolor epigástrico, progresivo, que inició hace 24 horas y que se ha asociado a ictericia y acolia. Al examen físico está afebril, con FC: 80x' y PA: 120/76 mmHg y se aprecia dolor a la palpación del hemiabdomen superior e ictericia de piel y mucosas. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran GOT: 42 UI/L, GPT: 63 UI/L, FA: 430 UI/L, GGT: 566 UI/L y bilirrubina de 6,4 mg/dl. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

- a) TAC de abdomen
- b) Ecografía abdominal
- c) Endoscopia digestiva alta y biopsia
- d) Colangiografía
- e) Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

7) Una paciente de 30 años, con antecedente de un quiste mamario izquierdo, consulta por dolor en la mama izquierda, asociada a fiebre y eritema. Al examen físico se constata eritema, aumento de volumen y dolor en la mama izquierda, con un nódulo doloroso a la palpación. Se solicita una ecografía que muestra una imagen quística de 5 cm de diámetro, con signos inflamatorios en las partes blandas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar seguimiento ecográfico
- b) Iniciar tratamiento con AINES
- c) Realizar punción y drenaje
- d) Drenar mediante cirugía
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear de mamas

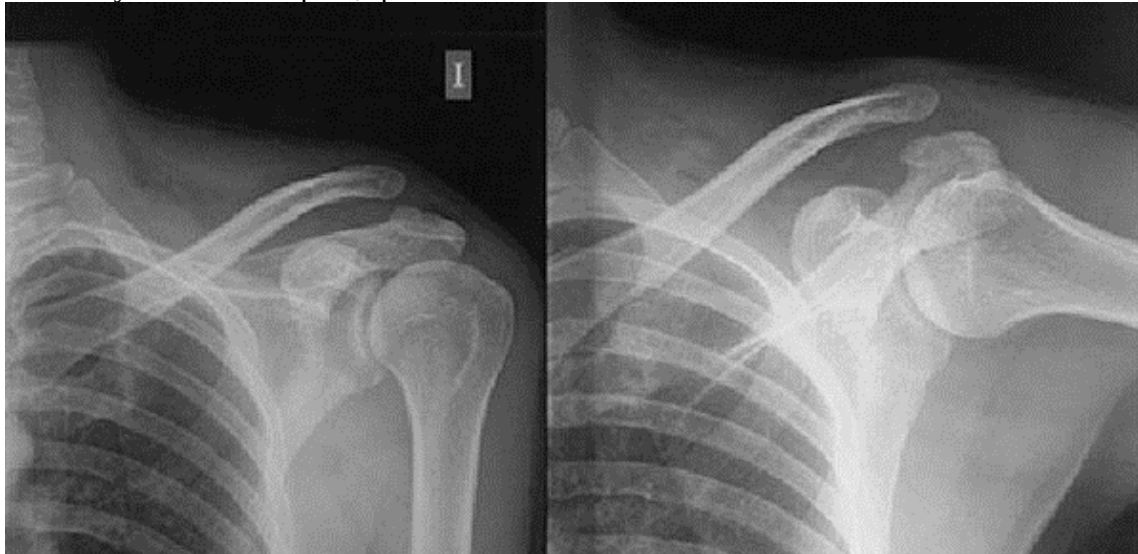
8) Mujer de 81 años, hospitalizada por neumonía, presenta agitación psicomotora en las noches, agrediendo al personal hospitalario y no reconoce a sus familiares. En el día, por el contrario, está en buenas condiciones, tranquila y no recuerda lo sucedido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Esquizofrenia
- b) Accidente vascular encefálico
- c) Delirium
- d) Demencia
- e) Trastorno delirante

9) Paciente 80 años con antecedente de artrosis en tratamiento con paracetamol 1 gr c/8 horas, con control parcial del dolor. Realiza adecuadamente sus actividades de la vida diaria, usa bastón y sale acompañada. Tiene antecedente de HTA e Insuficiencia cardíaca congestiva en capacidad funcional III. ¿Cuál es el mejor fármaco a agregar para continuar el manejo del dolor?

- a) Ibuprofeno v.o.
- b) Pregabalina v.o.
- c) Ketorolaco v.o.
- d) Lidocaína en parches
- e) Tramadol v.o.

10) Un paciente de 24 años, sufre una caída a nivel, mientras jugaba básquetbol, cayendo con el hombro izquierdo, contra el suelo. Presenta impotencia funcional y al examen físico destaca dolor a la movilización del hombro izquierdo. Se solicita una radiografía AP de hombro y axial de escápula, que se muestran a continuación:



El diagnóstico más probable es:

- a) Luxación anterior de hombro
- b) Fractura de escápula
- c) Luxación acromioclavicular
- d) Fractura de clavícula
- e) Lesión del tendón del manguito rotador

11) Una paciente de 48 años, se somete a una gastrectomía total. Al segundo día postoperatoria presenta fiebre y taquicardia, con FC: 100x' y PA: 140/90. Al examen físico presenta herida operatoria sin alteraciones, con abdomen sensible a la palpación. El examen pulmonar muestra hipoventilación basal. ¿Cuál es la causa más probable de la fiebre?

- a) Infección urinaria
- b) Filtración de la anastomosis
- c) Reacción adversa a medicamentos
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Atelectasia infectada

12) Un niño de 20 días de edad, presenta lesiones eritematosas, con descamación en la cabeza y la zona interiliar, con descamación amarilla, de aspecto oleoso. Se ve de buen aspecto y ha subido de peso. La indicación más adecuada es:

- a) Administrar fórmula, con proteína hidrolizada, como alimentación
- b) Crema de betametasona tópica
- c) Crema de clotrimazol tópico
- d) Vaselina topica
- e) Antibióticos tópicos

13) En un estudio de cohortes sobre el tabaco y cáncer de pulmón, luego de 20 años, se determinó que 65 de 2.000 pacientes fumadores enfermaron de cáncer. ¿Qué medida es posible calcular con esta información?

- a) Incidencia acumulada en los pacientes fumadores
- b) Prevalencia en los pacientes fumadores
- c) Riesgo relativo
- d) Odds ratio
- e) Tasa de ataque en los pacientes fumadores

14) Una paciente de 53 años, diabética tipo 2, es diagnosticada recientemente de hipertensión. Sus exámenes generales, incluyendo un electrocardiograma, no muestran alteraciones ¿Qué fármaco es más adecuado para su tratamiento?

- a) Atenolol
- b) Hidroclorotiazida
- c) Carvedilol
- d) Amlodipino
- e) Enalapril

15) Paciente masculino, de 50 años de edad, consulta por prurito intenso en el glande y al examen físico se constata eritema y edema en el glande y el prepucio, asociado a un anillo fibrótico en el prepucio. Refiere que ha tenido varios episodios similares antes. ¿A qué enfermedad se puede atribuir el cuadro?

- a) Alcoholismo
- b) Diabetes mellitus
- c) VIH
- d) Esclerodermia
- e) Lupus

16) Una paciente de 34 años, multipara, embarazada de 36 semanas, presenta pérdida de líquido amniótico hace una hora, confirmandose rotura de membranas, con la prueba de microglobulina placentaria. La ecografía obstétrica muestra disminución del líquido amniótico, con presentación cefálica, y con bienestar fetal ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar cesárea
- b) Administrar corticoides
- c) Inducir el parto
- d) Esperar 48 horas para inicio espontáneo del trabajo de parto
- e) Administrar antibióticos

17) Un lactante de 11 meses acude a control de niño sano, constatándose que no tiene aún ningún diente. El resto de su examen físico, así como su desarrollo psicomotor es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Derivar al odontopediatra
- b) Solicitar radiografía panorámica dentaria
- c) Solicitar TSH plasmática
- d) Solicitar niveles plasmáticos de vitamina D
- e) Observar evolución y controlar en 2 meses

18) Una paciente de 40 años, cursando un embarazo de 24 semanas, se realiza ecografía obstétrica, que visualiza a los vasos umbilicales en las membranas amnióticas y al cordón umbilical, que se inserta en la zona marginal inferior de la placenta. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar una nueva ecografía el tercer trimestre
- b) Observar evolución
- c) Realizar rotura de membranas tardía
- d) Realizar cesárea de inmediato
- e) Administrar corticoides e interrumpir el embarazo en 48 horas

19) Un niño de 2 años, presenta deposiciones abundantes y pastosas, de 1 año de evolución. Además ha subido poco de peso en ese tiempo, teniendo actualmente un índice peso/talla de -1 DS y peso/edad de -2 DS. No ha tenido cuadros febriles. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad celíaca
- b) Fibrosis quística
- c) Diarrea crónica inespecífica
- d) Intolerancia a la lactosa
- e) Alergia a la proteína de vaca

20) Un recién nacido, con antecedente de pielectasia bilateral, diagnosticada por ecografía obstétrica, presenta retraso en la eliminación de orina, por lo que se realiza una ecografía abdominal al tercer día de vida, que visualiza hidroureteronefrosis bilateral, asociada a una vejiga de paredes engrosadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Valvas uretrales posteriores
- b) Síndrome de Prune Belly
- c) Reflujo vésico-ureteral
- d) Vejiga neurogénica
- e) Megauréter congénito

21) Paciente femenina de 35 años, quien evidencia masa en cuadrante superoexterno de mama izquierda, no doloroso, de consistencia lisa y no adherido a planos profundos. Tiene una tía fallecida de cáncer de mama a los 71 años y usa anticonceptivos orales. La conducta más apropiada es:

- a) Realizar ecotomografía de mamas
- b) Realizar mamografía
- c) Punción con aguja fina
- d) Realizar tumorectomía y biopsia
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear de mamas

22) Un niño de 4 años, presenta un cuadro de 10 días de evolución de edema bipalpebral, a lo que se ha agregado, en los últimos dos días, oliguria y orinas espumosas. Al examen físico presenta presión arterial 102/62 mmHg, FC: 80x', edema facial y de extremidades inferiores. En sus exámenes destaca examen de orina con proteínas ++, creatininemia 0,9 mg/dl y BUN: 20 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome nefrótico
- b) Glomerulonefritis aguda
- c) Insuficiencia renal crónica
- d) Síndrome hemolítico urémico
- e) Nefritis intersticial

23) Una niña de 5 años, en tratamiento con amoxicilina por una amigdalitis, evoluciona al séptimo día con fiebre y lesiones cutáneas generalizadas. Al examen físico se aprecian lesiones en tiro al blanco, asociadas a úlceras en las mucosas oral, rectal y vaginal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Urticaria aguda
- b) Gingivoestomatitis herpética
- c) Síndrome de Steven Johnson
- d) Escarlatina
- e) Mononucleosis infecciosa

24) ¿Cuál es la mejor estrategia de vigilancia para una enfermedad infectocontagiosa, que se transmite a través de la contaminación de acuíferos?

- a) Vigilancia activa
- b) Vigilancia pasiva
- c) Vigilancia estacional
- d) Encuestas
- e) Centros centinelas

25) Una paciente de 25 años presenta un nódulo tiroideo de 2 cm de diámetro, a la palpación. Se solicita TSH y T4 libre, que resultan normales. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de esta paciente?

- a) Ecografía cervical
- b) Punción aspiración con aguja fina
- c) Anticuerpos antitiroideos
- d) Cintigrafía con yodo radiactivo
- e) TAC cervical

26) Un paciente de 30 años sufre una caída de altura, desde 15 metros, golpeándose contra el suelo. Al examen físico está orientado, con FC: 80x' y PA: 120/80 mmHg, con mucho dolor a la compresión de la pelvis, mayor a izquierda. Se solicita una radiografía de pelvis AP, que se muestra a continuación:



¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Pasar una sonda Foley
- b) Indicar reposo en hamaca
- c) Administrar antibióticos
- d) Realizar cirugía
- e) Solicitar ecografía de abdomen y pelvis

27) Un lactante de 10 meses de edad, presenta un cuadro de fiebre hasta 37,8 grados Celsius, asociado a aparición de un exantema generalizado, de tipo macular eritematoso, de aspecto tenue. Al examen físico destacan adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores, sensibles a la palpación. El diagnóstico más probable es:

- a) Exantema súbito
- b) Eritema infeccioso
- c) Rubeola
- d) Sarampión
- e) Exantema por citomegalovirus

28) Si se quiere determinar la utilidad de una prueba diagnóstica, ¿Qué técnica es la más adecuada?

- a) Elaboración de curvas de ROC
- b) Determinar la sensibilidad y especificidad de la prueba
- c) Determinar la sensibilidad de la prueba y la prevalencia de la enfermedad
- d) Determinar la especificidad y el valor predictivo negativo de la prueba
- e) Determinar el número necesario para tratar (NNT)

29) Un hombre de 29 años, presenta un cuadro de tos seca, de 5 semanas de evolución, a lo que se ha agregado disnea y malestar general. Al examen físico destaca FC: 100x', PA: 110/70 mmHg, temperatura: 37,5 grados Celsius y FR: 30x'. El examen cardiopulmonar, así como la radiografía de tórax son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Infección por adenovirus
- b) Infección por virus influenza
- c) Infección por Bordetella pertusis
- d) Infección por Pneumocystis jiroveci
- e) Infección por Mycobacterium tuberculosis

30) Un paciente de 65 años, alcohólico inveterado, se queda dormido sobre el costado derecho, mientras estaba borracho. Al despertar, al día siguiente, no puede mover la mano derecha. Al examen neurológico, no puede extender los dedos ni la muñeca, aunque puede flectarlos sin problemas. Además no tiene alteraciones visuales ni afasia. El diagnóstico más probable es:

- a) Hematoma subdural izquierdo
- b) Trombosis de la vena subclavia
- c) Neuropatía compresiva del nervio radial
- d) Trombosis de la arteria subclavia
- e) Hematoma capsular izquierdo

31) Un paciente de 70 años, diabético tipo 2 e hipertenso, en tratamiento con metformina, losartán e hidroclorotiazida, presenta un cuadro de 4 días de vómitos alimentarios y diarrea, evolucionando con malestar general y disminución del volumen urinario. Al examen físico está bradipsíquico, con presión arterial de 100/50 mmHg, frecuencia cardíaca de 110x'. En sus exámenes de laboratorio destaca creatinina: 2,0 mg/dl, BUN: 78 mg/dl, FeNa: 0,5%, sodio: 130 mEq/L, potasio: 2,0 mEq/L y cloro: 110 mEq/L. ¿Qué fluido debe administrarse inicialmente?

- a) Solución glucosada al 5%
- b) Solución ringer lactato
- c) Albúmina al 5%
- d) Solución glucosalina isotónica
- e) Solución de bicarbonato al 2/3 molar

32) Una paciente de 14 años aún no ha tenido su menarquia. Presenta desarrollo puberal Tanner 2, mamario y pubiano, con vello axilar. No tiene otras alteraciones en el examen físico. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía ginecológica
- b) Solicitar cariotipo
- c) Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, LH y FSH
- d) Realizar prueba de progesterona
- e) Controlar en un año

33) Un paciente de 32 años presenta un cuadro de cólico renal, asociado a microhematuria en el sedimento de orina. ¿Cuál es el examen de elección para el estudio de este paciente?

- a) UroTAC
- b) PieloTAC
- c) Pielografía de eliminación intravenosa
- d) Ecografía
- e) Radiografía simple

34) Un niño de 2 años presenta estrabismo divergente, con desviación del ojo derecho hacia temporal, que apareció hace pocos meses y que ha ido progresando. Al examen físico, además se constata ausencia del rojo pupilar de ese ojo. El diagnóstico más probable es:

- a) Glaucoma congénito
- b) Retinoblastoma
- c) Catarata congénita
- d) Leucoma
- e) Estrabismo esencial

35) Una paciente de 20 años, universitaria, tiene escasa interacción con sus compañeros, porque la inhibe el juicio que ellos puedan tener sobre su desempeño. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad esquizoide
- b) Trastorno de ansiedad
- c) Fobia social
- d) Trastorno del espectro autista
- e) Esquizofrenia

36) Una mujer de 33 años, cursando con un embarazo de 26 semanas, sufre un accidente de tránsito, por lo que es llevada al servicio de urgencias, constatándose metrorragia moderada. Desde el punto de vista obstétrico, lo primero que se debe evaluar es:

- a) La vitalidad fetal
- b) La ubicación placentaria
- c) La dilatación cervical
- d) La dinámica uterina
- e) La integridad de las membranas

37) Mujer de 25 años, con embarazo de 15 semanas, presenta un VDRL positivo en dilución 1/16. Refiere ser alérgica a la amoxicilina, con una reacción alérgica, que requirió hospitalización, cuando presentó una infección faríngea en la infancia. La conducta más adecuada es:

- a) Tratar con penicilina benzatina, administrando una dosis ahora y otra en una semana.
- b) Pedir ANA y anticuerpos anti-DNA
- c) Solicitar FTA-abs
- d) Tratar con eritromicina
- e) Tratar con ceftriaxona

38) Una paciente de 31 años, cursando un embarazo de 28 semanas, sin alteraciones hasta el momento, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, con 75 gramos de glucosa, que resulta 75 mg/dl basal y 160 mg/dl a las 2 horas de la carga de glucosa. El diagnóstico más probable es:

- a) Intolerancia a la glucosa
- b) Diabetes gestacional
- c) Diabetes pregestacional
- d) Diabetes mellitus 2
- e) Resistencia a la insulina

39) Una paciente de 67 años consulta por un cuadro de dolor e impotencia funcional del codo derecho, asociado a fiebre, que inició hace 2 días. Al examen físico tiene temperatura de 39 grados Celsius, FC: 100x' y PA: 110/70 mmHg, asociado a aumento de volumen del codo derecho, con eritema y aumento de la temperatura local. Además, tanto la movilidad pasiva, como la activa, son muy dolorosas. ¿Cual es el diagnóstico más probable?

- a) Artritis reactiva
- b) Artritis séptica
- c) Artritis gotosa
- d) Condrocálcinosis
- e) Artritis reumatoide

40) Una paciente múltipara, con un parto anterior por cesárea, cursando con un nuevo embarazo de 35 semanas, consulta por metrorragia moderada. Al examen físico presenta una contracción uterina cada diez minutos y se realiza ecografía que visualiza una placenta posterior que sobrepasa en dos centímetros al orificio cervical. El ecodoppler materno-fetal es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar tocolíticos
- b) Inducir el parto con misoprostol
- c) Administrar corticoides para maduración pulmonar
- d) Repetir la ecografía a las 37 semanas
- e) Realizar cesárea

41) Un paciente de 40 años consulta por un síncope, mientras jugaba fútbol, con recuperación completa. Además refiere disnea de esfuerzos que inició hace 3 meses y que ha aumentado lentamente. Su hermano murió súbitamente a los 25 años. Al examen físico se constata un soplo sistólico eyectivo, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Síndrome de Brugada
- c) Miocardiopatía hipertrófica
- d) Síndrome disautonómico
- e) Síndrome de QT largo

42) En Chile, el financiamiento de la seguridad social relacionada a los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales viene dado principalmente por:

- a) El aporte de Fonasa y las Isapres
- b) Financiamiento tripartito (Estado, trabajadores y empleadores)
- c) El 7% de aporte de los trabajadores
- d) El aporte estatal directo
- e) Aporte patronal de 0,85% del sueldo del trabajador

43) Un paciente adulto mayor, diabético, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de aparición de una lesión eritematosa en el tronco, como se ve en la siguiente imagen:



El tratamiento más adecuado es:

- a) Aciclovir 400 mg cada 8 horas, por 5 días
- b) Valaciclovir 1g cada 8 horas, por 5 días
- c) Aciclovir tópico
- d) Loratadina 10 mg al día por 5 días
- e) Flucloxacilina 500 mg cada 8 horas por 10 días

44) Paciente masculino de 27 años de edad , quien presenta desde hace 1 año temor a volar, por lo que prefiere desplazarse por tierra siempre. Incluso ha dejado de asistir a congresos y visitar a familiares en el extranjero. Siente mucha angustia y palpitaciones, cada vez que sabe que debe tomar un avión, desde los días antes y en dos oportunidades, previo a los vuelos, ha tomado benzodiacepinas con respuesta parcial. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de ansiedad generalizada
- b) Fobia específica
- c) Agorafobia
- d) Trastorno de pánico
- e) Trastorno por ansiedad de separación

45) Paciente de 23 años, que desde hace 6 meses experimenta desánimo, que ella dice que es causado por estar muy disconforme con su figura. Refiere que experimenta momentos en que come muchas galletas, sin parar, hasta ser imposible seguir comiendo, en especial cuando está ansiosa. Además, tiene miedo de reprobar en la universidad. Refiere que 3 veces por semana, puede trotar 5 horas y comer menos de 200 Calorías al día. Niega provocarse vómitos, ya que refiere que no puede inducírseles, aunque ha intentado. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?

- a) Anorexia nervosa
- b) Trastorno por atracones
- c) Depresión mayor
- d) Bulimia nervosa
- e) Trastorno de ansiedad generalizada

46) Recién nacido de término, con peso bajo para edad gestacional, tiene perímetro cefálico menor a percentil 3 para la edad gestacional y evoluciona después de nacer con ictericia progresiva, más hepatomegalia. ¿Cuál es el agente causal más probable?

- a) Citomegalovirus
- b) Virus papiloma humano
- c) VIH
- d) Virus Zika
- e) Chlamydia trachomatis

47) Una paciente de 35 años, usuaria de dispositivo intrauterino, hace 9 años, consulta por un cuadro de dolor pélvico, que aumentó en la última menstruación. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra una lesión quística de 6 cm en el ovario derecho, con contenido denso. Se solicitan niveles de Ca-125 que resultan 160 UI/ml (VN: menor a 35). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Quiste folicular
- b) Cáncer de ovario inicial
- c) Quiste endometriósico
- d) Cáncer de ovario avanzado
- e) Teratoma ovárico

48) Una paciente de 26 años, se realiza una colecistectomía laparoscópica hace 2 semanas. Inicialmente evoluciona bien, pero hace 12 horas presenta un cuadro de fiebre y dolor cutáneo generalizado, con eritema generalizado de la piel y compromiso de las mucosas. Hace algunas horas comienza con aparición de ampollas generalizadas. Al examen físico se observa lo mostrado en la siguiente imagen:



El diagnóstico más probable es:

- a) Psoriasis eritrodérmica
- b) Escarlatina quirúrgica
- c) Pustulosis exantemática
- d) Necrosis epidermolítica tóxica
- e) Pénfigo

49) Paciente masculino de 42 años, cursa desde hace 1 año con disfagia asociada a regurgitación ocasional de alimentos no digeridos, por lo que necesita tomar agua con las comidas, para poder tragar. Además refiere baja de peso en los últimos meses. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer esófago
- b) Cáncer gástrico de cardias
- c) Estenosis esofágica, secundaria a esofagitis por reflujo gastroesofágico
- d) Acalasia esofágica
- e) Esofagitis por *Cándida albicans*

50) Un paciente de 70 años, consulta por un cuadro de varios meses de evolución de constipación, alternado con diarrea. Su examen físico no aporta mayor información. En sus exámenes destaca hematocrito: 36% y hemoglobina de 12 g/dl. ¿Qué examen debe solicitarse a continuación?

- a) Test de sangre oculta en deposiciones
- b) Ecografía abdominal
- c) TAC de abdomen y pelvis
- d) Colonoscopia
- e) Rectosigmoidoscopia

51) Una paciente de 20 años, consulta por dolor intenso en la fosa iliaca izquierda, de 3 horas de evolución, que se ha asociado a vómitos. Al examen físico está afebril, con signos vitales normales y al examen abdominal presenta intenso dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda, con signo de Blumberg y resistencia muscular. No presenta atraso menstrual. Se solicita ecografía ginecológica, que muestra útero y ovario derecho normales y ovario izquierdo, con aumento de tamaño y presencia de un quiste de 6 x 4 cm, sin flujo al doppler y sin visualización de líquido peritoneal libre. El diagnóstico más probable es:

- a) Endometrioma
- b) Cuerpo lúteo hemorrágico
- c) Quiste ovárico torcido
- d) Teratoma ovárico
- e) Embarazo ectópico

52) Un paciente de 49 años, fumador, presenta un cuadro de dispepsia postprandial de 4 meses de evolución, asociado a astenia, palidez, ictericia y prurito, que aumenta en las noches. Se solicitan exámenes que muestran hemograma normal y pruebas hepáticas que resultan GOT: 23 UI/L, GPT: 28 UI/L, bilirrubina total: 9,7 mg/dl, bilirrubina directa: 8,5 mg/dl, fosfatasas alcalinas: 322 UI/L y GGT: 131 UI/L, con protrombinemia 80% y albúmina: 3,2 g/dl. El examen de elección para el estudio de este paciente es:

- a) Endoscopia digestiva alta
- b) Ecotomografía abdominal
- c) TAC abdominal
- d) Colangiografía por RMN
- e) Colangiografía endoscópica retrógrada

53) Un niño de 8 años de edad presenta un cuadro de aparición de lesiones eritematosas en las extremidades inferiores y en los glúteos, asociado a dolor en ambos tobillos, a lo que luego se agrega dolor abdominal y vómitos. Al examen presenta lesiones eritematosas solewantadas en las zonas descritas, aumento de volumen en ambos tobillos y dolor abdominal difuso a la palpación. ¿Qué examen es más adecuado para definir el pronóstico de esta enfermedad?

- a) Hemograma
- b) Sedimento de orina
- c) LDH
- d) Perfil bioquímico
- e) VHS

54) Un paciente de 20 años presenta un cuadro de poliuria y polidipsia, de 2 días de evolución, a lo que se ha agregado dolor abdominal y vómitos hace pocas horas. Se solicita una glicemia, que resulta 360 mg/dl. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?

- a) Cetonemia
- b) Creatininemia
- c) Perfil lipídico
- d) Hemoglobina glicosilada
- e) Hemograma

55) Paciente de 63 años, fumador y diabético, que hace una hora comienza con dolor torácico opresivo, intenso, que se irradia a cuello, con diaforesis y sensación de angustia. Se solicita un electrocardiograma, que muestra ritmo sinusal, a 80 lpm, con bloqueo completo de rama izquierda, que no se había visualizado en electrocardiogramas previos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar enzimas cardíacas
- b) Solicitar angiografía pulmonar
- c) Solicitar ecocardiograma transesofágico
- d) Instalar marcapaso externo transitorio
- e) Iniciar terapia de reperfusión miocárdica precoz

56) Una paciente múltipara, de 40 años, cursando un embarazo de 32 semanas, se realiza una ecografía obstétrica, que muestra líquido amniótico sin alteraciones, con un feto creciendo en percentil 10 para la edad gestacional, con un peso fetal estimado de 1.320 gramos. ¿Cuál es la actitud más adecuada?

- a) Observar evolución
- b) Solicitar ecodoppler uterina
- c) Solicitar ecodoppler umbilical
- d) Repetir la ecografía obstétrica en 2 semanas
- e) Inducir maduración pulmonar con corticoides

57) Una paciente femenina de 33 años, que hace 5 años comienza con síntomas recurrentes y variables de molestias genitourinarias, y gastrointestinales, asociados a mareos y prurito, ha consultado en reiteradas ocasiones a especialistas los cuales han descartado enfermedad orgánica, llegando incluso a realizarse una laparoscopia exploradora, que no tenía alteraciones. Sus síntomas le impiden trabajar. ¿Cuál es el diagnostico más probable?

- a) Hipocondria
- b) Trastorno facticio
- c) Trastorno de personalidad
- d) Trastorno de somatización
- e) Simulación

58) Una mujer de 23 años quien, desde la niñez es extremadamente introvertida y con baja autoestima por lo que se le es difícil conseguir amigos, por miedo a que pensarán de ella, esto la hace infeliz. En cambio, con su familia es muy cariñosa. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno evitativo de la personalidad
- b) Síndrome de Asperger
- c) Depresión mayor
- d) Distimia
- e) Fobia social

59) Una paciente de 60 años presenta cefalea, astenia y calambres en extremidades inferiores. Al examen físico destaca PA: 170/95 mmHg, FC: 80 lpm y en sus exámenes destaca Na: 150 mEq/L, K:2.6 mEq/L, Cl:90 mEq/L y TSH: 4.0 UI/L. La causa más probable de la hipertensión es:

- a) Hipertensión renovascular
- b) Feocromocitoma
- c) Hipotiroidismo
- d) Hiperaldosteronismo
- e) Hipertensión esencial

60) Un niño de 4 años presenta un cuadro de 2 días de evolución de aparición de múltiples lesiones eritematosas en las extremidades inferiores, palpables, asociado a dolor abdominal difuso y dolor de ambos tobillos. Al examen físico se palpa abdomen blando, depresible, doloroso leve, de manera difusa, sin signos peritoneales y los tobillos se aprecian aumentados de volumen, con dolor a la movilización. ¿Qué examen es más adecuado para definir el pronóstico de la enfermedad descrita?

- a) Perfil bioquímico
- b) Biopsia de médula ósea
- c) Hemograma
- d) Sedimento de orina
- e) LDH

61) Un paciente de 24 años, con antecedente de retraso mental severo, en tratamiento con clorpromazina, aumenta la dosis de 100 mg al día, a 300 mg al día. Evoluciona con mayor agresividad, asociada a retención urinaria y constipación. Al examen destacan mucosas secas y midriasis. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome colinérgico
- b) Síndrome anticolinérgico
- c) Síndrome neuroléptico maligno
- d) Síndrome serotoninérgico
- e) Síndrome adrenérgico

62) Un joven 17 años, comienza tratamiento con risperidona 3mg al día, hace 1 semana, por esquizofrenia primer brote. Presenta contracción cervical, mantenida y recurrente, que se acompaña de dolor. El diagnóstico más probable es:

- a) Disonía aguda
- b) Disquinesia tardía
- c) Acatisia
- d) Trastorno conversivo
- e) Parkinsonismo por drogas

63) Una niña 14 años consulta por talla baja. Tiene IMC/edad: p65, Talla/edad: - 2 DS, cabello de implantación baja, cuello alado, mamas y vello púbico en Tanner 1. Trae radiografía de mano, con edad ósea de 11 años. ¿Con que examen debe continuar el estudio?

- a) Hemograma
- b) Cariotipo
- c) Anticuerpos antitransglutaminasa
- d) LDH
- e) Hormona de crecimiento

64) Una mujer de 28 años, puérpera de 2 meses, con 3 semanas de diarreas con presencia de sangre y dolor abdominal difuso leve. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con abdomen blando, sensible a la palpación profunda, sin signos de irritación peritoneal, con meteorismo. El diagnóstico más probable es:

- a) Diarrea debida a Clostridium difficile
- b) Colitis ulcerativa
- c) Enfermedad de Cröhn
- d) Colitis inespecífica
- e) Shigellosis

65) Una paciente de 65 años sufre caída a nivel, apoyando la mano derecha contra el suelo, en extensión de la extremidad. Evoluciona con dolor intenso en la muñeca, que le impide realizar movimientos. Al examen físico se aprecia deformidad de la muñeca y dolor epicrítico a la presión del radio distal. El diagnóstico más probable es:

- a) Fractura de escafoides
- b) Fractura de epifisis distal del radio
- c) Disyunción-fractura de radio distal
- d) Luxofractura de Monteggia
- e) Luxación de cúpula radial

66) Paciente de 35 años, multípara, con un nuevo embarazo de 32 semanas, presenta salida de líquido amniótico por genitales. El test de cristalización confirma rotura prematura ovular. Al examen físico se constata taquicardia materna y fetal, asociada a contracciones uterinas dolorosas y útero doloroso a la palpación. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Inducir el parto
- b) Realizar cesárea
- c) Administrar corticoides
- d) Administrar antibióticos
- e) Administrar tocolíticos

67) Paciente masculino de 88 años de edad quien consulta por astenia de 3 meses de evolución. Al examen físico se observa palidez de piel y mucosas y leve tinte icterico en escleras. Hemograma: Hemoglobina 6,6 grs/dl; hematocrito: 17%; VCM : 117 fl; plaquetas: 110.000 por mm³; glóbulos blancos: 3.400 x mm³; fórmula diferencial: neutrófilos: 74 %, linfocitos: 20 %, eosinófilos: 5 % y baciliformes: 1 %. El examen para confirmar el diagnóstico es:

- a) Mielograma
- b) Citometría de flujo
- c) Prueba de Coombs
- d) Niveles de Eritropoyetina.
- e) Niveles de vitamina B12 y Ácido fólico.

68) Niña de 7 años de edad, quien consulta por cuadro de 12 horas de evolución, caracterizada por fiebre y dolor hipogástrico. Al examen físico tiene temperatura: 38,7 grados, FC: 100x', PA: 100/60, dolor a la palpación de hipogastrio, con signo de Blumberg positivo y resistencia en la pared abdominal. Exámenes de laboratorio; 18.000 glóbulos blancos. Sedimento urinario muestra 20 leucocitos por campo. Proteína C reactiva: 15. El diagnóstico más probable es:

- a) Pielonefritis aguda
- b) Apendicitis aguda
- c) ITU baja
- d) Torsión ovárica
- e) Plastrón apendicular

69) ¿Cuál de las siguientes enfermedades corresponde con mayor probabilidad a una enfermedad laboral?

- a) Dermatitis de contacto alérgica
- b) Asma
- c) Mesotelioma
- d) Síndrome del manguito rotador
- e) Trastorno adaptativo

70) Un lactante de 10 meses de edad, con antecedente de dermatitis del pañal presenta aparición de lesiones eritematosas y pruriginosas en los muslos, que se muestran en la imagen:



El tratamiento más adecuado es:

- a) Antimicóticos tópicos en crema
- b) Corticoides tópicos en crema
- c) Antibióticos tópicos en crema
- d) Aciclovir tópico
- e) Vaselina tópica

71) Un paciente de 38 años con cuadro de 6 meses con aumento de volumen en región preauricular derecha. Al examen físico se constata nódulo en región preauricular de 4 cm de diámetro, de consistencia blanda, indoloro a la palpación y fija, sin afectación de la piel que lo recubre. El diagnóstico más probable:

- a) Adenopatía tuberculosa
- b) Adenoma pleomorfo
- c) Lipoma
- d) Quiste sebáceo
- e) Sarcoma

72) Un hombre de 40 años presenta un cuadro de dolor abdominal, de 3 meses de evolución, leve, intermitente. Al examen físico presenta leve dolor a la palpación del hipocondrio derecho, por lo que se solicita una ecografía de abdomen, que visualiza una lesión hepática quística, con paredes visibles y gruesas, de 8 cm. En sus exámenes destaca hemograma con hematocrito y plaquetas normales, con 8.000 blancos, 50% de neutrófilos, 40% de linfocitos, 3% de eosinófilos y 7% de monocitos. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?

- a) IgG para Toxoplasma gondii
- b) Serología para hidatidosis
- c) Serología para Triquinella spiralis
- d) IgG para Fasciola hepática (Distoma)
- e) Examen parasitológico seriado de deposiciones

73) Paciente con diagnóstico de una leucemia mieloide aguda, en su cuarto ciclo de quimioterapia, se encuentra hospitalizado por fiebre sin foco, asociado a neutropenia (neutropenia febril), por lo que está en tratamiento con ceftazidima, amikacina y vancomicina, sin mayor respuesta. En sus exámenes de laboratorio presenta neutrófilos 100 por mm³ y en la radiografía de tórax se observa una imagen apical derecha radiopaca, de 3 cm de diámetro, espiculada y con bordes difusos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tuberculosis
- b) Neumonía intrahospitalaria
- c) Aspergilosis invasiva
- d) Nocardosis
- e) Neumonía por *Pneumocystis jiroveci*

74) Si se mejorara el tratamiento de una enfermedad crónica, y se mantiene la incidencia, ¿que pasaría con la prevalencia?

- a) Aumenta
- b) No se modifica
- c) Disminuye
- d) No se puede saber
- e) Depende de la enfermedad

75) Una paciente de 32 años, con antecedentes de asma y rosácea, usuaria de corticoides inhalados, presenta un cuadro de algunos meses de evolución de ojo rojo bilateral, asociado a ardor, epifora y secreción mucosa, que a veces se vuelve purulenta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Glaucoma agudo
- b) Blefaritis
- c) Uveítis
- d) Dacriocistitis
- e) Conjuntivitis bacteriana crónica

76) Una mujer de 65 años de edad, multípara de 4, con todos los partos por vía vaginal, con menopausia a 50 años, sin terapia de reemplazo hormonal, presenta escape de pequeñas cantidades de orinal, al realizar esfuerzos, así como al toser o reírse, lo que la obliga a usar protectores. No tiene urgencia miccional. Su examen físico no aporta mayor información, pero es posible visualizar leve escape de orina, al toser. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para esta paciente?

- a) Cirugía (TVT)
- b) Anticolinérgicos
- c) Alfa adrenérgicos
- d) Kinesioterapia del piso pélvico
- e) Antibióticos, como profilaxis de ITU

77) Una lactante de 8 meses de edad, con antecedente de prematurez, presenta un cuadro de 12 horas de evolución, de irritabilidad, llanto y dolor abdominal, asociado a dos de posiciones sanguinolentas. Al examen físico presenta abdomen blando y doloroso a la palpación. En su analítica destaca hematocrito de 34%, con Hemoglobina de 11,2 g/dl, leucocitos: 14.500 por mm³ y plaquetas: 230.000 por mm³. El diagnóstico más probable es:

- a) Enterocolitis necrotizante
- b) Divertículo de Meckel complicado
- c) Atresia esófagica
- d) Invaginación intestinal
- e) Shigellosis

78) Un niño de 7 años es traído por su madre, porque presenta mal rendimiento escolar. Tiene un hermano con déficit atencional diagnosticado. Durante el examen, presenta un breve episodio de desconexión con el medio. ¿Con que examen se debe continuar el estudio de este paciente?

- a) Psicometría
- b) Evaluación psicopedagógica
- c) Electroencefalograma
- d) TAC cerebral
- e) Audiometría

79) Adolescente de 15 años con cuadro de 5 días de evolución con fiebre, astenia, náuseas, ictericia, a lo que últimamente se ha agregado prurito. Ha tomado Paracetamol (500 mg), un total de 6 tabletas. Al examen físico, hipocondrio derecho levemente sensible a la palpación. Tiene antecedente de haber estado en un campamento hace 1 mes. En sus exámenes tiene fosfatasas alcalinas y GGT: 8 veces por encima del valor normal; y transaminasas: 20 veces por encima del valor normal; bilirrubinemia aumentada. ¿Cuál es el diagnóstico probable?

- a) Colecodolitiasis
- b) Hepatitis A
- c) Hepatitis C
- d) Hepatitis por fármacos
- e) Hepatitis autoinmune

80) ¿A qué indicador corresponde la siguiente afirmación "De 100 pacientes tuberculosos, 13 fallecen"?

- a) Valor absoluto
- b) Razón
- c) Frecuencia relativa
- d) Índice
- e) Tasa

81) Un Paciente de 52 años con historia de ronquidos frecuentes, de larga data, que desde hace 5 años, se asocia a somnolencia diurna excesiva y deterioro cognitivo. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca de 75x' y presión arterial de 140/100 mmHg. Su IMC es de 35. Se realiza polisomnografía que evidencia índice de apenas de 50 eventos de apnea / hipopnea por hora, con predominio de los eventos obstructivos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Oxígeno nocturno
- b) C-PAP nocturno
- c) Cirugía bariátrica
- d) Uvulopalatoplastía
- e) Dispositivo orofaríngeo

82) Una niña de 5 años, con antecedentes de atopía, consulta por presentar lesiones hipo pigmentadas en el rostro, no pruriginosas, ni dolorosas con descamación amarilla como se muestra en la siguiente imagen:



La indicación más adecuada es:

- a) Crema de hidrocortisona tópica
- b) Crema de betametasona tópica
- c) Crema de clotrimazol tópico
- d) Griseofulvina oral
- e) Bloqueador solar

83) Un hombre de 46 años refiere que las mujeres de su trabajo se le insinúan y quieren tener una relación con él. Sin embargo, no hay testigos de esos hechos y al interrogar a sus compañeras de trabajo, lo niegan. Al confrontar al paciente, se enoja, ya que le molesta que no crean en lo que él dice. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipomanía
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Dismorfofobia
- e) Trastorno de personalidad narcisista

84) Un paciente de 55 años, con antecedente de diabetes mellitus 2, consulta por un cuadro de hematemesis, seguida de malestar general. Al examen físico está pálido, con FC:110x', PA: 100/60 mmHg, constatándose obesidad. En sus exámenes destaca albúmina: 3,0 g/dl; INR: 1,3; hematocrito: 30%, plaquetas: 77.000 por mm³, VCM: 105 fl y VHS: 20 mm/h. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Mallory Weiss
- b) Úlcera gástrica
- c) Úlcera duodenal
- d) Várices esofágicas
- e) Gastritis crónica atrófica

85) Una paciente de 15 años, consulta por hipermenorrea y menometrorragia, de Se solicita una ecografía transvaginal, que no muestra lesiones, ni alteraciones uterinas ni ováricas. El endometrio tiene 5 mm de grosor. Su hemograma muestra anemia leve, con glóbulos blancos: 7.000 por mm³ y plaquetas: 250.000 por mm³. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar biopsia de endometrio
- b) Solicitar estudio de alteraciones de la hemostasia
- c) Solicitar estudio de trombofilias
- d) Solicitar resonancia magnética nuclear abdominopélvica
- e) Solicitar endosonografía uterina (histerosonografía)

86) Un hombre de 40 años consulta por disnea y palpitaciones ocasionales. Al examen físico presenta un soplo sistólico basal, con desdoblamiento fijo del segundo ruido. Se solicita un electrocardiograma, que muestra un bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Comunicación interauricular
- b) Ductus arteriosos persistente
- c) Comunicación interventricular
- d) Estenosis aórtica
- e) Estenosis pulmonar

87) Un lactante de 12 meses de edad, que a los 9 meses presentó un exantema, al introducir huevo a su alimentación por lo que fue suspendido, sin haberlo comido de nuevo. ¿Cuál es la conducta a tomar con repecho a la vacuna trivírica?

- a) Aplicar a los 12 meses
- b) Contraindicar la vacuna
- c) Aplicar a los 18 meses
- d) Diferir hasta los 2 años
- e) Realizar IgE específica del huevo y decidir según resultado

88) Paciente de 30 años, multípara de 1 parto vaginal, presenta parto de término, con 4 cm de dilatación, membranas rotas, se administra anestesia peridural, presentando PA 100/65 mmHg, LCF 90/min y 6 contracciones uterinas cada 10 minutos. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar volumen y monitorización fetal
- b) Realizar cesárea de urgencia
- c) Iniciar tocolisis de urgencia
- d) Realizar fórceps
- e) Iniciar amniotransfusión

89) Un paciente de 45 años, diagnosticado de VIH, presenta sangrado rectal ocasional. Al examen físico, se observa lesión solevada en los márgenes anales, de 4 cm, que se introduce en el recto, sobrepasando la línea pectínea, con una con una ulceración central, con escaso sangrado. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemorroide externa trombosado
- b) Condiloma acuminado
- c) Sífilis
- d) Cáncer epidermoide
- e) Enfermedad de Cröhn

90) Cuando se realiza una intubación orotraqueal en un paciente que se está reanimando, ¿cuál es la conducta es parámetro ideal para confirmar que está adecuadamente intubado?

- a) Pulsometría
- b) Auscultación pulmonar
- c) Capnografía
- d) Oximetría
- e) Expansión torácica

NOMBRE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

APELLIDO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

APELLIDO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RUT o número P

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	A	B	C	D	E	19	A	B	C	D	E	37	A	B	C	D	E	55	A	B	C	D	E	73	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E	20	A	B	C	D	E	38	A	B	C	D	E	56	A	B	C	D	E	74	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E	21	A	B	C	D	E	39	A	B	C	D	E	57	A	B	C	D	E	75	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E	22	A	B	C	D	E	40	A	B	C	D	E	58	A	B	C	D	E	76	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E	23	A	B	C	D	E	41	A	B	C	D	E	59	A	B	C	D	E	77	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E	24	A	B	C	D	E	42	A	B	C	D	E	60	A	B	C	D	E	78	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E	25	A	B	C	D	E	43	A	B	C	D	E	61	A	B	C	D	E	79	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E	26	A	B	C	D	E	44	A	B	C	D	E	62	A	B	C	D	E	80	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E	27	A	B	C	D	E	45	A	B	C	D	E	63	A	B	C	D	E	81	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E	28	A	B	C	D	E	46	A	B	C	D	E	64	A	B	C	D	E	82	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E	29	A	B	C	D	E	47	A	B	C	D	E	65	A	B	C	D	E	83	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E	30	A	B	C	D	E	48	A	B	C	D	E	66	A	B	C	D	E	84	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E	31	A	B	C	D	E	49	A	B	C	D	E	67	A	B	C	D	E	85	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E	32	A	B	C	D	E	50	A	B	C	D	E	68	A	B	C	D	E	86	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E	33	A	B	C	D	E	51	A	B	C	D	E	69	A	B	C	D	E	87	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E	34	A	B	C	D	E	52	A	B	C	D	E	70	A	B	C	D	E	88	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E	35	A	B	C	D	E	53	A	B	C	D	E	71	A	B	C	D	E	89	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E	36	A	B	C	D	E	54	A	B	C	D	E	72	A	B	C	D	E	90	A	B	C	D	E



SEGUNDA PARTE

91) Adolescente de 13 años quien consulta por dolor inguinal y testicular izquierdo, intenso, de 45 minutos de evolución, irradiado a hipogastrio y acompañado de náuseas y vómitos. Al examen físico está afebril, con escroto enrojecido, testículo retraído y doloroso a la palpación. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- a) Administrar AINES
- b) Administrar antibióticos
- c) Cirugía
- d) Realizar suspensión testicular
- e) Solicitar ecografía testicular

92) Hombre de 75 años que hace 4 años tuvo un infarto y actualmente presenta palpitaciones intensas y compromiso de conciencia que se recupera después de reanimación cardiopulmonar ¿Qué arritmia debe descartarse en primer lugar?

- a) Fibrilación Auricular
- b) Taquicardia Ventricular
- c) Taquicardia paroxística supraventricular
- d) Bloqueo A-V de segundo grado mobitz 1
- e) Flutter auricular

93) Una paciente de 70 años de edad, con antecedente de cirrosis hepática, sin hábito alcohólico actual, VHBsAg (-) y Anticuerpos anti-VHC (-), Child Pugh clase A, MELDS: 8 puntos, se realiza una ecografía abdominal, que muestra una lesión sólida, en el lóbulo hepático derecho, de 3,5 cm y aspecto hipoeocogénico. En su laboratorio destaca alfafetoproteína de 5,3 ng/ml (VN: 0-7 ng/ml)

El diagnóstico más probable es:

- a) Metastásis hepática
- b) Adenoma hepático
- c) Carcinoma hepatocelular
- d) Quiste hepático
- e) Hemangioma hepático

94) Paciente mujer de 74 años, hipertensa controlada. Presenta dolor de tipo "eléctrico" lascinante en la mejilla y ala nasal izquierda, que compromete la arcada dentaria superior y la encía, así como la zona maxilar superior del lado izquierdo. Además presenta dolor retro ocular izquierdo. El dolor es de escasos segundos, pero intenso EVA 10/10, que se al tacto y al realizar actividades, como cepillarse los dientes e incluso una suave brisa puede desencadenarlo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para este cuadro?

- a) Pregabalina
- b) Tramadol
- c) Prednisona
- d) Carbamazepina
- d) Paracetamol y AINEs

95) Una niña de 5 años, ingiere accidentalmente soda cáustica, hace 45 minutos. Evoluciona con sialorrea y dolor abdominal y torácico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar carbon activado
- b) Solicitar endoscopía digestiva alta
- c) Administrar agente alcalinizante
- d) Instalar una sonda nasogástrica y aspirar el contenido
- e) Inducir los vómitos

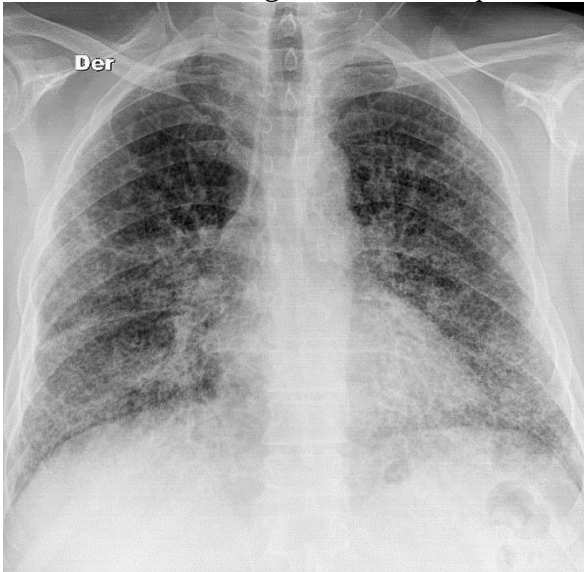
96) Un hombre de 32 años presenta dolor muscular y oliguria, 24 horas después de realizar ejercicio intenso, a lo que se agrega malestar general. En sus exámenes destaca creatininemia de 5 mg/dl, uremia de 9 mg/dl y potasemia de 5,4 mEq/L, con natremia: 140 UI/L. ¿Qué examen debe pedirse a continuación?

- a) Creatininkinasa
- b) Proteinuria de 24 horas
- c) Hemograma
- d) Sedimento de orina
- e) Clearance de creatinina

97) Mujer 54 años obesa, diabética e hipertensa, presenta hace 3 meses genitorragia intermitente, con antecedentes de menopausia a los 50 años, sin terapia hormonal de reemplazo y PAP normal de este año. El examen físico y ginecológico es normal. Se realiza una Ecografía tranvaginal, que muestra: útero en anteversoflexión, con tamaño normal, endometrio homogéneo de 3 mm de grosor, con anexos normales, sin liquido libre. ¿Cual es el diagnóstico más probable?

- a) Hiperplasia endometrial.
- b) Cáncer endometrial
- c) Pólipo endometrial
- d) Atrofia endometrial.
- e) Sarcoma uterino

98) Mujer de 56 años cardiópata y con fibrilación auricular crónica, en tratamiento con espironolactona, isosorbide, hidralazina, amiodarona y anticoagulante oral. Inicia hace 6 meses un cuadro de disnea y tos seca. A la exploración pulmonar tiene crépitos bibasales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación:



¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Suspender amiodarona
- b) Solicitar TAC de tórax
- c) Aumentar diurético
- d) Solicitar ecocardiograma
- e) Solicitar fibrobroncoscopia

99) Un paciente de 64 años, con antecedente de cirrosis por NASH, con Child Pugh C, en tratamiento con carvedilol. Hace 1 semana presenta ascitis a tensión, por lo que se indica furosemida y espironolactona. Desde entonces, ha subido 4 kg de peso y al examen físico presenta FC: 90 por minuto, PAM: 72 mmHg, ascitis grado III. En sus exámenes destaca bilirrubina 2,5 mg/dl, INR 1,34, creatinemia: 3,1 mg/dl, Na: 122 mEq/L, K 5.5: mEq/L, Cl: 100 mEq/L y polimorfonucleares: 230 por mm³ en el líquido ascítico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar ceftriaxona i.v.
- b) Administrar solución fisiológica i.v.
- c) Aumentar la dosis de diuréticos
- d) Realizar paracentesis evacuadora y administrar albúmina i.v.
- e) Suspender el carvedilol

100) Una paciente primigesta, cursando un embarazo de 38 semanas, presenta presiones arteriales cercanas a 150/90 mmHg. Está en buenas condiciones generales, sin exaltación neurológica, ni otros síntomas. Se solicita proteinuria de 24 horas, que resulta 400 mg. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar ecodoppler de arterias umbilicales
- b) Realizar operación cesárea
- c) Solicitar monitoreo fetal no estresante
- d) Inducir el parto
- e) Repetir la proteinuria en 2 semanas

101) Un paciente de 18 años, consulta porque desde hace un año presenta aumento de volumen progresivo en la cara anterior del muslo derecho, que recientemente se ha vuelto dolorosa. Al examen físico se palpa una masa de 10 cm de diámetro, de consistencia dura, no pétreo, sin afectación de la piel. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar resección y biopsia
- b) Observar evolución
- c) Solicitar ecografía de partes blandas
- d) Solicitar radiografía de fémur
- e) Realizar punción y drenaje

102) Una paciente de 61 años consulta por dolor articular de ambas manos. Al examen se aprecia aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Se solicita radiografía de manos, que muestra disminución simétrica del espacio interarticular de las articulaciones interfalángicas, con compromiso de la primera articulación carpometacarpiana bilateral, con presencia de quistes subcondrales. Los ANA y FR resultan positivos. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis psoriática
- b) Artritis reumatoide
- c) Artritis reactiva
- d) Condrocálcinosis
- e) Artrosis

103) Una paciente de 61 años, hipertensa y diabética, en tratamiento regular con hipoglucemiantes orales y antihipertensivos, desde hace 3 días presenta dolor y aumento de volumen en hombro derecho. Al examen físico presenta temperatura 38,2 °C, eritema, rubor y aumento de volumen del hombro derecho y limitación funcional, que impide el movimiento. El diagnóstico más probable es:

- a) Gota
- b) Condrocálcinosis
- c) Artritis reumatoidea
- d) Artritis séptica
- e) Artritis reactiva

104) Una paciente de 64 años, con antecedente de by-pass gástrico, por obesidad mórbida, presenta un cuadro de dificultad a la marcha, asociado a astenia y malestar general. En sus exámenes destaca anemia macrocítica, plaquetas: 100.000 por mm³, blancos: 6.000 por mm³, ferritina 56 ug/dl y saturación de transferrina de 18%. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en este caso?

- a) Fierro
- b) Ácido fólico
- c) Cianocobalamina
- d) Zinc
- e) Tiamina

105) Una niña de 5 años presenta dolor en muslo izquierdo, que luego se ubica en la cadera izquierda y que limita su movimiento. Al examen físico está en buenas condiciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Sinovitis transitoria
- b) Arititis séptica
- c) Artritis reumatoidea
- d) Osteomielitis
- e) Tumor de Ewing

106) Una paciente primigesta de 40 años, con amenorrea de 8 semanas, se realiza un test de embarazo en orina, que resulta positivo. Se realiza ecografía transvaginal, que visualiza saco generacional de 15 mm diámetro, con saco vitelino, pero no se observa embrión. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Repetir la ecografía en 7 días
- b) Observar evolución por 30 días
- c) Realizar legrado
- d) Administrar misoprostol
- e) Solicitar betaHCG y niveles de progesterona

107) Una paciente de 56 años de edad presenta metrorragia abundante, que requiere de legrado. Se envía a biopsia, que es informada, como hiperplasia endometrial atípica y compleja. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Anticonceptivos combinados
- b) Solicitar niveles de estradiol y FSH
- c) Progestágenos orales en altas dosis
- d) Histerectomía total
- e) Progestágenos endovaginales

108) Un lactante de 4 meses de edad presenta una diarrea grave, abundante, asociada a deterioro del estado general y sopor. Sus exámenes muestran elevación de la creatinina, hiponatremia e hipokalemia. Es imposible encontrar una vía venosa para para administrar fluidos, ¿cuál es el medio de hidratación más adecuada?

- a) Catéter femoral
- b) Catéter subclavio
- c) Denudación safena
- d) Vía intraósea
- e) Sonda nasogástrica

109) Un lactante de 3 meses de edad pesa 7 kg. Se alimenta con lactancia materna exclusiva a libre demanda. Tiene peso para la edad en +1 DS y el índice peso/talla en +2 DS. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Dar formula de relleno
- b) Amamantar cada 4 horas
- c) Dar agua entre cada toma
- d) Mantener la lactancia materna a libre demanda
- e) Supender la lactancia nocturna

110) Un paciente de 24 años mantiene relaciones sexuales, por vía vaginal, sin protección, evolucionando con disuria, sin otros síntomas. Al examen físico y genital, no hay alteraciones. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Trichomona vaginalis
- b) Treponema pallidum
- c) Ureaplasma urealyticum
- d) Mycoplasma genitalis
- e) Chlamydia trachomatis

111) Un adolescente, con diagnóstico de linfoma de Hodgkin, se realiza un ciclo de quimioterapia



El diagnóstico más probable es:

- a) Reacción adversa a medicamentos
- b) Infiltración cutánea por linfoma
- c) Prurito paraneoplásico
- d) Mononucleosis infecciosa
- e) Meningococemia

112) Un paciente de 75 años presenta un cuadro de dolor lumbar de 3 meses de evolución, asociado a pérdida de peso y astenia. En sus exámenes tiene hemograma con hemoglobina: 9,2 g/dl, Plaquetas: 92.000 por mm³, blancos: 5000 por mm³, VHS:103 mm/h, creatinina: 1,7 mg/dl, albúmina: 3,2 g/dl, proteínas plasmáticas: 9,8 g/dl. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar la sospecha diagnóstica?

- a) Radiografía de huesos largos
- b) Radiografía de cráneo
- c) Recuento de inmunoglobulinas
- d) Mielograma
- e) Calcemia

113) Una paciente de 43 años es diagnosticada de bronquitis, iniciándose tratamiento con amoxicilina oral por 14 días, con buena respuesta. Al décimo día de tratamiento antibiótico evoluciona con dolor abdominal y diarrea, que en oportunidades es sanguinolenta. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Agregar sales de rehidratación oral
- b) Solicitar parasitológico seriado de deposiciones
- c) Agregar ciprofloxacino al tratamiento
- d) Solicitar colonoscopia
- e) Suspender el tratamiento antibiótico y solicitar toxinas de Clostridium difficile en deposiciones

114) Un paciente de 43 años acude al servicio de urgencia, luego de 7 días de ingesta alcohólica, porque presentó vómitos alimentarios intensos, seguidos de hematemesis. Al examen físico está en buenas condiciones, con dolor a la palpación epigástrica y en sus exámenes destaca hematocrito: 32%, GOT: 180UI/L, GPT: 130 UI/L, protrombinemia: 78%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Úlcera gástrica
- b) Úlcera duodenal
- c) Síndrome de Mallory Weiss
- d) Gastritis erosiva
- e) Várices esofágicas

115) Paciente masculino de 45 años, presenta súbitamente hemiparesia derecha, refiere historia de 2 meses de evolución de astenia, compromiso del estado general y fiebre de predominio nocturno. Al examen físico presenta hemiparesia derecha, fiebre de 37,8 grados celsius y la auscultación cardíaca muestra un ritmo regular en 2 tiempos, con un soplo sistólico IV/VI en el ápex. Su sedimento de orina muestra hematuria microscópica. El diagnóstico más probable es:

- a) Absceso cerebral
- b) Tuberculosis meníngea
- c) Meningitis bacteriana
- d) Endocarditis bacteriana
- e) Leucemia mieloide aguda

116) Un paciente de 25 años de edad, sin patologías previas, presenta desde hace 4 años aumento de volumen cervical lateral, que ha ido creciendo. Al examen se constata una masa palpable, de 3 cm, en la zona lateral del cuello, de ubicación submandibular. Se solicita una ecografía cervical, que muestra un nódulo hipoeecogénico, de bordes bien delimitados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Nódulo tiroideo
- b) Quiste branquial
- c) Quiste tirogloso
- d) Linfadenopatía tuberculosa
- e) Tumor de glándula salival secundaria

117) En un paciente adulto mayor, que presenta síncope, ¿cuál de las siguientes arritmias requiere un marcapaso definitivo?

- a) Fibrilación auricular crónica
- b) Bloqueo auriculoventricular de primer grado
- c) Flutter auricular 2-3 a 1
- d) Enfermedad del nodo sinusal
- e) Bloqueo completo de rama izquierda

118) Un paciente es diagnosticado de tuberculosis pulmonar, por lo que se inicia tratamiento con antibióticos asociados. Sus baciloscopías mensuales de control resultan: mes 1 (+), mes 2 (-), mes 3 (-), mes 4 (-), mes 5 (+) y mes 6 (+). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Recaída
- b) Eliminación esporádica
- c) Fracaso
- d) Contaminación
- e) Nocardiosis pulmonar

119) Un paciente de 26 años de edad presenta un cuadro de tos con expectoración de algunos años de evolución, mayor en las mañana y que ha presentado hemoptisis. Su examen físico presenta acropaquias y a la auscultación pulmonar hay crepitaciones y estertores bilaterales. El diagnóstico más probable es:

- a) Bronquiectasias
- b) Cáncer pulmonar
- c) Tuberculosis pulmonar
- d) Asma
- e) EPOC

120) Niño con lesiones eritematosas en miembros inferiores (foto) con artralgias de tobillos de 2 días de evolución y dolor abdominal. Al examen físico presenta edema de ambos tobillos, con lesiones en las piernas, como las que se muestran en la siguiente imagen:



Considerando las complicaciones frecuentes del cuadro, es importante solicitar:

- a) Creatininemia
- b) Hematocrito
- c) Plaquetas
- d) Protombinemia
- e) Proteína C reactiva

121) Paciente 36 años, sin antecedentes de importancia, cursa con un cuadro de un mes de evolución de edema de EEII que posteriormente se agrega edema bipalpebral que aparece en las mañanas. Al examen físico, presenta FC: 96'x, TA: 130/70 mmHg, se constata edema de miembros inferiores, en ambos tobillos, que asciende hasta la pierna. Se solicitan exámenes de laboratorio, que muestran creatininemia 1,7 mg/dl, BUN 20 mg/dl, albúmina: 3,0 g/dl, examen de orina con densidad: 1020 g/L, glucosuria (-), nitritos (-), proteínas (++), eritrocitos: 2-3 x campo, leucocitos 3-5 x campo. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome nefrítico
- b) Síndrome nefrótico
- c) Síndrome cardiorrenal
- d) Injurias renal aguda
- e) Hiperaldosteronismo primario

122) Una niña de 3 años presenta, hace 4 días, un cuadro de diarrea y fiebre hasta 38°C, a la que se agrega sangre en las deposiciones, 48 horas después. En su examen físico se ve decaída, pálida y en sus exámenes destaca hematocrito de 28%, leucocitos 9.800, plaquetas 75.000, BUN 28, creatinina 2,3 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Leucemia aguda
- b) Síndrome hemolítico urémico
- c) Shock Séptico
- d) Glomerulonefritis aguda
- e) Púrpura de Schölein Henoch

123) ¿Qué tipo estudio es el más adecuado para determinar el desarrollo de obesidad en un grupo de escolares a lo largo de un determinado tiempo?

- a) Estudio de prevalencia
- b) Estudio de incidencia
- c) Estudio de caso control
- d) Estudio de cohortes
- e) Ensayo clínico controlado

124) Una paciente, cursando embarazo de término, inicia contracciones uterinas intensas. Al examen obstétrico, se palpan 3 contracciones cada 10 minutos y dilatación cervical de 5 cm. Al romper las membranas, se produce metrorragia moderada, seguida de bradicardia fetal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Rotura uterina
- b) Desprendimiento de placenta normoinsera
- c) Placenta previa
- d) Rotura de vasa previa
- e) Procidencia de cordón umbilical

125) Una paciente de 45 años, fumadora de 25 paquetes-año, fuma al despertarse, y fuma más durante la mañana, con grandes bocanadas. Evita lugares donde no se puede fumar y fuma a pesar de enfermarse. La ansiedad es el principal desencadenante para fumar. Ella refiere que no desea dejar de fumar. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Vareniclina
- b) Bupropión oral
- c) Parches de nicotina
- d) Tratar la ansiedad
- e) Entrevista motivacional

126) Un hombre de 30 años, con rinorrea frecuente, se realiza prueba cutánea (prick test), que muestra reacción de 5mm a pólenes y de 0 mm al control histamina. ¿Cuál es la interpretación más adecuada de esta prueba?

- a) Es alérgico
- b) Está sensibilizado a pólenes
- c) Tiene rinitis vasomotora
- d) Tiene sinusitis crónica
- e) Anergia cutánea

127) Un lactante de 1 año de presenta un ataque súbito de tos, sofocamiento y dificultad respiratoria. Al examen presenta sibilancias y disminución del murmullo pulmonar, con FR: 34x'. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumotórax
- b) Laringitis aguda
- c) Bronquitis obstructiva
- d) Cuerpo extraño bronquial
- e) Angioedema

128) Un paciente de 28 años presenta ánimo bajo e irritable, desde hace 2 meses, fecha en que murió su hermano. Se siente ansioso e intranquilo, sin cambios en el peso. Los síntomas interfieren moderadamente con sus actividades laborales. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de estrés agudo
- b) Trastorno de adaptación
- c) Episodio depresivo mayor
- d) Trastorno de ansiedad generalizada
- e) Distimia

129) Una mujer de 34 años se siente muy ansiosa al realizar actividades como hacer presentaciones o hablar en reuniones de trabajo. Por ello evita ese tipo de situaciones y asigna dichas tareas a sus subalternos, sobrecargándolos. Incluso dejó de asistir a un congreso de ejecutivos, en el que tendría que exponer. El diagnóstico más probable es:

- a) Fobia social
- b) Trastorno de ansiedad generalizada
- c) Trastorno de personalidad antisocial
- d) Trastorno de personalidad evitativo
- e) Trastorno de pánico

130) Una paciente de 70 años acude por cuadro clínico de doce horas de evolución caracterizada por dolor en hemiabdomen inferior, que ha ido en aumento, siendo mayor en el hemiabdomen izquierdo. Al examen físico, presenta frecuencia cardíaca de 96 lpm, PA: 90/60 mmHg, temperatura 38,5 grados, sudoración y palidez, y examen abdominal con abdomen doloroso a la palpación, con Blumberg (+) y signos de irritación peritoneal en la fosa iliaca izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Diverticulitis aguda
- b) Cáncer colorectal complicado
- c) Vólvulo sigmoideo
- d) Obstrucción intestinal
- e) Cáncer de ovario complicado

131) Mujer de 85 años tiene el diagnóstico de incontinencia urinaria de urgencia. Su examen ginecológico es normal, y trae un examen de orina, que resulta normal. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el mas indicado para el manejo de esta paciente?

- a) Amitriptilina
- b) Imipramina
- c) Oxibutinina
- d) Tolterodina
- e) Trazodona

132) Una paciente de 54 años ha presentado dolores simétricos en pequeñas y grandes articulaciones, con compromiso de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, que iniciaron hace un año, y que se asocian a rigidez matinal de más de una hora y a sensación de arenilla y sequedad ocular. Se solicitan exámenes que muestran PCR: 10, factor reumatoideo: negativo, anticuerpos antinucleares: negativo y anticuerpos anti-CCP negativos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Artritis reumatoidea
- b) Artritis reactiva
- c) Artrosis
- d) Artritis psoriática.
- e) Síndrome de Sjörgren primario

133) Una mujer de 34 años, cursando un embarazo de 24 semanas, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, con 75 gramos de glucosa, que resulta 205 a las 2 horas. Además de dieta y ejercicio, el tratamiento de elección es:

- a) Acarbosa
- b) Sitagliptina
- c) Metformina
- d) Insulina
- e) Glibenclamida

134) Una mujer de 55 años se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 4, con microcalcificaciones agrupadas. ¿Cuál es la conducta mas adecuada?

- a) Ecotmografía mamaria
- b) Biopsia estereotáctica.
- c) Resonancia magnética
- d) Control mamográfico en 6 meses
- e) mastectomía parcial

135) Niño de 8 meses que sufre desde hace 6 meses diarrea pastosa, abundante. Tiene también antecedente de episodios bronquiales obstructivos y 4 cuadros de infecciones respiratorias, que han requerido de hospitalización.

Cuál es el diagnóstico de sospecha?

- a) Enfermedad celiaca
- b) Enteropatía perdedora de proteínas
- c) Enfermedad de cilio inmóvil
- d) Fibrosis quística
- e) Alergia a la proteína de la leche de vaca

136) Un paciente de 64 años consulta por astenia y mialgias de 3 meses de evolución. Se solicita TSH, que resulta 5,6 UI/L y T4 libre, que resulta 1,2 ug/ml (Valor Normal: 0,95 a 1,75 ug/ml). La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía cervical
- b) Iniciar levotiroxina
- c) Solicitar TSH y T4 libre en 3 meses
- d) Indicar punción tiroidea
- e) Solicitar cintigrafía tiroidea

137) Una paciente de 23 años, cursando un embarazo de 7 semanas, presenta un cuadro de disuria y polaquiuria, por lo que se realiza un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli sensible, con más de 100.000 UFC. El tratamiento más adecuado es:

- a) Cotrimoxazol
- b) Flucloxacilina
- c) Nitrofurantoína
- d) Levofloxacino
- e) Ciprofloxacino

138) Una paciente de 78 años, diabética e hipertensa, es hospitalizada por una pielonefritis aguda. Estaba en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida y metformina. Durante el día está tranquila, pero en la noche se agita y dice que la tienen secuestrada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Indicar benzodiacepinas en la noche
- b) Indicar haloperidol oral
- c) Agregar glibenclamida al tratamiento
- d) Disminuir la dosis de metformina
- e) Administrar suero fisiológico

139) Un paciente de 60 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y tos, asociada a expectoración mucopurulenta. Evoluciona con dificultad respiratoria, por lo que es llevado al servicio de urgencia. Al examen físico tiene FC: 113x', PA: 100/60 mmHg, FR: 33x' y al examen pulmonar presenta crepitaciones inspiratorias, en el hemicampo pulmonar derecho. La radiografía de tórax muestra condensación en los lóbulos medio e inferior derecho y satura 83%, con FiO2 ambiental, que sube a 90%, con oxígeno al 40%, por mascarilla de recirculación. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección para este paciente?

- a) Cefepime más amikacina
- b) Ceftriaxona más clindamicina
- c) Cloxacilina más metronidazol
- d) Cefotaximo más moxifloxacino
- e) Piperacilina más tazobactam

140) Puérpera de 15 días, inicia disnea y tos, asociada a expectoración, hemoptoica. Al examen pulmonar tiene murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos y satura 90% a FiO2 ambiental. El diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Neumonía adquirida en la comunidad
- c) Neumonía intrahospitalaria
- d) Tuberculosis pulmonar
- e) VIH

141) Un hombre de 48 años, diagnosticado de esquizofrenia, presenta episodio agitación, por lo cual se aumenta la dosis de haloperidol de 10 a 20 mg al día, evolucionando con malestar general, dificultad para la marcha y disminución del nivel de conciencia. Al examen físico, tiene FC: 100x', PA: 140/90 mmHg, temperatura 38 grados Celsius y rigidez de las extremidades. Se solicitan exámenes, en los que destaca leucocitosis de 19.000 blancos por mm3 y CPK de 1200 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Disonía
- b) Síndrome neuroléptico maligno
- c) Síndrome anticolinérgico
- d) Síndrome adrenérgico
- e) Distrofia muscular de Duchenne

142) En la vigilancia de las enfermedades transmisibles, ¿cuál es el parámetro que se utiliza para definir si la notificación de los casos de dicha enfermedad es de tipo diaria o inmediata?

- a) Periodo de incubación
- b) Oportunidad de control y prevención
- c) Letalidad y prevalencia
- d) Número de casos
- e) Disponibilidad de vacuna

143) Una mujer de 26 años, presenta un cuadro de 5 días de rinorrea, que a los dos días se vuelve mucopurulenta, agregándose odinofagia, y congestión nasal. Al examen físico se aprecia rinorrea, asociada a eritema y congestión faríngea. Se solicita una radiografía de senos paranasales que muestra velamiento de ambos senos maxilares. El tratamiento más adecuado es:

- a) Amoxicilina oral
- b) Amoxicilina más ácido clavulánico oral
- c) Corticoide tópico
- d) Descongestionantes tópicos
- e) Antihistamínicos orales

144) Una adolescente de 15 años presenta lesiones en ambas orejas, que se extienden hasta el cuello. Tiene antecedente de hacerse piercings, hace una semana. Al examen físico se observa la siguiente imagen:



El diagnóstico más probable es:

- a) Celulitis
- b) Erisipela
- c) Dermatitis de contacto alérgica
- d) Dermatitis de contacto irritativa
- e) Piodermitis superficial

145) Una paciente de sexo femenino de 17 años de edad, con antecedente de relaciones sexuales sin protección, consulta prurito vulvar, asociado a ardor progresivo. Refiere sensación de aumento del volumen de la vulva, que luego fue seguido por los síntomas actuales. Al examen físico se observa lo expuesto en la siguiente imagen.



Se trata de una infección por:

- a) Treponema pallidum
- b) Virus herpes simplex
- c) Chlamydia trachomatis
- d) Virus papiloma humano
- e) Ureaplasma urealyticum

146) Un niño de edad escolar presenta aparición de petequias y equimosis en el dorso y en las extremidades, con epistaxis y gingivorragia, que comenzaron hace 4 días. Se solicita un hemograma, que demuestra hematocrito de 35%, con hemoglobina de 11,8 g/dl, blancos: 9.000 por mm³, con fórmula diferencial normal y plaquetas: 18.000 por mm³. Además presenta INR: 1,1 y protrombinemia de 80%. El diagnóstico más probable es:

- a) Púrpura de Schönlein Henoch
- b) Púrpura trombocitopénico inmune
- c) Leucemia aguda
- d) Meningococcemia
- e) Hemofilia

147) Una paciente de 78 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con hidroclorotiazida, presenta un cuadro de diarrea y vómitos, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está en sopor profundo, con PA: 80/50 y frecuencia cardiaca de 120x', regular, con sequedad de mucosas. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran natremia: 156. mEq/L, cloremia: 114 mEq/L, potasemia: 3,1 mEq/L, pH: 7,40, bicarbonato: 14 mmol/L, CO₂: 20 mmHg. ¿Cuál de los siguientes fluidos se debe administrar en primer lugar?

- a) Suero glucosado al 5% ev
- b) Suero fisiológico al 0,9% ev
- c) Solución de bicarbonato al 2/3 molar ev
- d) Agua por sonda nasogástrica
- e) Sales de rehidratación oral

148) Una paciente de 42 años se realiza un histerectomía radical, por un cáncer de cuello uterino. Evoluciona con bochornos, cefalea y dispareunia profunda, por resequedad vaginal. Al examen físico tiene sobrepeso y presión arterial normal. Además trae exámenes en los que destaca Colesterol total: 204 mg/dl, Colesterol HDL: 54 mg/dl, Triglicéridos: 405 mg/dl. ¿Qué tratamiento es el más adecuado?

- a) Estrógenos más progestágenos orales
- b) Estrógenos orales
- c) Estrógenos en parches
- d) Progestágenos endovaginales
- e) Sertralina

149) Una paciente de 25 años, con atraso menstrual de 3 semanas, consulta por dolor abdominal de 5 días de evolución, que ha ido en aumento. Al examen físico presenta abdomen doloroso a la palpación abdominal baja, mayor en la fosa iliaca izquierda, sin signos peritoneales. Además se realiza una HCG, que resulta 5.500 UI/L y se solicita una Ecografía Transvaginal, que visualiza útero sin gestación intrauterina, con endometrio de 15 mm, y un tumor anexial izquierdo de 53 mm de diámetro, de aspecto complejo, sin líquido libre. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar laparoscopia exploradora
- b) Realizar laparotomía exploradora
- c) Indicar metotrexato
- d) Solicitar ecografía en 7 días
- e) Solicitar niveles de HCG y ecografía en 48 horas

150) Una paciente de 46 años, nulípara, sin método anticonceptivo, presenta una metrorragia, que es manejada con legrado uterino. La biopsia demuestra presencia de hiperplasia endometrial atípica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Repetir el legrado en 3 meses
- b) Implantar DIU medicado con progestágenos
- c) Realizar histerectomía total
- d) Indicar progestágenos cíclicos
- e) Indicar progestágenos continuos

151) Un niño de 5 meses de edad presenta un cuadro de rinorrea y tos, que va en aumento, hasta presentar accesos de tos y dificultar la alimentación. Al examen físico está en buenas condiciones generales, afebril y sin alteraciones en el examen cardiopulmonar. Se solicita un hemograma, que muestra leucocitosis de 17.000, con 78% de linfocitos y 22% de neutrófilos. La PCR y VHS están levemente elevadas. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un patrón intersticial leve. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumonía atípica
- b) Infección por virus influenza
- c) Infección por adenovirus
- d) Coqueluche
- e) Bronquiolitis aguda

152) Un paciente de 42 años, fumador de 2,6 paquetes-año, presenta un cuadro de 3 meses de compromiso del estado general, astenia y baja de peso de 3 kilogramos, asociado a tos y expectoración mucopurulenta, que en ocasiones es hemoptoica. Su examen físico no aporta mayor información. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra zonas de relleno alveolar en el lóbulo superior derecho. ¿Con qué examen(es) se debe proseguir el estudio?

- a) Baciloscopías de expectoración y cultivo para mycobacterias
- b) Elisa VIH
- c) Biopsia pulmonar por videtoracoscopia
- d) Lavado bronquioalveolar por broncoscopia
- e) TAC de tórax

153) Un paciente de 64 años, con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y tabaquismo, presenta pérdida de la visión del ojo izquierdo, con instalación súbita. Al examen, es capaz de distinguir la luz de la sombra y contar dedos y destaca defecto pupilar aferente relativo. El diagnóstico más probable es:

- a) Glaucoma agudo
- b) Glaucoma crónico terminal
- c) Neuritis óptica
- d) Neuropatía óptica isquémica
- e) Desprendimiento de retina

154) Paciente femenina, de 17 años presenta astenia, decaimiento, dolores óseos y pérdida de peso, de 2 meses evolución. Al examen físico se constatan múltiples adenopatías cervicales y axilares, con bazo palpable 3 cm debajo del reborde costal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Linfoma de Hodgkin
- b) Leucemia mieloide aguda
- c) Leucemia linfática aguda
- d) Síndrome mononucleósico
- e) Leucemia linfática crónica

155) Un paciente de 66 años, fumador de 40 paquetes-año presenta tos con expectoración mucosa, de 4 años de evolución. Tiene broncorrea, mayor en la mañana y presenta 2 infecciones respiratorias al año, que requieren de antibióticos. Su radiografía de tórax y espirometría son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cáncer de pulmón
- b) Tuberculosis pulmonar
- c) Fibrosis pulmonar
- d) EPOC
- e) Bronquitis crónica

156) Un paciente de 64 años, con antecedente de haber sido tratado por un mieloma, con buena respuesta, consulta ahora por cuadro de astenia, con constipación y aumento del volumen urinario, a lo que luego se le agrega desorientación. Al examen físico se aprecia soporoso, pálido. En sus exámenes presenta hematocrito 27%, con Hb: 9 g/dl, VHS: 93 mm/h, proteínas plasmáticas: 7,8 g/dl, albúmina: 3,7 g/dl, sodio: 140 mEq/L, potasio: 4,8 mEq/L, calcio: 14,3 mg/dl. En este momento debe recibir:

- a) Calcitonina
- b) Solución salina al 0,9%
- c) Vitamina D
- d) Bifosfonatos
- e) Corticoides

157) Mujer de 88 años de edad, quien presenta clínica un día de evolución caracterizada por fiebre, diarrea y dolor en hipogastrio. Refiere evacuaciones sin otras alteraciones. Al examen físico presenta temperatura en 38,5 grados, presión arterial de 90/50 mmHg y al examen abdominal presenta dolor y sensibilidad a la palpación en fosa ilíaca izquierda, sin signos de irritación peritoneal. El diagnóstico más probable es:

- a) Diverticulitis aguda
- b) Colitis isquémica
- c) Pielonefritis aguda
- d) Enfermedad inflamatoria intestinal
- e) Rectocolitis bacteriana

158) Mujer asintomática de 46 años de edad, con IMC de 24. Tiene antecedente de diabetes gestacional con su último embarazo. Se practica una glicemia en ayunas que resulta en 112 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Repetir la glicemia en ayunas
- b) Practicar niveles de hemoglobina glicosilada
- c) Indicar metformina
- d) Realizar control de glicemia en 6 meses
- e) Solicitar curva de tolerancia a la glucosa

159) Paciente femenina, fumadora de 30 paquetes/año, presenta hematuria, con abundante coágulos de sangre. No presenta dolor, fiebre, ni otros síntomas. Se solicita un sedimento de orina, que muestra abundantes eritrocitos, sin bacterias. El diagnóstico más probable es:

- a) Cistitis hemorrágica
- b) Cáncer de vejiga
- c) Cáncer renal.
- d) Tuberculosis renal
- e) Infección urinaria

160) Una mujer de 86 años, con múltiples patologías crónicas, en tratamiento farmacológico, acude a control, constatándose IMC: 23, frecuencia cardíaca: 76 lpm, presión arterial: 110/70 mmHg. Además trae exámenes, que muestran TSH: 2,65 UI/L, LDH: 152 UI/L, hemoglobina glicosilada: 5,2%, colesterol HDL: 35 mg/dl, colesterol total: 205 mg/dl. ¿Qué fármaco debería suspenderse?

- a) Losartán
- b) Atorvastatina
- c) Levotiroxina
- d) Carvedilol
- e) Glibenclamida

161) Paciente masculino, de 71 años de edad, con un cuadro de 2 años de evolución de temblor de ambas extremidades superiores, lo cual le sucede al escribir, tomar un objeto, o al usar cubiertos. Toma alprazolam 0,5 mg/dl, dos veces por día por cuadro ansioso. Al examen físico no tiene temblor de reposo y se observan reflejos osteotendíneos conservados, con tono muscular y sensibilidad normal. El temblor se acentúa al tratar de tomar un objeto. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertiroidismo
- b) Enfermedad de Parkinson
- c) Temblor esencial
- d) Temblor por ansiedad
- e) Temblor por medicamentos

162) Un niño de 24 meses ha presentado 3 episodios de llanto de breve duración, seguido de apnea y luego pérdida de conciencia, recuperándose al poco tiempo. Al examen físico no tiene alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Instruir a los padres en reanimación cardiopulmonar
- b) Solicitar TAC de cerebro
- c) Educar a los padres en el manejo de las emociones del niño
- d) Solicitar electroencefalograma
- e) Indicar monitor cardíaco

163) ¿Cuál es el diagnóstico que se visualiza en el siguiente electrocardiograma?



- a) Bloqueo AV completo
- b) Fibrilación auricular lenta
- c) Bloqueo AV de 2do grado
- d) Bradicardia sinusal
- e) Paro sinusal

164) Paciente de 17 años presenta un cuadro de fiebre, malestar general y odinofagia, de 7 días de evolución. Al examen, presenta lesiones blanquecinas en las amígdalas y congestión de la orofaringe, adenopatías cervicales y se palpa el bazo moderadamente aumentado de tamaño. ¿Cuál es el agente causal más probable?

- a) Adenovirus
- b) Virus influenza
- c) Virus de Epstein Barr
- d) Citomegalovirus
- e) Streptococo A

165) Una paciente se realiza un PAP, que es informado como probable lesión de bajo grado y presencia de virus papiloma humano. ¿Cuál es la conducta mas adecuada?

- a) Vacunar contra virus papiloma humano
- b) Realizar colposcopia y biopsia
- c) Repetir el PAP en 6 meses
- d) Realizar hibridación para serotipos oncogénicos de virus papiloma
- e) Realizar PAP en fase líquida en 1 a 3 meses

166) paciente de 28 años de edad, con 34 semanas de gestación consulta por metrorragia moderada. Al examen físico tiene presión arterial: 130/70 mmHG y FC: 107x', útero doloroso e hipertónico y metrorragia escasa en la especuloscopia. Se realiza ecografía obstétrica que resulta normal, con placenta posterior, sin signos de desprendimiento. El doppler materno-fetal resulta normal y el cuello tiene 30 mm de longitud. La conducta mas adecuada con la paciente es:

- a) Administrar nifedipino
- b) Inducción de parto
- c) Repetir el doppler fetal en 7 días
- d) Realizar rotura de membranas
- e) Realizar cesárea

167) Paciente de 36 años con fiebre y la presencia de una lesión en miembro inferior, en forma de una placa de eritematosa, con bordes definidos de aproximadamente 15 x 8 cm, que responde bien al tratamiento con cloxacilina. Al quinto día comienza con náuseas, vómitos, diuresis adecuada, con leucocitosis de 15.000 por mm³, con 10% de eosinófilos, 40% de neutrófilos y 48% de linfocitos, uremia en 50 mg/dl, creatinina en 3 mg/dl, hematuria microscópica, leucocituria, y proteinuria de 0,8 g/día. Identificar el posible diagnóstico:

- a) Glomerulonefritis post estreptocócica
- b) Vasculitis de vasos pequeños
- c) Injuria renal pre renal
- d) Endocarditis infecciosa
- e) Nefritis intersticial

168) Un paciente de 80 años, hipertenso en tratamiento hace 10 años, consulta por disnea de esfuerzos, que inició hace 6 meses. Al examen físico destaca PA 150/90, ritmo regular, con ausencia del segundo ruido, asociado a soplo mesosistólico III/VI en margen esternal izquierdo, pulso carotídeo de ascenso lento y choque punta en el quinto espacio intercostal izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis mitral
- b) Estenosis aórtica
- c) Insuficiencia aórtica
- d) Insuficiencia mitral
- e) Miocardiopatía dilatada

169) Una mujer de 34 años, con amenorrea de 6 meses, presenta un cuadro de astenia y malestar general. Además refiere equimosis ante mínimos traumatismos. Actualmente tiene PA: 150/90 mmHg, acné facial, cuello ancho, obesidad centrípeta y estrías violáceas. Tiene prueba de embarazo negativa. ¿Cuál es la prueba a realizar en primer lugar?

- a) Cortisol plasmático basal
- b) FSH y estradiol plasmático
- c) Cortisol libre urinario
- d) Prueba de estimulación con ACTH
- e) Resonancia magnética de silla turca

170) Paciente de 45 años presenta paresia facial bilateral de instalación progresiva, en 2 semanas, a lo que luego se agrega parálisis del sexto par craneal. Al examen físico, el tono muscular está disminuido de forma simétrica en las cuatro extremidades, con reflejos osteotendinosos abolidos. El diagnóstico más probable es:

- a) Accidente vascular tronco encefálico
- b) Miastenia gravis
- c) Sd. de Guillain Barre
- d) Botulismo
- e) Hemorragia intracraneana

171) Un paciente de 32 años consulta por un cuadro de disfunción sexual asociado a disminución del vello facial. Al examen físico presenta disminución del vello corporal y disminución del tamaño testicular bilateral. ¿Cuál es el estudio más adecuado para proseguir el enfrentamiento de este paciente?

- a) Prolactina
- b) Testosterona y LH
- c) Espermiograma y FSH
- d) Ecografía testicular
- e) HCG y estradiol

172) Un paciente masculino, de 22 años, desde hace más de 6 meses ha dejado de compartir con su familia y casi no sale de su pieza. Además, ha descuidando su aspecto personal. Sus familiares refieren que en ocasiones lo escuchan musitar, hablar y reírse solo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Esquizofrenia
- b) Depresión psicótica
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Trastorno de personalidad esquizoide
- e) Trastorno bipolar

173) Paciente femenina con artritis reumatoide, en tratamiento con metotrexate y prednisona desde hace 4 años, es diagnosticada de diabetes mellitus, por lo que se inicia metformina como tratamiento. ¿Que examen es perentorio realizarle, como seguimiento a esta paciente?

- a) Hemograma, con recuento de plaquetas
- b) Radiografía atlantoaxoidea
- c) Insulinemia
- d) LDH
- e) Densitometría ósea

174) Una paciente de 54 años, se realiza exámenes como parte de chequeo médico, que muestran SGOT: 43 UI/L, SGPT: 70 UI/L, GGT: 433 UI/L, FA: 531 UI/L, bilirrubina total: 3,0 mg/dl, albúmina: 3,7 g/dl y protrombinemia: 88%. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?

- a) Colestasia por esteatosis hepática
- b) Cirrosis biliar primaria
- c) Colestasia por compresión externa
- d) Colangitis esclerosante primaria
- e) Colangitis esclerosante secundaria

175) Una mujer de 65 años, nulípara, con IMC de 33, sin síntomas, se realiza un PAP que muestra abundantes células endometriales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Controlar con nuevo PAP en un año
- b) Indicar estrógenos tópicos
- c) Solicitar colposcopia y biopsia
- d) Realizar curejate endocervical
- e) Solicitar ecografía transvaginal

176) Una paciente de 43 años, multípara de 3, con antecedente de oligomenorrea, presenta metrorragia abundante, por lo que se realiza una ecografía transvaginal, que muestra endometrio engrosado, por lo que se realiza una biopsia endometrial por técnica de Pipelle, que demuestra presencia de hiperplasia endometrial compleja, con células atípicas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar anticonceptivos combinados orales
- b) Indicar progestágenos orales en altas dosis
- c) Realizar histerectomía total
- d) Repetir el legrado
- e) Indicar estrógenos orales en altas dosis

177) Un recién nacido de 36 semanas de edad gestacional, nacido por cesárea, presenta dificultad respiratoria, luego de nacer, con taquipnea, retracción subcostal y crepitantes basales. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra ambos campos pulmonares con hiperinsuflación, reforzamiento hiliar, aplanamiento del diafragma y silueta cardiaca normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumomediastino
- b) Neumonía congénita
- c) Taquipnea transitoria
- d) Enfermedad de membrana hialina
- e) Cardiopatía congénita

178) Niño de 12 años, obeso, refiere dolor de 3 meses en cadera izquierda y claudicación progresiva, que actualmente impide la marcha. Al examen físico presenta dolor a la rotación interna y externa de la cadera izquierda. Se realiza radiografía AP pelvis y caderas, que se muestra a continuación:



El diagnóstico es:

- a) Displasia del desarrollo de la cadera
- b) Epifisiolisis
- c) Fractura del cuello del fémur
- d) Luxación de la Cadera izquierda
- e) Necrosis avascular de la cabeza del fémur

179) Mujer de 54 años, con antecedente de síndrome de intestino irritable, que presenta un cuadro de astenia, debilidad de las extremidades superiores y mialgias. Además refiere sequedad ocular y cefalea. Al examen físico presenta movilidad articular normal, sin alteraciones de la sensibilidad, ni paresias evidentes. Presenta dolor a la presión de ambos epicóndilos y a la palpación de los músculos de la espalda. En sus exámenes presenta hemograma normal, con anticuerpos antinucleares positivos, en titulación 1/40, con factor reumatoide negativo y anticuerpos contra antígenos nucleares extractables negativos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar hidrocortisona endovenosa y reevaluar en una semana
- b) Indicar pregabalina y ejercicios suaves de elongación
- c) Iniciar prednisona oral
- d) Solicitar biopsia de glándula salival secundaria
- e) Iniciar metotrexato y antiinflamatorios no esteroidales

180) Mujer de 51 años consulta por metrorragia moderada de 10 días de evolución. Su última menstruación fue hace 6 meses. ¿Cuál es la causa mas probable de su hemorragia?

- a) Atrofia vaginal
- b) Hiperplasia endometrial
- c) Cáncer de endometrio
- d) Cáncer cervicouterino
- e) Metrorragia disfuncional

FIN DEL EXAMEN

La pauta de esta prueba estará disponible en el siguiente enlace:

<http://pruebas.drguevara.cl/pauta-julio-2016>

NOMBRE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

APELLIDO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

APELLIDO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RUT o número P

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

91	A	B	C	D	E	109	A	B	C	D	E	127	A	B	C	D	E	145	A	B	C	D	E	163	A	B	C	D	E
92	A	B	C	D	E	110	A	B	C	D	E	128	A	B	C	D	E	146	A	B	C	D	E	164	A	B	C	D	E
93	A	B	C	D	E	111	A	B	C	D	E	129	A	B	C	D	E	147	A	B	C	D	E	165	A	B	C	D	E
94	A	B	C	D	E	112	A	B	C	D	E	130	A	B	C	D	E	148	A	B	C	D	E	166	A	B	C	D	E
95	A	B	C	D	E	113	A	B	C	D	E	131	A	B	C	D	E	149	A	B	C	D	E	167	A	B	C	D	E
96	A	B	C	D	E	114	A	B	C	D	E	132	A	B	C	D	E	150	A	B	C	D	E	168	A	B	C	D	E
97	A	B	C	D	E	115	A	B	C	D	E	133	A	B	C	D	E	151	A	B	C	D	E	169	A	B	C	D	E
98	A	B	C	D	E	116	A	B	C	D	E	134	A	B	C	D	E	152	A	B	C	D	E	170	A	B	C	D	E
99	A	B	C	D	E	117	A	B	C	D	E	135	A	B	C	D	E	153	A	B	C	D	E	171	A	B	C	D	E
100	A	B	C	D	E	118	A	B	C	D	E	136	A	B	C	D	E	154	A	B	C	D	E	172	A	B	C	D	E
101	A	B	C	D	E	119	A	B	C	D	E	137	A	B	C	D	E	155	A	B	C	D	E	173	A	B	C	D	E
102	A	B	C	D	E	120	A	B	C	D	E	138	A	B	C	D	E	156	A	B	C	D	E	174	A	B	C	D	E
103	A	B	C	D	E	121	A	B	C	D	E	139	A	B	C	D	E	157	A	B	C	D	E	175	A	B	C	D	E
104	A	B	C	D	E	122	A	B	C	D	E	140	A	B	C	D	E	158	A	B	C	D	E	176	A	B	C	D	E
105	A	B	C	D	E	123	A	B	C	D	E	141	A	B	C	D	E	159	A	B	C	D	E	177	A	B	C	D	E
106	A	B	C	D	E	124	A	B	C	D	E	142	A	B	C	D	E	160	A	B	C	D	E	178	A	B	C	D	E
107	A	B	C	D	E	125	A	B	C	D	E	143	A	B	C	D	E	161	A	B	C	D	E	179	A	B	C	D	E
108	A	B	C	D	E	126	A	B	C	D	E	144	A	B	C	D	E	162	A	B	C	D	E	180	A	B	C	D	E



PAUTA PRUEBA DIAGNÓSTICA (Eunacom julio 2016)

PARTE 1

1) A. El EPOC contraindica los betabloqueadores, como el atenolol. En cambio los beta-agonistas (como el salbutamol) son parte del tratamiento del EPOC. Lo mismo aplica al asma.

2) D. Es normal que esté en amenorrea si sigue dando lactancia y está con medroxiprogesterona (recordar que los anticonceptivos orales de elección en la lactancia son los progestágenos solos). Si bien su sensibilidad es algo más baja, por regla general, un test de embarazo negativo en orina, es suficiente para descartar el embarazo.

3) A. Ante la sospecha de embarazo ectópico, se debe pedir HCG. Si es menor a 1.500 U/L, puede ser un embarazo normal, pero de menor edad gestacional y se debe esperar 48 horas y repetir la HCG. Si la HCG es mayor a 1.500 U/L, se confirma el diagnóstico (aunque en las recomendaciones norteamericanas más recientes, se sugiere esperar a que sea mayor a 3.500, o bien a que no suba al menos un 66% en 48 horas, antes de dar el metotrexato) y se procede al tratamiento con metotrexato o cirugía.

4) D. En estricto rigor, es una mala pregunta, ya que puede ser cualquiera de los tipos de linfoma (adenopatías, síntomas B). Sin embargo, los síntomas B (sudoración, fiebre y baja de peso) y la edad orientan más a linfoma Hodgkin (clásico de adolescentes y adultos jóvenes) La palidez y otros signos de anemia son más frecuentes en las leucemias, pero el resto de la clínica sugiere linfoma.

5) D. Tanto la clínica (amaurosis más defecto pupilar aferente o escape pupilar), como la esclerosis múltiple, orientan a Neuritis óptica. La causa más frecuente es autoinmune.

6) D. Es una coledocolitiasis residual (hasta 2 años después de la colecistectomía; luego de ese tiempo, se llama coledocolitiasis recurrente). La coledocolitiasis se estudia actualmente, de manera preferente con la colangiografía, ya que permite identificar de manera no invasiva los cálculos que se pueden extraer con la CPRE y los que requieren cirugía (ej. localización muy alta). El orden en que se estudia es el siguiente: 1. La ecografía abdominal es el examen de primera línea y puede mostrar dilatación de la vía biliar (mayor a 7 mm), 2. La colangiografía es el examen de elección para confirmar el diagnóstico y se pide después de la Eco y 3. La CPRE es el examen diagnóstico terapéutico, que solo se pide I. si hay clínica de colangitis o II. si la colangiografía ve los cálculos en el colédoco, aunque también se pide III. si la Eco misma ve los cálculos y no solo signos indirectos, como la dilatación (en este caso no se pide la colangiografía).



7) D. Es un absceso mamario, que se debe drenar en pabellón. Además, se deben dar antibióticos (cloxacilina o cefazolina). En cambio, el flegmón mamario y las mastitis no abscedadas, solo se tratan con antibióticos.

8) C. Es un delirium clásico (alteración de la atención, compromiso de conciencia de inicio agudo, desorientación y agitación; suele tener un curso fluctuante y empeorar al atardecer y en la noche). También se llama síndrome confusional agudo.

9) E. Si bien los AINES son el tratamiento de segunda línea (paracetamol es de primera), en los pacientes hipertensos (mal controlados) y con insuficiencia cardíaca suelen estar contraindicados (por el riesgo de insuficiencia renal aguda), por lo que creo que la respuesta es tramadol (aunque habitualmente es de tercera línea). Aun así es una pregunta difícil, ya que no se es tan explícito en la contraindicación (otras contraindicaciones son úlcera por AINES y la IRC).

10) C. En la imagen se veía la disyunción acromioclavicular o luxación acromioclavicular, con leve desplazamiento hacia superior del extremo distal de la clavícula. La sola clínica, en este caso, no permite diferenciarlo. Sin embargo, es característico de la luxación anterior de hombro el signo de la charretera y, de la disyunción, el signo de la tecla de piano.

11) A. Es una pregunta capciosa, con redacción insuficiente. Las atelectasias son la primera causa de fiebre postoperatoria (en especial en las primeras 48 horas) y además la hipoventilación basal la sugiere. Sin embargo, no necesariamente está infectada. Además, el cuadro también podría calzar con un TEP, por el tiempo de evolución y por la taquicardia, aunque falta información (ej. inicio súbito, desaturación arterial, etc.). Además, siempre que se pregunta algo así, lo importante es descartar el TEP, el que se pregunta siempre y de manera muy inespecífica: "paciente con antecedente de un factor de riesgo de TEP, que le pasa cualquier cosa compatible con un TEP". La única razón por la cual se elige la atelectasia es porque preguntan dirigidamente por la causa de fiebre.

12) D. Lo más correcto es simplemente observar evolución, porque es una dermatitis seborreica del lactante. Sin embargo, también se le puede aplicar vaselina o aceite mineral, para ayudar a remover la descamación. En los adultos, por ser por un hongo (*Pitirosporum ovale*), sí se suelen usar los antimicóticos tópicos, e incluso los corticoides tópicos como segunda línea, pero en los niños, se prefiere o no hacer nada o aplicar vaselina.

13) A. Solo se puede calcular la incidencia con esa información (incidencia a 20 años = $65 / 2.000 = 3,25\%$). Si se tuvieran los datos en los no fumadores, además podría calcularse el riesgo relativo.

14) E. Tanto por ser menor de 55 años, como especialmente por ser diabética, el antihipertensivo de elección son los IECAs (enalapril).



15) B. Las balanopostitis candidiásicas se asocian a diabetes. También las candidiasis genitales femeninas.

16) C. La RPO o RPM (rotura prematura de ovular o de membranas) mayor a 34 semanas se induce de inmediato, si no hay contraindicación del parto vaginal (en ese caso, se haría cesárea). Las menores a 34 semanas, se mantienen con una conducta expectante, bajo antibióticos y corticoides. La alfamicroglobulina placentaria es el examen con mejor rendimiento para confirmar el diagnóstico, ante la duda clínica.

17) E. La erupción dentaria puede observarse hasta los 15 meses. A esa edad recién se piden las radiografías. Nota: la típica pregunta de pediatría: "un niño tiene una alteración rara que nunca has escuchado en tu vida, pero todo lo demás está estrictamente normal. La conducta es:"... ¡¡¡Observar!!!

18) A. Es una inserción velamentosa cuyo manejo no debe realizar un médico general. Se asocia a rotura de vasa previa, al momento del parto, por lo que es correcto hacer cesárea (en el momento del parto o desde las 35 semanas), pero no ahora (a las 24 semanas), sino al término. Además, un porcentaje de los casos se resuelve a medida que avanza el embarazo, por lo que se debe confirmar con una nueva ecografía más adelante. La opción de observar evolución es correcta, pero en general da a entender que es algo completamente normal, en que no hay que hacer nada más, por lo que no la consideraremos correcta en esta pregunta.

19) A. Es una enfermedad celiaca clásica. Aunque no cumple criterios de talla baja (talla/edad < -2) ni de desnutrición (peso/talla >= -2), igual es alarmante que no haya subido de peso, como es esperable. Si hubiese tenido sintomatología respiratoria, sería fibrosis quística.

20) A. La dilatación bilateral, más la vejiga de lucha orienta a obstrucción uretral. La única opción era la de las valvas/válvulas uretrales, que son una malformación relativamente frecuente.

21) A. Es un fibroadenoma, que se estudia con ecografía. Además, las mamografías suelen ser poco útiles antes de los 40 años. Sin embargo, si la clínica no hubiese sido tan sugerente de fibroadenoma, sino de otras cosas (ejemplo nódulo mamario inespecífico o cáncer), el examen de elección sí sería la mamografía (se pide desde los 40 años, cada 1 a 2 años y se pide antes, si es que hay nódulos palpables). La ecografía, en cambio, es de elección es: 1. el embarazo, 2. mamografía Birrads 0, 3. clínica de fibroadenoma y 4. Clínica de quiste o mastopatía fibroquística.

22) A. Es un síndrome nefrótico clásico (orina espumosa, edema y proteinuria), aunque le faltan los exámenes confirmatorios (proteinuria cuantitativa o índice proteinuria / creatininuria, albumnemia y perfil lipídico). No hay hematuria dismórfica,



así que no puede ser una glomerulonefritis. No tiene insuficiencia renal, así que no puede ser ninguna de las otras opciones.

23) C. Es un síndrome de Steven Johnson clásico (rash pápulo-vesicular, con compromiso importante de mucosas, sin Nikolski). Las lesiones en tiro al blanco también se ven en el eritema multiforme menor, pero no suele afectar las mucosas.

24) A. Pregunta muy rara. La vigilancia activa de los acuíferos (aguas superficiales y aguas subterráneas) es lo más razonable, con toma de muestras y análisis periódicos de las aguas en cuestión, más análisis directo, en caso de reportarse casos sospechosos (por eso marcamos la vigilancia activa como respuesta). Pero la verdad es que, en Chile, las diarreas (incluyendo el cólera, por ejemplo), se vigilan mediante centros centinelas (hospitales o clínicas determinadas, que deben estudiar las etiologías y notificarlas a la Seremi de Salud). Sin embargo, dado que vigilancia activa y vigilancia pasiva son términos muy amplios, que abarcan todo lo demás, lo más probable es que quien redactó la pregunta apuntara a una de esas opciones.

25) A. Ante un nódulo tiroideo, lo primero es pedir TSH, luego la ecografía y luego la punción con aguja fina (si es mayor a 10 mm).

26) B. Lo primero frente a una fractura de pelvis, y frente a un politraumatizado en general, es hacer el ABC y en este caso, instalar vías venosas periféricas y aportar volumen. Luego, lo principal es reducir de manera externa la pelvis, de modo de evitar o al menos limitar las hemorragias pélvicas, lo que se puede hacer con un tutor externo y si no se tiene, son una férula neumática o por último con una sábana o hamaca pélvica (por eso elegimos esta respuesta, aunque la redacción no es la mejor). Una opción razonable era la cirugía de reducción, pero al preguntar la conducta inicial, parecería que la respuesta es otra. Respecto a la sonda Foley, es posible ponerla, pero la indicación es la retención urinaria y en la fractura de pelvis, hay riesgo de rotura uretral, lo que contraindica la Sonda Foley, hasta no haberla descartado con una uretrocistografía.

27) C. Es una rubeola clásica (exantema macular tenue y generalizado, con adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores). Por tener menos de 1 año, aún no recibe la trivírica.

28) B. El cálculo de la Sensibilidad y Especificidad es la clásica forma de determinar la utilidad de una prueba diagnóstica. Eso sí, también sirven las curvas de ROC, que justamente comparan sensibilidad vs. especificidad, de modo de identificar el valor de corte óptimo y comparar distintas pruebas diagnósticas. Sin embargo, las curvas de ROC solo sirven para test que miden variables cuantitativas y además requieren previamente de la determinación de la sensibilidad y la especificidad.

29) D. Pregunta difícil. Parece una infección por *Pneumocystis* en un paciente VIH, tan inmunosuprimido que no condensa la radiografía. El tiempo de evolución hace



imposible el ADV y la influenza (son agudos y de corta evolución). La tos es compatible con Bordetella, pero no la fiebre ni la disnea. Finalmente, no tiene clínica ni radiografía de TBC (falta expectoración, fiebre alta y RxTx alterada).

30) C. Es una presentación clásica de neuropatía compresiva del nervio radial. De hecho, la llaman la “parálisis del borracho”.

31) B. Lo primero en un paciente shockeado siempre es reponer la volemia y luego preocuparse de los electrolitos. La volemia se repone preferentemente con cristaloideos (suero fisiológico y Ringer lactato) y en este caso, por la severa hipokalemia es más recomendable el Ringer (aunque no ha demostrado ser mejor que el SF en ninguna situación). Además, no salía SF dentro de las alternativas. La única excepción (aunque sin evidencia que lo demuestre) es la deshidratación hiperosmolar, en que da miedo dar SF, por el riesgo de una mayor hipernatremia (ahí se da suero hipotónico al 0,45% o suero glucosalino: 0,45% NaCl + glucosa 2,5%, aunque insisto que no hay evidencia).

32) E. Es absolutamente normal. Como tiene desarrollo puberal, aún no se puede hablar de amenorrea primaria (se diagnostica a los 15 años si hay desarrollo puberal y se estudia con prueba de progesterona; en cambio, si no hay desarrollo puberal, se diagnostica a los 13 años y se estudia con muchas pruebas hormonales, ya que además hay un retraso puberal).

33) B. El cólico renal se estudia con PielotAC (TAC sin contraste). El UroTAC se utiliza como estudio de la hematuria, después de descartar TU, cuando se sospecha cáncer, ya que dibuja bien la vía urinaria.

34) B. Es la clínica clásica del retinoblastoma (leucocoria, proptosis y estrabismo). El glaucoma congénito se caracteriza por opacidad corneal, buftalmo (ojos grandes) y epifora.

35) C. Parecía que además tenía un T. de personalidad evitativo, pero en esta pregunta no estaba en las opciones. Además, que la ansiedad la genere el juicio de los demás, es lo clásico de la fobia social.

36) A. El bienestar fetal siempre es lo primero a evaluar en un traumatismo obstétrico o en cualquier patología aguda del embarazo, ya que podría determinar una cesárea de urgencia.

37) D. Todo VDRL positivo en el embarazo se debe tratar de inmediato, sin esperar la confirmación, aunque sí se confirma con FTA-abs posteriormente. Por ser alérgica a la penicilina, con reacción grave, están contraindicadas la penicilina y la ceftriaxona. La eritromicina y otros macrólidos es el tratamiento de elección de la sífilis en alérgicos y la eritromicina es el macrólido de elección en el embarazo. La recomendación norteamericana es, además, desensibilizar contra la penicilina y tratar con penicilina. Sin embargo, la recomendación del Minsal es eritromicina.



38) B. Es diabetes gestacional (DMG) por diagnosticarse durante el embarazo y por cumplir con el criterio de TTGO mayor o igual a 140 (es el corte en la DMG). No es pregestacional (DMPG), ya que esta se diagnostica antes del embarazo, o al inicio del embarazo, pero con 2 glicemias de ayuno mayores o iguales a 126 mg/dl o con una glicemia mayor o igual a 200 mg/dl más síntomas). Si se diagnostica en el segundo semestre, solo se puede hablar de DMG y no DMPG.

39) B. Por afectar el codo y por la fiebre alta, es séptica. La reactiva, habitualmente no es tan dolorosa, no tiene fiebre y está precedida por alguna infección (diarreas por lo general). La gotosa y la condrocalcinosis pueden ser muy dolorosas, pero es infrecuente la fiebre (igual pueden tener) y afecta generalmente otras articulaciones (primera metatarsal-falángica: gota y rodilla: condrocalcinosis).

40) E. Tiene una placenta previa sintomática, por lo que debe interrumpirse por cesárea. Si bien está en buenas condiciones, ya tiene más de 34 semanas, por lo que se interrumpe sin mayor riesgo de complicaciones por prematuridad.

41) C. Es una miocardiopatía hipertrófica clásica (síncope, antecedentes de muerte súbita en la familia, soplo eyectivo y clínica de insuficiencia cardíaca). Veremos en detalle toda la semiología cardíaca.

42) E. Es el aporte del empleador, que varía según el tipo de empresa, entre 0% y 3,4%. La salud general, en cambio, se financia con el aporte estatal (lo más importante en Fonasa), más el 7% de los trabajadores (tanto Fonasa como Isapres)

43) B. Tiene un herpes zóster. Sirven tanto el aciclovir, como el valaciclovir, pero solo la dosis del valaciclovir estaba bien, porque la de aciclovir, para herpes zóster es 800 mg cada 4 horas, por 5 a 7 días.

44) B. Es una aerofobia, que es la fobia específica a volar.

45) D. Es una bulimia, con los atracones característicos y además con la purga, por medio de ejercicios y ayuna (no solo se purga con vómitos o laxantes).

46) A. Es un TORCH clásico por CMV (microcefalia, calcificaciones cerebrales, ictericia y hepatoesplenomegalia). En Chile no hay Zika. El TORCH por toxoplasma es casi igual al del CMV, pero es más infrecuente y, además, puede cursar con hidrocefalia.

47) C. Es un endometrioma clásico, que también puede llamarse quiste endometriósico.

48) D. Es una NET clásica, con el signo de Kikolski (se desprende la epidermis), aunque no era la imagen más característica de la NET.



49) A. Es una pregunta algo capciosa, porque la clínica calza tanto con cáncer de esófago, como con cáncer gástrico cardial, ya que se trata de una disfagia lórica. Sin embargo, la correcta será cáncer de esófago, por ser la presentación clásica.

50) D. Es un cuadro sugerente de cáncer de colon (constipación y anemia en adulto mayor), que se estudia con colonoscopia.

51) C. Tanto la clínica (algia pélvica aguda intensa, con náuseas y vómitos), como la presencia de un tumor anexial (principal factor de riesgo), como el doppler alterado son muy sugerentes de torsión ovárica.

52) C. Es un probable cáncer con obstrucción de la vía biliar (colestasia silente), probable cáncer de páncreas, por ser fumador. Es una pregunta muy difícil, porque el examen de primera línea de la colestasia silente es la Ecografía abdominal, mientras que el examen de elección, para el cáncer de páncreas en específico, es el TAC abdominal con contraste. Finalmente, el mejor examen para ver las ictericias malignas en general es la colangiRMN y se suele pedir después de la Ecografía. Por la clínica con algo de dolor y el antecedente de fumar, asumiremos que estaban preguntando un cáncer de páncreas en específico, por lo que dejaremos como correcta la TAC.

53) B. Es un púrpura de Schönlein Henoch, cuyo pronóstico depende principalmente de la afectación renal. Se pide un sedimento de orina para determinar si hay glomerulonefritis y también creatinina para ver si hay insuficiencia renal y luego se sigue con examen de orina completa (muestra la hematuria y la proteinuria que pueden persistir, deteriorando el pronóstico).

54) A. Parece una cetoacidosis, así que lo más urgente es confirmar el diagnóstico, con la cetonemia (o cetonuria) y los gases venosos (para ver el estado ácido base). Los criterios son cetonas ++ en sangre u orina, pH menor a 7,3, bicarbonato menor a 16 mEq/L y glicemia mayor o igual a 200 o 250 mg/dl (niños y adultos, respectivamente).

55) E. El BCRI nuevo es equivalente al SDST en el manejo del infarto, así que se debe reperfundir de inmediato, idealmente con angioplastia (o bien con trombolisis si no está disponible la angioplastia en menos de 90 minutos).

56) C. El retraso del crecimiento intrauterino se estudia con Doppler umbilical, como examen de elección (permite diferenciar el PEG del RCIU y además determina la gravedad del RCIU, de manera de determinar la edad de interrupción). Varias de las otras opciones (D y E) serán correctas, dependiendo del resultado del doppler.

57) D. Es un trastorno de somatización clásica (muchos síntomas distintos, sin causa orgánica). El haber accedido a la laparoscopia, descarta la simulación y el T. facticio.



58) A. Es un trastorno evitativo clásico (inicio temprano, pocos amigos, etc.), aunque puede confundirse con una fobia social, sin embargo, en la fobia social sí tienen amigos, solo que no hacen cosas frente a ellos, en las que los puedan juzgar.

59) D. Es un hiperaldosteronismo clásico. La hipertensión renovascular también puede presentar hipokalemia (porque produce un hiperaldosteronismo secundario, por activación de eje renina – angiotensina – aldosterona), pero el resto de la clínica calza mejor con hiperaldosteronismo primario (mucho debilidad, calambres y cefalea). En cambio, la HTA RV tiene soplo abdominal y algo de elevación de la creatininemia.

60) D. Es un púrpura de Schönlein Henoch, que se complica con glomerulonefritis. El compromiso renal marca el pronóstico. De hecho, luego se sigue con orina completa (para ver la proteinuria y la hematuria).

61) B. Es un síndrome anticolinérgico clásico (compromiso de conciencia, retención urinaria, constipación, midriasis, sequedad de mucosas y taquicardia). El colinérgico tiene vómitos, miosis, bradicardia, temblor, contracturas musculares y dificultad respiratoria: ej. organofosforados). El neuroléptico maligno se caracteriza por compromiso de conciencia, hipertermia e hipertensión. El serotoninérgico tiene HTA, aumento del tono muscular, vasoconstricción periférica, compromiso de conciencia. El adrenérgico tiene HTA, taquicardia, hipertermia, midriasis, temblor.

62) A. Es una distonía aguda clásica (contractura muscular tónica). La disquinesia tardía aparece años después y tiene movimientos reptantes de la boca, lengua y luego de extremidades. La acatisia es un cuadro de inquietud psicomotora y cambios continuos de posición.

63) B. La sospecha es un síndrome de Turner (talla baja, cuello alado: pterigium coli y retraso puberal). Su edad ósea es menor, por el retraso puberal. Se estudia con cariotipo (45 XO).

64) A. Seguro recibió antibióticos en el puerperio, por lo que se sospecha la diarrea por *C. difficile*. Las otras opciones no tienen relación con el antecedente de puerperio.

65) B. Es una mala pregunta: no hay duda de que es una fractura de radio distal, pero la clínica es insuficiente para distinguir entre la fractura de epífisis y la disyunción fractura. Sin embargo, “disyunción fractura” o “luxofractura” se usa más para las fracturas de Monteggia y Galeazzi, que no corresponden a este cuadro, por lo que dejaremos la B como correcta. Sin embargo, la fractura no necesariamente es de la epífisis y puede ser de la metáfisis por ejemplo, así que definitivamente es una mala pregunta. Dolor epicrítico es sinónimo de dolor somático o superficial, en contraposición a dolor profundo o visceral.



66) B. Pregunta con información insuficiente. Tiene clínica de corioamnionitis (por lo que es una corioamnionitis), por lo que lo más correcto es interrumpir el embarazo, bajo cobertura antibiótica (clinda-genta). Ninguna de las opciones entregaba el manejo completo. Lo más importante es la interrupción del embarazo, por lo que dejaremos como correcta la B. Es importante aclarar que la corioamnionitis no es indicación per sé de cesárea y puede nacer por parto vaginal, siempre y cuando ya esté en trabajo de parto avanzado, de modo que no demore mucho en salir.

67) E. Era una anemia perniciosa clásica, con la macrocitosis y pancitopenia clásicas. Se estudia con B12 (cianocobalamina) y B9 (folatos).

68) B. Es una apendicitis clásica.

69) C. Los mesoteliomas son por exposición a asbesto. De todos modos, es una pregunta muy específica y además la frecuencia de mesoteliomas es muy baja en la actualidad (cerraron la empresa Pizarreño hace muchos años: era la que hacía placas de asbesto).

70) A. Si bien en la foto original parecían ectimas bacterianos en la foto, lo que se preguntaban eran las lesiones satélite en el muslo del lactante, por lo que se trataba de una candidiasis.

71) B. Es una mala pregunta, porque clínicamente es imposible distinguir un lipoma de un adenoma pleomorfo solo con la descripción del examen físico. Tiene las características clínicas de un lipoma (consistencia blanda, adherido en la zona profunda, pero sin compromiso de la piel). Sin embargo, la ubicación sugiere muy fuertemente un adenoma pleomorfo, que es el tumor benigno más frecuente de la parótida (50%, vs. 3% de los lipomas). El adenoma pleomorfo suele ser más móvil y no fijo y puede ser tanto duro, como blando, pero, aun así, dejaremos esa como respuesta correcta.

72) B. Es un quiste hidatídico con el patrón ecográfico clásico (lesión quística con paredes y/o tabiques). El diagnóstico se confirmó ya con la Ecografía, pero la serología puede ayudar a confirmarlo y además sirve para el seguimiento postquirúrgico (en que deben disminuir los niveles de anticuerpos). Además, era la única opción relacionada con el diagnóstico.

73) C. La aspergilosis es una complicación clásica de la neutropenia prolongada. Además, por ser un hongo, no responde a los antibióticos.

74) A. Al mejorar el tratamiento, mueren menos enfermos, pero al seguir la incidencia, hay más casos cada vez (mismos casos nuevos y más casos antiguos que no murieron), por lo que aumenta la prevalencia.



75) E. La clínica parece una conjuntivitis alérgica (antecedente de asma), pero no estaba en las alternativas. El antecedente de rosácea orienta mucho a blefaritis, sin embargo, falta la descripción del eritema y descamación palpebral y le sobra la secreción mucosa y mucopurulenta. La conjuntivitis bacteriana crónica (mayor a 4 semanas) clásicamente se asocia a otras alteraciones, como la blefaritis, y sí tiene secreción mucosa y purulenta, más el ojo rojo. No se describe el aumento de volumen de la dacriocistitis. Es una pregunta difícil y no queda completamente claro cuál es el diagnóstico, pero dejaremos como correcta la conjuntivitis crónica, por el tiempo de evolución, por el factor de riesgo y por la clínica compatible. Es una pregunta muy difícil.

76) D. Es una incontinencia de esfuerzo, cuyo tratamiento inicial son los ejercicios de Kegel. Si fallan, se indica el TVT o TOT (cirugía).

77) D. Es una invaginación o intususcepción clásica (incluyendo la edad y la clínica: dolor y hematoquecia).

78) C. Tiene una probable epilepsia por crisis de ausencia. Se estudia con EEG, al igual que las demás epilepsias primarias. Su hermano también debería estudiarse.

79) B. Es una hepatitis aguda, cuya primera causa es la hepatitis A. Además, la clínica es compatible: pródromo febril, seguido de ictericia. La cantidad de paracetamol que ha tomado no alcanza a producir hepatitis ni aunque se lo tomara todo junto.

80) E. Es la tasa de letalidad (probabilidad de fallecer si se enferma).

81) B. Tiene un síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño severa (>30 eventos por hora; moderada es entre 20 y 30; leve es <20), por lo que requiere C-PAP (se indica en la severa y en la que no responde al tratamiento médico de baja de peso y cambios de posición al dormir). La cirugía podría servir, pero requiere de obstrucción anatómica y además, dada la severidad, el C-PAP igual es de elección.

82) E. Es una pitiriasis alba. Por regla general se observa y se humecta, porque está asociada a atopía, pero el bloqueador solar está indicado (la verdad es que está indicado en todas las personas).

83) C. Es un trastorno delirante crónico de libro (delirio sistematizado; pérdida de juicio de realidad).

84) D. Son várices porque se presenta como hematemesis grave y los exámenes sugieren consumo de alcohol (VCM elevado) y daño hepático crónico (albúmina baja e INR levemente aumentado).

85) B Las alteraciones de la hemostasia primaria, como la enfermedad de von Willebrand (EvW), pueden presentar hipermenorrea y es compatible con la edad de



la paciente: de hecho, toda adolescente con aumento del flujo menstrual se debe estudiar al menos con un hemograma, plaquetas y tiempos de coagulación y luego se realizan las pruebas de agregación plaquetaria en busca de la EvW. Por la edad y por la delgado del endometrio es absolutamente improbable una hiperplasia endometrial o un cáncer de endometrio, como para elegir la biopsia o las otras opciones.

86) A. Es una CIA (comunicación interauricular) clásica, aunque en un adulto: soplo sistólico eyectivo, desdoblamiento del segundo ruido y eje desviado a derecha.

87) A. La alergia al huevo actualmente no es contraindicación de la vacuna trivírica, a menos que haya requerido hospitalización, caso en el que igualmente se da la vacuna, pero en el hospital, bajo observación.

88) B. Pareciera un desprendimiento de placenta, pero le falta la metrorragia. De todos modos, está con un sufrimiento fetal agudo (FC: menor a 100) y la bradicardia fetal es indicación de interrumpir por la vía más expedita y en este caso es la cesárea, porque está en fase activa y no se puede hacer un fórceps (a menos que esté en expulsivo: 10 cm, con descenso en tercer plano de Hodge o espinas +2).

89) D. Es un cáncer de recto, que aumenta el riesgo en el paciente VIH, en especial con VPH de alto riesgo (serotipos 16 y 18).

90) C. La capnografía es de elección actualmente para confirmar la intubación traqueal y descartar la intubación esofágica (mide CO₂, que seguramente viene de los pulmones). Eso sí, la clínica, en especial la auscultación, sigue siendo un buen indicador.

PARTE 2

91) C. Es una torsión testicular o al menos es un testículo agudo, que se maneja con exploración quirúrgica.

92) B. También podría haber sido una fibrilación ventricular, pero suelen estar precedidas por taquicardias ventriculares. Los infartos son la primera causa, porque se produce un fenómeno de reentrada alrededor de la zona ventricular infartada y por eso es frecuente la muerte súbita, al tener antecedente de un infarto.

93) B. Es un adenoma hepático, por el aspecto, el tamaño (sólido, hipoecogénico, aspecto homogéneo) y por la alfafetoproteína no elevada. La cirrosis aumenta el riesgo de adenomas y hepatocarcinomas. Metástasis: se ven hipoecogénicas, sólidas y múltiples. Hepatocarcinoma: se ve heterogéneo y más grande, sólido y además eleva la AFP. Quiste: se ve anecogénico, con refuerzo posterior. Hemangioma: se ve hiperecogénico, homogéneo.



94) D. Es una neuralgia del trigémino y de primera línea se dan carbamazepina u otros anticonvulsivantes, aunque también sirven los antidepresivos tricíclicos. De segunda línea, se puede agregar la pregabalina (lo habitual es CBZ y luego pregabalina).

95) B. La ingesta de cáusticos se debe estudiar con EDA precoz: si no hay lesiones, se observa; si hay lesiones leves, se deja en régimen cero y se reinicia la alimentación de a poco, en 2 días. Si hay lesiones más severas, se alimenta por SNG y si hay perforación (se puede ver en la RxTx como neumomediastino), se debe hacer cirugía de inmediato, porque las perforaciones evolucionan a mediastinitis aguda, que son cuadros muy graves. Las demás medidas o no tienen utilidad o están contraindicadas en la ingesta de álcalis.

96) A. Parece una rabdomiólisis, que se estudia con CK.

97) D. Si bien, tiene los antecedentes que orientan a hiperplasia endometrial o cáncer (HONDA: hipertensión arterial, obesidad, nuliparidad, diabetes y anovulación), el grosor del endometrio es un muy fuerte indicador de atrofia endometrial (menor a 5 mm se observa), que es la causa más frecuente de metrorragia postmenopáusica.

98) A. Si bien es imposible ver bien la radiografía, la historia sugeriría mucho una fibrosis pulmonar por amiodarona, por lo que se debe suspender.

99) D. Es una ascitis a tensión, en la que se descartó PBE (menos de 250 PMN), por lo que está indicado la paracentesis evacuadora, con albúmina en dosis de 8 g i.v. por litro de líquido sacado.

100) D. Tiene una preclamsia, que pareciera ser moderada, aunque falta información para estar seguro. De todos modos, por haber llegado al término, se debe interrumpir el embarazo. No hay indicación de cesárea con la información que se entrega. Sin embargo, es una pregunta que induce a error, porque no está de más, evaluar el bienestar fetal antes, ya que en toda paciente con preclamsia debería hacerse un Doppler fetal. Sin embargo, a mi parecer lo correcto es la interrupción, ya que ese es el tratamiento de la preclamsia a las 38 semanas y aunque el Doppler salga normal, igualmente se debe interrumpir.

101) C. Es un probable sarcoma de partes blandas. Debe estudiarse con resonancia magnética nuclear, como examen de elección, para determinar el grado de invasión, antes de definir qué tipo de cirugía se le hará. Como no aparecía en las opciones, lo más razonable es hacer la ecografía, porque al menos es suficiente para distinguir entre un tumor benigno y uno maligno. Luego sí se hará la resección y biopsia.

102) E. Tanto la clínica (compromiso de IFD, IFP y primera CMC), como la radiografía son clásicas de artrosis. No importa la positividad de marcadores, ya que



están positivos en un 5% de las personas sanas y solo tienen importancia cuando la clínica es de Lupus o Artritis reumatoide, que no es el caso.

103) D. La fiebre y que afecte el hombro, orienta mucho a que es una A. séptica. Faltan datos como para pensar en condrocalcinosis que es otra de las causas de monoartritis aguda (afectan más otras articulaciones: rodilla en condrocalcinosis).

104) C. Es un déficit de B12 o cianocobalamina, por el antecedente de cirugía gástrica y porque tiene una bicitopenia con macrocitosis.

105) A. Si bien la sinovitis transitoria suele ser en menores de 5 años, la clínica es compatible, por estar en buenas condiciones.

106) A. Tiene un huevo anembrionado, pero menor a 25 mm, por lo que debe seguirse con nueva ecoTV en 7 a 10 días. La HCG se pide en la sospecha de embarazo ectópico (no confundirlos, ya que el EE no tiene saco intrauterino, sino que se ve el útero vacío). Si tuviera más de 25 mm, podría observarse (por 2 a 4 semanas) o legarse, sabiendo que es un aborto retenido.

107) D. La HPE atípica (en especial si es compleja) se trata con histerectomía, porque tiene alto riesgo de evolucionar a un cáncer de endometrio. La HPE simple se trata con progestágenos orales o con el DIU medicado.

108) D. La osteoclastosis es la vía de elección en lactantes, cuando no es posible encontrar una vía venosa. En los adultos, en cambio, se realiza la denudación venosa.

109) D. Es una pregunta muy discutible. Aunque esté con lactancia materna exclusiva, hoy se considera obeso (para el diagnóstico de obesidad manda el IPT en menores de 1 año; en cambio para el diagnóstico de desnutrición se usa el IPE hasta el año de edad). Sin embargo, si está con LME, no es necesario tomar ninguna medida, ni siquiera espaciar las tomas, hasta los 6 meses.

110) E. Pregunta pésima, puede ser cualquiera de las opciones, menos la B. Sin embargo, la causa más frecuente de uretritis no gonocócica es la Chlamydia trachomatis. Si bien le falta clínica para tener una uretritis (solo tiene disuria, sin secreción uretral), pareciera que es lo que se está preguntando, dadas las alternativas.

111) A. El exantema macular eritematoso es la reacción adversa a medicamentos más frecuente. Las otras opciones no pueden ser.

112) D. Es un mieloma, que se diagnostica con mielograma o biopsia de médula ósea (el mielograma equivale al frotis de médula ósea).



113) E. Lo más importante es confirmar el diagnóstico de *C. difficile*. Sin embargo, las toxinas han sido desplazadas por la PCR (aunque tiene más falsos positivos) y en general no es necesario suspender los antibióticos (en este caso sí se debían suspender, porque no estaban indicados, ya que las bronquitis no se tratan con ATB).

114) C. Parece una hepatitis por consumo de alcohol (aunque la relación GOT/GPT no alcanza a ser mayor a 2), que luego vomitó y siguió con un Mallory Weiss clásico (desgarro esofágico por vómitos).

115) D. Tanto el soplo, como los fenómenos embólicos, orientan a EBSA (endocarditis bacteriana subaguda; la aguda es menor a 7 días). Ninguna de las opciones puede ser, por no tener relación con la clínica.

116) B. Es un quiste branquial clásico (zona lateral del cuello y crecimiento muy lento). No puede ser nódulo tiroideo, por la ubicación (la tiroides está en la zona media inferior del cuello). Tampoco un quiste del conducto tirogloso, porque este es de la línea media. La adenopatía tuberculosa o escrófula crece más rápido y suele fistulizarse, dando salida a material caseoso.

117) D. La enfermedad del nodo sinusal, sintomática, requiere de marcapasos definitivo. El bloqueo AV requiere ser de tercer grado o de segundo grado Mobitz II, para ser indicación de marcapasos. El flutter y la FA se tratan farmacológicamente y no con marcapasos. El BCRI se observa.

118) C. Dos BK (baciloscopías) positivas seguidas, después del cuarto mes, es sospechosa de fracaso a tratamiento. El diagnóstico de fracaso requiere del cultivo, pero las 2 BK positivas son suficientes para que se derive a tratamiento secundario, mientras está el resultado del cultivo de Koch y el antibiograma.

119) A. Son bronquiectasias clásicas (persona joven con clínica respiratoria, hemoptisis, broncorrea, infecciones recurrentes y estertores y sibilancias). Las acropaquias se ven en A, B y C, pero son más frecuentes en el cáncer de pulmón.

120) A. Es un púrpura de Schönlein Henoch, que se complica con glomerulonefritis e Insuficiencia renal. Es normal que se pregunte varias veces lo mismo en el Eunacom.

121) B. Es un síndrome nefrótico clásico (proteinuria, edema, hipoalbuminemia). No hay hematuria ni HTA, así que no puede ser nefrítico.

122) B. Es un SHU clásico (niño, antecedente de diarrea, insuficiencia renal aguda grave, anemia hemolítica y trombocitopenia).

123) B. La aparición de una enfermedad a lo largo del tiempo es la definición de incidencia. La incidencia se mide con los estudios de incidencia y con los estudios



de cohortes, con la diferencia que el estudio de incidencia es simplemente descriptivo y no tiene un grupo de comparación (dice “un grupo de escolares”), mientras que los de cohortes tienen un grupo de control (se separan en expuesto y no expuestos a un factor de riesgo y se siguen en el tiempo, para ver las incidencias de patología). Es una pregunta que induce a error, ya que ambas respuestas son correctas, pero dejaremos como correcta la B, por ser solo un grupo y dar la definición de incidencia en el enunciado.

124) D. Es una rotura de vasa previa clásica (hemorragia con la rotura de membranas, asociada a sufrimiento fetal agudo y sin dolor ni afectación materna). La rotura uterina, además tiene dolor y antecedente de cesárea. El DPPNI además tiene contracciones dolorosas, hipertensión uterina. La placenta previa no puede ser, porque no habría habido salida de líquido ni afectación fetal. La prolapso de cordón no tiene metrorragia (sí tiene el sufrimiento fetal tras la rotura de membranas).

125) D. Tiene un claro diagnóstico de tabaquismo. Sin embargo, está en etapa precontemplativa, porque no quiere dejar de fumar. Por ello, la única opción es tratar los desencadenantes.

126) B. En mi opinión, es una pregunta con error, ya que el control positivo (con histamina) resulta 0 mm, lo que habitualmente significa que está usando antihistamínicos y el examen no sirve, por la anergia cutánea farmacológica, sin embargo, también resulta negativo para todo lo demás. En cambio, en este caso, resultó positivo para pólenes (>3 mm), lo que es imposible según lo anterior, pero da cuenta que está sensibilizado para pólenes. Por eso, dejaremos como respuesta correcta la B. Lo más correcto es que hubiese dicho que el control con suero fisiológico estaba en 0 mm y no el de la histamina. No es posible afirmar que sea alérgico, ya que ese es un diagnóstico clínico y no mediante el prick test.

127) D. Es el cuadro clásico de aspiración de cuerpo extraño (síndrome de penetración: tos intensa; y luego clínica obstructiva localizada).

128) B. Es un T. adaptativo clásico (gatillante claro, síntomas depresivos y/o ansiosos, pero sin cumplir criterios de depresión u otro trastorno ansioso: ej. no tiene cambios en el peso ni afectación grave de su vida).

129) A. Es una fobia social clásica: ansiedad al realizar actividades en público y evitación de las mismas.

130) A. Es una diverticulitis clásica, con irritación peritoneal en la FII (fosa iliaca izquierda).

131) D. Los anticolinérgicos son los fármacos de elección para la IOU (en particular la oxibutinina y la tolterodina). Los tricíclicos están absolutamente contraindicados



en los adultos mayores, dado los efectos adversos potencialmente graves. La mayoría de los estudios no muestran diferencias entre ambas, pero la tolterodina tiene menos efectos adversos (menos boca seca). Hoy hay algunos anticolinérgicos más nuevos y seguros: fesoterodina y solifenacina (que serían de segunda línea, por ser más caros).

132) A. Aunque los marcadores estén negativos, es una AR clásica. Tiene además un Sjögren secundario.

133) D. La diabetes gestacional se trata con dieta y ejercicios y luego insulina como fármacos de elección. Si bien los hipoglucemiantes orales hoy pueden darse en el embarazo, la insulina sigue siendo de elección.

134) B. Birrads 4 = biopsia histológica. Birrads 0 = Ecografía; Birrads 1 y 2 = control en 1 año con mamografía; Birrads 3 = control con mamografía en 6 meses y además es posible complementar con Eco. Birrads 5 = biopsia quirúrgica.

135) D. Tanto por las infecciones respiratorias, como por la malabsorción es una fibrosis quística. Las demás opciones producen solo síntomas digestivos (A, B y E) o solo neumonías (C).

136) C. Es una pregunta muy discutible, ya que el diagnóstico es un hipotiroidismo subclínico y el manejo de esta patología está llena de controversias. Los niveles de TSH y T4 libre de este paciente no justifican los síntomas. Lo más correcto sería seguir estudiando la causa de la astenia y mialgias. Dentro de las opciones, sería válida iniciar tratamiento, si la pregunta se refiere a un hipoT4 sintomático (y por lo tanto clínico), pero probablemente no se refiere a eso, por tener una TSH de apenas 5,6. Por el contrario, sería controlar con pruebas tiroideas, si se refiere a un hipotiroidismo subclínico propiamente tal y decidir el manejo con levotiroxina solo si persiste con los niveles elevados de TSH en 3 meses y con los síntomas, o si se asocia algún otro factor de riesgo, como dislipidemia, depresión.

137) C. El tratamiento de elección de la ITU en el embarazo son las cefalosporinas de primera generación. Pero no aparecía en las alternativas, por lo que la única aceptable era la nitrofurantoína, ya que las demás opciones o no cubren la ITU o están contraindicadas en el embarazo.

138) B. Es un delirium. Se trata, tratando la causa, pero sirve dar haldol en bajas dosis (también sirve la risperidona en bajas dosis, aunque no ha demostrado ser mejor que el Haldol). Para el manejo de la diabetes, está indicada la insulina, en este caso. Las BDZ están contraindicadas.

139) D. Es una neumonía grave, que requiere tratamiento en UCI y ventilación mecánica (insuficiencia respiratoria grave). De los tratamientos, lo más adecuado es cefotaximo o ceftriaxona, más un macrólido o una quinolona respiratoria.



140) A. el antecedente de puerperio orienta muy fuertemente a TEP. La clínica es compatible.

141) B. Es un síndrome neuroléptico maligno clásico: se inicia o aumenta la dosis de un neuroléptico (sinónimo de antipsicótico) y evoluciona con la triada de rigidez, hipertermia y compromiso de conciencia.

142) C. La velocidad con la que se notifica considera la gravedad de la enfermedad (letalidad) y la frecuencia de casos (más que prevalencia es la incidencia, pero es la única respuesta aceptable). En general solo se notifican enfermedades graves y que son infrecuentes y mientras más graves, se notifican más rápido.

143) A. Es una sinusitis aguda. Por el tiempo de evolución es probablemente viral y no requiere sino tratamiento sintomático. Sin embargo, no aparecía dentro de las alternativas y lo que se pregunta entonces es el tratamiento de la sinusitis bacteriana aguda, que de primera línea es con amoxicilina. Los descongestionantes tópicos, no son muy indicados, ya que tienen efectos adversos y no solucionan los demás síntomas.

144) C. Faltaba información y no era posible ver bien la imagen. Podría ser una dermatitis de contacto alérgica, porque era en relación a un aro y excedía la zona de contacto, pero las lesiones en la cara no calzaban del todo. La visualización de costras mielicéricas es muy sugerente de impétigo (piodermitis superficial), pero también puede verse en la dermatitis de contacto y el cuadro es clásico de esta enfermedad. No puede ser celulitis, porque no hay tejido celular subcutáneo en la oreja.

145) B. Es un herpes genital clásico.

146) B. Es un PTI clásico, con el hemograma característico: trombocitopenia asilada.

147) B Es una pregunta muy discutible, pero dado el diagnóstico de deshidratación hipertónica, con marcada hipernatremia e hipeclorremia, da miedo el suero fisiológico (la evidencia no soporta esta recomendación, pero lo habitual es que se crea que el SF puede agravar la hiponatremia). Debería iniciarse suero glucosalino isosmolar, pero no aparece en las opciones. Se pregunta el primer suero a administrar y el suero glucosado parece la única opción aceptable, ya que es hipotónico. Sin embargo, también está la afirmación: "se corrige primero la volemia y luego, nos preocupamos de los electrolitos" y en ese caso sería correcto el SF, ya que con él se logrará corregir la volemia (con SF o Ringer) y luego corregir la natremia (con suero glucosado). Entonces ante la duda, se responde así: ¿Qué pasa si le doy solo suero glucosado?: se muere; y ¿qué pasa si le doy solo suero fisiológico?: tal vez vive. Por tanto, se elige el suero fisiológico.



148) C. Por estar hysterectomizada, debe recibir estrógeno solo y por ser dislipidémica, debe ser por vía transdérmica. Recordar que lo habitual es dar estrógenos más progestágenos, para evitar el riesgo de cáncer de endometrio, pero con la hysterectomía, ya no existe el riesgo de dicho cáncer y bastan los estrógenos.

149) A. Tiene un embarazo ectópico no complicado (aún), con contraindicación de metotrexato (más de 4 cm y más de 5.000 de HCG), por lo que debe tratarse con laparoscopia (tiene menos riesgo de la laparotomía). La laparotomía se usa en los casos en que se rompe.

150) C. La hiperplasia atípica se trata con hysterectomía. Si bien la paciente es nulípara, a los 46 años es improbable que se le indique un tratamiento más conservador, ya que probablemente no tendrá más hijos. De todos modos, en la vida real, se debe consultar la opinión de la paciente, ya que, si sus deseos de fertilidad son importantes, se puede hacer una hormonoterapia con progestágenos y reevaluar con biopsia endometrial. La hiperplasia endometrial simple, en cambio, se trata con progestágenos.

151) D. Es un coqueluche clásico: tos en accesos, precedido por cuadro catarral y linfocitosis en el hemograma.

152) A. Parece una TBC (cuadro subagudo, con compromiso de los lóbulos superiores), por lo que debe estudiarse con baciloscopías y cultivo.

153) D. Parecía una trombosis de la vena central, pero no aparece en las opciones. Por tener DPAR (defecto pupilar aferente relativo) sugiere un desprendimiento de retina, pero le falta tener fopsias o entopsias que antecedan. Así, dados los antecedentes, lo más probable es la neuropatía óptica isquémica. No puede ser una neuritis óptica, porque esta no es súbita, sino que aparece en varias horas.

154) C. La clínica es de leucemia aguda. En la práctica es imposible diferenciar una leucemia mieloide aguda de una linfática aguda solo por la clínica, pero las adenopatías y la edad (joven) sugieren más una leucemia linfática aguda.

155) E. Es una bronquitis crónica clásica: fumador con tos y expectoración crónicas, mayores en la mañana. No tiene EPOC, porque su espirometría está normal. Asimismo, la radiografía normal hace improbables las demás opciones. Finalmente, la clínica no es sugerente de ninguna de las otras.

156) B Tiene una hipercalcemia por el mieloma. La primera medida es el suero fisiológico. Luego los bifosfonatos, para evitar que recurra. Solo si no funciona se administra calcitonina. Los corticoides sirven en la hipercalcemia por cáncer hematológicos, pero no son lo más importante.



157) A. Es una diverticulitis aguda clásica, aunque aún no tenga signos peritoneales. El dolor en la FII y la fiebre lo sugieren fuertemente. Por el buen estado general, seguro es Hinchey I.

158) E. Las glicemias de ayuno menores a 100, se observan; las entre 100 y 125 se solicita prueba de tolerancia a la glucosa. Las de 126 o más, se repiten. En el embarazo es distinto, así que siempre se debe leer si está o no embarazada, antes de contestar.

159) B. El cáncer de vejiga es la causa más frecuente de hematuria monosintomática (sin otros síntomas; si en cambio viene con síntomas de ITU, es ITU; si viene con síntomas de litiasis, es litiasis, etc.) en el adulto, en especial si es un paciente fumador. Las demás opciones tienen otros síntomas. La clínica clásica del cáncer renal es: masa, hematuria y fiebre (más ictericia en algunos casos).

160) E. Tiene una HbA1c menor a 7%, de hecho, menor a 6%, que es lo normal. En el adulto mayor el objetivo es de 8%, por lo que no hay problema en suspender la glibenclamida y más aún, se puede disminuir el riesgo de hipoglicemias. Ninguno de los demás fármacos está contraindicado.

161) C. Es el cuadro típico del temblor esencial: temblor bilateral que aumenta al adoptar una postura y disminuye con el alcohol y las BDZ (benzodiazepinas).

162) C. Son apneas emotivas. Lo más indicado es la educación, ya que son de bajo riesgo. Dentro de los ALTE (evento que aparentemente amenaza la vida), las apneas emotivas son las de más bajo riesgo.

163) C. Tiene una imagen de un BAV de segundo grado, Mobitz I, en que se va alargando el PR, hasta que una onda P no conduce.

164) C. Es una mononucleosis clásica, causada por el VEB. La esplenomegalia hace que no sea una faringitis estreptocócica, sino una mononucleosis, con seguridad.

165) B. Un PAP alterado, con probable lesión neoplásica, debe ir a colposcopia y biopsia, independiente del grado de las atipías celulares, más aún si hay VPH. La tipificación de VPH es cara, pero se recomienda, en caso de haber recursos (no es el caso de Chile), cuando hay una ASCUS (atipías celulares de significado incierto). La vacunación de VPH ya no sirve (se debe hacer antes de contraer el virus: en Chile se hace en 7° y 8° básico).

166) E. Aunque la ecografía no lo vea, el diagnóstico clínico es un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que requiere de interrupción por la vía más expedita: en este caso cesárea, por no estar en trabajo de parto avanzado.



167) E. Es una nefritis intersticial clásica, con la eosinofilia característica y la insuficiencia renal, probablemente secundaria al tratamiento farmacológico con la cloxacilina (de base tenía una erisipela).

168) B. Es una estenosis aórtica de libro. En el manual de semiología cardíaca veremos las clínicas de todas las patologías cardíacas, ya que siempre se preguntan.

169) C. El síndrome de Cushing se estudia primeramente con cortisol libre urinario de 24 horas. También hubiese sido correcto un test de supresión corta con dexametasona o el cortisol en saliva, si es que no hubiese estado la opción del CLU 24 horas. Si están alterados, se prosigue el estudio con ACTH y prueba de supresión larga. La RMN de silla turca, se pide más adelante, en caso de que la ACTH sea alta y la prueba de supresión larga suprima parcialmente. La prueba de estimulación con ACTH sirve para la insuficiencia suprarrenal (ej. Addison).

170) C. Es un Guillain Barré clásico (tetraparesia fácida y arrefléctica, con parálisis facial bilateral).

171) B. Es un hipogonadismo clínico (disminución del vello corporal, astenia y disfunción sexual: impotencia y disminución del deseo sexual), que se estudia con gonadotropinas (LH) y hormonas sexuales (testosterona en el hombre).

172) A. Es una forma clásica del primer brote de esquizofrenia. La edad es compatible. Seguramente tiene alucinaciones auditivas y por eso habla y se ríe solo.

173) E. Todo paciente con tratamiento corticoidal debe hacerse densitometrías óseas, porque se produce osteoporosis secundaria. Si bien la artritis reumatoide (AR) aumenta el riesgo de daño de la articulación atlantoaxoidea, no es necesario hacer la radiografía de rutina.

174) B. Es una CBP (cirrosis biliar primaria) clásica: mujer de edad media, con colestasia crónica, con elevación prominente de las fosfatasas alcalinas; aunque falta la clínica de astenia, que es el síntoma más frecuente. No tiene factores de riesgo para la esteatosis hepática (hígado graso) y, además, suele cursar con hepatitis y no colestasia. La colestasia por compresión externa, suele ser por cáncer y viene con mucha ictericia (no es el caso). La colangitis esclerosante primaria puede tener un cuadro similar, pero en lugar de ser una mujer de edad media, suele ser en hombres, con antecedente de colitis ulcerosa.

175) E. Tiene factores de riesgo de cáncer de endometrio (HONDA; obesidad y nuliparidad) y además células endometriales. Se debe descartar una hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio, partiendo por la Ecografía y en caso necesario, con biopsia. Sin embargo, es importante aclarar que, en mujeres premenopáusicas,



sin factores de riesgo, la presencia de células endometriales es algo estrictamente normal.

176) C. Las hiperplasias endometriales atípicas y también las complejas se tratan con histerectomía, a menos que la paciente tenga altos deseos de paridad (en que se puede intentar un tratamiento alternativo: progestágenos y legrado). Es frecuente que en el Eunacom se pregunten varias veces lo mismo.

177) C. Tanto por el antecedente de cesárea, como por la radiografía es taquipnea transitoria clásica.

178) B. Es una clásica epifisiolisis de la cabeza femoral (adolescente con claudicación de la marcha y dolor en la cadera. Se asocia a sobrepeso y obesidad). Además, se ve el signo del “helado caído”.

179) B. Era una fibromialgia (mialgias, astenia y dolor a la compresión de las masas musculares, sin otras alteraciones), probablemente en contexto de un trastorno de somatización. El tratamiento es con ejercicios y estabilizadores de la conducción nerviosa. Que los ANA estén positivos, no importa, porque no hay clínica de lupus. Además, están en una titulación baja (1/40), lo que se encuentra hasta en un 5% de la población sana.

180) E. Por estar en el climaterio, es muy probable que sea disfuncional (es la causa más frecuente de metrorragia premenopausia). No aparecía atrofia endometrial como opción, sino atrofia vaginal, que está descartada.

Dr. Guevara

Preparación EUNACOM

Eunacom julio 2017

Esta es la reconstrucción del Eunacom de julio de 2017. Agradezco la colaboración de mi primo y amigo, el Dr. Augusto Aliaga, por haberme ayudado a redactarlo, mientras estaba convaleciente.

De todos los Eunacom que he hecho, este es el con mayor nivel de dificultad, en particular porque muchas de las preguntas están fuera de lo que debe saber un médico general y porque otras tienen enunciados con muy poca información, como para poder estar seguro del cuadro clínico o simplemente porque inducen al error.

Es urgente que se empiecen a publicar las preguntas, de modo de poder tener algún grado de control sobre ellas, con la posibilidad de objetarlas. La falta de transparencia es sin duda la mayor debilidad del examen.

Dado que se eliminan muchas preguntas (y en este examen probablemente se eliminarán más de lo habitual), el puntaje que obtengan puede variar muchísimo. Por ello, no se queden con resultado que obtengan en la revisión esta reconstrucción.

Aquellos que reprueben, no se angustien, ya que el Eunacom es una prueba difícil, pero superable. Nosotros aún tenemos varios cupos disponibles, aunque suelen agotarse el día de la entrega de resultados, así que si alguien está interesado en inscribirse, le recomiendo que nos contacte antes.

Finalmente, a fines de agosto iniciaremos un curso de preparación para el examen práctico. Subiremos la información sobre el mismo a nuestra página web, apenas tengamos definidos algunos detalles.

Espero que esta reconstrucción les sea de utilidad y les deseo el mayor de los éxitos, tanto en el Eunacom, como en su vida profesional y personal.

Un abrazo,

Guillermo Guevara Aliaga

PRIMERA PARTE

0) ¿Cuál es el mejor curso de preparación para el Eunacom?

- a) El curso del Dr. Guevara
- b) Otro

1) Una paciente de 92 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer por lo que está institucionalizada, presenta un cuadro de astenia, debilidad, baja de peso de 6 kilos en los últimos dos meses, asociado a hematoquesia intermitente en algunas oportunidades, que los familiares atribuyen a hemorroides externos. Al examen físico presenta un abdomen blando, depresible, con ruidos hidroaéreos presentes. Su piel se aprecia algo pálida y sus signos vitales son normales. ¿Con que examen debe iniciarse el estudio en esta paciente?

- a) Ecografía abdominal
- b) TAC de abdomen y pelvis
- c) Resonancia magnética de abdomen y pelvis
- d) Colonoscopia corta
- e) Colonoscopia completa

2) Un paciente de 75 años, es hospitalizado hace 2 días, por un accidente vascular encefálico. Presenta dolor, eritema y aumento de volumen de la rodilla izquierda, con impotencia funcional. Al examen se aprecia eritema y signos de derrame articular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Artritis séptica
- b) Artritis por cristales
- c) Artritis reactiva
- d) Artritis reumatoide
- e) Osteoartritis

3) Un lactante de 12 meses de edad es traído por su madre, ya que presenta coloración amarillenta-anaranjada en las palmas de las manos, las plantas y en las mejillas. No tiene otros antecedentes, pesa 9,5 Kg y mide 73,5 cm y su examen físico no muestra otras alteraciones. ¿Cuál es la causa de esta alteración?

- a) Hipercolesterolemia
- b) Hipertrigliceridemia
- c) Hiperbilirrubinemia de predominio directo
- d) Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
- e) Un componente de la dieta

4) Una paciente de 25 años, con antecedente de anorexia nervosa desde hace 5 años. Actualmente pesa 29 kilos y mide 1,68 metros, con IMC de 10,3. ¿Con cuantas kilocalorías diarias se debe iniciar su alimentación?

- a) 300
- b) 600
- c) 1200
- d) 1500
- e) 2400

5) Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 21 semanas, presenta un cuadro de malestar general marcado, asociado a confusión en el último tiempo. Al examen físico está desorientada, tiene petequias en abdomen y extremidades y equimosis en ambas extremidades inferiores. Se controlan exámenes, que muestran LDH: 2.550 UI/L, hemograma con hematocrito 29%, plaquetas: 33.000 por mm³ y frotis con abundantes esquistocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Púrpura trombocitopénico inmune
- b) Púrpura trombocitopénico trombótico
- c) Síndrome de HELLP
- d) Trombocitopenia gestacional
- e) Enfermedad gestacional

6) Un recién nacido presenta aumento de volumen parietal izquierdo, limitado a la zona parietal, que no sobrepasa la línea media. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la alteración descrita?

- a) Fistulización a la piel
- b) Osteomielitis
- c) Disección de cuero cabelludo
- d) Hiperbilirrubinemia
- e) Abscedación

7) Un paciente presenta vértigo, de segundos de duración, que se le produce al girar la cabeza a derecha, mientras está acostado. No tiene síntomas auditivos y como antecedente refiere haber sufrido un traumatismo encefálico hace 10 días, en un accidente de trabajo. No presenta adiadococinesia ni dismetría. El resto de su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar flunarizina
- b) Iniciar tietilperazina
- c) Solicitar un TAC de oídos
- d) Derivar para maniobras de reposición vestibular
- e) Iniciar difenidol

8) Paciente de 62 años, diabético diagnosticado hace 5 años en tratamiento con hipoglucemiantes orales, como parte de un chequeo se realiza exámenes de chequeo donde se aprecia creatinina de 0,9mg/dL, hemoglobina glicosilada menor a 7% y un perfil lipídico que muestra triglicéridos de 250 mg/dL, colesterol total de 258 mg/dL, HDL 52 mg/dL, LDL 156 mg/dL. No presenta síntomas. El tratamiento más adecuado para disminuir su riesgo cardiovascular es:

- a) Fibratos
- b) Estatinas
- c) Dieta baja en ácidos grasos saturados
- d) Ácido nicotínico
- e) Ezetimibe

9) Un paciente de 54 años, presenta un cuadro de varias semanas de evolución de astenia, adinamia y disnea que aparecen a los grandes esfuerzos. Al examen físico se aprecia palidez de piel y mucosas, se palpa el hígado 6 cm bajo el reborde costal derecho y el bazo se palpa 10 cm bajo el reborde costal izquierdo. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito de 29% con hemoglobina de 9,6g/dL, blancos 4.200/mm³, plaquetas 111.000/mm³ y al frotis se aprecia macrocitosis y abundantes dacriocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Mieloptisis
- b) Mieloma múltiple
- c) Leucemia mieloide crónica
- d) Mielodisplasia
- e) Mielofibrosis primaria

10) Una paciente de 33 años, consulta por dolor cervical intenso de una semana de evolución asociado a sensación febril. Al examen físico destaca glándula tiroides del doble del tamaño normal, muy dolorosa a la palpación, frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto y presión arterial de 120/80 mm Hg. Se solicitan exámenes que muestran TSH: 0,2 UI/L, T4L: 1,9 ng/mL (Valor normal: 0,6-1,7 ng/mL), captación de yodo radioactivo de 2% (Valor normal: mayor a 3%). ¿Cuál es el tratamiento de elección en esta paciente?

- a) Propiltiouracilo
- b) Ibuprofeno
- c) Prednisona
- d) Levotiroxina
- e) Yodo radioactivo

11) Una mujer de 30 años, multipara de 1, cursando un embarazo de 29 semanas, consulta por dinámica uterina persistente. Al examen físico presenta 3 contracciones uterinas en 10 minutos y su tacto vaginal muestra feto en cefálica, con cuello delgado y dila-

tado de 8 centímetros. Además de administrar antibióticos, la conducta más adecuada es:

- a) Dar fenoterol endovenoso
- b) Dar nifedipino oral
- c) Dar sulfato de magnesio endovenoso
- d) Realizar cesárea de urgencia
- e) Administrar corticoides

12) Una paciente de 59 años, luego de una pelea con su marido, se va de su casa y es encontrada varias horas después sin recordar lo sucedido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno facticio
- b) Trastorno disociativo
- c) Trastorno somatomorfo
- d) Trastorno conversivo
- e) Trastorno adaptativo

13) Un paciente de 43 años, obeso mórbido, consulta por cansancio y somnolencia diurna. Refiere que ronca en la noche y se queda dormido en las luces rojas del semáforo. En su examen físico destaca PA: 140/90 mmHg, FC: 72x' y faringe normal. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir el estudio en este paciente?

- a) Poligrafía nocturna
- b) Polisomnografía
- c) Saturación arterial de oxígeno durante el sueño
- d) Monitorización de presión arterial de 24 horas
- e) Nasofibroscopía

14) Una paciente presenta disminución de la sensibilidad e imposibilidad de mover la extremidad superior derecha, luego de haber sido despedida de su trabajo. Su examen neurológico no tiene alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno somatomorfo
- b) Trastorno facticio
- c) Trastorno disociativo
- d) Trastorno conversivo
- e) Trastorno por simulación

15) Un paciente presenta disfonía y disartria, como secuela, luego de haber sufrido un traumatismo encefalo craneano. Evoluciona posteriormente con múltiples neumonías aspirativas. ¿Cuál es la causa más probable de estas neumonías?

- a) Reflujo gastroesofágico

- b) Estenosis subglótica
- c) Divertículo esofágico
- d) Trastorno de la deglución
- e) Parálisis frénica

16) Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, consulta por disminución progresiva de la agudeza visual del ojo derecho. En su evaluación, tiene agudeza visual 20/20 en el ojo izquierdo y 10/20 en el ojo derecho. Su rojo pupilar demuestra una opacidad con forma de estrella, en la zona central. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Desprendimiento de retina
- b) Edema macular
- c) Catarata
- d) Glaucoma
- e) Retinopatía diabética proliferativa

17) Una paciente de 43 años, ex fumadora de 8 paquetes año, consulta por disnea, asociada a tos con expectoración mucosa y respiración sibilante, que aparecen después de realizar ejercicio o presentar infecciones virales. Al examen físico presenta disminución del murmullo pulmonar, sibilancias espiratorias y aumento del diámetro anteroposterior torácico. Se realiza una radiografía que se muestra a continuación:

INSERTAR FOTO

El tratamiento inicial más adecuado es:

- a) Salmeterol inhalado
- b) Ipratropio inhalado
- c) Budesonida inhalado
- d) Salbutamol inhalado
- e) Tiotropio inhalado

18) Un paciente de 66 años consulta por dolor lumbar derecho de 8 horas de evolución, irradiado al flanco ipsilateral y asociado a fiebre, vómitos, hematuria y agitación psicomotora. Al examen físico presenta FC: 100x', con ritmo cardíaco irregular, en dos tiempos, PA: 120/70 mmHg y puñopercusión positiva a derecha. En sus exámenes, se aprecian incontables glóbulos rojos en el sedimento de orina y 20 glóbulos blancos por campo. Destaca además creatinina plasmática de 2,3 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Aneurisma aórtico abdominal roto
- b) Urolitiasis
- c) Pielonefritis aguda
- d) Torsión testicular
- e) Embolia renal

19) Un paciente de 47 años, obeso, consulta por dolor y aumento de volumen en la zona interglútea. Al examen físico se aprecia aumento de volumen en la zona sacra, de consistencia blanda, eritematoso y doloroso a la palpación. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar drenaje quirúrgico con anestesia local
- b) Antibióticos orales
- c) Solicitar una ecografía de partes blandas
- d) Solicitar resonancia nuclear magnética de pelvis
- e) Solicitar TAC de abdomen y pelvis

20) Un escolar de 7 años consulta por una zona alopécica de 2 semanas de evolución, que ha ido en creciendo. Al examen físico se aprecia la placa alopécica de 4 cm, con descamación y pelos entrecortados, tal como se muestra en la siguiente imagen:

INSERTAR FOTO

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tiña capitis
- b) Tricotilomanía
- c) Alopecia areata
- d) Lupus discoide
- e) Dermatitis solar

21) Un paciente de 32 años, lleva un año conviviendo con pacientes bacilíferos, se encuentra asintomático y su radiografía de tórax no muestra alteraciones, se solicita un PPD que resulta en 23 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar tratamiento antibiótico con isoniazida, pirazinamida, rifampicina y etambutol por 6 meses
- b) Repetir PPD en un mes
- c) Dar de alta y control en caso de síntomas
- d) Solicitar reacción en cadena de polimerasa para mycobacterium tuberculosis en lavado bronquioloalveolar
- e) Indicar isoniazida por 6 meses

22) ¿Cuál de las siguientes sustancias es una causa frecuente de asma pulmonar por exposición laboral?

- a) Asbesto
- b) Sílice
- c) Harina
- d) Algodón
- e) Carbón

23) Una paciente de 24 años, que hace 1 semana inicia cuadro de fiebre, dolores osteoarticulares, ictericia. Como antecedente, hace tres semanas regresó de un viaje al Caribe. Se solicitan exámenes que muestran GOT: 1.210 UI/L, GPT: 1.120 UI/L, bilirrubina de 12 mg/dL. El examen inicial para el diagnóstico etiológico es:

- a) IgG anti VHA
- b) Anticuerpos anti VHC
- c) Ag VHBs
- d) IgM VHA
- e) Anticuerpos antinucleares

24) Una paciente de 27 años, con antecedente de soplo en la infancia, consulta por astenia y disnea que aparece con medianos esfuerzos. Al examen físico presenta edema de extremidades inferiores, ritmo regular en dos tiempos con soplo sistólico intenso asociado a segundo ruido desdoblado permanente, murmullo pulmonar disminuido en bases con crépitos bilaterales. Su electrocardiograma muestra arritmia completa por fibrilación auricular y bloqueo completa de la rama de His.

- a) Comunicación interventricular
- b) Comunicación interauricular
- c) Estenosis mitral
- d) Estenosis aórtica
- e) Conducto arterioso persistente

25) Una paciente de 68 años, hipertensa de larga data, consulta por disnea de pequeños esfuerzos, fatigabilidad y palpitaciones irregulares. Al examen físico, su presión arterial es de 100/60 mmHg con frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, irregular, además, presenta ingurgitación yugular y crépitos pulmonares bilaterales. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a continuación:

INSERTAR FOTO

¿Qué fármaco está contraindicado en esta paciente?

- a) Verapamilo
- b) Amiodarona
- c) Lanantósido C
- d) Heparina
- e) Digoxina

26) Una paciente de 67 años, con antecedente de várices en las piernas con indicación de cirugía, presenta rotura de una de las várices, luego de un traumatismo en la pierna derecha, que produce sangramiento abundante. Al examen tiene FC: 80 latidos por minuto, PA: 120/80 mmHg y se aprecia sangrado profuso del várice roto, en el tercio medio de la pierna. ¿Cuál es el tratamiento inicial?

- a) Torniquete inframaleolar
- b) Ligadura del cayado de la safena interna
- c) Sutura del várice sangrante
- d) Escleroterapia variceal
- e) Safenectomía de urgencia

27) Un niño de 2 años presenta tos de 3 días de evolución, asociado a odinofagia y fiebre de 38 grados Celsius. Al examen físico presenta congestión y eritema de la faringe y las amígdalas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Ibuprofeno oral
- b) Amoxicilina oral
- c) Azitromicina oral
- d) Aciclovir oral
- e) Oseltamivir oral

28) Una paciente de 20 años, que desde los siete años presenta epistaxis frecuente y equimosis ante pequeños traumatismos, desde los 14 años tiene su menarquía con sangrado menstrual abundantes. Se solicita hemograma que muestra hematocrito 45%, VCM: 90fl, leucocitos 6.000/mm³, plaquetas 2.5000/mm³, TTPK normal, protrombinemia 85%, tiempo de sangría mayor a 8 minutos. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir con el estudio en este caso?

- a) Mielograma
- b) Citometría de flujo para receptor de la proteína IIbIIIa
- c) Estudio de enfermedad de Von Willebrand
- d) Niveles plasmáticos de factor VIII y factor IX de la coagulación
- e) Electroforesis de proteína en sangre

29) Se realiza un estudio de casos y controles que busca establecer la asociación entre el uso de anticonceptivos orales y cáncer. Luego de analizar los datos se obtiene que el Odds Ratio 1,3 con intervalo de confianza al 95% con valores entre 0,86 y 2,1. Con estos resultados se puede afirmar que:

- a) Existe una relación positiva entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer
- b) Existe una relación positiva entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer, pero que no es estadísticamente significativa
- c) Existe una asociación entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer, pero este resultado no es extrapolable a otras poblaciones
- d) Las personas que tienen cáncer consumen un 30% más de anticonceptivos orales
- e) Las personas que usan anticonceptivos orales, tienen 1,3 veces más riesgo de desarrollar cáncer.

30) Un paciente de 24 años, cursando un embarazo de 8 semanas, consulta por leucorrea y molestias genitales. Se realiza una especuloscopia, que se muestra a continuación:

INSERTAR FOTO

El tratamiento de elección es:

- a) Metronidazol oral
- b) Clotrimazol tópico
- c) Tinidazol oral
- d) Fluconazol oral
- e) Azitromicina oral

31) Un lactante de 5 meses presenta opacidad corneal bilateral, asociado a epifora y aumento del diámetro corneal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Retinoblastoma
- b) Macrocornea
- c) Glaucoma congénito
- d) Atresia lagrimal
- e) Catarata congénita

32) Se realiza un estudio en el que se busca la asociación entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de hipertensión arterial, el cual concluye que existe mayor desarrollo de hipertensión arterial en pacientes que utilizaban anticonceptivos orales. Sin embargo, las pacientes que recibieron anticonceptivos orales fueron controladas 3 veces más que las pacientes que no recibieron esta intervención. ¿Qué sesgo se encuentra presente en el estudio descrito?

- a) Sesgo de selección
- b) Sesgo de notificación
- c) Sesgo de exclusión
- d) Sesgo de vigilancia
- e) Sesgo del evaluador

33) Un lactante de 18 meses de edad, presenta una convulsión tónico-clónica de 3 minutos de duración. Al examen físico está afebril, sin alteraciones en el examen segmentario. ¿Cuál es el tratamiento de la crisis?

- a) Diazepam
- b) Ácido valproico
- c) Fenitoína
- d) Carbamazepina
- e) Topiramato

34) Un paciente de 65 años, es traído por su señora, dado que presenta dificultades en sus actividades de la vida diaria. Ella refiere que ha estado repetitivo con errores en el manejo del dinero, así como dificultad para realizar actividades que normalmente realizaba sin problemas. El niega estos síntomas. Al examen físico presenta frecuencia cardíaca 68 latidos por minutos, con presión arterial de 130/85 mmHg, sin alteraciones en el examen segmentario, ni signos de focalidad neurológica. El diagnóstico más probable es:

- a) Delirium
- b) Demencia vascular
- c) Depresión del adulto mayor
- d) Demencia tipo Alzheimer
- e) Demencia por cuerpos de Lewi

35) Un paciente de 60 años, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 y tabaquismo de 50 paquetes año, consulta por dolor precordial opresivo y durante la anamnesis presenta compromiso de conciencia, sin respuesta. Al examen no respira y es imposible palpar el pulso carotídeo. Además de solicitar ayuda, la conducta más adecuada es:

- a) Realizar compresiones torácicas
- b) Realizar intubación orotraqueal
- c) Dar golpe torácico
- d) Administrar adrenalina intracardiaca
- e) Realizar angioplastia de urgencia

36) Un niño de 7 años presenta olor axilar, vello púbico en Tanner 2, testículos de 2 cc de volumen. Se solicita radiografía de mano, que muestra edad ósea acorde con la edad cronológica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tumor suprarrenal
- b) Pubertad precoz central
- c) Pubertad precoz periférica
- d) Hiperplasia suprarrenal congénita
- e) Adrenarquia normal

37) Una paciente de 30 años, con antecedente de parto hace 3 meses y que está en lactancia materna exclusiva, consulta por dispareunia intensa. Al examen físico se aprecia la mucosa vaginal pálida y muy seca. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antimicóticos orales
- b) Iniciar metronidazol oral
- c) Iniciar anticonceptivos combinados orales

- d) Iniciar ceftriaxona intramuscular más azitromicina oral
- e) Indicar lubricante genital

38) Un paciente de 27 años, con historia de pirosis y regurgitación de algunos meses de evolución, siendo diagnosticado de reflujo gastroesofágico. Se indican cambios en los hábitos alimentarios y omeprazol a razón de 20 mg al día y se controla un mes después con endoscopia digestiva alta que demuestra esofagitis distal severa y test de ureasa (+). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Agregar prokinéticos
- b) Agregar antiácidos
- c) Duplicar la dosis de omeprazol
- d) Erradicar *Helicobacter Pylori*
- e) Tratamiento quirúrgico

39) Un lactante de 5 días de vida, alimentado con lactancia materna exclusiva, presenta ictericia en la cara y el tronco, que inició hace 2 días. Se solicita bilirrubina plasmática, que resulta 10 mg/dl, bilirrubina directa de 0,3 mg/dl, hematocrito de 56%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hepatitis neonatal
- b) Atresia biliar primaria
- c) Ictericia fisiológica
- d) Ictericia hemolítica
- e) Ictericia por leche materna

40) Un paciente de 35 años, consulta por cuadro de 5 semanas de tos irritativa y expectoración que ha ido empeorando, agregándose disnea importante. Al examen físico se aprecia enflaquecido, con frecuencia respiratoria de 35 por minuto, frecuencia cardíaca de 92 por minuto, presión arterial de 100/70mmHg y saturación de 93% con FiO2 ambiental. Examen pulmonar muestra crepitaciones, estertores y algunas sibilancias bilaterales. Se solicita radiografía que se muestra a continuación:

INSERTAR FOTO

El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa
- b) Bronquitis chlamydia trachomatis
- c) Tuberculosis pulmonar
- d) Neumonía por mycoplasma
- e) Neumonía por pneumocystis jiroveci

41) Un paciente de 85 años presenta APE de 7,5 ng/ml. Está asintomático y no tiene antecedente de infecciones urinarias. Su tacto rectal demuestra una próstata sin nódulos,

de tamaño normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cintigrafía ósea
- b) Realizar TAC de pelvis
- c) Realizar RMN de pelvis
- d) Realizar biopsia prostática
- e) Iniciar finasteride oral

42) Una paciente de 56 años, en terapia de remplazo hormonal combinada oral, desde hace 5 años, presenta metrorragia de 3 días de evolución, escasa. Su examen físico no tiene alteraciones y en la especuloscopia se aprecian restos de sangre en el orificio cervical externo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Atrofia endometrial
- b) Pólipo endometrial
- c) Hiperplasia endometrial
- d) Cáncer de endometrio
- e) Metrorragia disfuncional

43) Una pareja consulta por infertilidad de 2 años de evolución. Ella no tiene antecedentes de importancia y tanto su examen físico, como exploración ginecológica son normales. Él realiza ciclismo de montaña y en su examen físico se constatan testículos de tamaño pequeño, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el primer examen para evaluarlo?

- a) Espermiograma
- b) Ecografía testicular
- c) Niveles plasmáticos de LH, FSH y testosterona
- d) Niveles plasmáticos de TSH, prolactina
- e) Biopsia testicular

44) Un paciente de 40 años consulta por hiperqueratosis y cambio de coloración de las uñas de los ortejos, de algunos meses de evolución. Se realiza estudio micológico, que muestra presencia de *Trichophyton rubrum*. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Itraconazol
- b) Griseofulvina
- c) Fluconazol
- d) Terbinafina
- e) Clotrimazol

45) Un niño de 4 años presenta un cuadro de fiebre hasta 39,5 grados, asociada a tos con expectoración mucopurulenta, de 2 días de evolución. Además refiere cefalea y marcado malestar general. Al examen físico está decaído, febril, con FC:100x', RR2T, sin soplos, examen pulmonar con presencia crepitaciones localizadas en la zona superior

del campo pulmonar derecho. Se realiza radiografía de tórax, que se muestra a continuación:

INSERTAR FOTO

¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) *Mycoplasma pneumoniae*
- b) *Chlamydia pneumoniae*
- c) *Streptococcus pneumoniae*
- d) *Haemophilus influenzae*
- e) *Staphylococcus aureus*

46) Un paciente de 62 años, con antecedentes de dislipidemia y diabetes en tratamiento con dieta e hipoglicemiantes orales, consulta por dolor torácico opresivo irradiado a ambos hombros intenso EVA 9/10, asociado a disnea y sudoración. Al examen físico, su presión arterial es 140/70 mmHg con frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. Presenta RR3T con presencia de R3, murmullo pulmonar presente con crépitos bibasales. Electrocardiograma: SDST en V1-V4. La conducta más adecuada es:

- a) Tratamiento anticoagulante
- b) Tratamiento antiplaquetario
- c) Solicitar AngioTAC de tórax
- d) Ecocardiograma bidimensional
- e) Coronariografía de urgencia

47) Una paciente de 30 años, diabética tipo 1, con historia de 5 hospitalizaciones en el último año por cuadros de hipoglicemia severa. Actualmente ingresa en shock hipoglucémico, el que es manejado adecuadamente. Durante su hospitalización, es sorprendida en el baño inyectándose una dosis de insulina que no le correspondía, lo cual ella posteriormente niega. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno disociativo
- b) Trastorno somatomorfo
- c) Trastorno hipocondríaco
- d) Trastorno por simulación
- e) Trastorno facticio

48) Un niño de 7 años, respirador bucal es traído por su madre. No presenta apnea del sueño, ni infecciones a repetición. Al examen físico, no tiene obstrucción nasal y se observa faringe con amígdalas grado II. Se solicita radiografía de cavum, que constata hipertrofia adenoidea, con 80% de obstrucción. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Desloratadina oral
- b) Fluticasona intranasal
- c) Adenoidectomía

d) Observar evolución y controlar ambulatoriamente

e) Solicitar TAC de cavidades paranasales

49) Una paciente de 81 años, multípara de 3, histerectomizada, inicia escapes de orina de esfuerzos hace 5 años y además, desde hace 2 años tiene escapes de urgencia. No tiene antecedente de infecciones urinarias, ni hematuria. Al examen físico se aprecia un grado leve de prolapso genital. Se realiza sedimento de orina con 4-5 leucocitos por campo y 2-3 hematíes por campo, sin bacterias y se realiza un urocultivo, que resulta negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Realizar tratamiento quirúrgico del prolapso

b) Indicar ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico

c) Iniciar anticolinérgicos

d) Iniciar alfabloqueadores adrenérgicos

e) Solicitar ecografía abdomino-pélvica

50) Un paciente de 30 años, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de rinorrea, tos y disfonía, a lo que se agregó hematuria. Al examen físico presenta frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, con presión arterial 150/100 mmHg, edema blando de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes entre los que destaca sedimento de orina con 15 leucocitos por campo más incontables eritrocitos con 9% de dismorfia, proteinuria de 24 horas de 2 gramos y creatinina de 1,7mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Glomerulonefritis post estreptocócica

b) Nefropatía por depósitos de IgA

c) Litiasis renal

d) Pielonefritis aguda

e) Lupus eritematoso sistémico

51) Un paciente con antecedente de daño hepático crónico por consumo de alcohol, bebedor activo, que toma 1 botella de vino al día, sin emborracharse, es ingresado al hospital. Evoluciona con malestar general, ansiedad y luego desorientación, asociada a alucinaciones zoomorfas de pequeños animales que lo atacan. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

a) Haloperidol

b) Lorazepam

c) Tiamina

d) Carbamacepina

e) Setralina

52) Un paciente con antecedente de EPOC, fumador de 25 paquetes año, consulta por cuadro de tres días de evolución de exacerbación de su disnea basal y expectoración mucosa, asociado a sensación febril y hace un día se agrega dolor tipo puntada de costado. Al examen se aprecia frecuencia respiratoria de 21 por minuto, frecuencia cardíaca de 92 por minuto, temperatura de 38,1°C. Al examen pulmonar presenta crepitaciones de la cara lateral del hemitórax derecho, asociado a matidez a la percusión. Se solicita una radiografía que se muestra a continuación:

INSERTAR FOTO

El diagnóstico más probable:

- a) Tuberculosis
- b) Derrame pleural
- c) Neumonía
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Cáncer bronquial

53) Una mujer de 17 años presenta traumatismo en la rodilla izquierda, siendo diagnosticada de esguince de rodilla, el que se maneja con reposo y antiinflamatorios. Evoluciona con dolor persistente, por lo que consulta nuevamente. Se solicita una radiografía de rodilla que muestra reacción perióstica y compromiso de partes blandas. El diagnóstico más probable es:

- a) Osteomielitis del fémur distal
- b) Osteosarcoma osteogénico
- c) Fractura del fémur distal, con callo óseo
- d) Osteocondroma
- e) Hematoma en organización

54) Un paciente de 54 años consulta por dolor anal, que se presenta al defecar, persistiendo por algunos minutos luego de la defecación. En algunas ocasiones además ha presentado sangre en las deposiciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hemorroide externo trombosado
- b) Cáncer de recto
- c) Fisura anal
- d) Fístula anal
- e) Absceso perianal

55) Un paciente masculino, de 30 años, consulta por disminución del calibre miccional, asociada a disuria de esfuerzo de varios meses de evolución. Tiene antecedente de un trauma perineal hace 3 años atrás. Al examen físico tiene genitales externos normales y su tacto rectal demuestra una próstata pequeña y blanda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cáncer de próstata
- b) Uretritis
- c) Hiperplasia prostática benigna
- d) Estenosis uretral
- e) Urolitiasis

56) Un lactante de 7 meses, con antecedente de haber sido hospitalizado en varias oportunidades por cuadros respiratorios febriles, presenta diarrea de algunos meses de evolución, asociada a esteatorrea y mal incremento ponderal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Enfermedad celíaca
- b) Inmunodeficiencia primaria
- c) Fibrosis quística
- d) Alergia a la proteína de la leche de vaca
- e) Giardiasis intestinal

57) Una paciente, usuaria de DIU hace 7 años, se realiza Papanicolaou como chequeo médico, que muestra presencia de *Actinomyces israeli*, sin otras alteraciones. No refiere síntomas y su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar Papanicolaou en 1 año
- b) Derivar a colposcopia
- c) Realizar ecotomografía pelviana
- d) Retirar el DIU
- e) Iniciar antibióticos orales

58) Una paciente de 52 años, con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento permanente con AINES y prednisona por vía oral y tratamiento intermitente con metotrexate por vía oral, presenta un cuadro de astenia, adinamia y disnea de esfuerzos que ha empeorado en el último tiempo. Se solicitan exámenes en los que destacan una creatinina de 1,6mg/dL, hemograma con hematocrito 29%, hemoglobina 9,7g/dL, plaquetas 147.000/mm³, blancos 4.200/mm³ y al frotis se aprecia microcitosis. Además se solicita perfil de hierro que muestra ferremia de 40ug/dL (60-160 ug/dL) y transferrina de 190mg/dL (240-360mg/dL). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Anemia por enfermedades crónicas
- b) Mielodisplasia
- c) Anemia por insuficiencia renal crónica
- d) Hipoplasia medular
- e) Mieloma múltiple

59) Un paciente de 60 años, que hace tres años se habría realizado una colecistectomía con coledocostomía, consulta por cuadro de dolor abdominal tipo cólico intenso, asociado a vómitos alimentarios. No ha podido eliminar gases. Al examen físico presenta dolor difuso a la palpación abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados en intensidad y tonalidad, con blumberg presente. El diagnóstico más probable es:

- a) Obstrucción intestinal
- b) Trombosis venosa mesentérica
- c) Embolia mesenterica
- d) Pancreatitis
- e) Diverticulitis

60) Un paciente de 65 años, diabético e hipertenso, consulta por dolor precordial opresivo intenso, EVA: 9/10, asociado a malestar general y disnea. Al examen físico con frecuencia cardiaca de 90 por minuto, presión arterial de 150/90 mmHg, al examen cardiaco se ausculta un ritmo regular y tercer ruido. Se realiza estudio con electrocardiograma que muestra supradesnivel del segmento ST en DII, DIII y AVF. Diagnóstico más probable:

- a) Infarto de pared anterior
- b) Infarto de pared inferior
- c) Pericarditis
- d) Infarto de pared posterior
- e) Infarto de pared lateral

61) Un paciente de 50 años, presentó una pelea con su vecino hace 4 meses y desde hace un mes comienza con recuerdos del incidente, asociado a pesadillas recurrentes. En las últimas semanas evita pasar por fuera de la casa de su vecino por miedo, y su familia refiere que se encuentra con ánimo bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno adaptativo
- b) Trastorno de estrés postraumático
- c) Depresión reactiva
- d) Depresión psicótica
- e) Trastorno de ansiedad generalizada

62) Un niño de 3 años presenta diarrea de 3 meses de evolución, intermitente, generalmente acuosa, pero que en ocasiones contiene escasos restos vegetales. Ha subido 600 gramos en ese periodo y su talla es 90 cm. Tiene signos vitales normales, se aprecia hidratado y su examen abdominal muestra un abdomen blando, depresible e indoloro, sin visceromegalia ni otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Diarrea crónica inespecífica
- b) Enfermedad celíaca

- c) Enteropatía perdedora de proteínas
- d) Alergia a la proteína de la leche de vaca
- e) Intolerancia a los disacáridos

63) Un paciente de 70 años consulta por anhedonia, marcada angustia y desconcentración de 2 meses de evolución, asociada a insomnio de conciliación y de despertar precoz y baja de peso de 5 kilogramos. No presenta alteraciones del pensamiento, ni del examen neurológico ¿Cuál es el tratamiento de elección para iniciar el tratamiento en este paciente?

- a) Trazodona
- b) Mirtazapina
- c) Venlafaxina
- d) Fluoxetina
- e) Amitriptilina

64) Un niño de 7 años comienza hace 3 meses con pestañeo frecuente asociado a expresiones faciales como levantar las cejas, a lo que en el último tiempo se agregan movimientos involuntarios de las extremidades superiores, asociados a sacudidas bruscas de la cabeza y en los últimos días además se ha agregado carraspora. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome de Gilles de la Tourette
- b) Trastorno obsesivo
- c) Corea
- d) Enfermedad por tics
- e) Crisis epiléptica parcial

65) Un paciente de 77 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, consulta por dolor abdominal de tipo inespecífico, de 2 meses de evolución, sin otros síntomas. En su examen físico se palpa un tumor abdominal de 4 a 5 cm de diámetro, en la zona umbilical, pulsátil, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trombosis mesentérica
- b) Tumor de colon
- c) Tumor de páncreas
- d) Disección aórtica
- e) Aneurisma aórtico abdominal

66) Paciente de 30 años comienza hace una semana con cuadro de dolor en la espalda y extremidades, a lo que luego se agrega debilidad progresiva que actualmente dificulta la marcha asociado a dificultad para orinar. Al examen físico se constata debilidad de

las cuatro extremidades con abolición de los reflejos osteotendíneos y disminución del tono muscular. Se constata nivel sensitivo a la altura de T4. Su sondaje vesical da salida a 1300 cc de orina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Miastenia gravis
- b) Síndrome de Guillain Barre
- c) Mielitis transversa
- d) Compresión medular torácica
- e) Parálisis hipokalémica episódica

67) Un lactante de 8 meses, presenta un cuadro de malestar general y vómitos alimentarios en varias oportunidades, durante las últimas horas. En el último episodio de vómitos, se agregó escasa hematemesis, por lo que acude al servicio de urgencias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Esofagitis péptica
- b) Esofagitis erosiva
- c) Síndrome de Mallory Weiss
- d) Gastritis erosiva
- e) Gastritis por *Helicobacter pylori*

68) Un paciente se realiza una cirugía abdominal. Usted lo evalúa a las 24 horas y observa que la herida operatoria presenta abundante secreción serohemática, con depresión de la zona central. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hernia umbilical
- b) Eventración
- c) Seroma
- d) Evisceración
- e) Infección de la herida operatoria

69) Un paciente de 84 años consulta por un cuadro de 4 semanas de evolución de desconfianza, asociada a enojo porque quienes viven con él le roban y le cambian sus cosas de lugar, para molestarlo. Hace 1 semana despidió a alguien que había trabajado por 30 años con él, por la misma razón. Al examen se muestra molesto respecto al tema, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Demencia
- b) Paranoia
- c) Delirium
- d) Trastorno delirante
- e) Depresión psicótica

70) Un paciente de 45 años, consulta por fiebre de 3 semanas de evolución sin otros síntomas. Al examen físico tiene temperatura 37,8°C, frecuencia cardiaca de 92 por minuto, con presión arterial 120/80mmHG. Al examen cardiaco se ausulta un soplo sistólico en ápex irradiado a dorso. En sus exámenes destacan leucocitos de 12.000/mm³ y PCR 9,6 (valor normal menor a 1,0). ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?

- a) Ecocardiografía bidimensional
- b) Resonancia magnética cardiaca
- c) Radiografía de tórax
- d) AngioTAC de tórax
- e) TAC de tórax abdomen y pelvis

71) Una paciente de 28 años, cursando un embarazo de 39 semanas inicia trabajo de parto. Al tacto vaginal, tiene feto en cefálica, con cuello borrado, con 8 cm de dilatación y membranas íntegras. Se realiza un registro fetal intraparto, cuyo trazado se muestra a continuación:

INSERTAR FOTO

¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Mantener una conducta expectante
- b) Realizar rotura de membranas
- c) Realizar cesárea de urgencia
- d) Iniciar oxitocina endovenosa
- e) Solicitar perfil biofísico

72) Un recién nacido de 2 semanas es hospitalizado por presentar apneas. La madre refiere tos de 3 semanas de evolución, en crisis, que en ocasiones la hacen vomitar. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado?

- a) Amoxicicilina
- b) Azitromicina
- c) Ceftriaxona
- d) Oseltamivir
- e) Aciclovir

73) Un paciente de 40 años, con antecedente de colecistectomía laparoscópica hace un año por colelitiasis, consulta por cuadro de 24 horas de dolor abdominal asociado a vómitos e ictericia. Su perfil hepático muestra GOT: 42UI/L, FA: 450mg/dL, bilirrubina total es de 10,3mg/dL, con bilirrubina directa de 9,5 mg/dL. Se realiza una ecografía abdominal que muestra dilatación de la vía biliar principal, sin visualización de cálculos. El examen de elección para continuar el estudio es:

- a) Colangioresonancia
- b) Colangiografía endoscópica

- c) TAC de abdomen y pelvis
- d) Exploración quirúrgica
- e) Marcadores tumorales

74) Una paciente de 28 años, consulta por artralgias generalizadas, asociadas a sensación febril y úlceras orales. En sus exámenes destaca creatinina: 1,5 mg/dl, sedimento de orina con hematuria y cilindros hemáticos y hemograma con 4.000 blancos por mm³. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

- a) Solicitar factor reumatoide
- b) Solicitar radiografía de tórax
- c) Solicitar PCR, VHS y creatinfosfoquinasa
- d) Solicitar anticuerpos antinucleares
- e) Solicitar anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos

75) Un niño de 2 años presenta un cuadro de 7 días de fiebre hasta 39 grados, asociado a inyección conjuntival y boca roja con labios partidos, a lo que se agrega un exantema eritematoso generalizado. Al examen, se aprecia decaído, con fiebre de 38,8 grados, presenta adenopatías cervicales y se observa descamación gruesa de los dedos de las 4 extremidades. Se encuentra hospitalizado, recibiendo un tratamiento adecuado. ¿Cuál es la evolución más probable en este paciente?

- a) Daño permanente de las arterias coronarias
- b) Recurrencia esporádica de los síntomas
- c) Resolución completa, sin secuelas
- d) Daño vascular periférico generalizado
- e) Daño a las válvulas cardíacas

76) Paciente de 45 años, fumadora activa de 40 paquetes año, consulta por tos irritativa asociada a disnea y crisis de sibilancias que aparecen en relación a la actividad física e infecciones respiratorias. Se realiza una espirometría que muestra:

Basal:

VEF1/CVF: 62%

VEF1: 2,4L (62% del valor teórico)

CVF: 4,9L (92% del valor teórico)

Post-Salbutamol

VEF1/CVF: 74%

VEF1: 3,6L (89% del valor teórico)

CVF: 5,0L (95% del valor teórico)

El diagnóstico más probable es:

- a) Asma
- b) EPOC
- c) Fibrosis pulmonar
- d) Bronquiectasias
- e) Bronquitis crónica

77) Un niño de 10 años convulsiona a la mañana siguiente, de haber trasnochado jugando videojuegos. Además refiere mioclonías matinales frecuentes, desde hace algunos meses. Su examen físico es normal, al igual que su examen neurológico. ¿Cuál es la medida más adecuada?

- a) Prohibir por completo los videojuegos
- b) Iniciar ácido valproico
- c) Iniciar carbamazepina
- d) Iniciar fenobarbital
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro

78) Paciente de 63 años, con antecedente de hipernefroma operado hace un año, con buena evolución, consulta por cuadro de astenia y debilidad de 7 días, controlándose exámenes de sangre entre los que destaca calcemia de 11,8 mg/dL (valor normal 8,5-10,5 mg/dL), albúmina normal. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de este paciente?

- a) Cintigrafía ósea
- b) Niveles plasmáticos de calcio y paratohormona
- c) TAC de abdomen y pelvis
- d) Niveles plasmáticos de vitamina D
- e) Resonancia magnética de abdomen y pelvis

79) Un niño de 2 años y 8 meses realiza rabietas con frecuencia, se tira al suelo y grita cuando no se hace lo que él quiere, lo que ha pasado frente a sus padres y las profesoras del jardín infantil. Dice 300 palabras y su desarrollo motor es acorde a su edad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno oposicionista desafiante
- b) Trastorno de conducta
- c) Trastorno por déficit atencional
- d) Trastorno generalizado del desarrollo
- e) Oposicionismo normal para su desarrollo

80) Una paciente de 58 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril, consulta por disnea de esfuerzo que ha empeorado en el último tiempo

siendo actualmente de mínimos esfuerzos, presentando además edema de extremidades inferiores. Refiere expectoración rosada en algunas oportunidades. Al examen físico se palpa choque de la punta en el 5° espacio intercostal a la altura de la línea media clavicular. La auscultación cardíaca muestra un soplo diastólico de tonalidad ruda, su frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto, irregular. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis mitral
- b) Estenosis aórtica
- c) Miocardiopatía hipertrófica
- d) Insuficiencia aórtica
- e) Cardiopatía hipertensiva

81) Un paciente de 65 años, consulta por fiebre y cefalea de 3 días de evolución, a lo que luego se agrega desorientación. Al examen físico se aprecia confuso, con temperatura 38,5 grados Celsius, FC: 95x' y PA: 110/70 mmHg. En su examen neurológico se aprecia rigidez de nuca, por lo que realiza punción lumbar, que da salida a un líquido cefalorraquídeo con 610 células por mm³, con 90% de polimorfonucleares, glucosa: 26 mg/dl y proteínas 123 mg/dl. Además, la tinción de Gram muestra visualización de diplococos gramnegativos. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a) Ceftriaxona endovenosa
- b) Cloxacilina endovenosa
- c) Vancomicina endovenosa
- d) Imipenem endovenoso
- e) Ciprofloxacino oral

82) ¿Cuál de las siguientes actividades o medidas, está relacionado con el principio de calidad de las garantías explícitas de salud (GES)?:

- a) Autorización sanitaria de prestadores y laboratorios
- b) Certificación por parte de la superintendencia de los prestadores de salud
- c) Vigilancia del cumplimiento de plazos
- d) Convenios entre ISAPRES y prestadores de salud
- e) Vigilancia epidemiológica

83) Una paciente de 21 años, consulta por cuadro de algunos días de evolución de astenia, compromiso del estado general y disnea progresiva que actualmente es de mínimos esfuerzos, además ha presentado hematuria. Al examen físico su frecuencia cardíaca es 75 por minuto, con presión arterial 180/110 mmHg. Se aprecia edema facial y de extremidades inferiores, con signo de la fovea. Su examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en tres tiempos con presencia de R3 y se auscultan crépitos pulmonares bilaterales, mayores en ambas bases. Se solicitan exámenes que muestran hematuria dismór-

fica, ANA (-), ANCA (-), ASO: 6 veces por sobre el valor normal, creatinina de 1,5mg/dL.

¿Cuál es el tratamiento inicial para esta paciente?

- a) Prednisona vía oral
- b) Furosemida endovenosa
- c) Bisoprolol vía oral
- d) Captopril vía oral
- e) Amoxicilina vía oral

84) Un paciente de 62 años presenta tendencia a la somnolencia, asociado a dificultad para realizar movimientos con la mitad derecha del cuerpo, que inició hace 2 horas. Al examen físico se aprecia un paciente confuso con una hemiparesia braquicrural derecha, parálisis del tercer par izquierdo y signo de Babinski bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Infarto de arteria cerebral media derecha
- b) Infarto de arteria cerebral media izquierda
- c) Infarto de tronco-encéfalo
- d) Síndrome de enclavamiento
- e) Infarto vertebro-basilar

85) Una paciente de 60 años, menopáusica desde los 50 años, consulta por metrorragia de 7 días de evolución. Al examen ginecológico se observa que la metrorragia proviene de la cavidad uterina. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

- a) Ecografía transvaginal
- b) Histerosalpingografía
- c) TAC de pelvis
- d) Resonancia magnética de pelvis
- e) Marcadores tumorales en sangre

86) Un niño de 8 años presenta una lesión en la cara lateral del primero ortejo derecho. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada, hiperqueratósica, con puntos negros en su superficie, la que se muestra en la siguiente imagen:

INSERTAR FOTO

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Queratosis seborreica
- b) Melanoma
- c) Panadizo
- d) Verruga vulgar
- e) Cuerpo extraño periungueal

87) ¿Cuál es el mejor diseño de estudio epidemiológico que entrega evidencia de mayor calidad, para buscar la asociación entre una exposición y una enfermedad en una población?

- a) Estudio de serie de casos
- b) Estudio de series temporales
- c) Estudio de casos y controles
- d) Estudio de cohorte
- e) Estudio clínico no randomizado

88) Una paciente de 22 años, acude a su primer control de un embarazo de 8 semanas. Entre sus exámenes trae un VDRL que resultó negativo, hematocrito de 39% y glicemia de ayuno de 112 mg/dL. Su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
- b) Iniciar hipoglicemiantes orales
- c) Repetir glicemia de ayuno
- d) Solicitar insulínemia basal
- e) Mantener el control embarazo normal

89) Una paciente de 14 años, con menarquia a los 13 años, presenta ciclos menstruales que varían entre 26 y 35 días. Su examen físico es normal y no refiere otros síntomas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar anticonceptivos orales
- b) Iniciar estrógenos solos por vía oral
- c) Iniciar progestágenos solos por vía oral
- d) Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, progesterona, LH y FSH
- e) Controlar ambulatoriamente con calendario menstrual

90) Un paciente obeso, con antecedente de hígado graso. Luego de una trasgresión alimentaria con abundante consumo de alcohol, presenta cuadro de dolor epigástrico irradiado a ambos costados, asociado a vómitos alimentarios, sensación febril e ictericia. Al examen físico, su presión arterial es de 110/70mmHg, con frecuencia cardíaca 100 por minuto, y al examen abdominal presenta dolor a la palpación de forma difusa, con abolición de ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

- a) Isquemia mesentérica
- b) Colangitis
- c) Pancreatitis
- d) Colecistitis
- e) Coledocolitiasis

SEGUNDA PARTE

91) Una mujer cursando un embarazo de 27 semanas, presenta dinámica uterina persistente y dolorosa, asociada a fiebre hasta 38 grados. Al examen físico tiene temperatura 37,8 grados Celsius, FC: 80x', PA: 120/80 mmHg y 4 contracciones uterinas cada 10 minutos, que persisten, a pesar de administrar nifedipino oral. Sus exámenes de sangre demuestran PCR: 25 ng/ml (VN: menor a 10 ng/ml) y hemograma con 12.000 glóbulos blancos por mm³. El monitoreo fetal es tranquilizador. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Interrumpir el embarazo
- b) Administrar fenoterol
- c) Administrar atosiban
- d) Realizar amniocentesis
- e) Iniciar antibióticos

92) Un paciente de 62 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo dos y de daño hepático crónico secundario a una esteatohepatitis no alcohólica, ha presentado hospitalizaciones por cuadros de hemorragia digestiva alta en el último año, actualmente controlado. Se realizan exámenes de control en que se demuestra fosfatasas alcalinas de 565 UI/L, GOT: 186 UI/L GPT: 172 UI/L, bilirrubina total 4,2mg/dL, alfafetoproteína: 119 ng/mL. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio de este paciente?

- a) Endoscopia digestiva alta
- b) Ecografía abdominal
- c) TAC abdominal
- d) Gammaglutamil transferasa
- e) Colangiografía resonancia

93) Una paciente de 45 años, hipertensa, se detecta un nódulo mamario, por lo que se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 4. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar mamografía en un año
- b) Solicitar ecografía mamaria
- c) Solicitar resonancia nuclear magnética de mamas
- d) Realizar biopsia por punción
- e) Realizar mastectomía parcial

94) Un paciente 67 años, diabético en tratamiento con metformina 1,5 gramos al día, consulta por edema de extremidades inferiores asociado a orinas espumosas. Al examen físico se constata edema blando de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes entre los que destaca una glicemia de ayuno de 215mg/dL, hemoglobina glicosilada de 12,5%, creatininemia 1,2mg/dL, proteinuria +++ y albuminemia 3,0g/dL. La conducta

más adecuada es:

- a) Aumentar dosis de metformina
- b) Iniciar insulina NPH
- c) Reemplazar la metformina por glimepiride
- d) Agregar glibenclamida al tratamiento
- e) Reemplazar la metformina por insulina cristalina

95) Una paciente de 81 años, hace un año tiene la idea de padecer de VIH, por lo que se ha realizado múltiples exámenes, los que siempre han resultado negativo. A pesar de ello, ella continúa con la idea. Fuera de esto, su vida no ha sido mayormente afectada. El diagnóstico más probable es:

- a) Demencia
- b) Trastorno obsesivo compulsivo
- c) Trastorno delirante crónica
- d) Trastorno por hipocondría
- e) Depresión psicótica

96) Un paciente de 66 años, hipertenso, cardiópata, en tratamiento anticoagulante por una fibrilación auricular crónica, consulta por dolor abdominal brusco, muy intenso, de 6 horas de evolución. Al examen físico presenta ritmo irregular en 2 tiempos y abdomen doloroso a la palpación, con signos peritoneales difusos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trombosis de la vena mesentérica
- b) Hemoperitoneo
- c) Úlcera péptica perforada
- d) Embolia mesentérica
- e) Aneurisma aórtico abdominal roto

97) Un paciente de 19 años consulta por dolor en el testículo izquierdo, de inicio brusco y que se ha asociado a vómitos y malestar general. Al examen físico se aprecia testículo izquierdo edematoso, muy doloroso y ascendido. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar exploración quirúrgica escrotal
- b) Realizar ecografía doppler testicular
- c) Realizar pielotAC
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- e) Indicar reposo y analgésicos

98) Una paciente de 37 años, multipara de 1, cesarizada anterior, presenta un nuevo embarazo de término. Ingres a la sala de parto, por contracciones uterinas dolorosas. Al examen tiene 3-4 contracciones uterinas cada 10 minutos y tacto vaginal con di-

latación completa, feto en cefálica con la cabeza en el segundo plano. Durante los minutos siguientes, se produce metrorragia y aumento del dolor. Al examen el útero es difícil de palpar y el monitoreo fetal resulta tipo III, con latidos fetales que se auscultan a 60 por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Placenta previa
- b) Procidencia de cordón
- c) Rotura uterina
- d) Rotura de vasa previa
- e) Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera

99) Un paciente de 70 años, consulta por cuadro de 6 meses de evolución caracterizado por tos con expectoración mucosa que en ocasiones es purulenta y baja de peso, asociado a compromiso del estado general, sensación febril ocasional y fatigabilidad. Se le solicita perfil hemático que muestra hematocrito de 32%, leucocitos 12.000/mm³.

Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación:

INSERTAR FOTO

La conducta más adecuada para proseguir con el estudio es:

- a) Realizar broncoscopía
- b) Solicitar baciloscopías de expectoración con cultivo de Koch
- c) Solicitar TAC de tórax
- d) Solicitar angioTAC de tórax
- e) Solicitar cultivo de expectoración

100) Un recién nacido de 20 días de vida presenta ginecomastia bilateral. Se palpa tejido mamario de 1,5 cm en cada mama, de consistencia firme. El resto del examen físico es normal y ha subido adecuadamente de peso. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar niveles plasmáticos de prolactina
- b) Solicitar niveles de estrógenos, progesterona, LH y FSH
- c) Solicitar ecografía mamaria
- d) Realizar biopsia
- e) Observar y controlar ambulatoriamente

101) Una paciente de 70 años consulta por un cuadro de dolor abdominal y sensación febril, de 6 horas de evolución, a lo que se ha agregado ictericia. Al examen físico presenta FC: 87x', PA. 90/60 mmHg, temperatura: 38,5 grados Celsius. Al examen abdominal tiene intenso dolor a la palpación epigástrica, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Coledocolitiasis
- b) Colangitis aguda
- c) Pancreatitis aguda

- d) Colecistitis aguda
- e) Hepatitis aguda

102) Paciente de 45 años, trabajador de una fábrica textil, sufre un accidente, resultado con atrición del brazo, en una de las máquinas, mientras se encontraba trabajando. ¿Quién cubre los gastos médicos de este paciente?

- a) El empleador
- b) 50% por parte de FONASA y 50% por parte del trabajador
- c) La institución de Salud Previsional
- d) La Mutual de Seguridad
- e) El Estado

103) Un niño de 12 meses recibe sus vacunas, según el Plan Nacional de Inmunizaciones, más una dosis de la vacuna pentavalente, que estaba atrasada. Diez días después, presenta fiebre hasta 38 grados Celsius. ¿Qué vacuna es la responsable de la fiebre, con mayor probabilidad?

- a) Antimeningocócica
- b) Antineumocócica
- c) Trivírica
- d) Pertusis
- e) Anti-Haemophilus

104) Una paciente de 58 años, con antecedente de cáncer de mama, tratado con cirugía y radioterapia hace un año, consulta astenia y debilidad de las 4 extremidades. Al examen físico presenta edema y eritema palpebral, asociado a aumento de volumen en el brazo derecho. Al examen neurológico se constata la tetraparesia, con reflejos osteotendíneos normales, sin alteraciones en el tono muscular, ni signos focales. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Guillain Barré
- b) Miastenia gravis
- c) Polimialgia reumática
- d) Dermatomiositis
- e) Vasculitis

105) Un paciente de 59 años, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con metformina 850mg dos veces al día y glibenclamida 5mg cada 12 horas, se realiza exámenes de control entre los que destaca una creatinina de 1,0 mg/dL y una hemoglobina glicosilada de 6,9%. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Suspender la glibenclamida

- b) Aumentar dosis de glibenclamida
- c) Suspender metformina
- d) Aumentar dosis de metformina
- e) Mantener el tratamiento sin cambios

106) Una paciente de 30 años presenta una caída, con erosión de la rodilla derecha. Usted la evalúa 3 días después, observándose una zona eritematosa que rodea la herida, de 10 cm de diámetro y bordes parcialmente definidos. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Curación con suero fisiológico y cobertura con apósito
- b) Curaciones con povidona yodada
- c) Mupirocina tópica
- d) Amoxicilina oral por 7 días
- e) Cefadroxilo oral por 7 días

107) Una paciente de 31 años, con antecedente de parto hace 3 meses, consulta por un cuadro de diarrea de dos meses de evolución de tipo acuoso que ha empeorado en los últimos días, no ha presentado fiebre ni sangre en sus deposiciones. En su examen físico presenta dolor difuso a la palpación abdominal y meteorismo. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad celiaca
- b) Colitis ulcerosa
- c) Diarrea nosocomial
- d) Enteroparasitosis
- e) Diarrea crónica funcional

108) Un niño de 4 años, hace 24 horas ingiere 7 comprimidos de algún medicamento desconocido, evolucionando con malestar general, vómitos e ictericia. Se solicitan exámenes, en los que destaca GOT: 403 UI/L, GPT: 390 UI/L, bilirrubina plasmática total: 5,2 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar L-carnitina endovenosa
- b) Administrar deferoxamina endovenosa
- c) Administrar N-acetil-cisteína endovenosa
- d) Administrar carbón activado vía oral
- e) Administrar piridoxina vía oral

109) Una niña de 4 años presenta sinequia vulvar parcial, de los labios menores. No tiene desarrollo puberal, ni antecedentes de infecciones urinarias, ni genitales. El resto de su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar lavados con ácido acéticos

- b) Aplicar corticoides tópicos
- c) Remover las sinequias de manera quirúrgica
- d) Indicar antibióticos
- e) Realizar aseo y masajes en la zona

110) Adulto mayor de 81 años, consulta por pérdida de conciencia súbita con recuperación ad integrum. Al examen físico, presión arterial de 140/90 mmHg, con frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, soplo sistólico eyectivo irradiado al cuello y choque de la punta se palpa en el quinto espacio intercostal. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Miocardiopatía dilatada
- c) Miocardiopatía hipertrófica
- d) Enfermedad coronaria con afectación del sistema excito-conductor
- e) Tromboembolismo pulmonar

111) Usted controla a una niña de 7 meses de edad, con antecedente de síndrome de Down, con infecciones respiratorias en múltiples ocasiones que han requerido hospitalización y que aún no ha podido duplicar el peso de nacimiento. Al examen físico se ausculta ritmo regular en dos tonos, con soplo holosistólico intenso, irradiado a dorso, asociado a un desdoblamiento del segundo ruido. El diagnóstico más probable es:

- a) Comunicación interauricular tipo ostium secundum
- b) Canal auriculoventricular
- c) Atresia tricuspídea
- d) Ductus arterioso persistente
- e) Comunicación interventricular

112) Un paciente de 68 años, con antecedente de EPOC, fumador de 30 paquetes año, consulta por cuadro de 3 días de hemoptisis escasa, asociada a dificultad respiratoria. Tiene antecedente de hernioplastía hace 7 días. Al examen físico su frecuencia cardíaca es de 100 por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto, presión arterial 120/80mmHg, saturación arterial 95% con FiO₂ ambiental. Su examen pulmonar muestra murmullo presente bilateral con escasas sibilancias. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con su estudio?

- a) TAC de tórax
- b) Cintigrafía V/Q
- c) Angiografía pulmonar
- d) Ecocardiograma
- e) AngioTAC de tórax

113) Una paciente de 41 años, cursando un embarazo de 13 semanas, se realiza una ecografía transvaginal, que muestra regurgitación tricuspídea, con presencia de hueso nasal, ductus venoso normal y translucencia nucal de 1,9 mm (VN: menor a 3 mm). ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

- a) Análisis genético de vellosidad corial
- b) Amniocentesis biopsica
- c) Ecocardiograma fetal
- d) Estudio genético de DNA fetal libre en sangre materna
- e) Niveles plasmáticos de HCG y alfafetoproteína

114) Un paciente alcohólico es ingresado, indicándosele tratamiento con diazepam 0,5 mg/noche y haloperidol 0,5 mg/noche. Evolucionando con sudoración, inquietud, palpitaciones e insomnio con angustia que es mayor en la noche,

- a) Acetosis
- b) Síndrome de privación de alcohol
- c) Síndrome neuroléptico maligno
- d) Distonía aguda
- e) Diquinesia aguda

115) Un paciente de 25 años consulta por aparición de lesiones en las extremidades inferiores. Refiere que ayer estuvo jugando fútbol y que las lesiones empezaron a aparecer después. Además, dice que hace un año, le había pasado algo similar, luego de andar en moto por los cerros. Al examen físico se observan lesiones como las que se muestran en la siguiente imagen:

INSERTAR FOTO (la imagen original mostraba ambos muslos y piernas con múltiples lesiones eritemato-violáceas, muchas de ellas con disposición lineal)

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Fitodermatitis
- b) Enfermedad ampollar
- c) Urticaria solar
- d) Lupus discoide
- e) Vasculitis leucocitoclástica

116) Una paciente de 23 años, consulta por un cuadro de diarrea de tres meses de evolución asociada a sensación febril y fiebre cuantificada hasta 38,0°C. Además, ha presentado disentería en algunas oportunidades y refiere entre otros síntomas, dolor articular migratorio en las cuatro extremidades. Al examen físico se aprecian aftas orales y nódulos eritematosos dolorosos en la cara anterior de las piernas. Su examen abdominal muestra un abdomen blando, doloroso a la palpación, sin signos peritoneales. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad celiaca
- b) Infección por salmonella
- c) Déficit de IgA
- d) Colitis ulcerosa
- e) Lupus eritematoso sistémico

117) Una paciente de 30 años consulta por molestias genitales, consistentes en leucorrea y prurito. Al examen ginecológico, destaca especuloscopia con leucorrea abundante, amarilla y espumosa. ¿Cuál es el examen de elección para realizar el diagnóstico etiológico?

- a) Prueba de aminas vaginales (test de KOH)
- b) Cultivo para *Candida albicans*
- c) Examen de determinación de “células clave” (clue cells)
- d) Frotis fresco de la secreción vaginal
- e) PCR para *Chlamydia trachomatis*

118) Paciente de 25 años, presenta desde hace 3 semanas compromiso del estado general, sensación febril cuantificada hasta 38°C, asociado a astenia y tendencia a presentar equimosis frente a pequeños traumatismos. Al examen físico se aprecia pálida, se palpa esplenomegalia y se observan abundantes petequias en abdomen y extremidades inferiores asociadas a equimosis en extremidades inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Leucemia aguda
- b) Mononucleosis infecciosa
- c) Linfoma
- d) Síndrome hemolítico uremico
- e) Coagulación intravascular diseminada

119) Una paciente de 24 refiere que luego de realizar ejercicios de elongación, presenta dolor súbito en el cuello y en la cabeza, con cefalea en trueno (thunderclap). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cefalea cluster o en racimo
- b) Accidente isquémico transitorio
- c) Disección de la arteria cerebral o carótida
- d) Migraña sin aura desencadenada por el ejercicio.
- e) Hernia traumática del núcleo pulposo

120) Una paciente de 30 años, con antecedente de displasia de cadera derecha, tratada con cirugía abierta en su infancia, consulta por dolor muy intenso en la cadera izquierda, que la hace cojear permanentemente. Al examen físico presenta acortamiento de 25

mm de la extremidad inferior derecha y su radiografía muestra artrosis severa de la articulación. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Tratamiento sintomático de la artrosis
- b) Indicar tratamiento kinesioterapéutico
- c) Realizar osteotomía acetabular
- d) Instalar prótesis total de cadera
- e) Compensar el acortamiento con calzado con realce

121) Una paciente de 64 años consulta por artralgiyas de las manos, caderas y rodillas. Al examen físico presenta aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas, con nódulos de Heberden. Además tiene limitación de los movimientos de las rodillas, con dolor y crepitación articular, sin signos inflamatorios y limitación a la abducción ambas caderas. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

- a) Prednisona
- b) Paracetamol
- c) Metotrexato
- d) Bifosfonatos
- e) Ibuprofeno

122) Usted atiende a un lactante de 10 meses de edad, con antecedente de haber nacido prematuro a las 30 semanas y que pesó 1.300 gramos al nacer. Según el Plan Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), ¿qué tipo de leche debe recibir?

- a) Fórmula de inicio
- b) Fórmula de continuación
- c) Leche purita fortificada
- d) Fórmula de inicio para prematuros
- e) Fórmula de continuación para prematuros

123) Un niño de 4 años presenta sensación febril y ojo rojo bilateral, asociado a ardor y lagrimeo, lo que se acompaña de rinorrea y odinofagia. Varios de sus familiares tienen los mismos síntomas. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Chlamydia trachomatis
- b) Staphylococcus aureus
- c) Streptococcus pyogenes
- d) Haemophilus influenzae
- e) Adenovirus

124) Un paciente de 87 años, institucionalizado por una demencia tipo Alzheimer y que es portador de sonda Foley a permanencia, que se cambia cada un mes, presenta orinas turbias, por lo que se realiza un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli

sensible a nitrofurantoína, gentamicina e imipenem. El paciente está asintomático, sin mayor confusión de la habitual. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar nitrofurantoína v.o.
- b) Iniciar gentamicina i.m.
- c) Iniciar imipenem e.v.
- d) Observar evolución, sin necesidad de retirar la sonda
- e) Solicitar hemograma, VHS y PCR y decidir conducta según hallazgos

125) Un paciente de 18 años presenta agudeza visual de 1 en el ojo izquierdo y de 0,6 en el ojo derecho, que mejora a 0,8, al mirar por un agujero estenoico. No presenta dolor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Glaucoma
- b) Estrabismo
- c) Vicio de refracción
- d) Catarata
- e) Coriorretinitis

126) Un escolar de 8 años consulta por aparición de lesiones en las extremidades inferiores, consistentes en pápulas eritematosas, palpables. Refiere además artralgias migratorias en las manos, rodillas y codos, y también hematoquezia en algunas oportunidades desde hace algunos días ¿Cuál es la complicación más probable en el mediano plazo?

- a) Aneurismas coronarios
- b) Infartos cerebrales
- c) Hepatitis
- d) Daño vascular periférico
- e) Nefritis

127) Una mujer puerpera hace 5 semanas, dando lactancia materna exclusiva, consulta por dolor y enrojecimiento del pezón izquierdo. Al examen físico se muestra lo siguiente:

INSERTAR FOTO

¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a) Mupirocina tópica
- b) Clotrimazol tópico
- c) Óxido de zinc tópico
- d) Lanolina purificada tópica
- e) Betametasona tópica

128) Una niña de 8 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y aparición de ictericia asociado a orinas oscuras que se identifica como coluria. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran GOT 1.525 UI/L, GPT 1.216 UI/L, bilirrubina total 11,3 mg/dL de predominio directo e IgM para VHA (+). Se indica reposo por 10 días evolucionando favorablemente, sin embargo, 10 días después reaparece la ictericia, agregándose prurito y astenia. Se controlan pruebas hepáticas que muestran protrombinemia: 90%, GOT: 1.025 UI/L y GPT: 968 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hepatitis crónica
- b) Remisión completa
- c) Portación asintomática del virus
- d) Remisión parcial con recurrencias
- e) Falla hepática

129) Un hombre de 18 años tiene la idea de que algunas personas quieren dañarlo. Previamente a esto presentaba retraimiento social. En el último tiempo el cuadro empeora, agregándose alucinaciones de voces, que lo insultan y ha descuidado significativamente su higiene personal. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Personalidad esquizotípica
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Trastorno esquizoafectivo
- e) Depresión psicótica

130) Un niño de 4 años presenta fiebre hasta 39 grados Celsius, mialgias y tos de 3 días de evolución. Además ha presentado rinorrea y cefalea. Al examen físico presenta temperatura de 38,8 grados y su examen pulmonar es normal. Se realiza test pack para virus respiratorios, que resulta positivo para virus influenza B. ¿Cuál es el fármaco de elección para el tratamiento de este paciente?

- a) Oseltamivir
- b) Acetaminofeno
- c) Aciclovir
- d) Amantadina
- e) Amoxicilina

131) Una paciente de 15 años, con menarquía a los 14 años, consulta por atraso menstrual de 2 meses. No tiene vida sexual. Su examen físico segmentario no muestra alteraciones y tiene desarrollo mamario y genital acorde a su edad. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Pedir niveles plasmáticos de TSH y prolactina
- b) Solicitar ecografía transvaginal

- c) Realizar histerosonografía
- d) Iniciar anticonceptivos orales
- e) Dar progesterona oral, si el atraso dura un mes más

132) ¿Qué alteración del examen físico, obliga a descartar una disrafia espinal de tipo espina bífida oculta?

- a) Melanocitosis cutánea congénita
- b) Nevus flammeus sacro
- c) Nevo congénito en la zona sacra
- d) Hoyuelo sacro o “fosita pilonidal”
- e) Seno dérmico sacrococcígeo

133) Una paciente de 36 años, cursando su primer embarazo a las 28 semanas, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, con 75 gramos de glucosa, que arroja una glicemia basal de 98 mg/dl y una glicemia postcarga, a las 2 horas, de 147 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Resistencia a la insulina
- b) Diabetes mellitus gestacional
- c) Diabetes mellitus pregestacional
- d) Intolerancia a la glucosa oral
- e) Embarazo normal

134) Un paciente de 40 años, con antecedente de infección crónica por VIH, diagnosticado hace varios años, sin tratamiento, consulta por diarrea de 3 meses, de tipo acuoso, sin fiebre, asociado a dolor abdominal. Al examen físico está afebril y presenta abdomen blando, depresible, levemente doloroso a la palpación, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Salmonella sp.
- b) Shigella sp.
- c) Criptococcus
- d) Microsporidium
- e) Toxoplasma gondii

135) Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 38 semanas, consulta por contracciones uterinas, que se constatan como 3-4 cada 10 minutos. Al tacto vaginal presenta 10 cm de dilatación, membranas rotas y cabeza fetal en espina 0, en variante mentoiliaca derecha posterior. EL monitoreo fetal resulta tranquilizador. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Dejar a evolución espontánea y controlar en una hora
- b) Hacer fórceps

- c) Realizar vaccum de la cabeza fetal
- d) Realizar amniotomía con rotación manual
- e) Hacer cesárea de urgencia

136) Un paciente de 50 años, con antecedente de infección de VIH, consulta por una lesión perianal, de larga data, sin tendencia a la cicatrización. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada, de consistencia aumentada, de 4 cm de diámetro, bordes cartográficos y que se introduce por el ano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Sífilis
- b) Enfermedad de Crohn
- c) Carcinoma epidermoide
- d) Melanoma
- e) Tuberculosis

137) Un niño es diagnosticado de displasia de cadera a los 6 meses de vida, mediante una radiografía, que muestra la displasia, con luxación del extremo proximal del fémur izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a) Doble pañal
- b) Correas de Pavlik
- c) Yeso con fijador
- d) Osteotomía periacetabular tipo Ganz
- e) Reducción abierta y fijación con osteosíntesis

138) Una paciente de 25 años presenta un aborto espontáneo, hace 2 meses, que no requirió de legrado. Actualmente presenta metrorragia de 7 días de evolución, que en la especuloscopia se aprecia que sale del orificio cervical externo. Su HCG resulta 135.000 UI/L. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra útero aumentado de tamaño, con contenido uterino irregular y múltiples vesículas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar metotrexato
- b) Esperar evolución espontáneo
- c) Realizar legrado
- d) Realizar resonancia magnética nuclear de pelvis
- e) Realizar histerectomía

139) ¿Qué antecedente es indicación del uso de estrógenos orales solos, en la terapia de reemplazo hormonal?

- a) Antecedente de cáncer de mama
- b) Antecedente de dislipidemia
- c) Antecedente de histerectomía total

- d) Osteoporosis
- e) Edad mayor a 70 años

140) Un lactante de 7 meses, en tratamiento con domperidona por reflujo gastroesofágico, presenta desviación del cuello a la izquierda, asociado a llanto y movimientos irregulares de los ojos. Al examen físico presenta contractura de los músculos del cuello. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Crisis epiléptica focal
- b) Distonía aguda por fármacos
- c) Disquinesia aguda por fármacos
- d) Síndrome de West
- e) Infección por *Clostridium tetani*

141) ¿Cuál es el mejor indicador para determinar si un test de tamizaje, para la detección de cáncer, es efectivo?

- a) Disminución de la tasa de incidencia
- b) Disminución de la tasa de prevalencia
- c) Disminución de la tasa de letalidad
- d) Disminución de la tasa de mortalidad
- e) Aumento de la supervivencia de la enfermedad

142) Un niño de 6 años presenta múltiples en el tronco, que se muestran en la imagen. Su padre tiene lesiones similares.

INSERTAR FOTO

El diagnóstico más probable es:

- a) Neurofibromatosis tipo 1
- b) Enfermedad de Addison
- c) Enfermedad celiaca
- d) Síndrome de Peutz-Jeghers
- e) Hiperplasia suprarrenal congénita

143) Una mujer de 87 años, es institucionalizada por una demencia tipo Alzheimer. Al examen físico del ingreso se aprecia lo siguiente:

INSERTAR FOTO

¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar cirugía de urgencia
- b) Realizar PAP y colposcopia
- c) Indicar pesario
- d) Realizar biopsia
- e) Cuidados paliativos

144) Una paciente de 25 años, cursando con embarazo de 30 semanas, con antecedente de epilepsia hace 1 año, presenta crisis convulsivas tónico-clónicas, desde hace una hora. Al examen físico se aprecia edema de extremidades inferiores, FC: 87x' y PA: 160/100 mmHg. La ecografía obstétrica muestra feto vivo. ¿Cuál es la primera medida?

- a) Administrar nifedipino
- b) Administrar fenobarbital
- c) Administrar diazepam
- d) Administrar sulfato de magnesio
- e) Administrar misoprostol

145) Un paciente de 35 años, padre de tres hijos consulta por disfunción eréctil progresiva que inició hace 3 meses. Su examen físico no muestra alteraciones, y su examen genital y testicular resulta normal. Se solicitan exámenes que muestran testosterona de 190 ng/dL (valor normal: 280-1100ng/dL) y LH de 1,8 UI/L (valor normal: 1,5-20 UI/L). ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de este paciente?

- a) Espermiograma
- b) Ecografía testicular
- c) Niveles plasmáticos de FSH
- d) Resonancia magnética de hipófisis
- e) Niveles plasmáticos de estrógeno y progesterona

146) Una paciente de 42 años, consulta por adenopatía supraclavicular derecha persistente. Al examen físico se palpa además un nódulo cervical paratraqueal derecho de consistencia amentada, que asciende con la deglución, de alrededor de 2 cm de diámetro. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio de esta paciente?

- a) Niveles plasmáticos de calcitonina
- b) Ecografía cervical
- c) TAC de cuello
- d) Resonancia magnética de cuello
- e) Biopsia quirúrgica

147) Una paciente de 49 años, obesa, consulta por metrorragia de 10 días de duración, sin otros síntomas. Al examen físico destaca especuloscopia con sangre que proviene del OCE. Se solicita beta-HCG que resulta negativa y ecografía transvaginal, que muestra un endometrio de 15 mm de grosor. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar resonancia magnética nuclear de pelvis
- b) Solicitar histerosalpingografía
- c) Realizar estudio de alteraciones de la hemostasia
- d) Realizar estudio de trombofilias
- e) Realizar biopsia endometrial

148) Una paciente de 66 años, que mide 1,68 metros y pesa 49 kilos, se realiza una densitometría ósea que muestra un T score de -3,5 DS en cadera izquierda y -2,8 en la columna lumbar a la altura de la vértebra L4. Trae además una glicemia, un perfil bioquímico y perfil lipídico, todos dentro de rangos normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada para esta paciente?

- a) Indicar calcio y vitamina D vía oral
- b) Indicar una carga de vitamina D vía oral
- c) Administrar calcitonina endovenosa
- d) Indicar bifosfonatos vía oral o endovenosa
- e) Iniciar terapia de reemplazo hormonal con estrógenos más progestágenos por vía oral

149) Un paciente de 60 años, con antecedente de diabetes mellitus 2 insulino dependiente, en tratamiento con insulina NPH 30U en la mañana y 20 U en la noche. Presenta un cuadro de malestar, sudoración y palpitaciones intensas a las 3 de la madrugada, constatándose un hemoglucotest de 50mg/dL. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál

- a) Disminuir la insulina NPH matinal
- b) Suspender la insulina NPH matinal
- c) Disminuir la insulina NPH nocturna
- d) Suspender la insulina NPH nocturna
- e) Disminuir ambas dosis de insulina NPH

150) Una paciente de 30 años, embarazada sin controles iniciales, con edad gestacional dudosa, consulta por pérdida de líquido por los genitales. Sus signos vitales son normales y al examen obstétrico no presenta dinámica uterina ni modificaciones cervicales en el tacto vaginal. Su altura uterina es de 25 cm y las pruebas de bienestar fetal son normales. Se realiza ecografía obstétrica, que muestra índice de líquido amniótico de 5,2 y biometría para 30 semanas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Inducir el parto con misoprostol
- b) Realizar cesárea
- c) Dar antibióticos y corticoides y mantener una conducta expectante
- d) Determinar madurez fetal en líquido amniótico
- e) Administrar nifedipino oral

151) Paciente de 58 años, con antecedente de diabetes mellitus, hipertensión y fumador de 40 paquetes año, consulta por un cuadro de tres semanas de evolución de dolor epigástrico opresivo, asociado a disnea y palpitaciones regulares, que lo obligan a detenerse cada 100 metros de caminata y ceden con el reposo. En el examen físico, su presión arterial es 140/90 mmHg, frecuencia cardiaca de 80 latidos por minuto regular. El diag-

nóstico más probable es:

- a) Angina crónica de reciente comienzo
- b) Fibrilación auricular paroxística
- c) Isquemia cardiaca con arritmia supraventricular
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Cardiopatía hipertensiva

152) Una paciente de 22 años presenta ansiedad persistente, relacionada a abandonar la cosa sola, por miedo a que le pase algo, sin recibir ayuda de sus familiares, lo que se ha agravado en el último tiempo. Por esto abandonó sus estudios hace un mes y en general ha visto seriamente afectada su vida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Fobia social
- b) Trastorno de angustia generalizada
- c) Trastorno de personalidad dependiente
- d) Trastorno de angustia
- e) Agorafobia

153) Un adulto de 65 años, con antecedente de EPOC, consulta por aumento de su disnea basal asociado a expectoración mucopurulenta y fiebre hasta 38,3°C. Al examen físico presenta frecuencia cardiaca de 95 por minuto, presión arterial 120/80mmHG, saturación 91%, frecuencia respiratoria de 27 por minuto. A la auscultación pulmonar presenta crépitos en base izquierda y se solicita radiografía que se muestra a continuación:

INSERTAR FOTO

El tratamiento de elección es:

- a) Cefuroximo oral
- b) Penicilina endovenosa
- c) Azitromicina oral
- d) Amoxicilina oral
- e) Ceftriaxona endovenosa

154) Un paciente de 33 años, hospitalizado por una endocarditis subaguda por estreptococcus víridans, en tratamiento con penicilina y gentamicina por vía endovenosa, presenta un cuadro de hematuria de algunos días de evolución. Se solicita sedimento de orina que muestra 50 glóbulos rojos por campo con 95% de dismorfia y presencia de cilindros hemáticos, creatinina de 2,4mg/dL, ANA (-), fracción C3 del complemento de 53mg/dL (valor normal: 75-135 mg/dL). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Embolias renales a repetición
- b) Nefritis intersticial secundaria al uso de penicilina
- c) Daño tubular agudo secundario al uso de gentamicina

- d) Glomerulonefritis por depósito de complejos inmunes
- e) Síndrome hemolítico urémico

155) Una paciente de 50 años se siente atrapada en lugares como estacionamientos, autopistas, los lugares al aire libre y los lugares cerrados, como ascensores. Por esto, ha dejado de salir de su casa. Además tiene cuadros de angustia episódica, con marcado miedo a perder el control. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Agorafobia
- b) Trastorno de ansiedad generalizada
- c) Trastorno de angustia
- d) Trastorno obsesivo compulsivo
- e) Fobia específica

156) Una niña de 8 meses de edad presenta un cuadro febril hasta 39,2 grados Celsius, sin otros síntomas, ni alteraciones en su examen físico. Se realiza un urocultivo por recolector, que resulta positivo para *Escherichia coli* sensible, con 45.000 unidades formadoras de colonias, por ml. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Tratar con cefadroxilo oral
- b) Tratar con nitrofurantoína oral
- c) Tratar con amoxicilina oral
- d) Solicitar hemograma, VHS y PCR
- e) Repetir el urocultivo por sondeo vesical

157) Una paciente de 65 años consulta por un cuadro de 3 meses de evolución de astenia y debilidad de las cuatro extremidades, asociada a mialgias. Al examen físico presenta dolor a la palpación de los músculos trapecios y supraespinosos y de la región trocantérica. En sus exámenes destaca CK: 125 UI/L, y hemograma con VHS: 65 mmHg. El diagnóstico más probable es:

- a) Fibromialgia
- b) Artritis reumatoide
- c) Polimiositis
- d) Polimialgia reumática
- e) Vasculitis

158) Un lactante de 15 meses de edad presenta una convulsión tónico-clónica de 1 minuto de duración, autolimitada, mientras cursaba con fiebre de 39 grados Celsius. Al examen está bien perfundido, algo pálido, consciente, con pulso y presión arterial normales, sin signos focales, ni signos meníngeos. El resto de su exploración, no presenta hallazgos de importancia. Además de bajar la temperatura del niño ¿cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar punción lumbar
- b) Iniciar diazepam
- c) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
- d) Iniciar ácido valproico
- e) Mantener en observación por 4 horas

159) Una paciente de 31 años, entra en trabajo de parto a las 37+6 semanas y al examinarla se constatan 3 contracciones uterinas en 10 minutos y su tacto vaginal muestra 5 cm de dilatación cervical, membranas íntegras y presentación cefálica, en espaldas -1. El registro de la frecuencia cardíaca fetal está dentro de rangos normales. Se la evalúa a las 3 horas, manteniéndose sin cambios obstétricos. La conducta de elección es:

- a) Mantener una conducta expectante por 1 hora y reevaluar
- b) Realizar fórceps
- c) Realizar cesárea
- d) Realizar rotura artificial de membranas y administrar anestesia epidural
- e) Administrar oxitocina endovenosa en goteo

160) Una paciente de 30 años de edad, cursando un embarazo de 40 semanas, inicia trabajo de parto en cefálica. Al tacto vaginal tiene 7 cm de dilatación, con membranas íntegras, por lo que se realiza rotura artificial de membranas, que da salida a líquido claro. A los pocos minutos evoluciona con registro fetal tipo III, por bradicardia fetal. La primera conducta a realizar es:

- a) Realizar tacto vaginal
- b) Cambiar de posición a la madre
- c) Administrar nifedipino
- d) Dar oxígeno a la madre
- e) Realizar cesárea de urgencia

161) ¿Qué institución da la autorización sanitaria para el funcionamiento de laboratorio y clínicas?

- a) Superintendencia de Salud
- b) Secretaría Regional Ministerial de Salud
- c) Corporaciones Municipales de Salud
- d) Dirección del Servicio de Salud
- e) Superintendencia de Seguridad Social

162) Un paciente de 30 años consulta por aumento de volumen escrotal derecho. Al examen físico se palpa un tumor en relación al testículo derecho. Se solicita ecografía testicular que visualiza una lesión sólida, de 3 cm de diámetro, sin vascularización, que reemplaza al parénquima testicular, sin compromiso del epidídimo. ¿Cuál es la conducta?

- a) Radioterapia
- b) Quimioterapia
- c) Orquiectomía radical
- d) TAC de abdomen y pelvis
- e) Biopsia testicular por punción

163) Una niña de 12 años consulta por molestias, secreción y una lesión en el ojo izquierdo, que se muestra en la siguiente foto:

INSERTAR FOTO

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Amoxicilina
- b) Azitromicina
- c) Aciclovir
- d) Mupirocina
- e) Dexametasona

164) Un paciente de 80 años, consulta por cuadro de disnea de un mes de evolución que ha aumentado en el último tiempo, asociado a baja de peso. Al examen físico presenta disminución del murmullo pulmonar en el hemitórax izquierdo con matidez a la percusión. Se solicita radiografía de tórax que muestra presencia de derrame pleural derecho, el que se punciona, dando salida a un líquido pleural con LDH de 300mg/dL, colesterol 60mg/dL, ADA 15 UI, leucocitos 3.000/mm³ con predominio mononuclear. El examen de elección para proseguir con el diagnóstico es:

- a) Broncoscopía
- b) Videotoracoscopía
- c) Ecografía pleural
- d) Ecocardiografía
- e) TAC de tórax

165) Un paciente de 50 años, en tratamiento con antimicóticos orales desde hace 3 semanas, consulta por un cuadro de 2 días de evolución de prurito, ictericia y acolia, sin dolor. En su examen físico se aprecia ictérico, afebril, con FC: 70x', PA: 110/70 mmHg, con abdomen blando, depresible. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran un patrón colestásico y la ecografía abdominal demuestra vesícula biliar con barro biliar y colédoco de 10 mm diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Coledocolitiasis
- b) Colestasia farmacológica
- c) Síndrome de Mirizzi
- d) Esteatosis hepática
- e) Colelitiasis

166) Un paciente de 60 años, con antecedente de depresión, en tratamiento con paroxetina 40 mg en la noche y clonazepam 0,5 mg en la noche, hace 7 días disminuyó la dosis de los fármacos a la mitad. Hace 4 días inicia un cuadro de malestar general, asociado a inquietud, insomnio, sensación de pinchazos eléctricos en los brazos y miedo a morir. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Acatisia
- b) Síndrome de discontinuación de antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
- c) Síndrome de privación de benzodiacepinas
- d) Manía aguda
- e) Delirium

167) ¿A que tipo de medida corresponde la vacunación contra una enfermedad, en la historia natural de una enfermedad?

- a) Promoción de salud
- b) Protección específica
- c) Erradicación de la enfermedad
- d) Diagnóstico oportuno
- e) Tratamiento precoz

168) Una paciente de 35 años, está en trabajo de parto de término. Durante el expulsivo, se produce desprendimiento de la cabeza fetal, sin embargo no se produce la rotación ni el descenso de los hombros. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Traccionar la cabeza fetal
- b) Realizar compresiones suprapúbicas
- c) Realizar hiperflexión de las caderas (maniobra de McRoberts)
- d) Realizar rotación manual de los hombros hacia anterior (maniobra de Rubin)
- e) Realizar extracción del brazo posterior (Maniobra de Jacquemier Barnum)

169) Una paciente de 19 años, con ciclos menstruales regulares, consulta por dolor abdominal intenso, mayor en la fosa ilíaca izquierda. Su FUR fue hace 20 días. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la FII, con signos peritoneales esbozados. Se solicita test de embarazo, que resulta negativo y una ecografía transvaginal, que muestra una lesión anexial mixta de 8 cm de diámetro, con presencia de líquido libre en moderada cantidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cuerpo lúteo hemorrágico
- b) Cuerpo lúteo roto
- c) Apendicitis aguda
- d) Torsión ovárica
- e) Absceso tubo-ovárico

170) Un paciente de 23 años consulta por odinofagia intensa, asociada a fiebre, que han empeorado y que y en el último tiempo se agrega dificultades para comer, por trismus. Al examen físico presenta eritema faríngeo, exudado amigdalino bilateral y abombamiento del pilar diafragmático derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Absceso retrofaríngeo
- b) Angina de Ludwig
- c) Amigdalitis ulcero-necrótica
- d) Absceso periamigdalino
- e) Mononucleosis infecciosa

171) Un paciente de 40 años, consulta por disnea desde hace 2 semanas, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia matidez a la percusión y disminución del murmullo pulmonar en base izquierda. Se realiza radiografía que se muestra a continuación:

INSERTAR FOTO

El examen más adecuado para seguir con el estudio es:

- a) TAC
- b) AngioTAC
- c) Ecocardiografía
- d) Análisis citoquímico del líquido pleural
- e) Ecografía pleural

172) Un hombre de 77 años, alérgico a la penicilina, consulta por dolor de la rodilla izquierda, asociado a aumento de volumen y fiebre. Al examen físico tiene temperatura de 38,5 grados y presenta aumento de volumen y eritema de la rodilla izquierda, asociado a signos de derrame articular. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este paciente?

- a) Cefazolina endovenosa
- b) Cloxacilina endovenosa
- c) Azitromicina oral
- d) Clindamicina endovenosa
- e) Gentamicina endovenosa

173) Una paciente sufre una fractura de la diáfisis humeral derecha, la que es manejada mediante cirugía, con osteosíntesis con placa. A las 24 horas, evoluciona con dolor en el sitio de la fractura, asociada a imposibilidad de extender la muñeca derecha. Mantiene la flexión activa de los dedos de esa mano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trombosis de la arteria braquial
- b) Neurapraxia del nervio radial
- c) Desplazamiento de la placa

d) Síndrome compartimental

e) Lesión del plexo braquial

174) Una paciente de 25 años, diagnosticada de depresión en tratamiento, hace algunas horas consume múltiples comprimidos de amitriptilina y evoluciona con desorientación, midriasis y taquicardia. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar su enfrentamiento?

a) Electrocardiograma

b) Radiografía de tórax

c) Creatina fosfoquinasa

d) Electroencefalograma

e) Pruebas hepáticas

175) Un paciente de 65 años consulta por dolor escrotal derecho de 3 días de evolución. Al examen físico presenta dolor y eritema en la zona escrotal derecha y se palpa aumento de volumen y dolor, del testículo y del epidídimo. Refiere tener pareja sexual monogámica. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

a) Streptococcus pyogenes

b) Staphylococcus aureus

c) Chlamydia trachomatis

d) Neisseria gonorrhoeae

e) Escherichia coli

176) Una paciente de 24 años consulta por atraso menstrual de 7 semanas. Se realiza HCG, que resulta 5.000 UI/L, por lo que se hace ecografía transvaginal, que muestra ausencia de gestación intrauterina y abundante líquido libre peritoneal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Realizar curva de HCG

b) Controlar con ecografía transvaginal en 7 días

c) Realizar laparoscopia

d) Administrar metotrexato

e) Mantener el control normal del embarazo

177) Un paciente de 68 años, diabético e hipertenso presenta disminución brusca de la visión del ojo izquierdo, que solo le permite diferenciar los movimientos de una mano, sin poder identificar letras. La agudeza visual del ojo derecho es normal. La exploración externa es normal y el rojo pupilar es negativo en ese ojo. En sus exámenes destaca hemoglobina glicosilada de 9,2%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a) Neuritis óptica isquémica

b) Desprendimiento de retina

- c) Hemorragia vítrea
- d) Trombosis de la arteria central
- e) Edema macular

178) Una paciente de 23 años, en tratamiento antidepresivo, desde hace 15 días, consulta por un cuadro paranoide, asociado a expansividad. Además presenta disminución de los requerimientos de sueño, irritabilidad, agresividad y aumento de la actividad psicomotora. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Acatisia
- b) Esquizofrenia
- c) Depresión psicótica
- d) Trastorno bipolar
- e) Trastorno de personalidad limítrofe

179) Una paciente de 28 años, multipara de uno, con embarazo de 22 semanas, con antecedente de un parto prematuro a las 26 semanas se realiza una cervicometría de control, que resulta 10 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar nifedipino oral
- b) Indicar progestágenos endovaginales hasta el término del embarazo
- c) Realizar cerclaje cervical
- d) Realizar test de la fibronectina fetal
- e) Observar evolución

180) Una paciente de 48 años, usuaria de DIU hace 8 años, consulta por reglas irregulares. Su FUR fue hace 50 días y no refiere otros síntomas. En la especuloscopia, no es posible visualizar las guías del DIU. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía pélvica
- b) Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, prolactina, FSH y LH
- c) Realizar ecotomografía pelviana
- d) Solicitar niveles plasmáticos de subunidad beta-HCG
- e) Intentar exploración uterina con pinza, para extraer el DIU

PAUTA

0 A Sin duda

1 E Se sospecha un cáncer de colon, que se estudia con colonoscopia completa

2 B La condrocalcinosis es la causa más frecuente de monoartritis aguda en el adulto mayor y suele desencadenarse por reposo, como este caso.

3 E Por ingesta de betacaroteno

4 A Para prevenir el síndrome de realimentación se debe iniciar con 10-15 Kcal/Kg/día. Pésima pregunta.

5 C ¿B? “Es un HELLP hasta que se demuestre lo contrario” es una frase que se repite con frecuencia en obstetricia, dado la gravedad del cuadro. Sin embargo, en este caso no hay dolor abdominal, ni se describe la ictericia u otro indicador de hepatitis. Por el otro lado, el cuadro es completamente compatible con un PTT, patología que se asocia al embarazo. Por tener más de 20 semanas creo que la respuesta es HELLP, pero es una pésima pregunta.

6 D Los cefalohematomas suelen evolucionar sin complicaciones, aunque pueden complicarse con ictericia, por la hemólisis del hematoma.

7 D Es un vértigo postural paroxístico benigno clásico.

8 B Por ser diabético, se exige LDL menor a 100. Dado que los triglicéridos están menores a 500, el LDL es la prioridad.

9 E Es una mielofibrosis clásica, sin embargo, toda mielofibrosis es a su vez una mielop-tosis. No debería haber un distractor correcto.

10 B Es una tiroiditis subaguda de Quervain, que se trata con AINEs

11 E Ya que está en fase activa, están contraindicados los tocolíticos. Además la indicación relativa (sin evidencia) de la cesárea en el parto prematuro, es cuando tiene menos de 28 semanas o 1Kg. Los corticoides poco servirán, pero siguen siendo indicados en el parto prematuro entre 24 y 34 semanas.

12 B Es una fuga disociativa clásica.

13 B Es un SAHOS, que se estudia con polisomnografía.

14 D Es un trastorno conversivo clásico. Sin embargo, son un tipo de trastorno somato-morfo. No debería haber un distractor correcto.

15 D Es un trastorno de la deglución clásico, en este caso como secuela de un TEC severo.

16 C Es una catarata inicial.

17 D Es un asma y lo más correcto es iniciar salbutamol SOS, más un corticoide inhalado (budesonida en este caso). Por tanto es una mala pregunta. Si fuerzan a elegir el tratamiento “inicial”, yo creo que la respuesta es salbutamol.

18 E Es una embolia renal clásica. El ritmo irregular, hace pensar en FA, como causa de la embolia. El resto del cuadro clínico y de los exámenes, son característicos.

19 A Es un quiste pilonidal infectado. Se debe drenar. Si no se infecta, solo se observa.

20 A Tiña capitis clásica.

21 E Es un contacto, con PPD mayor a 10, por lo que se debe indicar profilaxis antibiótica (isoniazida 6 meses es la recomendación del Minsal).

22 C Asbesto, sílice y carbón producen neumoconiosis. La inhalación de harina, produce asma y es la causa más frecuente de asma laboral.

23 D Lo primero a descartar, siempre es la hepatitis A, con IgM-VHA. Si no, se busca la B, con Ag-VHBs.

24 B Es una CIA clásica.

25 A Es una pregunta discutible, pero al estar algo hipotenso y en Shock cardiogénico, el verapamilo podría agravar el cuadro, por ser un bloqueador del calcio, que producen vasodilatación periférica (aunque el efecto del verapamilo en la circulación periférica es mínimo).

26 ¿? Lo más correcto es comprimir la várice sangrante, elevar la extremidad. Las alternativas que se presenta, exceden los conocimientos de un médico general.

27 A Es una simple infección respiratoria alta, que se trata de manera sintomática. Actualmente se recomienda preferir el paracetamol y evitar los AINES en lo posible, en la edad pediátrica.

28 C Es una EvW clásica.

29 B El OR pasa por el 1,0 en su intervalo de confianza al 95%, por lo que no es estadísticamente significativo.

30 B Es una candidiasis y por estar embarazada, se debe evitar el fluconazol oral y preferir el tratamiento tópico.

31 C Es un glaucoma congénito clásico.

32 D Es un clásico sesgo de vigilancia (se detectan más problemas en el grupo más vigilado).

33 A Preguntan el tratamiento de la crisis y las crisis convulsivas se tratan preferentemente con benzodiacepinas, aunque la de elección es el lorazepam.

34 D Parece una demencia inicial y dado que no tiene indicadores de otra patología, lo más probable es que sea una demencia tipo Alzheimer.

35 A Es un paro, por lo que se debe iniciar RCP. Sin embargo, por ser un paro presenciado, está indicado poner primero el desfibrilador, aunque no estaba en las opciones.

36 E Es una adrenarquia normal (olor axilar y en varones puede haber una ligera pubarquia). Los testículos pequeños hacían imposible una pubertad precoz central y la pubertad precoz periférica es algo muy raro, que habría tenido alteraciones de la edad ósea.

37 E Tiene un hipoestrogenismo postparto. No suele ser grave, por lo que basta el uso de lubricación. Además, por estar en lactancia, están contraindicados los estrógenos (cortan la lactancia).

38 E Es un RGE grave, en un paciente joven, con respuesta incompleta al omeprazol: Es la principal indicación de cirugía, además del esófago de Barret.

39 C No hay nada que oriente a ictericia patológica. Es una ictericia fisiológica clásica.

40 E Tanto el cuadro clínico, como la RxTx con compromiso bilateral hacen sospechar una infección por VIH más Pneumocystis.

41 D? A los 85 años, jamás se debió haber pedido el APE. Es una mala pregunta. En las opciones no salía observar. Dado que todo APE mayor a 4,0 se biopsia, creo que la respuesta es la D.

42 A Es una atrofia endometrial clásica (menopáusica y autolimitada). Además, la TRH combinada, por tener progestágeno, igual puede producir atrofia.

43 A El espermiograma es el examen de elección para el inicio del estudio de la infertilidad masculina.

44 D La terbinafina oral es el tratamiento de elección de la onicomicosis.

45 C Es una NAC neumocócica clásica.

46 E Es un SCA con SDST, por lo que requiere angioplastia de urgencia (o trombolisis, que no aparecía en las opciones).

47 E Es un trastorno facticio clásico. No es por simulación, porque no hay un fin económico.

48 ¿D? Esta pregunta excede lo que debe saber un médico general y causa conflicto en los mismo ORL que la analizaron. Tiene adenoides grado III, por lo que hay una indicación relativa de cirugía, pero no tiene complicaciones y a su edad ya no seguirán creciendo, por lo que probablemente se pueda intentar el tratamiento con corticoides tópicos (han demostrado reducir el tamaño de los adenoides) o incluso observar evolución, ya que la respiración bucal, no es de tipo obstructivo, sino por otra causa (hiperlaxitud, malos hábitos).

49 B Pregunta rara, ya que mezcla la IOE, con la IOU. De todos modos, al predominar la IOE, lo primero es intentar los ejercicios de piso pélvico.

50 B Es un Berger clásico.

51 B Es un delirium tremens, por privación de alcohol, que se trata con diazepam, aunque en el daño hepático, se prefiere el alprazolam.

52 C Tanto la clínica, como la radiografía apuntaban a NAC.

53 B Es un osteosarcoma clásico, aunque la pregunta estaba horriblemente redactada.

54 C Fisura anal clásica.

55 D Parece una estenosis uretral postraumática. Dada la edad y el tacto rectal, es improbable que sean las demás causas de UOB.

56 C La FQ suele producir neumonías bacterias (S. aureus y P. aureginosa) y un síndrome de malabsorción.

57 A La presencia de actinomyces en paciente asintomática, no tiene consecuencias. Si tuviese síntomas (dolor, leucorrea, metrorragia), habría que retirar el DIU e indicar antibióticos (amoxicilina o penicilina).

58 A Tanto por tener AR, como por la ferremia baja, con transferrina baja, orienta mucho a una anemia por enfermedades crónicas.

59 A Es una obstrucción intestinal clásica, probablemente por bridas (antecedente de cirugía).

60 B DII, DIII y AVF son las derivaciones inferiores.

61 B Es un TEPT clásico.

62 A Es una diarrea crónica inespecífica clásica. Se produce por consumo excesivo de jugos hiperosmolares.

63 D Es una depresión en el adulto mayor. Se trata con inhibidores de la recaptura de serotonina.

64 D Tiene múltiples tics. El síndrome de Tourette requiere al menos 1 año de duración, más afectación del lenguaje.

65 E Un tumor pulsátil en esa zona, hace pensar en un AAA.

66 ¿B? La clínica es sugerente de un Sd. Guillain Barré, pero el dolor de espalda, la afectación vesical y en especial el nivel sensitivo obliga a descartar una mielitis transversa; sin embargo, el nivel era torácico y la afectación motora era de las 4 extremidades y el Guillain Barré sí puede tener esos síntomas. Es una mala pregunta, ya que el cuadro clínico no era lo suficientemente limpio, como para elegir una de las dos opciones.

67 C Es un Sd. De Mallory Weiss clásico

68 C La descripción era muy pobre, pero seroma era lo más aceptable (aunque llevaba poco tiempo).

69 D Cumple criterios de trastorno delirante, con delirio de persecución. No se indicaba desorientación ni inatención, como para pensar en delirium; tampoco había síntomas anímicos, como para pensar en depresión. La memoria no estaba afectada, como para pensar en demencia. No es un trastorno delirante crónico (mayor a 3 meses).

70 A Se sospecha un endocarditis bacteriana subaguda (mayor a 7 días), por lo que se debe pedir hemocultivos y ecocardiografía.

71 C Era un registro ominoso, con múltiples desaceleraciones variables complejas. Faltaba un buen trazado de la dinámica uterina, ya que en ese parecía no haber contracciones.

72 B La sospecha es un coqueluche, que se trata con macrólidos.

73 ¿A, B? La sospecha es una coledocolitiasis residual y la verdad es que no existe una única forma de enfrentarla. La evidencia no es clara y las recomendaciones son muy variables. Por un lado, la conlangioresonancia da mucha información y en el algún momento, la sociedad chilena de cirugía la recomendó antes que la CPRE, por tener menos efectos adversos y poder diferenciar aquellos pacientes que se benefician de la CPRE de aquellos que requieren otro tratamiento. Sin embargo para muchos, la CPRE sigue siendo el examen de elección, por ser diagnóstico y terapéutico. No deberían poner ambas opciones.

74 D Es un lupus sistémico y la única opción aceptable eran los ANA.

75 C Es una enfermedad de Kawasaki y con adecuado tratamiento (IgG ev más aspirina) suele resolverse, sin secuelas.

76 A Es un patrón obstructivo, que mejora con broncodilatador, es decir, un asma.

77 B Es una probable epilepsia mioclónica, que se trata preferentemente con ácido valproico. Sí pueden jugar videojuegos, pero con pantallas e iluminación adecuadas y por ciertos horarios limitados. Es una pregunta que excede los conocimientos de un médico general.

78 B Es una hipercalcemia, con la posibilidad de ser secundaria al cáncer. Igualmente se estudia con PTH, ya que si está elevada es un hiperparatiroidismo primario y si está baja, es probablemente un cáncer.

79 E Por la edad y la intensidad de las rabietas, parece un niño normal.

80 A Es una estenosis mitral clásica, con FA y todo.

81 A Es una meningitis por meningococo, que se trata con ceftriaxona o penicilina endovenosas.

82 B La certificación asegura que el prestador cumple con los estándares de calidad.

83 ¿B? Tiene un glomerulonefritis aguda postestreptocócica, con un síndrome nefrítico y una insuficiencia cardiaca, por la crisis hipertensiva. Dada la sobrecarga de volumen, la furosemida ev parece ser el tratamiento más razonable, pero el captopril también podría ser de utilidad.

84 ¿C, D? Si bien parece un síndrome alterno clásico (compromiso de un par craneal, más hemiparesia contralateral), es probable que se trate de un infarto de troncoencéfalo. Sin embargo, la clínica del enclavamiento transtentorial es casi idéntica. No es posible hacer la distinción con el enunciado. Es una mala pregunta.

85 A La metrorragia postmenopáusica se estudia inicialmente con Ecografía TV.

86 D Es una verruga paraungueal clásica. La descripción era muy clara. La imagen era algo más confundente.

87 D Los ensayos clínicos son mejores, pero si no son randomizados, tienen sesgos. Por tanto lo mejor de esas opciones era cohortes, que superan a los de casos y controles.

88 C Tiene una glicemia de ayuno mayor o igual 100, lo que en el embarazo, obliga a repetir la glicemia de ayuno.

89 E Es una adolescente normal, ya que sus ciclos son normales y además durante los primeros dos años postmenarquia es normal que haya ciclos irregulares.

90 C Es una pancreatitis clásica.

SEGUNDA PARTE

90 C Es una pancreatitis clásica.

91 D No alcanzaba a cumplir criterios de coriomionitis, pero dado que se trataba de un parto prematuro, que no respondía a tocolíticos de primera línea, era necesario realizar la amniocentesis.

92 B La sospecha es un cáncer hepático, dada la alfafetoproteína de 119. Se inicia el estudio con una Ecografía.

93 D Birrads 0: Eco; 1 y 2: mamografía en un año; 3: mamografía en 6 meses; 4: biopsia histológica y 5: biopsia quirúrgica.

94 B Tanto el síndrome nefrótico, como especialmente la HbA1c mayor a 9%, obligan a iniciar insulina.

95 C Es un TDC clásico, con delirio de enfermedad.

96 D Es una embolia mesentérica clásica, por la FA. Sin embargo, suele cursar sin signos peritoneales al inicio, pero había pasado ya mucho tiempo, por lo que sí aparecen dichos signos.

97 A Todo testículo agudo se explora. Más aún a esa edad, en que se sospecha una torsión testicular.

98 C Es una rotura uterina clásica, con el antecedente de cesárea y la clínica habitual (dolor, sufrimiento fetal, escasa metrorragia y útero difícil de palpar).

99 B La sospecha es una tuberculosis, por el tiempo de evolución y por la clínica.

100 E Es un hallazgo normal.

101 B Tiene la triada de Charcot: fiebre, ictericia y dolor, más la hipertensión arterial. Es una colangitis clínica.

102 D Los accidentes laborales son cubiertos por las mutuales, ya que ellas administran el fondo del seguro de este tipo de accidentes.

103 C La pertusis da fiebre de inmediato, o al día siguiente. La trivírica, por ser a microorganismo vivo, puede producir un cuadro febril 7 a 10 días después.

104 D Es una dermatomiositis clásica: compromiso de párpados, mialgias, debilidad. Recordar que suele ser paraneoplásica, por lo que además se debe sospechar recidiva del cáncer.

105 E Si la hemoglobina glicosilada está bajo 7%, no es necesario hacer cambios en el tratamiento hipoglicemiante, aunque no sea el óptimo.

106 E Parece una infección de una herida abrasiva. Como los bordes son parcialmente definidos, no queda claro si es una celulitis o una erisipela. Afortunadamente el cefa-

droxilo cubre bien tanto al S. Aureus, como al S. Pyogenes.

107 C En el parto recibió antibióticos y la diarrea por clostridium puede aparecer hasta 2 meses después de haber terminado el uso de antibióticos. Eso sí, se debe ser cuidadoso, porque hay quienes definen a la diarrea nosocomial en términos más estrictos, que no calzan con el del caso clínico.

108 C Se sospecha intoxicación por paracetamol. Dado la hepatitis. Aún está en ventana para darle la N-acetil-cisteína.

109 E Es una pregunta difícil, ya que en distintas partes se manejan de manera diferente. Sin embargo, la mayor evidencia dice que el aseo es lo más importante para que se resuelva. Los masajes pueden ayudar a que se desprenda antes.

110 A Tiene el soplo clásico, más los síncope de la estenosis aórtica. Además la edad orienta mucho.

111 B Es un CAV clásico.

112 E La sospecha es un TEP, que se estudia preferentemente con angioTAC de tórax.

113 C Pésima pregunta. Quien sea que la haga hecho, por favor renuncie al Eunacom. Excede por demasiado lo que debe saber un médico general. Tiene un marcador aislado de aneuploidía (solo tenía la regurgitación mitral, pero estaba normal la translucencia nuchal, había hueso nasal presente y el ductus venoso estaba normal), por tanto, su probabilidad de aneuploidía es relativamente baja. Se debería controlar con una nueva Ecografía obstétrica en algunas semanas más. De las opciones que aparecían, el ecocardiograma fetal (que se realizaría después por un subespecialista) podría descartar problemas cardíacos primarios. De las demás opciones, todas eran análisis genético (el de menos riesgo es el DNA libre fetal, pero no hay suficiente evidencia que lo recomiende).

114 B Es un síndrome de abstinencia moderado. No tiene delirium tremens, ni convulsiones (sería severo).

115 A Era una fitofotodermatitis por litre (árbol de la zona central chilena).

116 D Es una mala pregunta, porque la clínica orienta a enfermedad de Crohn, que no aparecía en las enfermedades. Solo quedaba marcar la colitis ulcerosa, pero las úlceras orales no son compatibles.

117 D Es una tricomoniasis y el frotis permite ver a las tricomonas.

118 A Era una leucemia aguda clásica.

119 C La disección era la única opción posible. Sigue siendo un cuadro raro.

120 D En mi opinión tiene indicación de reemplazo articular. Pero la decisión exacta corresponde al especialista, según cada caso.

121 B La primera línea de tratamiento en la artrosis, es el paracetamol.

122 E Eso dice el PNAC, así que ya saben: según Asofamech, hay que saberlo. No debería preguntarse este tipo de cosas.

123 E Es una fiebre faringoconjuntival clásica por ADV.

124 D Es una bacteriuria asintomática en el paciente sondeado. Al igual que la mayoría de las bacteriurias asintomáticas, no requiere tratamiento.

125 C La mejora de la AV al mirar por un agujero estenopeico es característico de los vicios de refracción.

126 E Es un púrpura de Schönlein Henoch, que suele producir glomerulonefritis.

127 D Eran grietas del pezón, que si bien no tienen un tratamiento claro, más allá de mejorar la técnica de lactancia materna, se suele tratar con lanolina.

128 D Es una hepatitis A recurrente (una de las forma de presentación de la hepatitis A).

129 A Es una esquizofrenia clásica.

130 B El tratamiento de elección de la influenza es sintomático. La amantadina no sirve en los tipos B y el oseltamivir casi no sirve después de 48 horas.

131 E Sería una amenorrea secundaria, probablemente por anovulación. Aunque niegue vida sexual, lo primero es un test de embarazo. Luego, en adolescentes, se hace la prueba de progesterona, si es que alcanza a hacer amenorrea de 3 meses. Sin embargo, no se debe olvidar que dentro de los 2 primeros años post menarquia es normal tener todo tipo de alteraciones menstruales.

132 E Pregunta específica. La fosita pilonidal suele ser normal, a menos que sea atípica; en cambio el seno dérmico sacro debe estudiarse. (si es que aparecía hemangioma, también es una alteración que obliga a descartar espina bífida oculta).

133 B Tienen un TTGO mayor o igual a 140, lo que en una mujer embarazada es DMG.

134 D Pregunta que induce a error. El *Cryptosporidium* es la causa más frecuente de diarrea en el VIH. Sin embargo el criptococo no produce diarrea, sino meningitis y neumonía. Por otro lado el *microsporidium* puede producir diarrea, pero su rol patológico es algo muy discutido.

135 E Tiene una presentación de cara, que se maneja con cesárea, salvo que sea mento-anterior, que no es el caso.

136 C Es un cáncer de recto clásico.

137 B Tiene una displasia de cadera menor a 9 meses, que se trata con arnés de Pavlik.

138 E Es una neoplasia trofoblástica gestacional, que se trata con histerectomía y posteriormente sí recibirá metotrexato.

139 C El uso de progestágeno en la TRH está solo indicado para evitar el cáncer de endometrio. Si hay histerectomía, se hace innecesario dar progestágeno y se dan estrógenos solos.

140 B Es una tortícolis espasmódica clásica, que es un tipo de distonía.

141 ¿C? El tamizaje no baja la incidencia. La prevalencia baja tanto porque se mejoran, como porque se mueren. La letalidad es un buen indicador, porque al diagnosticar precozmente, se evita la muerte. La mortalidad también sería un indicado bueno, menos exacta, pero más disponible.

142 A Eran manchas café con leche, que si son más de 6, se asocian a NF1.

143 C Era un prolapso uterino completo. Si fuera una mujer sana, se haría cirugía electiva (no de urgencia), pero dado que era una paciente con alzheimer avanzado, se puede dejar pesario.

144 D Aunque haya tenido antecedente de epilepsia, el diagnóstico ahora es una eclamisia, que en primer lugar recibe MgSO₄.

145 D Tiene un hipogonadismo hipogonadotrópico, por tanto probablemente es hipotálamico o hipofisiario.

146 B Todo nódulo cervical se estudia inicialmente con Ecografía de cuello.

147 E Tiene una metrorragia, sin embarazo y con Ecografía que muestra endometrio grueso. Además tienen antecedente de obesidad, que aumenta el riesgo de hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio. P´or tanto, se debe biopsias.

148 D Tiene una osteoporosis (T score menor o igual a -2,5), por lo que se debe iniciar bifosfonatos. Sin embargo también tiene que recibir vitamina D y calcio. No debería haber distractores correctos.

149 C Está con hipoglicemias por insulina. La NPH nocturna es la que determina las glicemias a las 3 a.m., por lo que se debe disminuir esa.

150 ¿C, D? Pregunta demasiado específica y difícil y con todo al límite (si quien hizo esta pregunta es la misma persona que preguntó lo de la regurgitación tricuspídea, le comunico que no tiene idea de qué debe o no debe saber un médico general). Es una RPO y dado que la edad gestacional es dudosa, se hizo una biometría que tiene un rango de error de 3 semanas: así tiene entre 27 y 33 semanas. Al haber un ILA de 5,2 (aunque no describen el bolsillo, como para saber si se puede o no hacer una amniocentesis), se puede hacer una amniocentesis para determinar madurez fetal: si está maduro, se interrumpe; si no, se mantiene la conducta expectante. Yo creo que la respuesta es la D. La alternativa C también es muy aceptable.

151 A La única opción aceptable era la angina de reciente comienzo.

152 E Es una agorafobia clásica: miedo a no recibir ayuda.

153 ¿A, C, E? Falta información sobre el estado general del paciente. Además no se sabe la saturación basal del paciente. Una saturación de 91%, por regla general requiere hospitalización y por tanto ceftriaxona (yo marque E), pero si basalmente desatura, por ser EPOC, podría bastar el tratamiento oral.

154 D Es una glomerulonefritis (por la hematuria dismórfica), asociada a EBSA (por complejos inmunes), por la hipocomplementemia.

155 ¿A, C? También me parece una agorafobia por el miedo en relación a los lugares descritos (yo marqué A). Sin embargo, también puede ser un trastorno de angustia con

agorafobia (por a angustia episódica).

156 E El UCT por recolector solo es positivo si es mayor a 100.000 UFC por ml. Así que repetirlo por sondeo es la única opción aceptable.

157 D Si bien parecía a simple vista una fibromialgia, la edad, la VHS alta y las Ck elevadas hacen sospechar una plomialgia reumática.

158 E Parece una convulsión febril benigna. No tiene signos que hagan sospechar meningitis y por ser la primera convulsión, tampoco es necesario iniciar naticonvulsivantes.

159 D Tienen una fase activa lenta, que requiere de una prueba de trabajo de parto (romper membranas, anestesia y goteo oxitócico si las contracciones son menores a 3 en 10 min: no es el caso).

160 A Es una procidencia de cordón. Se diagnostica con el TV y permite empujar la cabeza fetal, para evitar la muerte del feto, hasta que se haga la cesárea.

161 B La Seremi de Salud es la autoridad sanitaria y por tanto quien da las autorizaciones sanitarias.

162 C Es un tumor testicular, confirmado con la ecografía, por lo que se debe realizar la orquiectomía radical, con biopsia excisional.

163 C Era un herpes periocular.

164 B Es un exudado pleural mononuclear y por tanto se debe biopsiar. Una forma nueva de hacer la biopsia es la videotoracoscopia, que tiene más sensibilidad y si está disponible, puede ser de mayor utilidad que las biopsias percutáneas (que no aparecían).

165 A Dado que hay dilatación del colédoco (mayor a 7 mm), lo más probable es que sea una colédocolitiasis. Las colestasias farmacológicas suelen producirse a nivel hepático y no a nivel del colédoco.

166 B Es un síndrome de discontinuación de ISRS clásico.

167 B Es una medida clásica de prevención primaria, de tipo prevención específica.

168 C La maniobra de McRoberts es el manejo de primera línea en la distocia de hombros, ya que tiene 90% de éxito y bajísima morbilidad.

169 A Es un cuerpo lúteo heorrágico clásico.

170 D Es un absceso periamigdalino clásico.

171 D Tiene un derrame pleural, que debe ser puncionado, para analizar el líquido.

172 D? Es una mala pregunta, ya que no indican el nivel de alergia la penicilina. En general, la alergia a la penicilina no contraindica a las cefalosporinas y la cefazolina es más potente antibiótico que la clindamicina. Sin embargo, si es que ha habido un shock anafilático o angioedema, sí se contraindican las cefalosporinas. La clindamicina es una buena opción y no tiene ninguna contraindicación por la alergia.

173 B Confundía el hecho de haber dolor en la zona, lo que orientaba a un síndrome compartimental, pero solo se describía la afectación del nervio radial, sin otras alteraciones, por lo que lo más probable es que haya sido la neurapraxia.

174 A La intoxicación con tricíclicos produce taquicardias ventriculares, que es lo más grave.

175 ¿E? La clásica causa de orquiepididimitis es la infección por clamidia y luego gonorrea (yo marqué Chlamydia). Sin embargo, la E. Coli es la causa más frecuente cuando no hay infección de transmisión sexual y es especialmente frecuente en adultos mayores. En este caso, si le creíamos que tenía pareja única, la respuesta probablemente era E. Coli.

176 C Es un embarazo ectópico y por tener líquido libre y también más de 3.000 de HCG, es de tratamiento quirúrgico.

177 C Es una hemorragia vítrea clásica, con todo y pérdida de rojo pupilar.

178 D Es una manía aguda, en contexto del uso de antidepresivos. Por tanto es un trastorno bipolar.

179 C Tiene una cervicometría menor a 25 mm, por lo que se debe hacer algo: Si no tuviera antecedentes de partos prematuros o abortos tardíos, tendría indicación de progestágenos endovaginales. Si por el contrario tiene esos antecedentes, como en este caso,

además de los progestágenos, se debe cerclar. Igual está mal que en una opción aparezca un distractor que es correcto.

180 D Lo primero siempre es descartar embarazo.

Todos los Derechos Reservados para DrGuevara



RECONSTRUCCIÓN EUNACOM DICIEMBRE 2018

Instrucciones:

- Dispone de 90 minutos para responder la primera parte. Se les avisará cuando queden 30 minutos y 10 minutos.
- Conteste con lápiz grafito HB N°2 o 2B. Si se equivoca, la única forma de corregirlo es borrar con una goma de borrar y luego marcar la respuesta correcta.
- Solo se corregirá la hoja de respuesta.
- Las preguntas incorrectas no descuentan puntaje, por lo que no debe omitir.
- El tiempo se hará muy escaso, por lo que debe contestar tan rápido como pueda.

Nota: En las citas de las imágenes, se ha omitido aquello que facilite adivinar la respuesta correcta.

INICIO DEL EXAMEN

1) Un paciente de 18 años consulta por cefalea de algunas semanas de evolución, que ha ido en aumento, hasta alcanzar gran intensidad. En su examen físico destaca presión arterial 170/100 mmHg, FC: 72x' y presencia de un soplo abdominal, en el flanco derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Disección aórtica
- b) Aneurisma aórtico abdominal
- c) Hipertensión esencial
- d) Hipertensión renovascular
- e) Accidente vascular encefálico

2) Un paciente masculino de 23 años, sin antecedentes de importancia consulta por disnea de esfuerzos e intolerancia al ejercicio, progresiva, que actualmente le obligan a caminar más lento. Al examen físico tiene FC: 88x', PA: 150/55 mmHg, choque de la punta en la línea axilar media y latido cervical visible. La auscultación cardíaca muestra ritmo regular, en dos tiempos, con un soplo diastólico IV/VI, con frémito. Al examen pulmonar, se constatan crépitos pulmonares. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia mitral
- b) Estenosis aórtica
- c) Estenosis mitral
- d) Insuficiencia aórtica
- e) Miocardiopatía hipertrófica



3) Un niño de 8 meses es traído, por su madre, al control de niño sano. En el examen físico se ausculta un segundo ruido desdoblado, asociado a un soplo sistólico eyectivo. El diagnóstico más probable es:

- a) Comunicación auricular
- b) Comunicación interventricular
- c) Ductus arterioso persistente
- d) Estenosis aórtica
- e) Coartación aórtica supravalvular

4) Un paciente ingresa al servicio de urgencia, por un cuadro de disnea marcada y síncope. Al examen físico está confuso, con pulso de 200 latidos por minuto, regular y presión arterial de 70/40 mmHg. Además, tiene frialdad de extremidades y piel sudorosa. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado en este momento?

- a) Maniobras vagues
- b) Amiodarona endovenosa
- c) Adenosina endovenosa
- d) Desfibrilación
- e) Cardioversión eléctrica

5) Un paciente de 64 años, con antecedente de hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca, en tratamiento con enalapril, metformina y digoxina, consulta por un cuadro de una semana de evolución de náuseas, asociadas a aumento de su disnea habitual. Al examen físico presenta FC: 114 lpm, regular, edema de extremidades inferiores y al examen pulmonar presenta crepitaciones en ambas bases pulmonares. El examen más adecuado para proseguir el estudio en este paciente es:

- a) Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas.
- b) Niveles plasmáticos de digoxina
- c) Ecocardiografía
- d) Clearance de creatinina
- e) Radiografía de tórax

6) Una paciente de 61 años, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes, diagnosticada hace 2 meses, momento en que inicia tratamiento con enalapril 10 mg/dl, metformina 850 mg cada 12 horas y dieta. Hace 4 semanas inicia tos, que ha ido en aumento, sin expectoración. Su examen físico muestra FC: 67 x', PA: 120/80 mmHg y su auscultación cardiopulmonar es normal, al igual que la radiografía de tórax. La conducta más adecuada es:

- a) Suspender el IECA
- b) Agregar hidroclorotiazida
- c) Solicitar espirometría
- d) Agregar salbutamol
- e) Agregar codeína



7) Una paciente de 75 años, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes, en tratamiento con metforminal, glibenclamida, hidroclorotiazida y enalapril consulta por un cuadro de cefalea y malestar general. Refiere que sus presiones arteriales habituales son cercanas a 150/90 mmHg. Al examen físico presenta PA: 200/105 mmHg, FC: 73 x', con examen pulmonar normal. ¿Cuál es el tratamiento del cuadro actual?

- a) Nifedipino sublingual
- b) Nitroglicerina sublingual
- c) Nitroprusiato endovenoso
- d) Captopril oral
- e) Labetalol endovenoso

8) Un paciente de 42 años consulta por tos y disnea de 2 semanas de evolución, asociada a expectoración mucopurulenta y, en ocasiones, hemoptoica. Además, ha presentado fiebre ocasional, hasta 38,2°C. Al examen físico presenta estertores bilaterales en ambos campos pulmonares. Se solicitaron baciloscopías de expectoración, que resultan negativas. Además, se solicita otros exámenes, que muestran quantiferón para tuberculosis (+) y PCR para Mycobacterium tuberculosis (+). Su radiografía de tórax se muestra más abajo.

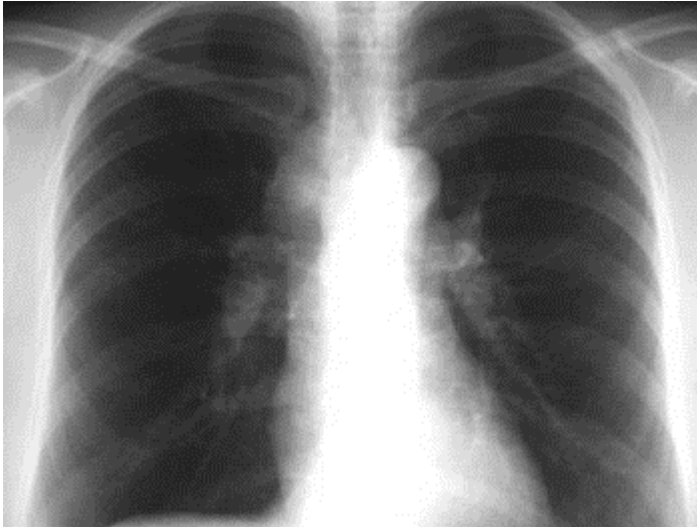


Foto 1 (https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-93082004000400006)

(La imagen ha sido ennegrecida, para que se parezca a las imágenes reales del Eunacom impreso).

La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar profilaxis con isoniazida
- b) Iniciar rifampicina más isoniazida
- c) Iniciar tratamiento habitual para la tuberculosis
- d) Solicitar TAC de tórax
- e) Esperar el resultado del cultivo de Koch y decidir conducta según resultado



9) Un paciente de 51 años presenta, desde hace 5 días, un cuadro de disnea, que ha ido en aumento, con compromiso del estado general y fiebre hasta 38°C, asociada a tos y expectoración mucopurulenta. Además, presenta dolor tipo puntada de costado izquierdo. Al examen físico está enflaquecido, tiene PA: 110/70 mmHg, FC: 96x', FR: 28x', satura 91% a FiO2 ambiental. En el examen pulmonar se aprecia disminución del murmullo pulmonar en la base izquierda, asociados a estertores bilaterales. Se solicita un hemograma que muestra blancos: 15.000 por mm3, plaquetas: 250.000 por mm3 y hematocrito: 38% y una radiografía de tórax, que se muestra a continuación.



Foto 2 (<https://www.neumosur.net/files/EB04-24%20XXXXXXXX%20XXXXXXXX.pdf>)

¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Solicitar baciloscopías de desgarro
- b) Realizar cirugía
- c) Solicitar ecografía de tórax
- d) Solicitar TAC de tórax
- e) Realizar toracocentesis evacuadora y diagnóstica

10) Un paciente de 38 años consulta por malestar general y fiebre de 3 días de evolución, asociada a mialgias, tos seca y rinorrea mucosa abundante. Al examen físico tiene secreción nasal y faringe congestiva y eritematosa. ¿Cuál es el fármaco más adecuado para el manejo de este paciente?

- a) Amoxicilina
- b) Aciclovir
- c) Acetaminofeno
- d) Claritromicina
- e) Prednisona



11) Un paciente de 76 años, jubilado de la minería y fumador de 20 paquetes año consulta por tos y disnea de 2 meses de evolución, asociada a expectoración mucosa, que a veces tiene estrías de sangre. Ha bajado 4 kilogramos de peso y presenta astenia. Su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar conservado, bilateral, con escasos crépitos y sibilancias, mayores en el lado derecho.

Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación:



Foto 3 (https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-93082004000400006)

¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?

- a) TAC de tórax
- b) Broncoscopía
- c) Baciloscopías
- d) PET
- e) Resonancia magnética de tórax

12) Un hombre de 23 años consulta por dolor abdominal de 2 meses de evolución, que ha ido en aumento y se asocia a diarrea acuosa. Al examen físico se palpa abdomen sensible, con ruidos hidroaéreos conservados. Hace 2 días aumenta el dolor y la diarrea, por lo que se solicita una TAC de abdomen y pelvis, que muestra engrosamiento del íleon distal y del ciego, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?

- a) Endoscopia digestiva alta
- b) Resonancia magnética de abdomen
- c) Ecografía abdominal
- d) Colonoscopia
- e) Parasitológico de deposiciones y coprocultivo



13) Un paciente de 38 años, con antecedente de colitis ulcerosa, desde hace 4 años, consulta por astenia y prurito de 5 meses de evolución, que han ido en aumento y que se ha asociado a ictericia de piel y mucosas. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran Bilirrubina: 6 mg/dl, Bilirrubina directa: 4,1 mg/dl, FA: 412 UI/L, GGT: 507 UI/L, GOT: 180 UI/L y GPT: 120 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Colangitis esclerosante
- b) Esteatohepatitis
- c) Hepatitis autoinmune
- d) Coledocolitiasis
- e) Cirrosis biliar primaria

14) Un paciente de 52 años presenta hematoquecia de 2 días de evolución, sin otros síntomas. Sus signos vitales muestran PA: 120/80 mmHg, FC: 75x' y T°: 36°C. Al examen físico, tiene leve palidez de mucosas y su abdomen es blando y depresible, sin masas ni visceromegalia y con preservación de los ruidos hidroaéreos. Se solicita una colonoscopia, que es normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

- a) Cintigrafía con glóbulos rojos marcados
- b) Endoscopia digestiva alta
- c) TAC de abdomen y pelvis
- d) Angiografía mesentérica
- e) Enteroscopia

15) Un paciente masculino, de 34 años, consulta por dolor abdominal epigástrico, de dos meses de evolución, mayor postprandial y que cede con antiácidos. En el último tiempo se agregan vómitos postprandiales. Hace pocos días presentó un episodio de dolor nocturno, de moderada intensidad. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio en este paciente?

- a) Ecografía abdominal
- b) pH esofágico de 24 horas
- c) Radiografías baritadas de esófago, estómago y duodeno
- d) Endoscopia digestiva alta
- e) TAC de abdomen y pelvis

16) Un joven de 14 años, deportista de alto rendimiento, consulta por un cuadro de polidipsia y poliuria de 3 semanas de evolución, al que hace 7 días se agrega astenia, náuseas y malestar general. Refiere marcada debilidad, después de realizar ejercicio. Se solicitan exámenes, en las que destaca glicemia: 312 mg/dl, Na+: 132 mEq/L, K+: 5,0 mEq/L, pH sanguíneo: 7,26, bicarbonato plasmático: 11 mEq/L, exceso de base: -13. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hiperglicemia secundaria al ejercicio
- b) Cetoacidosis diabética
- c) Debut de diabetes tipo 2
- d) Diabetes insípida descompensada
- e) Coma hiperosmolar



17) Un hombre de 33 años, obeso, consulta por polidipsia y baja de peso de 6 kilogramos, en los últimos dos meses. Su examen físico no aporta mayor información. Se solicitan exámenes, entre los que destacan glicemia de ayuno de 245 mg/dl y hemoglobina glicosilada: 9,2%. El tratamiento inicial más adecuado es:

- a) Metformina
- b) Sitagliptina
- c) Insulina
- d) Liraglutide
- e) Glibenclamida

18) Una paciente de 28 años aumento de peso de 5 meses de evolución, asociado a malestar general. Refiere importante astenia, que ha progresado y debilidad muscular. Al examen físico presenta PA: 150/100 mmHg, atrofia de las masas musculares de las extremidades, obesidad abdominal y piel con estrías vinosas en la pared abdominal e hirsutismo en cara, abdomen y pecho. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?

- a) Niveles de ACTH plasmático matinal y vespertino
- b) 17 hidroxiprogesterona
- c) TAC de silla turca
- d) Cortisol libre urinario de 24 horas
- e) Prueba de estimulación con ACTH

19) Una paciente de 22 años consulta por amenorrea de 4 meses de evolución, sin otras alteraciones. Se realiza exámenes, que muestran test de embarazo negativo, TSH y prolactina, que están dentro de rangos normales. Se solicita prueba de progesterona, que resulta negativa y prueba de estrógeno y progesterona, que resulta positiva. Además, se solicita LH y FSH, que están normales, dentro del límite bajo. El diagnóstico más probable es:

- a) Prolactinoma
- b) Falla ovárica primaria
- c) Embarazo ectópico
- d) Amenorrea hipotalámica
- e) Síndrome de ovario poliquístico

20) Un paciente tiene diarrea de 3 días de evolución, asociada a malestar general marcado y vómitos alimentarios, con deterioro del estado general. Al examen físico se observa deshidratado, con FC: 110 x', PA: 70/40 mmHg, abdomen doloroso, sin irritación peritoneal. Se solicitan exámenes, entre los que destacan Na⁺: 126 mEq/L, K⁺: 4,7 mEq/L, glicemia: 58 mg/dl, PCR: 4,0, blancos: 12.000 por mm³, creatinina 2,3 mg/dl. Se administran 3 litros de suero fisiológico, sin lograr estabilizar al paciente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Insuficiencia renal aguda
- b) Shigelosis
- c) Peritonitis aguda
- d) Insuficiencia suprarrenal aguda
- e) Accidente vascular hemorrágico



21) Una paciente de 17 años, con hábitos de vida sedentarios y obesidad se realiza exámenes de control, en los que presenta TSH: 6,5 UI/L, T4 libre: 1,5 ng/dl (VN: 0,7 a 1,9 ng/dl) y T3 libre 300 pg/dl (VN: 130 a 450 pg/dl). La conducta más adecuada es:

- a) Inicial levotiroxina
- b) Controlar hormonas tiroideas en 6 meses
- c) Solicitar anticuerpos antiperoxidasa tiroidea
- d) Solicitar ecografía tiroidea
- e) Solicitar cintigrafía tiroidea con yodo radiactivo

22) Un hombre de 55 años, diabético de larga data, presenta temblor de reposo y lentitud al realizar actividades, como vestirse, lo que se ha asociado a dificultades para iniciar la marcha. Relata que se había caído hacia adelante, en dos oportunidades, al empezar a caminar. Al inicio de la marcha es lento e inseguro, pero luego alcanza una velocidad normal, la que se mantiene por el resto del tiempo. No presenta disminución de las fuerzas de las extremidades y sus reflejos osteotendíneos son normales, al igual que la sensibilidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Parkinson
- b) Enfermedad de Alzheimer
- c) Polineuropatía diabética
- d) Polimialgia reumática
- e) Miopatía por cuerpos de inclusión

23) Un paciente de 29 años consulta por un cuadro de 7 días, progresivo, de disminución de la fuerza muscular, tanto en las extremidades superiores, como en las inferiores, siendo mayor en las inferiores. Tiene el antecedente de haber sufrido una influenza hace 14 días. Al examen físico tiene arreflexia aquiliana bilateral, asociada a hiporreflexia rotuliana mayor a derecha, con paresia M4 en las extremidades superiores y M3 en las inferiores. El diagnóstico más probable es:

- a) Radiculopatía S1 derecho
- b) Polineuropatía desmielinizante aguda
- c) Meningitis viral
- d) Mielopatía por influenza
- e) Miositis viral

24) Un paciente de, con antecedente de hipertensión arterial crónica y caídas, consulta por cefalea de instalación brusca, hace algunas horas, asociado a imposibilidad de mover las extremidades derechas. Al examen neurológico presenta hemiplejia armónica derecha, sin alteraciones sensitivas, del habla ni del estado de conciencia. El diagnóstico más probable es:

- a) Hematoma subdural
- b) Accidente vascular encefálico lacunar
- c) Accidente de la arteria cerebral media izquierda
- d) Accidente vascular hemorrágico del puente
- e) Hemorragia subaracnoidea



25) Un paciente, con antecedente de tiroidectomía total e hipoparatiroidismo, en tratamiento con levotiroxina, calcio y vitamina D, por vía oral, presenta diarrea aguda, de 2 días de evolución, abundante. Evoluciona con astenia, marcada debilidad, dolor en las extremidades inferiores y calambres. Al examen físico tiene reflejos osteotendíneos vivos y signo de Chvostek positivo. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Suero fisiológico endovenoso
- b) Gluconato de calcio endovenoso
- c) Suero glucosado con potasio endovenoso
- d) Suero Ringer endovenoso
- e) Hidrocortisona endovenosa

26) Un paciente de 62 años presenta edema de extremidades inferiores, asociada a malestar general y aumento de volumen facial. Al examen físico tiene FC: 60x', PA: 120/80 mmHg, edema de párpados y de extremidades inferiores, con signo de la fóvea. Se solicitan exámenes, que muestran glicemia: 147 mg/dl, hemoglobina glicosilada: 6,8%, sedimento de orina con 5 eritrocitos por campo y 2 a 3 leucocitos por campo, proteinuria de 500 mg/dl, colesterol total: 411 mg/dl, albúmina plasmática: 2,1 g/dl y creatinina: 0,9 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Nefropatía diabética
- b) Nefropatía membranosa
- c) Nefropatía lúpica
- d) Nefropatía a cambios mínimos
- e) Nefropatía por IgA

27) Un niño de 8 años presenta dolores óseos generalizados, asociada a malestar general y fiebre de 3 semanas de evolución. Al examen físico se palpa el bazo aumentado de tamaño e indurado, se constatan poliadenopatías indoloras y se observan petequias y equimosis generalizadas, mayores en las extremidades inferiores ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

- a) Cintigrafía ósea
- b) Hemograma
- c) Biopsia esplénica
- d) Mielograma
- e) Cuantificación de inmunoglobulinas



28) Una mujer de 30 años presenta un cuadro de malestar general y artralgiás de varias semanas de evolución, asociada a febrícula ocasional. Al examen físico se aprecia rash facial, úlceras orales, alopecia difusa, artritis de varias articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas de ambas manos.

Se solicitan exámenes, entre los que se encuentran hemograma con hematocrito: 30%, hemoglobina: 10 g/dl, leucocitos: 4.000 por mm³, con 15% de linfocitos, además se solicitan ANA (+) en dilución 1:640, Anti-DNA de 2 hebras (+) en dilución 1:160, C3: 60 mg/dl, C4:11 mg/dl, factor reumatoide: 65 U/ml y Anti-CCP (-). El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis reumatoide
- b) Púrpura trombocitopénico trombótico
- c) Lupus eritematoso sistémico
- d) Vasculitis
- e) Dermatomiositis

29) Una paciente de 42 años presenta artritis de las articulaciones interfalángicas distales y proximales de ambas manos, con afectación reciente de una articulación metatarsofalángica. Al examen físico, además de las artritis descritas, presenta múltiples depresiones en las uñas de las manos y engrosamiento de las uñas de los pies.

¿A qué tipo de artritis corresponde este cuadro?

- a) Reumatoide
- b) Reactiva
- c) Psoriática
- d) Gotosa
- e) Lúpica

30) Un paciente de 56 años, hipertenso y dislipidémico, en tratamiento con hidroclorotiazida y atorvastatina, consulta por dolor muy intenso en el pie derecho, especialmente en el primer orjejo, que inició hace algunas horas. Al examen físico tiene eritema del orjejo, el que es muy doloroso a la movilización. Se observa edema en dicho orjejo y en la zona bimalleolar. Se solicitan exámenes, que muestran hemograma, con leucocitos de 12.000 por mm³, PCR: 2 (VN: menor a 1 mg/L), ácido úrico: creatinina: 0,8 mg/dl. ¿Cuál es el primer fármaco que debe administrarse para el manejo actual de este paciente?

- a) Diclofenaco sódico
- b) Cloxacilina
- c) Alopurinol
- d) Prednisona
- e) Clindamicina



31) Una paciente de 47 años, con antecedente de pirosis y dolor epigástrico de 8 meses de evolución, consulta por disfagia ilógica, de localización alta, que ha ido en aumento. Refiere fenómeno de Raynaud y al examen físico se aprecia esclerodactilia, telangiectasias en el pecho y piel de la cara indurada, sin líneas de expresión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Acalasia esofágica
- b) Esclerosis sistémica
- c) Dermatomiositis
- d) Lupus eritematoso sistémico
- e) Enfermedad mixta del tejido conectivo

32) Un paciente de 68 años, con antecedente de hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial y diabetes, está en tratamiento con tamsulosina, atenolol, hidroclorotiazida, metformina y aspirina. Consulta por dificultades para lograr y mantener la erección, lo que le preocupa. ¿Qué fármaco puede ser el causante de estos síntomas?

- a) Aspirina
- b) Metformina
- c) Hidroclorotiazida
- d) Tamsulosina
- e) Atenolol

33) Una paciente, con antecedente de parto hace 3 meses, realizado por cesárea, VIH positivo, en tratamiento antirretroviral, con cargas virales indetectables y sin lactancia materna, consulta por un tratamiento anticonceptivo. ¿Cuál es el método de elección?

- a) Anticonceptivos orales combinados
- b) Anticonceptivos orales con progestágeno solo
- c) Anticonceptivos orales con estrógeno solo
- d) Preservativo
- e) Dispositivo intrauterino

34) Una paciente de 32 años presenta imágenes recurrentes, en que se ve a sí misma matando a su hijo de 12 meses, con un cuchillo. Por ello, sacó todos los cuchillos de la casa y nunca se queda a solas con él. Está muy angustiado y triste, porque no quiere que le pase nada malo a su hijo y teme perder la tuición del niño. Ha pensado incluso en morir, con tal de proteger a su familia. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno bipolar
- b) Trastorno delirante
- c) Trastorno obsesivo compulsivo
- d) Trastorno depresivo mayor
- e) Trastorno de estrés postraumático



35) Una paciente de 52 años, con antecedente de abuso sexual reiterado por un familiar, entre los 12 y los 14 años, refiere episodios de ánimo irritable y lábil, asociada a ira y peleas con sus familiares, con llanto y agresividad, que luego de algunos días mejoran. Estos episodios le traen problemas con sus cercanos y, en algunas ocasiones, son muy intensos, en especial cuando se expone a conversaciones relacionadas con el tema, en los que llora, siente intensa angustia, grita e incluso actúa como niña y luego no lo recuerda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno bipolar
- b) Trastorno delirante
- c) Trastorno esquizoafectivo
- d) Trastorno esquizotípico
- e) Trastorno de estrés postraumático

36) Un paciente esquizofrénico inicia tratamiento con risperidona oral y evoluciona con intranquilidad, especialmente de las extremidades inferiores, disestesias en las piernas y angustia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Distonía aguda
- b) Acatisia
- c) Hipomanía
- d) Disquinesia tardía
- e) Parkinsonismo farmacológico

37) Una paciente de 28 años presenta episodios súbitos de marcada angustia, con miedo a morir y síntomas como disnea con “imposibilidad de sacar el aire”, vértigo, parestesias en las extremidades, imposibilidad de tragar, opresión en el pecho, náuseas, visión borrosa y sensaciones eléctricas en el cuerpo, en los que siente la necesidad de salir corriendo para su casa. Ha presentado 5 episodios en las últimas 4 semanas y está muy preocupada por lo que le está pasando. Los exámenes generales descartan patología orgánica. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente?

- a) Amitriptilina 150 mg
- b) Sertralina 50 mg
- c) Risperidona 3 mg
- d) Clonazepam 6 mg
- e) Clorpromazina 300

38) Un paciente de 18 años, adicto a la pasta base, presenta un episodio psicótico, en relación al consumo, el que es manejado con haloperidol intramuscular. Al día siguiente presenta contracción tónica del cuello, que desvía la cabeza hacia la izquierda, con intenso dolor. El diagnóstico más probable es:

- a) Distonía aguda
- b) Acatisia
- c) Síndrome neuroléptico maligno
- d) Disquinesia tardía
- e) Parkinsonismo farmacológico



39) Un paciente de 52 años presenta un cuadro de alucinaciones auditivas, desde la adolescencia. En el último tiempo, las alucinaciones se intensifican, escuchando voces que la insultaban y le decían que se suicidara. Está muy angustiada y se ha sentido triste por lo que le sucede. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Trastorno esquizoafectivo
- d) Trastorno depresivo mayor
- e) Trastorno esquizotípico de la personalidad

40) Una niña de 2 años ingirió muchas pastillas, que había en la casa. Al examen físico, está inconsciente, pálida e hipotónica, con pulso a 117 por minutos, frecuencia respiratoria de 38 por minuto y pupilas arreactivas a la iluminación. ¿Qué fármacos son los más probablemente ingeridos?

- a) AINES
- b) Benzodicepinas
- c) Salicilatos
- d) Opiáceos
- e) Antidepresivos tricíclicos

41) La notificación obligatoria de ciertas enfermedades transmisibles tiene como objetivo:

- a) Evaluar la efectividad de las vacunas administradas a la población
- b) Identificar las enfermedades infecciosas más importantes en la población
- c) Determinar la propagación de las enfermedades más letales
- d) Identificar y controlar situaciones epidémicas
- e) Reunir información estadística completa y confiable, para determinar las políticas de salud

42) Un paciente consulta por dolor y aumento de volumen en la pierna derecha. ¿Qué característica del dímero D es aquella que permite descartar una trombosis venosa profunda cuando resulta negativo?

- a) Alta especificidad
- b) Alta sensibilidad
- c) Elevado valor predictivo negativo
- d) Elevado valor predictivo positivo
- e) Baja especificidad

43) Una prueba de tamizaje obligatoriamente debe tener:

- a) Alta especificidad, sin importar la sensibilidad
- b) Alta sensibilidad, independiente de la especificidad
- c) Alto valor predictivo positivo y facilidad en su aplicación
- d) Bajo valor predictivo negativo y reproductibilidad
- e) Bajo costo y baja sensibilidad



44) ¿Qué tipo de vigilancia se utiliza en patologías como las infecciones respiratorias altas, las diarreas y las enfermedades de transmisión sexual?

- a) Vigilancia activa
- b) Vigilancia centinela
- c) Vigilancia de notificación obligatoria
- d) Estudios de prevalencia
- e) Estudios experimentales

45) En un estudio se realiza la medición de los niveles plasmáticos promedio de pesticidas, en la población de distintos países y se correlaciona con las tasas de mortalidad por cáncer. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

- a) Ecológico
- b) Cohortes
- c) Caso control
- d) Observacional
- e) Experimental

46) Un estudio investiga la correlación entre el uso de drogas durante el embarazo y las alteraciones cognitivas en los niños. Para ello, se selecciona a un grupo de niños con discapacidad cognitiva y se compara con otro grupo de niños sanos, realizándole una entrevista a la madre, sobre la exposición a distintos factores de riesgo, durante el embarazo. ¿Qué medida de asociación se debe utilizar en este estudio?

- a) Riesgo relativo
- b) Riesgo atribuible
- c) Riesgo atribuible poblacional
- d) Odds ratio
- e) Incidencia

47) ¿Qué tipo de estudio es el indicado para evaluar la realización de intervenciones focalizadas y solicitar financiamiento para ellas?

- a) Estudio de cohortes
- b) Estudio de incidencia
- c) Estudio de casos y controles
- d) Estudio experimental
- e) Estudio ecológico



48) Un hombre de 50 años consulta por disuria dolorosa y fiebre, asociada a malestar general, polaquiuria y dolor perineal. Al examen físico presenta fiebre alta, con hemodinamia estable. Se realizan exámenes entre los que destacan sedimento de orina con leucocitos +++, bacterias ++. Su urocultivo está pendiente. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?

- a) Ciprofloxacino
- b) Amoxicilina
- c) Claritromicina
- d) Nitrofurantoína
- e) Doxiciclina

49) Un paciente de 63 años consulta por impotencia sexual de algunos meses de evolución, que ha avanzado. Tiene antecedente de diabetes de 20 años de evolución. Está preocupado, ya que le ha provocado problemas maritales. El tratamiento más adecuado es:

- a) Inyecciones intracavernosas de papaverina
- b) Yohimbina
- c) Sildenafil
- d) Prótesis peneana
- e) Psicoterapia

50) Una paciente de 80 años sufrió una caída a nivel, luego de la cual no pudo levantarse, presentando mucho dolor. Al examen físico presenta acortamiento de la extremidad inferior derecha, con ligera abducción y rotación externa, sin equimosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Esguince de cadera
- b) Fractura de cadera
- c) Luxación posterior de cadera
- d) Fractura de pelvis
- e) Fractura vertebral con lesión del plexo lumbar

51) Un paciente de 28 años sufre un accidente de tránsito de alta intensidad, por lo que es trasladado al servicio de urgencia. En la evaluación inicial tiene presión arterial de 90/50 mmHg, frecuencia cardíaca 115x' y se aprecia adolorido. Al examen, además, tiene dolor intenso al comprimir la zona iliaca y púbica y al realizar movimientos de rotación de la pelvis. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Instalar sonda Foley
- b) Realizar laparotomía exploradora
- c) Realizar radiografía AP de pelvis
- d) Instalar sábana pélvica
- e) Solicitar TAC de pelvis



52) Un paciente de 63 años consulta por dolor progresivo, de una semana de evolución, en la cara lateral de la cadera, que aumenta con la caminata y limita sus movimientos. Además, en el último tiempo, le impide dormir para ese lado. Al examen físico tiene dolor a la palpación de la cara externa de la cadera y a la rotación externa forzada. El diagnóstico más probable es:

- a) Coxartrosis
- b) Fractura incompleta de cadera por estrés
- c) Hernia del núcleo pulposo, con radiculopatía L2
- d) Bursitis trocantérica
- e) Síndrome de la fascia lata rígida

53) Un paciente de 38 años, con antecedente de cirugía bariátrica, consulta por dolor abdominal tipo cólico y vómitos de 10 horas de evolución, que inició al día siguiente de una gran ingesta de alcohol y alimentos. Refiere que no ha eliminado gases. Al examen físico está adolorido, con FC: 106x', PA: 120/80 mmHg, T°: 37,6°C. El abdomen se aprecia distendido y es doloroso a la palpación, sin Blumberg. Se auscultan los ruidos hidroaéreos aumentados de intensidad y bazuqueo. El diagnóstico más probable es:

- a) Pancreatitis aguda
- b) Embolia mesentérica
- c) Úlcera gastroduodenal complicada
- d) Colecistitis aguda
- e) Obstrucción intestinal por bridas

54) Una paciente de 39 años, con antecedente de obesidad, se realiza una ecografía abdominal que muestra hígado graso leve, con presencia de un quiste hepático simple de 1,0 cm y un pólipo vesicular de 0,5 cm. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar biopsia por punción del pólipo
- b) Controlar con una nueva ecografía en 6 meses
- c) Realizar laparotomía exploradora
- d) Realizar colecistectomía laparoscópica
- e) Realizar punción del quiste hepático

55) Un paciente de con antecedente de cáncer gástrico avanzado, con metástasis hepáticas múltiples y adenopatías perigástricas, consulta por cuadro de vómitos postprandiales intensos, que han ido en aumento y actualmente dificultan mucho la alimentación. Al examen físico está muy enflaquecido, con ausencia de grasa y con edema de extremidades inferiores. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Instalar sonda nasogástrica
- b) Indicar nutrición parenteral total
- c) Realizar radioterapia de urgencia
- d) Realizar gastrectomía paliativa
- e) Realizar derivación gastrointestinal



56) Una paciente de 53 años presenta cambio del hábito intestinal, caracterizado por diarrea acuosa, de 3 meses de evolución, asociada a dolor abdominal ocasional. Además, ha bajado 4 kilogramos de peso, desde el inicio de los síntomas. Se realizan exámenes de sangre, entre los que destacan hematocrito: 30%, Hemoglobina: 9,7 g/dl y VCM: 69 fl, albúmina: 2,8 g/dl y GOT: 40 UI/L. Tiene antecedente de un hijo con enfermedad celíaca. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio en esta paciente?

- a) Endoscopia digestiva alta, con biopsia de duodeno
- b) Ecografía abdominal
- c) Colonoscopia
- d) Detección de anticuerpos antitransglutaminasa en sangre
- e) Test de sangre oculta en deposiciones

57) Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes e hipertensión, en tratamiento con metformina, glibenclamida y enalapril, consulta por dolor abdominal, de 2 días evolución, mayor en el flanco izquierdo y en la fosa iliaca izquierda, asociado a sensación febril. Al examen físico presenta T°: 38°C, PA: 100/60 mmHg, FC: 88x', abdomen doloroso a la palpación, mayor en la zona, con signos peritoneales localizados en dicha área y disminución de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Infarto del ciego
- b) Trombosis venosa mesentérica
- c) Colitis isquémica
- d) Obstrucción intestinal
- e) Diverticulitis aguda

58) Un paciente de 61 años, fumador, consulta por disfonía de 2 meses de evolución, asociada a aparición de una adenopatía cervical, de consistencia aumentada. ¿Cuál es el examen inicial para el estudio de este paciente?

- a) Radiografías de cuello
- b) Endoscopia digestiva alta
- c) Nasofibroscofia
- d) Ecografía de cuello
- e) TAC de cuello

59) Un niño de 8 años presenta un cuadro de 14 días de congestión nasal con rinorrea purulenta, cefalea, sensación febril, asociada a odinofagia y tos con expectoración mucopurulenta. En los últimos días se agrega mayor malestar general y fiebre. Al examen físico presenta rinorrea purulenta abundante, descarga posterior y faringe congestiva y eritematosa, con examen pulmonar normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Indicar tratamiento sintomático con paracetamol
- b) Iniciar claritromicina oral
- c) Iniciar ceftriaxona endovenosa
- d) Iniciar amoxicilina oral
- e) Solicitar radiografía de tórax y baciloscopías



60) Un niño de 4 meses de edad consulta por epifora del ojo izquierdo y eritema, que no ha respondido al uso de antibióticos tópicos. Al examen físico se aprecia edema y aumento de volumen de la zona medial, con borramiento de la hendidura palpebral y reflujo al comprimir el saco lagrimal. El diagnóstico más probable es:

- a) Glaucoma congénito
- b) Conjuntivitis bacteriana
- c) Atresia lagrimal congénita
- d) Queratitis por Chlamydia trachomatis
- e) Dacriocèle

61) Una paciente de 30 años consulta por aparición de eritema, pápulas y pústulas en ambas mejillas, de varios meses de evolución, que aumentan con la exposición solar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Acné del adulto
- b) Rosácea
- c) Dermatomiositis
- d) Erupción polimorfa solar
- e) Lupus cutáneo crónico

62) Una paciente de 28 años, embarazada de 28 semanas, consulta por aparición de una lesión cutánea en el dedo medio, de algunas semanas de evolución, friable, que ha sangrado en varias oportunidades. Al examen físico, se observa la siguiente fotografía:



Foto 4 (<http://sanchezcarpinterodermatologo.blogspot.com/2013/03/no-todas-las-lesiones-de-la-XXXXXX.html>)

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Verruga vulgar
- b) Granuloma piógeno
- c) Molusco contagioso
- d) Melanoma amelanótico
- e) Carcinoma basocelular



63) Una paciente de 58 consulta por aparición de una lesión pruriginosa, de 3 meses de evolución en el párpado inferior derecho, que ha aumentado de volumen. Al examen físico, se observa lo siguiente:



Foto 5 (<https://martindevoto.com/XXXXXXXXXXXX-foto/>).

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Orzuelo
- b) Verruga vulgar
- c) Herpes simplex
- d) Carcinoma basocelular
- e) Chalazión

64) Un paciente, de 17 años, consulta por aparición de un nódulo blanquecino, que apareció hace 3 semanas, en una zona donde se había puesto un arete y que ha ido aumentando de tamaño. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatofibroma
- b) Quiste dermoides
- c) Neurofibroma
- d) Dermatitis de contacto
- e) Queloides

65) Un paciente de 36 años consulta por disfonía de varios meses de evolución, de predominio matinal, que mejora durante el día y que se intercala con periodos de tiempo, en los cuales no tiene alteraciones de la voz. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar esomeprazol
- b) Iniciar prednisona oral
- c) Solicitar endoscopia digestiva alta
- d) Solicitar radiografías contrastadas de esófago-estómago-duodeno
- e) Solicitar TAC de cuello



66) Un niño de 5 años consulta por un cuadro de 7 días de evolución de rinorrea purulenta, descarga posterior, cefalea, fiebre y obstrucción nasal. En el último tiempo se agrega mayor fiebre, más edema y eritema periocular derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Queratoconjuntivitis viral
- b) Absceso periorbitario
- c) Conjuntivitis bacteriana
- d) Sinusitis maxilar
- e) Absceso frontal

67) Un lactante de 4 meses acude a su control de niño sano. Tiene antecedente de una invaginación intestinal a los 2 meses, ¿cuál de las siguientes vacunas está contraindicada en este paciente?

- a) VPO
- b) VPI
- c) Rotavirus oral
- d) Toxoide tetánico
- e) Toxoide diftérico

68) Un lactante de 12 meses ha comido huevo en dos oportunidades y en ambas ha presentado un exantema eritematoso generalizado, sin otras manifestaciones. ¿Qué conducta es la más adecuada, respecto a la vacuna trivérica?

- a) Administrarla en este momento
- b) Eliminarla de su esquema de vacunación
- c) Administrarla a los 18 meses
- d) Esperar a los 4 años para administrarla
- e) Esperar a que esté en primero básico para administrarla

69) Un niño de 5 años, es traído por su madre, por fiebre hasta 38,0°C y aparición de eritema facial marcado, que luego desaparece, dando paso a aparición de un exantema “en encaje”, que afecta el abdomen, las extremidades superiores y las extremidades inferiores, el que ha persistido por 15 días. Ha recibido ibuprofeno para sus síntomas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Rubéola
- b) Infección por virus Coxsackie A16
- c) Infección por parvovirus B19
- d) Reacción adversa al ibuprofeno
- e) Mononucleosis infecciosa



70) Un niño de 18 meses lleva 3 días con fiebre, cuantificada de 38,8°. Se inicia amoxicilina, desapareciendo la fiebre y apareciendo un exantema eritematoso generalizado, que se muestra en la siguiente imagen:



Foto 6 (<http://www.childnuture.com/article/XXXXXXX>)

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Eritema infeccioso
- b) Exantema súbito
- c) Reacción alérgica a medicamentos
- d) Enfermedad de Kawasaki
- e) Síndrome de piel escaldada

71) Un niño de 7 años, consulta por fiebre, malestar general y dolor de garganta, a lo que se le agregó un exantema. Al examen físico presenta adenopatías cervicales anteriores sensibles y un rash generalizado, mayor en los pliegues de los codos y axilas. La piel se palpa áspera. ¿Cuál es el agente más probable?

- a) Virus de Epstein Baar
- b) Virus sarampión
- c) Estreptococo betahemolítico grupo A
- d) Virus rubéola
- e) Estafilococo aureo

72) Un recién nacido de 10 días pesó 3.100 gramos al nacer. Se alimenta con lactancia materna exclusiva y actualmente pesa 3.180 gramos. ¿Cuál es el diagnóstico nutricional?

- a) Desnutrición
- b) Riesgo de desnutrición
- c) Sobrepeso
- d) Buen incremento ponderal
- e) Mal incremento ponderal



73) Un niño de 7 años, mientras estaba comiendo, presenta agitación súbita, asociada a imposibilidad de respirar. No puede toser, hablar ni llorar. ¿Cuál es la maniobra más adecuada en este momento?

- a) Realizar respiración boca a boca
- b) Meterle los dedos en la boca y retirar el cuerpo extraño
- c) Dar golpes en la región interescapular
- d) Abrazarlo por detrás y realizar compresiones subxifoideas
- e) Realizar compresiones en el pecho, en decúbito supino

74) Un recién nacido de término presenta dificultad respiratoria severa y progresiva. Al examen físico se aprecia abdomen excavado y se auscultan ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra niveles hidroaéreos en el hemitórax izquierdo. ¿Cuál es la secuela más importante de esta patología?

- a) Estenosis traqueal
- b) Compresión hepática
- c) Estenosis intestinal
- d) Compresión del ventrículo izquierdo
- e) Hipoplasia pulmonar

75) Un niño de 2 años y 6 meses presenta fiebre, hasta 39°C, asociado a irritabilidad, odinofagia y malestar general. En su examen físico destacan adenopatías cervicales bilaterales y faringe eritematosa y congestiva, con abundante exudado amigdalino bilateral. La auscultación pulmonar muestra murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Amigdalitis estreptocócica
- b) Mononucleosis infecciosa
- c) Influenza
- d) Infección por Streptococcus pneumoniae
- e) Infección por adenovirus

76) Un niño de 14 años, con antecedente de su padre, que murió de muerte súbita, presenta talla alta, sus dedos y extremidades son muy largos y algo desproporcionados. Además, presenta hiperlaxitud de las articulaciones y tiene un soplo diastólico cardíaco en la auscultación cardiopulmonar. ¿Cuál es el síndrome más probable?

- a) Neurofibromatosis
- b) Síndrome alcohólico fetal
- c) Síndrome de Miller
- d) Síndrome de Marfán
- e) Síndrome de Ehler Dahnlos



77) Un recién nacido de término, pequeño para la edad gestacional, presenta un cuadro de ictericia y alteración de la termorregulación. Al examen físico tiene un síndrome purpúrico y se palpa hepatoesplenomegalia. Se solicitan exámenes, en los que destaca trombocitopenia. ¿Cuál es el agente más probable?

- a) Virus rubéola
- b) Citomegalovirus
- c) Virus herpes simplex
- d) Treponema pallidum
- e) Streptococo beta hemolítico grupo B

78) Una paciente de 22 años consulta por la vacuna contra el virus papiloma humano. Inició su actividad sexual hace 4 años y cuenta con un PAP normal, hace 1 año. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Repetir el PAP
- b) Vacunar con 2 dosis
- c) Vacunar con 3 dosis
- d) Realizar tipificación del virus papiloma humano
- e) Derivar a colposcopia y eventual biopsia

79) Una paciente, con antecedente de varias parejas sexuales, consulta por disuria inicial y leucorrea. En la especuloscopia se observa cuello uterino con cambios inflamatorios y abundante leucorrea amarillenta, sin otras alteraciones en el examen ginecológico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Vaginosis bacteriana
- b) Proceso inflamatorio pélvico
- c) Candidiasis urogenital
- d) Tricomoniasis
- e) Cervicitis gonocócica

80) Una paciente de mantiene actividad sexual, sin método anticonceptivo, consulta por fiebre, asociada a dolor abdominal de 3 días de evolución. Al examen físico presenta abdomen sensible y al examen ginecológico destaca útero doloroso, tanto a la palpación, como a la movilización. Se solicitan exámenes, que muestran test de embarazo negativo, hemograma con leucocitos: 18.000 por campo y PCR: 8,0 mg/L. La ecografía transvaginal muestra presencia de líquido libre escaso en la cavidad peritoneal, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento sintomático con ácido mefenámico
- b) Realizar cultivo endocervical
- c) Indicar anticonceptivos orales
- d) Iniciar tratamiento antibiótico
- e) Realizar laparotomía exploradora



81) Una paciente de 32 años, usuaria de DIU, con antecedente FUR dudosa hace más de un mes, consulta por dolor abdominal bajo, asociado a escaso sangrado genital. Al examinarla, se constata PA: 110/70 mmHg, FC: 100x', abdomen blando, depresible, con dolor a la palpación de la zona abdominal baja. En el examen ginecológico se observan las guías del DIU y se aprecia escasa metrorragia, que proviene del orificio cervical externo. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

- a) Ecografía transvaginal
- b) Gonadotropina coriónica plasmática
- c) Radiografía de abdomen y pelvis
- d) Laparoscopia exploradora
- e) Hemograma y PCR

82) Una paciente de 31 años, usuaria de DIU desde hace 8 meses, consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de flujo menstrual muy abundante, asociado a escaso dolor abdominal. Se solicita hemograma, que muestra anemia con hemoglobina: 8,9 g/dl, VCM: 70 fl, HCM: 24 pg. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Iniciar anticonceptivos orales
- b) Realizar biopsia de endometrio
- c) Iniciar ácido tranexámico
- d) Retirar el DIU
- e) Realizar ecografía transvaginal

83) Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 40 semanas, consulta por ausencia de movimientos fetales, por lo que se realiza un perfil biofísico, que resulta 8/10, con oligoamnios. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar a evolución espontánea
- b) Interrumpir ahora por cesárea
- c) Inducir el parto en este momento
- d) Realizar cesárea al momento del trabajo de parto
- e) Inducir el parto a las 41 semanas

84) Una paciente de 27 años, cursando un embarazo de 39 semanas, consulta por contracciones uterinas dolorosas. Al examen físico, está en buenas condiciones generales, con dinámica uterina de 1 contracción en 10 minutos. El tacto vaginal comprueba cuello uterino 50% borrado, permeable a un dedo, con feto en cefálica, sin cambios respecto a un tacto vaginal, realizado hace 4 días. El monitoreo fetal no tiene alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Esperar a que inicie el trabajo de parto
- b) Realizar cesárea
- c) Inducir el parto con misoprostol
- d) Hospitalizar y conducir el trabajo de parto
- e) Realizar test de tolerancia a las contracciones



85) Una paciente de 25 años, con 33 semanas de embarazo, consulta por prurito de predominio palmo-plantar, pero que en ocasiones es generalizado. Refiere que es más intenso en la noche. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

- a) Transaminasas
- b) Ecografía abdominal
- c) Ácidos biliares
- d) Fosfatasas alcalinas
- e) Bilirrubina total y diferenciada

86) Una paciente de 32 años, cursando un embarazo de 33 semanas, consulta por malestar general, asociado a dolor en el hipocondrio derecho, que ha aumentado. Además, tiene astenia, náuseas, y cefalea. Su examen físico muestra FC: 67x', PA: 120/80 mmHg, edema de extremidades inferiores y abdomen doloroso en el hipocondrio derecho, palpándose el hígado bajo el reborde costal. Entre sus exámenes destacan glicemia: 58 mg/dl, creatinina plasmática: 1,1 mg/dl, plaquetas: 120.000 por mm³, LDH: 420 UI/L y PCR: 3 (VN: menor a 1). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome de HELLP
- b) Hepatitis viral
- c) Hígado graso agudo del embarazo
- d) Colestasia intrahepática del embarazo
- e) Coledocolitiasis

87) Una paciente de 70 años consulta por dolor abdominal, de intensidad progresiva, que inició hace 4 meses. Ha bajado 5 kilogramos de peso. Al examen físico se observa abdomen distendido y destaca una masa anexial de 7 cm, de consistencia aumentada. El diagnóstico más probable es:

- a) Quiste funcional
- b) Mioma uterino
- c) Cáncer de ovario
- d) Cáncer de colon
- e) Endometriosis

88) Una mujer de 52 años presenta reglas irregulares, desde hace 6 meses, asociada a bochornos frecuentes, con calor y enrojecimiento de la cara, que le molestan para dormir. ¿Cuál es la indicación más adecuada?

- a) Fitoestrógenos
- b) Terapia de reemplazo hormonal combinada continua
- c) Terapia de reemplazo hormonal combinada cíclica
- d) Estrógenos solos continuos
- e) Progestágenos solos continuos



89) Una mujer de 28 años, cursando un embarazo de 18 semanas, educadora de párvulos, estuvo en contacto con un niño con varicela. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Solicitar serología materna
- b) Administrar gamaglobulina hiperinmune
- c) Indicar licencia médica por 21 días
- d) Iniciar valaciclovir
- e) Observar evolución

90) Una paciente con antecedente de reglas irregulares, que ocurren cada 45 a 60 días, se realiza un test de embarazo, que resulta positivo. Tiene una FUR segura hace 6 semanas y se solicitó HCG plasmática de 25.000 UI/L, que corresponde a una edad gestacional entre 6 y 7 semanas. ¿Cuál es la forma ideal para determinar la edad gestacional en esta paciente?

- a) FUR segura
- b) Medición de la altura uterina
- c) Determinación de HCG plasmática en 48 horas
- d) Medición ecográfica del saco gestacional
- e) Medición ecográfica de la longitud cráneo-nalgas

Fin de la primera parte



SEGUNDA PARTE RECONSTRUCCIÓN EUNACOM DICIEMBRE 2018

91) Un paciente de 18 años, con antecedente de coartación aórtica, operada en la infancia, consulta por disnea de esfuerzos, que ha ido en aumento, desde hace 2 meses. Además, refiere edema de extremidades inferiores y palpitaciones ocasionales. Al examen físico tiene FC: 88x', PA: 155/55 mmHg, el choque de la punta se palpa hiperdinámico, en la línea media axilar y en la auscultación cardíaca se constata soplo sistólico eyectivo II/VI, más un soplo diastólico III/VI, que dura toda la diástole. Su examen pulmonar muestra crépitos escasos en ambas bases. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Insuficiencia aórtica
- c) Recoartación aórtica
- d) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
- e) Miocardiopatía dilatada

92) Un paciente de 73 años, diabético e hipertenso, en tratamiento farmacológico con enalapril, hidroclorotiazida, glibenclamida y metformina, presenta crisis de palpitaciones que duran 1 a 4 horas y que se han repetido en 5 ocasiones, durante las últimas semanas. Actualmente su examen físico muestra una frecuencia cardíaca es 62x', regular; su presión arterial, 133/83 mmHg y su examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en dos tonos, sin soplos y murmullo pulmonar presente, simétrico, sin otros ruidos.

A continuación, se muestra un electrocardiograma tomado durante una de las crisis:

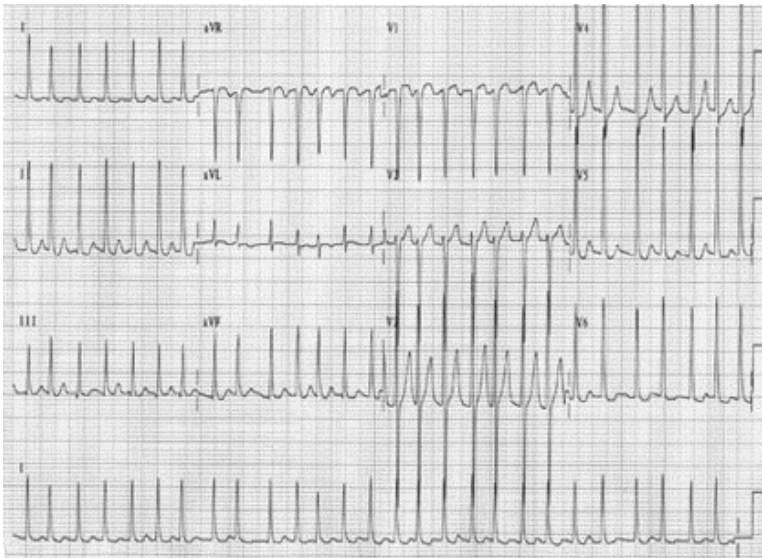


Foto 7 (https://www.emedicinehealth.com/XXXXXXXXXX/article_em.htm).

¿Qué fármaco es el más importante agregar en este momento?

- a) Antiagregantes
- b) Adenosina
- c) Verapamilo
- d) Acenocumarol
- e) Betabloqueantes



93) Un paciente masculino, de 69 años, con antecedente de diabetes e hipertensión arterial, con cardiopatía hipertensiva, en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida y metformina consulta por mayor disnea de la habitual, la que limita sus actividades de la vida diaria, asociada a ortopnea y disnea paroxística nocturna. Al examen físico su PA: 130/80 mmHg, FC: 70x', se observa edema de extremidades inferiores y se auscultan crepitaciones pulmonares escasas, en ambas bases. El examen cardiaco demuestra un choque de la punta en el 5° espacio intercostal, con auscultación normal. Se inicia tratamiento con carvedilol y furosemida, sin mayor respuesta. ¿Qué fármaco es más importante agregar al tratamiento de este paciente?

- a) Isosorbide
- b) Hidralazina
- c) Atorvastatina
- d) Espironolactona
- e) Digoxina

94) Un paciente de 40 años, con antecedente de reflujo gastroesofágico, consulta por dolor torácico de algunas horas de evolución, tipo puntada, muy intenso. Refiere que el dolor no respondió al uso de omeprazol. En su examen físico se aprecia adolorido, con FC: 76x', PA: 110/70 mmHg, ritmo regular en 2 tonos, sin soplos. Se solicita un electrocardiograma, que se muestra a continuación:

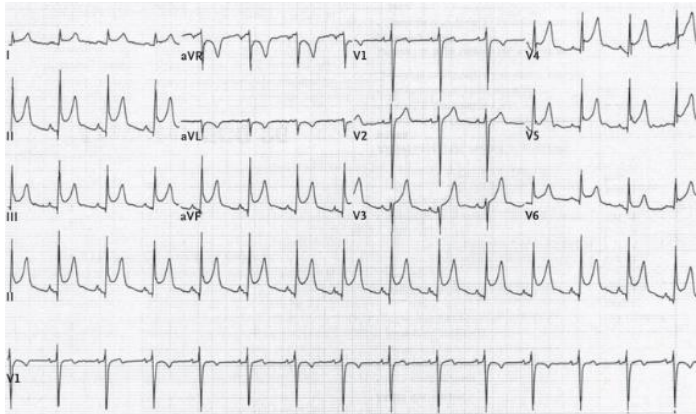


Foto 8 (<https://www.intramed.net/contenido.asp?contenidoID=86115>).

El diagnóstico más probable es:

- a) Pericarditis aguda
- b) Espasmo esofágico
- c) Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared lateral
- d) Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared inferior
- e) Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared inferolateral



95) Un paciente de 40 años, con antecedente de reemplazo valvular, secundario a una endocarditis bacteriana, consulta por palpitaciones muy intensas, asociadas a disnea. Al examen físico tiene un pulso a 140 latidos por minutos, regular. Se realizan maniobras vagales (masaje carotídeo) y se observa el siguiente electrocardiograma:



Foto 9 (<https://www.slideshare.net/XXXXchandrabarik/svtalogarythm>).

El diagnóstico más probable es:

- a) Taquicardia paroxística supraventricular
- b) Fibrilación auricular
- c) Flutter auricular
- d) Síndrome de Wolff Parkinson White
- e) Taquicardia auricular



96) Un paciente de 70 años presenta astenia, intolerancia al ejercicio y disnea de algunos días de evolución. Además, presenta lipotimias luego de levantarse de la cama. Al examen físico tiene FC: 48 x', regular. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación:

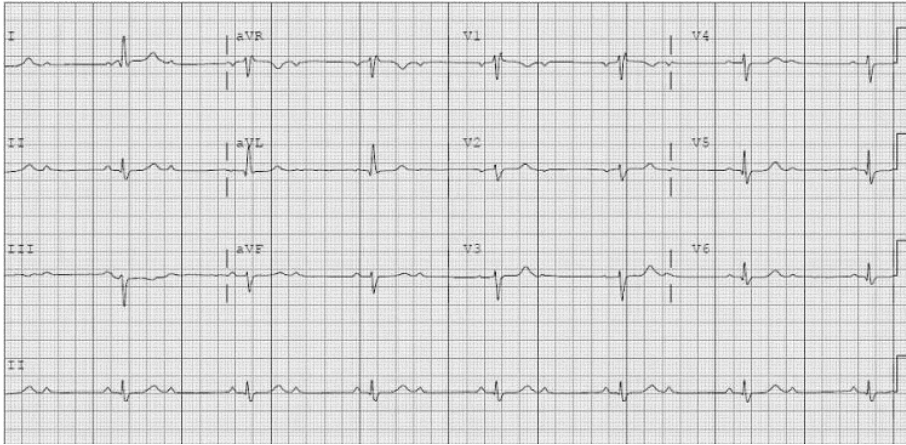


Foto 10 (<https://cardioparamap.com/2016/12/09/XXXXXXXXXXXXX/>).

El diagnóstico más probable es:

- a) Bloqueo aurículo-ventricular de primer grado
- b) Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, Mobitz I
- c) Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, Mobitz II
- d) Bloqueo aurículo-ventricular completo
- e) Enfermedad del nodo sinusal

97) Un paciente de 68 años, con antecedente de cáncer de próstata, en tratamiento con hormonoterapia, consulta por un cuadro de 2 días de evolución de dolor torácico, en el lado izquierdo, tipo puntada de costado, asociado a disnea, tos y fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Metástasis pulmonares
- b) Neumotórax
- c) Infarto agudo al miocardio
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Distrés respiratorio



98) Un paciente de 62 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida y fumador de 5 paquetes año, consulta por un cuadro de disnea de esfuerzos de 2 años de evolución, que ha progresado desde entonces. Por ello, en la actualidad, evita subir escaleras y cargar cosas pesadas. Al examen físico se aprecian acropaquías y su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar simétrico, con crepitaciones gruesas bilaterales. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación:

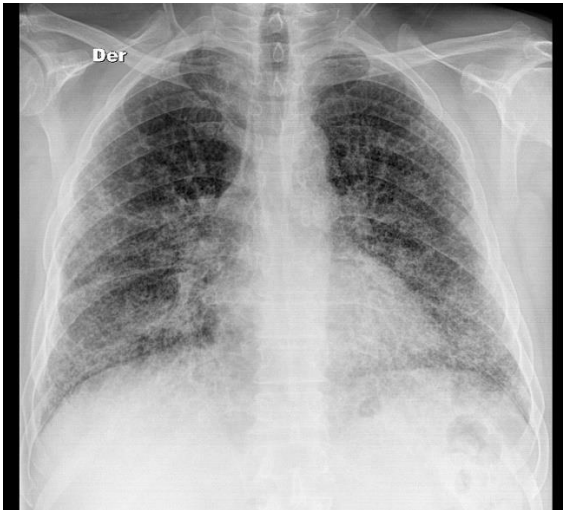


Foto 11 (<https://radiopaedia.org/cases/XXXXXXXXXXXX-2>).

El diagnóstico más probable es:

- a) Neumoconiosis
- b) Cáncer bronquioloalveolar
- c) Bronquiectasias
- d) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- e) Fibrosis pulmonar idiopática

99) Un paciente masculino de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica, diabetes y dislipidemia, de larga data, en tratamiento oral. Desde hace 2 meses está en quimioterapia por cáncer de colon. Hoy presenta un síncope luego de levantarse de la cama y se asocia a disnea y dolor torácico. Su FC: 120x', PA: 90/50 mmHg, FR: 32x' y saturación de oxígeno: 93%. Su examen pulmonar es inespecífico.

Se solicita electrocardiograma que muestra un bloqueo completo de rama derecha, con alteraciones inespecíficas de la repolarización.

¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio en este paciente?

- a) Radiografía de tórax
- b) TAC de tórax
- c) Dímero D
- d) Ecocardiograma
- e) AngioTAC de tórax



100) Una mujer de 63 años, hipertensa, en tratamiento con enalapril y amlodipino, consulta por tos, con expectoración mucopurulenta, de 3 días de evolución. Además, presenta fiebre, malestar general y dolor torácico con la inspiración máxima. Al examen físico, se constata T°: 38 °C, PA: 120/80 mmHg, FC: 80 lpm, FR: 15 rpm, saturación de oxígeno: 97% y en el examen cardiopulmonar destacan crepitaciones localizados en el lado derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación:



Foto 12 (<http://elesfenoides.blogspot.com/2014/07/XXXXXXXXXX-imagenes-1.html>)

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Amoxicilina con ácido clavulánico
- b) Ceftriaxona
- c) Levofloxacino
- d) Clindamicina
- e) Azitromicina

101) Un paciente de 65 años, fumador de 20 paquetes-año, fuma el primer cigarrillo al despertarse y fuma en lugares donde está prohibido y a pesar de resfriarse. Consulta porque ha pensado en suspender el tabaco. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a) Entrevista motivacional
- b) Bupropión
- c) Parche de nicotina
- d) Diazepam
- e) Vareniclina



102) Un paciente de 30 años consulta por ictericia de larga data, que suele aumentar en ciertos periodos. Se solicitan pruebas hepáticas que se informan como bilirrubina total: 3,0 mg/dl, bilirrubina directa: 0,5 mg/dl, GGT: 50 UI/L, GPT: 30 UI/L, GOT: 40 UI/L y fosfatasas alcalinas: 90 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Anemia hemolítica
- b) Colangitis esclerosante primaria
- c) Síndrome de Dubin Johnson
- d) Coledocolitiasis
- e) Síndrome de Gilbert

103) Un hombre de 26 años consulta por dolor abdominal de 3 meses de evolución, asociado a diarrea acuosa, que en ocasiones ha presentado hematoquecia. Hace una semana se agrega marcado pujo y tenesmo, más aumento de la intensidad del dolor abdominal. Al examen físico tiene signos vitales normales y su abdomen es sensible a la palpación, con dolor a la palpación de la fosa iliaca y el flanco izquierdos, sin signos peritoneales. Los ruidos hidroaéreos se auscultan conservados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Enfermedad de Cröhn
- b) Enfermedad celiaca
- c) Colitis ulcerosa
- d) Megacolon amebiano
- e) Cáncer de colon

104) Una paciente de 23 años, vegetariana estricta, consulta por diarrea de algunos meses de evolución, asociada a baja de peso. Se solicitan exámenes, entre los que destaca anemia ferropénica. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Parasitosis intestinal
- b) Enfermedad celiaca
- c) Colitis ulcerosa
- d) Enfermedad de Cröhn
- e) Enteropatía perdedora de proteínas

105) Un paciente de 84 años se realiza una TSH, que resulta 8,4 UI/L. La TSH se repita 3 meses después, resultando 9,2 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar propiltiouracilo oral
- b) Iniciar levotiroxina oral 25 ug/día
- c) Iniciar tiamazol
- d) Iniciar corticoides orales
- e) Iniciar levotiroxina oral 75 ug/día



106) Un paciente de 66 años es hospitalizado por una neumonía adquirida en la comunidad. En su hemoglucotest de ingreso, se constata una glicemia capilar de 256 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes exámenes confirma el diagnóstico de diabetes?

- a) Glicemia de ayuno > 126 mg/dl
- b) Prueba de tolerancia a la glucosa > 200 mg/dl, postcarga de glucosa
- c) Hemoglobina glicosilada > 6,5%
- d) Prueba HOMA > 2,6
- e) Albuminuria/creatininuria > 0,3

107) Un paciente de 72 años, con antecedente de un infarto miocárdico, hace 2 meses. Durante la hospitalización, se diagnosticó diabetes mellitus, iniciándose metformina 850 mg cada 12 horas. Sin embargo, desde entonces ha presentado diarrea. Sus glicemias de ayuno son cercanas a 140 mg/dl y su hemoglobina glicosilada resulta 8,2%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Reemplazar la metformina por glibenclamida
- b) Agregar insulina NPH
- c) Reemplazar el tratamiento por metformina 750 mg XR
- d) Reemplazar la metformina por sitagliptina
- e) Aumentar la dosis de metformina

108) Un paciente diabético, hipertenso y con antecedente de una cardiopatía coronaria, en tratamiento con aspirina, metformina, glibenclamida y enalapril, se realiza un perfil lipídico, que se informa como LDL: 165 mg/dl, HDL: 38 mg/dl, triglicéridos: 288 mg/dl. Inició atorvastatina 40 mg al día, las que suspendió por presentar artralgias y mialgias. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar rosuvastatina 10 mg y controlar con CK
- b) Iniciar fenofibrato mg y controlar con perfil lipídico y glicemia
- c) Iniciar atorvastatina 5 mg cada 2 días
- d) Iniciar ezetimibe
- e) Reforzar la dieta

109) Un paciente de 82 años, con antecedente de diabetes y enfermedad coronaria, en tratamiento farmacológico con metformina 1 gramo cada 8 horas, glibenclamida 10 mg cada 12 horas, aspirina 100 mg al día y atorvastatina 40 mg al día, presenta un cuadro de mialgias generalizadas, asociadas a debilidad muscular, mayor en la cintura escapular y los muslos. Se solicitan exámenes, entre los que destacan CK: 1.320 UI/L, GOT: 128 UI/L y GPT: 133 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Miopatía diabética
- b) Polineuropatía diabética
- c) Miopatía por estatinas
- d) Polimiositis
- e) Polimialgia reumática



110) Una paciente de 17 años, con antecedente de haber tenido su menarquia a los 16 años, con reglas que ocurren cada 3 a 4 meses. Tiene hirsutismo en el mentón, los brazos, el pecho, los muslos y la línea media abdominal, tanto infraumbilical, como supraumbilical, con un índice de Ferriman-Gallwey > 15. ¿Cuál es el examen de elección para hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de ovario poliquístico?

- a) Relación FSH/LH
- b) Cariograma
- c) Curva de insulina
- d) Prolactina
- e) 17-hidroxi-progesterona

111) Un paciente consulta por disminución del deseo sexual y de las erecciones. Además, presenta astenia y debilidad, que ha ido aumentando, desde hace algunos meses. También, refiere haber chocado con un mueble, por no haberlo visto, resultado con lesiones. Al examen físico se aprecia pálido, con disminución del vello corporal, tiene edema de extremidades inferiores y disminución de la visión en la zona temporal del campo visual. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio de este paciente?

- a) Radiografía de silla turca
- b) Prolactinemia
- c) Resonancia magnética de silla turca
- d) Fondo de ojo
- e) TAC de cerebro

112) Un paciente de 43 años consulta por dolor y parestesias en el dedo meñique y anular derechos, que inició hace 3 años y ha progresado, aumentando su intensidad. Relata que, en la noche, los síntomas suelen ser más intensos y que actualmente tiene parestesias continuas en el meñique. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome del túnel carpiano
- b) Contractura de Dupuytren
- c) Radiculopatía C7
- d) Atrapamiento cubital
- e) Compresión del plexo braquial

113) Una paciente de 26 años, consulta por malestar general, asociada a cefalea y orinas oscuras. Refiere fotosensibilidad. Al examen físico tiene FC: 66x'. PA: 160/106 mmHg, úlceras orales y edema de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes que muestran sedimento de orina con eritrocitos abundantes, con 17% de dismorfia, proteinuria 500 mg/L. Su creatinina plasmática resulta 1,4 mg/dl y la fracción del complemento C3 está disminuida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Nefropatía lúpica
- b) Nefropatía por IgA
- c) Vasculitis ANCA positivo
- d) Glomerulonefritis postestreptocócica
- e) Glomerulopatía por cambios mínimos



114) Un paciente de 62 años, diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina 850 mg/8h, hidroclorotiazina 50 mg/día y atenolol 50 mg/día, acude a control. Su presión arterial es 146/100 mmHg. Su examen físico segmentario no aporta mayor información. Trae algunos exámenes, entre los que destacan clearance de creatinina de 48 mililitros por minuto y proteinuria de 500 mg/litro. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Agregar amlodipino
- b) Agregar doxazosina
- c) Agregar enalapril
- d) Mantener las indicaciones
- e) Reemplazar la hidroclorotiazida por furosemida

115) Un niño de 9 meses tiene palidez de piel y mucosas, por lo que se solicita un hemograma, que muestra hemoglobina: 9 g/dl, hematocrito: 36%, VCM: 68 fl, glóbulos blancos: 6.500 por mm³, plaquetas: 450.000 por mm³. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Anemia ferropriva
- b) Anemia por enfermedades crónicas
- c) Trombocitosis esencial
- d) Hemoglobinopatía
- e) Microesferocitosis familiar

116) Una paciente de 27 años, vegana estricta, con antecedente de cirugía bariátrica, presenta astenia y disnea de esfuerzos, asociado a palidez, por lo que se solicita un hemograma, con hematocrito: 23%, hemoglobina: 7,1 g/dl, VCM: 122 fl, blancos: 4.100 por mm³ y plaquetas: 150.000 por mm³. ¿El déficit de qué elemento puede explicar los síntomas y hallazgos de laboratorio?

- a) Hierro
- b) Folatos
- c) Zinc
- d) Vitamina B12
- e) Vitamina D

117) Un paciente de 73 años presenta astenia y disnea de esfuerzos importante, asociada a gran palidez de piel y mucosas. Refiere, también, parestesias en las 4 extremidades. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina: 6 mg/dl, VCM: 126 fl, glóbulos blancos: 3.100 por mm³, plaquetas: 105.000 por mm³ y 2 eritroblastos / 100 leucocitos. Se solicitan, además, LDH: 1.800 UI/L y bilirrubina: 5 mg/dl, de predominio indirecto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Mielodisplasia
- b) Aplasia medular
- c) Anemia por déficit de vitamina B12
- d) Síndrome leucoeritroblástico
- e) Anemia hemolítica autoinmune



118) Un hombre de 68 años, diabético mal controlado, consulta por mialgias generalizadas, asociadas a debilidad, mayor en la cintura escapular y astenia. En el último tiempo refiere dificultades para ponerse de pie, desde una silla o desde la cama. Se solicitan exámenes, entre los que destacan CK: 1.800 UI/L, LDH: 1.050 UI/L, PCR: 4,3 (VN: menor a 1). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Polimiositis
- b) Polimialgia reumática
- c) Polineuropatía diabética
- d) Miopatía por cuerpos de inclusión
- e) Dermatomiositis

119) Una paciente de 74 años hospitalizada, desde hace una semana, por una fractura de cadera. Ha presentado cambios en su conducta, ya que al inicio era amable y cooperadora, pero en el último tiempo se ha agitado y mostrado confusa, e incluso ha llegado a agredir a otros pacientes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Enfermedad de Alzheimer
- b) Trastorno delirante
- c) Esquizofrenia
- d) Demencia vascular
- e) Delirium

120) Un paciente de 82 años, sano, presenta un cuadro de desgano, desesperanza y ánimo bajo de algunos meses de evolución. Ha bajado 4 kilogramos de peso y sale muy poco de su casa, ya que no siente ganas de hacer nada y no disfruta de las cosas que habitualmente le gustaba hacer. ¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?

- a) Paroxetina
- b) Sertralina
- c) Duloxetina
- d) Amitriptilina
- e) Clonazepam

121) Un paciente de 80 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer, hipotiroidismo y artrosis, en tratamiento con donepecilo, levotiroxina y paracetamol, presenta escapes frecuentes de orina y diarrea. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Agregar memantina
- b) Disminuir la dosis de levotiroxina
- c) Agregar oxibutinina
- d) Disminuir la dosis de donepecilo
- e) Aumentar la dosis de levotiroxina



122) Un paciente de 90 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer, por lo que está institucionalizado. Presentó un cuadro de obstrucción urinaria aguda, secundaria a una hiperplasia prostática benigna, por lo que se instaló una sonda Foley a permanencia, la que se cambia cada 30 días. El último cambio se realizó hace 15 días y posteriormente se realizó un urocultivo, que resultó positivo para Escherichia coli multisensible. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar ciprofloxacino
- b) Realizar cistoscopia
- c) Cambiar la sonda
- d) Observar evolución
- e) Derivar a cirugía abierta de la uropatía obstructiva

123) Un paciente de 51 años, con antecedente de un recambio valvular, secundario a una valvulopatía, consulta por un cuadro de 2 semanas de astenia, fiebre y malestar general. Al examen físico tiene T°: 38,2°C, PA: 120/80 mmHg, FC: 94x', se observan lesiones eritematosas en los dedos de ambas manos y algunas Petequias en las extremidades inferiores y, en el examen cardíaco, se aprecia un soplo diastólico de intensidad IV/VI. Se solicitan exámenes de sangre, entre los que destaca PCR: 12 mg/L, VHS: 70 mm/h y leucocitosis de 16.000 por mm³. Además, se realizan 3 hemocultivos, que resultan todos positivos para cocáceas Gram positivas, en cadena. ¿Cuál es el antibiótico de elección para iniciar el tratamiento?

- a) Penicilina sódica
- b) Cloxacilina
- c) Clindamicina
- d) Ceftazidima
- e) Gentamicina

124) Un paciente de 41 años, diabético tipo 1, consulta por fiebre, asociado a rinorrea purulenta y enrojecimiento facial. Al examen físico, se observa eritema de la mejilla izquierda y de la punta de la nariz, con una zona necrótica en el ala nasal. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Stafilococcus aureus
- b) Candida albicans
- c) Streptococcus pyogenes
- d) Mucor
- e) Pseudomona aureginosa

125) Una niña de 5 años presenta prurito anal importante, asociado a prurito vulvar. La madre refiere que también presenta bruxismo. Al examen físico presenta signos de grataje en la zona perianal y perivulvar. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

- a) Parasitológico seriado
- b) Test de Graham
- c) Microscopía óptica de frotis directo de deposiciones
- d) Coprocultivo
- e) Medición de eosinófilos en sangre



126) Un paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, consulta por cefalea de 3 días de evolución, a lo que se le ha agregado desorientación y confusión. Además, ha presentado algunas convulsiones clónicas. Se realiza punción lumbar, que da salida a líquido cefalorraquídeo con 100 células por mm³, con 90% mononucleares, con 15 glóbulos rojos por mm³, glucosa: 80 mg/dl, proteínas: 40 mg/dl; glicemia: 100 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Toxoplasmosis cerebral
- b) Meningoencefalitis herpética
- c) Tumor cerebral
- d) Meningitis viral
- e) Meningitis bacteriana aguda

127) Una paciente de 41 años, con antecedente de VIH, con baja de peso, consulta por dolor y ardor en la zona derecha del dorso, que se irradia a la región mamaria ipsilateral. En el examen físico se observan vesículas en la espalda y en la mama derecha. El tratamiento de elección es:

- a) Aciclovir
- b) Cloxacilina
- c) Mupirocina
- d) Valganciclovir
- e) Azitromicina

128) Un paciente de 19 años, estudiante universitario, inicia sertralina oral, debido a un trastorno de ansiedad social. Evoluciona con verborrea e hiperactividad, le habla a personas con las que normalmente no conversaba y se muestra muy inquieto y optimista. No se observa cansado, a pesar de dormir poco. Como antecedente, tuvo una depresión diagnosticada a los 18 años, que respondió al tratamiento antidepressivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno bipolar
- b) Trastorno esquizoafectivo
- c) Trastorno esquizotípico de la personalidad
- d) Distimia
- e) Trastorno por déficit atencional

129) Un hombre de 23 años consulta por un cuadro de 2 semanas de evolución de ánimo expansivo, irritabilidad, verborrea y disminución de las necesidades de sueño, más un delirio de perjuicio. En los últimos 2 años, ha sido hospitalizado en 5 oportunidades, por episodios psicóticos, relacionados con suspensión del tratamiento. En ese tiempo presentó un episodio delirante, aún sin síntomas anímicos. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno bipolar
- b) Trastorno esquizoafectivo
- c) Esquizofrenia
- d) Trastorno delirante crónico
- e) Trastorno esquizotípico



130) Una paciente de 25 años fue encontrada vagando por la calle descalza, desorientada y confusa. Hace 5 horas había tenido una discusión con su padre, luego de lo cual salió de su casa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno disociativo
- b) Trastorno adaptativo
- c) Trastorno conversivo
- d) Trastorno somatomorfo
- e) Trastorno facticio

131) Un paciente de 46 años presenta múltiples síntomas, como cefalea, molestias abdominales, calambres, astenia, entre otros, desde hace un año. Se han realizado múltiples exámenes, sin encontrar una causa orgánica. Llama la atención que ha tenido proteinuria persistente, que no se correlaciona con el cuadro clínico, ni con los demás exámenes, por lo que se tienen fuertes sospechas de que ha manipulado las muestras de orina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno somatomorfo
- b) Trastorno conversivo
- c) Trastorno facticio
- d) Trastorno disociativo
- e) Trastorno hipocondriaco

132) Una paciente de 32 años, madre de 4 hijos, de distintos padres, de los cuales no se hace cargo, tiene relaciones inestables y problemas frecuentes con sus compañeros de trabajo. Pelea frecuentemente con su familia y como antecedente, ha tenido varios episodios de autoagresión e intentos suicidas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno límite de la personalidad
- c) Trastorno bipolar
- d) Trastorno delirante
- e) Trastorno depresivo mayor

133) Una paciente presenta mucha angustia ante ciertas situaciones como lugares con muchedumbre, los malls, los ascensores con mucha gente, los espacios desolados y otros, ya que presenta miedo a sufrir un colapso y que nadie la ayude. Como antecedente, cuando niña lloraba por largas horas cuando iba al colegio y su mamá la dejaba. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad evitativo
- b) Trastorno de ansiedad de separación del adulto
- c) Trastorno de ansiedad social
- d) Agorafobia
- e) Trastorno de angustia generalizada



134) Una paciente de 32 años presenta un cuadro de 3 meses de angustia, asociada a afectación de su vida social y su trabajo, con dificultad para concentrarse. Ha bajado de peso y ya no realiza las actividades que le eran placenteras. Al preguntarle, de manera dirigida, reconoce intención suicida, sin un plan actual. La familia refiere que todo empezó hace 2 años, en relación a una ruptura sentimental de larga duración. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno adaptativo de tipo mixto
- b) Distimia
- c) Episodio depresivo mayor
- d) Trastorno de angustia
- e) Trastorno de angustia generalizada

135) ¿Cuál es el mejor indicador para determinar la contratación del recurso humano obstétrico en un servicio de salud?

- a) La población beneficiaria del servicio
- b) La tasa de fecundidad en la población
- c) Los recién nacidos por residencia
- d) El número de partos históricos en el plantel
- e) La tasa de fertilidad de la población

136) La última fase del diagnóstico de salud participativo es:

- a) La comprobación de los problemas de salud, referidos por la comunidad
- b) La determinación de estadísticas y datos objetivos y completos
- c) La determinación de la prevalencia de las patologías más importantes de la comunidad
- d) La definición de estrategias de intervención, priorizadas
- e) Realización de estudios experimentales

137) Un paciente de 18 años presenta aumento de volumen escrotal, doloroso, de inicio súbito. La conducta más adecuada es:

- a) Antibióticos orales
- b) Punción escrotal
- c) Antiinflamatorios orales
- d) Exploración quirúrgica
- e) Ecografía escrotal



138) Una paciente de 82 años presenta un cuadro de fiebre alta, disuria dolorosa y orinas turbias, más hematuria macroscópica. Al examen físico, tiene PA: 120/80, FC: 90x', T°: 38,9°C. Se solicitan exámenes, entre las que destaca hemograma con 20.000 glóbulos blancos por mm³, PCR: 12 mg/L. El sedimento orina muestra más de 50 glóbulos blancos por campo, con bacterias abundantes y el urocultivo está pendiente. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección?

- a) Gentamicina
- b) Amikacina
- c) Moxifloxacino
- d) Ceftazidima
- e) Cefotaximo

139) Un paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, consulta por dolor de la rodilla izquierda, de 4 semanas de evolución, que le dificulta la marcha. Al examen físico, su rodilla no tiene alteraciones. ¿Qué otra articulación se debe examinar?

- a) La cadera
- b) La sínfisis del pubis
- c) La sacroilíaca
- d) El tobillo
- e) La articulación astragalotarsiana

140) Una paciente de 58 años, consulta porque, desde hace una semana, presenta dolor en el hombro derecho, que es más intenso durante la noche y que empeora con los movimientos del mismo, por lo que ha limitado sus actividades normales. El dolor aumenta con la abducción y con la elevación sobre 90° del brazo derecho. Al examen físico tiene movilidad completa del hombro, con dolor en las maniobras descritas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Capsulitis adhesiva de hombro
- b) Patología del manguito rotador
- c) Artritis séptica
- d) Tendinopatía de la cabeza larga del bíceps braquial
- e) Artrosis de la articulación glenohumeral

141) Un paciente de 70 años, sufre una caída a nivel, con apoyo de la extremidad superior en extensión, contra el suelo. Evoluciona con dolor en la muñeca, que le impide realizar movimientos. Consulta al día siguiente, con la muñeca deformada en “dorso de tenedor” y presencia de equimosis en la zona palmar y en la zona dorsal. Presenta dolor a la compresión de la zona distal del radio. EL diagnóstico más probable es:

- a) Esguince de muñeca
- b) Fractura de la epífisis distal del radio
- c) Disyunción del extremo distal del radio
- d) Luxofractura de Monteggia
- e) Fractura de escafoides carpiano



142) Un paciente de 27 años sufre una caída a nivel, con golpe del hombro, contra el piso. Evoluciona con intenso dolor e impotencia funcional, por lo que se solicitan radiografías de hombro, que. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Reducción cruenta en una semana
- b) Inmovilización por 10 días con yeso
- c) Artroscopia para reparación del labrum
- d) Inmovilización por 7 días con cabestrillo bloqueado
- e) Reducción ortopédica de inmediato

143) Un paciente de 19 años consulta por dolor torácico derecho, de 24 horas de evolución, que aumenta con la inspiración. Al examen físico, se aprecia disminución del murmullo pulmonar en el lado derecho. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación:

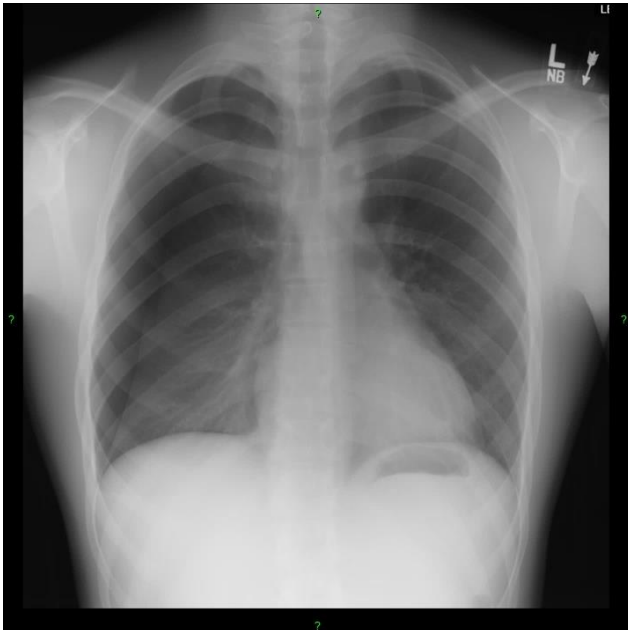


Foto 13 (<https://imgur.com/gallery/U6p0b/comment/113820836>)

(La foto fue ennegrecida, para que se pareciera a las del Eunacom real, impreso).

¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Control radiológico en 24 horas
- b) Solicitar TAC de tórax
- c) Realizar cirugía abierta
- d) Drenaje con tubo pleural
- e) Videotoracoscopia



144) Una paciente de 60 años consulta por aumento de volumen en la cara anterior del muslo, que en ocasiones es dolorosa y se asocia a náuseas y dolor abdominal. Al examen físico se aprecia dicho aumento de volumen, por debajo del ligamento inguinal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Linfoma
- b) Hernia inguinal
- c) Adenopatía metastásica
- d) Hernia femoral
- e) Sarcoma de partes blandas

145) Una paciente de 70 años presenta dolor abdominal intenso de 24 horas de evolución, asociada a fiebre hasta 38,5°C, marcado malestar general y vómitos alimentarios, en múltiples ocasiones. Al examen físico tiene PA: 90/60 mmHg, FC: 105x', se aprecia ictericia de piel y mucosas y su abdomen es doloroso, de manera difusa, con resistencia muscular, mayor en el hemiabdomen superior. Sus pruebas hepáticas muestran bilirrubina total: 6,8 mg/dl, Bilirrubina directa: 6,1 mg/dl, FA: 512 UI/L, GGT: 334 UI/L, GOT: 250 UI/L y GPT: 170 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Colecistitis enfisematosa
- b) Plastrón vesicular
- c) Hepatitis aguda
- d) Colangitis aguda
- e) Colédocolitiasis

146) Un paciente de 55 años consulta por dolor abdominal, de 3 días de evolución, mayor en el epigastrio, asociado a vómitos alimentarios. Su examen abdominal muestra dolor a la palpación del epigastrio e hipocondrio derecho. Se realiza una ecografía abdominal, que muestra vía biliar de 8 mm, con múltiples cálculos en la vesícula, de pequeño tamaño. Se solicitan pruebas hepáticas con fosfatasas alcalinas: 520 UI/L, GGT: 612 UI/L, GOT: 102 UI/L y GPT: 87 UI/L, bilirrubinemia: 6,0 mg/dl, con fracción directa de 4,6 mg/dl. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Realizar colangiopancreatografía endoscópica retrógrada
- b) Indicar colangiografía resonancia
- c) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- d) Resolver quirúrgicamente
- e) Indicar tratamiento analgésico y antibiótico endovenoso



147) Un paciente de 61 años, con antecedente de haberse realizado una colonoscopia, hace un mes, la que estaba normal, consulta por una hemorragia digestiva baja abundante, con compromiso hemodinámico. Su frecuencia cardiaca es 120x' y su presión arterial, 90/60 mmHg. Se realiza endoscopia digestiva alta, que resulta normal y su hemograma muestra hematocrito de 19%, con hemoglobina: 6,3 g/dl. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?

- a) Ecografía abdominal
- b) TAC de abdomen y pelvis
- c) Cintigrafía con glóbulos rojos marcados
- d) Colonoscopia
- e) Angiografía mesentérica

148) Un paciente, apendicetomizado hace 6 horas evoluciona con malestar general y dolor abdominal. Su pulso es regular a 120 latidos por minuto y su presión arterial es 90/50 mmHg. En el examen abdominal presenta dolor y signos peritoneales en el hemiabdomen inferior. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemoperitoneo
- b) Evisceración
- c) Trombosis de la vena porta
- d) Dehiscencia de la base apendicular
- e) Tromboembolismo pulmonar masivo

149) Un paciente de 48 años, con antecedente de hipermetropía, consulta por dolor en el ojo izquierdo, muy intenso, irradiado a la frente. Al examen físico, se aprecia eritema periquerático del ojo izquierdo, con pupila midriática arreactiva y se aprecia opacidad corneal. El ojo derecho tiene visión 20/20, mientras que el ojo izquierdo tiene visión borrosa, que solo es capaz de contar dedos. El diagnóstico más probable es:

- a) Conjuntivitis
- b) Uveítis aguda
- c) Queratitis viral aguda
- d) Trombosis de la vena central de la retina
- e) Glaucoma agudo



150) Un paciente de 77 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica, presenta visión distorsionada de las letras y refiere que las líneas se ven onduladas. Actualmente tiene un escotoma central. Se hace un fondo de ojo, que se muestra a continuación:



Foto 14 (<https://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/01/25/medicina/1169733276.html>).

El diagnóstico más probable es:

- a) Desprendimiento de retina
- b) Retinopatía hipertensiva
- c) Trombosis de la vena central de la retina
- d) Catarata
- e) Degeneración macular relacionada con la edad

151) Un paciente de 19 años consulta por caída de cabello en la zona occipital, que inició hace 2 semanas. Al examen físico, se aprecia una zona sin cabellos, tal como se muestra en la foto:



Foto 15 (<https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/XXXXXXX>).

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Lupus eritematoso cutáneo crónico
- b) Alopecia areata
- c) Alopecia androgénica
- d) Tricotilomanía
- e) Tiña capitis



152) Un recién nacido que, después de la caída del cordón umbilical, presenta aumento de volumen, de color rosado, bordes netos y superficie brillante, en la zona umbilical. El tratamiento más adecuado es:

- a) Nitrato de plata
- b) Povidona yodada
- c) Quirúrgico
- d) Neomicina más mupirocina
- e) Furazolidona

153) Un lactante de 3 meses presenta aparición de lesiones en el abdomen y muslo, que se muestran a continuación:



Foto 16 (<https://accesspediatrics.mhmedical.com/content.aspx?bookid=447§ionid=40442582>).

¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Virus herpes simplex
- b) Streptococcus pyogenes
- c) Virus varicela zóster
- d) Virus pox
- e) Staphylococcus aureus

154) Un niño de 6 semanas de vida presenta ictericia desde hace 2 semanas. Al examen físico se aprecia icterico y presenta deposiciones claras en el pañal, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Estenosis hipertrófica del píloro
- b) Atresia biliar primaria
- c) Hepatitis viral
- d) Síndrome de Crigler Najjar
- e) Hipotiroidismo congénito



155) Un niño de 28 días presenta vómitos después de comer, que iniciaron hace una semana y que han aumentado en frecuencia e intensidad. La madre refiere que llora después de comer y vomitar y se objetiva que no ha incrementado bien de peso en el último tiempo, observándose algo enflaquecido. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?

- a) Radiografía baritada de esófago-estómago-duodeno
- b) Ecografía abdominal
- c) Endoscopia digestiva alta con biopsia duodenal
- d) Colonoscopia con biopsia de la pared intestinal
- e) Radiografía simple toracoabdominal

156) Una niña de 30 días de vida con mal incremento ponderal presenta deposiciones amarillas, abundantes y oleosas. Los padres refieren que su piel tiene un sabor salado. ¿Cuál es el examen más adecuado para realizar el diagnóstico?

- a) Ecografía abdominal
- b) Colonoscopia
- c) Anticuerpos anti-transglutaminasa y endoscopia digestiva alta
- d) Electrolitos en sudor
- e) Hemograma y pruebas de función renal

157) Un niño de 7 años presenta rinorrea y tos de 9 días de evolución, que han aumentado y se asociaron a disnea, progresiva y fiebre hasta 38,2°C. Al examen físico presenta T°C: 37,5°C, frecuencia respiratoria de 30 por minuto, murmullo pulmonar bilateral, simétrico, algo disminuido, con sibilancias y crepitaciones bilaterales. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Mycoplasma pneumoniae
- b) Streptococcus pyogenes
- c) Bordetella pertussis
- d) Virus parainfluenza
- e) Virus respiratorio sincicial

158) Una niña de 3 años, previamente sana, presenta un cuadro de 2 días de evolución de rinorrea, asociada a fiebre de 39°C, con tos disfónica, a la que se agrega dificultad respiratoria hace una hora. Al examen físico, su frecuencia respiratoria es 48 por minuto, se escucha estridor inspiratorio y espiratorio y se objetiva retracción subcostal y supraesternal. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Administrar adrenalina subcutánea
- b) Realizar nebulizaciones con salbutamol al 0,5%
- c) Realizar intubación orotraqueal
- d) Realizar nebulizaciones con bromuro de ipatropio al 0,5%
- e) Realizar nebulizaciones con adrenalina racémica al 0,1%



159) Un niño de 8 años acude al servicio de urgencia por un cuadro de epistaxis, que respondió al tratamiento con taponamiento nasal anterior. Al examen físico tiene petequias generalizadas y equimosis, principalmente en las extremidades inferiores. Su hemograma muestra hemoglobina 12 g/dl, hematocrito: 36%, plaquetas: 10.000 por mm³ y glóbulos blancos: 5.600 por mm³. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Leucemia aguda
- b) Púrpura trombocitopénico inmune
- c) Púrpura trombocitopénico trombótico
- d) Hemofilia
- e) Enfermedad de Von Willebrand

160) Una niña de 1 año y 10 meses presenta diarrea de dos meses de evolución, con mal incremento ponderal. Hace una semana empeora la diarrea y se agregan vómitos y malestar general. Al examen físico tiene edema de extremidades inferiores y palidez y su abdomen se palpa blando, sensible, sin irritación peritoneal. Se piden exámenes en los que destacan Na⁺: 132 mEq/L, K⁺: 2,8 mEq/L, glicemia: 66 mg/dl, albuminemia: 2,1 g/dl y hematocrito: 30%. El diagnóstico más probable es:

- a) Parasitosis intestinal
- b) Fibrosis quística
- c) Enteropatía perdedora de proteínas
- d) Diarrea viral
- e) Crisis celiaca

161) Un lactante de 11 meses presenta diarrea aguda, de 2 días de evolución, abundante, asociada a decaimiento marcado y tendencia al llanto. Al examen físico está somnoliento, con frialdad de extremidades y el llenado capilar es de 3 segundos. Las mucosas se observan secas. ¿Cuál es la indicación inicial para su hidratación?

- a) Sales de hidratación oral
- b) Suero salino al 0,9%
- c) Suero glucosado al 5%
- d) Suero glucosalino
- e) Albúmina endovenosa

162) Un recién nacido de término presenta estridor desde el nacimiento, sin otros síntomas. Al examen físico está en buenas condiciones, sin cianosis ni uso de musculatura accesoria. El diagnóstico más probable es:

- a) Anillo vascular
- b) Traqueomalacia
- c) Laringomalacia
- d) Hendidura laríngea
- e) Fístula traqueoesofágica



163) Un niño de 4 años presenta incontinencia fecal, en algunas ocasiones, desde hace dos meses. Sin embargo, en otras ocasiones, pasan muchos días sin defecar y cuando lo hace, sus deposiciones son duras y caprinas. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Niño sano
- b) Atresia duodenal
- c) Constipación funcional
- d) Megacolon aganglionótico
- e) Malrotación intestinal

164) Un niño de 2 meses, con antecedente de haber nacido a las 34 semanas de gestación, acude a control. ¿En qué momento debe administrarse la vacuna antineumocócica conjugada?

- a) En este momento
- b) En 4 semanas más
- c) En 6 semanas más
- d) A los 4 meses de edad
- e) No debe administrarse

165) Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 32 semanas, sin controles previos, se realiza un Elisa para VIH, que resulta positivo. ¿Cuál es la conducta más importante para evitar la transmisión vertical?

- a) Iniciar triterapia antirretroviral ahora
- b) Realizar cesárea ahora
- c) Iniciar triterapia antirretroviral si la carga viral es alta
- d) Administrar terapia antirretroviral durante el trabajo de parto
- e) Realizar cesárea al llegar a las 38 semanas

166) Una paciente de 24 años, multípara de 1, con antecedente de una cesárea previa, por desproporción céfalo pélvica. Cursa con un nuevo embarazo, de término, cuando inicia trabajo de parto. Inicialmente tiene buena dinámica uterina, sin embargo, luego desaparece, agregándose escasa metrorragia. El monitoreo fetal muestra bradicardia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Desprendimiento de placenta
- b) Rotura uterina
- c) Rotura de vasa previa
- d) Placenta previa
- e) Hipotensión secundaria a la anestesia



167) A una paciente se le inserta un DIU en un box de atención ginecológica, pero se sospecha que se produce una rotura uterina. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar analgésicos
- b) Solicitar radiografía de pelvis
- c) Traccionar las guías del DIU
- d) Hospitalizar
- e) Citar a control en 48 horas

168) Una paciente de 30 años, con actividad sexual, consulta por dolor vulvar y sensación febril. Al examen físico se aprecia aumento de volumen eritematoso, de 6 cm de diámetro, doloroso, en relación a la zona posterior del labio mayor derecho. La conducta terapéutica más adecuada es:

- a) Cistectomía de Bartholino
- b) Drenaje por punción
- c) Drenaje quirúrgico simple
- d) Iniciar antibióticos orales y esperar el drenaje espontáneo
- e) Bartholinocistostomía

169) Una paciente de 19 años consulta por disuria dolorosa y lesiones vulvares, de 48 horas de evolución. Refiere relaciones sexuales sin protección. Al examen genital, tiene 3 úlceras de fondo amarillento y halo eritematoso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Molusco contagioso
- b) Infección por Chlamydia trachomatis
- c) Herpes genital
- d) Chancro sifilítico
- e) Condiloma acuminado

170) Una paciente de 30 años, púerpera de 28 días, en lactancia materna, consulta por dolor en la mama derecha, asociado a fiebre hasta 38,5°C. Al examen tiene aumento de volumen y eritema zona superior derecha de la mama, con aumento de volumen palpable, de consistencia aumentada y dolorosa, de 4 cm de diámetro, no fluctuante ni renicente (una palabra inventada por quien hizo esa pregunta), ubicado en el cuadrante superoexterno de dicha mama. El diagnóstico más probable es:

- a) Congestión mamaria
- b) Flegmón mamario
- c) Absceso mamario derecho
- d) Mastitis derecha
- e) Cáncer inflamatorio de mama



171) Una paciente de 26 años, puérpera de 5 días, presenta fiebre, malestar general y loquios de mal olor. Al examen físico tiene dolor a la palpación y se solicita una PCR, que resulta 9,2 mg/L. Se inicia tratamiento antibiótico con penicilina sódica y gentamicina, sin embargo, dos días después, continúa febril, con dolor y PCR 8,8 mg/L. El agente más probable es:

- a) *Proteus mirabilis*
- b) *Escherichia coli*
- c) *Bacteroides fragilis*
- d) *Streptococcus beta-hemolítico grupo B*
- e) *Chlamydia trachomatis*

172) Una niña de 9 años, sin antecedentes de importancia, consulta por dolor mamario derecho. Al examen físico presenta mama derecha en Tanner II y mama izquierda en Tanner I, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar ecografía mamaria
- b) Controlar en 1 año
- c) Solicitar resonancia magnética de silla turca
- d) Realizar ecografía pelviana
- e) Solicitar 17-OH-progesterona

173) Una paciente de 23 años, usuaria de anticonceptivos orales, desde hace 8 meses, consulta por cefalea intensa, que inicia 3 días antes de la menstruación y que dura hasta el segundo día de la menstruación. Refiere que la cefalea se asocia a visión de destellos de luces. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Anticonceptivos orales de ciclo extendido
- b) Disminuir la dosis de estrógeno
- c) Disminuir la dosis de progestágeno
- d) Indicar anticonceptivos orales de progestágeno solo
- e) Indicar anticonceptivos combinados inyectables

174) Una mujer de 30 años, cursando un embarazo inicial, presenta un aborto espontáneo, que es manejado con legrado, con buen resultado y sin complicaciones. Se controla dos semanas después y la biopsia es informada como “mola hidatiforme”. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar anticonceptivos orales por 12 meses
- b) Controlar con beta-HCG seriada
- c) Controlar con ecografía transvaginal en 2 semanas
- d) Quimioterapia profiláctica
- e) Realizar histerectomía



175) Una niña de 17 años, con antecedente de menarquia a los 15 años y cuyas reglas son irregulares, cada 30 a 40 días. Consulta por dolor pélvico muy intenso, asociado a sudoración y vómitos. Al preguntarle dirigidamente, niega actividad sexual. Al examen físico se observa adolorida, quejumbrosa y se palpa una masa hipogástrica de 7 cm de diámetro, muy dolorosa. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de ovario
- b) Absceso tuboperitoneal
- c) Síntomas de aborto
- d) Torsión anexial
- e) Pelviperitonitis

176) Una mujer cursa un embarazo de 10 semanas y se realiza una glicemia de ayuno, que resulta 128 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Prediabetes
- b) Diabetes mellitus gestacional
- c) Glicemia de ayuno alterado
- d) Diabetes mellitus pregestacional
- e) Intolerancia a la glucosa oral

177) Una mujer de 62 años, con antecedente de 2 episodios de metrorragia autolimitada, en los últimos 3 meses, se realiza una ecografía transvaginal, que muestra un endometrio de 10 mm de grosor. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar anticonceptivos orales
- b) Realizar estudio de alteraciones de la hemostasia
- c) Solicitar resonancia magnética de pelvis
- d) Realizar biopsia endometrial
- e) Observar evolución

178) Una paciente de 41 años, presenta un nódulo mamario derecho, de 2 cm de diámetro, que se autopalpó hace 2 meses. Al examen físico tiene consistencia dura e irregular. Cuenta con una mamografía, que es informada como Birrads 4. La conducta más adecuada es:

- a) Controlar con nueva mamografía en 1 año
- b) Solicitar ecotomografía mamaria
- c) Solicitar resonancia magnética de mama
- d) Realizar biopsia con aguja gruesa
- e) Realizar biopsia estereotáxica



179) Una paciente tiene antecedente de una trombosis venosa profunda, hace 4 años, en relación al inicio de anticonceptivos orales, la que fue tratada con anticoagulación oral por 6 meses. Consulta por un embarazo de reciente diagnóstico. ¿Cuál es el manejo de elección?

- a) Iniciar antiagregantes plaquetarios
- b) Realizar estudio de trombofilia
- c) Iniciar heparina de bajo peso molecular
- d) Iniciar ácido tranexámico
- e) Iniciar tratamiento anticoagulante oral

180) Una mujer de 35 años, con antecedente de parto hace 3 meses, actualmente dando lactancia materna, consulta por dispareunia y prurito postcoital de algunas semanas de evolución. En su especuloscopia se observan paredes vaginales con mucosa pálida y seca

- a) Realizar cultivo para Candida
- b) Realizar microscopía en búsqueda de Trichomonas vaginalis
- c) Iniciar anticonceptivos combinados orales
- d) Realizar búsqueda de “clue cells”
- e) Indicar lubricante íntimo genital

Fin del examen

¡Les deseamos el mayor de los éxitos!



Pauta Eunacom Diciembre 2018

PRIMERA PARTE

- 0 A Sin duda es el mejor curso, además de ser el más completo y actualizado.
- 1 D Es una HTA renovascular clásica, tanto por el soplo renal, como por la clínica de hipertensión secundaria (joven, severa),
- 2 D Es una insuficiencia aórtica clásica (ver resumen de semiología cardíaca).
- 3 A Es una CIA clásica (ver resumen de semiología cardíaca).
- 4 E Por tener compromiso hemodinámico, da igual de qué taquiarritmia se trate y se debe cardiovertir eléctricamente (no confundir con la desfibrilación, que se usa en el paro con FV o TVSP).
- 5 B Por las náuseas, más la descompensación de la insuficiencia cardíaca, parece una intoxicación digitálica.
- 6 A La tos es la reacción adversa más frecuente de los IECA y es la razón principal para reemplazarlos por inhibidores de la angiotensina II.

- 7 D El tratamiento de la crisis hipertensiva, sin compromiso de órgano blanco (urgencia hipertensiva) es el captopril oral. Sin embargo, la evidencia es errática y permite usar otros antihipertensivos.
- 8 C La radiografía no se veía bien, pero tanto por la PCR + para TBC, como por el *quantiferón* positivo, probablemente se trata de una TBC, aunque las baciloscopías estén negativas y se debe iniciar el tratamiento habitual.
- 9 E Tiene un derrame pleural izquierdo, por lo que se debe evacuar y estudiar. La clínica orienta a neumonía o tuberculosis, sin dejar claro cuál es la causa.
- 10 C Parece una influenza u otra infección respiratoria alta, por lo que se trata con paracetamol o acetaminofeno.
- 11 A Es una pregunta discutible. Lo primero a revisar siempre son las radiografías previas. Luego, el TAC es el examen de elección para el enfrentamiento del nódulo pulmonar. Sin embargo, el PET/TC ha demostrado ser de gran utilidad (a pesar de falsos positivos), por lo que también es una respuesta potencialmente correcta. Luego se hace la biopsia por broncoscopia.
- 12 D No queda claro cuál es el diagnóstico, pero parece una enfermedad de Crohn, por lo que se estudia con colonoscopia. También podría ser un linfoma MALT, que se estudia igual.
- 13 A Es una colangitis esclerosante primaria clásica (se asocia a colitis ulcerosa y tiene patrón colestásico).
- 14 B Es una pregunta discutible. La hematoquecia con compromiso hemodinámico (HDB masiva) siempre se debe estudiar con EDA (en este caso falta el compromiso hemodinámico, pero creemos que es la respuesta correcta igual). La colonoscopia es el examen de elección en la HDB (y acá se hizo) y si no localiza, se sigue estudiando con pruebas radiológicas (cintigrafía o angiografía).

- 15 D Se sospecha una úlcera gastroduodenal (aunque el dolor suele ser más intenso en ayunas). Se estudia con EDA.
- 16 B Es una cetoacidosis diabética clásica (acidosis metabólica y diabetes tipo 1).
- 17 C Tanto por los síntomas de diabetes (baja de peso y polidipsia), como por la HbA1c mayor a 9%, está indicada la insulina.
- 18 D El síndrome de Cushing se estudia de elección con el cortisol libre urinario de 24 horas.
- 19 D Tiene un hipogonadismo hipogonadotrófico (las gonadotropinas normales se consideran como hipogonadotrófico), por lo que es de causa hipotalámica o hipofisiaria (el hipo-hipo es hipo-hipo).
- 20 D Tiene una crisis suprarrenal clásica: shock refractario, hiponatremia, hipoglicemia e hiperkalemia (el K⁺ está normal en este caso, pero en el límite alto). Sin embargo, también tiene una insuficiencia renal aguda (creatinina elevada), pero el diagnóstico más importante es la insuficiencia suprarrenal.
- 21 B Tiene un hipotiroidismo subclínico, sin complicaciones, por lo que no requiere tratamiento y se debe observar.
- 22 A Es una enfermedad de Parkinson clásico: temblor de reposo, bradicinesia y problemas de inicio de marcha.
- 23 B Es un síndrome de Guillain Barré clásico
- 24 B En la práctica no es fácil diferenciar los distintos tipos de AVE con la sola clínica. La cefalea orienta más a hemorrágico, pero en el puente, habría tenido compromiso de conciencia y afectación de pares craneales. El de arteria cerebral media tendría alteraciones del habla y sensitivas. Una AVE lacunar clásico es el con hemiparesia pura, sin afectación del habla ni

conciencia. Suelen no tener cefalea, pero el 10% sí tiene.

25 B Tiene una hipocalcemia aguda grave clínica. Se debe tratar con gluconato de calcio urgente.

26 B Tiene un síndrome nefrótico clásico (edema, proteinuria, hipoalbuminemia y dislipidemia), que en los adultos suele ser causado por la nefropatía membranosa. Vale la pena mencionar que la proteinuria debe ser mayor a 3 gramos al día y acá solo se dice que es de 500 mg/dl, lo que es muy alto (si hace un litro de orina al día, sería de 5 gramos al día).

27 D Tiene una probable leucemia aguda. Si bien el examen inicial es el mielograma, el que confirma (lo que se pregunta) es la biopsia de médula ósea y también sirve el mielograma (frotis de médula ósea).

28 C Tiene muchas cosas de lupus sistémico: úlceras orales, rash malar, linfocitos bajo, ANA+, anti-DNA+, hipocomplementemia.

29 C Es una artritis psoriática clásica (con los “picotazos” ungueales).

30 A La gota aguda se trata con AINEs (la HCTZ es un desencadenante). También sirve la colchicina. El alopurinol jamás se inicia en agudo.

31 B Es un síndrome de CREST clásico (Solo falta la calcinosis, pero tiene Raynaud, Esofagopatía, eSclerodactilia y Telangiectasias, más la Tirantez e la cara).

32 E Ahora ya saben, el atenolol puede producir impotencia sexual.

33 D Por el VIH está obligada a usar métodos de barrera.

34 C Es un TOC clásico (obsesión de dañar y compulsión de no exponerse a la posibilidad). Igual era difícil, porque probablemente se había complicado con una depresión.

- 35 E Es un trastorno de estrés postraumático, con síntomas disociativos. Era una pregunta difícil, pero cumple con los criterios del CIE-10.
- 36 B Es una acatisia clásica.
- 37 B Tiene un trastorno de pánico clásico, que se trata con antidepresivos IRS, como la sertralina.
- 38 A Es una distonía clásica: la tortícolis espasmódica.
- 39 A Parece una esquizofrenia por las alucinaciones auditivas y el inicio en la adolescencia.
- 40 A Es una intoxicación por tricíclicos por el compromiso de conciencia, taquicardia y pupilas arreactivas (en midriasis). No puede ser benzodiacepinas ni opiáceos, porque no tenía disminución de la frecuencia respiratoria. AINEs y salicilatos no afectan las pupilas.
- 41 D La vigilancia activa (notificación obligatoria) busca identificar los brotes de manera rápida, para poder contenerlo, haciendo un adecuado manejo de los casos (aislamiento y tratamineto) y de los contactos (profilaxis y observación).
- 42 C Es una pregunta difícil, ya que tanto alta sensibilidad, como alto valor predictivo negativo son respuestas correctas y, de hecho, se relacionan entre sí. Sin embargo, en estricto rigor, es el alto VPN lo que hace que se descarte una enfermedad al resultar negativo el examen.
- 43 B La sensibilidad debe ser alta, para detectar todos los casos, aunque la especificidad no sea tan alta (por ello, luego se confirma con otros exámenes más específicos).
- 44 B La vigilancia por centros centinelas se usa en las siguientes enfermedades: infecciones respiratorias altas, diarreas, varicela y las infecciones de transmisión sexual (excepto la sífilis y gonorrea, que son de notificación obligatoria).

- 45 A Es un estudio ecológico clásico, sin embargo, vale la pena mencionar que también es un estudio de tipo observacional (ya que no es experimental).
- 46 D Es un estudio de casos y controles, por lo que se calcula el OR, como medida de asociación. El riesgo relativo también era una medida de asociación (las demás no).
- 47 C? Es una mala pregunta, ya que hay más de un tipo de estudio que se puede utilizar para ello (además que no queda claro a qué tipo de intervenciones focalizadas se refiere). Sin embargo, el estudio de casos y controles suele dar información rápida y barata, que permite identificar los factores de riesgo, para controlarlos. Los ecológicos son baratos, pero abarcan toda la población (no son focalizados).
- 48 A No queda claro si es una prostatitis aguda o una ITU, pero el ciprofloxacino las cubre a ambas.
- 49 A Es una pregunta difícil, ya que el sildenafil está contraindicado por el infarto reciente. De primera línea está el sildenafil, la apomorfina y los dispositivos de vacío (no recuerdo si salía apomorfina). De segunda línea, están las inyecciones intracavernosas de papaverina o prostaglandina. La última línea es la prótesis peneana. La yohimbina y la prostaglandina tópica sirven, pero poco.
- 50 B Es una fractura de cadera clásica, con la posición impúdica.
- 51 D Tiene una probable fractura de pelvis, pero por tener compromiso hemodinámico, lo más urgente es poner una vía venosa, administrar fluidos y estabilizar la pelvis (por ejemplo con una sábana pélvica).
- 52 D Parece una bursitis trocantérica clásica.
- 53 E Es una obstrucción intestinal clásica, cuya causa más frecuente son las bridas (en especial en pacientes con antecedente de cirugía abdominal previa).

- 54 B El hígado graso se trata con ejercicio, dieta y metformina. Los quistes simples son algo normal y frecuente. Los pólipos vesiculares menores a 1 cm se observan.
- 55 E La derivación gastroyeyunal es menos agresiva que la hgastrectomía y permite reestablecer el tránsito gastrointestinal.
- 56 C Lo primero a descartar es el cáncer de colon (después la enfermedad celíaca).
- 57 E Es una diverticulitis clásica.
- 58 C La disfonía crónica se estudia con nasofibroscopía (más aún cuando se sospecha un cáncer de laringe, como en este caso).
- 59 D Es una sinusitis aguda, que se trata con amoxicilina.
- 60 C Es una atresia lagrimal clásica. No tien buftalmo ni opacidad corneal, como para pensar en glaucoma congénito.
- 61 B Es una rosácea clásica: aumenta con la exposición solar. El lupus sistémico también puede afectar las mejillas y aumentar con el sol, pero no tiene tantas pústulas. Además, el lupus cutáneo crónico es una o más placas, sin pústulas, de curso crónico.
- 62 B Es un granuloma piógeno clásico. Eso sí, la foto era distinta.
- 63 D Es un cáncer basocelular clásico.
- 64 E Es un queloide clásico (cicatriz patológica, grande, que sobrepasa los límites de la herida).
- 65 A Parece una disfonía por reflujo (mayor en la mañana). Se puede hacer una prueba terapéutica, aunque lo mejor suele ser solicitar una pH-metría para confirmar el diagnóstico.

- 66 D? Es una mala pregunta. En estricto rigor parece una celulitis preorbitaria, que no estaba en las opciones, secundaria a una sinusitis (no queda claro si es maxilar, etmoidal o frontal). Tampoco parece un absceso orbitario (no existe el concepto periorbitario), por no tener limitación a la movilización de los movimientos, proptosis o otras alteraciones similares.
- 67 C La vacuna contra el rotavirus se ha asociado a la invaginación intestinal.
- 68 A La alergia al huevo no contraindica ninguna vacuna.
- 69 C Es un eritema infeccioso clásico. El exantema puede durar hasta 30 días.
- 70 B Es un exantema súbito clásico, por virus herpes 6.
- 71 C Es una escarlatina clásica por *S. pyogenes* (EBHGA).
- 72 D Considerando que es normal que bajen de peso, hasta un 10% del peso y que lo recuperen a los 7 días, su incremento de peso es del todo normal.
- 73 D Después de los 12 meses se hace la maniobra de Heimlich. Bajo los 12 meses de edad, se dan los golpes interescapulares.
- 74 E La hernia diafragmática congénita se complica con hipoplasia pulmonar que puede ser muy grave.
- 75 E Es una infección clásica por adenovirus: recordar que antes de los 3 años son muy raras las amigdalitis bacterianas.
- 76 D Es un síndrome de Marfán clásico (afecta tanto a hombre, como a mujeres y es genético, autosómico dominante).
- 77 B Es un TORCH clásico (pequeño para la edad gestacional), cuya causa más frecuente es el CMV. La sepsis (por SGB) puede tener un cuadro similar, pero le sobra lo pequeño para la edad

gestacional.

78 A La vacuna está pensada para niñas y niños que no han iniciado su actividad sexual (además que no ha demostrado ser mejor que el PAP). Por eso, el PAP de control es lo más importante. Eso sí, en la vida real, si es "virgen al virus", igual serviría la vacuna.

79 E Es una cervicitis aguda clásica, cuyas causas más frecuentes son la gonorrea y la clamidia.

80 D Tiene un proceso inflamatorio pélvico, no complicado, por lo que se trata con antibióticos de amplio espectro.

81 B Se sospecha un embarazo ectópico y es lo primero a descartarse.

82 D El DIU es causa de aumento del flujo menstrual y de dismenorrea. Se debe retirar y se puede cambiar por un DIU medicado.

83 C El oligoamnio se maneja según la causa (no aparecía bucar la causa). El idiopático puede manejarse como un embarazo normal y no contraindica el parto vaginal. Se suele interrumpir al llegar a término y máximo a las 40 semanas, por el riesgo de óbito fetal.

84 A Le faltan las modificaciones cervicales, por lo que aún no inicia el trabajo de parto. Es más, si tuviese dilatación hasta 3 cm, estaría en fase latente y también se envía a domicilio, indicando recontrol en una hora).

85 D El diagnóstico de la colestasia intrahepática es clínico y no requiere de exámenes. Sin embargo, las fosfatasa alcalinas se elevan con mucha frecuencia, mientras que la bilirrubina puede ser normal.

86 C La astenia, la hipoglicemia y la clínica inespecífica son clásicas del hígado graso agudo del embarazo. No es HELLP, a pesar de la LDH alta, por la PA normal.

- 87 C Es un cáncer de ovario clásico.
- 88 B La TRH comúnmente indicada es la combinada (estrógeno más progestágeno) continua. Si hubiese sido histerectomizada, se indican estrógenos solos.
- 89 A Se debe solicitar la serología: IgG antivariela. Si está positiva, no hay riesgo. Si está negativa, se indica la gamaglobulina hiperinmune, por tener menos de 20 semanas.
- 90 E La FUR no es confiable (por ser irregular) por lo que no sirve. Aún así, la ecografía es el mejor indicador y a esa edad gestacional manda la longitud céfalo-nalgas.

SEGUNDA PARTE

- 91 B También era una insuficiencia aórtica clásica (ver resumen de semiología cardíaca).
- 92 D Tiene una fibrilación auricular paroxística. Tiene baja frecuencia cardíaca, por lo que no se debe iniciar verapamilo ni betabloqueo. Por ser hipertenso y diabético, tiene 2 puntos del CHADS₂, por lo que se debe anticoagular.
- 93 D La espironolactona aumenta la sobrevida en la insuficiencia cardíaca (no era necesario un enunciado tan grande para preguntar eso).
- 94 A Es una pericarditis clásica, tanto por la clínica, como por el EKG con SDST en J en casi todas las derivaciones.
- 95 C Con las maniobras vagales baja la frecuencia, se ven las ondas de serrucho y luego vuelve a aumentar la frecuencia. Es lo clásico del flutter auricular.

- 96 B? C? Es un bloqueo AV de segundo grado, con bloqueo 2:1. Por lo tanto es imposible hacer la diferencia entre Mobitz I y II, por lo que es una mala pregunta. Yo marqué B.
- 97 D Es un TEP clásico.
- 98 E Tanto por la clínica, como por la radiografía es una fibrosis pulmonar clásica.
- 99 D Es un TEP masivo (compromiso hemodinámico), por lo que se estudia con ecocardiograma (para evaluar la disfunción del ventrículo derecho), y no con el angioTAC (de elección en el TEP no masivo).
- 100 A Tiene una neumonía del lóbulo superior derecho. En estricto rigor, se puede tratar con amoxicilina, ya que no tiene indicación de ácido clavulánico. Pero de las opciones, la mejor era la A.
- 101 A Es una mala pregunta, ya que lo más correcto es indicar psicoterapia cognitivo conductual (es lo más importante y asumo que se incluye dentro de la entrevista motivacional), sin embargo, también se deben indicar fármacos de apoyo, como la B, C y E.
- 102 E Es un síndrome de Gilbert clásico (hiperbilirrubinemia de predominio no conjugado, sin otras alteraciones).
- 103 C Es una colitis ulcerosa clásica. No tiene elementos que hagan elegir a la enfermedad de Cröhn.
- 104 B Es una enfermedad celíaca clásica del adulto (diarrea y ferropenia).
- 105 B Tiene un hipotiroidismo subclínico o clínico (no daban la T4 libre, por lo que no se puede saber). Sin embargo, de las opciones, la única que tenía sentido era iniciar levotiroxina y, por ser una adulto mayor, se debe iniciar con una dosis más baja.
- 106 C? Tanto B, como C cumplen criterios de diabetes. No queda claro qué es lo que se

quiere preguntar. Como ahora está con una neumonía, la PTGO puede salir falsamente alterada, en cambio la HbA1c es más estable (por lo que la consideraremos correcta). Sin embargo, la HbA1c no está dentro de los criterios diagnósticos de la guía Minsal. Es una mala pregunta.

107 D Tiene efectos adversos, por lo que se debe suspender la metformina y cambiar a sitagliptina (por lo frágil: adulto mayor con infarto reciente, se prefiere la sitagliptina sobre la glibenclamida). No tenía indicaciones evidentes de insulina.

108 A El LDL debe ser menor a 70, por ser de alto riesgo coronario. Por ello, se prefieren las estatinas. Eso sí, por haber tenido mialgias, se debe iniciar con una dosis más baja y controlar con CK, para asegurarse que no haya miopatía por estatinas.

109 C Es una miopatía pos estatinas clásica.

110 E? No se entiende qué es lo que se quería pregunta. La 17-OH progesterona permite diagnosticar la hiperplasia suprarrenal congénita, que es el diagnóstico diferencial del SOP más importante y que también tiene mucho hirsutismo. Por otro lado, la relación LH/FSH elevada sugiere un SOP, aunque no se usa como criterio, por tener muchos falsos negativos.

111 C Es un tumor hipofisiario clásico, con síntomas compresivos del quiasma e hipopituitarismo. Se estudia con RMN de silla turca.

112 D Es un atrapamiento cubital clásico.

113 A Es un lupus sistémico clásico, con afectación renal.

114 C Tanto por ser diabético (en HTA), como por la proteinuria, como por tener PA mayor a 130/80 (en falla renal), está indicado iniciar un IECA.

115 A Es una anemia ferropénica clásica, tanto por la edad, como por la microcitosis.

116 D Tanto por ser vegetariana, como por la cirugía bariátrica, como por el VCM mayor a

108, es un déficit de B12.

117 C Tanto por la afectación neurológica, como por la pancitopenia con VCM tan elevado, es una anemia perniciosa, por déficit de B12.

118 A??? Por la edad, lo más probable es la polimialgia reumática, aunque generalmente no eleva tanto las CK y suele cursar sin debilidad, sino solo con las mialgias. Por otro lado, tanto polimiositis (PM), como la miositis por cuerpos de inclusión (MCI) calzan con el cuadro y las alteraciones, aunque la MCI tiene atrofia de cuádriceps y del antebrazo, como cosa característica (pero es más frecuente a esa edad que la PM). No sé cual es la respuesta correcta (esperemos que se elimine).

119 E Es un síndrome confusional agudo o delirium clásico.

120 B La depresión en el adulto mayor se trata con IRS, en especial la sertralina y el citalopram/escitalopram.

121 D El síndrome colinérgico: diarrea e incontinencia urinaria es una complicación frecuente del donepecilo. La metformina solo produce diarrea.

122 D Tiene una bacteriuria asintomática, por lo que no es necesario hacer ningún cambio.

123 A Tiene una endocarditis subaguda por Streptococcus viridans, que se trata con ampicilina o penicilina sódica.

124 D Es una mucormicosis clásica.

125 B La oxiuriasis se diagnostica con el test de Graham.

126 B Es una encefalitis herpética clásica: alteraciones conductuales, convulsiones, compromiso de conciencia, líquido cefalorraquídeo compatible con meningitis viral, pero

hemorrágico. Lo unico raro era la edad, ya que suele afectar a personas más jóvenes.

127 A Es un herpes zóster, que se trata con aciclovir o valaciclovir. El valganciclovir se usa en las infecciones por CMV.

128 A Tiene una manía aguda, por lo que tiene un trastorno bipolar.

129 B Tiene síntomas anímicos y psicóticos. Además, por la severidad del cuadro y haber tenido síntomas psicóticos sin compromiso anímico, es más probable que tenga un trastorno esquizoafectivo, en la variante bipolar.

130 A Es una fuga disociativa clásica.

131 C La sospecha de manipulación de los exámenes, hace que sea facticio.

132 B Es un TP limítrofe clásico.

133 D Es una agorafobia clásica.

134 C Es una depresión clásica (cumple criterios: si bien no tiene tristeza, sí tiene anhedonia).

135 D Si hay más partos en el hospital, se necesitan más obstetras y matronas.

136 D Lo importante es que se interactúa con la comunidad y se van escogiendo las patologías y factores de riesgo más importantes para la salud pública y para la comunidad, de manera de intervenir sobre ellas, haciendo una priorización previamente.

137 D Puede ser una torsión testicular, por lo que se debe explorar de inmediato.

138 E Si bien no tiene indicación evidente de hospitalización, a pesar de ser una pielonefritis aguda, de las opciones, la más acertada parecía ser el cefotaximo, que cubre muy bien a

los gram negativos.

139 A Recordar que la patología de cadera puede producir gonalgia (dolor de rodilla).

140 B Es un síndrome de manguito rotador clásico.

141 B Es una fractura de muñeca clásica.

142 E La luxación anterior de hombro se reduce ortopédicamente, de inmediato. Si recurre, se trata con cirugía.

143 D Por la clínica era un neumotórax. La radiografía era muy oscura, pero con imaginación y paciencia, se veía el neumotórax derecho (acá se ve más que en el real). Por ser mayor a 15%, se trata con tubo pleural.

144 D Es una hernia femoral clásica (bajo el ligamento inguinal). Es más frecuente en mujeres.

145 D Tiene la triada de Charcot: dolor, ictericia y fiebre, más el compromiso hemodinámico clásico de la colangitis.

146 B Parece una coledocolitiasis. Se debe estudiar inicialmente con una colangiografía y luego (si la colangiografía ve los cálculos), se procede a la CPRE (también se hace la CPRE si tiene clínica de colangitis o si la eco ve los cálculos en el colédoco).

147 D La colonoscopia es el examen de elección para enfrentar la HDB. La EDA se hizo, porque tenía hemodinamia inestable (siempre se debe hacer en ese caso). No importa que hace un mes tuviese una colonoscopia normal. Si no localiza, se procede a la cintigrafía con GR marcados o a la angiografía mesentérica.

148 A? Es una pregunta difícil, ya que el compromiso hemodinámico y los signos peritoneales pueden corresponder tanto a un hemoperitoneo, como a la dehiscencia de la base

apendicular. Sin embargo, por predominar el compromiso hemodinámico, nos inclinamos a marcar hemoperitoneo. Si, en cambio, hubiese tenido predominancia de los signos peritoneales, nos habríamos inclinado a la dehiscencia.

149 E Es un glaucoma agudo clásico: antecedente de hipermetropía, ojo rojo central y midriasis arreactiva.

150 E Es un DMRE clásica, tanto por la clínica (metamorfopsias y escotoma central), como por el fondo de ojo (aunque se veían exudados y hemorragias maculares y no solo drusas).

151 B Es una alopecia areata clásica.

152 A Tiene un granuloma umbilical. En general se observa (por lo que el NiTrato de tocarlo es mejor que el nitrato de plata), pero de las opciones era la mejor.

153 E Es un impétigo buloso, causado por S. aureus.

154 B Es una atresia biliar primaria clásica: ictericia tardía y acolia.

155 B Tiene una estenosis hipertrófica del píloro, que se estudia con ecografía abdominal.

156 D Se sospecha una fibrosis quística, que se estudia con el test del sudor, que mide cloro en el sudor.

157 A Es una neumonía atípica, que suelen ser causadas por mycoplasma y son muy frecuentes en la edad escolar.

158 E La laringitis obstructiva, se trata con O2, adrenalina racémica en nebulización y corticoides sistémicos (en ese orden de administración).

159 B Tiene un PTI clásico: alteración de hemostasia primaria, con trombocitopenia aislada.

- 160 E Es una crisis celíaca clásica: historia compatible con enfermedad celíaca previa, que se descompensa. En los exámenes tiene signos carenciales: hipoalbuminemia, hipokalemia y ferropenia.
- 161 B Tanto por el compromiso de conciencia, como por el compromiso hemodinámico (signos de shock hipovolémico: palidez y llene capilar lento) tiene indicación de hidratación endovenosa con suero fisiológico (plan C).
- 162 C La laringomalacia es la causa más frecuente de estridor congénito.
- 163 C Tiene una constipación funcional clásica, probablemente complicada con un fecaloma (por la incontinencia fecal). Es la causa más frecuente de constipación en niños y se mejora con laxantes y formación de hábitos de defecación.
- 164 A La vacuna antineumocócica se administra a los 2, 4 y 12 meses. No se ajusta por edad gestacional. Además, el ajuste solo se hace en menores de 32 semanas (y aunque así fuera, esta vacuna no se ajusta).
- 165 A La triterapia se inicia a las 20 semanas y es la medida más importante, ya que baja la carga viral, que es el predictor de transmisibilidad.
- 166 B Es una rotura uterina clásica: antecedente de cesárea, contracciones dolorosas que ceden, metrorragia intraparto y sufrimiento fetal.
- 167 B Lo primero es localizar el DIU, para saber dónde está (incluso puede estar dentro de un vaso sanguíneo). La localización se hace con ecografía o con radiografía. Luego se ve si se deja o se saca.
- 168 E Es una pregunta discutible, pero desde hace algunos años se recomienda de entrada la marsupialización del absceso de Bartholino (Bartholinocistostomía) por tener menos recurrencia y ser técnicamente muy simple (yo la tuve mala, porque marué drenaje simple).

- 169 C? Es un herpes genital clásico.
- 170 B Por no ser fluctuante, parece un flegmón mamario. Aunque en estricto rigor igual es una mastitis. Sin embargo, se hacía mucho hincapié en la lesión no fluctuante, por lo que dejaremos flegmón como respuesta correcta. Es una mala pregunta.
- 171 C Por no haber respondido, lo más probable es que sea un anaerobio (por eso se deja penicilina + gentamicina + clindamicina). Las demás opciones estaban cubiertas con el esquema indicado.
- 172 B Es una telarquia normal (inicio puberal), que puede ser asimétrica al inicio.
- 173 A Tiene una jaqueca premenstrual, que se desencadena por la caída de los niveles de estrógeno. Por ello, se indican ACO de ciclo extendido, que tienen niveles más homogéneos de estrógeno. Sin embargo, la evidencia dice que se debe tratar como toda jaqueca común y corriente.
- 174 B Lo más importante es la HCG seriada, para detectar precozmente la aparición de una neoplasia trofoblástica gestacional. Sin embargo, también deberá quedar con ACO, para evitar un embarazo que eleva la HCG y alterará el seguimiento.
- 175 D Parece una torsión ovárica clásica: dolor intenso, asociado a vómitos, de inicio súbito.
- 176 D Si bien le falta otra glicemia de ayuno mayor o igual a 126, para confirmar el diagnóstico, sobre dicho valor se sospecha una diabetes pregestacional.
- 177 D Por tener metrorragia postmenopáusica, más un endometrio mayor o igual a 5 mm, se debe biopsiar (con TRH es mayor o igual a 9 mm).
- 178 E Birrads 4 se biopsia. Tanto aguja gruesa, como biopsia estereotáxica son respuestas aceptables. Sin embargo, la biopsia estereotáxica suele ser mas fidedigna.

179 C? Es una mala pregunta, ya que lo ideal es contar con un estudio de trombofilia (las guías gringas lo recomiendan, aunque en el embarazo es un mal mometo para hacerlo). Sin embargo, por haber sido una TVP relacionada a los estrógenos, creo que lo mejor será anticoagularla durante el embarazo, con heparina de bajo peso.

180 E Tiene una atrofia vaginal, por hipoestrogenismo fisiológico. Se trata de primera línea, con lubricación genital.

Guillermo Guevara | Scholarship Theme por Mystery Themes.

RECONSTRUCCIÓN EUNACOM JULIO 2019

Dr. Guillermo Guevara Aliaga

Este examen se caracterizó por los siguientes cambios:

- 1) Las preguntas incorrectas ya no descontaban, por lo que no era recomendable omitir.
- 2) Las preguntas aparecieron, por primera vez, en dos columnas (ahorraron hojas, a expensas de tener imágenes muy pequeñas).
- 3) Los enunciados fueron algo más cortos que los de las últimas versiones.
- 4) Se repitieron muchas preguntas de las versiones previas del Eunacom, dentro de las que estaban las más difíciles del examen.

Pregunta 0) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) El curso del Dr. Guevara es el mejor curso de preparación para el Eunacom y con mejor relación precio-calidad.
- b) El curso práctico del Dr. Guevara también es el mejor curso para enfrentar la sección práctica del Eunacom y los cupos se agotan rápido.
- c) En Chile no es obligatorio afiliarse al Colegio Médico y, además, es caro, por lo que lo más conviene es contratar el servicio de MedLaw, que incluye un seguro de mal praxis, más la mejor y más completa asistencia legal, contable y tributaria.
- d) El Centro de Apoyo al Médico Extranjero de MedLaw es un servicio gratuito, que pretende ayudar a los médicos extranjeros a integrarse correctamente en el sistema chileno, resguardando sus derechos.
- e) Todas son verdaderas.

RC: E

Podemos decir con absoluta confianza de que nuestros cursos son los mejores y que nos esforzamos día a día para ello. Aprovechamos de desearles a todos nuestros alumnos que les haya ido excelente en este examen. Les dejamos también el link de nuestra página web www.drguevara.cl donde podrán encontrar información sobre nuestros cursos y, también, material de estudio gratuito.

Aprovechamos de contarles que recientemente iniciamos nuestra empresa de asistencia legal, contable y tributaria MedLaw y nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio de Chile. En www.medlaw.cl podrás conocer nuestros servicios y encontrar información de interés y, además, si estudiaste en el extranjero, puedes unirse gratuitamente al Centro de Apoyo al Médico Extranjero y permitírnos defenderte.

Finalmente, dejamos el link del Diario Constitucional, donde se resume la condena a Eunamed, por plagiarlos, dado que creemos importante que se sepa, en especial después de las declaraciones que han emitido: <https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/asuntos-de-interes-publico/2019/05/08/juzgado-civil-acoge-demanda-por-plagio-de-programa-de-preparacion-de-examen-nacional-de-medicina/>

Dr. GUEVARA
WWW.DRGUEVARA.CL

¡INSCRIPCIONES ABIRTAS!

CURSO PRÁCTICO

INICIO: 9 DE AGOSTO

PRÁCTICAS: MEDICINA INTERNA - PEDIATRÍA - GINECOLOGÍA Y OBSTERICIA - CIRUGÍA

<http://www.drguevara.cl/curso-practico/>

www.drguevara.cl

Curso teórico para
Eunacom de diciembre

¡Inscripciones abiertas!

- ✓ CURSO TEÓRICO ONLINE
- ✓ CURSO TEÓRICO SEMIPRESENCIAL

Dr. GUEVARA

<http://www.drguevara.cl/cursos-y-precios/>

MedLaw
WWW.MEDLAW.CL

+56 9 3425 5314 / 2 3263 2291

CENTRO DE
APOYO AL
MÉDICO
EXTRANJERO

¡INSCRÍBETE GRATIS!

<http://medlaw.cl/servicios-2/>

1) Una mujer de 26 años, con embarazo de término, de 39 semanas, ingresa en trabajo de parto. Tiene 3 contracciones uterinas cada 10 minutos y, al tacto vaginal, tiene dilatación cervical de 5 cm, con membranas íntegras, feto en posición transversa y se palpa la fontanela anterior en el centro de la pelvis. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar fórceps
- b) Realizar cesárea
- c) Observar evolución espontánea
- d) Iniciar goteo oxitócico
- e) Administrar tocolíticos

2) Un paciente de 76 años, diabético, en hemodiálisis desde hace varios años, presenta un cuadro de fiebre hasta 39°C, al día siguiente de dializarse, por lo que se toman exámenes y se inician antibióticos endovenosos biasociados: vancomicina más cefotaximo, con buena respuesta clínica. Al tercer día, se controla con hemocultivo, que resulta positivo para *Staphilococcus aureus* meticilino sensible. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Mantener el esquema antibiótico
- b) Mantener solo el tratamiento con vancomicina
- c) Mantener solo el tratamiento con cefotaximo
- d) Cambiar el tratamiento a cloxacilina
- e) Cambiar el tratamiento a clindamicina

3) Un paciente de 64 años, con antecedente de hipertensión arterial, consulta por dolor torácico intenso, de carácter opresivo, irradiado al cuello y asociado a angustia y disnea. Se realiza un electrocardiograma que muestra un bloqueo completo de rama izquierda, que no estaba presente en electrocardiogramas previos. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar enzimas cardíacas
- b) Solicitar un angioTAC de tórax de inmediato
- c) Realizar tratamiento de reperfusión miocárdica de inmediato
- d) Solicitar una ecocardiografía
- e) Administrar analgésicos y mantener en observación

4) Un lactante de 11 meses de edad, con antecedente de haber nacido prematuro, a las 32 semanas, presenta peso de 7.450 gramos.

Tabla peso edad para niños de 0 a 24 meses:

Meses	-2DS	-1DS	Prom.	1DS	2DS
0	2.525	2.929	3.333	3.939	4.444
1	3.434	3.939	4.545	5.151	5.858
2	4.343	4.949	5.656	6.363	7.171
3	5.050	5.757	6.464	7.272	8.080
4	5.656	6.262	7.070	7.878	8.787
5	6.060	6.767	7.575	8.484	9.393
6	6.464	7.171	7.979	8.888	9.898
7	6.767	7.474	8.383	9.292	10.403
8	6.969	7.777	8.686	9.696	10.807
9	7.171	8.080	8.989	9.999	11.110
10	7.474	8.282	9.292	10.302	11.514
11	7.676	8.484	9.494	10.605	11.817
12	7.777	8.686	9.696	10.908	12.120
13	7.979	8.888	9.999	11.110	12.423
14	8.181	9.090	10.201	11.413	12.726
15	8.383	9.292	10.403	11.615	12.928
16	8.484	9.494	10.605	11.817	13.231
17	8.686	9.696	10.807	12.120	13.534
18	8.888	9.898	11.009	12.322	13.837
19	8.989	10.100	11.211	12.625	14.039
20	9.191	10.201	11.413	12.827	14.342
21	9.292	10.403	11.615	13.029	14.645
22	9.494	10.605	11.918	13.332	14.847
23	9.595	10.807	12.120	13.534	15.150
24	9.797	10.908	12.322	13.736	15.453

¿Cuál es el diagnóstico nutricional?

- a) Desnutrición
- b) Riesgo de desnutrición
- c) Eutrófico
- d) Sobrepeso
- e) Obesidad

5) Una mujer de 40 años presenta artralgiyas y rigidez matinal, que afecta especialmente las muñecas, articulaciones metacarpofalángicas y, desde hace algunos meses, también afecta los tobillos y articulaciones metatarsofalángicas. Al examen tiene artritis de varias a de las articulaciones descritas. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para determinar el curso clínico de la enfermedad?

- a) Velocidad de sedimentación hemática
- b) Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo
- c) Anticuerpos antipéptido citrulinado
- d) Proteína C reactiva
- e) Anticuerpos antinucleares

6) Un niño de 24 meses es traído por episodios repetidos de llanto, apnea, seguidos de hipotonía y compromiso de conciencia, que luego se recuperan espontáneamente. En algunos de estos episodios, además, presentó movimientos clónicos, de corta duración. Los episodios se han presentado en relación a situaciones en las que ha llorado o se ha enojado mucho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar TAC de cerebro y electroencefalograma
- b) Iniciar ácido valproico
- c) Solicitar electroencefalograma
- d) Iniciar carbamazepina
- e) Indicar manejo conductual

7) Un paciente de 66 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por otalgia derecha, de algunos meses de evolución, asociado a odinofagia y disfagia, a lo que se le ha agregado atoramiento con algunos alimentos y cambios en la resonancia de la voz. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de esófago
- b) Disfunción temporomandibular
- c) Cáncer de hipofaringe
- d) Faringitis crónica
- e) Cáncer de laringe

8) Un paciente de 65 años sufre una caída a nivel, con golpe en la rodilla derecha. Evoluciona con dolor e impotencia funcional. Se observa depresión suprarrotuliana en dicha rodilla y se solicita una radiografía de rodilla derecha, que no evidencia rasgos de fractura. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Luxación de rótula
- b) Disfunción patelo-femoral
- c) Rotura del ligamento cruzado anterior
- d) Rotura del ligamento rotuliano
- e) Rotura del ligamento del cuádriceps

9) Un paciente de 55 años, fumador de 20 paquetes años, consulta por tos de 3 meses de evolución, asociado a disnea y expectoración mucosa. Al examen físico se ausculta murmullo pulmonar conservado, sin ruidos agregados. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación.



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Asma bronquial
- b) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- c) Cáncer bronquial
- d) Hidatidosis pulmonar
- e) Enfermedad pulmonar intersticial

10) Una mujer de 32 años consulta por dismenorrea de 2 años de evolución, progresiva. Al examen ginecológico se palpa un tumor anexial derecho. Se solicita una ecografía transvaginal que muestra un tumor ovárico derecho, de 6,5 cm de diámetro y aspecto quístico, en vidrio esmerilado. Su Ca-125 resulta 86 UI/L (VN: < 35 UI/L). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Carcinoma epitelial
- b) Endometrioma ovárico
- c) Teratoma maduro
- d) Disgerminoma ovárico
- e) Quiste folicular

11) ¿Cuál de las siguientes medidas es más eficaz, en el mediano plazo, para disminuir la cantidad de pacientes diabéticos que progresan a necesitar hemodiálisis?

- a) Screening de glicemia en población de riesgo de diabetes
- b) Screening de glicemia en población adulta
- c) Tratamiento eficaz en pacientes diabéticos diagnosticados
- d) Prevención de factores de riesgo cardiovascular en la población adulta
- e) Prevención de obesidad en la población de riesgo de diabetes

12) Una paciente de 45 años, usuaria de anticonceptivos orales, suspende los ACO, presentando amenorrea de 4 meses. Se solicitan exámenes, que muestran TSH: 3,7 UI/L, prolactina normal, FSH: 60 UI/L (VN < 40), estradiol: 13 pg/ml (VN: 25 – 75). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome de ovario poliquístico
- b) Hipogonadismo hipergonadotrópico
- c) Atrofia endometrial por anticonceptivos
- d) Hipogonadismo hipogonadotrópico
- e) Síndrome de Asherman

13) Un paciente de 32 años se lava las manos repetidamente durante el día. Al examen está lúcido, cooperador, pero angustiado. Refiere que una voz interior le ordena lavarse las manos y no puede desobedecerle. ¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?

- a) Litio
- b) Fluoxetina
- c) Olanzapina
- d) Carbamazepina
- e) Alprazolam

14) Una niña de 8 años es traída por su madre, por talla baja. Está creciendo en el percentil 5 para la edad, con velocidad de crecimiento normal. Su madre mide 158 cm y su padre mide 166 cm. Su edad ósea corresponde a 7 años y 10 meses. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Controlar en 6 meses
- b) Frenar la pubertad
- c) Solicitar un cariógrama
- d) Solicitar radiografías de huesos largos
- e) Solicitar niveles plasmáticos de hormona de crecimiento

15) Un paciente de 42 años, alcohólico, consume cerca de 3 botellas de vino al día, durante dos semanas. Luego de 3 días de abstinencia, presenta agitación psicomotora, desorientación y temblor, asociado a alucinaciones visuales. ¿Cuál es el tratamiento inicial para el manejo de este paciente?

- a) Tiamina
- b) Zink
- c) Clorpromazina
- d) Haloperidol
- e) Diazepam

16) Una paciente de 35 años, puérpera de 3 meses, consulta por disuria, dispareunia y molestias genitales. Al examen físico, tiene la mucosa genital seca y pálida, sin leucorrea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tricomoniasis
- b) Candidiasis
- c) Vaginosis
- d) Atrofia genital
- e) Infección por clamidia

17) Una paciente de 14 años presenta disminución de la visión del izquierdo, de dos días de evolución. Su agudeza visual es 20/200 en el ojo izquierdo y 20/20 en el derecho. Tiene antecedente de hemiparesia braquial. Al fondo de ojo se observa papilitis izquierda. Su resonancia magnética nuclear muestra lesiones desmielinizantes cerebrales. El diagnóstico más probable es:

- a) Desprendimiento de retina
- b) Neuritis óptica
- c) Neuropatía óptica isquémica
- d) Degeneración macular
- e) Hipertensión endocraneana

18) Un paciente de 23 años, con retraso mental severo, en tratamiento con clorpromacina, sube la dosis de este medicamento de 100 a 300 mg al día, evolucionando con agitación psicomotora, confusión, boca seca, palpitaciones y malestar general. Su examen físico muestra FC: 115x', PA: 130/90 mmHg, pupilas con midriasis. El diagnóstico más probable es un síndrome:

- a) Anticolinérgico
- b) Adrenérgico
- c) Serotoninérgico
- d) Colinérgico
- e) Neuroléptico maligno

19) Un recién nacido presenta marcada dificultad respiratoria. Al examen física tiene abolición del murmullo pulmonar izquierdo y se auscultan los ruidos cardíacos desplazados, en el lado derecho. Su abdomen está excavado. La conducta inicial es:

- a) Cirugía de urgencia
- b) Realizar intubación orotraqueal
- c) Realizar toracostomía de urgencia
- d) Administrar prostaglandinas y oxígeno al 100%
- e) Ventilación a presión positiva por mascarilla

20) ¿Cuál es el examen de elección para el enfrentamiento inicial de un paciente de 22 años, en su primer cuadro de cólico renal, con microhematuria?

- a) Pielografía de eliminación
- b) UroTAC
- c) PieloTAC
- d) Ecografía renal y vesical
- e) Radiografía simple

21) Un paciente de 62 años presenta malestar general marcado, desde hace 20 minutos. Al examen físico está sudoroso, tiene FC: 33x', PA: 120/50 mmHg. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a continuación:



El diagnóstico más probable es:

- a) Bloqueo auriculoventricular de primer grado
- b) Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo I
- c) Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo II
- d) Bloqueo auriculoventricular de tercer grado
- e) Enfermedad del nodo sinusal

22) Una paciente de 27 años presenta amenorrea de 8 semanas, por lo que se realiza un test de embarazo, que resulta positivo. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra un embrión de 3 mm de diámetro, sin latidos cardiotetales. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar HCG seriadas
- b) Observar evolución espontánea
- c) Realizar evacuación uterina
- d) Controlar nueva ecografía en 7 días
- e) Administrar metotrexato

23) Un lactante de 10 meses de edad presenta eritema en la cara, que al día siguiente se generaliza. Al examen físico tiene un exantema rosado macular tenue, asociado a adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores. El diagnóstico más probable es:

- a) Eritema infeccioso
- b) Rubéola
- c) Exantema por citomegalovirus
- d) Sarampión
- e) Exantema súbito

24) Un paciente de 81 años, con antecedente de diabetes, en tratamiento con metformina 850 al día, se realiza exámenes de control, entre los que destaca una hemoglobina A1c de 7,5%. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener el tratamiento
- b) Agregar glibenclamida
- c) Subir la dosis de metformina
- d) Agregar insulina
- e) Agregar sitagliptina

25) Una paciente de 34 años, con antecedente de by pass gástrico hace 2 años, por obesidad mórbida, consulta por astenia, disnea y marcada fatigabilidad y debilidad de extremidades inferiores. Al examen físico tiene paresia M4 de ambas extremidades inferiores, con disminución de la sensibilidad distal e hiporreflexia. Se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 7,0 g/dl, hematocrito: 20%, glóbulos blancos: 3.100 por mm³ y plaquetas: 93.000 por mm³. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Desnutrición proteica
- b) Déficit de zinc
- c) Déficit de fosfatos
- d) Déficit de niacina
- e) Déficit de cianocobalamina

26) Un niño presenta aparición de lesiones eritematosas en las extremidades inferiores, hace 7 días, las que se muestran más abajo, a lo que se ha agregado edema de ambos tobillos.



¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para identificar una complicación frecuente de esta patología?

- a) Creatininemia
- b) Coronariografía
- c) Recuento de plaquetas
- d) Radiografía de pelvis
- e) Velocidad de eritrosedimentación

27) Una paciente de 35 años, presenta dolor en el hipocondrio izquierdo, asociado a meteorismo, por lo que se realiza una ecografía abdominal, que visualiza un pólipo en el fondo vesicular, de 4 mm de diámetro, homogéneo y se observa la vía biliar de 5 mm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Control ecográfico en 6 meses
- b) Solicitar una TAC de abdomen y pelvis
- c) Solicitar una resonancia magnética nuclear abdominal
- d) Realizar biopsia del pólipo
- e) Realizar colecistectomía laparoscópica

28) Una paciente de 14 años presenta caída al suelo, con inconsciencia de 30 segundos, recuperándose luego por completo. ¿Cuál de los siguientes antecedentes orientan a una causa cardiogénica del cuadro?

- a) Ausencia de episodios anteriores
- b) Relación con la micción
- c) Relación con el ejercicio
- d) Relación con la tos
- e) Ocurrencia al incorporarse desde la posición acostada

29) Un paciente de 40 años, oficinista, estuvo moviendo muebles durante 2 días, evolucionando luego con intenso dolor lumbar, que le impide realizar sus actividades. Al examen físico se aprecia muy adolorido, con dificultades para subirse a la camilla y para caminar, tiene IMC de 28 y se observa una contractura muscular a nivel lumbar, con dolor ante todos los movimientos de la columna lumbar, sin signos de irritación nerviosa. Además de administrar analgésicos, la indicación más adecuada es:

- a) Resonancia magnética nuclear
- b) Radiografía de columna lumbosacra
- c) Kinesioterapia motora por 10 días
- d) Reposo en cama por 5 días
- e) Reposo laboral por 3 días

30) Una paciente de 24 años, cursando un embarazo de 8 semanas, tiene antecedente de haber sufrido una trombosis venosa profunda, hace 5 años, en relación al uso de anticonceptivos orales. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?

- a) Iniciar antiagregantes orales
- b) Iniciar anticoagulación oral
- c) Realizar estudio de trombofilia
- d) Iniciar heparina de bajo peso molecular
- e) Solicitar ecografía Doppler de extremidades inferiores

31) ¿Cuál de las siguientes medidas de asociación es más adecuada para establecer cuántas veces aumentan los casos de asma en la población fumadora, en comparación a la población no fumadora?

- a) Riesgo relativo
- b) Riesgo atribuible
- c) Razón de prevalencias
- d) Tasa de incidencia
- e) Riesgo atribuible porcentual

32) Un paciente de 35 años consulta por cefalea y debilidad muscular de algunos meses de evolución. Al examen físico presenta FC: 70x', PA: 160/110 mmHg, sin otros hallazgos. Se solicitan exámenes que muestran creatininemia de 0,9 mg/dl, sodio: 138 mEq/l, potasio: 3,0 mEq/l y cloro: 98 mEq/l. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio en este paciente?

- a) Doppler de arterias renales
- b) Holter de presión arterial
- c) Determinación de metanefrinas urinarias
- d) Relación aldosterona / actividad de renina plasmática
- e) Cortisol libre urinario de 24 horas

33) Una mujer de 24 años, primípara, en trabajo de parto, con dilatación completa, membranas rotas y buena dinámica. Cuenta con episiotomía mediolateral. Se produce desprendimiento de la cabeza fetal, sin embargo, el resto del cuerpo no progresa, luego de 5 minutos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Ampliar la episiotomía
- b) Realizar tracción continua por 5 minutos
- c) Realizar flexión de las caderas de la madre y realizar compresión suprapúbica
- d) Girar el hombro posterior, en el sentido de las agujas del reloj
- e) Poner a la madre en posición genupectoral y realizar suave tracción de la cabeza fetal

34) Un paciente de 22 años es traído por sus familiares, dado que anda muy irritable y ha iniciado una serie de proyectos de negocio, en áreas que no maneja bien. Presenta aceleramiento del habla y hay noches en las que pasa sin dormir, a pesar de lo cual, al día siguiente no presenta sueño. En ocasiones, se ríe a carcajadas y, en otras, se emociona fácilmente al hablar de ciertos temas. Sus amigos lo describen como “patudo y sin filtro”. Tiene antecedente de haberse deprimido hace algunos años, en relación a una ruptura sentimental. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno esquizoafectivo
- b) Trastorno adaptativo mixto
- c) Trastorno bipolar
- d) Trastorno por déficit atencional
- e) Trastorno de personalidad en crisis

35) Un paciente de 82 años, hace 2 años sufrió un accidente vascular encefálico, sin secuelas. Hace 2 meses presenta un cuadro de labilidad emocional, desinhibición social y dificultades para realizar algunas de sus actividades habituales. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión
- b) Enfermedad de Alzheimer
- c) Demencia vascular
- d) Demencia por cuerpos de Lewy
- e) Hidrocéfalo normotensivo

36) Un paciente de 56 años, con antecedente de enfermedad de Cröhn, desde los 26 años, sin tratamiento, desde hace 4 meses, presenta un cuadro de dolor abdominal y vómitos, que han ido en aumento. Sus vómitos son de tipo alimentario y al examen físico tiene PA: 110/70 mmHg, FC: 90 x', T°: 37°C, al examen abdominal se observa abdomen distendido, con auscultación de gorgoritos y ruidos hidroaéreos intensos. Se solicita radiografía, que se muestra a continuación:



El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Cröhn activa
- b) Apendicitis aguda
- c) Perforación intestinal
- d) Vólvulo de sigmoides
- e) Obstrucción intestinal

37) Un niño de 5 años, presenta fiebre baja, hasta 37,5°C y eritema malar. Dos días después se agrega un exantema eritematoso macular en el tronco y extremidades, durando el cuadro un total de 10 días. El agente más probable es:

- a) Streptococcus pyogenes
- b) Parvovirus B19
- c) Virus de Epstein Barr
- d) Virus herpes humano número 6
- e) Virus rubéola

38) Una paciente de 56 años, con antecedente de haber vivido en Brasil, hasta hace 6 meses, consulta por disfagia lórica y progresiva, asociada a baja de peso de 6 kilogramos. Su examen físico no tiene alteraciones. Tiene antecedente de pirosis y regurgitación de larga data.

- a) Cáncer de esófago
- b) Estenosis péptica
- c) Esofagitis eosinofílica
- d) Acalasia esofágica
- e) Cáncer gástrico

39) Un recién nacido presenta, a los pocos minutos de nacer, cianosis generalizada, con saturación de 65%. En su examen físico, se ausculta un soplo sistólico eyectivo II/VI paraesternal. Su radiografía de tórax muestra campos pulmonares sin alteraciones, hilos de tamaño normal, recesos costodiafragmáticos libres y mediastino delgado ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Canal auriculoventricular completo
- b) Coartación aórtica
- c) Comunicación interventricular grande
- d) Transposición de grandes arterias
- e) Cardiopatía hipertrófica

40) Un niño de 6 años consulta por dificultades para ver. Al examen físico destaca agudeza visual de 20/60, que cambia a 20/30, al mirar por un agujero estenopeico. La madre refiere que siempre se restriega los ojos. El diagnóstico más probable es:

- a) Blefaritis
- b) Conjuntivitis viral
- c) Ametropía
- d) Conjuntivitis bacteriana crónica
- e) Glaucoma congénito

41) Un niño de edad presenta un cuadro de agitación, alternado con obnubilación, asociado a vómitos, sialorrea, diarrea, dolor abdominal, taquicardia, tos, temblor y sudoración. Se sospecha que haya ingerido algún tóxico. ¿Cuál es la conducta inicial?

- a) Administrar antieméticos
- b) Administrar omeprazol
- c) Administrar solución glucosada al 10%
- d) Administrar N-acetil.cisteína
- e) Administrar atropina

42) Una niña de 8 años, desde hace 6 meses presenta halitosis y odinofagia leve. Al examen físico se observan las amígdalas rosadas, con surcos profundos y en la amígdala derecha se observa secreción blanquecina, de aspecto caseoso, de 5 mm de diámetro. El diagnóstico más probable es:

- a) Mononucleosis infecciosa
- b) Absceso peritonsilar
- c) Amigdalitis bacteriana
- d) Linfoma amigdalino
- e) Tonsilolitiasis

43) Un niño de 8 años presenta, desde hace dos semanas de odinofagia, rinorrea y tos, a lo que se le ha agregado disnea progresiva y fiebre hasta 38,5°C. Hace dos días se agrega un exantema eritematoso polimorfo. Al examen físico destacan crepitaciones y sibilancias bilaterales, difusas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Amoxicilina
- b) Amoxicilina más ácido clavulánico
- c) Claritromicina
- d) Oseltamivir
- e) Aciclovir

44) ¿Por qué la meningococcemia es una enfermedad de notificación inmediata?

- a) Para aislar a los contactos
- b) Para vacunar a la familia
- c) Para identificar y manejar a los contactos
- d) Para detectar casos secundarios
- e) Por la gravedad de la enfermedad

45) Una paciente de 58 años, multípara de cuatro, presenta sensación de peso vaginal, asociada a escapes de orina, al inicio del deseo miccional. Al examen físico presenta prolapso genital. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar oxibutinina oral
- b) Realizar prueba Q-TIP
- c) Realizar pelvic organ prolapse quantification (POP-Q)
- d) Solicitar resonancia magnética pelviana
- e) Realizar histerectomía

46) Un paciente de 35 años consulta por otalgia izquierda de 3 días de evolución, asociada a otorrea ipsilateral. El dolor aumenta al traccionar el pabellón auricular. A la otoscopia se observa el conducto auditivo externo edematoso, con escasa secreción y tímpano normal. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

- a) Amoxicilina oral
- b) Ciprofloxacino tópico
- c) Amoxicilina más ácido clavulánico oral
- d) Neomicina tópica
- e) Antiinflamatorios orales

47) Un niño de 5 años, al que le molestan los ruidos fuertes, presenta vocabulario muy escaso. Caminó a los 24 meses y dijo su primera palabra a los 36 meses. No pareciera tener interés en relacionarse con los demás niños de su edad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno por déficit atencional
- b) Trastorno generalizado del desarrollo
- c) Parálisis cerebral
- d) Distrofia muscular
- e) Trastorno del lenguaje

48) Un paciente de 22 años, con antecedente de una amigdalitis bacteriana, hace 2 semanas, con tratamiento antibiótico incompleto, presenta un cuadro de cefalea y orinas espumosas, asociado a edema de extremidades inferiores. Al examen físico, tiene PA: 180/110 mmHg, FC: 62 lpm. Se solicitan exámenes, que muestran creatinina: 2,0 mg/dl, BUN: 46 mg/dl, sedimento de orina con abundantes glóbulos rojos, con 80% de dismorfia, ANA (-) y proteinuria de 900 mg/24 horas; C3 y C4 bajos. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a) Diuréticos
- b) Antiinflamatorios
- c) Antibióticos
- d) Inmunosupresores
- e) Corticoides

49) Una paciente de 43 años presenta ánimo bajo, desde hace 3 meses, asociado a llanto y a baja de peso de 8 kilogramos, desde ese entonces. Refiere que ya no disfruta de las cosas de la vida. Hace 2 semanas presenta alucinaciones auditivas, que ella identifica como una voz masculina que emite comentarios negativos sobre su situación. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno bipolar
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Depresión con síntomas psicóticos
- d) Trastorno esquizoafectivo
- e) Trastorno esquizotípico de la personalidad

50) Un paciente de 35 años, desde hace un año, presenta debilidad muscular, disminución de la libido e impotencia sexual progresiva. Se realizan exámenes, que muestran prolactina normal, niveles de LH: 1,6 UI/L (valor normal: 1,8 a 8,6 UI/L) y de testosterona: 160 ng/dl (valor normal: 270 a 1.070 ng/dl). ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

- a) Ecografía testicular
- b) Niveles plasmáticos de estradiol
- c) Niveles de FSH
- d) Solicitar niveles de testosterona libre
- e) Resonancia magnética de hipófisis

51) Una paciente de 67 años, hipertensa, en tratamiento con losartán 50 mg, hidroclorotiazida 25 mg, amlodipino 5 mg, carvedilol 12,5 mg. Presenta edema de las extremidades inferiores, que ha ido en aumento. En su examen físico tiene FC: 57x' regular, con PA: 130/90 mmHg, RR2T, examen pulmonar sin alteraciones y examen abdominal con hígado palpable 1 cm bajo el reborde costal y extremidades inferiores con edema bimalleolar con signo de la fóvea. La conducta más adecuada es:

- a) Reforzar la dieta hiposódica e indicar reposo con las extremidades en alto
- b) Suspender el amlodipino
- c) Subir la dosis del diurético
- d) Suspender el losartán y agregar doxazosina
- e) Solicitar ecodoppler de extremidades inferiores

52) Un paciente de 34 años, tienen antecedente de úlceras orales a repetición y artralgias. Además, presentó una úlcera genital hace algunas semanas. Consulta por dolor en el ojo derecho, asociado a visión borrosa, de dos días de evolución. Al examen físico, se aprecia marcado enrojecimiento del ojo derecho, con agudeza visual 20/100. El diagnóstico más probable es:

- a) Úlcera corneal
- b) Trombosis de la vena central de la retina
- c) Conjuntivitis viral
- d) Uveítis
- e) Queratitis aguda

53) Un lactante de 3 meses, diagnosticado de hipotiroidismo congénito, en tratamiento con levotiroxina 25 mg/día. Se solicita TSH que resulta 0,09 UI/L (VN: 0,7 a 5,7) y T4 libre: 2,18 ng/dl (VN: 0,9 a 2,1). La conducta más adecuada es:

- a) Suspender la levotiroxina
- b) Subir la dosis de levotiroxina
- c) Repetir la TSH en 6 semanas
- d) Disminuir la dosis de levotiroxina
- e) Solicitar cintigrafía tiroidea

54) Una paciente de 34 años, cursando su primer embarazo, gemelar, bicorial biamniótico, de 26 semanas de edad gestacional. Se controla con ecografía obstétrica, que visualiza un gemelo muerto, sin compromiso hemodinámico del gemelo sobreviviente. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar extracción del feto muerto
- b) Realizar controles periódicos con dímero D
- c) Interrumpir el embarazo
- d) Realizar cesárea a las 37 semanas
- e) Realizar controles periódicos con pruebas de coagulación

55) Un recién nacido de 28 días, presenta, desde hace 7 días, deposiciones frecuentes, semiformadas, con mucosidad y algunas estrías de sangre. Ha subido bien de peso, está con alimentación mixta y su examen físico no tiene alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Intolerancia a la lactosa
- b) Alergia a la proteína de la leche de vaca
- c) Infección por rotavirus
- d) Sangre deglutida del pezón materno
- e) Fisura anal

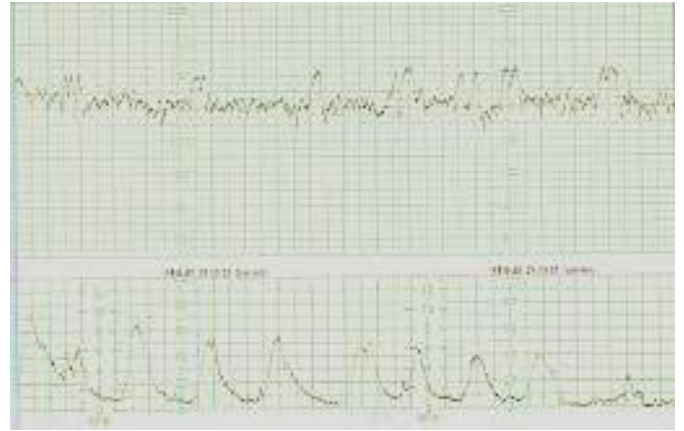
56) Un paciente de 75 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, sin tratamiento, consulta por edema de las extremidades inferiores y malestar. Al examen físico tiene PA: 150/100 mmHg, FC: 70x', edema marcado en ambas extremidades inferiores, con signo de la fóvea, hígado palpable, examen cardíaco normal y murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos basales. En sus exámenes destaca creatinina: 2,2 mg/dl, 5 mg/dl, Na+: 136 mEq/l, K+: 5,3 mEq/l y Cl-: 95 mEq/l. ¿Qué diurético es de elección para el manejo del edema en este paciente?

- a) Clortalidona
- b) Hidroclorotiazida
- c) Furosemida
- d) Indapamida
- e) Espironolactona

57) Un paciente de 22 años, que desde la infancia tiene infecciones respiratorias a repetición, que requerían uso de antibiótico. Al examen físico, es mesomorfo, con FC: 72x', PA: 120/80 mmHg, su examen físico presenta crepitaciones y estertores bilateral. Se solicita radiografía de tórax que muestra múltiples imágenes de dilataciones bronquiales bilaterales, compatibles con bronquiectasias. ¿Cuál es el examen para proseguir el estudio?

- a) Broncoscopia con biopsia bronquial
- b) Prueba de provocación bronquial con metacolina
- c) Espirometría
- d) Test del sudor
- e) Baciloscopías de expectoración

58) Una paciente de 31 años, en trabajo de parto de término, en fase activa, con progresión de 2 a 7 cm, en dos horas tiene dinámica de 3 contracciones en 10 minutos y membranas rotas. Se realiza registro cardíaco fetal, que se muestra a continuación:



¿Cuál es el diagnóstico más probable del estado fetal?

- a) Registro tipo I
- b) Registro tipo II
- c) Registro tipo III
- d) Registro reactivo
- e) Variabilidad disminuida

59) Una paciente de 70 años consulta por dolor tipo urente en las extremidades inferiores, asociado a parestesias, descritas como “hormigueos” en los pies. Al examen físico tiene disminución de la sensibilidad en calcetín, con paresia a la extensión de los ortejos y disminución de ambos reflejos aquilianos. En cambio, los reflejos rotulianos se encuentran conservados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Radiculopatía S1 bilateral
- b) Síndrome de cauda equina
- c) Síndrome del cono medular
- d) Síndrome de Guillain Barré
- e) Polineuropatía

60) ¿Cuál de las siguientes características del Elisa permite detectar a los pacientes con infección por el VIH, en la población asintomática?

- a) Alta sensibilidad
- b) Baja especificidad
- c) Alta especificidad
- d) Alto valor predictivo positivo
- e) Alto valor predictivo negativo

61) Un hombre de 34 años consulta por disuria, asociada a secreción uretral purulenta, de un día de evolución. Refiere haber tenido relaciones sexuales sin protección hace una semana. Se realiza tinción de Gram de la secreción uretral, observándose abundantes cocáceas Gram negativas intra y extracelulares. El agente etiológico más probable es:

- a) *Neisseria gonorrhoeae*
- b) *Treponema pallidum*
- c) *Chlamydia trachomatis*
- d) *Mycoplasma genitalium*
- e) *Streptococcus pyogenes*

62) Una mujer de 53 años, desde hace 3 meses presenta metrorragia intermitente, que ha aumentado. Su FUR fue a los 48 años y se realiza una ecografía transvaginal que muestra un mioma submucoso de 24 mm, otro subseroso de 52 mm, además, se visualiza su endometrio de 17 mm de grosor. La indicación más adecuada es:

- a) Histerectomía
- b) Estrógenos más progestágenos orales
- c) Miomectomía
- d) Biopsia de endometrio
- e) Progestágenos orales

63) Un paciente de 62 años, fumador de 10 paquetes año, consulta por disnea, asociada a tos y expectoración mucosa. Los síntomas aumentan especialmente cuando presenta infecciones respiratorias. En su examen físico se auscultan sibilancias bilaterales y espiración prolongada.

Se solicita una espirometría que muestra:

	Basal	Postbroncodilatador
CVF	5.810cc 98%	5.870cc 99%
VEF1	3.835cc 70%	4.696cc 91%
VEF1/CVF	66%	80%

Su radiografía de tórax se muestra a continuación:



El diagnóstico más probable es:

- a) Asma bronquial
- b) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- c) Bronquiectasias
- d) Bronquitis crónica
- e) Enfermedad pulmonar intersticial difusa

64) Un paciente de 81 años presenta dolor muy intenso den la rodilla derecha, con EVA 8/10, que le impide caminar. En su examen físico, se aprecia eritema y aumento de volumen de la rodilla. Se solicita radiografía de rodilla, que se muestra más abajo. Además, se realiza punción articular, que da salida a un líquido sinovial, con 160.000 glóbulos blancos por mm³, sin visualización de bacterias y con presencia de cristales con elongación positiva débil.



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Artritis séptica
- b) Artritis por cristales de pirofosfato de calcio
- c) Artritis por cristales de hidroxapatita de calcio
- d) Artritis por oxalato de calcio
- e) Gota

65) Un niño de 3 años, con antecedente de una convulsión febril a los 10 meses de edad, autolimitada, presenta fiebre, de 3 días de evolución, asociada a convulsión en dos oportunidades y desorientación. Se realiza punción lumbar, que da salida a líquido cefalorraquídeo, con glucosa 76 mg/dl (glicemia: 96 mg/dl), 210 células por mm³, con 85% de mononucleares, con 70 glóbulos rojos por mm³, 80% crenados y proteínas de 73 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Meningitis bacteriana
- b) Epilepsia
- c) Meningitis por enterovirus
- d) Encefalitis herpética
- e) Hemorragia subaracnoidea

66) Una paciente presenta múltiples episodios de 5 minutos de duración, recurrentes, en los que presenta mucha angustia, llanto, sensación de ahogo, parestesias en las cuatro extremidades y marcado miedo a sufrir un infarto al corazón. Ya no sale de la casa por miedo a presentar uno de esos episodios en la calle. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de pánico
- b) Agorafobia
- c) Trastorno de angustia generalizada
- d) Trastorno de ansiedad social
- e) Crisis de pánico

67) Un niño de 9 meses debe vacunarse por primera vez contra la influenza. Tiene antecedente de haber desarrollado un rash eritematoso en las dos oportunidades en las que se le dio a probar el huevo. ¿Cuál es la conducta más adecuada para su vacunación?

- a) Vacunar, de acuerdo al programa, sin cambios
- b) Prohibir permanentemente la vacunación contra la influenza
- c) Esperar la reacción ante la vacuna trivírica y decidir según aquello
- d) Postergar la vacunación hasta que cumpla 24 meses
- e) Realizar test cutáneo de alergia y decidir según resultado

68) Una paciente de 54 años presenta cambio en el hábito intestinal, asociada a distensión abdominal. Se realiza una ecografía abdominal, que muestra un pólipo de 5 mm en la vesícula biliar, de aspecto homogéneo y delimitado. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar dieta baja en grasas
- b) Realizar colecistectomía
- c) Solicitar PCR ultrasensible
- d) Realizar TAC de abdomen
- e) Realizar colonoscopia

69) ¿A qué tipo de medidas corresponde la instalación de las salas IRA (Infecciones Respiratorias Agudas) y salas ERA (Enfermedades Respiratorias del Adulto), durante las campañas de invierno, por parte del Ministerio de Salud?

- a) Prevención primaria
- b) Prevención secundaria
- c) Prevención terciaria
- d) Promoción de la salud
- e) Prevención específica

70) Un recién nacido de 28 semanas, comienza con decaimiento y vómitos, desde hace una semana, con tendencia a la deshidratación. Al examen físico, está hipotenso, taquicárdico, con genitales masculinos, sin otros hallazgos. Sus electrolitos muestran Na⁺: 129 mEq/L, K⁺: 6,5 mEq/L, Cl⁻: 89 mEq/L. Además, de la solución fisiológica, ¿qué medicamento se debe administrar en el manejo inicial de este paciente?

- a) Ondasentrón
- b) Omeprazol
- c) Calcio
- d) Cefotaximo
- e) Hidrocortisona

71) Una paciente de 37 años presenta escapes de orina, en grandes cantidades, precedidos por deseos incontrolables de orinar. Su examen físico no aporta mayor información. Su urocultivo es negativo y su desimento de orina no presenta alteraciones. Se solicita una cistomanometría que muestra contracciones no inhibidas del detrusor, que aparecen entre los 80 y 100 cc de llenado vesical. El tratamiento inicial más adecuado es:

- a) Anticolinérgicos
- b) Bloqueadores alfa 1 adrenérgicos
- c) Cirugía
- d) Kinesioterapia pélvica
- e) Reducción vesical

72) Un paciente de 39 años, trabajador de la construcción, con IMC de 30, psoriático, consulta por dolor en la zona glútea profunda, de predominio nocturno, muy intenso y que va desapareciendo en la mañana, a medida que realiza sus actividades. El dolor inició hace 3 meses y ha aumentado. Hace 2 meses presentó una uveítis derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Radiculopatía S1
- b) Espondiloartritis
- c) Espondilodiscitis
- d) Hernia del núcleo pulposo con compresión del plexo lumbar
- e) Raquiestenosis

73) Un paciente de 36 años presenta la idea de que puede ser pedófilo. Aquello lo angustia mucho y le aterra la idea de acercarse a los niños. Por ello reza y evita situaciones en las que estará en contacto con niños. Su diagnóstico es:

- a) Trastorno delirante
- b) Parafilia
- c) Trastorno obsesivo compulsivo
- d) Trastorno de la inclinación sexual
- e) Trastorno de ansiedad generalizada

74) Un paciente de 18 años consulta por dolor lumbar izquierdo, de larga evolución. Al examen físico tiene una masa en el flanco izquierdo, por lo que se solicita una ecografía abdominal, que muestra una hidronefrosis izquierda, con adelgazamiento de la corteza renal, sin dilatación uretral. Su creatinina plasmática es 0,9 mg/dl y su sedimento de orina no presenta alteraciones. La cintigrafía renal muestra captación de 90% a derecha y 10% a izquierda. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar pieloplastía izquierda
- b) Realizar nefrostomía percutánea
- c) Realizar nefrectomía izquierda
- d) Instalar sonda Foley
- e) Solicitar pielotAC

75) Una paciente de 35 años, con antecedente de bypass gástrico hace un año, presenta crisis de mareos, palpitaciones, malestar general y diarrea, que aparecen después de comer. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipoglicemias reactivas
- b) Síndrome de dumping
- c) Hernia del espacio de Petersen
- d) Estenosis de la anastomosis
- e) Déficit de vitamina B12

76) Una paciente de 30 años, con antecedente de enfermedad de Marfán, puérpera hace un mes, consulta por dolor torácico precordial, opresivo, irradiado al dorso, EVA 8/10. Al examen físico tiene. Su electrocardiograma muestra taquicardia sinusal, sin otras alteraciones. El examen de elección para iniciar el enfrentamiento de esta paciente es:

- a) Coronariografía
- b) Ecocardiograma transtorácico
- c) Dímero D
- d) AngioTAC de tórax
- e) Test de esfuerzo

77) Una paciente de 25 años, con antecedente de un quiste mamario de dos centímetros, en la mama derecha, diagnosticado hace 2 años. Consulta ahora por dolor y aumento de volumen, en relación a la mama derecha. Al examen físico tiene fiebre de 38,6°C, más una zona aumentada de volumen, con eritema y aumento de la temperatura, en la mama derecha, mayor en la zona superoexterna. Se solicita una ecografía mamaria, que visualiza signos inflamatorios de las partes blandas, más la lesión quística de 5 cm de diámetro, con contenido irregular. La conducta más adecuada es:

- a) Punción del quiste
- b) Solicitar resonancia magnética de mama
- c) Drenaje quirúrgico
- d) Realizar biopsia con aguja gruesa
- e) Control mamográfico

78) Una niña de 15 años presenta hipermenorrea y menometrorragia de larga data. Se solicita un hemograma, que muestra hemoglobina: 9g/dl, hematocrito: 27%, blancos: 6.000 por mm³ y plaquetas: 240.000 por mm³. Su ecografía ginecológica es normal. La conducta más adecuada para proseguir el estudio es:

- a) Resonancia magnética de pelvis
- b) Prueba de progesterona
- c) Biopsia de endometrio
- d) Estudio de trombofilias
- e) Estudio de hemostasia

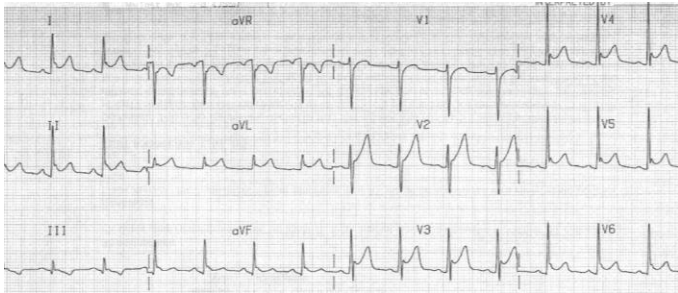
79) Un paciente de 80 años consulta por rinorrea bilateral, de tres meses de evolución, muy molesta, asociada a congestión nasal, que es más intensa en las mañanas y aumenta con los cambios de temperatura. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer nasal
- b) Pólipos nasales
- c) Sinusitis bacteriana crónica
- d) Rinitis vasomotora
- e) Rinitis alérgica

80) Una paciente de 54 años, con antecedente de jaqueca, que trata profilácticamente con topiramato. Refiere estar con más estrés del habitual. Hace dos horas comienza con cefalea intensa, de localización periocular derecha, asociada a náuseas y vómitos. Al examen físico se aprecia el ojo izquierdo enrojecido, con la pupila fija, en semimidriasis. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Manitol endovenoso
- b) Clorpromazina endovenosa
- c) Ketorolaco endovenoso
- d) Oxígeno al 100% más eletriptán subcutáneo
- e) Carbamazepina oral

81) Un hombre de 31 años, deportista, consulta por dolor precordial de 2 días de evolución, EVA 8/10, asociado a leve sensación de ahogo, que aparece especialmente al recostarse. Se solicita un electrocardiograma, que se muestra a continuación:



El diagnóstico más probable es:

- a) Infarto agudo al miocardio
- b) Pericarditis aguda
- c) Neumotórax espontáneo
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Costocondritis del deportista

82) Un paciente de 86 años, con antecedente de un accidente vascular encefálico, hace un año, seculado con un síndrome de inmovilidad y marcada dependencia, presenta una lesión en la zona sacra. Al examen físico, presenta eritema en la zona sacra, sin solución de continuidad de la piel. El tratamiento más adecuado es:

- a) Aseo con hidrogel
- b) Colchón antiescaras
- c) Antibióticos
- d) Resolución quirúrgica
- e) Cambios de posición frecuentes

83) Un niño de 4 años presenta disuria, asociada a molestias abdominales, sin fiebre. Su examen físico no tiene alteraciones. Se solicita sedimento de orina, que muestra 6 a 8 glóbulos blancos por campo y urocultivo, que muestra desarrollo de Escherichia coli multisensible, con 60.000 UFC por mm³. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Repetir el sedimento y urocultivo
- b) Iniciar cefadroxilo 50 mg/Kg/día, por 5 días
- c) Iniciar nitrofurantoína 5-7 mg/Kg/día, por 7 días
- d) Solicitar cintigrafía DSMA
- e) Solicitar ecografía abdominal

84) Un paciente de 83 años, calvo, con antecedente de múltiples queratosis actínicas en la cabeza, presenta una lesión en el cuero cabelludo, que notó hace 3 meses y que ha ido creciendo hasta alcanzar un diámetro de 2 x 3 cm. Se muestra a continuación:



El diagnóstico más probable es:

- a) Melanoma
- b) Impétigo
- c) Dermatitis de contacto
- d) Quemadura solar
- e) Carcinoma espinocelular

85) Un paciente de 38 años consulta por paresia facial bilateral, de una semana de evolución, mayor a izquierda. Además, presenta paresia del sexto nervio craneal izquierdo. Al examen físico tiene disminución generalizada de las fuerzas de las extremidades, con arreflexia e hipotonía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Polineuropatía
- b) Síndrome de Guillain Barré
- c) Miastenia gravis
- d) Esclerosis múltiple
- e) Infarto de troncoencéfalo

86) Una mujer de 26 años, sexualmente activa y alérgica a la penicilina, consulta por disuria y molestias genitales, de 4 días de evolución, asociada a leucorrea. Al examen físico, se observan signos inflamatorios en el cuello uterino, con escasa leucorrea. El cultivo de Thayer Martin es positivo y prueba de aminas, negativa. El tratamiento de elección es:

- a) Ciprofloxacino
- b) Ceftriaxona
- c) Azitromicina
- d) Doxiciclina
- e) Penicilina benzatina

87) Una paciente de 35 años, con antecedente de una histerectomía radical, por un cáncer de cuello uterino, hace dos años, consulta por bochornos frecuentes, asociado a sequedad genital y dispareunia, más insomnio, secundaria a los bochornos. En su examen físico tiene IMC: 28. Se solicitan exámenes, en los que destaca colesterol total: 221 mg/dl, colesterol HDL: 32 mg/dl y triglicéridos: 456 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Estrógeno más progestágeno oral
- b) Estrógeno solo vía oral
- c) Estrógeno en parches
- d) Venlafaxina oral
- e) Progestágenos tópicos

88) Un paciente de 50 años presenta cefalea, náuseas, mareos y epigastralgia, de dos años de evolución. Cuenta con múltiples exámenes que descartan causa orgánica, sin embargo, él insiste en exigir más estudios. No se identifica ánimo de obtener alguna ganancia. El diagnóstico más probable es un trastorno:

- a) Depresivo mayor
- b) Delirante
- c) Obsesivo compulsivo
- d) De somatización
- e) Facticio

89) Una paciente de 32 años consulta por amenorrea de 5 meses de evolución. Se realiza múltiples exámenes, entre los que destacan HCG: < 5 UI/L, FSH y LH < 5 UI/L, con pruebas tiroideas y prolactina dentro de rangos normales. Su prueba de progesterona es negativa y su prueba de estrógeno más progesterona es positiva. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome de ovario poliquístico
- b) Falla ovárica primaria
- c) Síndrome de Asherman
- d) Falla hipotalámica / hipofisiaria
- e) Disgenesia gonadal

90) Una paciente de 26 años consulta por dispepsia de varios meses de evolución. Al examen físico se observa ictericia de piel y escleras. Tiene antecedente de alteraciones en sus pruebas hepáticas, hace 2 años. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran bilirrubinemia total: 2,2 mg/dl, bilirrubina directa: 0,3 mg/dl, SGOT: 26 UI/L, SGPT: 23 UI/L, GGT: 46 UI/L, FA: 65 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Colangitis esclerosante primaria
- b) Síndrome de Gilbert
- c) Colestasia intrahepática
- d) Hepatitis en resolución
- e) Cirrosis biliar primaria



 **MedLaw**

Medlaw te optimiza
Contabilidad, planificación
societaria y tributaria

www.medlaw.cl Contacto: +56 2 32632291 / +56 9 3425 5314

This advertisement features a background image of hands working with a calculator and documents. The MedLaw logo is in the top left. The main headline 'Medlaw te optimiza' is in a blue box, followed by the services 'Contabilidad, planificación societaria y tributaria'. The contact information is at the bottom in a blue bar.

www.medlaw.cl



 **Medlaw te Defiende**
ASISTENCIA LEGAL
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA

CONTÁCTANOS:
 +56 9 3425 5314 / +56 2 3263 2291

This advertisement features a background image of two people shaking hands. The MedLaw logo is in the top left. The main headline 'Medlaw te Defiende' is in a blue box, followed by the services 'ASISTENCIA LEGAL' and 'SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA'. The contact information is at the bottom.

www.medlaw.cl



 **MedLaw**
WWW.MEDLAW.CL

**CENTRO DE
APOYO AL
MÉDICO
EXTRANJERO**

¡INSCRÍBETE GRATIS!

 +56 9 3425 5314 / 2 3263 2291

This advertisement features a background image of a smiling male doctor. The MedLaw logo and website are in the top left. The main headline 'CENTRO DE APOYO AL MÉDICO EXTRANJERO' is in a dark blue box, followed by '¡INSCRÍBETE GRATIS!' in a teal box. The contact information is at the bottom.

91) Un hombre de 57 años presenta epigastralgia, inapetencia y baja de peso, de 2 meses de evolución, a lo cual se agrega un episodio de melena, por el que consulta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cáncer gástrico
- b) Úlcera gastroduodenal
- c) Cáncer de esófago
- d) Linfoma gástrico, asociado a mucosa
- e) Gastritis erosiva

92) Un paciente de 65 años, diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina y enalapril, consulta por tos seca de 3 meses de evolución. Al examen físico tiene murmullo pulmonar conservado bilateral, sin presencia de otros ruidos. Su radiografía de tórax se muestra a continuación:



La conducta inicial más adecuada es:

- a) Suspender la metformina
- b) Iniciar salbutamol
- c) Iniciar codeína
- d) Suspender el enalapril
- e) Solicitar prueba de provocación bronquial

93) Un paciente de 67 años presenta hemiparesia derecha de dos horas de evolución, que inició de manera súbita y se asocia a dificultades para hablar. Al examen físico tiene hemiparesia faciobraquiocrural derecha y afasia. Su TAC de cerebro es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Anticoagular con heparina
- b) Administrar antiagregantes plaquetarios
- c) Solicitar resonancia magnética nuclear
- d) Realizar embolectomía
- e) Realizar trombólisis

94) Un hombre de 16 años presenta dolor testicular intenso, que inició hace 8 horas. Tiene EVA 8/10 y al examen testicular se constata testículo derecho muy doloroso, que no mejora con la suspensión testicular. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Antibióticos orales
- b) Doppler testicular
- c) Analgésicos orales
- d) Antibióticos endovenosos
- e) Exploración quirúrgica

95) Un paciente de 39 años, con antecedente de obesidad, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, que muestra una glicemia basal de 117 mg/dl y postcarga de 75 gramos de glucosa de 136 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Normal
- b) Diabetes mellitus 2
- c) Intolerancia a la glucosa oral
- d) Diabetes mellitus 1
- e) Prediabetes

96) Un recién nacido de 38 semanas, presenta hipotonía, dificultad a la succión y circunferencia craneana 26 cm. Al examen tiene ausencia del rojo pupilar bilateral y ambas pupilas se observan de aspecto blanquecino. Además, se ausculta un soplo sistólico eyectivo III/VI, paraesternal. ¿Cuál es el agente más probable?

- a) Virus rubéola
- b) Parvovirus B12
- c) Citomegalovirus
- d) *Toxoplasma gondii*
- e) Virus herpes simplex

97) Una paciente de 22 años, cursando un embarazo de 37 semanas, en trabajo de parto, presenta dilatación cervical de 5 cm, con buena dinámica uterina y presentación cefálica. Se produce rotura espontánea de las membranas, saliendo líquido amniótico hemático y apareciendo una bradicardia fetal mantenida. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar a evolución espontánea
- b) Realizar un tacto vaginal
- c) Administrar tocolíticos de urgencia
- d) Lateralizar y dar oxígeno a la madre
- e) Solicitar Doppler fetal

98) Una paciente de 30 años, con antecedente de hipotiroidismo, en tratamiento, consulta por diarrea de 3 meses de evolución, no disentérica, asociada a baja de peso y artralgias. Al examen físico destacan lesiones pruriginosas y vesiculares en el tronco y extremidades. El diagnóstico más probable es:

- a) Colitis ulcerosa
- b) Enfermedad celíaca
- c) Enfermedad de Cröhn
- d) Lupus
- e) Trastorno digestivo funcional

99) Una paciente de 47 años, cuya FUR fue hace 55 días, presenta metrorragia de 10 días de evolución, abundante. Se solicita hemograma, que muestra hematocrito: 7,4 g/dl, blancos: 7.000. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar legrado uterino
- b) Administrar progestágenos orales
- c) Administrar estrógenos orales
- d) Realizar histerectomía
- e) Administrar estrógenos endovenosos

100) Un paciente de 43 años, presenta un cuadro clínico de fiebre de 4 días de evolución, asociado a cefalea. Hoy se agrega desorientación y confusión, convulsionando en dos oportunidades antes de consultas. La TAC de cerebro muestra una zona hiperdensa en el lóbulo temporal izquierdo. Se realiza punción lumbar, con 130 células por mm³, 85% mononucleares, glucosa: 75 mg/dl (glicemia 90 mg/dl), proteínas 100 mg/dl, con Pandy (+), látex negativo y ausencia de bacterias en la tinción de Gram. Los cultivos están pendientes. El diagnóstico más probable es:

- a) Meningitis bacteriana aguda
- b) Meningitis tuberculosa
- c) Meningoencefalitis herpética
- d) Meningitis por enterovirus
- e) Meningitis por VIH

101) Un paciente de 20 años, con antecedente de soplo en su infancia, consulta por sensación de opresión precordial, que aparece al caminar, se asocia a disnea leve y que cede rápidamente con el reposo. Al examen físico tiene PA: 150/80 mmHg, FC: 63x', pulso débil, regular, de ascenso lento. El examen cardíaco muestra un soplo sistólico eyectivo, paraesternal, que se irradia al cuello. Su electrocardiograma muestra signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis mitral
- b) Estenosis aórtica
- c) Insuficiencia mitral
- d) Insuficiencia aórtica
- e) Miocardiopatía hipertrófica

102) Un paciente alcohólico, en situación de calle, con antecedente de una tuberculosis tratada hace 2 años, consulta por astenia de 3 meses de evolución, asociada a debilidad muscular, dolor abdominal y diarrea. Al examen físico tiene FC: 110x', PA: 90/60 mmHg y presenta hiperpigmentación en los pliegues y melanoplaquias. Entre sus exámenes destaca creatinina: 1,0 mg/dl, sodio: 131 mEq/L, potasio: 5,6 mEq/L, cloro: 94 mEq/L, hematocrito: 35% y blancos: 7.500 por mm³. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome paraneoplásico
- b) Cáncer de origen desconocido
- c) Enfermedad de Addison
- d) Daño hepático crónico
- e) Tuberculosis renal

103) Una paciente de 31 años, embarazada de 3 meses, presenta angustia y temor, que aparece al estar en presencia de aglomeraciones de personas, especialmente en la calle, sintiéndose atrapada y ahogada en esas situaciones. Refiere síntomas similares al ir al supermercado y al tener que cruzar puentes muy largos, por lo que evita exponerse a esto y ha salido menos de su casa. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a) Diazepam
- b) Citalopram
- c) Clorpromazina
- d) Risperidona
- e) Mirtazapina

104) Una paciente de 30 años presenta un cuadro de un mes de evolución de neuralgia de la primera rama del trigémino. Hace una semana se agrega disminución de la sensibilidad del muslo derecho, con dificultades para caminar. Como antecedente, refiere que hace un año tuvo un trastorno del equilibrio, que resolvió espontáneamente. El diagnóstico más probable es:

- a) Polineuropatía por déficit de vitamina B12
- b) Síndrome de Guillain Barré de presentación atípica
- c) Infarto talámico
- d) Esclerosis múltiple
- e) Neurinoma con compresión del troncoencéfalo

105) Un paciente con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica presenta un cuadro de 3 días de evolución, de fiebre hasta 38,9°C, asociada a malestar general, tos, expectoración mucopurulenta y aumento de la disnea. Al examen físico se observa con apremio respiratorio de reposo y se auscultan sibilancias difusas, más crepitaciones en la zona posterior del lóbulo inferior derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación.



¿Qué antibiótico es el más adecuado para el tratamiento de este paciente?

- a) Amoxicilina
- b) Claritromicina
- c) Clindamicina
- d) Cefotaximo
- e) Azitromicina

106) Una paciente de 76 años presenta, desde hace un mes tos, disnea y expectoración, que en ocasiones es hemoptoica. A lo anterior se agrega hematuria, orinas espumosas, edema de extremidades inferiores y malestar general. En sus exámenes destaca creatinina: 4,6 mg/dl, BUN: 89 mg/dl, K: 5,9 mEq/L, Na: 130 mEq/L, proteinuria: 1.600 mg/24 horas, ANA negativos y complemento normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Glomerulonefritis postestreptocócica
- b) Lupus eritematoso sistémico
- c) Tuberculosis miliar
- d) Vasculitis sistémica
- e) Púrpura trombocitopénico trombótico

107) Un niño de 8 años presenta odinofagia intensa, de dos días de evolución, con escasa congestión nasal. Al examen físico se observan amígdalas edematosas y aumentadas de volumen, con exudado blanquecino en los surcos, adenopatías cervicales dolorosas y fiebre: 39°C. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar amoxicilina
- b) Solicitar TAC de cuello
- c) Iniciar ceftriaxona
- d) Iniciar tratamiento sintomático
- e) Solicitar prueba rápida de detección de *Streptococcus pyogenes*

108) Un niño de 4 años presenta escaso vocabulario para su edad y confunde muchas palabras. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el estudio de este paciente?

- a) Evaluación fonoaudiológica
- b) Potenciales evocados auditivos
- c) Emisiones otoacústicas
- d) Audiometría
- e) Control en 6 meses

109) Una paciente de 30 años, con un hijo de 5 años con otra pareja, consulta por infertilidad de 3 años con su nueva pareja. Ella cuenta con estudio hormonal normal y él tiene un espermiograma sin alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cariograma
- b) Repetir el espermiograma
- c) Solicitar fragmentación de ADN espermático
- d) Realizar laparoscopia diagnóstica
- e) Realizar histerosalpingografía

110) ¿Cuál es el diseño de estudio más adecuado para estudiar enfermedades muy infrecuentes?

- a) Cohortes prospectivas
- b) Caso control
- c) De prevalencia
- d) Ensayo clínico
- e) Cohortes retrospectiva

111) Un paciente de 17 años, presenta aumento de volumen submentoniano, de 5 años de evolución. Hace 2 días aumenta de tamaño y se vuelve doloroso. Al examen físico, tiene aumento de volumen y eritema en la zona, con dolor importante a la palpación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Linfoma
- b) Adenitis submandibular
- c) Sialoadenitis bacteriana
- d) Quiste del conducto tirogloso infectado
- e) Sialolitiasis

112) Un paciente de 43 años consulta por un cuadro de podagra. Tiene antecedente de dos crisis similares en los últimos 6 meses. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Paracetamol
- b) Colchicina
- c) Probenecid
- d) Alopurinol
- e) Prednisona

113) Una paciente de 36 años, hipotiroidea y con antecedente de vitiligo fue diagnosticada de diabetes hace un año. Está en tratamiento con 2 gramos de metforminal al día y 20 mg de glibenclamida al día, más dieta. Su hemoglobina glicosilada es de 8,5% y su glicemia de ayuno resulta 196 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Diabetes mellitus 1 - LADA
- b) Diabetes mellitus Mody
- c) Diabetes mellitus secundaria
- d) Diabetes mellitus 2 con tendencia a la cetosis
- e) Diabetes mellitus controlada

114) Una lactante de 9 meses presenta dolor abdominal intenso, con llanto persistente y flexión de caderas. Presenta eliminación de deposiciones con abundante sangre. Se solicita radiografía abdominal, que resulta normal y ecografía abdominal, con imagen de “rosquilla”. ¿Cuál es la medida terapéutica más adecuada?

- a) Descompresión neumática
- b) Reducción manual quirúrgica abierta
- c) Ablación endoscópica
- d) Reducción laparoscópica
- e) Resección quirúrgica por laparotomía

115) Un paciente de 56 años, con antecedente de daño hepático crónico, por consumo de alcohol, consulta por obnubilación, asociado a dolor abdominal e ictericia. Al examen físico se observa quejumbroso y tiene desorientación temporoespacial, fiebre de 38,3°C, ascitis moderada, ictericia de piel y mucosas y asterixis. Se solicita un hemograma, que muestra leucocitos de 16.000, con recuento diferencial normal. Sus pruebas hepáticas muestran bilirrubina total: 5,2 mg/dl, albúmina: 2,8 g/dl, protrombinemia: 60%, GOT: 110 UI/L, GPT: 90 UI/L, GGT: 88 UI/L, FA: 120 UI/L.

Child-Pugh categoría C.

La conducta más adecuada en este paciente es:

- a) Solicitar amonemia
- b) Realizar laparoscopia exploradora
- c) Iniciar lactulosa oral
- d) Recuento de polimorfonucleares en líquido ascítico
- e) Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

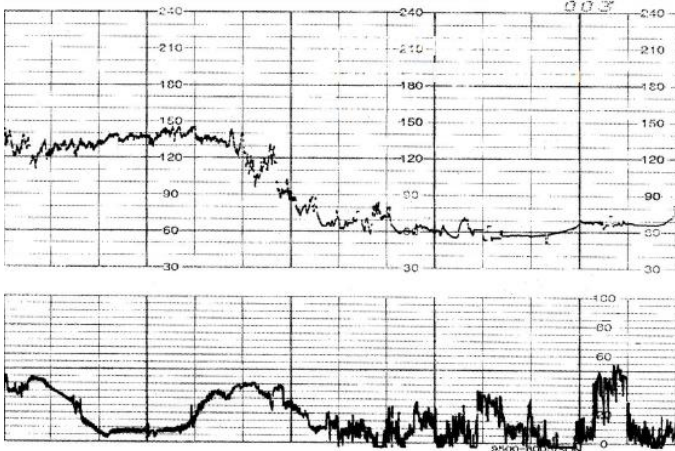
116) Un paciente de 68 años presenta tos de 4 meses de evolución, y disnea de esfuerzos. Al examen pulmonar tiene disminución del murmullo pulmonar a derecha, más matidez en la base derecha. Punción pleural con líquido claro, pH: 7,47, células: 70 por mm³, 80% mononucleares, ADA: 20 UI/L, LDH: 167 UI/L, colesterol: 119 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Insuficiencia cardíaca
- b) Tuberculosis pleural
- c) Empiema
- d) Cáncer bronquial
- e) Derrame secundario a artritis reumatoide

117) Un hombre de 80 años, diabético, consulta por dolor intenso en la zona costal derecha, que aumenta con la palpación y movimientos. Al examen físico tiene dolor epicrítico al palpar la zona. En sus exámenes destaca hemograma con hematocrito: 27%, plaquetas: 103.000 por mm³, blancos: 5.000 por mm³, VHS: 90 mmHg. Además, trae creatinemia: 2,1 mg/dl, calcio: 10,8 mg/dl, proteínas: 9,1 g/dl y albúmina plasmática: 3,0 g/dl. La ecografía abdominal muestra riñones de tamaño normal. ¿Cuál es el examen de elección para la confirmación diagnóstica?

- a) Beta2 microglobulina
- b) Resonancia magnética de columna
- c) Radiografía de parrilla costal
- d) Mielograma
- e) Biopsia renal

118) Una paciente de 33 años, cursando embarazo de 40 semanas, inicia trabajo de parto. Se realiza control del parto, que constata dilatación cervical completa y cabeza en espinas +2. El monitoreo electrónico fetal muestra lo siguiente:



La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea de urgencia
- b) Realizar fórceps
- c) Solicitar perfil biofísico
- d) Lateralizar a la madre y administrarle oxígeno
- e) Mantener una conducta expectante

119) ¿Cuál es la conducta más adecuada ante una paciente embarazada en el primer trimestre, que presenta una TSH de 4,5 UI/L?

- a) Iniciar propiltiouracilo
- b) Solicitar T4 libre
- c) Iniciar levotiroxina
- d) Solicitar una nueva TSH en un mes
- e) Solicitar cintigrafía tiroidea

120) Un paciente de 30 años, cuyo hermano está en tratamiento antituberculoso, en la fase bisemanal, presenta tos y expectoración mucopurulenta, asociada a fiebre de 38,7°C, desde hace 7 días. Se inició amoxicilina al inicio de los síntomas, con buena respuesta inicial, sin embargo, luego recurren los síntomas. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación:



La conducta más adecuada es;

- a) Agregar ácido clavulánico al tratamiento
- b) Solicitar TAC de tórax
- c) Solicitar PPD
- d) Iniciar tratamiento antituberculoso
- e) Realizar estudio de líquido pleural

121) Una mujer de 18 años presenta una placa eritematosa y levemente pruriginosa, de 5 cm, en la espalda, sin otros síntomas. Una semana después se agregan múltiples lesiones similares, de menor tamaño en todo el tronco. El diagnóstico más probable es:

- a) Tiña
- b) Lupus cutáneo subagudo
- c) Sífilis secundaria
- d) Pitiriasis versicolor
- e) Pitiriasis rosada

122) Un niño de 3 años, con un cuadro de fiebre alta, asociada a malestar general y odinofagia intensa. Se inició tratamiento con amoxicilina, pero a las 48 horas presenta un exantema, que se muestra más abajo. Al examen físico, se aprecia decaído, con adenopatías cervicales anteriores dolorosas y amígdalas edematosas y eritematosas, con exudado blanco en su superficie. El exantema se muestra a continuación:



El diagnóstico más probable es:

- a) Escarlatina
- b) Mononucleosis infecciosa
- c) Alergia a la penicilina
- d) Enfermedad de Kawasaki
- e) Sarampión

123) Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 37 semanas, tiene una estimación de peso fetal en el percentil 5 para la edad gestacional. Se realiza una ecografía obstétrica, que confirma feto con peso en percentil 5 para la edad e índice de líquido amniótico de 6. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar registro basal no estresante
- b) Inducir el parto
- c) Solicitar Doppler materno-fetal
- d) Realizar amnioinfusión
- e) Realizar cesárea

124) Un estudio determina que se deben tratar a 20 pacientes con una intervención, para evitar que uno fallezca. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

- a) De incidencia
- b) Casos y controles
- c) Cohortes anidada
- d) Ensayo clínico
- e) De prevalencia

125) Un paciente de 35 años sufre un traumatismo lumbar de alta energía, evolucionando con hematuria. Al examen físico está hemodinámicamente estable, con FC: 75x' y PA: 120/80 mmHg. ¿Cuál es el examen de elección para precisar el diagnóstico?

- a) PielotAC
- b) UroTAC
- c) Radiografía de abdomen simple
- d) Ecografía renal
- e) Pielografía de eliminación

126) Una paciente de 43 años presenta sequedad bucal, asociada a ardor y sensación de arenilla ocular y a artralgiás. Al examen físico tiene sequedad de piel y de mucosas, se observa aumento de volumen de ambas parótidas y se palpan adenopatías submandibulares de consistencia aumentada. Se solicitan exámenes, que muestra FR: 40 UI/nl, ANA positivos 1/16, ENA negativo, antiDNA negativo. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio diagnóstico?

- a) Punción parotídea
- b) Biopsia ganglionar
- c) Anticuerpos anti-CCP
- d) Biopsia de glándula salival accesoria
- e) Anticuerpos anti-Sm

127) Un paciente de 82 años, con múltiples patologías con tratamiento farmacológico, presenta TSH: 3,8 UI/L y hemoglobina glicosilada de 5,2%. ¿Qué fármaco debe suspender?

- a) Vitamina D
- b) Glibenclamida
- c) Enalapril
- d) Levotiroxina
- e) Calcio

128) ¿Cuál es la conducta más adecuada para una paciente de 22 años, primigesta, cursando un embarazo de 35 semanas, que sufre una rotura de membranas, sin trabajo de parto?

- a) Inducir el parto
- b) Administrar antibióticos terapéuticos
- c) Administrar corticoides
- d) Administrar tocolíticos
- e) Administrar sulfato de magnesio

129) Un paciente de 62 años, con antecedente de síndrome metabólico e hipertensión arterial mal controlada, consulta por ánimo depresivo marcado, asociado a baja de peso, anhedonia e insomnio de dos meses de evolución. El tratamiento de primera línea es

- a) Mirtazapina
- b) Escitalopram
- c) Venlafaxina
- d) Amitriptilina
- e) Imipramina

130) Una paciente de 25 años, con antecedente de sífilis tratada hace un año, cursando un embarazo de 8 semanas, se realiza un VDRL, que resulta positivo en dilución 1/16. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar FTA-ABS
- b) Controlar con VDRL seriado
- c) Solicitar RPR
- d) Administrar ceftriaxona
- e) Administrar penicilina benzatina

131) Un paciente de 24 años presenta un cuadro de cefalea y desorientación, asociado a malestar general e ictericia. Al examen físico tiene ictericia de piel y escleras, PA: 160/100 mmHg, se palpa edema de ambas extremidades inferiores. Se solicitan exámenes, entre los que destacan bilirrubina total: 12 mg/dl, LDH: 2.100 UI/L, creatinina: 3,5 mg/dl, hemoglobina: 7,0 g/dl, hematocrito: 22%, plaquetas: 50.000/mm³, blancos: 8.000/mm³, frotis con esquistocitos, poiquilocitos, anisocitosis y disminución de las plaquetas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Púrpura inmune trombocitopénica
- b) Síndrome de Evans
- c) Anemia hemolítica autoinmune
- d) Púrpura trombótico trombocitopénico
- e) Lupus eritematoso sistémico

132) Un paciente, con antecedente de leucemia mieloide crónica, en quimioterapia hace 2 semanas, presenta un cuadro de tos, con expectoración purulenta, con estrías de sangre, asociada a fiebre y malestar general. Se solicitan exámenes, entre los que destaca VHS: 90 mm/h, PCR: 22 mg/L. Se realiza TAC de tórax, que visualiza una tumoración densa, con un halo radiolúcido. El agente etiológico más probable es:

- a) *Pseudomona aureginosa*
- b) *Aspergillus*
- c) *Staphylococcus aureus*
- d) *Candida albicans*
- e) *Mycobacterium tuberculosis*

133) Un niño de 24 meses de edad, con antecedente de haber nacido prematuro, aún no logra la marcha sin apoyo, aunque recientemente logró ponerse de pie. La posición sentado comenzó a los 11 meses y actualmente tiene sialorrea, perímetro craneano en -2 DS y espasticidad de las cuatro extremidades, con reflejos osteotendíneos vívidos. El diagnóstico más probable es:

- a) Parálisis cerebral
- b) Diplejia espástica
- c) Polineuropatía periférica
- d) Microcefalia
- e) Distrofia muscular

134) Un niño de 11 años presenta un cuadro de 10 días de evolución de congestión nasal y rinorrea mucopurulenta, asociada a fiebre de 38,5°C, tos y odinofagia. Al examen físico se observa descarga posterior purulenta y faringe congestiva y eritematosa. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a) Amoxicilina
- b) Prednisona
- c) Paracetamol
- d) Clorfenamina
- e) Clindamicina

135) Una paciente de 57 años, menopáusica, sin antecedentes de importancia, se realiza un PAP, que es informado con presencia de células endometriales. La conducta más adecuada es:

- a) Derivar a colposcopia y biopsia
- b) Controlar con PAP en un año
- c) Solicitar ecografía transvaginal
- d) Tipificación de virus papiloma
- e) Realizar cono cervical

136) Una mujer de 49 años consulta prurito generalizado, que es mayor en las palmas y plantas y que aumenta en la noche. Se realiza pruebas hepáticas que muestran GOT: 48 UI/L, GPT: 50 UI/L, GGT: 710 UI/L, FA: 689 UI/L, bilirrubina total: 2,0 mg/dl y bilirrubina directa: 0,6 mg/dl, albúmina: 4,0 g/dl y protrombinemia 100%. El examen de elección para proseguir el diagnóstico es:

- a) Cuantificación de inmunoglobulina E sérica
- b) Colangiografía
- c) Ácidos biliares
- d) Anticuerpos antinucleares
- e) Anticuerpos antimitocondriales

137) Un paciente de 24 años presenta disnea de esfuerzos, asociado a edema de extremidades inferiores. Refiere antecedente de soplo en la infancia. Al examen físico tiene PA: 120/80 mmHg, FC: 74x', examen cardiopulmonar con un segundo ruido desdoblado y fijo, un soplo sistólico eyectivo, paraesternal izquierdo y crepitaciones escasas en ambas bases pulmonares. El electrocardiograma muestra una imagen de bloqueo completo de rama derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Comunicación interauricular
- b) Comunicación interventricular
- c) Coartación aórtica
- d) Ductus arterioso persistente
- e) Tetralogía de Fallot

138) Un paciente de 80 años presenta astenia, bradipsiquia, confusión y disnea de mínimos esfuerzos. Al examen físico se aprecia pálido, con FC: 115x, PA: 120/80 mmHg. Se realiza un hemograma, que muestra anemia con hemoglobina: 5,9 g/dl, HCM: 34 pg, VCM: 117 fl, blancos: 3.100 por mm³, plaquetas: 57.000 por mm³ y, además, destaca LDH: 890 UI/L. EL diagnóstico más probable es:

- a) Anemia aplásica
- b) Anemia hemolítica
- c) Anemia megalobástica
- d) Mielodisplasia
- e) Mieloma múltiple

139) Un paciente de 84 años presenta desgarramiento mucopurulento, desde hace 4 días, por lo que se hospitaliza y se inicia tratamiento antibiótico. Evoluciona con dificultades para reconocer a sus hijos y esposa, a quienes confunde con su mamá y hermanos ya fallecidos. Se molesta cuando lo contrarían e incluso llegó a agredir físicamente a uno de sus hijos. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Alzheimer
- b) Trastorno delirante
- c) Depresión psicótica
- d) Esquizofrenia
- e) Delirium

140) Una paciente de 32 años, con amenorrea de 7 semanas y test de embarazo positivo consulta por dolor abdominal bajo intenso. Su examen físico muestra FC: 92x', PA: 110/60 mmHg. Al examen ginecológico tiene útero elástico y sensible y ovarios normales. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra un huevo anembrionado de 13 mm y visualiza una lesión quística de 5 cm, en el ovario derecho.

- a) Niveles seriados de HCG
- b) Salpingectomía
- c) Aspiración manual endouterina
- d) Control con ecografía en 7 a 14 días
- e) Laparoscopia exploradora ginecológica

141) Un paciente con antecedente de una angioplastia coronaria hace 6 meses, diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina 2 gramos al día, presenta HbA1c de 8,2% y glicemia de ayuno de 180 mg/dl. ¿Cuál es el tratamiento más adecuada?

- a) Agregar glibenclamida
- b) Iniciar empaglifozina
- c) Iniciar saxagliptina
- d) Agregar insulina NPH nocturna
- e) Iniciar pioglitazona

142) ¿Cuál es la conducta más adecuada para un paciente, que es contacto intradomiciliario de otro individuo diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera?

- a) Solicitar PPD y cultivo de expectoración
- b) Solicitar radiografía de tórax y baciloscopías
- c) Controlar clínicamente por 3 meses
- d) Indicar profilaxis con isoniazida por 6 meses
- e) Solicitar cultivo de Koch y broncoscopia

143) Un paciente de 65 años, hipertenso de larga data, mal controlado, consulta por dolor torácico intenso, EVA 8/10, transfixiante. Al examen físico se observa angustiado y sudoroso, con FC: 115x' PA: 160/110 mmHg, murmullo pulmonar presente, simétrico y examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos, con auscultación de un soplo diastólico III/VI en el precordio. Se solicita un electrocardiograma que muestra una taquicardia sinusal y las enzimas cardíacas resultan negativas. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumotórax
- b) Espasmo esofágico
- c) Infarto agudo al miocardio
- d) Síndrome aórtico agudo
- e) Tromboembolismo pulmonar

144) Un lactante de 10 meses, presenta fiebre de 4 días de evolución, de hasta 39,1°C, asociado a irritabilidad y malestar general. Al examen físico tiene secreción conjuntival bilateral, adenopatías cervicales anteriores y amígdalas con exudado blanquecino bilateral. El agente etiológico más probable es:

- a) *Streptococcus pneumoniae*
- b) *Streptococcus pyogenes*
- c) *Staphylococcus aureus*
- d) Adenovirus
- e) Citomegalovirus

145) Una paciente de puérpera de 3 meses, cuyo parto fue por vía vaginal, sin complicaciones. Sin embargo, desde entonces presenta metrorragia intermitente, que ha aumentado. Está dando lactancia materna y no ha tenido otros síntomas. Se solicita ecografía transvaginal, que muestra endometrio de 17 mm de grosor, con algunas imágenes quísticas en su interior. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

- a) Niveles de HCG
- b) Resonancia magnética nuclear de pelvis
- c) Biopsia de endometrio
- d) TAC de pelvis
- e) Histeroscopia

146) La característica de los estudios experimentales, que los diferencian de los demás tipos de estudios es que:

- a) La selección es aleatorizada
- b) Siempre utiliza triple ciego
- c) El investigador controla algunas variables
- d) El investigador selecciona los grupos de intervención
- e) Utiliza test de hipótesis

147) Una paciente realiza un viaje a la selva amazónica y, al cuarto día luego de su regreso, presenta fiebre alta hasta 39,3°C, asociada a cefalea intensa y persistente, con marcado malestar general y mialgias. Se realiza un hemograma, que muestra hematocrito: 24%, hemoglobina: 8 g/dl, glóbulos blancos: 16.000 por mm³, con fórmula diferencial normal, plaquetas: 93.000 por mm³ y VHS: 35 mmHg. El agente etiológico más probable es:

- a) Virus zika
- b) Virus dengue
- c) *Plasmodium falciparum*
- d) *Salmonella typhi*
- e) Virus de fiebre amarilla

148) Un paciente de 55 años presenta múltiples episodios de hematemesis, de cerca de un litro, en la última hora. Al examen físico tiene palidez de piel y mucosas, FC: 120 x', PA: 80/40 mmHg, con estigmas de daño hepático crónico y abdomen blando, sensible. ¿Cuál es la conducta inicial?

- a) Administrar terlipresina endovenosa
- b) Administrar cristaloides endovenosos
- c) Instalar balón de Sengstaken
- d) Realizar endoscopia digestiva alta
- e) Transfundir glóbulos rojos

149) Un paciente consulta porque quiere dejar de fumar. Fuma cerca de 10 cigarrillos al día, especialmente cuando está más nervioso, los fines de semana y en las reuniones sociales. Disfruta del cigarrillo y no cree que podrá dejar de fumar sin apoyo. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este paciente?

- a) Terapia cognitiva conductual
- b) Parches de nicotina
- c) Bupropión
- d) Fluoxetina
- e) Vareniclina

150) Un paciente de 82 años, diabético e hipertenso, consulta por malestar general y edema de extremidades inferiores. Al examen físico tiene PA: 150/100 mmHg, FC: 63x', edema blando bimalear ++++. Se solicitan exámenes, que muestran creatinina: 3,0 mg/dl, BUN: 86 mg/dl, K+: 5,8 mEq/L, Na+: 133 mEq/L, bicarbonato: 15 mmol/L. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Hemodiálisis
- b) Gluconato de calcio
- c) Peritoneodiálisis
- d) Bicarbonato de sodio
- e) Amlodipino

151) Una niña de 10 meses de edad tiene mamas en desarrollo Tanner II, bilateral. Su crecimiento ha sido adecuado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar ecografía mamaria
- b) Solicitar cariograma
- c) Observar y controlar en 2 meses
- d) Solicitar niveles plasmáticos de estrógeno y progesterona
- e) Solicitar niveles plasmáticos de 17-OH-progesterona

152) Un niño de 13 años consulta por dolor y aumento de volumen, en relación a la pierna izquierda, que ha ido en aumento y lo hace cojear. Tiene antecedente de traumatismo en la zona. Se solicitan una radiografía y una resonancia magnética nuclear, que se muestran a continuación:



El diagnóstico más probable es:

- a) Osteocondroma
- b) Osteosarcoma
- c) Sarcoma de partes blandas
- d) Tumor de células gigantes
- e) Sarcoma de Ewing

153) Una mujer de 45 años se realiza una mamografía, que muestra microcalcificaciones agrupadas y espiculadas en el cuadrante superior externo de la mama derecha, de 2 cm de diámetro. Su examen mamario no tiene alteraciones y cuenta con una mamografía previa, de hace 2 años, informada como Birrads 2. La conducta más adecuada es:

- a) Pedir ecotomografía mamaria
- b) Realizar biopsia con aguja gruesa
- c) Programar biopsia estereotáxica
- d) Solicitar resonancia magnética mamaria
- e) Realizar control mamográfico en un año

154) Un niño de 3 años, con antecedente de ictericia neonatal, que requirió fototerapia, es traído a la urgencia por dolor abdominal y náuseas de 4 días de evolución. Al examen físico destaca ictericia de piel y mucosas, asociado a palidez y esplenomegalia. Su hemograma muestra hematocrito de 19%, hemoglobina de 6,2 g/dl, con 23% de reticulocitos, blancos: 8.000 por mm³ y plaquetas: 200.000 por mm³. El frotis muestra macrocitosis, poiquilocitosis y anisocitosis. En sus pruebas hepáticas destaca bilirrubina 6 mg/dl, con bilirrubina directa de 0,9 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia hemolítica
- b) Leucemia aguda
- c) Síndrome hemolítico urémico
- d) Anemia por déficit de vitamina B12
- e) Hepatitis aguda

155) Una paciente de 39 años es despedida de su trabajo y, a las pocas horas, presenta imposibilidad de realizar movimientos con ambas manos. Al examen físico tiene tono muscular y reflejos normales. Además, llama la atención la falta de concordancia entre el relato de los síntomas y la actitud de la paciente, que se ve muy tranquila con lo que sucede. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno dismórfico corporal
- b) Trastorno conversivo
- c) Trastorno facticio
- d) Trastorno somatomorfo
- e) Trastorno disociativo

156) Un paciente de 45 años, luego de una transgresión alcohólica y alimentaria, presenta múltiples episodios de vómitos alimentarios, seguidos de hematemesis en una oportunidad. Su hemograma muestra hemoglobina de 9 g/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Várices esofágicas
- b) Gastropatía erosiva
- c) Úlcera péptica activa
- d) Síndrome de Mallory Weiss
- e) Gastritis isquémica

157) Una paciente de 21 años presenta un episodio de rápida instalación, en 5 minutos, de marcada angustia, llanto, disnea y sensación de opresión precordial, más vértigo, imposibilidad de tragar, temblor y mucho miedo a morir. ¿Cuál es el tratamiento de esta crisis?

- a) Risperidona
- b) Carbamazepina
- c) Clorpromazina
- d) Fluoxetina
- e) Lorazepam

158) Una paciente de 76 años, diabética, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de aparición de una lesión eritematosa en el tronco, asociada a dolor urente, como se ve en la siguiente imagen:



El tratamiento más adecuado es:

- a) Aciclovir 400 mg cada 8 horas, por 5 días
- b) Valaciclovir 1g cada 8 horas, por 7 días
- c) Aciclovir tópico
- d) Loratadina 10 mg al día por 5 días
- e) Flucloxacilina 500 mg cada 8 horas por 10 días

159) Un niño de 18 meses de edad, con antecedente de haber nacido prematuro, a las 32 semanas de edad gestacional, camina en punta de pies. Logró la marcha independiente hace un mes. Al examen físico, tiene aumento del tono muscular de las extremidades inferiores, con hiperreflexia y presencia de signo de Babinski. El diagnóstico más probable es:

- a) Estereotipia de la marcha
- b) Retraso del desarrollo psicomotor
- c) Diplejia espástica
- d) Polineuropatía
- e) Distrofia muscular

160) Una paciente consulta por un cuadro de 3 semanas de evolución de fiebre, sudoración nocturna, temblor, malestar general y artralgias. Hace 7 días se agrega dolor en el cuello. Al examen físico tiene marcado dolor a la palpación de la glándula tiroides. Se solicitan exámenes que muestran TSH: 0,01 UI/L y T4 libre: 2,9 ng/dl, con captación de yodo radiactivo de 1% (VN: 2 a 40%). El tratamiento más adecuado es:

- a) Paracetamol
- b) Antibióticos
- c) Prednisona
- d) Metimazol
- e) Ketoprofeno

161) Una paciente de 24 años se autopalpa un nódulo mamario de 2 cm, indolora, que no está adherida a la piel ni a planos profundos. Se solicita una ecografía mamaria que muestra una lesión bien delimitada, de 25 mm de diámetro, homogénea, con una fina pared que la rodea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Quiste mamario
- b) Fibroadenoma
- c) Cáncer de mama
- d) Papiloma mamario
- e) Tumor filoides

162) Un paciente de 43 años presenta dolor epigástrico urente, de un mes de evolución. Hace 24 horas deja de eliminar gases y el dolor se vuelve difuso y persistente, agregándose distensión abdominal. Al examen, tiene FC: 110x', PA: 110/70 mmHg y al examen abdominal se observa abdomen doloroso y distendido, con pérdida de la matidez hepática y abolición de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Obstrucción intestinal
- b) Pancreatitis aguda
- c) Perforación de úlcera péptica
- d) Plastrón vesicular
- e) Cáncer de vesícula

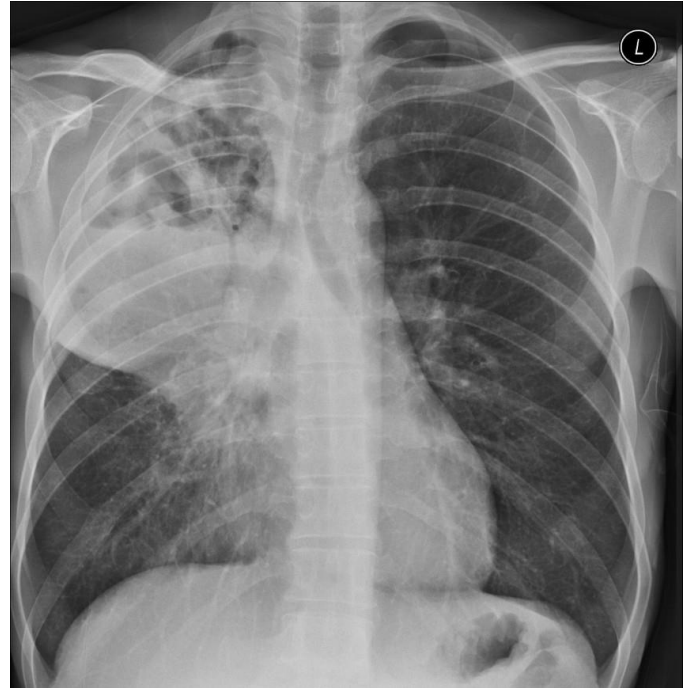
163) Una paciente de 40 años, con antecedente de artritis reumatoide, tratada con naproxeno oral, presenta un episodio de hemorragia digestiva alta, con melena. Se realiza una endoscopia digestiva alta, que muestra una úlcera duodenal activa; no se realizó el test de ureasa. La conducta más adecuada es:

- a) Cambiar el naproxeno por otro AINE
- b) Solicitar serología para *Helicobacter pylori*
- c) Solicitar nueva endoscopia con test de ureasa
- d) Realizar erradicación de *Helicobacter pylori*
- e) Iniciar inhibidores de la bomba de protones

164) Una paciente de 83 años se realiza exámenes preoperatorios, por una cirugía de cataratas, entre los que destaca un hemograma con 86.000 glóbulos blancos por mm³, hematocrito: 32%, hemoglobina: 11 g/dl, plaquetas: 123.000 por mm³. La fórmula diferencial muestra 86% de linfocitos, con aumento de citoplasma y sombras de Gumprecht en el frotis. Al examen físico se palpan múltiples adenopatías gomosas, generalizadas, de 2 a 3 cm de diámetro. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia mieloide crónica en crisis blástica
- b) Linfoma
- c) Leucemia linfática crónica clásica
- d) Leucemia mieloide crónica estable
- e) Leucemia de células velludas

165) Un paciente alcohólico, fumador de 10 paquetes año, presenta, desde hace 7 días, un cuadro de tos, con expectoración purulenta y fiebre hasta 38°C. Ha evolucionado con empeoramiento de los síntomas. Al examen físico está febril, con apremio respiratorio. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación:



El examen más adecuado para proseguir el estudio es:

- a) Broncoscopia
- b) Videotoracoscopia
- c) TAC de tórax
- d) PET-TC
- e) Resonancia magnética nuclear de tórax

166) Un niño de 4 años presenta cefalea de 1 mes de evolución, que es mayor en las mañanas y se asocia a diplopía. Además, ha presentado náuseas y vómitos alimentarios en el último tiempo, que han aumentado su frecuencia. ¿Cuál es la causa más probable de su cefalea?

- a) Migraña de presentación atípica
- b) Cefalea tensional
- c) Jaqueca clásica
- d) Vicio de refracción
- e) Hipertensión endocraneana

167) Un paciente de 30 años, presenta un nódulo tiroideo, que en el examen físico se palpa de consistencia elástica, indoloro, sin adenopatías cervicales. Se solicita TSH: 0,2 UI/L (VN: 0,3 a 5,0 UI/L), con T4 y T3 normales. Se solicita ecografía cervical, que muestra un nódulo tiroideo sólido, redondo, de aspecto homogéneo, sin microcalcificaciones, de 3 cm de diámetro. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar cintigrafía tiroidea
- b) Realizar punción con aguja fina
- c) Controlar con pruebas tiroideas en 6 meses
- d) Solicitar niveles de tiroglobulina
- e) Realizar cirugía

168) Una niña de 15 años presenta disconformidad con su cuerpo, por lo que lo oculta, utilizando ropa 2 o 3 tallas más grandes. Además, tiene retraimiento social y gran preocupación por las calorías que ingiere. Los padres refieren que anda con náuseas en el último tiempo, por lo que come poco y ha bajado de peso. Sin embargo ella se había negado a acudir al médico. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno distímico
- b) Trastorno alimentario mixto
- c) Anorexia nervosa
- d) Trastorno depresivo mayor
- e) Bulimia nervosa

169) Un paciente de 68 años consulta por dolor abdominal bajo, asociado a fiebre, que es mayor en el cuadrante inferior izquierdo. Al examen físico tiene T°: 37,7°C, FC: 94x', PA: 110/76 mmHg y su examen abdominal muestra abdomen doloroso a la palpación, con marcada resistencia muscular en la fosa iliaca izquierda y disminución de los ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

- a) Diverticulitis aguda
- b) Colitis isquémica
- c) Apendicitis aguda
- d) Vólvulo de sigmoides
- e) Cáncer de colon complicado

170) Un problema de los estudios de casos y controles es que, al ser retrospectivo, las personas evaluadas olvidan las situaciones a las que estuvieron expuestos. Aquello produce un tipo de error sistemático, que corresponde a un:

- a) Error de clasificación diferencial
- b) Sesgo de selección
- c) Sesgo de confusión
- d) Sesgo de información
- e) Error de clasificación no diferencial

171) Una paciente de 70 años, al tercer día después de una colonoscopia, con resección de un pólipo, acude al servicio de urgencia por dolor abdominal muy intenso, en la zona inferior izquierda, asociada a sensación febril y deposiciones con sangre, en una oportunidad. Al examen físico tiene abdomen doloroso a la palpación profunda, mayor en la fosa iliaca izquierda y signo de Blumberg en dicha zona. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de esta paciente?

- a) Radiografía de abdomen simple
- b) Ecotomografía abdominal
- c) Tomografía axial computada de abdomen y pelvis
- d) Resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis
- e) Colonoscopia

172) ¿Cuál es el mayor beneficio que la vacunación contra el rotavirus, en menores de 6 meses ha demostrado hasta ahora?

- a) Disminuir la mortalidad por cualquier causa de diarrea
- b) Disminuir la cantidad de casos secundarios de infecciones de rotavirus
- c) Disminución de la incidencia de infecciones por rotavirus
- d) Disminución de las hospitalizaciones pediátricas
- e) Disminución de los casos de intususcepción intestinal

173) Una mujer de 62 años, consulta por un cuadro de 3 horas de evolución de palpitaciones intensas, asociada a disnea. Al examen físico tiene pulso irregular, a 130 latidos por minuto, con PA: 110/70 mmHg. Su examen cardíaco muestra soplo diastólico III/VI, más un pequeño soplo sistólico eyectivo. Su electrocardiograma muestra una taquicardia irregular, con complejos QRS angostos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar propranolol y antiagregantes
- b) Administrar enoxiheparina y verapamilo
- c) Administrar heparina y amiodraona
- d) Realizar cardioversión eléctrica
- e) Administrar adenosina y anticoagulantes orales

174) Una paciente de 26 años, sexualmente activa, consulta por disuria y dolor abdominal bajo, que luego se extiende al hipocondrio derecho y se asocia a leucorrea. Al examen físico tiene dolor a la palpación hipogástrica y del hipocondrio derecho y, en el examen ginecológico, se constata leucorrea, sin mal olor. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) *Enterococcus faecalis*
- b) *Ureaplasma Urealyticum*
- c) *Chlamydia trachomatis*
- d) *Treponema pallidum*
- e) *Mycoplasma genitalium*

175) Un paciente de 32 años, con antecedente de litiasis renal a repetición se realiza exámenes, que muestran calcio plasmático: 9,8 mg/dl, albúmina: 3,0 g/dl, creatinina plasmática: 0,7 mg/dl, PTH: 90 UI/L (VN: 10 a 55 pg/ml) y calciuria de 200 mg/día (VN: 50 a 150 mg/día) . El diagnóstico más probable es:

- a) Hiperparatiroidismo primario
- b) Hiperparatiroidismo secundario
- c) Hiperparatiroidismo terciario
- d) Hipercalciuria primaria
- e) Hipercalciuria familiar

176) Una paciente de 33 años, con antecedente de molestias urinarias, caracterizadas por disuria dolorosa, por lo que es diagnosticada de infección urinaria y tratada con ciprofloxacino oral, con buena respuesta clínica. Sin embargo, algunos días después reaparece el ardor al orinar y presenta prurito genital. Al examen físico se aprecia eritema de la mucosa vulvar, sin leucorrea y se observan erosiones lineales a nivel de la horquilla. El tratamiento más adecuado es:

- a) Cotrimoxazol
- b) Fluconazol
- c) Metronidazol
- d) Doxicilina
- e) Aciclovir

177) Un paciente de 65 años, con antecedente de un infarto agudo al miocardio, hace 2 años, presenta un síncope, con compromiso de conciencia que requirió maniobras de reanimación para recuperarse. ¿Qué arritmia es la que debe descartarse en primer lugar?

- a) Taquicardia paroxística supraventricular
- b) Bloqueo auriculoventricular completo
- c) Síndrome de Wolff Parkinson White
- d) Taquicardia ventricular
- e) Fibrilación auricular

178) Un paciente de 65 años estuvo hospitalizado por una neumonía y, al cuarto día después del alta, inicia dolor abdominal, asociado a diarrea acuosa, con malestar general e incontinencia fecal, que ha ido empeorando, en los 7 días siguientes. Al examen físico tiene abdomen distendido, doloroso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal y con ruidos hidroaéreos +++. ¿Cuál es el examen de elección para el estudio inicial de este paciente?

- a) Colonoscopia
- b) Coprocultivo
- c) Recuento de leucocitos fecales
- d) Parasitológico en deposiciones
- e) Toxinas A y B para

179) Un hombre sufre una caída, mientras corría, golpeándose el hombro contra el piso y presentando dolor e impotencia funcional de dicho hombro. Al examen físico tiene equimosis clavicular y dolor con todos los movimientos del hombro. Se solicita radiografía, que se muestra a continuación:



¿Cuál es la conducta inicial?

- a) Yeso Velpeau
- b) Yeso colgante
- c) Vendaje en ocho
- d) Cabestrillo
- e) Osteosíntesis

180) Una paciente de 91 años, diabética, con antecedente de cólicos biliares a repetición, consulta por astenia, decaimiento, ictericia marcada y orinas oscuras, de 3 semanas de evolución, asociadas a dolor epigástrico moderado. Al examen físico, se aprecia ictericia de piel y mucosas y se palpa una masa en el hipocondrio derecho. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran SGOT: 60 UI/L, SGPT: 56 UI/L, GGT: 570 UI/L, FA: 755 UI/L, bilirrubina total: 21 mg/dl, bilirrubina directa: 19 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de la cabeza de páncreas
- b) Cáncer de vesícula
- c) Colangiocarcinoma
- d) Hepatocarcinoma
- e) Cáncer de la ampolla de Vater

FIN DEL EXAMEN

La PAUTA de la prueba, con las respuestas que nosotros consideramos correctas, estará disponible en el siguiente link:

<http://www.drguevara.cl/material-y-pruebas-gratis/180-preguntas-tipo-eunacom/pauta-eunacom-julio-2019/>

Algunas de las respuestas aún están en revisión, por lo que es posible que las cambiemos en los próximos días.

Este examen fue reconstruido con el fin de que los médicos y estudiantes de medicina de Chile tengan acceso a una fuente de estudio, que les permita enfrentar mejor el Eunacom y su vida profesional. Las imágenes utilizadas para esta reconstrucción fueron obtenidas de los siguientes sitios web:

Pregunta 9

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2017-03/html/2017-65-3-255-257.htm

Pregunta 21

https://www.researchgate.net/figure/Admission-electrocardiogram-demonstrating-complete-heart-block_fig2_46170688

Pregunta 26

<https://es.slideshare.net/cstorreramona/purpura-schonlein-henoch>

Pregunta 34

https://www.researchgate.net/figure/Abdominal-X-ray-radiography-showing-air-fluid-levels-representative-of-intestinal_fig1_261141116

Pregunta 58

http://www.cerpo.cl/items/File_002_00382_0028.pdf

Pregunta 62

<http://www.chestx-ray.com/index.php/education/normal-cxr-module-train-your-eye#!1>

Pregunta 63

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1889-836X2015000200004

Pregunta 81

https://www.intramed.net/contenido.asp?contenido_id=86115

Pregunta 84

<https://www.dermcoll.edu.au/atoz/squamous-cell-carcinoma/>

Pregunta 92

<https://twitter.com/rigotordoc/status/977153731249803264?lang=fi>

Pregunta 105

<https://www.radiologyinfo.org/sp/gallery/index.cfm?image=1109>

Pregunta 118

<http://oaawebcast.info/assets/4-nov-1600-shennan.pdf>

Pregunta 120

<https://www.flickr.com/photos/drvigon/10325768115/>

Pregunta 122

<https://armandoh.org/disease/common-skin-rashes/>

Pregunta 152

<https://www.ajronline.org/doi/pdf/10.2214/ajr.163.2.8037040>

<https://es.slideshare.net/Piojosa/tumores-oseos-38870600>

Pregunta 158

<https://omicronno.elespanol.com/2015/12/descubren-una-relacion-entre-el-herpes-zoster-y-el-riesgo-de-ictus/>

Pregunta 165

<https://radiopaedia.org/cases/acute-right-lung-abscess>

Pregunta 179

<http://www.amsj.org/archives/4503>

CURSO DE PREPARACIÓN EUNACOM

PRUEBA DE 180 PREGUNTAS

EUNACOM JULIO 2019

PRIMERA PARTE

- 1 C Está en presentación cefálica (fontanela se palpa en el centro de la pelvis), pero en posición transversa, la que no debe ser confundida con la situación transversa, que sí es indicación de cesárea. Aparte de eso está todo evolucionando bien, en fase activa (4 a 9 cm de dilatación).
- 2 D Hay dos cosas importantes: 1. toda infección intrahospitalaria debe estudiarse y mientras tanto recibir cobertura para microorganismos resistentes (en este caso la vancomicina cubre *S. aureus* meticilino resistente, *Enterococo* resistente a ampicilina y *Neumococo* resistente a penicilina, aunque este último no produce infecciones intrahospitalarias. 2. Una vez que se identifica el microorganismo, se cubre de la manera más simple posible. 3. La cloxacilina es más potente antibiótico que la vancomicina en las bacterias sensibles. 4. El cefotaximo no cubría bien *pseudomona*, así que al inicio habría sido mejor dejar vancomicina + cefoperazona o cefepime.
- 3 C Tiene un SCA con un BCRI reciente, por lo que debe ser manejado igual que un SCA con SDST.
- 4 B Por haber nacido a las 32 semanas se debe realizar la corrección de la edad gestacional (aunque en estricto rigor solo se realiza en los prematuros que nacen antes de las 32 semanas). La forma de hacer esta corrección es que a la edad cronológica (11 meses en este caso) se le debe restar el tiempo que le faltaba para llegar a las 40 semanas (8 semanas, es decir, 2 meses en este caso). Por tanto, realmente tiene 9 meses (11 - 2) y su peso cae entre -1 y -2 DS, es decir, riesgo de desnutrición.
- 5 C Tanto en la AR, como en el LES, los marcadores (FR y Anti-CCP para la AR y Anti-DNA2h para el LES) son 1. elementos diagnósticos y 2. marcadores de agresividad. En ambos casos, eso sí, el principal determinante del pronóstico es la clínica, que mientras más agresiva, refractaria, etc. sea, peor.
- 6 E Tiene apneas emotivas, que son ALTE de bajo riesgo. Orienta a eso la edad y la clara correlación con las emociones. Se observan y se educa. Los ALTE de alto riesgo, en cambio, son los que tienen menos de 6 meses, antecedentes de muerte súbita en la familia, alteraciones en el examen neurológico o cardíaco o la necesidad de reanimación.
- 7 C Es un clásico cáncer de hipofaringe. El cáncer de laringe suele presentar disfonía progresiva, sin los otros síntomas. El cáncer de esófago presenta disfagia lórica, sin los otros síntomas.
- 8 E Solo por la anatomía es posible adivinar la respuesta. El ligamento del cuádriceps está sobre la rótula. El tendón rotuliano está debajo de la rótula y se inserta en la tuberosidad tibial.

- 9 C Es un cáncer bronquial o pulmonar clásico, tanto por la clínica, como por la imagen. Revisar el resumen de semiología respiratoria.
- 10 B Es un endometrioma clásico, tanto por la clínica como por la imagen. Además, tiene la elevación del Ca-125, que, si bien es un marcador de cáncer de ovario, se eleva en otros procesos peritoneales, como la endometriosis.
- 11 C Es una pregunta muy rara y muy mala, pero la única respuesta aceptable es la C, ya que es la única medida de prevención terciaria y es la forma en que se plantea la pregunta (evitar complicaciones). La A y B son prevención secundaria. La D y E son prevención primaria.
- 12 B Tiene una menopausia normal (mayor a 40 años), que es un hipogonadismo (estrógenos bajos) hipogonadotrópico (FSH alta).
- 13 B Tiene un TOC, que, al igual que todos los trastornos ansiosos crónicos (TA, TAG, TEPT), se trata con antidepresivos (lo más importante), si bien también se dejan benzodiacepinas en dosis bajas. La "voz interior" no es una alucinación, mientras no la escuche directamente o la considere algo ajeno o externo a él.
- 14 A Ni siquiera tiene talla baja (talla < 2 DS para la edad), ya que ello equivale a <p3. De todos modos, la historia de padres bajos y la edad ósea acorde a la cronológica, mostraban que se quería preguntar una talla baja familiar.
- 15 E Es un clásico delirium tremens, que se trata con benzodiacepinas, idealmente diazepam, que tiene vida media larga, a menos que tenga DHC, en que se debe tratar con lorazepam. Las demás causas de agitación psicomotora psiquiátrica se tratan con haloperidol, pero esta es una excepción que hay que saber.
- 16 D Tanto la clínica como el antecedente de estar en lactancia orientan a atrofia. Otras causas de atrofia vaginal son embarazo y menopausia. No confundir con la atrofia endometrial, que es causa de metrorragia y que se ve en las mismas causas, más los ACO y TRH que contienen progestágenos, pero que no producen atrofia vaginal, por tener también estrógenos.
- 17 B Es una neuritis óptica clásica, en contexto de una esclerosis múltiple. El edema de papila bilateral es clásico de la HTEC, pero la NO también tiene edema de papila, ya que ahí es donde nace el nervio óptico.
- 18 A Los antipsicóticos producen 1. Síndrome neuroléptico maligno y 2. Síndrome anticolinérgico. Las clínicas de todos estos síndromes se preguntan y están descritas en la clase respectiva de intoxicaciones (psiquiatría). En este caso es un síndrome anticolinérgico clásico.
- 19 B Es una hernia diafrágica congénita, que producen hipoplasia pulmonar. Se trata con VMI de alta frecuencia (para lo que requiere intubar) más cirugía diferida, en algunas semanas (no ahora).
- 20 C El diagnóstico de cólico renal es clínico. El pielotAC es el examen de elección para identificar la ubicación y tamaño del cálculo renal, de modo de determinar si se observa (menor a 1 cm) o si se saca mediante LEC u otra intervención. El UroTAC, en cambio, se usa

para estudiar el trauma renal y la hematuria, en que se sospecha cáncer, antes de la cistoscopia.

21 D Se observa con disociación AV y, además, la FC cercana a 30 sugiere mucho un BAV completo o de tercer grado. Se deben saber identificar todas las arritmias de manera relativamente rápido en el EKG.

22 D Este tema es muy importante y está bien tratado en el video de resumen de GO. Tiene un embrión sin latidos (no importa entonces ni la HCG, que se mira cuando no hay saco ni embrión; ni el diámetro del saco, que se mira cuando no hay embrión, es decir, cuando hay un huevo anembrionado). Lo único que importa es la longitud del embrión: si es menor a 7 mm, se debe controlar con una ecografía en 7 a 14 días, porque puede ser un embarazo normal muy pequeño; si es de 7 mm o más, se diagnostica el aborto retenido y se puede observar o legar. La HCG solo sirve cuando se sospecha un embarazo ectópico, por no verse nada en la ecografía (no es el caso).

23 B Es una rubéola clásica. Revisar las clínicas de los exantemas y saberlos de memoria, porque se pregunta segura. Que tenga menos de un año, muestra que no está vacunado.

24 A Recordar que en el mayor de 75 años el objetivo de la HbA1c es menor a 8%. Por tanto, está bien.

25 E Es un déficit de B12 clásico. Recordar que el déficit de B6 (piridoxina) es el causado por el consumo crónico de isoniazida (ej. TBC o PFX TBC) y se presenta como una polineuropatía.

26 A Es una púrpura de Schönlein Henoch y su complicación más importante y que marca el pronóstico es la GNA con la consecuente falla renal. De hecho, no solo se pide la creatinina, sino también sedimento y proteinuria.

27 A Tiene clínica de un trastorno digestivo funcional (ej. Síndrome de intestino irritable) y los hallazgos en la ecografía no muestran sino un pólipo de características benignas (son malignos y hay que sacarlos si: miden más de 1 cm, tienen cálculos asociados, tienen aspecto invasor o heterogéneo). La vía biliar normal es hasta 7 mm.

28 C La B y la D se asocian a síncope disautonómicos, de tipo "situacional". La E se relaciona con los síncope ortostáticos. Tanto el ejercicio, como la ocurrencia en reposo, sin un desencadenante ni síntomas previos, sugiere etiología cardiogénica.

29 E Es un lumbago mecánico común y corriente (suelen ser muy intensos). Es fundamental la analgesia, el reposo relativo (no en cama) y, una vez que el dolor ha cedido, indicar KNT por largo tiempo, de modo de fortalecer los músculos del core (abdominales, lumbares, multifidos y glúteos), para disminuir las recurrencias.

30 D Si se anticoagula en el embarazo, se prefiere que sea con heparina de bajo peso molecular, ya que los anticoagulantes orales son teratogénico y aumentan el riesgo de sangrado en el parto. El antecedente de una TVP no necesariamente obliga a anticoagular a una embarazada, a menos que 1. tenga una trombofilia ya identificada (ej. déficit de ATIII o mutación de la protrombina) o 2. la TVP haya tenido relación con algo hormonal, como el embarazo, puerperio o inicio de ACO, como en este caso.

- 31 A Es la definición de RR, que es la razón de incidencias. B y E son medidas de impacto.
- 32 D Tiene una HTA secundaria. La hipoK+ sugiere HAP o RV. La clínica de debilidad y cefalea, más la hiponatremia marcada sugieren algo más un HAP que una HTA RV. Por ello, la respuesta es la D, aunque en realidad también se debería solicitar la A.
- 33 C El manejo de la retención de hombros sigue un orden específico: Primero: realizar hiperflexión de la cadera (maniobra de Mc Roberts). Segundo: realizar compresión suprapúbica (maniobra de Manzzanti / Rubbins). Tercero: intentar rotación del tronco u otra maniobra para sacar el hombro. De no funcionar nada se hacen maniobras más invasivas como sinfisiotomía púbica o fractura de la clavícula fetal.
- 34 C Es una manía clásica y, por tanto, un TAB. No tiene síntomas psicóticos. Si bien la personalidad parece estar afectada (ser "patudo y sin filtro"), no hay duda que de base hay un TAB.
- 35 C Es una clásica demencia vascular de tipo subcortical. Es una pregunta muy difícil, pero el antecedente de AVE es algo muy sugerente y la labilidad emocional y desinhibición son sugerentes de la localización subcortical. Si no hubiese estado en las opciones, sería una depresión.
- 36 E Es una obstrucción intestinal clásica tanto por la imagen como por la clínica. En este caso, el antecedente de E. Cröhn sugiere que se complicó con una estenosis intestinal.
- 37 B Es un eritema infeccioso o quinta enfermedad o megaloeritema clásico. Es causado por el PVB19. Cuando tiene ya el eritema (aunque sea el malar) ya no contagia (solo contagia en el pródromo). Revisar las clínicas de los exantemas y saberlos de memoria.
- 38 A El antecedente de haber vivido en Brasil sugiere Chagas, sin embargo, la clínica es muy sugerente de cáncer de esófago, ya que tiene una disfagia lógica (afecta más la deglución de los sólidos grandes, luego los más pequeños y solo al final los líquidos). En cambio, Chagas, esclerodermia y acalasia suelen tener disfagia ilógica.
- 39 D Revisar el resumen de semiología cardíaca. Si bien la TGV no suele tener soplos, sí puede tenerlo, ya que la arteria pulmonar queda algo estrecha para la sangre que proviene del ventrículo izquierdo y eso produce flujo turbulento. Además, la TGV es la única cardiopatía cianótica de las alternativas y, por ello, es la respuesta correcta con certeza. La TGV sí se caracteriza por un mediastino delgado.
- 40 C Tiene una caída de la AV que mejora al mirar por un agujero estenopeico, así que tiene un vicio de refracción, también llamado ametropía. La AV pasó de 0,33 a 0,67, por lo que mejoró (se calcula con la simple división de 20/60 y 20/30).
- 41 E Tiene un síndrome colinérgico clásico (lo más probable es que consumió insecticidas), por lo que debe recibir atropina como antídoto. Revisar los síndromes de las intoxicaciones en psiquiatría.
- 42 E Tiene amigdalitos o tonsilolitos clásicos. Se observan y se enseña al paciente a retirárselos con un palillo.

- 43 C Tiene una neumonía atípica por *Mycoplasma pneumoniae*. Recordar que puede hacer un exantema eritematoso o un eritema multiforme menor (más frecuentemente el EMM se produce por infección por herpes o por medicamentos).
- 44 C Si bien la vigilancia epidemiológica de este tipo (vigilancia activa) puede servir para todas las opciones, la respuesta más correcta y completa es la C. En el Covid-19 sí se aísla a los contactos, pero en la meningococcemia no se aíslan, sino que se les da profilaxis antibiótica (rifampicina, ciprofloxacino o ceftriaxona).
- 45 C El Prolapso se evalúa con el POP-Q: un examen físico formal, realizado por un ginecólogo, en el cual se mide el grado de prolapso de las distintas estructuras genitales.
- 46 B Es una pregunta discutible, ya que tiene una otitis externa y tanto B como D son respuestas correctas y la evidencia así lo dice. La neomicina solo estaría contraindicada si hubiese perforación timpánica, ya que los aminoglicósidos son ototóxicos. Dejaremos la B como respuesta correcta solo porque a los otorrinos con los que conversamos les gusta más.
- 47 B Tiene un trastorno del espectro autista clásico, de la variante autista (Asperger, en cambio, tiene lenguaje normal). Además, afecta otras áreas del desarrollo, por lo que antes se les llamaba trastornos generalizados del desarrollo.
- 48 A Es una GNAPE clásica, con la hipocomplementemia característica. Se trata con soporte y diuréticos para el edema y la HTA. Los corticoides solo se indican si hay Sd. Nefrótico asociado o si hay una GNRP. En este caso hay IRA, con una crea de 2, por lo que está al límite de requerir corticoides, pero de las opciones, la de los diuréticos sigue siendo la mejor.
- 49 C Por tener muchos síntomas anímicos de larga data, a los que luego se agrega el síntoma psicótico, lo más probable es que sea una depresión psicótica (al menos en la forma en que está redactada en esta pregunta). Sin embargo, vale la pena mencionar que las alucinaciones auditivas sugieren mucho más un T. esquizoafectivo que una depresión psicótica (que suele tener un delirio de ruina o de culpa). Una pregunta muy similar, además, decía que tenía un tío con litio (se asumía bipolar) y que había tenido una psicosis postparto ella, caso en el cual la respuesta cambia, sin duda, a T. esquizoafectivo.
- 50 E Tiene un hipogonadismo (testosterona baja) hipogonadotrópico (LH baja), por lo que es de causa hipotalámica o hipofisiaria ("el hipo hipo es hipo hipo"). Se estudia con RMN de hipófisis. Vale la pena mencionar que, si la LH hubiese estado normal, en la zona "baja" del rango normal, igualmente sería un hipogonadismo hipogonadotrópico.
- 51 B En este caso tiene un efecto adverso del amlodipino: edema, por lo que que hay que suspenderlo. Aunque la A y la C podrían servir, se debe siempre suspender y reemplazar el medicamento que produzca un efecto adverso, en la medida de lo posible, antes de tomar otras medidas (esto aplica para medicina en general).
- 52 D Tiene una enfermedad de Behçet, que se asocia a uveítis, al igual que las PEA y las EII. La A, C y E no afectan la agudeza visual. La B no tiene ojo rojo.
- 53 D Tiene la TSH menor a lo normal, por lo que está "sobretreatado" y se debe disminuir la dosis de levoT4. La habitual es 1,6 ug/Kg, así que probablemente estaba muy alta la dosis de 25 mg para un lactante de 3 meses (6 Kg aprox).

54 E Es una pregunta muy difícil, pero el manejo de un gemelo muerto depende de la edad gestacional y de la corionicidad. En el primer trimestre siempre se observa evolución, porque no hay nada más que hacer. En el segundo y tercer trimestre los monocoriales se tienen a interrumpir, ya que si uno muere, el otro también, a menos que se pueda hacer alguna otra intervención intrauterina (si muy prematuro). En los bicoriales, en cambio, se puede observar, pero existe el riesgo de sufrimiento fetal y de coagulación intravascular diseminada. Por tanto, se sigue con pruebas de bienestar fetal y con pruebas de coagulación, ya que, a pesar de que el DD es el examen con el que habitualmente se diagnostica la CID, en el embarazo el CID se altera per sé y, por ello, se usan las pruebas de coagulación (que se alargan en la CID).

55 B Ya sé que en clases les dije que era una fisura anal, pero la verdad es que cambié de opinión. La forma en que está redactada es difícil, ya que "deposiciones semiformadas" sí orientan a fisura. Sin embargo, la mucosidad (aunque puede ser normal) sugiere algo más la APLV y, además, que hagan énfasis en que está con alimentación mixta y que tiene deposiciones frecuentes, hace que sea mejor marcar la B. También sugiere que sea la B el resto de las opciones, que muestran que las redactó el pediatra general o digestivo y no el cirujano pediátrico. Sea como sea, lo importante es saber que, aunque uno se sepa la materia, siempre tendrá preguntas malas en el Eunacom y por ello es tan importante estudiar bien, hasta lograr un nivel de conocimiento en el que no importe tener algunas malas por leer mal o porque pensaron mal en el minuto de tiempo que tienen.

56 C Prefunta difícil. Tiene un edema por IRC (crea de 2,2) y también por IRC, por lo que la furosemida debería servir. Además, la A, B y D son tiazidas (la indapamida no es una tiazida propiamente tal, pero es cercana), por lo que ninguna es. La E sirve para aumentar la sobrevida en la ICC, pero junto a Enalapril y betabloqueo y en esta pregunta se interroga directamente por el manejo del edema.

57 D Es una sospecha de FQ en el adulto, tanto por las infecciones bacterianas, como por las bronquiectasias (en otro año, más difícil aún, se puso una RxTx con imágenes que sugerían bronquiectasias). Se estudia con test del sudor. Es una patología AUGE, así que se pregunta bastante. La A serviría para la enfermedad de cilio inmóvil, que suele tener la misma clínica, más *situs inversus* en la mitad de los casos.

58 A Tiene un MEFI I, por tener buena FCF, buena variabilidad y aceleraciones, sin desaceleraciones. Si no tuviese contracciones, sí podría ser la D, ya que se trataría de un RBNE (ver la clase de MEFI).

59 E Tiene una polineuropatía clásica (ver resumen de semiología neurológica y aprovechar de leerlo entero y aprenderlo).

60 A Recordar que las pruebas de screening requieren una alta S y toleran una E intermedia. En cambio, las pruebas confirmatorias necesitan una alta E y también necesitan que la S siga siendo elevada.

61 A Las cocáceas G(-) intracelulares son gonococo. Se debe tratar con ceftriaxona IM (259 mg por una vez), pero, además, se debe cubrir Chlamydia con doxiciclina o azitromicina o doxiciclina.

62 D Los miomas son un hallazgo normal y no causan metrorragia. En cambio, el endometrio grueso asusta y debe ser biopsiado (descartar cáncer de endometrio o HPE). Recordar que igual se biopsian las metrorragias posmenopáusicas con un endometrio mayor a 5 mm (8 mm si tienen TRH), ya que si es mayor a esos grosores, es improbable que sea la atrofia (causa más frecuente).

63 A Aunque por la edad y por el tabaquismo podría ser un EPOC, la verdad es que lo habitual es que el EPOC tenga más de 15 paquetes-año y, lo más importante, en este caso la espirometría es un patrón obstructivo que mejora con BD, por lo que está confirmado el diagnóstico de asma.

64 B Es una condrocalcinosis clásica tanto por la clínica como por la radiografía (meniscos calcificados). El líquido está muy inflamatorio y sugiere infección, pero dice que "no se visualizan bacterias" y, además, la CC puede presentarse, a veces, con más de 100.000 GB/mm³. Es causada por cristales de pirofosfato de calcio.

65 D Tanto la clínica (convulsiones y desorientación) como el LCR (líquido hemorrágico: GR crenados, con característica virales: glucosa normal y pleocitosis de predominio mononuclear), sugieren encefalitis herpética. Falta la imagen con las lesiones en los lóbulos temporales.

66 A Tiene un trastorno de pánico o trastorno de ansiedad o de angustia clásico: crisis de pánico recurrentes e inexplicadas. Que ya no salga de su casa sugiere que, además, tiene agorafobia, pero predomina el diagnóstico de TP.

67 A La alergia al huevo no contraindica ninguna vacuna. Solo son contraindicaciones las reacciones adversas severas, con las dosis previas o la alergia grave y conocida a alguno de sus componentes.

68 E El pólipo vesicular no tiene importancia, por tener aspecto benigno. En cambio, el cambio en el hábito intestinal es algo que sugiere cáncer de colon y obliga a hacer una colonoscopia completa.

69 C La enfermedad ya está presente y los pacientes ya tienen síntomas, así que es una medida de prevención terciaria. La primaria es antes de la enfermedad. La secundaria es antes de los síntomas.

70 E Tiene una crisis suprarrenal, por hiperplasia suprarrenal congénita (por ser niño). Sugieren esto la clínica, la hipoNa⁺ y a hiperK⁺. Se trata con corticoides ev ante la sola sospecha.

71 A Es una pregunta muy discutible, ya que, si bien está claro que tiene una incontinencia urinaria de urgencia, tanto los anticolinérgicos, como la terapia conductual (reeducación vesical sería lo más similar a ello) son tratamientos adecuados. Como se pregunta el tratamiento inicial, yo marqué la E, siguiendo las recomendaciones norteamericanas. Pero, la verdad, es que aquello es discutido por las asociaciones de especialistas luego de conversarlo mucho con varios especialistas, ellos recomiendan marcar la A, por ser claramente de urgencia. En fin... lo importante es no pelear con el Eunacom y seguir respondiendo.

72 B Tiene una espondilitis anquilosante clásica tanto por el lumbago inflamatorio (mayor en la noche y en el reposo) como por la uveítis.

73 C Es un TOC clásico con obsesión de conducta inmoral y compulsión de evitación y rezar. Se ha preguntado antes con la idea de ser homosexual (que en el caso puntual le generaba mucha angustia al paciente y era una idea recurrente, por lo que sí era una obsesión).

74 C Pregunta muy discutible y de manejo de especialista, que no debería preguntarse. Que tenga solo 10% de captación y adelgazamiento cortical muestra que el riñón probablemente tiene daño severo e irreparable, por lo que estaría indicada la nefrectomía. Eso sí, antes debería pedirse una TAC, ya que igual se puede intentar salvar ese 10% con una pieloplastía. Discutimos mucho esta pregunta con varios especialistas y aunque no hubo consenso, dejaremos como correcta la nefrectomía. Nuevamente, en fin... así es el Eunacom y lo más importante es no pelear con él, sino seguir respondiendo.

75 B Tiene un síndrome de dumping clásico (aprender dicha clínica), frecuente complicación de un by-pass gástrico. Se caracteriza por síntomas disautonómicos, que pueden ser muy similares a una hipoglicemia, por lo que siempre se debe solicitar HGT para descartarla. Sin embargo, la diarrea no calza con hipoglicemia, sino solo con dumping.

76 D La sospecha es una disección aórtica, especialmente por el antecedente de enfermedad de Marfán. La taquicardia sinusal es algo inespecífico, que también se puede ver en el IAM (aunque con signos de isquemia) y en el TEP (es más frecuente que el patrón S1Q3T3).

77 C Tiene un absceso mamario, como complicación de un quiste infectado. Se debe drenar y manejar con antibióticos. El drenaje es quirúrgico, con incisión y drenaje.

78 E Es una pregunta difícil, pero la hipermenorrea siempre se estudia primeramente con una ecografía transvaginal, de modo de buscar una causa anatómica. Si resulta normal y es una adolescente o si es que tiene clínica de alteraciones de la hemostasia, se debe proceder directamente al estudio de la hemostasia, en busca de una enfermedad de Von Willebrand u otra análoga.

79 D Tiene clínica de rinitis. Por ser más intensa en las mañanas y con los cambios de temperatura, es de tipo vasomotora. Otras cosas clásicas de la rinitis vasomotora es que empeora con el estrés, con alimentos muy calientes o condimentados. El cáncer se presenta como obstrucción y rinorrea serosanguinolenta unilateral. Los pólipos se ven en pacientes jóvenes y suelen ser bilaterales, con marcada obstrucción y sí pueden tener rinorrea o sinusitis secundarias.

80 A Tiene un glaucoma agudo clásico, cuyo tratamiento incluye el manitol ev, gotas mióticas (ej. pilocarpina) y la iridotomía láser.

81 B Es una pericarditis clásica, tanto por la edad y la clínica (aumenta al acostarse) como por el EKG con SDST en J casi todas las derivaciones. También tiene depresión del PR en algunas.

82 E Tiene una úlcera por presión en etapa I (sin solución de continuidad de la piel), por lo que el tratamiento consiste en cambios de posición frecuentes. El colchón antiescaras no reemplaza los cambios de posición, pero sí estaría indicado también.

83 A En estricto rigor no tiene una ITU, dado que tiene menos de 100.000 colonias en el cultivo de orina obtenida por micción. Dentro de las opciones de manejo están 1. repetirlo y 2. tomar el cultivo por sonda (requiere 10.000 UFC/mm³) o por punción (basta 1 UFC). Una vez que se confirme el diagnóstico recién estaría indicado tratar (B o C sirven) y posteriormente estudiar con la ecografía (toda ITU en pediatría se estudia).

84 E Tanto por las queratosis actínicas (pre malignas, que evolucionan a cáncer espinocelular) como por la imagen, tiene un cáncer espinocelular.

85 B Tiene una tetraparesia flácida y arrefléctica, por lo que tiene un síndrome de Guillain Barré. Es clásica la paresia facial bilateral y puede tener afectación de los oculomotores (aunque ello es más probable en una miastenia gravis, cuya clínica, de todos modos, es distinta a la presentada).

86 B Tiene una uretritis y cervicitis gonocócica (cultivo de Thayer Martin positivo) y, por tanto, se debe tratar con ceftriaxona de elección. La azitromicina y el ciprofloxacino también sirven, pero sigue siendo de elección la ceftriaxona. Es cierto que también se debe cubrir Chlamydia, por lo que la única respuesta que cubre todo es la azitromicina, pero se debe simplificar el enfrentamiento de esta pregunta, en que específicamente se pregunta el tratamiento de la gonorrea y, por ello, la respuesta es la B.

87 C Tiene un hipogonadismo, secundario a la histerectomía radical, en que se extirpan los ovarios, por lo que requiere TRH, para manejar sus síntomas vasomotores y genitales (atrofia). Por estar histerectomizada solo se dejan estrógenos, sin progestágenos (sí hay que dejarlos si hay útero). Por tener dislipidemia, debe evitarse la vía oral y sirven más los parches. La venlafaxina se usa como tratamiento de los síntomas vasomotores cuando están contraindicados los estrógenos, pero no sirve para la atrofia genital.

88 D Tiene un T. de somatización clásico. Por no tener ánimo ganancial, no es facticio.

89 D PP negativa descarta anovulación (A); PE+P negativa confirma hipogonadismo; FSH y LH muy bajas muestran que es hipogonadotrópico y, por tanto, hipotalámico o hipofisiario. La B sería hipergonadotrópico. La C sería uterino, por lo que sus exámenes hormonales serían todos normales y tanto la PP como la PE+P estarían negativas.

90 B La dispepsia probablemente es de tipo funcional. La única alteración de las pruebas hepáticas es una hiperbilirrubinemia, de predominio indirecto, por lo que es un Sd. de Gilbert. Las colestasias tendrían elevación de la GGT, FA y bilirrubina directa (A, C y E), la hepatitis tendría elevación de la GOT y GPT (D).

SEGUNDA PARTE

91 A Es un cáncer gástrico clásico. El episodio de melena da cuenta de una HDA. La úlcera habría tenido dolor urente, sin baja de peso, aunque sí podría tener melena. El cáncer de esófago tendría disfagia, más que inapetencia, aunque sí podría tener baja de peso.

92 D Es un caso clásico de tos, como efecto adverso de los IECAs. Se deben suspender y reemplazar por un ARA2 (ej. losartán).

93 E Tiene un AVE diagnosticado (se diagnostica con la clínica de signos focales de inicio súbito). La TAC se pide solo para diferenciar los AVE hemorrágicos, de los isquémicos y, en este caso, por estar normal la TAC se confirma que no es hemorrágico, sino isquémico. Por tener menos de 4,5 horas de evolución, está dentro de la ventana de trombolíticos, que es lo más urgente (rTPA ev).

94 E Todo testículo agudo se explora. En este caso, por la edad (adolescente o adulto) y por la clínica, se sospecha una torsión testicular.

95 E Es una pregunta difícil, pero la glicemia de ayuno está en 117, es decir, tiene una glicemia de ayuno alterada (GGA). La glicemia poscarga está normal (menor a 140), por lo que no tiene intolerancia a la glucosa (IGO) ni diabetes (DM). La prediabetes se define como GAA, IGO o GAA + IGO, sin criterios de DM.

96 A La rubéola congénita se caracteriza por todo lo que tiene el caso: cardiopatía congénita, catarata congénita, microcefalia y, además, suele ser pequeño para la edad gestacional (PEG). El CMV y el toxoplasma suelen presentar microcefalia, calcificaciones cerebrales, hipotonía y ser PEG. El PVB19 en el embarazo produce abortos o hídrops fetal.

97 B Es una pregunta difícil, por la redacción, que no permite diferenciar entre una procidencia de cordón y una rotura de vasa previa (ambas tienen sufrimiento fetal, tras la rotura de membranas, pero la rotura de vasa previa tiene metrorragia y, en este caso, solo se dice líquido hemático, lo que orienta más a rotura de vasa previa). De todos modos, el tratamiento en ambas es la interrupción inmediata, por la vía más expedita y aquella se determina con el tacto vaginal (sin embargo, en este caso, se indica que ya tenía 5 cm, por lo que la vía más expedita es la cesárea). En el caso de la procidencia de cordón, el TV, además, podría ayudar a descomprimir el cordón, mientras se organiza el equipo para la cesárea de urgencia (esto hace pensar que realmente se quería preguntar una procidencia de cordón, ya que es la única opción aceptable).

98 B La primera parte es compatible con A, B y C. Sin embargo, las lesiones cutáneas descritas son una dermatitis herpetiforme, que se asocia a la enfermedad celíaca. En cambio, las EII (A y C) se asocian a eritema nodoso y pioderma gangrenoso, como manifestaciones cutáneas.

99 A Tiene una metrorragia grave, anemizante. Por ello, se debe legar para detener la hemorragia. Lo mismo aplica a las metrorragias graves, asociadas a compromiso hemodinámico. Los estrógenos sí se usan en las metrorragias disfuncionales, pero si es que no tienen ni anemia severa ni compromiso hemodinámico.

100 C Es una meningoencefalitis herpética clásica, con la clínica de compromiso de conciencia (o convulsiones) y la clásica afectación de los lóbulos temporales. La punción sugiere infección viral (glucosa normal: sobre 40; y pleocitosis mononuclear), aunque le falta la presencia de glóbulos rojos, característica del herpes.

101 B Es una estenosis aórtica clásica, probablemente congénita. Deben revisar el resumen de semiología cardíaca completo y aprendérselo hoy de una vez por todas. Insisto: hoy. El pulso débil y de ascenso lento (*parvus et tardus*) hace que sea una estenosis aórtica y no una MCPHT, que tiene pulso amplio o Cellier.

102 C Tiene una insuficiencia suprarrenal primaria clásica, probablemente secundaria a tuberculosis suprarrenal (segunda causa, después de la autoinmune). Tiene la hiperpigmentación, la hipotensión, la hipoNa⁺ y la hiperK⁺ clásicas.

103 B El diagnóstico es una agorafobia. Se trata con antidepresivos IRS, al igual que todos los trastornos ansiosos crónicos de importancia. En el embarazo se pueden usar la sertralina, la fluoxetina y el citalopram. Las benzodiacepinas se intentan evitar en el embarazo, pero si tuviese síntomas demasiado intensos, se podría dejar una dosis bajas de alprazolam.

104 D Es una pregunta difícil, pero el cuadro solo es compatible con una esclerosis múltiple ya que ha tenido múltiples signos focales, de inicio subagudo, que pueden recuperarse (como el trastorno del equilibrio). Revisar el resumen de semiología neurológica.

105 D Tiene una neumonía, en contexto de EPOC. En el cuadro clínico no queda del todo claro que requiera hospitalizarse, como para recibir cefotaximo o ceftriaxona (misma cobertura) o si solo requiere tratamiento ambulatorio (con amoxicilina clavulánico, dado que el antecedente de EPOC obliga a cubrir *Haemophilus influenzae*, lo que también se podría lograr con macrólidos). El apremio respiratorio hace que probablemente la respuesta correcta sea cefotaximo. Además, la B y E son equivalentes, por lo que podemos asumir que no eran la respuesta esperada por quien redactó la pregunta.

106 D Tiene un síndrome riñón-pulmón, con una alveolitis hemorrágica y una GNRP, que, por la edad, corresponde probablemente a una PAM (poliangeítis microscópica), que es una vasculitis primaria muy agresiva, clásica de los adultos mayores y que se presenta con esta clínica, más mononeuritis múltiple, rash y fiebre, además de síntomas inespecíficos, como malestar y artralgias. Es muy grave y requiere de corticoides e inmunosupresores.

107 A Orienta a etiología bacteriana: 1. el dolor intenso, 2. el exudado característico, 3. las adenopatías, 4. la fiebre alta, 5. la edad (3 a 15 años) y la ausencia de sintomatología catarral. La congestión nasal suele orientar más a etiología viral, pero se describe como "escasa". Con ello, cumple 4 o 5 criterios para iniciar antibióticos (amoxicilina de elección). Con 0 o 1, se asume viral; con 2 o 3 se pide cultivo o test rápido; con 4+ se trata como bacteriana.

108 B Es una pregunta difícil y discutible, pero se resumen en "¿Cuál es el examen de elección ante la sospecha de hipoacusia congénita?" y la respuesta es potenciales evocados auditivos. Las emisiones otoacústicas son una opción más barata, como screening en los pacientes asintomáticos, pero si hay una sospecha, lo ideal es pedir potenciales evocados. Eso sí, a los 4 años es posible que el paciente ya coopere en la audiometría, por lo que técnicamente es una mala pregunta.

109 E El estudio de la infertilidad siempre es de la pareja y no importa si tienen hijos de antes. El hombre solo se estudia con espermiograma. La mujer se estudia con exámenes por etapas: la primera línea es el seguimiento folicular con ecografías seriadas y exámenes hormonales; de segunda línea se pide la histerosalpingografía (busca alteraciones tubepéritoneales); de tercera línea se hace la laparoscopia exploradora, en busca de endometriosis.

110 B Casos y controles sirve más que los estudios de cohortes en 1. enfermedades raras, 2. enfermedades que demoran mucho tiempo en aparecer, 3. casos en que hay déficit de presupuesto (son más baratos).

- 111 D De las opciones, el quiste del conducto tirogloso es la única que tiene ubicación en la línea media (aunque con esa redacción no queda claro si la localización submentoniana es central o lateral) y que, además, tiene ese perfil temporal (5 años, que ahora se complicó).
- 112 B Es una pregunta muy complicada, ya que en el cuadro agudo actual (podagra) se debe indicar AINEs de elección y, si no está en las opciones, pues se indica la colchicina. Además, el hecho de que haya tenido más crisis en el último año (1 o más en un año) obliga a iniciar alopurinol, aunque no es posible iniciarlo ahora en agudo, mientras está con la podagra, sino que se debe esperar a que se resuelva, razón por la cual la respuesta es colchicina.
- 113 A Tanto por los antecedentes de autoinmunidad, como por el mal control metabólico con altas dosis de HGO, se trata de una diabetes LADA (autoinmune del adulto). Además, tiene un síndrome poliglandular (reacción autoinmune contra múltiples glándulas).
- 114 A Tiene una invaginación intestinal clásica, con la confirmación ecográfica (imagen en dona, en tiro al blanco o en herradura), la que se trata con desinvaginación neumática y solo se opera si falla o si se complica con perforación.
- 115 D Esta es una pregunta que se ha repetido en múltiples ocasiones, con distintos enunciados y que se resumen en: "paciente con ascitis que le pasa cualquier cosa (ej. dolor, fiebre, desorientación, compromiso hemodinámico, HDA, etc.), lo primero a hacer es puncionarlo, para descartar PBE. Por tanto, la respuesta es el recuento de polimorfonucleares en la paracentesis diagnóstica (si es más de 250 por mm³ se confirma la PBE y se inicia cefotaximo ev más albúmina, prohibiendo la evacuación de la ascitis).
- 116 D Si bien la LDH está menor a 180, el colesterol está mayor a 40, por lo que es un exudado (esa era la parte difícil). Además, es de predominio mononuclear, con ADA baja, por lo que probablemente es un cáncer. La A es un transudado. La B y E son exudados MN, pero tienen ADA alta (mayor a 50 o al menos mayor a 30). La C es un exudado PMN, con ADA alta también.
- 117 D La sospecha es un mieloma múltiple (se diagnostica con biopsia de médula ósea, aunque es suficiente el mielograma): anemia, disminución de las plaquetas, IRC, hipercalcemia, hiperproteinemia con hipoalbuminemia y el dolor óseo. Por si acaso, dolor epicrítico es lo mismo que dolor somático (ej. cuando alguien se quiebra un hueso), en contraposición al dolor visceral o neuropático.
- 118 B Tiene una bradicardia fetal mantenida (mayor a 10 minutos), por lo que se debe interrumpir inmediatamente por la vía más expedita. En este caso, la vía más expedita es el fórceps, ya que cumple con todos los requisitos: cefálica, dilatación completa, espinas +2 y anestesia (aunque no se menciona, pero tampoco se puede hacer una cesárea sin anestesia).
- 119 C Pregunta muy discutible, ya que el manejo del hipoT4 subclínico en el embarazo es algo que no está zanjado en la discusión médica y que distintas guías entregan distintas recomendaciones, incluyendo las guías Minsal, que son contradictorias entre sí. Sin embargo, la recomendación es la siguiente: 1. El objetivo de TSH en el embarazo es de 0,4 a 2,5 UI/L y 2. hay que tratar el hipoT4 subclínico en el embarazo.

120 E Es una pregunta discutible, sin embargo, la radiografía muestra únicamente un derrame pleural izquierdo y, por tanto, se debe puncionar y estudiar. Además, queda la duda si se trata de un derrame tuberculoso o de otra causa, ya que respondió parcialmente a la amoxicilina y tiene una clínica aguda, sugerente de neumonía bacteriana, por lo que podría ser paraneumónico. Finalmente, el manejo de los contactos de tuberculosis, se hace apenas se diagnostica el caso y no cuando ya está en la fase bisemanal, en que ya no contagia (además que el estudio de los contactos es con BK y RxTx).

121 E Es una pitiriasis rosada de Gibert clásica, con la mancha heráldica y la posterior aparición del exantema rosado y descamativo. Puede o no tener prurito.

122 B Es una mononucleosis clásica, dado que tiene el síndrome mononucleósico (odinofagia, fiebre y adenopatías), más el clásico rash morbiliforme (similar al sarampión), que aparece luego de iniciar aminopenicilinas (ampicilina o amoxicilina). También es clásico el exudado amigdalino blanco y adherente sobre la superficie amigdalina. La escarlatina tendría clínica de amigdalitis bacteriana (ya explicada en otra pregunta) y un exantema en piel de gallina, con especial afectación de pliegues cubitales y que respeta el triángulo de Filatov. La enfermedad de Kawasaki no suele tener odinofagia ni exudado amigdalino, sino fiebre, adenopatías, ojo rojo, boca roja, rash de cualquier tipo (salvo vesicular o pustular) y compromiso de pies y manos.

123 C Tiene un RCIU leve (p5 a p9), con un ILA normal para la edad gestacional (OHA se define como ILA menor a 8 o menor a 5 si es de término; por tanto, no hay OHA en este caso). Sea como sea, todo RCIU siempre debe estudiarse con un doppler materno-fetal, ya que si todo está bien, puede ser PEG y se puede esperar a las 40 semanas y nacer por vía vaginal; si está alterado el doppler, se debe interrumpir por cesárea (por tener ya 37 semanas). Revisar manejo y edades de interrupción del RCIU

124 D Se calculó el NNT, que en este caso es de 20. Sin embargo, lo preguntado es qué tipo de estudio es y por tratarse de una "intervención", se asume que es un estudio experimental, es decir, un ensayo clínico.

125 B Tiene un traumatismo renal (golpe lumbar más hematuria), que se estudia con el Uro TAC. No confundir con la lesión uretral (golpe pélvico más uretrorragia), que se estudia con la UCG.

126 D La historia es compatible con un síndrome de Sjögren (tiene el síndrome de Sicca: xeroftalmia y xerostomía). El 90% tiene FR positivo. Además, es frecuente que tengan positivos los ANA, con un perfil ENA que muestra anticuerpos anti-Ro o anti-La positivos. Se confirma la biopsia de glándula salival menor o con los anticuerpos anti-Ro o anti-La, aunque actualmente el diagnóstico se realiza en base a una serie de criterios clínicos y de laboratorio, que no vale la pena aprenderse.

127 B En los mayores de 75 años, el objetivo de la TSH es 3 a 6 UI/L, por lo que está bien y el objetivo de la HbA1c es menor a 8%, por lo que está sobretratado y no hay problema en suspender la glibenclamida, en especial, tomando en cuenta el riesgo de hipoglicemia. Los demás fármacos no están especialmente contraindicados.

128 A Toda RPM mayor a 34 semanas se debe interrumpir. Si no tiene contraindicación del parto vaginal, se induce; si tiene contraindicación, se hace una cesárea. En

cambio, las menores a 34 semanas se maduran con corticoides, se les da antibióticos y se interrumpen al cumplir 34 semanas, desarrollar una corioamnionitis clínica o comprobarse madurez fetal en la amniocentesis (la que se hace si hay sospecha de infección, sin cumplir criterios de corioamnionitis).

129 B El tratamiento de elección de la depresión es con antidepresivos IRS, dentro de los que está el escitalopram. A y C son antidepresivos duales, que sirven como tratamiento de segunda línea. D y E son antidepresivos tricíclicos, que actualmente ya no se usan para el manejo de la depresión, por sus múltiples efectos adversos, sino que se usan como moduladores del dolor, en enfermedades dolorosas crónicas o neuropáticas.

130 E Debe tratarse por cualquier de las dos siguientes razones: 1. Todo VDRL positivo en el embarazo se trata, incluso antes de confirmarse con las pruebas treponémicas. 2. Alguien que ya tuvo sífilis mantendrá siempre positivas las pruebas treponémicas (FTA-ABS o MHA-TP), por lo que basta que vuelvan a positivizar las pruebas no treponémicas (VDRL o RPR) para indicar tratamiento.

131 D Es un PTT clásico (pregunta difícil), que se caracteriza por 1. trombopenia, 2. anemia hemolítica (LDH alta y esquistocitos, junto a la hiperbilirrubinemia indirecta), 3. falla renal (creatinina elevada, HTA) y 4. compromiso nervioso tanto central (convulsiones, compromiso de conciencia) como periférico (parestesias migratorias). El síndrome de Evans es una anemia hemolítica autoinmune, asociada a trombopenia autoinmune (pero le sobra la falla renal). El lupus sí puede verse así exactamente, pero es un hombre y, lo más importante, es un PTT clásico.

132 B Es una aspergilosis pulmonar clásica. Previamente se había preguntado, con la radiografía, que mostraba el aspergiloma clásico, que en este caso solo se describe. Suele elevar mucho la VHS y se ve tanto en pacientes inmunosuprimidos (como en este caso), como en pacientes con lesiones bronquiales (bronquiectasias o cavernas tuberculosas).

133 A Tiene una parálisis cerebral de tipo espástica. En este caso, la prematuridad probablemente fue la causa. No alcanza a tener una microcefalia (-3 DS), pero se sugiere daño cerebral. La diplejía espástica suele ser un tipo de parálisis cerebral, pero solo afecta las extremidades inferiores (no las 4). La polineuropatía periférica no tendría espasticidad (sino hipotonía), ni sialorrea, ni disminución del tamaño cefálico. La distrofia muscular solo tiene debilidad muscular progresiva, con hipertrofia de los músculos.

134 A El diagnóstico es una amigdalitis aguda (se hace con la clínica). Por tener más de 7 días y estar muy sintomática, se puede presumir que es bacteriana, por lo que está indicado tratar con antibióticos, de elección, amoxicilina.

135 C La presencia de células endometriales en el PAP se maneja igual que la presencia de menstruación. Por tanto, si es una mujer en edad fértil, se considera algo normal. En cambio, si es en una mujer postmenopáusica, se debe estudiar con una ecografía TV y, eventualmente, biopsiar el endometrio si tiene más de 5 mm o más de 8 mm, en caso de que use TRH.

136 E Tiene una colestasia clínica (prurito palmoplantar mayor en la noche) y de laboratorio (elevación de la GGT, FA y bilirrubina). Por la edad y por ser mujer, lo más probable es que sea una cirrosis biliar primaria (CBP), por lo que se estudia con los AMA (anticuerpos

antimitocondriales) y luego se confirma con la biopsia hepática (se trata con ácido ursodeoxicólico, que ayuda a disminuir los síntomas). La clínica más frecuente de la CBP es con marcada astenia y eventualmente prurito e ictericia. La CIE (colestasia intrahepática del embarazo) tiene la misma clínica, solo que en el embarazo y se resuelve con el parto.

137 A Es una CIA clásica. Insisto, de verdad hay que aprenderse el resumen de semiología cardíaca.

138 C Es un clásico déficit de B12, con el compromiso neurológico y hematológico (pancitopenia, con VCM elevado). La LDH y la bilirrubina indirecta se elevan por la mielopoyesis inefectiva, al igual que en las anemias hemolíticas. Que el VCM sea mayor a 108 se conoce como anemia megaloblástica. Finalmente, la etiología más probable, en este caso, es una anemia perniciosa (enfermedad autoinmune contra las células parietales gástricas, que secretan el factor intrínseco, que permite la absorción de B12).

139 E Tiene un delirium o síndrome confusional agudo clásico (desorientación y compromiso de conciencia de inicio agudo), patología frecuente en el adulto mayor y que, en este caso, es secundario a la infección bacteriana. Las alucinaciones y el delirio son frecuentes y no por ello se trata de una esquizofrenia (cuadro crónico, que inicia en la adolescencia) o un trastorno delirante (delirio sistematizado de más de un mes, que, si dura más de 3 meses, se llama trastorno delirante crónico).

140 E Es una pregunta muy difícil y mal intencionada, ya que no queda claro si están preguntando un huevo anembrionado menor a 25 mm (que se observa y controla con una nueva ecografía en 7 a 14 días) o si es un embarazo heterotópico (es decir, uno normal y otro ectópico), con el embarazo ectópico complicado, caso en el cual habría que hacer una laparoscopia exploradora. Por tener dolor intenso, FC sobre 90 (igual normal en el embarazo), PA de 110/60 (normal también en el embarazo) y la lesión quística en el ovario derecho (que puede ser también el cuerpo lúteo, aunque suele ser sólido-quístico, lo que hace pensar que también pueda ser un embarazo ectópico), creemos que se está preguntando el embarazo heterotópico y se debe proceder a la laparoscopia exploradora, pero solo quien redactó la pregunta sabe realmente qué quería preguntar.

141 B Pregunta ultra específica, pero si alguien tiene máximo riesgo cardiovascular, por enfermedad coronaria (además de la diabetes), los hipoglicemiantes de elección para agregarle a la metformina son la empaglifozina y el liraglutide, es decir, los análogos de las incretinas. Si no lo sabían, pues ahora ya lo saben.

142 B El manejo actual de los contactos de TBC es solicitar radiografía, baciloscopías y consultar la presencia de síntomas. Además, se puede pedir el PPD (obligatorio en menores de 15 años): si está positivo y todo el resto normal, se deja profilaxis por 6 meses con isoniazida. Si las BK están positivas, se trata con los 4 ATB antiTBC (en el menor de 15 años, también si es que tiene la RxTx alterada).

143 D Es una disección aórtica clásica, debido al soplo diastólico de la insuficiencia aórtica. Se debe estudiar con angioTAC y, en este caso, por ser probablemente tipo A, se debe operar (ya que está afectando la válvula aórtica y, por ello, se puede asumir que disecó sobre la subclavia izquierda).

144 D Es la clásica infección por ADV, en este caso con una fiebre faringoconjuntival. Es importante hacer notar que es la causa más frecuente de amigdalitis exudativa en el menor de 3 años, así que, incluso si no hubiese tenido una conjuntivitis, seguiría siendo una infección por ADV.

145 C Es una pregunta muy discutible y que no tiene una respuesta clara. Tiene una insuficiencia renal, con hiperkalemia, hiponatremia y acidosis metabólica. De las complicaciones, la hiperkalemia es la más urgente de mejorar, por el riesgo de evolucionar a una pregunta muy discutible y, además, de manejo de especialista. Lo que se pregunta es una NTG, en específico un tumor del sitio de inserción placentaria (las más rara de todas y la que menos eleva la HCG, en comparación con las molas). La conducta debe incluir solicitar niveles de HCG en toda sospecha de HCG y, si está elevada, es prácticamente confirmatoria, sin embargo, el único examen que realmente confirma el diagnóstico se debe hacer con la biopsia, por lo que la C (biopsia de endometrio) es la respuesta correcta (más aún en el tumor del sitio de inserción placentario, en que la HCG es menos sensible).

146 C Los estudios experimentales (ej. ensayo clínico y estudio de intervención comunitaria) se caracterizan porque existe una intervención, que es lo mismo que decir que se controlan algunas variables independientes. Esto los diferencia de los estudios observacionales. Los test de hipótesis se usan en los estudios analíticos, en contraposición a los estudios descriptivos (es una clasificación distinta y hay estudios observacionales tanto analíticos como descriptivos, por ejemplo). La selección aleatorizada es algo recomendable para evitar el sesgo de selección, pero un estudio experimental no necesariamente funciona así. Lo mismo ocurre con el ciego, ya sea simple (del evaluado), doble (también del evaluador) o triple (además, del analista de datos), que sirve para evitar sesgos de medición, pero no todos los estudios experimentales los usan.

147 C Pregunta muy difícil, en especial porque es muy infrecuente la malaria por *P. falciparum* en América, incluyendo la Amazonía. Sin embargo, la presencia de anemia marcada hace que el diagnóstico sea malaria y no las demás opciones. La clínica es compatible también con el dengue. El virus Zika puede tener la misma clínica, pero suele ser menos intensa; a la fiebre amarilla le falta la ictericia; a la fiebre tifoidea le falta la diarrea.

148 B Tiene una HDA por várices esofágicas. De todas formas, independientemente de la causa de la hemorragia, toda HDA y HDB se manejan primeramente con reposición de la volemia EV, primeramente, con cristaloides (suero fisiológico o Ringer). La terlipresina sí está indicada, al igual que la EDA. El balón de Sengstaken se instala en lugares en que no hay EDA disponible, mientras se traslada a un centro de mayor complejidad.

149 A La base del tratamiento de todas las adicciones es la TCC. Además, en fumadores de menos de 15 cigarrillos al día suele ser la única intervención necesaria, ya que no suelen tener dependencia física a la nicotina. Sobre esa cantidad, a la TCC se le suele agregar sustitución con nicotina (si muchos síntomas de abstinencia) y bupropión o vareniclina (si mucho deseo de fumar).

150 B Es una pregunta muy discutible y que no tiene una respuesta clara. Tiene una insuficiencia renal, con hiperkalemia, hiponatremia y acidosis metabólica. De las complicaciones, la hiperkalemia es la más urgente de mejorar, por el riesgo de evolucionar a una arritmia maligna, pero, por lo general, el gluconato de calcio solo está indicado si hay

compromiso electrocardiográfico o si el potasio está sobre 7 mEq/L. La acidosis sí se debe tratar con bicarbonato de sodio, ya sea EV o VO, dependiendo del pH (en este caso no lo dan, pero por el nivel de bicarbonato parece candidato a EV). Las diálisis solo se indican si es que tiene un síndrome urémico o una complicación grave y refractaria al tratamiento médico. Como se pregunta la conducta inicial, en conjunto con varios especialistas, asumimos que la respuesta es el gluconato de calcio, para el manejo de la hiperkalemia, pero insistimos en que es una pregunta mala.

151 C La presencia de botón mamario es normal en los recién nacidos y suele durar unas pocas semanas, aunque es posible que persista, incluso hasta los 12 meses. Además, la respuesta suele ser "observar" en cualquier pregunta de pediatría que sea más o menos así: "un niño tiene una cosa rara que no tengo idea, pero todo lo demás está normal".

152 E Es una pregunta difícil, pero que ya se había realizado antes y se trata de un sarcoma de Ewing clásico, especialmente por la edad (menores de 15 años es lo más frecuente, aunque incluso se ve en adultos jóvenes) y por localización diafisaria. Eso sí, también podría ser un sarcoma de partes blandas (más frecuente desde los 15 años), pero la clara afectación ósea de la RMN y también de la Rx hace que la respuesta sea la E, sin dudarlo mucho.

153 C Tiene una lesión sospechosa, que actualmente es Birrads 4 a 5 (microcalcificaciones agrupadas y espiculadas). Si alguien leyó a la rápida, se quedó con la idea de que era Birrads 2, pero esa es la mamografía antigua. La forma de biopsiar suele ser aguja gruesa, si es que el nódulo mamario es palpable y por biopsia estereotáxica, cuando no lo es (como en este caso, que se describe que el examen mamario es normal).

154 A Tiene todos los elementos de anemia hemolítica: elevación de los reticulocitos (es regenerativa), hiperbilirrubinemia indirecta y el clásico dolor abdominal, cuya fisiopatología no está muy clara. El SHU sí tiene hemólisis, pero, además, plaquetopenia y falla renal o compromiso del SNC. El antecedente de ictericia neonatal no aporta mucho, ya que parece una anemia autoinmune (por el poco tiempo de evolución), aunque existan anemias hemolíticas de tipo genético (que son crónicas y sí podrían haberse asociado a ictericia neonatal).

155 B Es un trastorno conversivo típico: síntomas neurológicos de inicio rápido y sin una causa orgánica que los explique. En estricto rigor sí es un trastorno somatomorfo (D), ya que los trastornos conversivos son un tipo de trastornos somatomorfos, pero la B es más específica.

156 D Es un síndrome de Mallory Weiss clásico: hematemesis precedida de vómitos alimentarios. Se produce una laceración esofágica por los vómitos. No se debe confundir con el síndrome de Böerhave, que es una perforación esofágica secundaria a los vómitos y que se presenta como una mediastinitis aguda.

157 E Tiene una crisis de pánico, es decir solo un síntoma. Se pregunta el tratamiento de la crisis, que es con benzodiacepinas de rápida acción (lorazepam, clonazepam e incluso alprazolam, aunque el lorazepam es el más usado), generalmente por una vía de rápida absorción (sublingual, EV o IM). No se debe confundir la crisis de pánico con el trastorno de pánico, que tiene múltiples crisis de pánico, sin una causa evidente, asociado a miedo a las

crisis, evitación y angustia. El trastorno de angustia, en cambio, se trata con antidepresivos IRS, como fármaco más importante.

158 B El tratamiento del herpes zóster es con aciclovir 800 mg, 5 veces al día o con valaciclovir 1g c/8 horas, por un tiempo de 5 a 7 días. En cambio, los herpes simplex (genital o bucal) se tratan con la mitad de la dosis. Es muy raro que el Eunacom pregunte dosis de medicamentos, pero en esta pregunta era la única forma de elegir.

159 C La caminata en punta de pies puede tener múltiples causas, siendo normal en menores de 3 años, pero también asociándose a trastornos del espectro autista (se `pensaría si tuviese otras estereotipias, alteraciones del lenguaje o de la interacción social) y se asocia asimismo a parálisis cerebral con espasticidad. La diplegia espástica es una variante de ello, en que se afectan las extremidades inferiores. Tiene buen pronóstico con un adecuado tratamiento multidisciplinario. La distrofia muscular suele tener un desarrollo normal, pero luego va perdiendo fuerza, especialmente en los grupos musculares grandes, que, por ejemplo, le dificulta ponerse de pie, por lo que suele hacerlo con el apoyo de las manos.

160 E Tiene una clásica tiroiditis subaguda o tiroiditis de Quervain, que se trata con AINEs. Solo si es que tiene muchos síntomas hipertiroideos se agrega el propranolol. No están indicadas las drogas antitiroideas (metimazol o propiltiouracilo).

161 B Es un fibroadenoma clásico (joven con nódulo liso y móvil).

162 C Tiene toda la clínica de una úlcera perforada. De hecho, comienza con la clínica de una úlcera activa (epigastralgia urente que mejora con la ingesta) y luego el dolor intenso, con un íleo paralítico (distensión y RHA abolidos) por la peritonitis, más los signos de neumoperitoneo (pérdida de la matidez hepática).

163 D Las úlceras gástricas se erradican solo si tienen HP positivo (a menos que no haya consumo de AINEs y exista algo que genere falsos positivos, como el uso de antibióticos o de omeprazol) y se controlan con una EDA, de modo de descartar que haya un cáncer debajo. Las úlceras duodenales (este caso) se erradican siempre, ya sea con HP positivo o negativo y se controlan con pruebas no invasivas, como la detección de antígenos en heces. Por ello, la respuesta es erradicar.

164 C Es una LLC clásica: adulto mayor con leucocitosis, linfocitosis y suele tener anemia y trombopenia. Las sombras de Gumprecht también son características (no confundir con los bastones de Auer de la LMA). Su clínica suele ser ausente o inespecífica y al examen físico suelen haber adenopatías (también en la LLA y en los linfomas). Los linfomas suelen tener hemograma normal. La LMC tiene leucocitosis de predominio neutrofílico, con desviación izquierda y con trombocitosis y elevación de los eosinófilos, basófilos y monocitos; pero, luego se va "agudizando", a medida que avanza la enfermedad y va aumentando el número de blastos y disminuyendo el número de plaquetas y glóbulos rojos.

165 C Tiene un absceso pulmonar gigante. El manejo es discutible, pero la TAC podrá identificarlo mejor y descartar que haya un cáncer debajo. La broncoscopia también aparece como una opción aceptable, ya que permitiría el drenaje, pero la TAC igualmente debe solicitarse antes y, además, el tratamiento suele ser con clindamicina endovenosa, más drenaje postural, por lo que la broncoscopia solo se hace si falla.

166 E No queda claro la causa precisa de sus síntomas (tumor cerebral, meningitis tuberculosa, pseudotumor cerebral), pero sí tiene un síndrome de HTEC clásico, con 1. la cefalea de predominio matinal, 2. las náuseas y vómitos y 3. solo le falta el edema de papila. La migraña y la cefalea tensional suelen aumentar en las tardes y no en las mañanas.

167 A Pregunta difícil, ya que el manejo general del nódulo tiroideo es 1. solicitar TSH (y T4 libre), 2. solicitar ecografía tiroidea (puede ser simultáneamente con la TSH), 3. si tiene más de 10 mm, solicitar PAAF. Sin embargo, la excepción es cuando está hipertiroideo, en que se debe pedir una cintigrafía tiroidea: como en este caso que la TSH está baja y, por tanto, tiene un hipertiroidismo subclínico (con T4 normal). Si es un nódulo caliente (hipercaptante), se diagnostica el adenoma tóxico y se debe extirpar. Si es frío (capta igual o menos que el resto de la tiroides), se procede a la punción.

168 C Es una forma clásica de presentación de la anorexia, aunque no muestren todos los criterios (bajo peso, preocupación por el peso, alteración de la percepción corporal y amenorrea). Es frecuente que la paciente lo oculte, mienta o manipule a la familia, para que no la obliguen a subir de peso.

169 A Es una diverticulitis clásica: dolor en la FII, con signos peritoneales (resistencia muscular y RHA disminuidos).

170 D El sesgo de memoria es un tipo de sesgo de información o medida, que afecta al evaluado. Los errores de clasificación son aquellos...

171 C Es otra diverticulitis, que, aunque su diagnóstico es clínico, se estudia con TAC de abdomen y pelvis, de modo de definir el manejo (buscar abscesos y líquido libre). Recordemos que el tratamiento de la diverticulitis depende de la clasificación de Hinchey; Tipo I (solo edema o abscesos pericólicos menores a 5 cm): ATB orales; tipo II (absceso mayor a 5 cm o a distancia): ATB ev y drenaje por punción; tipo III (peritonitis difusa) y tipo IV (peritonitis estercorácea): cirugía de Hartmann. Si bien la colonoscopia sirve para el diagnóstico de la enfermedad diverticular no complicada y la para la HDB de origen diverticular, está absolutamente contraindicada en la diverticulitis aguda.

172 D La vacuna del rotavirus actualmente no está en el PNI, pero se puede indicar, de manera particular a los 2 y 4 meses. Es a virus vivo, se da vía oral y su beneficio es reducir las hospitalizaciones por rotavirus. Si bien sus efectos adversos más frecuentes son fiebre, irritabilidad y diarrea leve, su efecto más temido (por raro que sea) es la invaginación intestinal.

173 B Tiene una fibrilación auricular aguda y rápida. El soplo da cuenta de que de base probablemente tiene una valvulopatía y probablemente sí valga la pena anticoagularla (aunque por tener menos de 48 horas y no tener un ecocardiograma transesofágico, no es del todo claro). Tanto B, como C son respuestas correctas, ya que incluyen la anticoagulación, más algún fármaco que maneje ritmo o frecuencia. Conversando con varios especialistas, no están de acuerdo, pero tienden a dejar la B como una mejor respuesta, ya que 1. las heparinas de bajo peso molecular suelen ser más fáciles de usar, 2. está muy taquicárdica, así que lo más urgente es controlar la frecuencia y 3. les da miedo usar la amiodarona, por si tuviera un trombo, al menos hasta que se haga la ecocardiografía transesofágica y se descarte. Por no

tener compromiso hemodinámico, no está indicada la cardioversión eléctrica. La adenosina se usa en la TPSV. Los antiagregantes actualmente no están indicados en la FA.

174 C Tiene un PIP clásico, con la perihepatitis (síndrome de Fitz-Hugh-Curtis), que habitualmente es causado por *Chlamydia trachomatis* o por gonococo.

175 A Tiene hipercalcemia, con elevación de la PTH, así que se confirma el diagnóstico de un hiperparatiroidismo primario. El secundario tiene la calcemia baja o normal y suele ser por IRC. El terciario es igual al primario, pero en un paciente con IRC, que tenía uno secundario y luego empezó a tener hipercalcemia, en lugar de la hipocalcemia del secundario. La hipercalcemia maligna tiene PTH baja. La hipercalcemia primaria sí tiene litiasis, pero la PTH y la calcemia son normales. El hiperparatiroidismo primario tiene hipercalcemia secundaria y, por ello, se produce la litiasis también.

176 B Es una infección por *Candida albicans*, secundaria al uso de antibióticos, por tanto, se trata con fluconazol. Orientan a ello el prurito vaginal, la disuria y el compromiso de la horquilla. Eso sí, la ausencia de leucorrea inducía a la confusión, ya que habitualmente se pregunta con la infección más interna, con la leucorrea blanca grumosa clásica.

177 D Si bien cualquier arritmia se puede presentar así, el antecedente de un IAM previo orienta mucho a TV. Además, la TV suele ser más grave y letal que las demás, por lo que la necesidad de maniobras de reanimación orienta también a TV.

178 E Tiene una diarrea asociada a antibióticos (seguramente indicados para tratar la neumonía), por lo que se debe estudiar la presencia de *C. difficile* con PCR o con toxinas A y B en deposiciones. Si no están disponibles, se puede proceder a tratar con metronidazol oral.

179 E Es una pregunta discutible y la radiografía de este caso no es igual a la que apareció en el Eunacom. El tratamiento de la fractura de clavícula suele ser ortopédico y se basa actualmente en la inmovilización con un inmovilizador de hombro (un tipo de cabestrillo). Más antiguo, pero aún vigente es el vendaje en ocho. En el Eunacom real, la respuesta probablemente era el cabestrillo, a menos que se tratara de una pregunta muy antigua y repetida, que se haya quedado con el vendaje en 8. Sin embargo, en la imagen de la prueba que hicieron, hay un desplazamiento muy grande, mayor a 2 cm, por lo que se debe resolver con cirugía (en el Eunacom real probablemente la respuesta siempre será ortopédica y no se preguntará una excepción, como la de esta imagen, que insisto, era distinta a las del Eunacom real).

180 B Las pruebas hepáticas muestran una colestasia clara y la clínica también. La colestasia silente (sin dolor) o con escaso dolor suele ser por cáncer (cualquier a de los de las opciones). De todos modos, orienta a cáncer de vesícula el hecho de que sea mujer y, además, el antecedente de cólicos biliares (ya que la colelitiasis es el factor de riesgo más importante). El cáncer de cabeza de páncreas suele preguntarse en diabéticos o fumadores y suele mostrarse la dilatación del colédoco en la ecografía.

RECONSTRUCCIÓN EUNACOM DICIEMBRE 2019

Dr. Guillermo Guevara Aliaga

PRIMERA PARTE

En este examen se repitieron muchas preguntas de las versiones previas del Eunacom, dentro de las que estaban las más difíciles del examen. En total fueron al menos 80 preguntas repetidas.

Pregunta 0) ¿Cuál es el mejor curso para el Eunacom?

- a) El curso del Dr. Guevara
- b) El curso del Dr. Copión
- c) PlagiaMed
- d) Estudiar para el MIR y rezar que me vaya bien en el Eunacom
- e) Instagram, Facebook y Netflix

RC: A

Podemos decir con absoluta confianza de que nuestros cursos son los mejores y que nos esforzamos día a día para ello.

Les dejamos también el link de nuestra página web www.drguevara.cl donde podrán encontrar información sobre nuestros cursos y, también, material de estudio gratuito.

Dr. GUEVARA
WWW.DRGUEVARA.CL

¡INSCRIPCIONES ABIRTAS!

CURSO PRÁCTICO

INICIO: 10 DE ENERO

► Clic para más información

PRÁCTICAS: MEDICINA INTERNA - PEDIATRÍA - GINECOLOGÍA Y OBSTERICIA - CIRUGÍA

<http://www.drguevara.cl/curso-practico/>

www.drguevara.cl

Curso teórico para
Eunacom de julio 2020

¡Inscripciones abiertas!

- ✓ CURSO TEÓRICO ONLINE
- ✓ CURSO TEÓRICO SEMIPRESENCIAL

Dr. GUEVARA

Clic para más información

<http://www.drguevara.cl/cursos-y-precios/>



MedLaw

ASESORÍAS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA

CONTABILIDAD Y PLANIFICACIÓN SOCIETARIA

► CLIC PARA MÁS INFORMACIÓN

<http://medlaw.cl/>

1) Una paciente de 40 años, usuaria de anticonceptivos orales, consulta por cefalea holocránea, muy intensa, de 5 días de evolución, que se ha asociado a náuseas y vómitos alimentarios, mayores en la mañana, y que no ha respondido al uso de analgésicos orales. Hoy presentó una convulsión tónico-clónica. En su examen físico tiene sopor superficial paresia de las extremidades derechas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Migraña por anticonceptivos
- b) Infarto cerebral extenso
- c) Accidente vascular lacunar
- d) Epilepsia con parálisis de Todd
- e) Trombosis venosa cerebral

2) Un paciente de 58 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por disfonía de 3 semanas de evolución, asociada a ligera odinofagia. Al examen físico, además, se palpa una adenopatía submandibular, de consistencia aumentada. ¿Cuál es el examen más adecuada para proseguir el estudio?

- a) TAC de cuello
- b) TAC de tórax
- c) Ecografía de cuello
- d) Nasofibrolaringoscopia
- e) Endoscopia digestiva alta

3) Un paciente de 30 años, hipermetrope, consulta por cefalea intensa, en el lado derecho, asociado a náuseas, de intensidad 10/10. Al examen físico se observa ojo rojo profundo en el lado derecho, con pupila en midriasis fija y arreactiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Glaucoma agudo
- b) Trombosis de la vena central de la retina
- c) Cefalea cluster
- d) Celulitis orbitaria
- e) Accidente vascular encefálico

4) En gestión de salud, ¿cuál es la diferencia entre planificación y programación?

- a) La planificación se refiere a objetivos y recursos específicos, mientras que la programación es global
- b) La planificación es a largo plazo, mientras que la programación es anual
- c) La programación, a diferencia de la planificación, debe ser concordante con la misión y la visión de la institución
- d) La planificación se basa en lo determinado con la programación
- e) La planificación se relaciona a los costes y recursos de actividades concretas y la programación se relaciona con el presupuesto general del proyecto

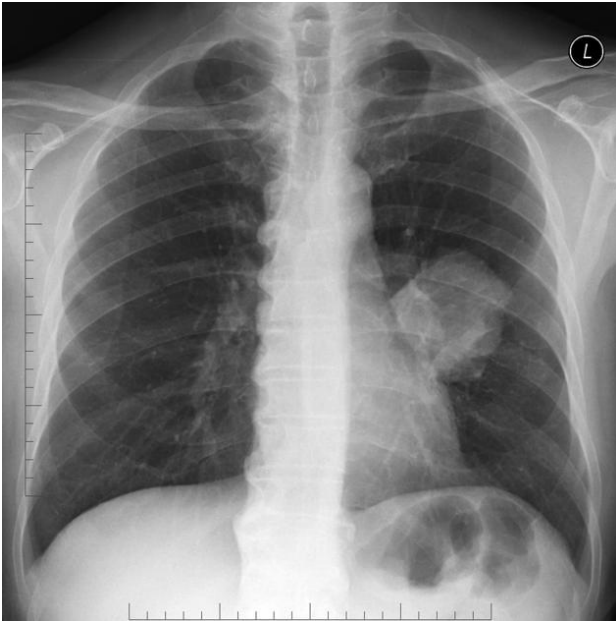
5) Un paciente de 26 años consulta por aparición de una lesión en los genitales. Tiene antecedente de relaciones sexuales de riesgo, con múltiples parejas sexuales. Al examen físico tiene una lesión ulcerada de 1 cm, en el glande, indolora, de aspecto limpio. Además, se palpan pequeñas adenopatías inguinales bilaterales, indoloras. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

- a) Tinción de Gram de la secreción de la lesión
- b) VDRL
- c) Reacción de polimerasa para *Chlamydia trachomatis*
- d) Reacción de polimerasa para virus herpes simplex
- e) Reacción de polimerasa para virus papiloma humano

6) Un paciente de 76 años, con antecedente de accidente vascular secuelado, hace 2 meses, se alimenta mediante gastrostomía, la cual fue realizada endoscópicamente. Accidentalmente se retiró la sonda. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar radiografía de abdomen simple
- b) Solicitar ecografía abdominal
- c) Solicitar TAC de abdomen
- d) Instalar una nueva sonda por el ostoma
- e) Realizar una nueva gastrostomía

7) Un paciente de 60 años, fumador de 40 paquetes años, consulta por disnea de 3 meses de evolución, asociado a tos con expectoración mucosa. Al examen físico tiene FC: 72x', PA: 110/70 mmHg, FR: 15x' y a la auscultación pulmonar se constatan escasos crépitos y algunas sibilancias, que son mayores en el campo pulmonar izquierdo. Se realiza una radiografía, que se muestra a continuación:



Fuente: radiopaedia.org

¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

- a) Biopsia pulmonar por fibrobroncoscopía
- b) TAC de tórax
- c) Fibrobroncoscopía con lavado bronquioalveolar
- d) Biopsias por videotoracoscopía
- e) Resonancia magnética nuclear de tórax

8) Un paciente de 25 años, esquizofrénico, recibe 5 mg de haloperidol intramuscular, por un cuadro de agitación psicomotora. A las dos horas presenta contracción tónica y dolorosa del cuello, con desviación hacia la derecha. ¿Cuál es el tratamiento de este cuadro?

- a) Bromocriptina
- b) Clorpromazina
- c) Lorazepam
- d) Diclofenaco
- e) Propanolol

9) Un paciente de 78 años, con patologías psiquiátricas en tratamiento con diazepam, sertralina y clorpromazina, presenta un cuadro de 24 horas de evolución de confusión y desorientación, asociado a náuseas, vómitos y sudoración. Al examen físico tiene taquicardia de 115x', hipertensión arterial de 170/110 mmHg, aumento del tono muscular, y sopor superficial. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome neuroléptico maligno
- b) Síndrome de discontinuación de antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
- c) Síndrome de privación de benzodiacepinas
- d) Síndrome serotoninérgico
- e) Síndrome anticolinérgico

10) Una paciente de 30 años, con antecedente de embarazo de 7 semanas de amenorrea, se realiza una ecografía transvaginal, que muestra útero con presencia de un huevo anembrionado de 18 mm, sin otras alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar laparoscopia
- b) Solicitar nueva ecografía en 7 días
- c) Solicitar niveles seriados de HCG
- d) Realizar legrado
- e) Solicitar curva de progesterona

11) Una paciente de 53 años, en tratamiento con tamoxifeno 20 mg/día, por un cáncer de mama, diagnosticado hace 9 años, presenta metrorragia desde hace 7 días, por lo que se solicita una ecografía transvaginal, que muestra un endometrio de 8 mm, sin alteraciones anexas. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar estrógenos orales
- b) Iniciar progestágenos orales
- c) Disminuir la dosis de tamoxifeno
- d) Solicitar biopsia endometrial
- e) Realizar histerectomía

12) Un paciente de 70 años, con antecedente de hipertensión, en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida, consulta por dolor torácico, EVA 9/10, irradiado a dorso, asociado a malestar general y sudoración. Al examen físico tiene FC: 110x', PA: 170/110 mmHg, examen pulmonar con crépitos escasos bibasales y examen cardíaco con choque de la punta no desplazado y auscultación con ritmo regular, en dos tiempos, con presencia de un soplo cardíaco diastólico aspirativo, de intensidad IV/VI, de ubicación paraesternal derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Neumotórax
- b) Aneurisma de la aorta ascendente
- c) Infarto miocárdico con rotura del músculo papilar
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Disección aórtica tipo A

13) Un paciente de 20 años inicia tratamiento con fluoxetina, por un cuadro de ansiedad social, evolucionando con aumento de la sociabilidad, volviéndose muy conversador, pero siendo en ocasiones muy intrusivo, al punto de ser desagradable. Muestra ausencia de empatía y ha tenido problemas con sus compañeros de estudios. Con frecuencia, se muestra irritable, ansioso y a veces emocionado, con llanto. Ha aumentado su nivel de actividad física y, además, presenta disminución de las horas de sueño, sin disminuir su nivel de energía. En ocasiones, presenta ganas de salir corriendo, sin saber por qué. Tiene antecedente de un episodio depresivo a los 16 años, que respondió al tratamiento con sertralina. El diagnóstico más probable es un trastorno:

- a) Bipolar
- b) Adaptativo mixto
- c) Por déficit atencional
- d) Esquizoafectivo
- e) Delirante

14) Una paciente de 34 años, diabética con control metabólico irregular, consulta por edema de las extremidades inferiores y orinas espumosas. Al examen físico se constata edema palpebral y facial, edema blando de extremidades inferiores. En sus exámenes destaca hemoglobina glicosilada de 8,2% y proteinuria cuantitativa de 9 g en 24 horas. ¿Cuál es la conducta de elección para proseguir el manejo de esta paciente?

- a) Electroforesis de proteínas en sangre
- b) Biopsia renal
- c) Inmunofijación de proteínas en orina
- d) Prednisona oral
- e) ANCA, C3 y C4

15) Un hombre de 34 años, que fue padre hace 2 meses, presenta imágenes recurrentes y desagradables, en las que él se ve asfixiando a su bebé con una almohada. Se siente muy angustiado y evita el contacto con su hijo, por miedo a hacerle daño. No ha querido contarle a su cónyuge, ya que se siente avergonzado y cree que se puede estar volviendo loco. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión psicótica
- b) Trastorno de estrés postraumático
- c) Trastorno adaptativo
- d) Trastorno obsesivo compulsivo
- e) Trastorno delirante

16) Una paciente de 45 años se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 0, por presencia de opacidades nodulares bilaterales, bien delimitadas. La conducta más adecuada es:

- a) Control mamográfico en 6 meses
- b) Ecografía mamaria
- c) Biopsia estereotáxica
- d) Biopsia quirúrgica
- e) Resonancia magnética nuclear de mama

17) Un lactante de 3 años presenta, desde hace 2 días, edema de extremidades inferiores, de la cara y de la zona escrotal, asociado a malestar general. Hace 4 días está con diarrea. Al examen físico se aprecia pálido, se constata el edema blando y se observan múltiples equimosis en las extremidades inferiores. Se solicitan exámenes que muestran creatinina: 3,0 mg/dl, BUN: 35 mg/dl, hemograma con hematocrito: 28%, plaquetas: 120.000, blancos: 11.000 por mm³, frotis con esquistocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome nefrótico
- b) Púrpura de Schönlein Henoch
- c) Insuficiencia renal prerrenal
- d) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
- e) Síndrome hemolítico urémico

18) Un paciente de 71 años presenta un cuadro de dos meses de adinamia, astenia y disnea de medianos esfuerzos, progresiva. Al examen físico se observa importante palidez de piel y mucosas, por lo que se piden exámenes entre los que destacan hematocrito: 23%, hemoglobina: 7,8 g/dl, VCM: 65 fl, plaquetas: 400.000 por mm³, blancos: 5.600 por mm³, frotis: microcitosis, hipocromía, poiquilocitosis y anisocitosis, transferrina: 460 ug/dl y ferremia: 24 ug/dl. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Solicitar biopsia de médula ósea
- b) Realizar estudio endoscópico del tubo digestivo
- c) Solicitar ferritina plasmática
- d) Solicitar test de sangre oculta en deposiciones
- e) Transfundir glóbulos rojos

19) Una paciente de 27 años hace 3 años se realiza una gastrectomía longitudinal y hace 6 meses se realiza una colecistectomía laparoscópica. Luego de eso ha presentado dolor epigástrico tipo cólico, intenso, intermitente, postprandial, que en ocasiones la despiertan en la madrugada. Su examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de vesícula
- b) Coledocolitiasis
- c) Úlcera péptica
- d) Obstrucción intestinal por bridas
- e) Síndrome de dumping

20) Una paciente de 24 años se realiza un PAP que es informado como probable lesión de bajo grado, por lo que se realiza una colposcopia, que muestra una neoplasia intraepitelial de bajo grado. La conducta más adecuada es:

- a) Controlar con PAP y colposcopia cada 6 meses
- b) Tratar con diatermocoagulación bipolar
- c) Tratar con crioterapia
- d) Realizar cono cervical con asa LEEP
- e) Realizar tratamiento con láser

21) Una paciente de 25 años, con antecedente de haber iniciado su vida sexual a los 14 años y, desde entonces, mantener relaciones sexuales, con múltiples parejas, sin utilización de métodos de barrera, se realiza un PAP que es informado como lesión de alto grado. Además, se realiza tipificación de virus papiloma humano, que muestra serotipo de bajo grado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar nuevo PAP en 6 meses
- b) Solicitar nuevo PAP en 6 años
- c) Realizar colposcopia y eventual biopsia
- d) Realizar conización cervical
- e) Realizar histerectomía

22) Un paciente de 28 años, fumador, consulta por aumento de volumen cervical. Al examen físico se palpa nódulo paratraqueal derecho, de 3 cm de diámetro y consistencia aumentada, que asciende con la deglución. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Quiste tirogloso
- b) Quiste branquial
- c) Cáncer de laringe
- d) Adenopatía metastásica
- e) Nódulo tiroideo

23) Un paciente de 32 años, con antecedente de madre con cáncer de tiroides, por lo que se realiza una ecografía cervical, que muestra un nódulo tiroideo de 7 mm de diámetro y aspecto quístico. Su TSH y T4 libre son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar punción aspiración con aguja fina
- b) Solicitar cintigrafía tiroidea
- c) Solicitar captación de yodo radiactivo
- d) Solicitar nueva ecografía en 6 meses
- e) Realizar tiroidectomía

24) Una paciente de 34 años, tiene un embarazo de 35 semanas, con feto creciendo en el percentil 2, desde la semana 33, con Doppler fetal normal, en ese entonces. Se solicita un nuevo Doppler fetal de control, que no muestra alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Inducir el parto
- b) Realizar cesárea
- c) Solicitar perfil biofísico
- d) Controlar semanalmente con el Doppler
- e) Interrumpir a las 37 semanas

25) Un niño de 5 años presenta un exantema pruriginoso, desde hace 4 días, generalizado y pleomorfo, consistente en máculas, pápulas, vesículas, que inició en el cuero cabelludo y luego se extendió al tronco y las extremidades. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Aciclovir
- b) Valaciclovir
- c) Prednisona
- d) Clorfenamina maleato
- e) Talco mentolado

26) Un niño de 3 años presenta lesiones pruriginosas en la nariz y la cara de 3 días de evolución. Al examen físico se aprecia lo siguiente:



¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Curaciones con suero fisiológico
- b) Curaciones con povidona yodada
- c) Aciclovir oral por 5 días
- d) Prednisona oral por 7 días
- e) Flucloxacilina por 7 días

27) Un paciente de 58 años, fumador de 10 paquetes año, consulta por disnea, asociada a tos y expectoración mucosa. Los síntomas aumentan especialmente en relación a la actividad física y cuando presenta infecciones respiratorias. En su examen físico se auscultan escasas sibilancias bilaterales y espiración prolongada.

Se solicita una espirometría que muestra:

	Basal		Postbroncodilatador	
CVF	5.928cc	100%	6.106cc	103%
VEF1	4.163cc	76%	5.040cc	92%
VEF1/CVF		65%		73%

Su radiografía de tórax se muestra a continuación:



El diagnóstico más probable es:

- a) Asma bronquial
- b) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- c) Bronquiectasias
- d) Bronquitis crónica
- e) Enfermedad pulmonar intersticial difusa

28) Un hombre de 40 años consulta por disnea de esfuerzos de algunos años de evolución, que aparece con medianos esfuerzos, asociada a palpitaciones ocasionales. Al examen físico tiene edema de extremidades inferiores, FC: 75x', PA: 120/80 mmHg, murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos bibasales y al examen cardíaco presenta un soplo sistólico de ubicación paraesternal, con segundo ruido desdoblado fijo. Se solicita un electrocardiograma, que muestra eje a +120°, fibrilación auricular, con un bloqueo completo de la rama derecha del haz de His. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Comunicación interauricular
- b) Ductus arteriosos persistente
- c) Comunicación interventricular
- d) Estenosis aórtica
- e) Estenosis mitral

29) Un recién nacido de 2 días de vida, presenta aumento de volumen parietal izquierdo, que deforma la cabeza, limitado a la zona parietal, que no sobrepasa la línea media. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la alteración descrita?

- a) Fistulización a la piel
- b) Osteomielitis
- c) Disección de cuero cabelludo
- d) Hiperbilirrubinemia
- e) Abscedación

30) Una paciente de 23 años, consulta por malestar general y sensación febril de una semana de evolución, asociado a artralgias y palpitaciones. Al examen físico destaca glándula tiroides del doble del tamaño normal, muy dolorosa a la palpación, frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto y presión arterial de 120/80 mm Hg. Se solicitan exámenes que muestran TSH: 0,01 UI/L (valor normal: 0,3-4,5 UI/L), T4L: 1,9 ng/mL (valor normal: 0,6-1,7 ng/mL), captación de yodo radioactivo de 2% (valor normal: 20% a 30%). ¿Cuál es el tratamiento de elección en esta paciente?

- a) Tiamazol
- b) AINEs
- c) Propiltiouracilo
- d) Bloqueadores beta
- e) Yodo radioactivo en dosis terapéutica

31) Una paciente de 42 años es traída por sus hijos, dado que ha dejado de salir de la casa o solo lo hace acompañada, por tiempo breve y con deseos de regresar pronto. Evita algunos lugares como los estacionamientos subterráneos y los ascensores, ya que le producen una sensación desagradable. Recientemente presentó mucha angustia al pasar por un túnel, en el que gritaba descontroladamente. Teme estar volviéndose loca y se muestra preocupada por su situación. Como antecedente, el cuadro comenzó luego de sospechar una infidelidad del marido. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno delirante
- b) Agorafobia
- c) Episodio psicótico
- d) Trastorno de angustia generalizada
- e) Trastorno de pánico

32) Un recién nacido de 20 días de vida, cuyo embarazo no fue controlado y que tiene antecedente de haber nacido por parto vaginal en su casa, es traído por presentar secreción ocular bilateral, desde hace 5 días. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival y escasa secreción bilateral. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) *Neisseria meningitidis*
- b) *Neisseria gonorrhoeae*
- c) *Streptococcus pneumoniae*
- d) *Streptococcus agalactiae*
- e) *Chlamydia trachomatis*

33) Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, consulta por disminución progresiva de la agudeza visual del ojo derecho. En su evaluación, tiene agudeza visual 20/20 en el ojo izquierdo y 15/20 en el ojo derecho. Su rojo pupilar demuestra una opacidad central con forma de estrella. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Retinopatía diabética
- b) Edema macular
- c) Catarata
- d) Glaucoma
- e) Hemorragia vítrea

34) Un paciente de 76 años consulta por dolor lumbar derecho intenso, EVA; 9/10, de 6 horas de evolución, irradiado al flanco ipsilateral y asociado a fiebre, vómitos, hematuria y agitación psicomotora. Al examen físico presenta FC: 100x', con ritmo cardíaco irregular, en dos tiempos, PA: 120/70 mmHg y puñopercusión positiva a derecha. En sus exámenes se aprecian 100 glóbulos rojos por campo y 20 glóbulos blancos por campo, en el sedimento de orina. Destaca, además, electrocardiograma con fibrilación auricular y creatinina plasmática de 2,3 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Quiste renal complicado
- b) Urolitiasis
- c) Pielonefritis aguda
- d) Obstrucción ureteral por coágulos
- e) Embolia renal

35) Se realiza un estudio de cohortes que busca establecer la asociación entre la exposición a estrógenos y el cáncer de ovario. Luego de analizar los datos, se obtiene que el Odds Ratio es 1,3 con intervalo de confianza al 95% con valores entre 0,86 y 2,1. Con estos resultados se puede afirmar que:

- a) Las mujeres expuestas a estrógeno tienen 1,3 veces más riesgo de presentar cáncer de ovario
- b) Las mujeres expuestas a estrógeno tienen 30% más de riesgo de presentar cáncer de ovario
- c) Existe una asociación entre el uso de estrógenos y el desarrollo de cáncer de ovario, pero no es significativa
- d) Las mujeres que tienen cáncer de ovario estuvieron expuestas a un 30% más de estrógeno
- e) Se prueba la asociación entre el uso de estrógenos y el desarrollo de cáncer de ovario, pero no es extrapolable

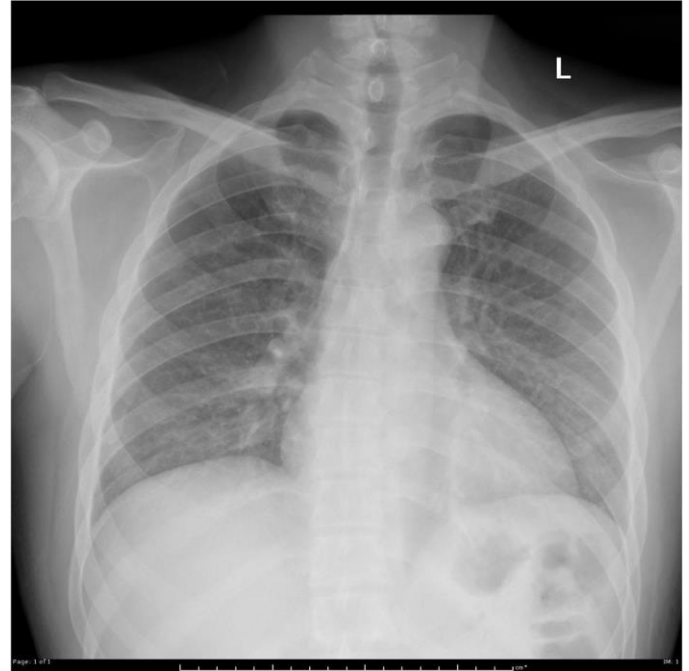
36) Una paciente de 53 años, en terapia de remplazo hormonal combinada oral, desde hace 6 meses, presenta metrorragia de 3 días de evolución, escasa. Su examen físico no tiene alteraciones y en la especuloscopia se aprecian restos de sangre en el orificio cervical externo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Atrofia endometrial
- b) Pólipo endometrial
- c) Hiperplasia endometrial
- d) Cáncer de endometrio
- e) Metrorragia disfuncional

37) Un paciente se hospitaliza hace 48 horas, por un traumatismo, secundario a un accidente de tránsito. Como antecedente, toma 1 botella de vino al día, sin llegar a la ebriedad. Al segundo día de ingreso presenta un cuadro de agitación psicomotora, desorientación temporoespacial, temblor y alucinaciones visuales zoomórficas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Haloperidol
- b) Lorazepam
- c) Risperidona
- d) Carbamacepina
- e) Tiamina

38) Un paciente de 34 años, consulta por cuadro de 5 semanas de tos irritativa y expectoración que ha ido empeorando, agregándose disnea de medianos esfuerzos. Al examen físico se aprecia enflaquecido, con frecuencia respiratoria de 27 por minuto, frecuencia cardíaca de 90 por minuto, presión arterial de 100/70 mmHg y saturación de 92% con FiO2 ambiental. Examen pulmonar muestra crepitaciones, estertores y algunas sibilancias bilaterales. Se solicita radiografía que se muestra a continuación:



El diagnóstico más probable es:

- a) Fibrosis pulmonar
- b) Asma bronquial
- c) Neumonitis viral
- d) Neumonía por mycoplasma
- e) Neumonía por *Pneumocystis jiroveci*

39) Una mujer de 18 años presenta traumatismo en la rodilla derecha, siendo diagnosticada de esguince de rodilla, el que se maneja con reposo y antiinflamatorios. Evoluciona con dolor persistente, por lo que consulta nuevamente. Se solicita una radiografía de rodilla que muestra reacción perióstica y compromiso de partes blandas. El diagnóstico más probable es:

- a) Osteomielitis del fémur distal
- b) Osteosarcoma osteogénico
- c) Fractura del fémur distal, con callo óseo
- d) Osteocondroma
- e) Hematoma calcificado

40) Un recién nacido de 3 semanas de vida es hospitalizado por presentar apneas. La madre refiere tos frecuente de 2 semanas de evolución, intensa, que en ocasiones la hacen vomitar. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado?

- a) Amoxicicilina
- b) Azitromicina
- c) Ceftriaxona
- d) Oseltamivir
- e) Aciclovir

41) Un niño de 16 años convulsiona al despertar, en la mañana siguiente de haber estado jugando videojuegos hasta tarde. Además, refiere mioclonías matinales frecuentes, desde hace algunos meses. Su examen físico es normal, al igual que su examen neurológico. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a) Suspender por completo los videojuegos
- b) Ácido valproico
- c) Carbamazepina
- d) Melatonina en la noche
- e) Diazepam si convulsiona nuevamente

42) ¿Cuál de las siguiente actividades o medidas de las garantías explícitas de salud (GES), está relacionado con la garantía de calidad?

- a) Autorización sanitaria de los prestadores de salud
- b) Acreditación de los prestadores de salud
- c) Vigilancia del cumplimiento de plazos
- d) Convenios entre ISAPRES y prestadores de salud
- e) Subsidio estatal

43) Un niño de 10 años presenta, desde hace algunas semanas, una lesión en la cara lateral del índice derecho, dolorosa. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada, hiperqueratósica, con puntos negros en su superficie, la que se muestra en la siguiente imagen:



Fuente: <https://www.dermrounds.com/>

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Molusco contagioso
- b) Melanoma
- c) Panadizo
- d) Verruga vulgar
- e) Cuerpo extraño periungueal

44) Una paciente de 30 años, acude a su primer control de un embarazo de 10 semanas. Sus partos anteriores fueron eutócicos, con recién nacidos de término de 4 kilogramos. Entre sus exámenes de control trae un Elisa VIH que resultó negativo, hematocrito de 38%, glicemia de ayuno de 112 mg/dL y urocultivo negativo. Su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
- b) Iniciar metformina oral
- c) Repetir glicemia de ayuno
- d) Repetir el urocultivo
- e) Mantener el control embarazo normal

45) Una paciente de 60 años presenta cefalea, astenia, debilidad muscular y calambres en extremidades inferiores. Al examen físico se observa obeso, con PA: 170/100 mmHg, FC: 70 lpm y en sus exámenes destaca Na: 150 mEq/L, K: 2.6 mEq/L, Cl:100 mEq/L y TSH: 4.0 UI/L. La causa más probable de la hipertensión es:

- a) Hipertensión renovascular
- b) Feocromocitoma
- c) Hipotiroidismo
- d) Hiperaldosteronismo primario
- e) Hipertensión esencial

46) ¿Cuál de las siguientes enfermedades corresponde con mayor probabilidad a una enfermedad laboral?

- a) Dermatitis de contacto alérgica
- b) Asma
- c) Mesotelioma
- d) Patología del manguito rotador
- e) Cáncer de piel

47) Si se mejorara el tratamiento de una enfermedad crónica, y se mantiene la incidencia, ¿qué pasará con la prevalencia?

- a) Aumenta
- b) No se modifica
- c) Disminuye
- d) No se puede determinar
- e) Depende de la enfermedad

48) Una mujer de 55 años se realiza una mamografía, como parte de un chequeo médico, que es informada como Birrads 4, por presencia de microcalcificaciones pleomorfas agrupadas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Ecografía mamaria
- b) Biopsia estereotáctica.
- c) Resonancia magnética
- d) Control mamográfico en 6 meses
- e) Biopsia excisional

49) Una paciente de 55 años, se realiza exámenes como parte de chequeo médico, que muestran GOT: 54 UI/L, GPT: 70 UI/L, GGT: 654 UI/L, FA: 455 UI/L, bilirrubina total: 1,0 mg/dl, albúmina: 3,7 g/dl y protrombinemia: 90%. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?

- a) Coledocolitiasis
- b) Cirrosis biliar primaria
- c) Colestasia por obstrucción neoplásica
- d) Colangitis esclerosante primaria
- e) Colangitis esclerosante secundaria

50) Mujer de 52 años presenta un cuadro de astenia, mialgias y artralgias generalizadas, con debilidad de las extremidades superiores. Refiere que despierta muy cansada, con dolores generalizados que limitan su actividad. Al examen físico presenta movilidad articular normal, con fuerzas conservadas, sin alteraciones sensitivas, ni artritis, pero con dolor a la palpación muscular en múltiples zonas. En sus exámenes presenta hemograma normal, VHS: 12 mm/h, PCR: 0,2 mg/dl, anticuerpos antinucleares positivos, en titulación 1/40, factor reumatoide: 26 UI/ml (VN: < 15 UI/mL) y anticuerpos anti-CCP: 13 UI/L (VN: < 8 UI/L). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar biopsia muscular
- b) Indicar pregabalina y ejercicios de estiramiento muscular
- c) Iniciar prednisona oral
- d) Solicitar perfil ENA (antígenos nucleares extractables)
- e) Iniciar metotrexato oral

51) Un paciente de 30 años presenta un cuadro de astenia y piel seca. Al examen se detecta un nódulo tiroideo, que se palpa de 15 mm de diámetro, en relación al lóbulo derecho. Se solicita TSH y T4 libre, que resultan normales. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de esta paciente?

- a) Ecografía cervical
- b) Biopsia citológica por punción con aguja fina
- c) Biopsia excisional
- d) Cintigrafía tiroidea
- e) Captación de yodo radiactivo

52) Una paciente de 56 años de edad presenta metrorragia abundante, que se maneja con legrado. Se envía a biopsia, que es informada, como hiperplasia endometrial compleja, sin atipías. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Controlar con ecografía en 6 meses
- b) Solicitar resonancia magnética nuclear de pelvis
- c) Iniciar progestágenos orales
- d) Realizar histerectomía total
- e) Iniciar estrógenos orales

53) Una paciente de 65 años consulta por disfagia ilógica, asociada a halitosis de reciente comienzo y regurgitación de alimentos recién ingeridos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Estenosis péptica del esófago distal
- b) Divertículo de Zenker
- c) Cáncer de esófago cervical
- d) Cáncer de faringe
- e) Acalasia esofágica

54) Un paciente de 32 años, presenta una trombosis venosa profunda femoropoplítea. Como antecedente, su abuelo falleció a los 85 años, por un accidente vascular encefálico y su padre tuvo un infarto agudo al miocardio a los 60 años. En sus exámenes destacan plaquetas: 140.000 por mm³, TTPA prolongado y VDRL (+). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Déficit de antitrombina III
- b) Déficit de factor VIII
- c) Síndrome antifosfolípidos
- d) Púrpura trombocitopénica trombótica
- e) Enfermedad de Von Willebrand

55) Un paciente de 18 años consulta por dolor y aumento de volumen en la pantorrilla izquierda, en relación a un pequeño traumatismo. Se solicita un estudio Doppler de las extremidades inferiores, que muestra alteraciones del drenaje venoso profundo de la zona. En sus exámenes, se constata hematocrito: 38%, hemoglobina: 12,8 g/dl, plaquetas: 145.000 por mm³, blancos: 8.000 por mm³, TTPA 54 segundos, protrombina: 85%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Déficit de antitrombina III
- b) Hemofilia A
- c) Trombofilia por anticoagulante lúpico
- d) Hemofilia B
- e) Enfermedad de Von Willebrand

56) Un paciente de 58 años, diabético tipo 2 de larga data, mal controlado, consulta por dolor en las extremidades inferiores, de tipo urente y que es más intenso en la noche. Al examen físico se aprecia ausencia de la sensibilidad de las extremidades con el uso de monofilamento e importante disminución de los pulsos pedios. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?

- a) Estudio Doppler vascular de extremidades inferiores
- b) Electromiografía
- c) Resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra
- d) Angiografía aortofemoral
- e) Pletismografía de volumen del pulso de extremidades inferiores

57) Un paciente esquizofrénico, recién diagnosticado, inicia tratamiento con risperidona 3 mg/día hace 5 días. Al tercer día, inicia un cuadro de disestesias en las extremidades inferiores, asociadas a angustia, inquietud y cambio continuo de posición. Se muestra muy incómodo y angustiado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome neuroléptico maligno
- b) Distonía aguda
- c) Disquinesia aguda
- d) Acatisia
- e) Hipomanía

58) Un paciente, con antecedente de rinitis alérgica, presenta obstrucción nasal marcada, asociada varios episodios de sinusitis en el último tiempo. Respira por la boca, por la obstrucción nasal. En la rinoscopía anterior, se visualizan numerosos pólipos en la mucosa, de aspecto pálido y brillante, que obstruyen completamente las fosas nasales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar fluticasona tópica c/12 horas
- b) Iniciar prednisona oral 1 mg/Kg/día por 7 días
- c) Solicitar TAC de cavidades paranasales
- d) Realizar cirugía endoscópica nasal
- e) Solicitar niveles plasmáticos de inmunoglobulinas

59) Una mujer de 18 años sufrió un rapto al salir de la oficina, por dos desconocidos. Es encontrada por terceras personas en un sitio eriazo, con evidentes signos de haber sido abusada sexualmente, sin lesiones físicas. Fue trasladada al Servicio Médico Legal, donde se constató la violación. Sin embargo, ella no recuerda nada de lo sucedido, recordando solo cuando fue abordada por los desconocidos y luego cuando estaba en el Servicio Médico Legal. Ella se muestra muy preocupada, pero no logra recordar nada de lo que aconteció entremedio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno conversivo
- b) Trastorno de estrés postraumático
- c) Trastorno facticio
- d) Trastorno adaptativo
- e) Trastorno disociativo

60) Un recién nacido de 18 horas de vida, desarrolla ictericia hasta los muslos. Se solicitan niveles plasmáticos de bilirrubina que resulta 15,3 mg/dl, con fracción indirecta de 15 mg/dl. La madre es O-IV Rh positiva y el niño es B-I Rh negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico
- b) Ictericia hemolítica por incompatibilidad Rh
- c) Ictericia fisiológica
- d) Hepatitis neonatal
- e) Síndrome de Gilbert

61) Un niño de 5 semanas de vida presenta ictericia, que inició hace una semana. Se alimenta con lactancia materna exclusiva y no ha tenido otros síntomas. Se solicitan exámenes que muestran una bilirrubina total de 4,3 mg/dl y una bilirrubina directa de 3,6 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Ictericia por lactancia materna
- b) Síndrome de Gilbert
- c) Atresia primaria de las vías biliares
- d) Hipotiroidismo congénito
- e) Hepatitis neonatal

62) Una mujer de 35 años desea embarazarse. Como antecedentes tiene hipertensión, resistencia a la insulina, hipotiroidismo y depresión. Está en tratamiento con enalapril, levotiroxina, sertralina y metformina, a lo que agregó ácido fólico 1 mg/día. ¿Cuál es el consejo preconcepcional más adecuado?

- a) Disminuir la dosis de metformina
- b) Aumentar la dosis de levotiroxina
- c) Cambiar el enalapril por otro antihipertensivo
- d) Suspender la sertralina
- e) Aumentar la dosis de ácido fólico a 4 mg/día

63) Una paciente de 32 años, primigesta, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta por metrorragia escasa. Su examen físico muestra PA: 120/70 mmHg, FC: 86x' y la especuloscopia se ven cuello cerrado, sin metrorragia actual. El monitoreo fetal no estresante resulta reactivo, con FCF basal de 144 lpm ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar betametasona 12 mg/día IM por dos veces
- b) Inducir el parto con misoprostol
- c) Realizar cesárea
- d) Solicitar una ecografía obstétrica
- e) Realizar un tacto vaginal

64) Una paciente de 21 años presenta rinorrea, congestión nasal, disnea, tos, con expectoración mucosa y sibilancias, que aparecen luego de realizar ejercicio y durante las infecciones respiratorias, siendo mayores en primavera. Su examen físico tiene frecuencia respiratoria 12x', frecuencia cardíaca 73x', PA: 120/70 mmHg, examen cardiopulmonar normal. Se solicitar un PEF, que resulta 580 L/min, que equivale al 100% del valor esperado. ¿Cuál de los siguientes es el examen más adecuado para proseguir con el estudio en esta paciente?

- a) Prick test
- b) TAC de tórax
- c) Espirometría basal y postbroncodilatador
- d) Prueba de eosinófilos nasales
- e) Prueba de provocación bronquial

65) Un paciente de 35 años, en situación de calle, con antecedente poliadicciones, presenta un cuadro de 2 meses de evolución de tos con expectoración mucosa y mucopurulenta, en ocasiones hemoptoica, asociada a malestar general, disnea de esfuerzos, baja de peso y sensación febril. Al examen físico, está enflaquecido con peso 52 Kg, pálido, con edema de extremidades inferiores, T°: 37,2°C, FC: 87x', PA: 90/60 mmHg, FR: 15x'. Su examen pulmonar muestra crépitos bilaterales. Su hemograma muestra hematocrito: 32%, hemoglobina: 10,6 g/dl, leucocitos: 15.000 por mm³, VHS: 50 mm/h, PCR: 120 mg/L y elisa VIH negativo. Se realiza una radiografía de tórax, que se muestra a continuación:



Fuente: www.radiopaedia.org

¿Cuál es el examen de elección para proseguir con el estudio?

- a) TAC de tórax
- b) Videotoracoscopia
- c) PPD
- d) Baciloscopías de expectoración
- e) Fibrobroncoscopia

66) Un hombre de 34 años presenta erección dolorosa, desde hace 8 horas. Al examen tiene erección completa, pero turgencia solo de los cuerpos cavernosos, con glándula y cuerpos esponjosos blandos. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Aplicar paños hielo en la zona genital
- b) Realizar derivación cavernoesponjosa
- c) Administrar atropina intracavernosa
- d) Administrar analgésicos
- e) Administrar fenilefrina intracavernosa

67) ¿Cuál de las siguientes vacunas optativas se puede se puede recomendar a un niño de 2 meses?

- a) Virus hepatitis A
- b) Varicela
- c) Neumocócica polisacárida
- d) Influenza
- e) Rotavirus

68) Un hombre de 42 años presenta dolor en el hombro derecho, de dos semanas de evolución, que inició en relación a un partido de tenis y que limita sus actividades, en especial, los movimientos de abducción y elevación. Al examen físico tiene dolor a la palpación subacromial, con dolor a la abducción y elevación del hombro, que dificulta estos movimientos, por sobre 80°. Se solicitan radiografías de hombro, que muestran esclerosis del acromion y leve ascenso de la cabeza humeral. El diagnóstico más probable es:

- a) Tendinitis cálcica
- b) Pinzamiento subacromial
- c) Rotura completa del tendón del supraespinoso
- d) Capsulitis adhesiva
- e) Tendinitis bicipital

69) Un paciente de 78 años consulta por gonalgia derecha intensa, que impide la marcha, asociada a aumento de volumen. Al examen físico presenta edema, eritema y aumento de la temperatura local, con signos de derrame articular. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos endovenosos
- b) Solicitar factor reumatoide, ANA y ácido úrico
- c) Iniciar AINEs
- d) Realizar artrocentesis diagnóstica
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear de rodilla

70) Un paciente de 36 años se hace una endoscopia digestiva alta, que muestra test de ureasa positiva para *Helicobacter pylori*. Como antecedente, tuvo una hemorragia digestiva alta hace 2 años, por una úlcera duodenal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Repetir la endoscopia digestiva alta
- b) Erradicar *Helicobacter pylori*
- c) Solicitar el test del aliento con úrea-C14
- d) Iniciar antihistamínicos H2
- e) Indicar omeprazol por 6 meses

71) Un niño recibe sus vacunas a los 2 meses. Algunas horas después evoluciona con decaimiento, hiporreactividad, hipotonía, fiebre de 37,7°C, seguido de convulsiones generalizadas, autolimitadas, con palidez y llene capilar menor a 1 segundo. El cuadro dura dos horas y luego se recupera por completo. ¿Qué componente de la vacuna es causante de esta reacción, con mayor probabilidad?

- a) Toxoide tetánico
- b) Toxoide diftérico
- c) VPO
- d) VHIB
- e) Pertusis celular

72) Un lactante de 5 meses presenta un cuadro de tos y coriza, asociada a fiebre hasta 38,5°C. Al día siguiente evoluciona con dificultad respiratoria, taquipnea, retracción subcostal y subcostal. Al examen físico tiene FR: 70x', uso de musculatura accesoria, sibilancias inspiratorias y espiratorias difusas e intensas, más cianosis perioral. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Virus respiratorio sincicial
- b) *Bordetella pertusis*
- c) Virus influenza
- d) Virus parainfluenza
- e) Neumococo

73) Un paciente de 45 años presenta un cuadro de 2 semanas de dificultades para mover las extremidades derechas. Los síntomas comenzaron en relación a un accidente de tránsito que él presenció. En su examen se aprecia que al caminar arrastra aparatosamente la pierna derecha y se constata tono muscular y reflejos normales, por lo que se descarta patología orgánica. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno conversivo
- b) Trastorno disociativo
- c) Trastorno de somatización
- d) Trastorno facticio
- e) Trastorno dismórfico corporal

74) Un niño de 3 años y 2 meses, hijo único, de padres no consanguíneos, está en terapia de lenguaje, desde hace 6 meses, sin mayores logros. Acude al jardín infantil y el padre lo describe como tímido y poco sociable. Además, tiene un juguete que hace ruido, con el que juega solo. Su desarrollo motor es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Privación social
- b) Hipoacusia
- c) Discapacidad intelectual
- d) Trastorno por déficit atencional, sin hiperactividad
- e) Trastorno del espectro autista

75) Un paciente de 78 años, IMC: 32, presenta alteraciones de la memoria, desde hace 2 años, que han progresado, asociado a desconcentración e hipersomnia. ¿Cuál es el diagnóstico de elección para iniciar el estudio?

- a) Electrocardiograma
- b) Ecocardiograma
- c) Polisomnografía
- d) RMN de cerebro
- e) TAC de cerebro

76) ¿Cuál de los siguientes hallazgos del examen físico sugieren un trastorno de conducta alimentaria en una adolescente?

- a) IMC de 20
- b) Hipertrofia de las parótidas
- c) Telangiectasias periorales
- d) Pulso dicrótico
- e) Hiperpigmentación areolar

77) Una paciente de 26 años consulta por dolor mamario bilateral, de 3 semanas de evolución. Su FUR fue hace 12 días. Al examen físico tiene galactorrea bilateral, sin nódulos. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio en esta paciente?

- a) Resonancia magnética de mama
- b) Ecografía mamaria
- c) Prolactinemia
- d) Niveles de gonadotropina coriónica
- e) Resonancia magnética de silla turca

78) Una paciente de 28 años, con antecedente de IMC: 29 y resistencia a la insulina, usuaria de DIU desde hace 5 años, presenta reglas abundantes y dismenorrea, por lo que solicita cambiar a anticoncepción oral. ¿Cuál de las siguientes opciones es la de elección?

- a) Etinilestradio 0,02 mg, más drospirenona 3 mg
- b) Etinilestradio 0,03 mg, más gestodeno 75 ug
- c) Etinilestradio 0,03 mg, más dienogest 3 mg
- d) Estradiol 2 mg, más dienogest 2 mg
- e) Gestodeno 75 ug

79) Una paciente de 30 años, múltipara de 2, con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento, es usuaria de DIU desde hace 8 años y presenta hipermenorrea y dismenorrea de 8 meses de evolución, por lo que quiere cambiar de método anticonceptivo. ¿Cuál de las siguientes opciones es de elección?

- a) DIU medicado con progestágeno
- b) Anticonceptivos orales combinados
- c) Anillo vaginal combinado
- d) Progestágenos inyectables cada 3 meses
- e) Estrógeno solo

80) Un hombre de 70 años, consulta por una lesión en la mano derecha, que apareció hace 6 meses y que ha crecido progresivamente. Es dolorosa y se ulcera y sangra con facilidad. Al examen físico se aprecia una lesión escamosa, ulcerada, de 2 cm de diámetro. Como antecedente, trabajó por 20 años, como minero, en la región de Tarapacá. El diagnóstico más probable es:

- a) Carcinoma espinocelular
- b) Carcinoma basocelular
- c) Melanoma maligno
- d) Granuloma piógeno
- e) Queratosis actínica

81) Una paciente de 29 años, cursando un embarazo de 28 semanas, se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa oral, que muestra glicemia basal de 86 mg/dl y glicemia poscarga de 139 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Repetir la prueba de tolerancia a la glucosa a las 32 semanas
- b) Iniciar metformina
- c) Iniciar dieta hipoglucídica
- d) Iniciar insulina
- e) Mantener el control normal del embarazo

82) Un paciente de 68 años, fumador y dislipidémico, en tratamiento con lavastatina y aspirina, comienza hace 2 meses con angina de pecho persistente, pero estable. ¿Qué fármaco es recomendable agregar?

- a) Amlodipino
- b) Dinitrato de isosorbide
- c) Carvedilol
- d) Enalapril
- e) Hidroclorotiazida

83) Una paciente de 20 años, en tratamiento con isotretinoína, desde hace 10 días, por acné, consulta por dolor abdominal, asociada a malestar general y astenia, a lo que se ha agregado ictericia y orinas oscuras. En su examen físico se aprecia ictericia de piel y mucosas y su abdomen se palpa bando, doloroso en epigastrio e hipocondrio, con hígado palpable 3 cm por debajo del reborde costal. Sus pruebas hepáticas resultan GOT: 328 UI/L, GPT: 459 UI/L, bilirrubina: 1,8 mg/dl, FA: 80 UI/L, GGT: 92 UI/L, protrombinemia: 80%.

Además, se solicita serología que muestra IgG(+)VHA, IgM(-)VHA, Antígeno VHBs(-), Anticuerpos totales antiHBVc(+). Anticuerpos anti-VHC y marcadores de autoinmunidad pendientes. El diagnóstico más probable es:

- a) Hepatitis A
- b) Hepatitis B
- c) Hepatitis C
- d) Hepatitis por drogas
- e) Hepatitis autoinmune

84) Un hombre de 30 años presenta pirosis frecuente, por lo que se solicita una endoscopia digestiva alta, que muestra una esofagitis por reflujo, grado A. Se inician inhibidores de la bomba de protones por 6 meses. Al control refiere buena respuesta, sin embargo, los síntomas recurren al suspender el tratamiento. La conducta más adecuada es:

- a) Repetir la endoscopia digestiva alta
- b) Solicitar pH-metría esofágica
- c) Indicar inhibidores de la bomba de protones
- d) Solicitar manometría esofágica
- e) Cambiar a antihistamínicos H2

85) Una paciente de 54 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de disuria, polaquiuria y dolor abdominal bajo. Sus urocultivos repetidos han resultado negativos. Al examen físico tiene mucosa vaginal seca y pálida. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar terapia de reemplazo hormonal oral
- b) Solicitar cistoscopia
- c) Solicitar ecografía transvaginal
- d) Indicar estrógenos tópicos
- e) Iniciar antimicóticos orales

86) Un paciente de 78 años, diabético, en tratamiento con glibenclamida, presenta convulsiones tónico-clónicas subintrantes hace algunos minutos. Hace 3 días se realizó control de exámenes, con glicemia de 185 mg/dl y electrolitos plasmáticos dentro de rangos normales. ¿Cuál es la causa más probable de sus convulsiones?

- a) Hipomagnesemia
- b) Hipernatremia
- c) Hipoglicemia
- d) Hipocalcemia
- e) Cetoacidosis

(nota: **subintrante** significa que comienza una nueva crisis, antes de recuperarse por completo de la anterior)

87) Un paciente de 56 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por disnea progresiva de 2 meses de evolución, asociada a tos irritativa y compromiso del estado general. Sus signos vitales son FC: 88x', PA: 130/80 mmHg, saturación 93% a FiO2 ambiental y al examen pulmonar presenta matidez y crépitos en la base derecha. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural moderado, a derecha, el que se confirma con la TAC de tórax. Se realiza toracocentesis, que da salida a un líquido pleural opalescente, con LDH: 700 UI/L, mayor a 0,6 en relación a la LDH plasmática y proteínas mayores a 0,5, en relación a las proteínas plasmáticas, con 40 células por mm3, 90% de mononucleares, ADA: 24 UI/L y citología negativa. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

- a) Biopsia pulmonar por videotoracoscopia
- b) Broncoscopia con biopsia pulmonar
- c) PET-TC
- d) Biopsia pleural por videotoracoscopia
- e) Broncoscopia con lavado bronquioalveolar

88) Un recién nacido es hijo de madre con hipotiroidismo, secundario a tratamiento con yodo radiactivo, por enfermedad de Basedow Graves, hace varios años. ¿Cuál es la conducta más adecuada para con el recién nacido?

- a) Esperar el resultado del tamizaje de hipotiroidismo neonatal
- b) Solicitar TSH y T4 libre a las 48 horas de vida
- c) Solicitar TSH y T4 libre al nacer
- d) Realizar ecografía tiroidea
- e) Solicitar anticuerpos antitiroideos a los 15 días de vida

89) Un paciente de 35 años ha presentado 6 episodios, en el último año, de litiasis renal por cálculos cálcicos. ¿Qué alteración endocrinológica puede ser causante de esto?

- a) Hiper cortisolismo
- b) Hipocortisolismo
- c) Hiperprolactinemia
- d) Hiperparatiroidismo
- e) Hipoparatiroidismo

90) Un paciente de 42 años sufre un accidente automovilístico, resultado con múltiples traumatismos. Al examen físico tiene movilidad de las extremidades inferiores, sin signos de fractura y examen genital con uretrorragia. Las radiografías confirman una fractura de pelvis estable. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

- a) Pielografía de eliminación endovenosa
- b) Uretrocistografía retrógrada
- c) Cistoscopia
- d) TAC de pelvis
- e) Resonancia magnética nuclear de pelvis

RECONSTRUCCIÓN EUNACOM DICIEMBRE 2019

Dr. Guillermo Guevara Aliaga

SEGUNDA PARTE

Pregunta 181) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdadera?

- a) MedLaw entrega una completa asesoría jurídica para médicos.
- b) MedLaw entrega un servicio contable excelente.
- c) MedLaw cuenta con un seguro de mala práctica médica de la mejor compañía de seguros de Chile.
- d) MedLaw entrega un servicio de calidad y personalizado.
- e) En www.medlaw.cl/informacion-y-educacion puedo encontrar información clara y completa sobre el sistema tributario chileno

RC: Todas son verdaderas.

Más información en www.medlaw.cl/



Dr. GUEVARA
WWW.DRGUEVARA.CL

¡INSCRIPCIONES ABIRTAS!

CURSO PRÁCTICO

INICIO: 10 DE ENERO

► Clic para más información

PRÁCTICAS: MEDICINA INTERNA - PEDIATRÍA - GINECOLOGÍA Y OBSTERICIA - CIRUGÍA

<http://www.drguevara.cl/curso-practico/>



www.drguevara.cl

Curso teórico para Eunacom de julio 2020

¡Inscripciones abiertas!

✓ CURSO TEÓRICO ONLINE
✓ CURSO TEÓRICO SEMIPRESENCIAL

Dr. GUEVARA

Clic para más información

<http://www.drguevara.cl/cursos-y-precios/>

91) Un paciente de 68 años, diabético de larga data, fumador, presenta pérdida brusca de la visión del ojo derecho, sin dolor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Infarto occipital
- b) Desprendimiento de retina
- c) Hemorragia vítrea
- d) Degeneración macular
- e) Edema macular

92) Se busca la asociación entre distintos parámetros con el cáncer de tiroides, en un estudio de caso – control, con el Odds Ratio (OR), más un intervalo de confianza (IC) al 95%, obteniéndose los resultados hipotéticos que se muestran a continuación. ¿Qué factor es más importante en esta asociación?

- a) Antecedentes familiares: OR: 1,88 ; IC [0,56 – 4,01]
- b) Edad: OR: 2,6 ; IC [0,95 – 3,17]
- c) Sexo masculino: OR: 0,56 ; IC [0,33 – 0,87]
- d) Tiroiditis de Hashimoto: OR: 4,6 ; IC [0,7 – 6,2]
- e) Exposición a radiación: OR: 1,89 ; IC [1,0 – 3,01]

93) Un paciente de 38 años, obesa, en tratamiento con antifúngicos orales desde hace 2 meses por onicomycosis, consulta por un cuadro de 7 días de evolución de prurito, ictericia y acolia, sin dolor abdominal. En su examen físico se aprecia icterico, afebril, con FC: 70x', PA: 110/70 mmHg, con abdomen blando, depresible. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran un patrón colestásico y la ecografía abdominal demuestra vesícula biliar con barro biliar y colédoco de 10 mm diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Coledocolitiasis
- b) Colestasia farmacológica
- c) Colangitis aguda
- d) Colestasia por esteatosis hepática
- e) Colelitiasis

94) En un estudio se realiza la validación y estandarización de las encuestas a aplicar. ¿Qué tipo de sesgo se busca evitar?

- a) Sesgo de memoria
- b) Sesgo de información
- c) Sesgo de confusión
- d) Sesgo de notificación
- e) Sesgo del entrevistador

95) Una paciente de 42 años, que 2 meses después de un quiebre conyugal, evoluciona con un cuadro de delirio de persecución y alucinaciones auditivas, asociado a marcada tristeza, anhedonia, irritabilidad y culpa patológica. Como antecedentes psiquiátricos, ella sufrió una depresión postparto y uno de sus tíos está en tratamiento con litio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Depresión psicótica
- b) Trastorno adaptativo mixto
- c) Trastorno esquizoafectivo
- d) Esquizofrenia
- e) Trastorno esquizoide

96) Un paciente de 35 años, colecistectomizado hace 6 meses por vía laparoscópica, consulta por dolor epigástrico, progresivo, que inició hace 24 horas y que se ha asociado a ictericia y acolia. Al examen físico está afebril, con FC: 80x' y PA: 120/76 mmHg y se aprecia dolor a la palpación del hemiabdomen superior e ictericia de piel y mucosas. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran GOT: 45 UI/L, GPT: 52 UI/L, FA: 430 UI/L, GGT: 566 UI/L, bilirrubina de 6,4 mg/dl y TP: 88%. ¿Cuál es el examen de elección para establecer el diagnóstico?

- a) TAC de abdomen
- b) Ecografía abdominal
- c) Resonancia magnética nuclear abdominal
- d) Colangiografía
- e) Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

97) Una paciente de 52 años consulta por dolor abdominal de 12 horas de evolución, intenso, de localización epigástrica e irradiado a los flancos, que se asocia a vómitos y orinas oscuras. Además, ha presentado fiebre hasta 39°C y aumento del dolor abdominal, en especial en el hemiabdomen superior. Al examen físico tiene ictericia de escleras, piel y mucosas, PA: 90/60 mmHg y FC: 110x'. Se realiza una ecografía abdominal que muestra colédoco de 11 mm de dilatación y litiasis múltiple en la vesícula biliar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar colecistectomía laparoscópica
- b) Realizar colecistectomía abierta más coledocostomía
- c) Solicitar colangiografía magnética nuclear
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- e) Realizar drenaje endoscópico de la vía biliar

98) Un paciente de 55 años, está hospitalizado por una pancreatitis aguda, de 10 días de evolución. Presenta un cuadro de fiebre, malestar general y taquipnea de 1 día de evolución. ¿Qué conducta es más adecuada?

- a) Solicitar radiografía de tórax
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Realizar laparoscopia exploradora
- d) Solicitar angioTAC de tórax
- e) Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

99) Una niña de 3 años, en tratamiento con amoxicilina, desde hace 9 días, por una amigdalitis, evoluciona con fiebre y aparición de un exantema morbiliforme generalizado, con lesiones en diana y úlceras en las mucosas oral, rectal y vaginal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Urticaria
- b) Gingivoestomatitis herpética
- c) Síndrome de Steven Johnson
- d) Enfermedad de Kawasaki
- e) Mononucleosis infecciosa

100) Un paciente de 24 años mantiene relación sexual casual hace 7 días, con penetración vaginal, sin protección evolucionando con disuria, sin otros síntomas. Al examen físico y genital, no hay alteraciones. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Mycoplasma genitalium
- b) Ureaplasma urealyticum
- c) Chlamydia trachomatis
- d) Trichomona vaginalis
- e) Escherichia coli

101) Una paciente de 56 años presenta incontinencia urinaria, con escapes de orina, en grandes cantidades, precedidos por deseos incontrolables de orinar. En ocasiones, también presenta escapes de orina en la noche. Al examen no presenta pérdida de orina con la maniobra de Valsalva y no tienen otras alteraciones. Sus urocultivos son negativos y su sedimento de orina es normal. Se solicita una ecografía que muestra vejiga de paredes delgadas, sin cálculos ni residuo postmiccional significativo. El tratamiento más adecuado es:

- a) Iniciar tamsulosina
- b) Iniciar oxibutinina
- c) Realizar cistoscopia
- d) Realizar suspensión uretral con cinta transvaginal
- e) Indicar ejercicios de kinesioterapia pélvica

102) Una mujer de 24 años, primípara, en trabajo de parto avanzado. Se produce desprendimiento de la cabeza fetal, sin embargo, no se produce la rotación de la cabeza, ni el descenso de los hombros. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Pivotar la cabeza
- b) Realizar compresión de la región suprapúbica (maniobra de Kristeller)
- c) Rotar el hombro hacia anterior
- d) Realizar hiperflexión de las caderas (maniobra de McRoberts)
- e) Realizar fórceps

103) Una paciente de 34 años, múltipara, embarazada de 36 semanas, presenta pérdida de líquido abundante por los genitales, hace una hora. La especuloscopia muestra cuello cerrado, con salida de líquido y la ecografía obstétrica muestra disminución del líquido amniótico, con presentación cefálica. El registro no estresante es reactivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Mantener conducta expectante
- b) Administrar corticoides
- c) Interrumpir el embarazo
- d) Esperar 24 horas para inicio espontáneo del trabajo de parto
- e) Administrar antibióticos

104) Una paciente de 27 años, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta por dinámica uterina, con contracciones dolorosas 2 en 10 minutos, que no han cedido al uso de antiespasmódicos, ni al de nifedipino. Al examen físico presenta temperatura 38,0 grados Celsius, PA: 120/80 mmHg, FC: 80x'. Su tacto vaginal tiene un cuello cerrado, duro y posterior. El monitoreo fetal muestra latidos a 145x'. Se solicita un hemograma muestra glóbulos blancos: 11.000 por mm3. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Dejar a evolución espontánea
- b) Solicitar perfil biofísico
- c) Realizar cesárea
- d) Realizar amniocentesis
- e) Administrar tocolíticos de segunda línea

105) Una paciente de 28 años, cursa un embarazo de 32 semanas por amenorrea, sin controles obstétricos previos. Consulta por pérdida de líquido amniótico por genitales. Al examen físico presenta temperatura 38,5 grados Celsius, PA: 120/80 mmHg, FC: 110x'. La especuloscopia muestra salida de líquido por el orificio cervical, con pH: 7. Su tacto vaginal tiene un cuello cerrado, duro y posterior. El monitoreo fetal muestra frecuencia cardíaca fetal de 180 latidos por minuto. La ecografía obstétrica, que muestra oligoamnios y peso fetal de 1.100 gramos, equivalente a un embarazo de 29 semanas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Interrumpir el embarazo
- b) Administrar corticoides y antibióticos y mantener una conducta expectante
- c) Solicitar Doppler materno-fetal
- d) Realizar amniocentesis
- e) Realizar amnioinfusión, con surfactante intramniótico

106) Una paciente de 58 años, consulta por metrorragia de 3 días evolución. Su examen ginecológico demuestra escasa metrorragia, que proviene del OCE, sin otras alteraciones. Sus mamografías y PAP son normales y fueron realizados hace menos de un año. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra endometrio de 3 mm, sin masas, ni otras alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar colposcopia
- b) Controlar con una ecografía en 3 meses
- c) Realizar legrado
- d) Iniciar terapia de reemplazo hormonal combinada
- e) Realizar biopsia de endometrio

107) Una paciente embarazada de 10 semanas, se realiza una glicemia de ayuno en su control del embarazo, que resulta 130 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Glicemia normal para el embarazo
- b) Intolerancia a la glucosa oral
- c) Diabetes mellitus gestacional
- d) Diabetes mellitus pregestacional
- e) Resistencia a la insulina

108) Una paciente de 28 años acude a la clínica de fertilidad. Presenta reglas irregulares, que ocurren cada 2 a 3 meses. Al examen físico se observa obesa y tiene hirsutismo y acné, sin alteraciones en el examen ginecológico. Se solicita prueba de HOMA, que resulta 2,1 (VN: < 2,6) y se realiza una ecografía transvaginal que muestra útero normal, con ovarios poliquísticos. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para lograr la fertilidad en esta paciente?

- a) Espironolactona
- b) Análogos de la GnRH
- c) Citrato de clomifeno
- d) Metformina
- e) Progesterona

109) Una paciente de 31 años, entra en trabajo de parto a las 38 semanas y al examinarla se constatan 3 contracciones uterinas en 10 minutos y su tacto vaginal muestra 5 cm de dilatación cervical, membranas íntegras y presentación cefálica, en espaldas -1. El registro de la frecuencia cardíaca fetal está dentro de rangos normales. Se la evalúa a las 3 horas, manteniéndose sin cambios obstétricos. La conducta de elección es:

- a) Mantener una conducta expectante por 1 hora y reevaluar
- b) Administrar misoprostol
- c) Realizar cesárea
- d) Realizar rotura artificial de membranas y administrar anestesia epidural
- e) Administrar oxitocina endovenosa en goteo

110) Un niño de 18 meses presenta dolor de garganta y fiebre de 2 días de evolución de hasta 39,0°C, asociado a irritabilidad, malestar general y secreción conjuntival bilateral. Al examen físico, además, se observa faringe eritematosa exudado amigdalino bilateral y se palpan adenopatías cervicales anteriores. El agente etiológico más probable es:

- a) *Staphylococcus aureus*
- b) *Streptococcus pyogenes*
- c) Metaneumovirus
- d) Adenovirus
- e) Virus de Epstein Baar

111) Niño de 12 años, obeso, refiere dolor de 3 meses en cadera izquierda y claudicación progresiva, que actualmente impide la marcha. Al examen físico presenta dolor a la rotación interna y externa de la cadera izquierda. Se realiza radiografía AP pelvis y caderas, que se muestra a continuación:



Fuente: www.radiopaedia.org

El diagnóstico es:

- a) Displasia del desarrollo de la cadera
- b) Epifisiolisis
- c) Fractura del cuello femoral
- d) Osteomielitis del extremo proximal del fémur
- e) Necrosis avascular de la cabeza femoral

112) Un recién nacido de término, de 5 días de vida, aún no ha eliminado meconio. Además, presenta irritabilidad, vómitos postprandiales frecuentes y distensión abdominal. Al examen tiene ano permeable y se realiza un enema baritado, que muestra colon proximal dilatado y colon distal estrecho. El examen más adecuado para confirmar el diagnóstico es:

- a) TAC abdominal
- b) Colonoscopia
- c) Test del sudor
- d) Biopsia por succión
- e) Cariograma

113) Un paciente de 18 años, asintomático, acude a control médico, para evaluación para realizar deporte. Se encuentra asintomática y en su examen físico se pesquiza la presencia de un soplo sistólico de intensidad III/VI en la zona paraesternal izquierda. Su electrocardiograma es normal.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Comunicación interauricular
- b) Estenosis aórtica
- c) Comunicación interventricular
- d) Estenosis pulmonar
- e) Ductus arterioso persistente

114) Un paciente de 85 años, institucionalizado por una demencia tipo Alzheimer y que es portador de sonda Foley a permanencia, que se cambia cada 30 días. Al momento de cambiarle la sonda, se observan orinas turbias, por lo que se realiza un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli sensible solo a nitrofurantoína, gentamicina e imipenem. El paciente está asintomático, afebril, sin mayor confusión de la habitual. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar nitrofurantoína v.o.
- b) Iniciar gentamicina i.m.
- c) Iniciar imipenem e.v.
- d) Observar evolución, sin necesidad de retirar la sonda
- e) Cambiar la sonda, sin necesidad de antibióticos

115) Un paciente de 40 años, con antecedente de infección crónica por VIH, diagnosticado hace 4 años, consulta por diarrea de 3 meses, de tipo acuoso, sin fiebre, asociado a dolor abdominal y baja de peso. Al examen físico está afebril, tiene algorra y presenta abdomen blando, depresible, levemente doloroso a la palpación, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) *Salmonella typhi*
- b) *Clostridium difficile*
- c) *Cryptococcus sp.*
- d) *Microsporidium*
- e) *Toxoplasma gondii*

116) Una paciente de 66 años se realiza una densitometría ósea que muestra un T score de -3,5 DS en cadera izquierda y -2,8 en la columna lumbar a la altura de la vértebra L4. Trae además una glicemia, un perfil bioquímico y perfil lipídico, todos dentro de rangos normales. Mide 1,68 metros y pesa 49 kilos, ¿Cuál es la conducta más adecuada para esta paciente?

- a) Indicar calcio y vitamina D vía oral
- b) Indicar una carga de vitamina D vía oral
- c) Administrar calcitonina intranasal
- d) Indicar bifosfonatos vía oral o endovenosa
- e) Iniciar terapia de reemplazo hormonal con estrógenos más progestágenos por vía oral

117) Un paciente de 50 años, con antecedente de infección de VIH de varios años, consulta por una lesión perianal, de larga data, sin tendencia a la cicatrización, que en ocasiones se ulcera y sangra. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada, de consistencia aumentada, de 3 cm de diámetro, bordes cartográficos y que se introduce por el orificio anal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Sífilis
- b) Enfermedad de Cröhn
- c) Carcinoma epidermoide
- d) Melanoma
- e) Linfogranuloma venéreo

118) Paciente de 58 años, con antecedente de diabetes mellitus, hipertensión y fumador de 40 paquetes año, consulta por un cuadro de tres semanas de evolución de dolor epigástrico opresivo, asociado a disnea y palpitaciones regulares, que lo obligan a detenerse cada 100 metros de caminata y ceden con el reposo. En el examen físico, su presión arterial es 140/90 mmHg, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto regular. El diagnóstico más probable es:

- a) Angina crónica de reciente comienzo
- b) Fibrilación auricular paroxística
- c) Isquemia cardíaca con arritmia supraventricular
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Insuficiencia cardíaca postinfarto

119) Un paciente de 50 años asintomático se realiza pruebas hepáticas como parte de un chequeo médico, que muestran una SGOT: 332 UI/L y SGPT: 210 UI/L, con bilirrubina de 1,5 mg/dl. No refiere hábitos tóxicos. Como antecedente, tuvo un hemoperitoneo traumático el año 1992, que requirió de transfusiones. ¿Qué examen se debe solicitar ante la sospecha diagnóstica?

- a) Antígeno de superficie
- b) IgM para VHA
- c) Test de HOMA
- d) TAC de abdomen
- e) Anticuerpos totales contra VHC

120) Una niña de 13 meses de edad, desde hace 4 meses ha detenido su crecimiento. Además, presenta deposiciones frecuentes y disgregadas, con tendencia al meteorismo. En sus exámenes destaca anemia ferropénica. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

- a) Anticuerpos IgA antiendomiso
- b) Cuantificación de inmunoglobulinas
- c) Test del sudor
- d) Colonoscopia
- e) 17 – OH – progesterona

121) Un paciente de 56 años, diabético, hospitalizado en su quinto día, por un síndrome nefrótico, presenta un cuadro de disnea y dolor torácico, por lo que se realiza una radiografía de tórax, la que muestra un derrame pleural derecho. Se realiza la punción pleural, dado salida a un líquido pleural de aspecto hemorrágico, con LDH: 650 UI/L, células 80% de polimorfonucleares, 20% de mononucleares, ADA: 30 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Derrame paraneumónico
- b) Trasudado por hipoalbuminemia
- c) Empiema
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Derrame pleural canceroso

122) Un paciente de 69 años, con antecedente de diabetes e hipertensión, en tratamiento con aspirina, losartán, amlodipino, hidroclorotiazida y metformina, consulta por sensación de hinchazón y molestias en las extremidades inferiores. Al examen físico, tiene edema de extremidades inferiores. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Suspender el amlodipino
- b) Aumentar la dosis de hidroclorotiazida
- c) Disminuir la dosis de metformina
- d) Suspender el losartán
- e) Aumentar la dosis de aspirina

123) Un paciente de 71 años, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes, en tratamiento con enalapril, metformina, aspirina, nifedipino e hidroclorotiazida consulta por disnea de esfuerzos, que aparece al caminar 2 cuadras. Al examen físico, se palpa el choque de la punta desplazado 2 cm hacia lateral y se ausculta ritmo cardíaco regular, en tres tiempos, con presencia de un tercer ruido y de un soplo de insuficiencia mitral III/VI, con escasos crépitos en la auscultación pulmonar. ¿Qué fármaco debe suspenderse?

- a) Enalapril
- b) Metformina
- c) Aspirina
- d) Nifedipino
- e) Hidroclorotiazida

124) Una paciente presenta un cuadro de 2 días de disnea de esfuerzo, que aparece ante medianos esfuerzos, asociado a tos con expectoración, que en ocasiones es rosada. Al examen físico tiene FC: 94x', PA: 110/70 mmHg, examen pulmonar con crepitaciones bilaterales y examen cardíaco con presencia de un soplo sistólico IV/VI. El diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Insuficiencia tricuspídea
- c) Neumopatía aguda
- d) Insuficiencia mitral aguda
- e) Disección aórtica

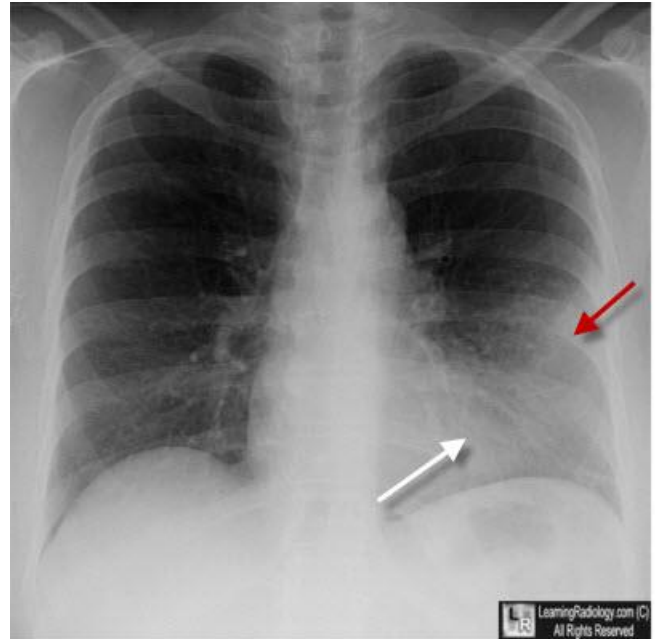
125) Un paciente está hospitalizado por un infarto agudo al miocardio, con supradesnivel del segmento ST, de dos días de evolución. Presenta deterioro del estado general y disnea de reposo, con tendencia a la hipotensión arterial. En su examen físico tiene FC: 115x', PA: 80/50 mmHg, examen pulmonar con crepitaciones bilaterales intensos y examen cardíaco con ritmo regular en 2 tonos, con soplo sistólico intenso, de localización precordial. El diagnóstico más probable es:

- a) Taponamiento cardíaco por rotura de la pared libre
- b) Disfunción valvular aórtica isquémica
- c) Rotura del músculo papilar
- d) Shock cardiogénico por infarto masivo
- e) Disección de la raíz aórtica

126) Un paciente de 80 años presenta disnea de esfuerzo de algunos meses de evolución, progresiva. Hace 24 horas sufre un síncope, con recuperación completa. Al examen físico tiene FC: 75x', PA: 110/70 mmHg se palpa el choque de la punta en el 4° espacio intercostal, línea medio clavicular y se ausculta el corazón con presencia de soplo protomesosistólico III/VI y segundo ruido muy apagado. El examen pulmonar no muestra alteraciones. Se solicita un electrocardiograma, que muestra un ritmo sinusal con onda S de 23 mm en V2 y onda R de 16 mm en V5. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Estenosis aórtica
- b) Estenosis mitral
- c) Insuficiencia aórtica
- d) Insuficiencia mitral
- e) Cardiopatía coronaria

127) Una paciente de 45 años, hipertensa, presenta un cuadro de 4 días de evolución de malestar general, fiebre hasta 38,8°C, mialgias, cefalea y tos con expectoración mucopurulenta. Al examen físico tiene FR: 13 lpm, FC: 80x'. PA: 120/80 mmHg, examen pulmonar con crépitos en la base izquierda, matidez y aumento de la transmisión de las vibraciones vocales en la zona. Examen cardíaco normal. Satura 98% a FiO2 ambiental y se solicita una radiografía, que se muestra a continuación:



Fuente: www.learningradiology.com

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Oseltamivir
- b) Levofloxacino
- c) Ceftriaxona
- d) Amoxicilina
- e) Claritromicina

128) Una paciente de 50 años consulta por artralgias y edema de las manos, especialmente en las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y en las muñecas de ambas manos. Refiere fenómeno de Raynaud y rigidez matinal de 1 hora de duración. Además, relata sensación de arenilla ocular y boca seca. Se solicitan exámenes, que muestran hemograma normal, VHS: 52 mm/h, PCR: 2,8 mg/dl, anticuerpos antinucleares positivos, en titulación 1/80, factor reumatoide: 118 UI/ml y anticuerpos anti-CCP: 200 UI/ml. La radiografía de manos muestra osteopenia yuxtarticular de los huesos metacarpianos. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus
- b) Artritis reumatoide
- c) Vasculitis primaria
- d) Esclerosis sistémica
- e) Síndrome de Sjörgren primario

129) Un paciente de 30 años presenta lumbago de 6 meses de evolución, intenso, que limita sus actividades y que es más molesto en la mañana y va cediendo durante el día. Al examen físico tiene lesiones descamativas en las rodillas y punteado ungueal y el examen de la columna muestra limitación a la flexión, con test de Schöber modificado de 2 cm. Se solicitan exámenes que muestran VHS: 60 mm/h, PCR: 5,0 mg/dl, anticuerpos antinucleares y factor reumatoide negativos. ¿Cuál es el examen de elección para establecer el diagnóstico en este paciente?

- a) Radiografía de columna lumbosacra
- b) Radiografía de columna dorsolumbar
- c) TAC de columna lumbosacra
- d) Resonancia magnética de columna dorsolumbar
- e) Resonancia magnética de articulaciones sacroilíacas

130) Un paciente de 18 años presenta equimosis frecuente y tendencia a presentar petequias en las extremidades inferiores. Como antecedente, presentó hemorragia tardía, en relación a la extracción de un molar y hace algunos años sufrió un hematoma en el muslo izquierdo, en relación a un traumatismo, que requirió manejo hospitalizado. Se solicitan exámenes que muestran hemograma con 160.000 plaquetas por mm³, sin alteraciones de la serie roja ni blanca, TTPA de 45 segundos y TP de 100%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Enfermedad de Glanzmann
- b) Enfermedad de von Willebrand
- c) Déficit de factor VII
- d) Hemofilia
- e) Púrpura trombopénica inmune

131) Un hombre de 78 años consulta por debilidad de las extremidades inferiores, que le dificulta realizar movimientos como pararse de una silla o subir escaleras. Al examen físico tiene paresia de las extremidades inferiores, la sensibilidad es normal y no tiene alteración de los reflejos osteotendíneos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Polimiositis
- b) Hipotiroidismo
- c) Déficit de vitamina B12
- d) Distrofia muscular progresiva
- e) Raquiestenosis

132) Un paciente de 45 años se realiza glicemias de ayuno que resultan 128 y 136 mg/dl. Se solicita hemoglobina glicosilada, que resulta 7,2%. ¿Cuál es el tratamiento de elección para iniciar el manejo de este paciente?

- a) Glibenclamida
- b) Metformina
- c) Pioglitazona
- d) Sitagliptina
- e) Repaglinida

133) Un paciente de 27 años presenta una lesión en la pierna derecha, consistente en una placa de 13 por 7 cm de diámetro, eritematosa y solevantada. Se inicia cloxacilina endovenosa. Al quinto día, la lesión cutánea ha mejorado, sin embargo, evoluciona con malestar general, fiebre y aparición de un exantema macular eritematoso, generalizado. Se solicitan exámenes que muestran sedimento de orina con hematuria microscópica, glóbulos blancos: 20 por campo, hemograma con leucocitosis de 14.000, con 20% de eosinófilos, BUN: 30 mg/dl y creatinina: 2,0 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
- b) Púrpura trombocitopénico trombótico
- c) Vasculitis sistémica primaria
- d) Insuficiencia renal aguda prerrenal
- e) Nefritis intersticial

134) Un paciente de 35 años, en tratamiento con atorvastatina, por hipercolesterolemia y cuyo padre tuvo un infarto a los 40 años, presentó mialgias y artralgias, por lo que decidió suspender el medicamento, sin indicación médica. Se controla con exámenes, entre los que destaca colesterol total: 354 mg/dl, colesterol LDL: 244 mg/dl, colesterol HDL: 70 mg/dl, triglicéridos: 198 mg/dl, creatinfosfoquinasa: 254 UI/L. El tratamiento más adecuado es:

- a) Colestiramina
- b) Dieta estricta
- c) Rosuvastatina
- d) Ezetimibe
- e) Fenofibrato

135) Un paciente de 48 años, diabético mal controlado, presenta una lesión en el muslo derecho, desde hace 5 días, que ha crecido y se ha asociado a malestar general y fiebre. Al examen físico tiene T°: 39,0°C, FC: 115x', PA: 90/60 mmHg y se aprecia la lesión de 20 cm de aspecto eritemato-violáceo, con bulas en su superficie. El diagnóstico más probable es:

- a) Erisipela
- b) Herpes zóster
- c) Ántrax
- d) Fasceítis necrotizante
- e) Miositis necrotizante

136) Un paciente consulta porque hace 3 días notó aparición de una úlcera en el pene, ubicada en el glande, de 1 cm de diámetro, de aspecto indurado, fondo limpio y sin otros síntomas. Además, se palpa una adenopatía inguinal derecha indolora. Se solicita VDRL y FTA-ABS, resultando ambos negativos. El diagnóstico más probable es:

- a) Sífilis primaria
- b) Chancroide
- c) Enfermedad de Behcet
- d) Infección por virus papiloma humano
- e) Linfogranuloma venéreo

137) Una paciente de 62 años presenta una caída a nivel, con erosión en la rodilla derecha. Tres días después presenta una lesión eritematosa, que rodea la herida, de 10 cm de diámetro y bordes difusos, con aumento de la temperatura local. ¿Cuál es la conducta de elección?

- a) Indicar mupirocina tópica
- b) Realizar curación con suero fisiológico y control en 48 horas
- c) Realizar curaciones diarias con suero fisiológico y povidona yodada
- d) Indicar amoxicilina oral por 7 días
- e) Indicar cefadroxilo oral por 7 días

138) Una paciente cefalea de 4 semanas de evolución, mayor en las mañanas, que se asocia a vómitos y, además, refiere alteraciones visuales. Al examen físico tiene fuerzas y sensibilidad conservada en las 4 extremidades y en el campo visual se constata hemianopsia bitemporal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tumor de la glándula pineal
- b) Glioma del nervio óptico
- c) Tumor de la base del lóbulo frontal
- d) Hiperprolactinemia
- e) Macroadenoma hipofisiario

139) Un paciente de 54 años, alcohólico e hipertenso, hace una semana suspende todos los antihipertensivos. Es traído a la urgencia por cefalea muy intensa, de inicio agudo, asociado a desorientación y compromiso de conciencia. Al examen físico está soporoso, no habla ni sigue indicaciones, aunque mantiene movilidad espontánea de las 4 extremidades. Sus reflejos osteotendíneos y tono muscular son normales y tiene signo de Babinski bilateral. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemorragia subaracnoidea
- b) Meningitis bacteriana
- c) Edema cerebral
- d) Intoxicación etílica
- e) Accidente vascular isquémico extenso

140) Un paciente de 64 años, con antecedente de insuficiencia renal crónica, con clearance de 40 ml/min se realiza exámenes de control que muestran fósforo: 4,0 mg/dl, calcio: 8,5, PTH: 120 pg/ml (VN: menor a 55) y TSH: 4,0 UI/L. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

- a) Niveles plasmáticos de 25-OH-vitamina D
- b) Niveles de T4 libre
- c) Calciuria de 24 horas
- d) Magneemia
- e) Bicarbonato plasmático

141) Un paciente de 36 años, desde hace 4 años sigue dieta vegana estricta. Consulta por astenia, adinamia y palidez, a lo que se ha agregado disnea de grandes esfuerzos, que ha aumentado. Al examen físico tiene palidez de piel y mucosas, FC: 92x', PA: 100/70 mmHg, sin alteraciones del examen segmentario. Se solicita hemograma que muestra plaquetas: 200.000 por mm³, glóbulos blancos: 6.500 por mm³, hematocrito: 27%, hemoglobina: 9 g/dl, VCM: 115 fl, HCM: 35 pg y reticulocitos 0,5%, con LDH: 450 UI/L. El examen más adecuado para proseguir el estudio es:

- a) Nivel de vitamina B12
- b) Mielograma
- c) Biopsia de médula ósea
- d) Perfil de hierro
- e) Prueba de Coombs

142) Una paciente de 25 años consulta por diarrea de un mes de evolución, asociada a dolor abdominal tipo cólico y algunos episodios de hematoquecia. Además, tiene artralgiás de las manos y rodillas, con artritis de la rodilla derecha. Al examen físico se observan úlceras orales y lesiones nodulares en la cara anterior de las piernas. El examen abdominal muestra abdomen blando sensible, sin masas. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus eritematosos sistémico
- b) Enfermedad de Behcet
- c) Colitis ulcerosa
- d) Artritis reumatoide
- e) Colitis por *Clostridium difficile*

143) Un paciente de 32 años, presenta infecciones respiratorias recurrentes, desde su infancia, que en varias ocasiones han requerido de antibióticos, asociado a disnea de esfuerzos. Al examen físico tiene FC: 80x', PA: 110/70 mmHg, T°: 36,5°C y al examen pulmonar se auscultan múltiples crépitos y sibilancias bilaterales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación:



Fuente: <http://www.lungindia.com/>

El examen más adecuado para proseguir el estudio diagnóstico es:

- a) Fibrobroncoscopía
- b) Cuantificación de inmunoglobulinas
- c) TAC de tórax
- d) Test del sudor
- e) Espirometría

144) Un adolescente de 14 años presenta cefalea de una semana de evolución. Es traído al servicio de urgencia, tras presentar una convulsión tónico-clónica de 10 minutos de duración, luego de lo que quedó con confusión postictal. Su examen físico no tiene signos focales. Se solicita una tomografía axial computada de cerebro, que muestra una lesión quística de 3 cm en la zona frontotemporal y se realiza una punción lumbar, que muestra proteínas 60 mg/dl, con 70 células por mm³, con 70% de mononucleares y presencia de abundantes eosinófilos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Quiste aracnoidal
- b) Astrocitoma pilocítico
- c) Encefalitis herpética
- d) Meningitis tuberculosa
- e) Neurocisticercosis

145) Una paciente de 34 años consulta por disfonía intermitente, principalmente en la mañana, asociada a carraspera. Su examen físico es normal. ¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?

- a) Azitromicina oral 500 mg/día por 5 días
- b) Prednisona oral 20 mg/día
- c) Lanzoprazol oral 20 mg/día por 30 días
- d) Amoxicilina oral 500 mg/8 horas por 7 días
- e) Ibuprofeno 400 mg/8 horas por 7 días

146) Una paciente de 24 años presenta tos frecuente y disnea, asociada a sibilancias, que son mayores en la noche y que aumentan con el ejercicio, cuando fuma y en la primavera. Al examen físico presenta espiración prolongada y examen pulmonar con sibilancias bilaterales inspiratorias y espiratorias. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Evitar la exposición a desencadenantes
- b) Salbutamol inhalado cada 6 horas
- c) Budesonida inhalada cada 12 horas
- d) Salmeterol inhalado cada 12 horas
- e) Desensibilizar para los alérgenos

147) Una mujer de 23 años, cursando un embarazo de 20 semanas, sin complicaciones, se realiza un urocultivo, que resulta positivo para *Escherichia coli* multisensible, 60.000 UFC por ml. La conducta más adecuada es:

- a) Repetir el urocultivo en 2 semanas
- b) Iniciar cefradina vo
- c) Iniciar ciprofloxacino vo
- d) Solicitar ecografía
- e) Iniciar ceftriaxona ev

148) Una paciente de 27 años, multipara, cursando un embarazo de 38 semanas, en trabajo de parto en fase activa, se produce rotura de membranas, con salida de líquido amniótico claro, luego de lo cual la frecuencia cardíaca fetal disminuye a 90 latidos por minuto. ¿Cuál es la conducta inmediata que debe realizarse en esta paciente?

- a) Realizar perfil biofísico
- b) Realizar cesárea
- c) Cambiar de posición a la madre
- d) Realizar tacto vaginal
- e) Realizar Doppler fetal

149) Una paciente de 30 años, cursando embarazo de 36 semanas, con feto creciendo en percentil 6 en la semana 35, con Doppler materno fetal normal en ese entonces. Se realiza ecografía de control que muestra feto que no ha crecido, en presentación podálica y Doppler normal. El registro basal no estresante es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar perfil biofísico
- b) Administrar corticoides
- c) Interrumpir a las 37 semanas
- d) Realizar cesárea en este momento
- e) Continuar el control semanal con Doppler

150) Una paciente de 32 años, con 32 semanas de embarazo, acude al servicio de urgencia por contracciones uterinas dolorosas, asociada a metrorragia. Al examen físico se palpa aumento del tono uterino, se objetiva metrorragia escasa y contracciones uterinas hipertónicas a razón de 3/10 minutos. El cuello uterino no tiene modificaciones y los latidos cardiotetales se auscultan a 120 lpm. La conducta más adecuada es:

- a) Interrumpir el embarazo de inmediato
- b) Administrar corticoides intramusculares
- c) Solicitar perfil biofísico
- d) Solicitar Doppler materno-fetal
- e) Administrar tocolíticos

151) Una mujer de 25 años, puerpera de 5 días, con parto vaginal, consulta por de aumento de la cantidad de loquios hemáticos y sensación febril. Al examen físico tiene FC: 80x', PA: 110/70 mmHg, examen genital con episiorrafia equimótica y dolor a la palpación uterina. El diagnóstico más probable es:

- a) Restos placentarios
- b) Neoplasia trofoblástica gestacional
- c) Infección de la episiorrafia
- d) Miometritis puerperal
- e) Endometritis puerperal

152) Una paciente de 32 años, cursando puerperio desde hace 8 días, con parto por cesárea, comienza con loquios abundantes y de mal olor, asociada a fiebre. Su examen físico muestra T°: 38,5°C FC: 85x'. PA: 120/80x', herida operatoria sin signos de infección y útero doloroso a la palpación. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos orales
- b) Realizar legrado
- c) Hospitalizar y manejar con antibióticos endovenosos
- d) Realizar histerectomía
- e) Administrar una dosis de antibióticos endovenosos y luego manejo ambulatorio con

153) Una paciente de 24 años, puérpera de 15 días, presenta dolor en la mama derecha, asociada a eritema, aumento de la temperatura local y fiebre hasta 38,8°C. Al examen físico se aprecia mama derecha eritematosa y congestiva, dolorosa a la palpación, sin zonas fluctuantes. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

- a) Antiinflamatorios
- b) Compresión con frío local
- c) Suspender la lactancia materna
- d) Drenaje mamario
- e) Antibióticos orales

154) Una paciente de 50 años consulta por amenorrea de 8 meses de evolución. Se realiza ecografía transvaginal que muestra múltiples imágenes nodulares, hipoecogénicas intramurales y subserosas de hasta 3 cm. La indicación más adecuada es:

- a) Histerectomía
- b) Ecografía en 6 meses
- c) Terapia de reemplazo hormonal
- d) Análogos de la GnRH
- e) Biopsia por histeroscopia

155) Una primigesta de 23 años, cursando un embarazo de 20 semanas, se realiza una ecografía transvaginal que muestra un cuello de 20 mm de longitud, sin otras alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Indicar pesario
- b) Iniciar progesterona endovaginal
- c) Realizar cerclaje
- d) Administrar corticoides sistémicos
- e) Observar evolución

156) Una paciente de 31 años, con embarazo de 40 semanas, acude al servicio de urgencia por ausencia de percepción de movimientos fetales. Se realiza un perfil biofísico, que resulta 8/10, con oligoamnios. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Interrumpir a las 41 semanas
- b) Interrumpir a las 42 semanas
- c) Interrumpir el embarazo ahora
- d) Repetir el perfil biofísico en 48 horas
- e) Esperar el inicio del trabajo de parto

157) Un niño de 8 años presenta un cuadro de cefalea y fiebre de 2 días de evolución, a lo que se agrega una conducta agresiva y luego desorientación. Convulsiona en varias oportunidades. Su TAC descarta hipertensión endocraneana, por lo que se realiza punción lumbar que da salida a líquido cefalorraquídeo con 100 glóbulos rojos por mm³, 20 glóbulos blancos por mm³, con 90% de mononucleares, proteínas: 80 mg/dl y glucosa: 60 mg/dl. ¿Cuál es el tratamiento inicial?

- a) Oseltamivir
- b) Vancomicina
- c) Ceftriaxona
- d) Aciclovir
- e) Ampicilina

158) Un niño de 10 años es traído a la consulta por aparición de múltiples equimosis y petequias, desde hace 2 semanas, asociadas a palidez. Al examen físico se aprecia pálido, con petequias en las extremidades inferiores y el tronco y múltiples equimosis de gran tamaño en las extremidades inferiores. Además, se palpa hepatomegalia de 3 cm bajo el reborde costal. El diagnóstico más probable es:

- a) Púrpura trombopénica inmune
- b) Enfermedad de von Willebrand
- c) Púrpura de Schönlein Henoch
- d) Meningococemia
- e) Leucemia

159) Un niño de 2 años presenta tendencia a las hemorragias, ya que sangra con facilidad y presenta múltiples equimosis. En el examen físico, se observan extremidades inferiores con equimosis en distinto grado de resolución, algunas de gran tamaño. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma con recuento de plaquetas normal, TP normal y TTPA alargado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Púrpura trombocitopénica inmune
- b) Hemofilia
- c) Enfermedad de von Willebrand
- d) Enfermedad de Glanzmann
- e) Púrpura trombocitopénica trombótica

160) Una niña de 7 años, con antecedente de hiperplasia suprarrenal congénita, en tratamiento con hidrocortisona y fludrocortisona, consulta por cuadro de 4 días de diarrea, fiebre y malestar general. Al examen físico tiene leve taquicardia y algunos signos de deshidratación. Además de la reposición de volumen, ¿qué conducta es la más adecuada?

- a) Fludrocortisona endovenosa
- b) Betametasona oral
- c) Prednisona oral
- d) Hidrocortisona endovenosa
- e) Aumentar la dosis de hidrocortisona oral

161) Un niño de 14 años consulta por dolor abdominal y vómitos de 3 días de evolución, con tendencia a la deshidratación. Hace dos meses estuvo hospitalizado por un cuadro similar, para hidratación endovenosa. Al examen físico tiene FC: 110x', PA: 110/70 mmHg, T°: 36,8°C. Se solicitan exámenes, que muestran glicemia: 36 g/dl, sodio: 126 mEq/L, potasio: 5,8 mEq/L, pH: 7,32, bicarbonato: 16 mEq/L. El examen de elección para confirmar el diagnóstico es:

- a) Niveles plasmáticos de cortisol basal
- b) Prueba de tolerancia a la glucosa con curva de insulina
- c) Creatinina plasmática
- d) Amilasemia
- e) Endoscopia digestiva alta

162) Una niña de 7 meses, con antecedente de síndrome de Down, ha tenido un mal incremento ponderal y aún no duplica su peso de nacimiento. Se cansa al alimentarse y ha presentado varias infecciones respiratorias. Al examen físico se palpa frémito en el precordio izquierdo y se ausculta un soplo holosistólico, ubicado en el mesocardio, con segundo ruido desdoblado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Coartación aórtica
- b) Comunicación interauricular
- c) Canal auriculoventricular completo
- d) Comunicación interventricular
- e) Ductus arterioso persistente

163) Un niño de 12 años consulta por cansancio, artralgiás, dolores musculares generalizados y fiebre. Refiere que las mialgias son intensas, al punto que limitan su actividad física. Al examen físico presenta dolor a la palpación de las masas musculares, en especial en la espalda alta y los hombros. Además, tiene eritema violáceo en los párpados superiores. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis reumatoide juvenil
- b) Distrofia muscular
- c) Dermatomiositis
- d) Triquinosis
- e) Lupus infantil

164) Un niño de 5 años presenta aumento de volumen de 4 cm de diámetro, doloroso, eritematoso y consistencia fluctuante, en relación al hueso hioides, de 3 días de evolución, con sensación febril. El diagnóstico más probable es:

- a) Quiste tirogloso infectado
- b) Quiste branquial infectado
- c) Quiste dermoides infectado
- d) Absceso simple de cuello
- e) Adenitis supurativa

165) Un niño de 7 años desde hace 3 años presenta deposiciones cada vez más infrecuentes y duras. Hace algunas semanas empeoran los síntomas, por lo que se inicia lactulosa 15 ml al día, sin lograr cambios. Además, comienza a manchar frecuentemente los calzoncillos con deposiciones. La causa más probable de la falta de respuesta en este paciente es:

- a) Dosis insuficiente de laxante
- b) Dieta baja en fibra
- c) Enfermedad de Hirschsprung
- d) Presencia de fecaloma
- e) Concomitancia de patología psiquiátrica

166) Un paciente de 60 años, diabético, hipertenso y dislipidémico, con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento con metotrexato, consulta por disminución progresiva de la calidad de la visión. A su examen físico, la exploración ocular es normal, con rojo pupilar normal bilateral. La agudeza visual es 20/25 en ambos ojos. La campimetría muestra defectos visuales en los dos cuadrantes superiores del campo visual izquierdo y en los dos cuadrantes mediales del campo visual derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Degeneración macular relacionada con la edad
- b) Tumor del lóbulo occipital
- c) Catarata
- d) Glaucoma crónico
- e) Neuropatía óptica isquémica

167) Un niño de 4 años consulta por infecciones recurrentes, habiendo tenido una otitis media aguda, 2 bronquitis y 3 amigdalitis en el último año. Presenta rinorrea con frecuencia, obstrucción nasal, respira por la boca y ronca en la noche. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Rinitis alérgica
- b) Inmunodeficiencia primaria por déficit de inmunoglobulinas
- c) Hipertrofia de adenoides
- d) Fibrosis quística
- e) Enfermedad de cilio inmóvil

168) Un paciente de 28 años presenta un pelletazo en la cara, hace 5 días, con golpe en la nariz. Evoluciona con dolor, edema, obstrucción nasal y luego sensación febril. Al examen físico se observa aumento de volumen bilateral, en relación al tabique nasal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Drenaje por punción con aguja fina
- b) Drenaje quirúrgico con bisturí
- c) Taponamiento anterior
- d) Administrar analgésicos
- e) Reducción en pabellón

169) La notificación de las enfermedades transmisibles está relacionada con el siguiente de los objetivos fundamentales de la Salud Pública:

- a) Promoción de la salud
- b) Protección de la salud
- c) Prevención, vigilancia y control de enfermedades
- d) Recopilación y análisis de información
- e) Protección específica de la salud pública

170) Una paciente de 32 años consulta por un cuadro de un mes de evolución, en que sale poco de su casa y presenta desgano y retraimiento social, disminuyendo el disfrute de las actividades que habitualmente le eran placenteras. También refiere desconcentración en su trabajo y, además, ha disminuido la cantidad del tiempo de sueño, en alrededor de 2 horas diarias. Refiere que los síntomas empeoran en el período premenstrual. El diagnóstico más probable es:

- a) Episodio depresivo mayor
- b) Trastorno adaptativo
- c) Hipomanía
- d) Trastorno esquizoafectivo
- e) Trastorno disfórico premenstrual

171) Un hombre de 50 años asegura que es constantemente espiado por los gobiernos de varios países, dado que el maneja información importante y confidencial de muchos políticos y personas de poder. Al preguntarle cómo sabe que lo espían, reacciona enojado diciendo que es obvio y que uno de sus vecinos fue quien inició todo esto. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno delirante
- c) Trastorno esquizoafectivo
- d) Trastorno esquizoide de la personalidad
- e) Trastorno paranoide de la personalidad

172) Un paciente de 57 años presenta múltiples síntomas difíciles de precisar. Se ha realizado múltiples exámenes y evaluaciones médicas, sin poder llegar a un diagnóstico. Sin embargo, él insiste en que está muy enfermo y no puede realizar actividades básicas, como asearse. Hace 2 años fue pensionado por esto, sin cambiar su conducta. Su esposa lo cuida y lo asiste abnegadamente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno por simulación
- b) Trastorno hipocondríaco
- c) Trastorno de somatización
- d) Trastorno facticio
- e) Trastorno de personalidad dependiente

173) Un paciente de 46 años se realiza una colecistectomía abierta. A las 48 horas presenta fiebre de 37,8°C. Al examen físico está eufórico, FR: 14x', FC: 78x', PA: 120/80 mmHg, satura 98% a FiO2 ambiental. Se aprecia herida operatoria sin eritema ni secreción y se revisan las vías venosas, que están permeables, sin signos inflamatorios. Su examen pulmonar presenta crépitos localizados en la base derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Neumonía
- b) Dehiscencia de la anastomosis
- c) Atelectasia
- d) Infección de la herida operatoria
- e) Tromboembolismo pulmonar

174) Una paciente de 40 años, IMC: 30, presenta dolor intermitente en el hipocondrio derecho, desde hace 3 meses, que cede espontáneamente. Se realiza una ecografía, que se muestra a continuación:



Fuente: www.radiopaedia.org

El diagnóstico más probable es:

- a) Colelitiasis
- b) Coledocolitiasis
- c) Colangiocarcinoma
- d) Cáncer de vesícula
- e) Colecistitis

175) Un paciente consulta en el servicio de urgencia, dado que hace 30 minutos le saltó una solución de soda cáustica caliente a la cara, la que entró a los ojos, presentando intenso dolor y dificultades para ver. Al examen físico tiene ojo rojo profundo, córneas opacas y con el ojo derecho solo es capaz de contar dedos, mientras que con el ojo izquierdo tiene agudeza visual 20/80. La conducta más adecuada es:

- a) Analgésicos
- b) Lavado con suero fisiológico abundante por 30 minutos
- c) Antibióticos tópicos
- d) Corticoides tópicos
- e) Parche ocular

176) ¿A qué tipo de medida corresponde el tamizaje de TSH y fenilketonuria que se hace a todos los recién nacidos en Chile?

- a) Promoción de la salud
- b) Prevención específica
- c) Prevención primaria
- d) Prevención secundaria
- e) Prevención terciaria

177) Un paciente de 26 años, sufre un accidente automovilístico de alta energía, como conductor. Llega a la urgencia entablillado y con hemodinamia estable. Destaca la extremidad inferior derecha en flexión y aducción, dolorosa. Se realiza radiografía AP de pelvis, que se muestra a continuación:



Fuente: www.radiopaedia.org

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Fractura de cuello femoral derecho
- b) Fractura posterior de cotilo derecho
- c) Luxofractura posterior de cadera derecha
- d) Fractura de pelvis inestable
- e) Fractura extracapsular de cadera derecha

178) Una paciente de 26 años nota aparición de una lesión en el tercio medio de la pierna derecha, desde hace 6 meses, con crecimiento progresivo. Al examen físico se observa lo siguiente:



Fuente: www.alamy.com

El diagnóstico más probable es:

- a) Nevo
- b) Melanoma
- c) Léntigo
- d) Queratosis seborreica
- e) Queratosis actínica

179) Un paciente de 60 años fue tratado hace 7 días con ciprofloxacino, por disuria. Hace dos días presenta dolor testicular izquierdo, asociado a fiebre. Al examen físico tiene aumento de volumen testicular, con dolor a la palpación, especialmente del conducto espermático. Se observa ligero edema escrotal, con eritema. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hidrocele
- b) Varicocele
- c) Torsión testicular
- d) Tumor testicular
- e) Orquiepididimitis

180) Una paciente de 44 años, con antecedente de estenosis mitral consulta por palpitaciones rápidas, intensas, regulares, asociadas a disnea y malestar general. Se realiza masaje carotídeo, observándose el siguiente trazado en el electrocardiograma:



Fuente: <https://empendium.com/manualmibe/chapter/B34.II.2.6.7.>

El diagnóstico más probable es:

- a) Taquicardia paroxística supraventricular
- b) Fibrilación ventricular
- c) Taquicardia sinusal
- d) Flutter auricular
- e) Taquicardia ventricular

Primera parte

- 1 E Pregunta difícil, pero tiene una cefalea con signos de HTEC y signos focales, más convulsiones. Orienta a trombosis de seno cavernoso el antecedente de ACO. También podría haber sido un tumor cerebral, aunque con una evolución más lenta. La migraña sería crónica.
- 2 D Toda disfonía crónica se estudia con NFC. En este caso, además, el cuadro clínico sugiere cáncer de laringe, así que con mayor razón está indicada la NFC.
- 3 A Es un glaucoma agudo clásico.
- 4 B La planificación es a largo plazo y se refiere a la estrategia global de la institución. La programación se basa en la planificación y fija las actividades a realizarse y los recursos necesarios en el corto plazo, generalmente anual, mensual y semanalmente. La A, D y E están al revés los conceptos de planificación y programación. Ambas deben ser compatibles con la misión (la forma en que satisface una necesidad) y la visión (objetivo a largo plazo de la institución), ya que estas regulan la planificación, la que, a su vez, determina la programación.
- 5 B Tiene un chanco o sífilis primaria clásica. Por tanto, no requiere ningún examen, ya que el diagnóstico es clínico y los exámenes suelen estar normales. A lo más, se confirma con una microscopía de campo oscuro. Sin embargo, la única opción concordante con sífilis es la B y, sea como sea, es necesario para el seguimiento de la respuesta al tratamiento (debería negativizar, si es que positiviza).
- 6 D Pregunta muy discutible y fuera de lo que debe hacer un médico general. Sin embargo, si es que la sonda se retiró, sin mayor daño, ni signos clínicos de perforación o filtración, se puede volver a instalar una nueva.
- 7 B Tiene un tumor pulmonar izquierdo y la clínica sugiere cáncer. Luego de la RxTx se recomienda una TAC, antes de proceder a la biopsia (por broncoscopía, en este caso), ya que que permite ver la ubicación, características y estado de diseminación, además de ayudar a detectar otros diagnósticos diferenciales.
- 8 C El manejo de la distonía aguda (tortícolis espasmódica, en este caso) es suspender el antipsicótico más administrar BDZ.
- 9 D Es una pregunta difícil. El diazepam da síndrome narcótico. La sertralina, síndrome serotoninérgico. La clorpromazina, síndrome neuroléptico maligno y síndrome anticolinérgico. La clínica sugiere síndrome serotoninérgico, que mezcla elementos del síndrome neuroléptico maligno (hipertonía, hipertermia y compromiso de conciencia), con el síndrome adrenérgico (HTA, taquicardia, hipertermia).
- 10 B Tiene un huevo anembrionado menor a 25 mm, por lo que puede ser un aborto retenido o un embarazo normal, debiendo controlarse con una ecografía en 7 a 14 días.
- 11 D El tamoxifeno aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. De todos modos, el manejo de la metrorragia postmenopáusica es estudiarla con una ecografía TV y luego biopsiar, si es que la ecografía no es compatible con una clara atrofia (endometrio menor a 4-5 mm o menor a 8 mm si está con TRH).

- 12 E Es una clásica disección aórtica, con el soplo diastólico de la insuficiencia aórtica (se diseca la válvula). Es tipo A, porque, al afectar la válvula, obviamente está sobre la subclavia izquierda.
- 13 A Tiene una manía clásica, secundaria al uso de fármacos y, por tanto, tiene un TAB.
- 14 B Pregunta muy difícil, pero tiene un claro síndrome nefrótico, que, por estar en contexto de una diabetes, se sospecha sea por nefropatía membranosa. Por ser una mujer joven, también podría ser un lupus, con nefropatía membranosa. De las opciones, solo la biopsia renal serviría para avanzar en el diagnóstico. Sí hay que solicitar ANA y complemento (no ANCA, ya que las vasculitis son nefríticas).
- 15 D Es un TOC clásico de con obsesión de acción negativa y compulsión de evitación. Otros ejemplos preguntados han sido la obsesión de ser pedófilo, ser infiel, agredir a las personas de la calle, empujarlas al metro.
- 16 B Birrads 0 = ecografía; Birrads 1 = control en 1 a 2 años; Birrads 2 = control en 1 a 2 años; Birrads 3 = mamografía en 6 meses (se puede complementar con ecografía); Birrads 4 = biopsia estereotáxica (si no es palpable) o con aguja gruesa (si palpable); Birrads 5 = biopsia quirúrgica.
- 17 E Es un SHU clásico: falla renal, anemia hemolítica y plaquetopenia. Suele estar precedido por diarrea en el 70% de los casos. La IRA prerrenal no tiene edema.
- 18 E Es una pregunta muy discutible, ya que tiene una clara anemia ferropénica, grave y se debe estudiar la presencia de cáncer digestivo, ya que es un adulto mayor. Sin embargo, probablemente sí se lo deba transfundir, ya que tiene una anemia muy sintomática. Por regla general, pero no absoluta, no se transfunden si tiene Hb mayor o igual a 10 g/dl y se suelen transfundir casi todos, si está menor a 7 g/dl. Entre 7 y 10, se ve caso a caso (aunque siempre se ve caso a caso). Dada la forma en que está redactada, recomiendo marcar la transfusión.
- 19 E Si bien, en estricto rigor, lo que tiene es un síndrome postcolecistectomía, la E es la única opción aceptable y la colecistectomía puede empeorarlo (síntomas disautonómicos y digestivos postingesta de alimentos de rápida absorción).
- 20 A A y C son respuestas aceptables para el manejo de una NIE 1; también la tipificación, al menos, según la guía Minsal. Sin embargo, lo más importante siempre es el control periódico de la paciente con un PAP alterado y, por eso, lo dejaremos como la respuesta correcta.
- 21 C El PAP de alto grado siempre va a colposcopia y biopsia. La tipificación de VPH no ha demostrado ser un buen examen y la guía Minsal solo lo tiene como opción ante el ASCUS (PAP de bajo grado) y no para el ASCH (alto grado).
- 22 E Ascenden con la deglución solo la el QTG y el nódulo tiroideo. Pero el QTG está en la línea media y no en el lado derecho, como este caso.
- 23 D Todo nódulo tiroideo se estudia con Ecografía y TSH + T4L. Si tiene más de 10 mm, se punciona con PAAF. Si tiene menos de 10 mm, se sigue (este caso). Si tiene TSH baja (hipertiroidismo) se estudia con cintigrafía tiroidea.

- 24 B Tiene un RCIU severo (p2 o menos), por lo que se interrumpe a las 34 semanas, por cesárea. RCIU no severo (p3-4: moderado; p5-9: leve) y con Doppler normal: 37 semanas por parto vaginal. Doppler alterado siempre cesárea a las 34 semanas (flujo umbilical ausente en diástole), 30 semanas (flujo reverso en diástole) o 26 semanas (ducto venoso reverso).
- 25 D Tiene una varicela clásica. Aciclovir y valaciclovir se podrían indicar, pero solo en mayores de 13 años, el segundo caso de la familia, un cuadro grave o un paciente inmunodeprimido. Por tanto, no están indicados, en este caso.
- 26 E Tiene un impétigo clásico. Se trata con cloxacilina, flucloxacilina, cefadroxilo o amoxi-clavulánico por 7 a 10 días. O bien con mupirocina o furazolidona tópica.
- 27 A Tiene un cuadro clínico y espirometría (patrón obstructivo que mejora con BD) compatibles con asma.
- 28 A Es una CIA clásica, por la dilatación derecha y el desdoblamiento fijo del 2º ruido.
- 29 D La hiperbilirrubinemia es la complicación más frecuente del cefalohematoma (descrito en el caso). Las demás pueden ocurrir, pero son infrecuentes.
- 30 B Tiene una tiroiditis subaguda de Quervain, cuyo tratamiento son los AINEs. No se usan las drogas antitiroideas y no sirve el yodo radiactivo (de hecho, no capta). El betabloqueo sí se usa cuando hay síntomas de hiperT4, pero lo más importante son los AINEs.
- 31 B Es una agorafobia clásica. Como solo tuvo una crisis de pánico y relacionada con un estímulo agorafóbico clásico (puentes, estacionamientos, muchedumbres, lugares cerrados, lugares abiertos, metro) no es un trastorno de pánico (crisis de pánico recurrentes, sin causa aparente, el que puede venir con agorafobia).
- 32 E Tanto gonococo como clamidia producen conjuntivitis neonatal, pero la gonorrea suele ser muy purulenta y aparecer en la primera semana de vida. La clamidia, en cambio, puede demorar más (algunas semanas), ser menos purulenta y asociarse a neumonía, similar a las neumonías atípicas.
- 33 C Es una catarata clásica por la disminución de la AV y por la alteración del rojo pupilar (la opacidad como estrella es la catarata misma). La RD no tiene síntomas; el edema macular tiene disminución de la AV en pocos días y no altera el rojo pupilar. El glaucoma no afecta la AV, sino el campo visual y no afecta el rojo pupilar. La HV tiene aparición súbita y se pierde el rojo pupilar.
- 34 E Es una embolia renal clásica, en contexto de una FA (ritmo irregular). Si no tuviera la FA podría haber sido un cólico renal.
- 35 C OR mayor a 1, muestra una asociación con aumento del riesgo; sin embargo, el IC, que pasa por el 1 (0,86 es menor a 1 y 2,1 es mayor a 1), hace que no exista una asociación significativa.
- 36 A Tanto por la edad como por el uso de TRH combinada, que tiene progestágeno, lo más probable es una atrofia endometrial.
- 37 B Tiene un delirium tremens clásico, que se trata con benzodiacepinas, en especial el diazepam. El lorazepam también es útil y es el de elección en el DHC.

38 E Es una pregunta difícil, pero que esté enflaquecido más el cuadro clínico, hace que se trate de una neumonía por P. jiroveci. Si hubiese venido sin mayores antecedentes y con un cuadro un poco más corto, sin baja de peso, habría que pensar en Mycoplasma, que puede ser igual. La fibrosis y el asma serían cuadros más crónicos, con radiografías distintas (panal de abejas en fibrosis y normal o hiperinsuflación en asma). La neumonitis viral es aguda.

39 B Pregunta rara, ya que ni siquiera dicen que hay un tumor, pero reacción perióstica y el compromiso de partes blandas son clásicas de un tumor maligno. Por la edad, lo más probable es un osteosarcoma. Es frecuente en el Eunacom que se dé el antecedente de trauma (aunque no tenga relación) en distintos tipos de tumores, ya que ahí es que se lo palpan.

40 B La sospecha es un coqueluche, que se trata con macrólidos.

41 B Tiene una epilepsia mioclónica. Los niños con epilepsia sí pueden ver pantallas, pero máximo 1 hora al día, con una buena iluminación.

42 B La autorización sanitaria (Seremi) sí se exige para acreditar al prestador (por la Superintendencia), lo que hace que sea un distractor fuerte, pero la acreditación es el acto que muestra la calidad. Los plazos se relacionan con el principio de oportunidad. Los convenios con Isapres y Fonasa se relacionan con el principio de acceso universal. El subsidio estatal se relaciona con el principio de protección financiera.

43 D Es una verruga paraungueal clásica.

44 C La sospecha es una diabetes gestacional (glicemia de ayuno mayor o igual a 100), por lo que se debe repetir. Si hubiese estado mayor o igual a 126 la sospecha sería una diabetes pregestacional, aunque la conducta sería la misma. Si no hubiese estado embarazada, se tendría que pedir un TTGO.

45 D Es un HAP clásico, por la hipokalemia y la sintomatología asociada a dicha hipokalemia. Eso sí, la HTA RV también tiene hipokalemia, así que, si tuviera soplo, antecedentes CV (que den estenosis renal) o hubiese estado HAP en las opciones, la RV habría sido la respuesta.

46 C Todas pueden ser profesionales, pero el mesotelioma casi exclusivamente se da en contexto de exposición a asbesto en las plantas de producción. En Chile se cerraron hace algunos años atrás.

47 A Si la enfermedad crónica es incurable, al mejorar el tratamiento, se muere menos gente y aumenta la prevalencia. Si fuera curable, sí disminuiría la prevalencia, ya que se curarían. Sin embargo, la D y la E hacen pensar que la respuesta que se quería como correcta era la A.

48 B Birrads 0 = ecografía; Birrads 1 = control en 1 a 2 años; Birrads 2 = control en 1 a 2 años; Birrads 3 = mamografía en 6 meses (se puede complementar con ecografía); Birrads 4 = biopsia estereotáxica (si no es palpable) o con aguja gruesa (si palpable); Birrads 5 = biopsia quirúrgica.

49 B Tiene colestasia en las pruebas hepáticas, sin hepatitis (por las GOT y GPT mínimamente elevadas) ni falla hepática (protrombinemia y albúmina normales). Por ser mujer y de esa edad lo más probable es una CBP, la que, además, se demora en elevar la bilirrubinemia, afectando mucho más las FA y luego la GGT. La coledocolitiasis tendría dolor y

mucha más ictericia. El cáncer produce bastante ictericia también. La CEP (opción D) suele asociarse a colitis ulcerosa o enfermedad de Cröhn y afectar más a hombres.

50 B El cuadro clínico es una fibromialgia y los marcadores algo elevados no tienen mayor relevancia (recordar que son una trampa).

51 E El nódulo tiroideo se inicia su estudio con la ecografía cervical. Se continúa el estudio, de acuerdo a lo explicado en la pregunta 23. Si bien igual probablemente se hará pa biopsia citológica por punción, el examen inicial sigue siendo la ecografía.

52 D Por el alto riesgo de cáncer, la HPE compleja, la HPE atípica y la HPE compleja y atípica se manejan todas con histerectomía, a menos que la paciente tenga muchos deseos de paridad, en que se intenta un tratamiento combinado de legrado y progestágenos.

53 B Si bien la disfagia ilógica es clásica de la acalasia (disfagia baja) y de la esclerodermia, también se puede ver en el divertículo de Zenker (disfagia alta), ya que puede estar más o menos lleno de alimentos. Eso sí, la halitosis orienta fuertemente a divertículo esofágico.

54 C Tiene una trombofilia (A y C son compatibles). El TTPA alargado y el VDRL reactivo orientan mucho a un síndrome antifosfolípidos. El déficit de factor VIII produce hemofilia, por lo que tiene hemorragias, al igual que la EvW.

55 C Es otro síndrome antifosfolípidos, por la misma razón del TTPA alargado (mayor a 40).

56 B Tiene una polineuropatía diabética, cuyo diagnóstico es clínico, por lo que no necesita ningún examen para confirmarse. Sin embargo, la electromiografía es el examen que permite objetivarla.

57 D Es una acatisia clásica. Ver resumen de psiquiatría.

58 B El tratamiento de los pólipos nasales es con corticoides orales. Si solo hubiese tenido la rinitis alérgica, con obstrucción, pero sin pólipos, el tratamiento serían los corticoides tópicos.

59 E Es una amnesia disociativa clásica.

60 A Por haber iniciado antes de las primeras 24 horas es patológica. La madre O puede hemolizar al hijo B. La madre Rh positiva no puede hemolizar al hijo Rh negativo (solo hemolizan las madres Rh negativas a los hijos Rh positivos).

61 C Tiene una ictericia tardía, de predominio directo, por lo que se sospecha una atresia biliar primaria. A, B y D son de predominio indirecto. La hepatitis neonatal es menos importante como diagnóstico.

62 C Los HGO se pueden mantener actualmente en el embarazo. La levotiroxina sí se aumentará probablemente cerca de un 30%, de modo de lograr el objetivo de TSH entre 0,4 y 2,5. Sin embargo, los antiHTA son teratogénicos y se deben cambiar por alfametildopa. El ácido fólico se debe dar 0,4 mg/día, a menos que sea diabética o tenga antecedentes de defectos del tubo neural, en que se sube a 4 mg/día.

- 63 D Las metrorragias de la segunda mitad del embarazo se estudian con ecografía obstétrica (diferencias placenta previa del DPPNI). Eso sí, si hay sufrimiento fetal, el examen más importante es el tacto vaginal, de modo de determinar la vía más expedita de parto.
- 64 E Aunque el diagnóstico de asma es principalmente clínico, tanto la espirometría como la prueba de provocación con metacolina son útiles para apoyar el diagnóstico. La espirometría es de elección en los pacientes con obstrucción clínica y la provocación con metacolina es de elección en los pacientes sin nada de obstrucción basal, como en esta paciente.
- 65 D Es una tuberculosis clásica, tanto por la clínica como por la radiografía. Si bien el cáncer también es compatible, la edad, la situación de calle, la elevación de los parámetros inflamatorios, la secreción mucopurulenta, la fiebre y la radiografía orientan más a TBC.
- 66 E El priapismo (erección dolorosa mayor a 4 horas, con pérdida de turgencia del glándulo y cuerpo esponjoso) se trata con fenilefrina intracavernosa, como primera línea.
- 67 E Actualmente la vacuna antivariólica y antiVHA no son optativas, pero se dan después del año de edad, a los 18 meses, según el PNI. La neumocócica está en el PNI, pero se da la conjugada en menores de dos años (2, 4 y 12 meses; prematuros también 6 meses) y no la polisacárida. La de la influenza se da desde los 6 meses, durante la campaña de vacunación anual. La del rotavirus es electiva, se da a los 2 y 4 meses, reduce las hospitalizaciones por diarrea, podría aumentar el riesgo de intususcepción (probablemente no, pero igual la contraindica) y por ser a virus vivo, puede producir fiebre, diarrea y está contraindicada en inmunosuprimidos.
- 68 C Pregunta muy rara, ya que parece un síndrome de manguito rotador. Sin embargo, el ascenso de la cabeza humeral orienta a la rotura del tendón supraespinoso. La tendinitis calcáica tendría calcificación del tendón del bíceps, lo que se vería. La capsulitis adhesiva limitaría totalmente los movimientos.
- 69 D Tiene una monoartritis aguda, que se estudia con punción. Por clínica, probablemente será una condrocalcinosis, pero también puede ser una artritis séptica, por lo que es fundamental la punción.
- 70 B Se erradican los pacientes con antecedente de úlcera y los con factores de riesgo para úlcera (uso de AINEs, dispepsia) y cáncer (displasia, metaplasia, antecedentes familiares marcados).
- 71 E La vacuna pertusis celular ya no se usa en Chile, precisamente porque tenía efectos adversos muy graves, como los ahí descritos.
- 72 A Es una bronquiolitis clásica, por VRS.
- 73 A Es un trastorno conversivo clásico: síntomas neurológicos sin una causa orgánica de base.
- 74 E Es un TEA clásico.
- 75 C Que tenga hipersomnia hace sospechar que haya un SAHOS, por lo que se debe estudiar con una polisomnografía.
- 76 B La hipertrofia de parótidas es un signo de vómitos recurrentes.

77 D? Pregunta muy discutible, ya que hay dos respuestas potencialmente correctas: la C y la D. La galactorrea se estudia 1. descartando embarazo y 2. luego prolactinemia. Dado que su FUR fue hace 8 días da a entender que no está embarazada y, por tanto, la respuesta debería ser prolactinemia. Sin embargo, también están las máximas "descarte siempre embarazo primero" y "no le crea a la FUR". Finalmente, el dolor mamario con congestión sugiere algo más embarazo que un prolactinoma. En fin, así es el Eunacom. Si bien en la clase les dije que marcaran la C, hoy amanecí marcando la D; la volvimos a discutir con varios ginecólogos y las opiniones estuvieron divididas, aunque tendió a ganar descartar el embarazo. Si encuentran esta pregunta, sigan su corazón, marquen la que más los convenza a ustedes y sigan.

78 C? Pregunta muy discutible, pero el ACO que controlar mejor el sangrado, de los que ahí están sería los que tienen etinilestradiol (en lugar de estradiol) con dienogest, que, además, tiene un excelente perfil cardiovascular. Es una pregunta que excede lo que debe saber un médico general

79 A El DIU medicado no produce la hipermenorrea y dismenorrea del DIU común. Además, tiene el mejor perfil cardiovascular, en relación a los métodos hormonales.

80 A Es un carcinoma espinocelular clásico, en especial porque se describe como "escamosa" y ulcerada y tiene antecedente de fotoexposición. Los demás cánceres también se pueden ulcerar. El granuloma piógeno sangra mucho, pero es de aspecto rojo y húmedo.

81 E Tiene un TTGO normal (basal menor a 100 y postcarga menor a 140), por lo que se debe observar.

82 B Lo más importante en la angina crónica es revascularizar (se pide test de esfuerzo y luego angiografía, para hacer angioplastia o bypass) y, además, dejar las estatinas y sobre todo la aspirina. Sin embargo, además, sirven los nitritos, como el isosorbide o la nitroglicerina. Los demás son antihipertensivos o fármacos para la insuficiencia cardíaca.

83 D Tiene una hepatitis, que, por descarte, es farmacológica (por la isotretinoína). No es VHA, porque la IgM está negativa. No es VHB porque el antígeno de superficie está negativo (no aporta mayor información los anticuerpos totales anticore). No es VHC, porque los anticuerpos totales anti VHC está negativos.

84 C Tiene reflujo clínico y por endoscopia. El tratamiento es IBP (ej. omeprazol) a permanencia. Que los síntomas hayan recurrido, solo hace que con mayor razón sea reflujo y se deban reiniciar los IBP.

85 B Es una pregunta discutible, ya que tiene la historia de una cistitis intersticial (se estudia con cistoscopia) y también la de atrofia genital (se trataría con estrógenos tópicos). El dolor abdominal bajo y la polaquiuria sugieren mucho más una cistitis intersticial.

86 C Tanto por la clínica, como por el antecedente de glibenclamida, lo más probable es que tenga hipoglicemias (probablemente se sintió mal de haber estado mal controlado e intentó arreglar sus glicemias subiendo la dosis de GBC).

87 D Tiene un líquido pleural sugerente de cáncer (exudado: cumple todos los criterios de light; mononuclear; con ADA menor a 30). Dado que la radiografía no muestra un tumor pulmonar, se debe proceder a las biopsias pleurales, las que se hacen por videotoracosopia y, si no está disponible, de manera percutánea.

88 B? La EBG, por ser autoinmune, con presencia de anticuerpos (los TRAB), tiene riesgo de pasar dichos anticuerpos al niño, incluso si es que la enfermedad está bien controlada. Por tanto, se produce un hiperT4 transitorio. Tanto la TSH y T4L como los niveles de TRAB deben solicitarse y se piden en varios momentos. De ellos, la función tiroidea es lo más importante y se piden a las 48 horas y también a los 15 días y en varios otros momentos. Al nacer pueden estar alterados por los valores maternos. Es una pregunta fuera de lugar y que no tiene una única respuesta.

89 D El hiperparatiroidismo produce salida de calcio desde los huesos, lo que aumenta la calcemia y también la calciuria, produciendo litiasis urológica.

90 B Tiene una sección uretral, la que se estudia con UCG y se trata con cirugía. Recordar que está contraindicada la sonda (también la cistoscopia) y si hay globo vesical se maneja con cistostomía suprapúbica.

Segunda parte

91 C Es una HV clásica, que es la causa de ceguera en la retinopatía diabética. La pérdida de rojo pupilar es un signo característico, aunque no se mencione. El infarto occipital daría hemianopsia homónima contralateral. El DR sí pierde la visión, pero suele ser como una "caída de telón" o "levantamiento de pared" y estar precedido de fotopsias y entopsias. La DMRE es crónica y la AV disminuye lentamente. El edema macular sí puede producir ceguera, pero demora varios días en instalarse.

92 C Es una pregunta rara, por la forma en que está redactada la pregunta, pero A, B, D y E pasan por el 1 y, por tanto, no son significativas. Solo la C, el sexo masculino es un factor protector, ya que tiene un OR menor a 1 (disminuye el riesgo) y, además, no pasa por el 1 (tanto 0,33 como 0,87 son menores a 1).

93 A Como tiene una vía biliar mayor a 7 mm, está dilatada y lo más probable es que sea una coledocolitiasis. Llama la atención que no tenga dolor, pero probablemente tiene una obstrucción incompleta. No tiene fiebre ni compromiso de conciencia ni hipotensión, como para pensar en colangitis aguda. La B y la D son raras y no dilatan la vía biliar. La colelitiasis no tiene ictericia, aunque en este caso el barro biliar sugiere que sí hay una colelitiasis de base, que produjo la colelitiasis.

94 B Los sesgos de información o sesgos de medida son aquellos en los que la información obtenida está sesgada. En este caso se trata de un sesgo del instrumento de medición. Ver resumen de SP o una película de terror (son iguales).

95 C Tiene clara coexistencia de síntomas psicóticos (alucinaciones y delirio) con síntomas anímicos depresivos, por lo que es un T. esquizoafectivo clásico.

96 D Es una pregunta difícil y discutible. El diagnóstico más probable es una coledocolitiasis. Suele iniciarse con ecografía. De elección para el diagnóstico la colangioRMN (por eso la dejamos como respuesta correcta). Sirve, además, como examen no solo diagnóstico, sino terapéutico, la CPRE (la que se pide si 1. la ecografía ve cálculos en el colédoco [no en la vesícula], 2. la CPRE confirma el diagnóstico o 3. la clínica es de colangitis).

- 97 E Tiene una colangitis aguda clásica. Se trata con drenaje endoscópico de la vía biliar (además, se da SF ev, ATB ev y, en segunda instancia, se realiza una colecistectomía laparoscópica).
- 98 D Se sospecha un TEP y se estudia con angioTAC de tórax.
- 99 C Las lesiones en diana y la gran afectación de mucosas hace que el diagnóstico sea un SSJ. La mononucleosis sí tendría el exantema morbiliforme, pero sin afectación rectal ni vaginal y habría aparecido al inicio del uso de la amoxicilina.
- 100 C Pregunta difícil, ya que A, B, C y D pueden producir ese cuadro clínico. Sin embargo, la Chlamydia es la causa más frecuente de uretritis, después de la gonorrea (la que bastante purulenta, casi siempre; mientras que las demás pueden no serlo).
- 101 B Tiene una incontinencia urinaria de urgencia, primero se debe descartar ITU y luego se trata con cambios conductuales y anticolinérgicos (tolterodina y oxibutinina). Esta es una de las preguntas que hace pensar que para el Eunacom se deben marcar los anticolinérgicos de inmediato en el manejo de la IOU.
- 102 D El manejo de la retención de hombros es primero la D, luego la B y luego la C, seguido de maniobras más agresivas (fracturar la clavícula del RN, sinfisiotomía púbica).
- 103 C Tiene una RPM mayor a 34 semanas, por lo que se debe interrumpir. En este caso no tiene indicación de cesárea, sino que bastaría con inducirla con misoprostol. Si fuera menor a 34 semanas, se maneja con corticoides, antibióticos y conducta expectante.
- 104 D Tiene dos razones para hacer la amniocentesis: 1. Un parto prematuro que no respondió a los tocolíticos de primera línea (nifedipino) y 2. Una sospecha de infección intramniótica, pero sin cumplir los criterios de corioamnionitis (dos o más de los siguientes: fiebre > 38°, taquicardia fetal, taquicardia materna, leucorrea, dolor a la palpación uterina y blancos > 15.000).
- 105 A Tiene una corioamnionitis clínica, por lo que se debe interrumpir bajo cobertura antibiótica, independientemente de la edad gestacional. También tiene RPM, OHA y RCIU, pero gana el diagnóstico de corioamnionitis.
- 106 B Tiene una probable atrofia endometrial (metrorragia postmenopáusica, con EM menor a 5 mm), por lo que se observa y controla.
- 107 D Si bien tiene solo una toma de glicemia, dos glicemias de ayuno mayores o iguales a 126, en un embarazo menor a 12 semanas es una DMPG. Si estuvieran entre 100 y 125 sería DMG.
- 108 C Tiene infertilidad por anovulación, secundaria al SOP (cumple criterio ecográfico y menstrual). Se induce la ovulación con clomifeno. La metformina podría ser útil, pero solo en las pacientes con resistencia a la insulina (no es el caso, por tener HOMA normal).
- 109 D Tiene una fase activa lenta, que no ha progresado, por lo que se debe hacer una prueba de parto (RAM, anestesia y oxitocina para tener 3 a 5 CU/10 min: no necesario en este caso, ya que tiene 3 CU/10 min).
- 110 D La clásica amigdalitis exudativa en el menor de 3 años es por ADV. Suele tener fiebre alta y, en este caso, además, viene con la clásica fiebre faringoconjuntival por ADV. Si no hubiese tenido afectación ocular igual sería por ADV, así que a aprender este caso clínico.

- 111 B Por clínica y por radiografía, tiene una epifisiolisis de la cabeza femoral izquierda.
- 112 D Se sospecha una enfermedad de Hirschsprüng, que se diagnostica con la biopsia intestinal, que muestra aganglioneosis del plexo submucoso o mientérico, en el segmento afectado.
- 113 A Por clínica, parece un soplo funcional. Sin embargo, no está entre las opciones. Por estar en el foco pulmonar (paraesternal izquierdo), se debe marcar CIA. La estenosis aórtica sopla paraesternal derecho (foco aórtico). La CIV tiene soplo holosistólico y el ductus tiene soplo continuo. La estenosis pulmonar tendría otros síntomas y es mucho menos frecuente que la CIA.
- 114 D Tiene una bacteriuria asintomática, que se observa, incluso en el adulto mayor o en el paciente sondeado (solo se trata en la embarazada). Si es resistente a las cefalosporinas, habría sido BLEE y, por tanto, si tuviese síntomas, el carbapenémico sería la respuesta.
- 115 D La diarrea crónica en el paciente VIH es primeramente por *Cryptosporidium sp.* Luego por *Isospora Belli* y discutiblemente por *Microsporidium sp.*
- 116 D Por tener una osteoporosis (T score menor o igual a -2,5) se debe tratar con bifosfonatos. Sin embargo, también se debe dar calcio y vitamina D e indicar ejercicios. Asumimos que se pregunta la diferencia entre osteopenia y osteoporosis.
- 117 C Parece un cáncer de recto, que es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos y con virus papiloma humano (también de transmisión sexual).
- 118 A Tiene una angina crónica de pared inferior (dolor epigástrico), dada la clara relación con el ejercicio. La angina mesentérica tiene dolor postingesta de comida.
- 119 E Tiene una hepatitis. El antecedente de transfusiones hace pensar en VHC, que se estudia con anticuerpos totales anti VHC. En la vida real se pedirían más exámenes.
- 120 A Se sospecha una enfermedad celíaca, que se estudia con anticuerpos antitransglutaminasa o antiendomiso, más una endoscopia digestiva alta, con biopsia duodenal.
- 121 D El antecedente de síndrome nefrótico orienta a TEP y la clínica también. Que tenga un líquido hemorrágico es clásico de TEP, que suele ser un exudado pleural hemorrágico, ya sea de predominio mononuclear o polimorfonuclear.
- 122 A El edema de EEII hace que probablemente sea un efecto adverso del amlodipino, por lo que se debe suspender.
- 123 D La ICC con disfunción sistólica contraindica el nifedipino. Pregunta difícil.
- 124 D El soplo sistólico y los síntomas de ICC izquierda hacen sospechar la insuficiencia mitral. La expectoración rosada suele ser más de estenosis mitral, pero sí se puede ver en la insuficiencia mitra. Ver resumen de semiología cardíaca.
- 125 C Es una rotura clásica del músculo papilar con la insuficiencia mitral secundaria. Insisto, lean el resumen de semiología cardíaca.

- 126 A Es una estenosis aórtica clásica. De verdad hay que leer y aprenderse el resumen de semiología cardíaca.
- 127 D Tienen una neumonía típica (con condensación del lóbulo inferior izquierdo), adquirida en la comunidad, sin criterios de hospitalización y en un menor de 65 años, sin antecedentes relevantes (la HTA no agrava las neumonías, salvo las por covid-19), por lo que se debe tratar con amoxicilina sola.
- 128 B Es una AR clásica.
- 129 E Es una artritis psoriática clásica, con la pelviespondiloartropatía, que se estudia con RMN de sacroilíacas, como el mejor examen, considerado de elección actualmente (por eso la dejamos como correcta), aunque se suele iniciar con la Rx de sacroilíacas.
- 130 B Es una EvW clásico (alteración de hemostasia primaria: petequias y alveolorragia), con plaquetas normales (es disfunción plaquetaria) y puede alargar levemente el TTPA. La hemofilia alarga el TTPA pero tendría muchos más síntomas y hematomas, además de hemartrosis y sin petequias.
- 131 A Tiene clínica de una miopatía: debilidad proximal, sin alteraciones sensitivas ni de los reflejos. B, C y E afectan los reflejos y tienen otros síntomas. La raquiestenosis principalmente tiene dolor al caminar, más afectación de las raíces comprometidas. D afecta más a niños, ya que es genética.
- 132 B Tiene diagnóstico de diabetes (dos glicemias mayores o iguales a 126). Por la edad y por no tener mayores antecedentes, lo más probable es que sea tipo 2. Por no tener indicaciones de insulina (ej. HbA1c mayor a 9%), se debe iniciar con metformina.
- 133 E Es una nefritis intersticial clásica, secundaria al uso de antibióticos, en contexto de un síndrome de DRESS (con eosinofilia). La lesión inicial era una erisipela o una celulitis.
- 134 C Si bien tiene todos los lípidos malos, tiene una hipercolesterolemia LDL muy elevada, por lo que requiere estatinas. Las mialgias, por lo general se estudian con CK. Si están normales, se evalúa mantener el tratamiento. Si están elevadas, se debe evaluar el riesgo / beneficio de la estatina. La rosuvastatina es de bajo riesgo de mialgias, al igual que la atorvastatina, por lo que, de las opciones, parece la más correcta, dado que los demás fármacos no son buenos para la hipercolesterolemia LDL.
- 135 D Es una fascitis necrotizante clásica.
- 136 A Es un chancro o sífilis primaria clásica. Es frecuente que las pruebas treponémicas y no treponémicas estén negativas al inicio, por lo que el diagnóstico es clínico (a lo más se confirma con una microscopía de campo oscuro).
- 137 E Tiene una celulitis. Se trata con antibióticos orales (solo si no tiene fiebre) o idealmente endovenosos, que cubran *S. aureus* (cloxacilina, flucloxacilina, cefalosporinas de primera generación; en alérgicos a todos los betalactámicos: clindamicina).
- 138 E Tiene un síndrome de hipertensión endocraneana más compresión del quiasma óptico, por lo que se trata de un tumor hipofisiario compresivo.
- 139 A Pregunta difícil, pero la cefalea ictal muy intensa sugiere HSA. El compromiso de conciencia también. Ver resumen de semiología neurológica.

- 140 A Tiene un hiperparatiroidismo secundario a la insuficiencia renal. Si bien la calciuria de 24 horas permite ver el grado de pérdida de calcio diario, lo más importante será determinar los niveles de vitamina D, ya que tanto la falla renal, como el hiperparatiroidismo mismo disminuyen sus niveles, agravando la osteodistrofia. Al medirla, se puede observar el déficit, de modo de indicar suplementos de vitamina D y, además, permite descartar el déficit primario de vitamina D, como causa del HPP.
- 141 A Tiene un déficit de B12, por baja ingesta (dieta vegana). La anemia macrocítica y megaloblástica (VCM > 108) la sugiere fuertemente.
- 142 C Si bien las úlceras orales sugieren más una enfermedad de Cröhn que una colitis ulcerosa, el cuadro clínico es compatible con una enfermedad inflamatoria intestinal, con la artritis secundaria y eritema nodoso. El LES sí tiene úlceras orales, pero es rara la afectación digestiva. La enfermedad de Behcet sí tiene úlceras orales y genitales, más artritis, pero con afectación del SNC y SNP y sin afectación digestiva.
- 143 D Tiene imágenes sugerentes de bronquiectasias bilaterales. El resto del cuadro clínico es compatible con una FQ, a pesar de la edad (neumonías bacterianas a repetición: habitualmente por *S. aureus* y *P. aereginosa*).
- 144 E Si bien es una pregunta rara, que tenga una lesión quística, más eosinófilos en el LCR hace que sea una neurocisticercosis por *Taenia solium*.
- 145 C Es una pregunta rara, pero se trata de un caso de RGE con síntomas atípicos: disfonía matinal. Otros son caries y asma de difícil manejo.
- 146 C? Es una pregunta técnicamente mala, ya que debe recibir corticoides inhalados (C) más broncodilatadores de corta acción (B) y, dada la abundancia de síntomas, probablemente también de larga acción (D). Además, obviamente debe dejar de fumar (A). De las opciones, tengo la impresión de que la respuesta podría ser C, porque los corticoides son los que previenen la aparición de síntomas, aunque el salbutamol debe indicarse de inmediato, por estar tan sintomático, aunque no cada 6 horas, sino SOS.
- 147 A El UCT está negativo, ya que para ser positivo requiere más de 100.000 UFC por ml. Por tanto, la única opción correcta es la A.
- 148 D Tiene una procidencia de cordón, por lo que se debe interrumpir de inmediato. El TV ayuda a 1. descomprimir el cordón umbilical y 2. determinar las condiciones obstétricas para la vía más expedita de parto (aunque suele ser por cesárea en la procidencia de cordón). La bradicardia también obliga a interrumpir por la vía más expedita (por tanto, hay que hacer también un TV).
- 149 E Pregunta difícil. Tiene un RCIU leve (p5 a p9) con Doppler normal, por lo que sería un RCIU tipo I, que se interrumpe a las 37 semanas o incluso a las 40 semanas, si es que se considera un PEG (todo bien y Doppler normal, como en este caso). Para hablar de "detención del crecimiento" deben pasar al menos 2 semanas, ya que en un tiempo menor está dentro de la variabilidad de la misma ecografía. Por tanto, en este caso, se debe seguir controlando con el Doppler semanal. Si tuviera menos de 34 semanas sí se darían corticoides. El PBF probablemente también se pediría.
- 150 A Tiene un DPPNI sintomático, por lo que se debe interrumpir por la vía más expedita, a pesar de que los LCF estén normales.

- 151 E Tiene una endometritis clásica: fiebre, dolor uterino, loquios de mal olor. También puede tener metrorragia. Los restos placentarios solo producen metrorragia tardía, sin dolor ni fiebre (generalmente entre el día 2 y día 4). La NTG suele producir metrorragia tardía, varios días o semanas postparto. La epifisiografía equimótica es normal.
- 152 C Nuevamente es una endometritis, que se trata con antibióticos endovenosos de amplio espectro.
- 153 E Tiene una mastitis aguda, que se trata con antibióticos, generalmente endovenosos, aunque si está bien se puede tratar con antibióticos orales (generalmente amoxicilina con ácido clavulánico, aunque también se pueden dar otros fármacos que cubran *S. aureus*).
- 154 B Tiene miomas asintomáticos (la amenorrea no es síntoma de miomas), por lo que se observan. Además, por estar en amenorrea a los 50 años, probablemente esté menopáusica y, con ello, los miomas tienden a involucionar (aunque da igual en realidad).
- 155 B El cuello corto, con cervicometría menor a 25 mm, se maneja con progesterona endovaginal, para reducir el riesgo de parto prematuro. Si ya tiene antecedentes de incompetencia cervical o partos muy prematuros, además de la progesterona, se realiza un cerclaje electivo (no es el caso, por ser primigesta).
- 156 C Pregunta discutible y con más de una opción aceptable. Que tenga un PBF 8/10 es tranquilizador y muestra que la única razón por la que ha bajado es por el OHA. Sin embargo, en los embarazos de término (mayores a 37 semanas) con ILA menor a 5 (probablemente sea el caso, por tener 0/2 en el PBF), se recomienda la interrupción del embarazo. Si tuviera un ILA mayor a 5, se podría mantener en control cada uno a dos días.
- 157 D Tiene una meningitis herpética, que se trata con aciclovir EV. Tanto la clínica, como el LCR viral (predominio MN y glucosa normal) hemorrágico la sugieren.
- 158 E Es una leucemia clásica, con signos de insuficiencia medular (anemia y alteraciones de la hemostasia primaria) y hepatoesplenomegalia. Ninguna de las otras tiene anemia. La meningococcemia es muy agresiva, en cosa de horas o pocos días. La PSH tiene púrpura palpable, alteraciones digestivas, compromiso articular y GNA. la EvW es algo crónico con alteración de la hemostasia primaria. La PTI sí puede tener equimosis y petequias, pero no la hepatomegalia.
- 159 B El alargamiento del TTPA sugiere fuertemente hemofilia. Que tenga una clínica tan florida, en un niño (sexo masculino) pequeño, la sugiere también. Suele evolucionar a hemartrosis y hematomas musculares y de otras partes del cuerpo. PTI y PTT tienen plaquetopenia. EvW y Glanzmann tienen alteración de la hemostasia primaria, con petequias y clínicas generalmente más leves que la hemofilia, aunque sí pueden tener una clínica similar, en las formas más graves. Eso sí, el TTPA suele estar normal, salvo en algunas variantes de la EvW en que sí se puede alargar.
- 160 D Se sospecha una insuficiencia suprarrenal aguda, por la clínica (deshidratación y taquicardia) y el antecedente de la HSRC (se descompensó por la infección y la diarrea). Ante la sospecha, se deben administrar corticoides de acción rápida, como la hidrocortisona.
- 161 A La sospecha es nuevamente una insuficiencia suprarrenal, por la clínica y por la hiperkalemia, hiponatremia e hipoglicemia. Se diagnostica con el test de estimulación con

ACTH (cortisol basal y post-ACTH), pero comenzar con el cortisol basal es una respuesta aceptable y la única que podía ser.

162 C Tanto por el antecedente del Sd. de Down como por la clínica que mezcla una CIV (soplo holosistólico), con una CIA (2º ruido desdoblado), se trata de un CAV clásico.

163 C Es una dermatomiositis infantil clásica, con el rash heliotropo y el rash en manto. Se debe descartar un cáncer (suele ser paraneoplásica).

164 A Solo por la ubicación (línea media: hueso hioides) se trata de un QTG. Lo demás simplemente muestra signos de infección, compatibles con todas las opciones.

165 D La clínica es de un fecaloma clásico: constipación que progresa y luego tiene la pseudoincontinencia (incluso, a veces, hay encopresis). Se debe realizar un tacto rectal (en presencia de alguien más del centro médico, para no ser acusado de abuso, en especial hoy en día que abundan tanto los abusadores como las personas que acusan de abuso falsamente) y luego proceder a la desimpactación: con enema evacuante o solución oral. Una vez eliminado, se mantiene con laxantes por varias semanas. El polietilenglicol es lo más usado en pediatría.

166 D Es un glaucoma crónico clásico, con afectación del campo visual, de predominio periférico y agudeza visual conservada. La DMRE afecta la AV, al igual que la catarata y la NOI. El tumor occipital produciría una hemianopsia homónima (ej. solo derecho o solo izquierdo, pero no "bimedial").

167 A La rinitis alérgica es la causa más frecuente de obstrucción nasal, rinorrea y respiración bucal en pediatría. La HT de adenoides sí tiene infecciones recurrentes y obstrucción, aunque le sobra la rinorrea. La B, D y E tendrían infecciones bacterianas, sin obstrucción nasal y la D y E tienden a hacer neumonías, mientras que la B sí hace neumonías, pero también las otitis y sinusitis. El número de infecciones recurrentes del paciente no alcanzan a ser realmente infecciones recurrentes.

168 B El hematoma del tabique nasal se debe drenar de inmediato, mediante incisión amplia con bisturí (también el hematoma del pabellón auricular). De lo contrario evoluciona con necrosis avascular del cartílago.

169 C La notificación obligatoria de enfermedades es una medida de vigilancia epidemiológica activa, que busca tanto prevenir el contagio a más personas (prevención primaria), como diagnosticar oportunamente a los contactos (prevención secundaria) y, así, controlar los brotes de la enfermedad. Ej. Covid-19.

170 A Tiene una depresión clásica con anhedonia y afectación de distintas áreas de la vida (sueño, actividad social, concentración, etc.). Que empeore en el periodo premenstrual es algo que puede ocurrir con cualquier patología psiquiátrica y también con cualquier problema normal, sin necesariamente ser un síndrome premenstrual.

171 B Tiene un delirio paranoide, con la reacción apodíptica clásica de alguien psicótico. La edad y la ausencia de alucinaciones y síntomas negativos hacen improbable una esquizofrenia. No tiene síntomas anímicos, como para pensar en T. esquizoafectivo. Los T. personalidad no están psicóticos, aunque el TP paranoide es muy celoso y desconfiado y el TP esquizoide es muy solitario, apático e indiferente.

172 D Que se haya pensionado hace sospechar un T. por simulación, pero que no cambie su conducta y que su vida esté tan afectada, hace sospechar más un T. facticio.

También el hecho de que su mujer lo cuide abnegadamente (fin ganancial de afecto, atención y cuidados).

173 C Las atelectasias son la causa más frecuente de fiebre postquirúrgica en las primeras 48 horas. Los crépitos también la sugieren. La neumonía sí tiene crépitos localizados y fiebre, pero le falta la tos y expectoración mucopurulenta. El TEP puede tener esa clínica, pero suele tener taquicardia o síntomas respiratorios de inicio súbito. La dehiscencia de la anastomosis produce una peritonitis aguda.

174 A Es una imagen clásica de cálculos biliares, con la sombra acústica característica de los cálculos. La clínica son cólicos biliares.

175 B Las causticaciones oculares (con ácidos, álcalis y otros irritantes) se manejan con lavado abundante con suero fisiológico o agua, por 30 minutos y luego ATB tópicos. El parche es discutible, ya que da miedo que se adhiera el párpado al globo ocular.

176 D Las medidas de tamizaje son prevención secundaria (detectan la enfermedad que ya existe, antes de los síntomas).

177 C La clínica en posición púdica (flexión y aducción) ya sugiere luxación posterior de cadera. La radiografía muestra la luxación posterior y un probable rasgo de fractura en el cuello.

178 B Es un melanoma clásico, tanto por la edad, como por el crecimiento. La imagen sí tiene un aspecto de queratosis seborreica, aunque el halo hiperpigmentado y la lesión satélite son más de melanoma.

179 E Es una orquiepididimitis clásica.

180 D Es un *flutter* o aleteo auricular clásico, con las ondas de serrucho.

RECONSTRUCCION DIECIEMBRE 2020

EUNACOM JULIO 2016

1.-31) Un paciente de 70 años, diabético tipo 2 e hipertenso, en tratamiento con metformina, losartán e hidroclorotiazida, presenta un cuadro de 4 días de vómitos alimentarios y diarrea, evolucionando con malestar general y disminución del volumen urinario. Al examen físico está bradipsíquico, con presión arterial de 100/50 mmHg, frecuencia cardíaca de 110x'. En sus exámenes de laboratorio destaca creatinina: 2,0 mg/dl, BUN: 78 mg/dl, FeNa: 0,5%, sodio: 130 mEq/L, potasio: 2,0 mEq/L y cloro: 110 mEq/L. ¿Qué fluido debe administrarse inicialmente?

- a) Solución glucosada al 5%
- b) Solución ringer lactato
- c) Albúmina al 5%
- d) Solución glucosalina isotónica
- e) Solución de bicarbonato al 2/3 molar

2.-32) Una paciente de 14 años aún no ha tenido su menarquia. Presenta desarrollo puberal Tanner 2, mamario y pubiano, con vello axilar. No tiene otras alteraciones en el examen físico. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía ginecológica
- b) Solicitar cariotipo
- c) Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, LH y FSH
- d) Realizar prueba de progesterona
- e) Controlar en un año

3.-38) Una paciente de 31 años, cursando un embarazo de 28 semanas, sin alteraciones hasta el momento, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, con 75 gramos de glucosa, que resulta 75 mg/dl basal y 160 mg/dl a las 2 horas de la carga de glucosa. El diagnóstico más probable es:

- a) Intolerancia a la glucosa
- b) Diabetes gestacional
- c) Diabetes pregestacional
- d) Diabetes mellitus 2
- e) Resistencia a la insulina

4.-47) Una paciente de 35 años, usuaria de dispositivo intrauterino, hace 9 años, consulta por un cuadro de dolor pélvico, que aumentó en la última menstruación. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra una lesión quística de 6 cm en el ovario derecho, con contenido denso. Se solicitan

niveles de Ca-125 que resultan 160 UI/ml (VN: menor a 35). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Quiste folicular
- b) Cáncer de ovario inicial
- c) Quiste endometriósico
- d) Cáncer de ovario avanzado
- e) Teratoma ovárico

5.-67) Paciente masculino de 88 años de edad quien consulta por astenia de 3 meses de evolución. Al examen físico se observa palidez de piel y mucosas y leve tinte icterico en escleras. Hemograma: Hemoglobina 6,6 grs/dl; hematocrito: 17%; VCM: 117 fl; plaquetas: 110.000 por mm³; glóbulos blancos: 3.400 x mm³; fórmula diferencial: neutrófilos: 74 %, linfocitos: 20 %, eosinófilos: 5 % y baciliformes: 1 %. El examen para confirmar el diagnóstico es:

- a) Mielo grama
- b) Citometría de flujo
- c) Prueba de Coombs
- d) Niveles de Eritropoyetina.
- e) Niveles de vitamina B12 y Ácido fólico.

6.-82) Una niña de 5 años, con antecedentes de atopia, consulta por presentar lesiones hipo pigmentadas en el rostro, no pruriginosas, ni dolorosas con descamación amarilla como se muestra en la siguiente imagen: FOTO: se muestra imagen de cara de niña, con pitiriasis alba. La indicación más adecuada es:

- a) Crema de hidrocortisona tópica
- b) Crema de betametasona tópica
- c) Crema de clotrimazol tópico
- d) Griseofulvina oral
- e) Bloqueador solar

7.-83) Un hombre de 46 años refiere que las mujeres de su trabajo se le insinúan y quieren tener una relación con él. Sin embargo, no hay testigos de esos hechos y al interrogar a sus compañeras de trabajo, lo niegan. Al confrontar al paciente, se enoja, ya que le molesta que no crean en lo que él dice. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipomanía
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Dismorfofobia
- e) Trastorno de personalidad narcisista

8.-86) Un hombre de 40 años consulta por disnea y palpitaciones ocasionales. Al examen físico presenta un soplo sistólico basal, con desdoblamiento fijo del segundo ruido. Se solicita un electrocardiograma, que muestra un bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Comunicación interauricular
- b) Ductus arteriosos persistente
- c) Comunicación interventricular
- d) Estenosis aórtica
- e) Estenosis pulmonar

9.-87) Un lactante de 12 meses de edad, que a los 9 meses presentó un exantema, al introducir huevo a su alimentación por lo que fue suspendido, sin haberlo comido de nuevo. ¿Cuál es la conducta a tomar con respecto a la vacuna trivírica?

- a) Aplicar a los 12 meses
- b) Contraindicar la vacuna
- c) Aplicar a los 18 meses
- d) Diferir hasta los 2 años
- e) Realizar IgE específica del huevo y decidir según resultado

10.-97) Mujer 54 años obesos, diabéticos e hipertensos, presenta hace 3 meses genitorragia intermitente, con antecedentes de menopausia a los 50 años, sin terapia hormonal de reemplazo y PAP normal de este año. El examen físico y ginecológico es normal. Se realiza una Ecografía tranvaginal, que muestra: útero en anteversoflexión, con tamaño normal, endometrio homogéneo de 3 mm de grosor, con anexos normales, sin líquido libre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hiperplasia endometrial.
- b) Cáncer endometrial
- c) Pólipo endometrial
- d) Atrofia endometrial.
- e) Sarcoma uterino

11.-105) Una niña de 5 años presenta dolor en muslo izquierdo, que luego se ubica en la cadera izquierda y que limita su movimiento. Al examen físico está en buenas condiciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Sinovitis transitoria
- b) Artritis séptica
- c) Artritis reumatoidea
- d) Osteomielitis
- e) Tumor de Ewing

12.-107) Una paciente de 56 años de edad presenta metrorragia abundante, que requiere de legrado. Se envía a biopsia, que es informada, como hiperplasia endometrial atípica y compleja. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Anticonceptivos combinados
- b) Solicitar niveles de estradiol y FSH
- c) Progestágenos orales en altas dosis
- d) Histerectomía total
- e) Progestágenos endovaginales

13.-116) Un paciente de 25 años de edad, sin patologías previas, presenta desde hace 4 años aumento de volumen cervical lateral, que ha ido creciendo. Al examen se constata una masa palpable, de 3 cm, en la zona lateral del cuello, de ubicación submandibular. Se solicita una ecografía cervical, que muestra un nódulo hipoecogénico, de bordes bien delimitados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Nódulo tiroideo
- b) Quiste branquial
- c) Quiste tirogloso
- d) Linfadenopatía tuberculosa
- e) Tumor de glándula salival secundaria

14.-123) ¿Qué tipo estudio es el más adecuado para determinar el desarrollo de obesidad en un grupo de escolares a lo largo de un determinado tiempo?

- a) Estudio de prevalencia
- b) Estudio de incidencia
- c) Estudio de caso control
- d) Estudio de cohortes
- e) Ensayo clínico controlado

15.-128) Un paciente de 28 años presenta ánimo bajo e irritable, desde hace 2 meses, fecha en que murió su hermano. Se siente ansioso e intranquilo, sin cambios en el peso. Los síntomas interfieren moderadamente con sus actividades laborales. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de estrés agudo
- b) Trastorno de adaptación
- c) Episodio depresivo mayor
- d) Trastorno de ansiedad generalizada
- e) Distimia

16.-129) Una mujer de 34 años se siente muy ansiosa al realizar actividades como hacer presentaciones o hablar en reuniones de trabajo. Por ello evita ese tipo de situaciones y asigna dichas tareas a sus subalternos, sobrecargándolos. Incluso dejó de asistir a un congreso de ejecutivos, en el que tendría que exponer. El diagnóstico más probable es:

- a) Fobia social
- b) Trastorno de ansiedad generalizada
- c) Trastorno de personalidad antisocial
- d) Trastorno de personalidad evitativo
- e) Trastorno de pánico

17.-155) Un paciente de 66 años, fumador de 40 paquetes-año presenta tos con expectoración mucosa, de 4 años de evolución. Tiene broncorrea, mayor en la mañana y presenta 2 infecciones respiratorias al año, que requieren de antibióticos. Su radiografía de tórax y espirometría son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cáncer de pulmón
- b) Tuberculosis pulmonar
- c) Fibrosis pulmonar
- d) EPOC
- e) Bronquitis crónica

18.-172) Un paciente masculino, de 22 años, desde hace más de 6 meses ha dejado de compartir con su familia y casi no sale de su pieza. Además, ha descuidado su aspecto personal. Sus familiares refieren que en ocasiones lo escuchan musitar, hablar y reírse solo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Esquizofrenia
- b) Depresión psicótica
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Trastorno de personalidad esquizoide
- e) Trastorno bipolar

19.-173) Paciente femenina con artritis reumatoide, en tratamiento con metotrexate y prednisona desde hace 4 años, es diagnosticada de diabetes mellitus, por lo que se inicia metformina como tratamiento. ¿Qué examen es perentorio realizarle, como seguimiento a esta paciente?

- a) Hemograma, con recuento de plaquetas
- b) Radiografía atlantoaxoidea
- c) Insulinemia
- d) LDH
- e) Densitometría ósea

20.-177) Un recién nacido de 36 semanas de edad gestacional, nacido por cesárea, presenta dificultad respiratoria, luego de nacer, con taquipnea,

retracción subcostal y crepitantes basales. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra ambos campos pulmonares con hiperinsuflación, reforzamiento hiliar, aplanamiento del diafragma y silueta cardíaca normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumomediastino
- b) Neumonía congénita
- c) Taquipnea transitoria
- d) Enfermedad de membrana hialina
- e) Cardiopatía congénita

EUNACOM JULIO 2017

21.-3) Un lactante de 12 meses de edad es traído por su madre, ya que presenta coloración amarillenta-anaranjada en las palmas de las manos, las plantas y en las mejillas. No tiene otros antecedentes, pesa 9,5 Kg y mide 73,5 cm y su examen físico no muestra otras alteraciones. ¿Cuál es la causa de esta alteración?

- a) Hipercolesterolemia
- b) Hipertrigliceridemia
- c) Hiperbilirrubinemia de predominio directo
- d) Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
- e) Un componente de la dieta

22.-7) Un paciente presenta vértigo, de segundos de duración, que se le produce al girar la cabeza a derecha, mientras está acostado. No tiene síntomas auditivos y como antecedente refiere haber sufrido un traumatismo encefálico hace 10 días, en un accidente de trabajo. No presenta adiadococinesia ni dismetría. El resto de su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar flunarizina
- b) Iniciar tietilperazina
- c) Solicitar un TAC de oídos
- d) Derivar para maniobras de reposición vestibular
- e) Iniciar difenidol

23.-20) Un escolar de 7 años consulta por una zona alopécica de 2 semanas de evolución, que ha ido en creciendo. Al examen físico se aprecia la placa alopécica de 4 cm, con descamación y pelos entrecortados, tal como se muestra en la siguiente imagen: INSERTAR FOTO ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tiña capitis
- b) Tricotilomanía
- c) Alopecia areata
- d) Lupus discoide
- e) Dermatitis solar

24.-21) Un paciente de 32 años, lleva un año conviviendo con pacientes bacilíferos, se encuentra asintomático y su radiografía de tórax no muestra alteraciones, se solicita un PPD que resulta en 23 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar tratamiento atibiótico con isoniazida, pirazinamida, rifampicina y etambutol por 6 meses
- b) Repetir PPD en un mes
- c) Dar de alta y control en caso de síntomas
- d) Solicitar reacción en cadena de polimerasa para mycobacterium tuberculosis en lavado bronquioloalveolar
- e) Indicar isoniazida por 6 meses

25.-36) Un niño de 7 años presenta olor axilar, vello púbico en Tanner 2, testículos de 2 cc de volumen. Se solicita radiografía de mano, que muestra edad ósea acorde con la edad cronológica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tumor suprarrenal
- b) Pubertad precoz central
- c) Pubertad precoz periférica
- d) Hiperplasia suprarrenal congénita
- e) Adrenarquia normal

26.-39) Un lactante de 5 días de vida, alimentado con lactancia materna exclusiva, presenta ictericia en la cara y el tronco, que inició hace 2 días. Se solicita bilirrubina plasmática, que resulta 10 mg/dl, bilirrubina directa de 0,3 mg/dl, hematocrito de 56%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hepatitis neonatal
- b) Atresia biliar primaria
- c) Ictericia fisiológica
- d) Ictericia hemolítica
- e) Ictericia por leche materna

27.-45) Un niño de 4 años presenta un cuadro de fiebre hasta 39,5 grados, asociada a tos con expectoración mucopurulenta, de 2 días de evolución. Además refiere cefalea y marcado malestar general. Al examen físico está decaído, febril, con FC: 100x', RR2T, sin soplos, examen pulmonar con presencia crepitaciones localizadas en la zona superior del campo pulmonar derecho. Se realiza radiografía de tórax, que se muestra a continuación: INSERTAR FOTO ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Mycoplasma pneumoniae
- b) Chlamydia pneumoniae

- c) Streptococcus pneumoniae
- d) Haemophilus influenzae
- e) Staphylococcus aureus

28.-47) Una paciente de 30 años, diabética tipo 1, con historia de 5 hospitalizaciones en el último año por cuadros de hipoglicemia severa. Actualmente ingresa en shock hipoglicémico, el que es manejado adecuadamente. Durante su hospitalización, es sorprendida en el baño inyectándose una dosis de insulina que no le correspondía, lo cual ella posteriormente niega. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno disociativo
- b) Trastorno somatomorfo
- c) Trastorno hipocondríaco
- d) Trastorno por simulación
- e) Trastorno facticio

29.-49) Una paciente de 81 años, multípara de 3, histerectomizada, inicia escapes de orina de esfuerzos hace 5 años y además, desde hace 2 años tiene escapes de urgencia. No tiene antecedente de infecciones urinarias, ni hematuria. Al examen físico se aprecia un grado leve de prolapso genital. Se realiza sedimento de orina con 4-5 leucocitos por campo y 2-3 hematíes por campo, sin bacterias y se realiza un urocultivo, que resulta negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar tratamiento quirúrgico del prolapso
- b) Indicar ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico
- c) Iniciar anticolinérgicos
- d) Iniciar alfa bloqueadores adrenérgicos
- e) Solicitar ecografía abdomino-pélvica

30.-58) Una paciente de 52 años, con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento permanente con AINES y prednisona por vía oral y tratamiento intermitente con metotrexate por vía oral, presenta un cuadro de astenia, adinamia y disnea de esfuerzos que ha empeorado en el último tiempo. Se solicitan exámenes en los que destacan una creatinina de 1,6mg/dL, hemograma con hematocrito 29%, hemoglobina 9,7g/dL, plaquetas 147.000/mm³, blancos 4.200/mm³ y al frotis se aprecia microcitosis. Además se solicita perfil de hierro que muestra ferremia de 40ug/dL (60-160 ug/dL) y transferrina de 190mg/dL (240-360mg/dL). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Anemia por enfermedades crónicas
- b) Mielodisplasia
- c) Anemia por insuficiencia renal crónica

- d) Hipoplasia medular
- e) Mieloma múltiple)

31.-107) Una paciente de 31 años, con antecedente de parto hace 3 meses, consulta por un cuadro de diarrea de dos meses de evolución de tipo acuoso que ha empeorado en los últimos días, no ha presentado fiebre ni sangre en sus deposiciones. En su examen físico presenta dolor difuso a la palpación abdominal y meteorismo. El diagnóstico más probable es

- a) Enfermedad celiaca
- b) Colitis ulcerosa
- c) Diarrea nosocomial
- d) Enteroparasitosis
- e) Diarrea crónica funcional

32.-108) Un niño de 4 años, hace 24 horas ingiere 7 comprimidos de algún medicamento desconocido, evolucionando con malestar general, vómitos e ictericia. Se solicitan exámenes, en los que destaca GOT: 403 UI/L, GPT: 390 UI/L, bilirrubina plasmática total: 5,2 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar L-carnitina endovenosa
- b) Administrar deferoxamina endovenosa
- c) Administrar N-acetil-cisteína endovenosa
- d) Administrar carbón activado vía oral
- e) Administrar piridoxina vía oral

33.-115) Un paciente de 25 años consulta por aparición de lesiones en las extremidades inferiores. Refiere que ayer estuvo jugando fútbol y que las lesiones empezaron a aparecer después. Además, dice que hace un año, le había pasado algo similar, luego de andar en moto por los cerros. Al examen físico se observan lesiones como las que se muestran en la siguiente imagen: INSERTAR FOTO (la imagen original mostraba ambos muslos y piernas con múltiples lesiones eritemato-violáceas, muchas de ellas con disposición lineal) ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Fitodermatitis
- b) Enfermedad ampollar
- c) Urticaria solar
- d) Lupus discoide
- e) Vasculitis leucocitoclástica

34.-117) Una paciente de 30 años consulta por molestias genitales, consistentes en leucorrea y prurito. Al examen ginecológico, destaca especuloscopia con leucorrea abundante, amarilla y espumosa. ¿Cuál es el examen de elección para realizar el diagnóstico etiológico?

- a) Prueba de aminas vaginales (test de KOH)

- b) Cultivo para *Candida albicans*
- c) Examen de determinación de “células clave” (clue cells)
- d) Frotis fresco de la secreción vaginal
- e) PCR para *Chlamydia trachomatis*

35.-142) Un niño de 6 años presenta múltiples en el tronco, que se muestran en la imagen. Su padre tiene lesiones similares. INSERTAR FOTO El diagnóstico más probable es:

- a) Neurofibromatosis tipo 1
- b) Enfermedad de Addison
- c) Enfermedad celiaca
- d) Síndrome de Peutz-Jeghers
- e) Hiperplasia suprarrenal congénita

36.-150) Una paciente de 30 años, embarazada sin controles iniciales, con edad gestacional dudosa, consulta por pérdida de líquido por los genitales. Sus signos vitales son normales y al examen obstétrico no presenta dinámica uterina ni modificaciones cervicales en el tacto vaginal. Su altura uterina es de 25 cm y las pruebas de bienestar fetal son normales. Se realiza ecografía obstétrica, que muestra índice de líquido amniótico de 5,2 y biometría para 30 semanas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Inducir el parto con misoprostol
- b) Realizar cesárea
- c) Dar antibióticos y corticoides y mantener una conducta expectante
- d) Determinar madurez fetal en líquido amniótico
- e) Administrar nifedipino oral

37.-154) Un paciente de 33 años, hospitalizado por una endocarditis subaguda por *Streptococcus viridans*, en tratamiento con penicilina y gentamicina por vía endovenosa, presenta un cuadro de hematuria de algunos días de evolución. Se solicita sedimento de orina que muestra 50 glóbulos rojos por campo con 95% de dismorfia y presencia de cilindros hemáticos, creatinina de 2,4mg/dL, ANA (-), fracción C3 del complemento de 53mg/dL (valor normal: 75-135 mg/dL). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Embolias renales a repetición
- b) Nefritis intersticial secundaria al uso de penicilina
- c) Daño tubular agudo secundario al uso de gentamicina
- d) Glomerulonefritis por depósito de complejos inmunes
- e) Síndrome hemolítico urémico

38.-156) Una niña de 8 meses de edad presenta un cuadro febril hasta 39,2 grados Celsius, sin otros síntomas, ni alteraciones en su examen físico. Se

realiza un urocultivo por recolector, que resulta positivo para Escherichia coli sensible, con 45.000 unidades formadoras de colonias, por ml. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Tratar con cefadroxilo oral
- b) Tratar con nitrofurantoína oral
- c) Tratar con amoxicilina oral
- d) Solicitar hemograma, VHS y PCR
- e) Repetir el urocultivo por sondeo vesical

39.-167) ¿A qué tipo de medida corresponde la vacunación contra una enfermedad, en la historia natural de una enfermedad?

- a) Promoción de salud
- b) Protección específica
- c) Erradicación de la enfermedad
- d) Diagnóstico oportuno
- e) Tratamiento precoz

40.-173) Una paciente sufre una fractura de la diáfisis humeral derecha, la que es manejada mediante cirugía, con osteosíntesis con placa. A las 24 horas, evoluciona con dolor en el sitio de la fractura, asociada a imposibilidad de extender la muñeca derecha. Mantiene la flexión activa de los dedos de esa mano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trombosis de la arteria braquial
- b) Neurapraxia del nervio radial
- c) Desplazamiento de la placa
- d) Síndrome compartimental
- e) Lesión del plexo braquial

41.-174) Una paciente de 25 años, diagnosticada de depresión en tratamiento, hace algunas horas consume múltiples comprimidos de amitriptilina y evoluciona con desorientación, midriasis y taquicardia. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar su enfrentamiento?

- a) Electrocardiograma
- b) Radiografía de tórax
- c) Creatina fosfoquinasa
- d) Electroencefalograma
- e) Pruebas hepáticas

42.-175) Un paciente de 65 años consulta por dolor escrotal derecho de 3 días de evolución. Al examen físico presenta dolor y eritema en la zona escrotal derecha y se palpa aumento de volumen y dolor, del testículo y del epidídimo. Refiere tener pareja sexual monogámica. ¿Cuál es el agente etiológico más

probable? a) Streptococcus pyogenes b) Staphilococcus aureus c) Chlamydia trachomatis d) Neisseria gonorrhoeae e) Escherichia coli

43.-179) Una paciente de 28 años, multípara de uno, con embarazo de 22 semanas, con antecedente de un parto prematuro a las 26 semanas se realiza una cervicometría de control, que resulta 10 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar nifedipino oral
- b) Indicar progestágenos endovaginales hasta el término del embarazo
- c) Realizar cerclaje cervical
- d) Realizar test de la fibronectina fetal
- e) Observar evolución

EUNACOM DIC 2017

44.-74) Un paciente de 60 años consulta por eritema y prurito en el glande y el prepucio. Al examen físico se constatan signos inflamatorios en dicha zona. Además de tratar la enfermedad descrita, ¿qué enfermedad sistémica se debe descartar?

- a) Cáncer
- b) Daño hepático crónico
- c) Diabetes
- d) Lupus
- e) Insuficiencia renal

45.-176) Una mujer de 22 años consulta por un nódulo mamario, que se autopalpó. Al examen físico se constata un nódulo en la mama derecha, de 2 cm de diámetro, móvil. No se palpan adenopatías axilares. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de esta paciente?

- a) Mamografías
- b) Ecografía mamaria

- c) Resonancia magnética nuclear de mamas
- d) TAC de tórax
- e) Biopsia

EUNACOM JULIO 2018

46.-1.-Una paciente de 15 años, sin antecedentes de importancia, presenta dolor pélvico muy intenso, en relación a la menstruación, que la hace faltar al colegio. Su menarquia fue hace un año y presenta reglas III-V / 30-35. El tratamiento de elección es:

Seleccione una:

- a. Ácido mefenámico
- b. Anticonceptivos orales
- c. Dienogest
- d. Paracetamol
- e. Ácido tranexámico

47.-7.-Una niña de 12 meses de edad que presenta botón mamario bilateral, con desarrollo de Tanner 2 en ambas mamas, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- a. Observar evolución
- b. Solicitar estradiol plasmático
- c. Solicitar LH y FSH plasmática
- d. Solicitar test de LHRH
- e. Solicitar RMN de pelvis

48.-18 ¿Cuál es el fármaco de mantención, de elección para un paciente masculino de 76 años, hipertenso, con diagnóstico de depresión recurrente?

Seleccione una:

- a. Trazodona
- b. Mirtazapina
- c. Clitalopram
- d. Venlafaxina
- e. Amitriptilina

49.-20.-Un paciente de 23 años, luego de una ruptura sentimental con su pareja, evoluciona con amnesia parcial de lo ocurrido y una actitud extraña. A la entrevista está perplejo y resignado a lo que estaba sucediendo. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Trastorno conversido
- b. Trastorno disociativo
- c. Trastorno somatomorfo
- d. Episodio psicótico reactivo
- e. Trastorno depresivo

50.-23.-Un paciente de 42 años, que trabaja en un aserradero, comienza con un cuadro de dificultad respiratoria, con tos y expectoración, asociada a respiración sibilante. Luego de estudiarlo, es diagnosticado de asma no laboral. Sin embargo, él discrepa de este diagnóstico, ya que lo considera de origen laboral. ¿A qué institución puede apelar contra esta determinación?

Seleccione una:

- a. Superintendencia de Seguridad Social
- b. Servicio de Salud de su comuna
- c. Instituto de Salud Pública
- d. Fonasa
- e. Ministerio de Salud

51.-24.-Un paciente de 25 años presenta disnea y tos, con expectoración mucosa, que aparece luego de realizar ejercicio y durante las infecciones respiratorias. No presenta síntomas en el reposo. Su examen físico es normal y se solicita un PEF, que resulta 540 L/min, que equivale al 90% del valor esperado. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación:

¿Cuál de los siguientes es el examen más adecuado para proseguir con el estudio en este paciente?

Seleccione una:

- a. Prick test
- b. TAC de tórax
- c. Espirometría basal y postbroncodilatador
- d. Niveles plasmáticos de inmunoglobulina E específica
- e. Prueba de provocación bronquial

52.-26.- Un paciente de 61 años, fumador de 31 paquetes años, tosedor, con antecedente de hipertensión arterial presenta un cuadro de disnea de esfuerzo, con edema de extremidades inferiores, que ha progresado en el último tiempo. Al examen físico tiene PA: 158/102 mmHg, FC: 88x', ápex cardíaco no palpable, ritmo regular, con ruidos cardíacos apagados y sibilancias escasas en el examen pulmonar. ¿Cuál de los siguientes fármacos está contraindicado?

Seleccione una:

- a. Losartán
- b. Amlodipino
- c. Digoxina
- d. Atenolol
- e. Espironolactona

53.-29.- Un paciente diabético tipo 2, en tratamiento con metformina 1,7 gramos al día y enalapril 20 mg cada 12 horas, asintomático, acude a control. Se solicitan exámenes, entre los que destacan HbA1c: 6,7%, colesterol total: 265 mg/dl, colesterol HDL: 34 mg/dl y triglicéridos: 344 mg/dl.

¿Qué fármaco se debe agregar al tratamiento?

Seleccione una:

- a. Fenofibrato
- b. Gemfibrozilo

- c. Atorvastatina
- d. Glibenclamida
- e. Ezetimibe

54-38.-Una paciente de 67 años, con antecedente de gastrectomía hace 2 años, presenta astenia y adinamia marcada, asociada a disnea de esfuerzo, que ha ido aumentando en los últimos meses. Al examen físico destaca palidez de la piel y las mucosas. Se realiza exámenes, entre los que destaca un hemograma que muestra Hematocrito: 32%, Hb: 10,6 g/dl, con VCM: 72 fl y HCM: 28 pg. Los blancos están en 7.800 por mm³ y las plaquetas, en 756.000 por mm³. El diagnóstico, que con mayor probabilidad es causa de su anemia, es:

Seleccione una:

- a. Anemia ferropénica
- b. Anemia por déficit de B12
- c. Anemia por enfermedades crónicas
- d. Trombocitosis esencial
- e. Talasemia

55.-48.-Un paciente de 43 años, es agredido en la calle, mientras se encontraba en estado de ebriedad, recibiendo una puñalada en la zona inferior derecha del tórax, por lo que se hace una radiografía que se muestra a continuación:

El diagnóstico

El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Neumotórax
- b. Hemotórax
- c. Enfisema subcutáneo
- d. Neumoperitoneo
- e. Hemoperitoneo

56.-49.-Un paciente de 27 años consulta por tos, fiebre alta, disnea y dolor torácico de tipo pleurítico. Al examen físico tiene disminución del murmullo pulmonar izquierdo, con respiración soplante y crépitos. Se solicita una radiografía de tórax que muestra una pleuroneumonía izquierda, por lo que se punciona el derrame pleural, dando salida a un líquido turbio, con LDH: 250 UI/L, proteínas: 5,0 g/dl, con PMN: 60% y MN: 40%, pH: 7,1, lactato: 6 mmol/L, ADA: 8 UI/L. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- a. Tomar biopsias pleurales
- b. Instalar un tubo pleural, con trampa de agua
- c. Administrar fibrinolíticos
- d. Realizar una pleurocentesis y drenaje en 24 horas
- e. Administrar antibióticos pleurales

57.-50.-Un paciente de 64 años, con antecedente de un infarto al miocardio hace 8 meses, consulta por dolor torácico de 40 minutos de duración, asociado a

palpitaciones. Al examen físico presenta PA: 90/60, FC: 200x' y se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación:

El diagnóstico más probable es:

Seleccione una o más de una:

- a. Taquicardia paroxística supraventricular
- b. Flutter auricular con bloqueo 1:1
- c. Fibrilación auricular con aberrancia
- d. Taquicardia ventricular
- e. Arritmia asociada a síndrome de Wolff Parkinson White

58.-54.-Una paciente de 45 años consulta por astenia de 8 meses de evolución, asociada a prurito. Hace 2 meses se agrega ictericia y acumulación de grasa en los pliegues cubitales, poplíteos y alrededor de los ojos. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran bilirrubina: 4,9 mg/dl, fosfatasas alcalinas: 655 UI/L, GOT: 88 UI/L, GPT: 76 UI/L, GGT: 230 UI/L. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Hepatitis autoinmune
- b. Cirrosis idiopática
- c. Colédocolitiasis
- d. Cirrosis biliar primaria
- e. Cirrosis biliar secundaria

59.-56.-Una paciente de 33 años presenta úlceras orales recurrentes, desde hace varios meses. Además, tiene úlceras genitales. Hace una semana comienza con aparición de eritema nodoso en la cara anterior de ambas piernas y uveítis. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Infección por virus herpes
- b. SIDA
- c. Sífilis
- d. Enfermedad de Behcet
- e. Granulomatosis microangeítica

60.-68.-Un recién nacido de 30 semanas de edad gestacional, presenta un síndrome de dificultad respiratoria grave, con cianosis, taquipnea y uso de musculatura accesoria. Su examen pulmonar demuestra algunos crépitos y requiere FiO₂ de 0,6. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?

Seleccione una:

- a. TAC de tórax
- b. Radiografía de tórax
- c. Hemocultivos y cultivos de expectoración
- d. Ecocardiografía
- e. Cateterismo cardíaco

61.-69.-Un recién nacido de 3 días de vida, presenta múltiples lesiones amarillentas, pequeñas, apenas sollevantadas en ambas alas nasales. La conducta más adecuada es:

Seleccione una:

- a. Corticoides tópicos
- b. Antimicóticos tópicos
- c. Vaselina líquida tópica
- d. Mantener el aseo habitual
- e. Antibióticos tópicos

62.-75.-Una paciente de 22 años presenta un nódulo mamario, en el lado derecho. Al examen físico se palpa un nódulo de 2 cm de diámetro, de consistencia gomosa, que no está adherido a la piel, ni a planos profundos. No tiene otras alteraciones. El examen más adecuado para iniciar el estudio es:

Seleccione una:

- a. Ecografía mamaria
- b. Mamografías bilaterales
- c. Punción con aguja fina
- d. Resonancia magnética nuclear
- e. Extirpación y biopsia de la pieza quirúrgica

63.-81.-Una paciente de 26 años, con atraso menstrual de 3 semanas, consulta por metrorragia escasa, sin dolor. Al examen físico. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra tumor anexial de 3 cm, sin líquido libre. Los niveles de HCG resultan 3.400 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

Seleccione una:

- a. Controlar con ecografía en 48 horas
- a. Controlar con ecografía en 48 horas
- b. Adminstrar metotrexato
- c. Controlar con HCG en 48 horas
- d. Realizar legrado
- e. Realizar salpingectomía

64.-97.- hombre de 36 años, que desde hace 3 días presenta un cuadro de congestión nasal y rinorrea, con escasa tos. Evoluciona con edemas maleolares, malestar general, hematuria en varias oportunidades y disnea. Al examen físico está FC: 68x', PA: 160/100 mmHg, tiene edema de ambas extremidades, con signo de la fóvea ++ y al examen pulmonar se auscultan crépitos bibasales. Se solicitan exámenes, con complemento normal, creatininemia: 0,9 mg/dl, BUN: 21 mg/dl, sedimento de orina con abundantes glóbulos rojos, con 30% de dismorfia. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Glomerulonefritis postinfecciosa
- b. Nefropatía por IgA
- c. Necrosis tubular aguda
- d. Síndrome hemolítico urémico
- e. Glomerulonefritis rápidamente progresiva, asociada a ANCA

65.-104.- Un paciente de 70 años consulta por astenia, malestar general y baja de peso, con dolor lumbar importante y progresivo. Al examen físico se palpa próstata indurada y aumentada de tamaño, bilateral. Se solicita APE, que resulta 125 ng/ml y se realiza una cintigrafía ósea, que muestra múltiples metástasis óseas, mayormente en las vértebras lumbares. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

Seleccione una:

- a. Prostatectomía radical
- b. Radioterapia
- c. Cuidados paliativos
- d. Hormonoterapia
- e. Inhibidores de la 5-alfa-reductasa

66.-135.- Una mujer de 35 años, diagnosticada recientemente de VIH, consulta por odinofagia y disfagia, que iniciaron hace una semana. Al examen físico tiene faringe eritematosa, con placas blanquecinas en la faringe y en la mucosa yugal, que se desprenden fácilmente al removerlas con un hisopo. Se palpan múltiples adenopatías cervicales, sensibles. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

Seleccione una:

- a. Colutorios de nistatina
- b. Anfotericina ev
- c. Aciclovir vo
- d. Fluconazol vo
- e. Cotrimoxazol vo

67.-140.- Un paciente de 31 años, que vive en una zona rural, consulta por un cuadro de malestar general, asociado a fiebre hasta 39°C y mialgias intensas, invalidantes. Al examen físico presenta dolor importante a la palpación de las masas musculares. Su hemograma muestra hematocrito: 44%, plaquetas: 400.000 por mm³, leucocitosis de 16.000 blancos por mm³, con 35% de eosinófilos. ¿Cuál es el agente más probable?

Seleccione una o más de una:

- a. Ascaris lumbricoides
- Trichinella spiralis
- b. Giardia lamblia
- c. Fasciola hepatica
- d. Entamoeba histolytica

68.-154.- Una paciente con antecedente de fibrilación auricular paroxística, la que trata con amiodarona, digoxina, enalapril e hidroclorotiazida, desde hace 6 meses. Evoluciona desde hace 1 mes, con disnea, ortopnea y palpitaciones. Además, refiere baja de peso de 4 kilogramos y temblor. Actualmente está en fibrilación auricular, con FC: 112 x', se auscultan crépitos pulmonares bilaterales y su radiografía de tórax muestra congestión pulmonar, con líneas B de Kerley. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Insuficiencia cardíaca secundaria a cardiopatía coronaria

- b. Cardiopatía isquémica
- c. Hipertiroidismo por amiodarona
- d. Intoxicación por digitálicos
- e. Tromboembolismo pulmonar crónico

69.-163.-Una paciente con antecedente de fibrilación auricular paroxística, la que trata con amiodarona, digoxina, enalapril e hidroclorotiazida, desde hace 6 meses. Evoluciona desde hace 1 mes, con disnea, ortopnea y palpitaciones. Además, refiere baja de peso de 4 kilogramos y temblor. Actualmente está en fibrilación auricular, con FC: 112 x', se auscultan crépitos pulmonares bilaterales y su radiografía de tórax muestra congestión pulmonar, con líneas B de Kerley. El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Insuficiencia cardíaca secundaria a cardiopatía coronaria
- b. Cardiopatía isquémica
- c. Hipertiroidismo por amiodarona
- d. Intoxicación por digitálicos
- e. Tromboembolismo pulmonar crónico

70.-172.-Una paciente presenta un cuadro de 2 semanas de evolución, de fotopsias en la zona inferolateral del campo visual izquierdo, al que hace dos días se agrega disminución de la visión de dicho ojo, que ella describe como un muro que se va levantando. Tiene antecedente de artritis reumatoide, en tratamiento de prednisona. Además, es hipertensa y tiene antecedente oftalmológico de una faquectomía izquierda, con lente intraocular. Su examen físico muestra agudeza visual de 1,0 en el ojo derecho y de 0,1 en el ojo izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Seleccione una:

- a. Catarata
- b. Desprendimiento de retina
- c. Neuropatía óptica isquémica
- d. Hemorragia vítrea
- e. Glaucoma

EUNACOM DICIEMBRE 2018

71.-7) Una paciente de 75 años, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes, en tratamiento con metforminal, glibenclamida, hidroclorotiazida y enalapril consulta por un cuadro de cefalea y malestar general. Refiere que sus presiones arteriales habituales son cercanas a 150/90 mmHg. Al examen físico presenta PA: 200/105 mmHg, FC: 73 x', con examen pulmonar normal. ¿Cuál es el tratamiento del cuadro actual?

- a) Nifedipino sublingual
- b) Nitroglicerina sublingual
- c) Nitroprusiato endovenoso
- d) Captopril oral
- e) Labetalol endovenoso

72.-8) Un paciente de 42 años consulta por tos y disnea de 2 semanas de evolución, asociada a expectoración mucopurulenta y, en ocasiones, hemoptoica. Además, ha presentado fiebre ocasional, hasta 38,2°C. Al examen físico presenta estertores bilaterales en ambos campos pulmonares. Se solicitaron baciloscopías de expectoración, que resultan negativas. Además, se solicita otros exámenes, que muestran quantiferón para tuberculosis (+) y PCR para Mycobacterium tuberculosis (+). Su radiografía de tórax se muestra más abajo. Foto 1 (https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-93082004000400006) (La imagen ha sido ennegrecida, para que se parezca a las imágenes reales del Eunacom impreso). La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar profilaxis con isoniazida
- b) Iniciar rifampicina más isoniazida
- c) Iniciar tratamiento habitual para la tuberculosis
- d) Solicitar TAC de tórax
- e) Esperar el resultado del cultivo de Koch y decidir conducta según resultado.

73.-14) Un paciente de 52 años presenta hematoquecia de 2 días de evolución, sin otros síntomas. Sus signos vitales muestran PA: 120/80 mmHg, FC: 75x' y T°: 36°C. Al examen físico, tiene leve palidez de mucosas y su abdomen es blando y depresible, sin masas ni visceromegalia y con preservación de los ruidos hidroaéreos. Se solicita una colonoscopia, que es normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

- a) Cintigrafía con glóbulos rojos marcados
- b) Endoscopia digestiva alta
- c) TAC de abdomen y pelvis
- d) Angiografía mesentérica
- e) Enteroscopia

74.-32) Un paciente de 68 años, con antecedente de hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial y diabetes, está en tratamiento con tamsulosina, atenolol, hidroclorotiazida, metformina y aspirina. Consulta por dificultades para lograr y mantener la erección, lo que le preocupa. ¿Qué fármaco puede ser el causante de estos síntomas?

- a) Aspirina
- b) Metformina
- c) Hidroclorotiazida
- d) Tamsulosina
- e) Atenolol

75.-37) Una paciente de 28 años presenta episodios súbitos de marcada angustia, con miedo a morir y síntomas como disnea con “imposibilidad de sacar el aire”,

vértigo, parestesias en las extremidades, imposibilidad de tragar, opresión en el pecho, náuseas, visión borrosa y sensaciones eléctricas en el cuerpo, en los que siente la necesidad de salir corriendo para su casa. Ha presentado 5 episodios en las últimas 4 semanas y está muy preocupada por lo que le está pasando. Los exámenes generales descartan patología orgánica. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente?

- a) Amitriptilina 150 mg
- b) Sertralina 50 mg
- c) Risperidona 3 mg
- d) Clonazepam 6 mg
- e) Clorpromazina 300

76.-42) Un paciente consulta por dolor y aumento de volumen en la pierna derecha. ¿Qué característica del dímero D es aquella que permite descartar una trombosis venosa profunda cuando resulta negativo?

- a) Alta especificidad
- b) Alta sensibilidad
- c) Elevado valor predictivo negativo
- d) Elevado valor predictivo positivo
- e) Baja especificidad

77.-43) Una prueba de tamizaje obligatoriamente debe tener:

- a) Alta especificidad, sin importar la sensibilidad
- b) Alta sensibilidad, independiente de la
- c) Alto valor predictivo positivo y facilidad en su aplicación
- d) Bajo valor predictivo negativo y reproductibilidad
- e) Bajo costo y baja sensibilidad

78.-68) Un lactante de 12 meses ha comido huevo en dos oportunidades y en ambas ha presentado un exantema eritematoso generalizado, sin otras manifestaciones. ¿Qué conducta es la más adecuada, respecto a la vacuna trivírica?

- a) Administrarla en este momento
- b) Eliminarla de su esquema de vacunación
- c) Administrarla a los 18 meses
- d) Esperar a los 4 años para administrarla
- e) Esperar a que esté en primero básico para administrarla

79.-72) Un recién nacido de 10 días pesó 3.100 gramos al nacer. Se alimenta con lactancia materna exclusiva y actualmente pesa 3.180 gramos. ¿Cuál es el diagnóstico nutricional?

- a) Desnutrición
- b) Riesgo de desnutrición

- c) Sobrepeso
- d) Buen incremento ponderal
- e) Mal incremento ponderal

80.-84) Una paciente de 27 años, cursando un embarazo de 39 semanas, consulta por contracciones uterinas dolorosas. Al examen físico, está en buenas condiciones generales, con dinámica uterina de 1 contracción en 10 minutos. El tacto vaginal comprueba cuello uterino 50% borrado, permeable a un dedo, con feto en cefálica, sin cambios respecto a un tacto vaginal, realizado hace 4 días. El monitoreo fetal no tiene alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Esperar a que inicie el trabajo de parto
- b) Realizar cesárea
- c) Inducir el parto con misoprostol
- d) Hospitalizar y conducir el trabajo de parto
- e) Realizar test de tolerancia a las contracciones

81.-104) Una paciente de 23 años, vegetariana estricta, consulta por diarrea de algunos meses de evolución, asociada a baja de peso. Se solicitan exámenes, entre los que destaca anemia ferropénica. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Parasitosis intestinal
- b) Enfermedad celíaca
- c) Colitis ulcerosa
- d) Enfermedad de Crohn
- e) Enteropatía perdedora de proteínas

82.-107) Un paciente de 72 años, con antecedente de un infarto miocárdico, hace 2 meses. Durante la hospitalización, se diagnosticó diabetes mellitus, iniciándose metformina 850 mg cada 12 horas. Sin embargo, desde entonces ha presentado diarrea. Sus glicemias de ayuno son cercanas a 140 mg/dl y su hemoglobina glicosilada resulta 8,2%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Reemplazar la metformina por glibenclamida
- b) Agregar insulina NPH
- c) Reemplazar el tratamiento por metformina 750 mg XR
- d) Reemplazar la metformina por sitagliptina
- e) Aumentar la dosis de metformina

83.-112) Un paciente de 43 años consulta por dolor y parestesias en el dedo meñique y anular derechos, que inició hace 3 años y ha progresado, aumentando su intensidad. Relata que, en la noche, los síntomas suelen ser más intensos y que

actualmente tiene parestesias continuas en el meñique. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome del túnel carpiano
- b) Contractura de Dupuytren
- c) Radiculopatía C7
- d) Atrapamiento cubital
- e) Compresión del plexo braquial

84.-124) Un paciente de 41 años, diabético tipo 1, consulta por fiebre, asociado a rinorrea purulenta y enrojecimiento facial. Al examen físico, se observa eritema de la mejilla izquierda y de la punta de la nariz, con una zona necrótica en el ala nasal. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) *Staphylococcus aureus*
- b) *Candida albicans*
- c) *Streptococcus pyogenes*
- d) *Mucor*
- e) *Pseudomonas aeruginosa*

85.-141) Un paciente de 70 años, sufre una caída a nivel, con apoyo de la extremidad superior en extensión, contra el suelo. Evoluciona con dolor en la muñeca, que le impide realizar movimientos. Consulta al día siguiente, con la muñeca deformada en “dorso de tenedor” y presencia de equimosis en la zona palmar y en la zona dorsal. Presenta dolor a la compresión de la zona distal del radio. EL diagnóstico más probable es:

- a) Esguince de muñeca
- b) Fractura de la epífisis distal del radio
- c) Disyunción del extremo distal del radio
- d) Luxofractura de Monteggia
- e) Fractura de escafoides carpiano.

86.-144) Una paciente de 60 años consulta por aumento de volumen en la cara anterior del muslo, que en ocasiones es dolorosa y se asocia a náuseas y dolor abdominal. Al examen físico se aprecia dicho aumento de volumen, por debajo del ligamento inguinal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Linfoma
- b) Hernia inguinal
- c) Adenopatía metastásica
- d) Hernia femoral
- e) Sarcoma de partes blandas

87.-180) Una mujer de 35 años, con antecedente de parto hace 3 meses, actualmente dando lactancia materna, consulta por dispareunia y prurito postcoital de algunas semanas de evolución. En su especuloscopia se observan paredes vaginales con mucosa pálida y seca.

- a) Realizar cultivo para Candida
- b) Realizar microscopía en búsqueda de Trichomonas vaginalis
- c) Iniciar anticonceptivos combinados orales
- d) Realizar búsqueda de "clue cells"
- e) Indicar lubricante íntimo genital

EUNACOM DICIEMBRE 2019

88.-27) Un paciente de 58 años, fumador de 10 paquetes año, consulta por disnea, asociada a tos y expectoración mucosa. Los síntomas aumentan especialmente en relación a la actividad física y cuando presenta infecciones respiratorias. En su examen físico se auscultan escasas sibilancias bilaterales y espiración prolongada. Se solicita una espirometría que muestra: Basal Postbroncodilatador CVF 5.928cc 100% 6.106cc 103% VEF1 4.163cc 76% 5.040cc 92% VEF1/CVF 65% 73% Su radiografía de tórax se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

- a) Asma bronquial
- b) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- c) Bronquiectasias
- d) Bronquitis crónica
- e) Enfermedad pulmonar intersticial difusa

89.-39) Una mujer de 18 años presenta traumatismo en la rodilla derecha, siendo diagnosticada de esguince de rodilla, el que se maneja con reposo y antiinflamatorios. Evoluciona con dolor persistente, por lo que consulta nuevamente. Se solicita una radiografía de rodilla que muestra reacción perióstica y compromiso de partes blandas. El diagnóstico más probable es:

- a) Osteomielitis del fémur distal
- b) Osteosarcoma osteogénico
- c) Fractura del fémur distal, con callo óseo
- d) Osteocondroma
- e) Hematoma calcificado

90.-91) Un paciente de 68 años, diabético de larga data, fumador, presenta pérdida brusca de la visión del ojo derecho, sin dolor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Infarto occipital
- b) Desprendimiento de retina
- c) Hemorragia vítrea

- d) Degeneración macular
- e) Edema macular

91.-117) Un paciente de 50 años, con antecedente de infección de VIH de varios años, consulta por una lesión perianal, de larga data, sin tendencia a la cicatrización, que en ocasiones se ulcera y sangra. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada, de consistencia aumentada, de 3 cm de diámetro, bordes cartográficos y que se introduce por el orificio anal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Sífilis
- b) Enfermedad de Cröhn
- c) Carcinoma epidermoide
- d) Melanoma
- e) Linfogranuloma venéreo

92.-160) Una niña de 13 meses de edad, desde hace 4 meses ha detenido su crecimiento. Además, presenta deposiciones frecuentes y disgregadas, con tendencia al meteorismo. En sus exámenes destaca anemia ferropénica. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

- a) Anticuerpos IgA antiendomiso
- b) Cuantificación de inmunoglobulinas
- c) Test del sudor
- d) Colonoscopia
- e) 17 – OH – progesterona.

PAUTAS EUNACOM 2020

EUNACOM JULIO 2016

1-31.- B.

Lo primero en un paciente shockeado siempre es reponer la volemia y luego preocuparse de los electrolitos. La volemia se repone preferentemente con cristaloides (suero fisiológico y Ringer lactato) y en este caso, por la severa hipokalemia es más recomendable el Ringer (aunque no ha demostrado ser mejor que el SF en ninguna situación). Además, no salía SF dentro de las alternativas. La única excepción (aunque sin evidencia que lo demuestre) es la deshidratación hiperosmolar, en que da miedo dar SF, por el riesgo de una mayor hipernatremia (ahí se da suero hipotónico al 0,45% o suero glucosalino: 0,45% NaCl + glucosa 2,5%, aunque insisto que no hay evidencia).

2-32.- E.

Es absolutamente normal. Como tiene desarrollo puberal, aún no se puede hablar de amenorrea primaria (se diagnostica a los 15 años si hay desarrollo puberal y se estudia con prueba de progesterona; en cambio, si no hay desarrollo puberal, se diagnostica a los 13 años y se estudia con muchas pruebas hormonales, ya que además hay un retraso puberal).

3-38.- B.

Es diabetes gestacional (DMG) por diagnosticarse durante el embarazo y por cumplir con el criterio de TTGO mayor o igual a 140 (es el corte en la DMG). No es pregestacional (DMPG), ya que esta se diagnostica antes del embarazo, o al inicio del embarazo, pero con 2 glicemias de ayuno mayores o iguales a 126 mg/dl o con una glicemia mayor o igual a 200 mg/dl más síntomas). Si se diagnostica en el segundo semestre, solo se puede hablar de DMG y no DMPG.

4-47.- C.

Es un endometrioma clásico, que también puede llamarse quiste endometriósico.

5-67.- E.

Era una anemia perniciosa clásica, con la macrocitosis y pancitopenia clásicas. Se estudia con B12 (cianocobalamina) y B9 (folatos).

6-82.- E.

Es una pitiriasis alba. Por regla general se observa y se humecta, porque está asociada a atopía, pero el bloqueador solar está indicado (la verdad es que está indicado en todas las personas).

7-83.- C.

Es un trastorno delirante crónico de libro (delirio sistematizado; pérdida de juicio de realidad).

8-86.- A.

Es una CIA (comunicación interauricular) clásica, aunque en un adulto: soplo sistólico eyectivo, desdoblamiento del segundo ruido y eje desviado a derecha.

9-87.- A.

La alergia al huevo actualmente no es contraindicación de la vacuna trivírica, a menos que haya requerido hospitalización, caso en el que igualmente se da la vacuna, pero en el hospital, bajo observación.

10-97.- D.

Si bien, tiene los antecedentes que orientan a hiperplasia endometrial o cáncer (HONDA: hipertensión arterial, obesidad, nuliparidad, diabetes y anovulación), el grosor del endometrio es un muy fuerte indicador de atrofia endometrial (menor a 5 mm se observa), que es la causa más frecuente de metrorragia postmenopáusica.

11-105.- A.

Si bien la sinovitis transitoria suele ser en menores de 5 años, la clínica es compatible, por estar en buenas condiciones.

12-107.- D.

La HPE atípica (en especial si es compleja) se trata con histerectomía, porque tiene alto riesgo de evolucionar a un cáncer de endometrio. La HPE simple se trata con progestágenos orales o con el DIU medicado.

13-116.- B.

Es un quiste branquial clásico (zona lateral del cuello y crecimiento muy lento). No puede ser nódulo tiroideo, por la ubicación (la tiroides está en la zona media inferior del cuello). Tampoco un quiste del conducto tirogloso, porque este es de la línea media. La adenopatía tuberculosa o escrófula crece más rápido y suele fistulizarse, dando salida a material caseoso.

14-123.- B.

La aparición de una enfermedad a lo largo del tiempo es la definición de incidencia. La incidencia se mide con los estudios de incidencia y con los estudios de cohortes, con la diferencia que el estudio de incidencia es simplemente descriptivo y no tiene un grupo de comparación (dice “un grupo de escolares”), mientras que los de cohortes tienen un grupo de control (se separan en expuesto y no expuestos a un factor de riesgo y se siguen en el tiempo, para ver las incidencias de patología). Es una pregunta que induce a error, ya que ambas respuestas son correctas, pero dejaremos como correcta la B, por ser solo un grupo y dar la definición de incidencia en el enunciado.

15-128.- B.

Es un T. adaptativo clásico (gatillante claro, síntomas depresivos y/o ansiosos, pero sin cumplir criterios de depresión u otro trastorno ansioso: ej. no tiene cambios en el peso ni afectación grave de su vida).

16-129.- A.

Es una fobia social clásica: ansiedad al realizar actividades en público y evitación de las mismas.

17-155.- E.

Es una bronquitis crónica clásica: fumador con tos y expectoración crónicas, mayores en la mañana. No tiene EPOC, porque su espirometría está normal. Asimismo, la radiografía normal hace improbables las demás opciones. Finalmente, la clínica no es sugerente de ninguna de las otras.

18-172.- A.

Es una forma clásica del primer brote de esquizofrenia. La edad es compatible. Seguramente tiene alucinaciones auditivas y por eso habla y se ríe solo.

19-173.- E.

Todo paciente con tratamiento corticoidal debe hacerse densitometrías óseas, porque se produce osteoporosis secundaria. Si bien la artritis reumatoide (AR) aumenta el riesgo de daño de la articulación atlantoaxoidea, no es necesario hacer la radiografía de rutina.

20-177.- C.

Tanto por el antecedente de cesárea, como por la radiografía es taquipnea transitoria clásica.

EUNACOM JULIO 2017

21-3.- E

Por ingesta de betacaroteno

22-7.- D

Es un vértigo postural paroxístico benigno clásico.

23-20.- A

Tiña capitis clásica.

24-21.- E

Es un contacto, con PPD mayor a 10, por lo que se debe indicar profilaxis antibiótica (isoniazida 6 meses es la recomendación del Minsal).

25-36.- E

Es una adrenarquia normal (olor axilar y en varones puede haber una ligera pubarquia). Los testículos pequeños hacían imposible una pubertad precoz central y la pubertad precoz periférica es algo muy raro, que habría tenido alteraciones de la edad ósea.

26-39.- C

No hay nada que oriente a ictericia patológica. Es una ictericia fisiológica clásica.

27-45.- C

Es una NAC neumocócica clásica.

28-47.-E

Es un trastorno facticio clásico. No es por simulación, porque no hay un fin económico.

29-49.- B

Pregunta rara, ya que mezcla la IOE, con la IOU. De todos modos, al predominar la IOE, lo primero es intentar los ejercicios de piso pélvico.

30-58.- A

Tanto por tener AR, como por la ferremia baja, con transferrina baja, orienta mucho a una anemia por enfermedades crónicas.

31-107 C

En el parto recibió antibióticos y la diarrea por clostridium puede aparecer hasta 2 meses después de haber terminado el uso de antibióticos. Eso sí, se debe ser cuidadoso, porque hay quienes definen a la diarrea nosocomial en términos más estrictos, que no calzan con el del caso clínico.

32-108 C

Se sospecha intoxicación por paracetamol. Dado la hepatitis. Aún está en ventana para darle la N-acetil-cisteína.

33-115 A

Era una fitofotodermatitis por litre (árbol de la zona central chilena).

34-117 D

Es una tricomoniasis y el frotis permite ver a las tricomonas

35-142 A

Eran manchas café con leche, que si son más de 6, se asocian a NF1.

36-150 ¿C, D?

Pregunta demasiado específica y difícil y con todo al límite (si quien hizo esta pregunta es la misma persona que preguntó lo de la regurgitación tricuspídea, le comunico que no tiene idea de qué debe o no debe saber un médico general). Es una RPO y dado que la edad gestacional es dudosa, se hizo una biometría que tiene un rango de error de 3 semanas: así tiene entre 27 y 33 semanas. Al haber un ILA de 5,2 (aunque no describen el bolsillo, como para saber si se puede o no hacer una amniocentesis), se puede hacer una amniocentesis para determinar madurez fetal: si está maduro, se interrumpe; si no, se mantiene la conducta expectante. Yo creo que la respuesta es la D. La alternativa C también es muy aceptable.

37-154 D

Es una glomerulonefritis (por la hematuria dismórfica), asociada a EBSA (por complejos inmunes), por la hipocomplementemia.

38-156 E

El UCT por recolector solo es positivo si es mayor a 100.000 UFC por ml. Así que repetirlo por sondeo es la única opción aceptable.

39-167 B

Es una medida clásica de prevención primaria, de tipo prevención específica.

40-173.- B

Confundía el hecho de haber dolor en la zona, lo que orientaba a un síndrome compartimental, pero solo se describía la afectación del nervio radial, sin otras alteraciones, por lo que lo más probable es que haya sido la neurapraxia.

41-174 A

La intoxicación con tricíclicos produce taquicardias ventriculares, que es lo más grave.

42-175 ¿E?

La clásica causa de orquiepididimitis es la infección por clamidia y luego gonorrea (yo marqué Chlamydia). Sin embargo, la E. Coli es la causa más frecuente cuando no hay infección de transmisión sexual y es especialmente frecuente en adultos mayores. En este caso, si le creíamos que tenía pareja única, la respuesta probablemente era E. Coli.

43-179 C

Tiene una cervicometría menor a 25 mm, por lo que se debe hacer algo: Si no tuviera antecedentes de partos prematuros o abortos tardíos, tendría indicación de progestágenos endovaginales. Si por el contrario tiene esos antecedentes, como en este caso, además de los progestágenos, se debe cerclar. Igual está mal que en una opción aparezca un distractor que es correcto.

PAUTA DICIEMBRE 2017**44-74 C.**

La balanopostitis (en especial la candidiásica) se asocia a diabetes

45-176 B.

Es un fibroadenoma clásico, que se estudia con ecografía mamaria.

PAUTA JULIO 2018**46-1.- A**

El ácido mefenámico es el AINE de elección en el tratamiento de la dismenorrea primaria.

La respuesta correcta es: Ácido mefenámico

47-7.- A

La presencia de botón mamario, hasta Tanner II, en los recién nacidos y en las lactantes es algo normal, a menos que venga asociada a otras alteraciones, como vello púbico por ejemplo.

La respuesta correcta es: Observar evolución

48-18.- C

En el adulto mayor, los antidepresivos de elección son los IRS.

La respuesta correcta es: Citalopram

49-20.- C

Es una amnesia disociativa clásica.

La respuesta correcta es: Trastorno disociativo

50-23.- A

Las resoluciones sobre patología laboral, se apelan a la Suseso.

La respuesta correcta es: Superintendencia de Seguridad Social

51-24.- E

Es un asma clínico, pero sin obstrucción actual y con examen físico normal, por lo que se debe estudiar con el test de metacolina.

La respuesta correcta es: Prueba de provocación bronquial

52-26.- D.

Como tiene EPOC, están contraindicados los betabloqueantes.

La respuesta correcta es: Atenolol

53-29.- C

Al calcular el colesterol LDL, resultaba 162, por lo que está muy por encima de los 70, que es el objetivo para el diabético. Por tanto, se debía privilegiar el tratamiento del LDL alto, con estatinas.

La respuesta correcta es: Atorvastatina

54-38.-A

Es una anemia ferropénica, por el VCM y HCM tan bajos y la trombocitosis reactiva.

La respuesta correcta es: Anemia ferropénica.

55-48.- D

En la radiografía se observa el neumoperitoneo.

La respuesta correcta es: Neumoperitoneo

56-49.- B

Tenía un empiema o derrame paraneumónico complicado, que se trata con tubo pleural.

La respuesta correcta es: Instalar un tubo pleural, con trampa de agua

57-50.- D

Si bien el EKG original se parecía mucho a una FA con Sd. de WPW, el antecedente de un IAM antiguo y la taquicardia con QRS ancho, hace que la respuesta sea una taquicardia ventricular.

La respuesta correcta es: Taquicardia ventricular

58-54.- D

Es una CBP clásica, tanto por ser una mujer de esa edad, como por la colestasia crónica, con xantomas, que son una manifestación frecuente.

La respuesta correcta es: Cirrosis biliar primaria

59-56.-D

Es una enfermedad de Behcet clásica.

La respuesta correcta es: Enfermedad de Behcet

60-68.- B

Se sospecha una enfermedad de membrana hialina, por la edad gestacional, la que se diagnostica con radiografía de tórax.

La respuesta correcta es: Radiografía de tórax

61-69.- D.

Es un millium sebáceo, que es un hallazgo normal del recién nacido.

La respuesta correcta es: Mantener el aseo habitual

62-75.- A

Parece un fibroadenoma, que se estudia y sigue con ecografía.

La respuesta correcta es: Ecografía mamaria

63-81.- B

Tiene un embarazo ectópico (HCG mayor a 1.500, sin visualización de saco gestacional intrauterino), menor de 4 cm y con menos de 5.000 UI/L de HCG, por lo que se debe tratar con metotrexato.

La respuesta correcta es: Adminstrar metotrexato

64-97.- B.

Es una nefropatía por IgA clásica, con síndrome nefrítico. No puede ser GNAPE, porque el complemento no está bajo. No puede ser GNRP, NTA ni SHU, porque no hay insuficiencia renal aguda.

La respuesta correcta es: Nefropatía por IgA

65-104.- D.

El cáncer de próstata avanzado, se trata con hormonoterapia (agonistas de la GnRH).

La respuesta correcta es: Hormonoterapia

66-135.- D.

Es una candidiasis orofoaríngea y eventualmente esofágica, que se trata con fluconazol oral, de elección.

La respuesta correcta es: Fluconazol vo

67-140.- B

Es una triquinosis clásica.

68-154.- C.

Es un hipertiroidismo clásico y la amiodarona lo explica perfectamente.

La respuesta correcta es: Hipertiroidismo por amiodarona

69-163.- C.

A pesar de que la amilasa está elevada, la clínica es completamente compatible con una colangitis, porque tiene la triada de Charcot, más la hipotensión arterial. Además, las colangitis sí pueden elevar la amilasa, en especial cuando la causa es

una coledocolitiasis, como en este caso. Prima el diagnostico de colangitis por sobre el de coledocolitiasis.

La respuesta correcta es: Colangitis aguda

70-172.- B.

Es un desprendimiento de retina clásico.

La respuesta correcta es: Desprendimiento de retina

DICIEMBRE 2018

71-7.- D

El tratamiento de la crisis hipertensiva, sin compromiso de órgano blanco (urgencia hipertensiva) es el captopril oral. Sin embargo, la evidencia es errática y permite usar otros antihipertensivos.

72-8.- C

La radiografía no se veía bien, pero tanto por la PCR + para TBC, como por el quantiferón positivo, probablemente se trata de una TBC, aunque las baciloscopías estén negativas y se debe iniciar el tratamiento habitual.

73-14 B

Es una pregunta discutible. La hematoquecia con compromiso hemodinámico (HDB masiva) siempre se debe estudiar con EDA (en este caso falta el compromiso hemodinámico, pero creemos que es la respuesta correcta igual). La colonoscopia es el examen de elección en la HDB (y acá se hizo) y si no localiza, se sigue estudiando con pruebas radiológicas (cintigrafía o angiografía).

74-32.- E

Ahora ya saben, el atenolol puede producir impotencia sexual.

75-37.- B

Tiene un trastorno de pánico clásico, que se trata con antidepresivos IRS, como la sertralina.

76-42.- C

Es una pregunta difícil, ya que tanto alta sensibilidad, como alto valor predictivo negativo son respuestas correctas y, de hecho, se relacionan entre sí. Sin embargo, en estricto rigor, es el alto VPN lo que hace que se descarte una enfermedad al resultar negativo el examen.

77-43.- B

La sensibilidad debe ser alta, para detectar todos los casos, aunque la especificidad no sea tan alta (por ello, luego se confirma con otros exámenes más específicos).

78-68.- A

La alergia al huevo no contraindica ninguna vacuna.

79-72.- D

Considerando que es normal que bajen de peso, hasta un 10% del peso y que lo recuperen a los 7 días, su incremento de peso es del todo normal.

80-84.- A

Le faltan las modificaciones cervicales, por lo que aún no inicia el trabajo de parto. Es más, si tuviese dilatación hasta 3 cm, estaría en fase latente y también se envía a domicilio, indicando recontrol en una horas).

81-104.- B

Es una enfermedad celíaca clásica del adulto (diarrea y ferropenia).

82-107.- D

Tiene efectos adversos, por lo que se debe suspender la metformina y cambiar a sitagliptina (por lo frágil: adulto mayor con infarto reciente, se prefiere la sitagliptina sobre la glibenclamida). No tenía indicaciones evidentes de insulina.

83-112.- D

Es un atrapamiento cubital clásico.

84-124.- D

Es una mucormicosis clásica.

85-141.- B

Es una fractura de muñeca clásica.

86-144.- D

Es una hernia femoral clásica (bajo el ligamento inguinal). Es más frecuente en mujeres.

87-180.- E

Tiene una atrofia vaginal, por hipoestrogenismo fisiológico. Se trata de primera línea, con lubricación genital.

DICIEMBRE 2019

88-27.- A

Tiene un cuadro clínico y espirometría (patrón obstructivo que mejora con BD) compatibles con asma.

89-39.- B

Pregunta rara, ya que ni siquiera dicen que hay un tumor, pero reacción perióstica y el compromiso de partes blandas son clásicas de un tumor maligno. Por la edad, lo más probable es un osteosarcoma. Es frecuente en el Eunacom que se dé el antecedente de trauma (aunque no tenga relación) en distintos tipos de tumores, ya que ahí es que se lo palpan.

90-91.- C

Es una HV clásica, que es la causa de ceguera en la retinopatía diabética. La pérdida de rojo pupilar es un signo característico, aunque no se mencione. El infarto occipital daría hemianopsia homónima contralateral. El DR sí pierde la visión, pero suele ser como una "caída de telón" o "levantamiento de pared" y estar precedido de fotopsias y entopsias. La DMRE es crónica y la AV disminuye lentamente. El edema macular sí puede producir ceguera, pero demora varios días en instalarse.

91-117.- C

Parece un cáncer de recto, que es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos y con virus papiloma humano (también de transmisión sexual).

92-160.- D

Se sospecha una insuficiencia suprarrenal aguda, por la clínica (deshidratación y taquicardia) y el antecedente de la HSRC (se descompensó por la infección y la diarrea). Ante la sospecha, se deben administrar corticoides de acción rápida, como la hidrocortisona.

RECONSTRUCCIÓN EUNACOM AGOSTO 2021

Dr. Guillermo Guevara Aliaga

PRIMERA PARTE

Instrucciones:

1. Esta prueba consta de 90 preguntas por parte.
 2. Dispondrá de un tiempo de 105 minutos para responder.
 3. Al final de la prueba, usted cuenta con una hoja de respuestas. Arránquela y conteste en ella, asegurándose de escribir su nombre y su RUT, con letra clara.
 4. Debe responder con lápiz mina HB N°2 o 2B, ennegreciendo completamente la casilla correcta.
 5. Si se equivoca, la única forma de corregir es borrar con una goma y marcar la respuesta correcta.
 6. Solo se corregirá la hoja de respuestas, así que asegúrese de contestarla a tiempo.
 7. Las preguntas incorrectas no descontarán puntaje, por lo que no debe omitir.
 8. Puede rayar el cuadernillo de preguntas. Sin embargo, solo se corregirá la hoja de respuestas.
 9. Al final de la prueba, debe entregar solo la hoja de respuestas. El cuadernillo de preguntas es suyo y puede llevárselo. La prueba será subida a la plataforma web, con su respectiva pauta y explicación. En ese entonces, podrá objetar las preguntas y, si procede, se anularán las preguntas defectuosas.
 10. No se responderán dudas durante la prueba. Debe permanecer en silencio.
 11. Asegúrese de pasar al baño antes de que inicie la prueba, ya que, durante esta, no podrá salir.
 12. La copia está absolutamente prohibida. Tanto copiar, como entregar las respuestas al compañero será considerada una falta grave, que se sancionará con la nota mínima en la prueba y la reprobación automática del curso.
 13. El simple hecho de tener un celular o un smartwatch (reloj inteligente) u otro dispositivo electrónico, a través del cual sea posible copiar o enviar información, será considerado copia y reprobará el curso.
 14. Si termina la prueba antes de que se acabe el tiempo, podrá entregar la hoja de respuestas y retirarse, sin hacer ruido ni hablar, hasta estar lo suficientemente lejos, como para que quienes no han terminado no se vean afectados.
 15. Las notas estarán disponibles en 15 días y les serán entregadas de manera individual, a su correo electrónico.
- ¡Les deseamos el mayor de los éxitos y mucha suerte!

RECONSTRUCCIÓN EUNACOM AGOSTO 2021

PRIMERA PARTE

1) Un paciente de 20 años presenta episodios de descontrol y agresividad, en los que rompe objetos, grita, amenaza con agredir y con autoagredirse. Se molesta mucho cuando le cambian sus cosas de lugar y tiene rutinas muy marcadas, las que le cuesta mucho modificar. Abandonó la secundaria, ya que reprobó dos veces primero medio. Además, tiene muy buena memoria, al punto que puede memorizar los códigos de barras de distintos productos. Desde niño que fue considerado como raro, no entablaba amistades y jugaba solo siempre con el mismo juguete, además de ver repetidamente sus dos películas favoritas. Saluda a las personas de una manera extraña, con aleteo de sus extremidades superiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno bipolar
- c) Trastorno de personalidad límite
- d) Trastorno del espectro autista
- e) Trastorno estereotipado del movimiento

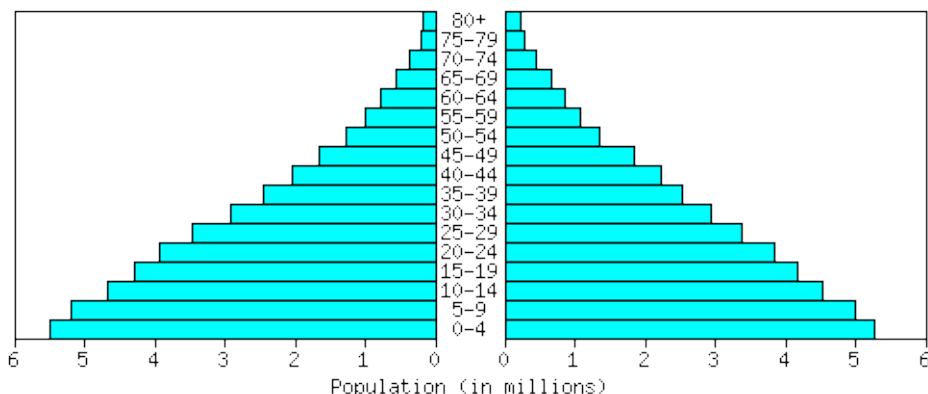
2) ¿Cuál es el mejor indicador para medir la efectividad de la campaña de vacunación contra la influenza?

- a) La tasa de mortalidad por influenza
- b) La tasa de letalidad de la influenza
- c) La tasa de incidencia de influenza
- d) La tasa de prevalencia de influenza
- e) La tasa de cobertura de vacunación contra la influenza

3) El indicador de letalidad de la influenza corresponde a lo siguiente:

- a) Casos de influenza / población general
- b) Casos de influenza / muertes influenza
- c) Casos de influenza / población expuesta
- d) Muertes por influenza / Casos de influenza
- e) Muertes por influenza / población general

4) Una población presenta la siguiente pirámide poblacional:



¿En qué tipo de medidas deben enfocarse sus políticas de salud pública?

- a) Prevención y manejo de patologías crónicas no transmisibles
- b) Prevención y tratamiento de patologías de salud mental
- c) Saneamiento básico, planificación familiar y vacunación
- d) Prevención de tabaquismo, alcoholismo y consumo de drogas
- e) Promoción de actividad física y alimentación saludable

5) La notificación obligatoria de algunas enfermedades transmisibles tiene como objetivo:

- a) Evaluar la efectividad de las vacunas administradas a la población
- b) Identificar las principales enfermedades transmisibles en la población
- c) Determinar la propagación de las enfermedades infecciosas más importantes
- d) Ayudar a identificar y controlar situaciones epidémicas
- e) Reunir información estadística completa y confiable, para determinar las políticas de salud

6) ¿Cuál es el mejor indicador para determinar si un programa de tamizaje del cáncer de mama es efectivo?

- a) Tasa de incidencia de cáncer de mama
- b) Tasa de prevalencia de cáncer de mama
- c) Tasa de letalidad de cáncer de mama
- d) Tasa de mortalidad de cáncer de mama
- e) Tasa de positividad de las pruebas de tamizaje del cáncer de mama

7) Un estudio investiga la correlación entre el desarrollo de alteraciones cognitivas en los niños y el uso de drogas durante el embarazo. Para ello, se selecciona a un grupo de niños con discapacidad cognitiva y se compara con otro grupo de niños sanos, realizándole una entrevista a los padres, sobre la exposición a distintos factores de riesgo, durante el embarazo. ¿Qué medida de asociación es la más adecuada para utilizar en este estudio?

- a) Riesgo relativo
- b) Riesgo atribuible
- c) Riesgo atribuible poblacional
- d) Odds ratio
- e) Incidencia

8) En un estudio se realiza medición de los niveles plasmáticos de pesticidas a personas de distintos países, obteniéndose los niveles promedios para la población de cada país. Luego, se correlaciona con las tasas de mortalidad por cáncer de cada país. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

- a) Observacional
- b) Cohortes
- c) Experimental
- d) Ecológico
- e) De contraste de hipótesis

9) Un paciente de 65 años presenta un cuadro de 7 días de dificultades para mover pierna derecha. En su examen físico se aprecia que al caminar arrastra ostentosamente la pierna derecha y se constata tono muscular y reflejos normales, por lo que se descarta patología orgánica. Refiere que los síntomas comenzaron luego de presenciar un accidente de tránsito, en el que hubo múltiples heridos de gravedad. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno conversivo
- b) Trastorno disociativo
- c) Trastorno de somatización
- d) Trastorno facticio
- e) Episodio psicótico

10) Una paciente de 52 años, con antecedente de abuso sexual reiterado por un familiar, entre los 12 y los 15 años, del que aún mantiene recuerdos y pesadillas, refiere episodios de algunos días de duración ánimo irritable y lábil, asociada a ira y peleas con sus familiares, con llanto y agresividad. En ocasiones, presenta episodios de hasta dos días de duración de descontrol y rabia, en los que rompe ropa y electrodomésticos de su marido. Estos episodios le traen problemas con sus cercanos y, en algunas ocasiones, son muy intensos, en especial cuando se expone a conversaciones relacionadas con el tema, en los que llora, siente intensa angustia, grita e incluso ha presentado momentos en que actúa como una niña, con lenguaje y entonación de una menor de edad. Estos episodios cursan con amnesia de lo sucedido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno bipolar
- b) Trastorno delirante
- c) Trastorno esquizoafectivo
- d) Trastorno conversivo
- e) Trastorno de estrés postraumático

11) Una paciente de 32 años presenta imágenes recurrentes, en que se ve a sí misma cortando a su hijo de 12 meses, con un cuchillo. Aquello le genera mucha angustia y miedo de dañar a su hijo. Por ello, nunca se queda a solas con el niño y sacó todos los cuchillos de los cajones de la casa. Está muy angustiada y triste, porque no quiere que le pase nada malo a su hijo y teme tener problemas con sus familiares o perder la tuición del niño, por lo que no le ha contado su problema a nadie. Ha pensado incluso en morir, con tal de proteger a su familia. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno bipolar
- b) Episodio psicótico
- c) Trastorno obsesivo compulsivo
- d) Trastorno depresivo mayor
- e) Trastorno de adaptación

12) Una paciente de 28 años presenta un episodio de rápida instalación de marcada angustia y variados síntomas como disnea con “imposibilidad de sacar el aire”, vértigo, parestesias en las extremidades, imposibilidad de tragar, opresión en el pecho, náuseas, visión borrosa y miedo a morir. En las últimas 4 semanas ha presentado varios episodios similares, por lo que teme salir de su casa. Su examen físico es normal y los exámenes generales descartan patología orgánica. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente?

- a) Amitriptilina 25 mg/día
- b) Sertralina 50 mg/día
- c) Risperidona 3 mg/día
- d) Clonazepam 2 mg/día
- e) Clorpromazina 300 mg/día

13) Un paciente esquizofrénico, recién diagnosticado, inicia tratamiento con risperidona 2 mg/día hace 5 días. Al tercer día, inicia un cuadro de disestesias en las extremidades inferiores, asociadas a angustia, inquietud y cambio continuo de posición. Se muestra muy incómodo y angustiado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno de adaptación
- b) Distonía aguda
- c) Disquinesia aguda
- d) Acatisia
- e) Hipomanía

14) Un paciente de 18 años, adicto a la pasta base, presenta un episodio psicótico, en relación al consumo, el que es manejado con haloperidol 5 mg por vía intramuscular. Al día siguiente presenta contracción tónica del cuello, que desvía la cabeza hacia la izquierda, con intenso dolor. El diagnóstico más probable es:

- a) Disonía aguda
- b) Acatisia
- c) Síndrome neuroléptico maligno
- d) Disquinesia tardía
- e) Parkinsonismo farmacológico

15) Una paciente de 27 años, en amenorrea por lactancia, presenta un cuadro de astenia y malestar general, constipación y dificultades para concentrarse, asociado a intolerancia al frío. Además, refiere que no ha podido bajar de peso. Al examen físico tiene FC: 67x', PA: 120/80 mmHg, se aprecia piel seca y cabello ralo, sin otras alteraciones en el examen físico segmentario. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran TSH: 14,7 UI/L, T4 libre: 0,6 ng/dl, T3: 46 ng/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?

- a) Iniciar tratamiento con levotiroxina oral
- b) Solicitar ecografía tiroidea
- c) Solicitar cintigrafía tiroidea
- d) Solicitar prueba de captación de yodo radiactivo
- e) Repetir los exámenes en 6 semanas

16) Un paciente de 32 años, con antecedente de familiar con cáncer de tiroides, acude a la consulta. Trae una ecografía cervical, que muestra un nódulo tiroideo de 7 mm de diámetro de aspecto quístico, sin calcificaciones, con presencia de adenopatías inespecíficas pequeñas. Su TSH y T4 libre son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar punción aspiración con aguja fina
- b) Solicitar cintigrafía tiroidea
- c) Solicitar captación de yodo radiactivo
- d) Solicitar nueva ecografía en 6 meses
- e) Realizar tiroidectomía

17) Un paciente de 30 años presenta un cuadro de astenia y piel seca. Al examen se detecta un nódulo tiroideo, que se palpa de 15 mm de diámetro, en relación al lóbulo derecho. Se solicita TSH, que resulta: 3,5 UI/L y T4 libre de 1,2 ng/dl. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de esta paciente?

- a) Ecografía cervical
- b) Biopsia citológica por punción con aguja fina
- c) Resonancia magnética nuclear de cuello
- d) Cintigrafía tiroidea
- e) TAC de cuello

18) Una paciente de 17 años consulta por amenorrea de 4 meses de evolución. Su examen físico no muestra alteraciones. Se realiza exámenes, que muestran test de embarazo negativo, TSH y prolactina dentro de rangos normales. Se solicita prueba de progesterona, que resulta negativa y prueba de estrógeno y progesterona, que resulta positiva. Además, se solicita LH y FSH, que están normales, dentro del límite bajo. El diagnóstico más probable es:

- a) Macroadenoma hipofisiario
- b) Falla ovárica primaria
- c) Embarazo ectópico
- d) Amenorrea hipotalámica
- e) Síndrome de ovario poliquístico

19) Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes e hipertensión, en tratamiento con metformina, glibenclamida y enalapril, consulta por dolor abdominal, de 24 horas de evolución, localizado en el hipogastrio y la fosa iliaca izquierda, asociado a sensación malestar general. Al examen físico presenta T°: 37,8°C, PA: 100/60 mmHg, FC: 88x', abdomen doloroso a la palpación superficial y profunda, mayor en la zona descrita, con signos peritoneales localizados en dicha área y disminución de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Infarto epiploico apendicular
- b) Embolia mesentérica
- c) Vólvulo de sigmoides
- d) Obstrucción intestinal
- e) Diverticulitis aguda

20) Un paciente de 38 años, con antecedente de colitis ulcerosa, desde hace 5 años con buen control, consulta por astenia y prurito de 2 meses de evolución, que han ido en aumento y que se ha asociado a ictericia de piel y mucosas. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran Bilirrubina: 3,3 mg/dl, bilirrubina directa: 2,4 mg/dl, FA: 512 UI/L, gama glutamil-peptidasa: 617 UI/L, GOT: 180 UI/L, GPT: 110 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Colangitis esclerosante primaria
- b) Colangiocarcinoma
- c) Hepatitis autoinmune
- d) Coledocolitiasis
- e) Colangitis biliar primaria

21) Un paciente de 45 años, con antecedente de colitis ulcerosa, diagnosticada a los 20 años, inactiva hace 10 años, desde hace una semana ha presentado episodios de deposiciones blandas, con presencia de sangre en escasa cantidad. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar rectosigmoidoscopia
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Solicitar parasitológico de deposiciones
- d) Solicitar colonoscopia
- e) Iniciar corticoides orales

22) Una paciente de 17 años, que desde los cinco años presenta epistaxis con frecuencia y equimosis ante pequeños traumatismos, desde los 14 años tiene su menarquia con sangrado menstrual abundantes. Se solicita hemograma que muestra hematocrito 45%, VCM: 90fl, leucocitos 6.000/mm³, plaquetas 250.000/mm³, TTPA normal, protrombinemia 85% y tiempo de sangría mayor a 8 minutos. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir con el estudio en este caso?

- a) Mielograma
- b) Citometría de flujo para receptor de la glicoproteína IIb IIIa
- c) Estudio de enfermedad de Von Willebrand
- d) Niveles plasmáticos de factor VIII y factor IX de la coagulación
- e) Electroforesis de proteínas en sangre

23) Una paciente de 64 años, con antecedente de by-pass gástrico, por obesidad mórbida, presenta un cuadro de dificultad a la marcha, asociado a astenia y malestar general. En sus exámenes destaca anemia macrocítica, plaquetas: 100.000 por mm³, blancos: 6.000 por mm³, ferritina 56 ug/dl y saturación de transferrina de 18%. ¿El déficit de qué nutriente explica mejor este caso?

- a) Hierro
- b) Ácido fólico
- c) Cianocobalamina
- d) Zinc
- e) Tiamina

24) Un niño de 8 años presenta dolores óseos, asociados a malestar general y fiebre de 3 semanas de evolución. Al examen físico se palpa el bazo aumentado de tamaño, por 3 cm bajo el reborde costal de consistencia indurada, se constatan poliadenopatías indoloras y se observan petequias y equimosis generalizadas, mayores en las extremidades inferiores ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

- a) Cintigrafía ósea
- b) Hemograma
- c) Biopsia esplénica
- d) Electroforesis de proteínas en sangre
- e) Mielograma

25) Un paciente de 34 años, consulta por cuadro de 5 semanas de tos irritativa con expectoración escasa, que ha ido empeorando, agregándose disnea de medianos esfuerzos en los últimos días. Al examen físico, se aprecia enflaquecido, con frecuencia respiratoria de 27 por minuto, frecuencia cardíaca de 90 por minuto, presión arterial de 100/70 mmHg y saturación de 92% con FiO₂ ambiental. Examen pulmonar muestra crepitaciones bilaterales difusas, con estertores y algunas sibilancias en ambos campos pulmonares. Se solicita radiografía de tórax que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia.org):



El diagnóstico más probable es:

- a) Fibrosis pulmonar
- b) Asma bronquial
- c) Neumonitis viral
- d) Neumonía por *Mycoplasma pneumoniae*
- e) Neumonía por *Pneumocystis jiroveci*

26) Un paciente de 39 años, VIH positivo, que abandonó el tratamiento antiviral hace varios meses, consulta por un cuadro de tos de 2 meses de evolución, asociado a expectoración mucopurulenta, que en ocasiones es hemoptoica, más sensación febril y baja de peso de 3 kilogramos. Al examen físico, se aprecia enflaquecido, con FC: 100x', PA: 110/60 mmHg, FR: 22x', saturación de oxígeno: 93%, Tº: 37,5°C y, en el examen pulmonar, se auscultan crepitaciones y estertores bilaterales. Se solicita radiografía de tórax que se muestra zonas de relleno bilaterales y se solicitan baciloscopías de expectoración que resultan negativas, con muestra hemorrágica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar TAC de tórax
- b) Realizar lavado bronquioalveolar
- c) Realizar broncoscopia
- d) Solicitar reacción en cadena de polimerasa para tuberculosis en expectoración
- e) Iniciar tratamiento con ceftriaxona endovenosa

27) Una mujer embarazada de 8 semanas se toma un VDRL, que resulta positivo en dilución 1/64. Tiene antecedente de alergia a la amoxicilina. El tratamiento de elección es:

- a) Penicilina
- b) Clindamicina
- c) Ceftriaxona
- d) Eritromicina
- e) Doxiciclina

28) Un niño de 8 años presenta odinofagia intensa, de 48 horas de evolución, asociada a malestar general, fiebre hasta 39°C, dolor abdominal y vómitos. Al examen físico está hidratado, con FC: 100x', FR: 15x', Tº: 38,7°C; se aprecia faringe congestiva y eritematosa, amígdalas con exudado blanquecino y se palpan múltiples adenopatías dolorosas en la cara anterior del cuello. El examen pulmonar es normal. Se solicita test pack rápido para estreptococo A, que resulta positivo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Penicilina sódica
- b) Cefadroxilo
- c) Ciprofloxacino
- d) Amoxicilina
- e) Clindamicina

29) Un niño de 7 años presenta lesiones pruriginosas en la nariz y la cara de 3 días de evolución. Al examen físico se aprecia lo siguiente (fuente: paperblog):



¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Curaciones con suero fisiológico
- b) Curaciones con povidona yodada
- c) Aciclovir oral por 5 días
- d) Prednisona oral por 7 días
- e) Flucloxacilina oral por 7 días

30) Un niño de 8 años presenta lesiones dolorosas en la espalda (pregunta original estaban en el cuello y zona dorsal alta), de 2 días de evolución, que se muestran a continuación (fuente: alamy stock photo):



¿Qué tratamiento es más adecuado?

- a) Mupirocina tópica
- b) Aciclovir oral
- c) Betametasona tópica
- d) Fluconazol tópico
- e) Cloxacilina oral

31) Una paciente de 28 años, embarazada de 28 semanas, consulta por aparición de una lesión cutánea en el dedo medio, de algunas semanas de evolución, friable, que ha sangrado en varias oportunidades. Al examen físico, se observa la siguiente fotografía (fuente: sanchezcarpinterodermatologo.blogspot.com):



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Verruga vulgar
- b) Granuloma piógeno
- c) Molusco contagioso
- d) Melanoma amelanótico
- e) Carcinoma basocelular

32) Un adolescente de 14 años consulta por una lesión de color rojo, en el tórax, que apareció hace algunas semanas y que ha sangrado varias veces, en relación al roce de la ropa. Se muestra a continuación:



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Pioderma gangrenoso
- b) Hemangioma infantil
- c) Nevo atípico inflamatorio
- d) Granuloma telangiectásico
- e) Melanoma maligno

33) Un niño de 5 años presenta un exantema pruriginoso, desde hace 4 días, generalizado y pleomorfo, consistente en máculas, pápulas, vesículas, que inició en el cuero cabelludo y la cara, a lo que luego se extendió al tronco y las extremidades, de proximal a distal. Fue precedido por un cuadro febril. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Aciclovir
- b) Valaciclovir
- c) Prednisona
- d) Clorfenamina maleato
- e) Talco mentolado

34) Un niño de 4 años presenta aparición de ronchas evanescentes en el tronco y extremidades, desde hace 4 días. Además, desde hace algunos días presentaba congestión nasal, con coriza y estornudos. Al examen físico se observan habones en el tórax y dermatografismo en las extremidades inferiores. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Indicar corticoides orales
- b) Solicitar prick test
- c) Indicar antihistamínicos orales
- d) Solicitar IgE sérica total
- e) Solicitar test de parches

35) Un niño de 18 meses presenta, desde hace 5 días irritabilidad y fiebre, cuantificada hasta 38,8°. Se inicia amoxicilina, cediendo la fiebre hace 48 horas y apareciendo un exantema eritematoso generalizado hace 24 horas, que se muestra en la siguiente imagen (fuente: wikipedia):



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Eritema infeccioso
- b) Exantema súbito
- c) Reacción cutánea a medicamentos
- d) Enfermedad de Kawasaki
- e) Rubéola

36) Un adolescente de 14 años presenta un cuadro de fiebre de 39°C, desde hace 3 días, asociado a malestar general, dolor abdominal, vómitos y diarrea, seguido de marcado compromiso, por lo que acude al servicio de urgencia. Al examen físico está con compromiso hemodinámico, con frecuencia cardíaca de 120x' y PA: 90/50 mmHg, por lo que es manejado con suero fisiológico endovenoso, con respuesta parcial. Tiene antecedente de PCR positiva para Covid-19 hace 30 días y se solicitan nuevos exámenes, que muestran hematocrito: 33%, blancos: 14.000 por mm³, plaquetas: 80.000 por mm³, VHS: 76 mmHg, PCR: 15,5 mg/L, dímero D: 670 ng/ml y troponinas elevadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Sepsis bacteriana
- b) Síndrome inflamatorio multisistémico
- c) Insuficiencia suprarrenal aguda
- d) Reinfección por Covid-19
- e) Enfermedad de Kawasaki

37) 67) Un lactante de 4 meses acude a su control de niño sano. Tiene antecedente de una invaginación intestinal a los 2 meses, ¿cuál de las siguientes vacunas está contraindicada en este paciente?

- a) VPO
- b) VPI
- c) Rotavirus oral
- d) Toxoide tetánico
- e) Toxoide diftérico

38) Un niño de 2 meses presenta estrabismo bilateral, fluctuante y que aparece con bastante frecuencia. Ha incrementado bien de peso y no tiene otros síntomas. Se realiza examen ocular, que muestra rojo pupilar presente bilateral, sin defectos y movilidad ocular sin alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar fondo de ojo
- b) Derivar a oftalmólogo pediátrico
- c) Indicar parches oculares intermitentes
- d) Solicitar TAC de órbitas
- e) Mantener el control habitual del niño sano

39) Un recién nacido de 20 días de vida, cuyo embarazo no fue controlado y que tiene antecedente de haber nacido por parto vaginal en su casa, es traído por presentar secreción ocular bilateral, desde hace 5 días. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival bilateral con escasa secreción. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Neisseria meningitidis
- b) Neisseria gonorrhoeae
- c) Streptococcus pneumoniae
- d) Streptococcus agalactiae
- e) Chlamydia trachomatis

40) Un niño de 3 meses de edad se realiza radiografía anteroposterior de pelvis, como screening para displasia de cadera. El ángulo acetabular se informa como 26º a derecha y 28º a izquierda. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Derivar a traumatología infantil
- b) Indicar doble pañal
- c) Indicar arnés de Pavlik
- d) Realizar ecografía de cadera
- e) Mantener los controles habituales de niño sano

41) Usted evalúa a una niña de 4 meses, cuyos índices antropométricos muestran índice peso/edad: normal, índice talla/edad: normal e índice peso/talla: +1. De acuerdo a las recomendaciones de diagnóstico nutricional infantil de la OMS – Ministerio de Salud, el diagnóstico más adecuado es:

- a) Desnutrición
- b) Riesgo de desnutrición
- c) Eutrofia
- d) Riesgo de obesidad
- e) Obesidad

42) Una paciente de 30 años, con antecedente de abscesos a repetición de la glándula de Bartholino derecha, que han sido drenados mediante punción o incisión, consulta nuevamente por dolor vulvar. Al examen físico se aprecia aumento de volumen, de 5 cm de diámetro, doloroso a la palpación, en relación a la zona posterior del labio mayor derecho. La conducta terapéutica más adecuada es:

- a) Cistectomía de Bartholino
- b) Drenaje por punción
- c) Drenaje quirúrgico simple
- d) Iniciar antibióticos orales y esperar el drenaje espontáneo
- e) Bartholinoneocistostomía

43) Una paciente de 20 años presenta aumento de volumen eritematoso y doloroso, en la zona interglútea, ubicado a dos centímetros de la línea media, sobre el coxis. Al examen físico, se observa aumento de volumen de 5 cm, doloroso, con presencia de dos orificios negros en la piel, cerca de la lesión. El diagnóstico más probable es:

- a) Linfoma
- b) Sarcoma
- c) Quiste pilonidal
- d) Absceso anorrectal
- e) Lipoma

44) Un paciente de 23 años consulta en el servicio de urgencia, por dolor torácico de 2 horas de evolución, intenso, asociado a diaforesis y palpitaciones, que inició algunos minutos después de haber inhalado cocaína. Al examen físico presenta FC: 120x', PA: 190/120 mmHg, ritmo regular en dos tonos, sin soplos. Su electrocardiograma muestra supradesnivel de segmento ST en las derivaciones de la pared anterior. ¿Qué fármaco está contraindicado en el manejo de este paciente?

- a) Estreptoquinasa
- b) Clopidogrel
- c) Nitroglicerina
- d) Atenolol
- e) Diazepam

45) Una paciente de 32 años, primigesta, cursando un embarazo de 33 semanas presenta presión arterial de 162/113 mmHg en el control. Se encuentra asintomática y los latidos cardíofetales se auscultan normales. ¿Cuál es el fármaco más adecuado para iniciar el tratamiento?

- a) Enalapril
- b) Sulfato de magnesio
- c) Metildopa
- d) Labetalol
- e) Hidralazina

46) Una paciente de 34 años, cursando embarazo de 32 semanas inicia prurito de palmas y plantas, que es más intenso en la noche y se asocia a astenia y vómitos. Al examen físico tiene signos vitales normales y se constata leve ictericia de escleras, sin alteraciones en las extremidades ni lesiones cutáneas. Su altura uterina es de 27 cm. Se solicitan exámenes, entre los que destacan bilirrubina: 1,5 mg/dl, fosfatasas alcalinas: 411 UI/L, SGOT: 32 UI/L, SGPT: 38 UI/L, gamaglutamiltransferasa: 398 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Colestasia intrahepática
- b) Colangitis biliar primaria
- c) Ictericia por hiperémesis gravídica
- d) Hígado graso agudo del embarazo
- e) Coledocolitiasis

47) Una paciente de 32 años, cursando un embarazo de 33 semanas, consulta por malestar general, asociado a dolor en el epigastrio e hipocondrio derecho de 3 días de evolución, que ha aumentado. Además, tiene astenia, cefalea y náuseas, asociadas a algunos episodios de vómitos alimentarios. Su examen físico muestra FC: 67x', PA: 120/80 mmHg, edema de extremidades inferiores y abdomen doloroso en el hipocondrio derecho, palpándose el hígado bajo el reborde costal. Entre sus exámenes destacan glicemia: 58 mg/dl, creatinina plasmática: 1,3 mg/dl, hemoglobina: 10,6 g/dl, plaquetas: 110.000 por mm³, LDH: 420 UI/L, PCR: 3 (VN: menor a 1), bilirrubina: 2,8 mg/dl, SGPT: 260 UI/L y SGOT: 340 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome de HELLP
- b) Hepatitis viral
- c) Hígado graso agudo del embarazo
- d) Colestasia intrahepática del embarazo
- e) Coledocolitiasis

48) Una paciente de 25 años, primigesta, cursa un embarazo de 29 semanas. Consulta por dolor abdominal de 2 días de evolución, de localización epigástrica, asociada a vómitos y malestar general. En su examen físico presenta FC: 90x', PA: 147/100 mmHg, FR: 12x', abdomen depresible, doloroso en la palpación epigástrica y más intenso en hipocondrio derecho. Sus exámenes muestran creatinina plasmática: 1,2 mg/dl, electrolitos plasmáticos normales, hemoglobina: 10,6 g/dl, plaquetas: 90.000 por mm³, blancos: 12.000 por mm³, LDH: 720 UI/L, PCR: 5,0, bilirrubina: 1,4 mg/dl, SGPT: 248 UI/L y SGOT: 277 UI/L. Su ecografía abdominal muestra cálculos biliares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome de HELLP
- b) Colecistitis aguda
- c) Hígado graso agudo del embarazo
- d) Colestasia intrahepática del embarazo
- e) Colangitis

49) Una paciente de 41 años se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 0, por presencia de opacidades fibronodulares bilaterales, bien delimitadas y sin calcificaciones. La conducta más adecuada es:

- a) Control mamográfico en 6 meses
- b) Ecotomografía mamaria
- c) Biopsia guiada por rayos X
- d) Mamografía en 1 año
- e) Resonancia magnética nuclear de mama

50) Un paciente de 35 años presenta un nódulo mamario, desde hace 8 meses. Su ecografía mamaria muestra un tumor de aspecto sólido, bordes bien delimitados, sin refuerzo posterior y con un índice ultrasonográfico Birrads 3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Mastopatía fibroquística
- b) Papiloma ductal
- c) Fibroadenoma
- d) Tumor phylloides
- e) Carcinoma ductal

51) Una paciente de 25 años, con antecedente de haber iniciado su vida sexual a los 14 años y, desde entonces, mantener relaciones sexuales, con múltiples parejas, sin utilización de métodos de barrera, se realiza un PAP que es informado como lesión de alto grado. Además, se realiza tipificación de virus papiloma humano, que muestra serotipo de bajo grado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar nuevo PAP en 6 meses
- b) Solicitar nuevo PAP en 1 año
- c) Realizar colposcopia y eventual biopsia
- d) Realizar cono LEEP
- e) Realizar histerectomía

52) Una paciente de 24 años se realiza un PAP, que es informado como lesión de bajo grado y probable infección de virus papiloma humano. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar PAP en 1 año
- b) Realizar colposcopia y biopsia
- c) Repetir el PAP en 6 meses
- d) Realizar tipificación de virus papiloma humano
- e) Realizar PAP en 3 meses

53) Una mujer de 42 años, diagnosticada de cáncer de cuello uterino en etapa IIIB, en tratamiento con quimioterapia y radioterapia combinada, consulta por abundante genitorragia. A su ingreso presenta PA: 100/60 mmHg y FC: 100x' y se realiza especuloscopia que confirma que el sangrado proviene de la lesión tumoral. Su hemograma muestra hemoglobina: 10 g/dl y hematocrito: 29%, con plaquetas de 170.000 por mm³. Se administra ácido tranexámico endovenoso y suero fisiológico. Sin embargo, la paciente continúa con abundante hemorragia. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar histerectomía
- b) Administrar plasma fresco endovenoso
- c) Realizar taponamiento vaginal
- d) Realizar ligadura de las arterias cervicales
- e) Realizar diatermocoagulación cervical

54) Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 40 semanas, consulta por ausencia de movimientos fetales, por lo que se realiza un perfil biofísico, que resulta 8/10, con presencia de oligoamnios. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar a evolución espontánea
- b) Interrumpir ahora por cesárea
- c) Inducir el parto en este momento
- d) Realizar cesárea al momento del trabajo de parto
- e) Inducir el parto a las 41 semanas

55) Un paciente de 60 años, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 y tabaquismo de 20 paquetes año, consulta en el servicio de urgencia, por dolor precordial opresivo. Luego de su ingreso, presenta compromiso de conciencia, sin respuesta. Al examen físico no respira y es imposible palpar el pulso carotídeo. Además de solicitar ayuda, la conducta inicial más adecuada es:

- a) Realizar compresiones torácicas
- b) Realizar intubación orotraqueal
- c) Dar golpe torácico
- d) Desfibrilar
- e) Administrar adrenalina endovenosa

56) Una mujer de 23 años está en trabajo de parto. Al momento de romperse las membranas, se observa salida de meconio espeso. El recién nacido nace cianótico, hipotónico, sin esfuerzos respiratorio. La conducta inicial debe ser:

- a) Aspirar vía aérea con sonda
- b) Dar ventilación a presión positiva
- c) Administrar adrenalina endotraqueal
- d) Realizar intubación orotraqueal
- e) Realizar masaje cardíaco

57) Un recién nacido nace por cesárea de urgencia, debido a un registro fetal con signos de hipoxia. Al examen físico tiene cianosis generalizada e hipotonía, sin esfuerzo respiratorio, por lo que se seca y se pone bajo calor radiante, en posición de olfateo, con aporte de oxígeno. A los 50 segundos persiste en apnea y se constata pulso carotideo a 30 latidos por minuto. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?

- a) Conectar a ventilación mecánica
- b) Administrar bicarbonato endovenoso
- c) Administrar adrenalina por vía orotraqueal
- d) Dar ventilación a presión positiva con mascarilla facial
- e) Realizar masaje cardíaco

58) Un niño de 8 años ingresa por un cuadro de decaimiento y malestar general, con diarrea y vómitos. Está somnoliento y con compromiso hemodinámico, con FC: 120x' y PA: 70/30 mmHg. Se administran dos bolos de suero fisiológico de 20 cc/kg de peso, sin lograr estabilizarlo. En sus exámenes destaca glicemia 62 mg/dl y pH: 7,29, con exceso de base: -16. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

- a) Administrar hidrocortisona endovenosa 2mg/kg de peso
- b) Administrar un tercer bolo de suero fisiológico 20 cc/Kg de peso
- c) Administrar solución glucosalina 1.700 cc/m² de superficie corporal
- d) Administrar plasma fresco 20 cc/kg de peso
- e) Administrar bicarbonato de sodio 2 mEq/Kg de peso

59) Una paciente de 27 años, diabética tipo 1, con mal control metabólico, consulta por edema de las extremidades inferiores y orinas espumosas. Al examen físico se constata edema palpebral y facial, edema blando de extremidades inferiores. En sus exámenes destaca hemoglobina glicosilada de 8,2%, ANA negativos, sedimento de orina con abundantes cuerpos ovoides grasos, 2-3 glóbulos rojos por campo y 2-4 glóbulos blancos por campo, creatinina: 1,2 mg/dl y proteinuria cuantitativa de 9 g en 24 horas. ¿Cuál es la conducta de elección para proseguir el manejo de esta paciente?

- a) Electroforesis de proteínas en sangre
- b) Biopsia renal
- c) Inmunofijación de proteínas en orina
- d) Prednisona oral
- e) Solicitar ANCA, C3 y C4

60) Un paciente de 78 años, diabético, hipertenso y dislipidémico está en tratamiento con metformina, glibenclamida, enalapril, hidroclorotiazida, aspirina y atorvastatina. Se realiza exámenes de laboratorio, entre los que destacan sodio plasmático: 130 mEq/L, potasio plasmático: 3,4 mEq/L, creatinina plasmática: 1,1 mg/dl. ¿Cuál es la causa más probable de sus alteraciones?

- a) Nefroesclerosis hipertensiva
- b) Uso de hidroclorotiazida
- c) Nefropatía diabética
- d) Uso de enalapril
- e) Uso de aspirina

61) Un paciente de 24 años sufre un accidente de tránsito a alta velocidad. Ingresa adolorido, con sangre fresca por uretra. Está en buenas condiciones, con estabilidad hemodinámica y sin signos de fracturas en el examen físico. La tomografía axial computada de tórax abdomen y pelvis muestra fractura de pelvis no desplazada, vejiga distendida, sin líquido libre peritoneal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

- a) Pielografía de eliminación
- b) UroTAC
- c) Uretrocistografía retrógrada
- d) Ecotomografía pélvica
- e) Resonancia magnética nuclear de pelvis

62) Un hombre de 34 años presenta erección dolorosa, desde hace 8 horas. Al examen se corrobora que tiene erección completa, pero turgencia solo de los cuerpos cavernosos, con glándula y cuerpos esponjosos blandos. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Aplicar hielo en la zona genital
- b) Realizar derivación cavernoesponjosa de urgencia
- c) Administrar atropina intracavernosa
- d) Administrar analgésicos endovenosos
- e) Administrar fenilefrina intracavernosa

63) Un paciente de 87 años, institucionalizado por una demencia tipo Alzheimer y que es portador de sonda Foley a permanencia, presenta orinas turbias, por lo que se realiza un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli sensible a nitrofurantoína, amikacina e imipenem. El paciente está en buenas condiciones, asintomático y sin mayor confusión de la habitual. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Retirar la sonda
- b) Iniciar amikacina
- c) Iniciar imipenem
- d) Iniciar nitrofurantoína
- e) Mantener sin tratamiento antibiótico

64) Un paciente de 34 años presenta su primer episodio de cólico renal. Presenta eliminación espontánea de un pequeño cálculo, el que no es preservado para estudio citológico. Actualmente está asintomático y el pielotAC no observa otras litiasis. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este paciente?

- a) Indicar dieta baja en lácteos
- b) Iniciar hidroclorotiazida
- c) Aumentar la ingesta de agua
- d) Realizar litotripsia extracorpórea
- e) Realizar estudio metabólico de urolitiasis

65) Un paciente de 60 años, fumador de 40 paquetes años, consulta por disnea de 3 meses de evolución, asociado a tos con expectoración mucosa, que en ocasiones es hemoptoica y que se ha asociado a baja de peso no cuantificada. Al examen físico tiene FC: 72x', PA: 110/70 mmHg, FR: 15x', saturación O₂: 95%. A la auscultación pulmonar se constatan escasos crépitos y algunas sibilancias, que son mayores en el campo pulmonar izquierdo. Se realiza una radiografía, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia):



¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

- a) Biopsia pulmonar por fibrobroncoscopía
- b) TAC de tórax con contraste
- c) Fibrobroncoscopía con lavado bronquioalveolar
- d) Biopsias por videotoracoscopia
- e) Resonancia magnética nuclear de tórax

66) Una paciente de 21 años presenta rinorrea, congestión nasal, disnea, tos, con expectoración mucosa y sibilancias, que aparecen especialmente luego de realizar ejercicio y durante las infecciones respiratorias, siendo mayores en primavera. Su examen físico tiene frecuencia respiratoria 12x', frecuencia cardíaca 73x', PA: 120/70 mmHg, examen cardiopulmonar normal. Se solicitar un PEF, que resulta 580 L/min, que equivale al 98% del valor esperado. Se solicita una radiografía, que resulta normal. ¿Cuál de los siguientes es el examen más adecuado para proseguir con el estudio en esta paciente?

- a) Prick test
- b) TAC de tórax
- c) Espirometría basal y postbroncodilatador
- d) Prueba de eosinófilos nasales
- e) Prueba de provocación bronquial

67) Un paciente de 58 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por disfonía de 3 semanas de evolución, asociada a ligera odinofagia. Al examen físico, además, se palpa una adenopatía submandibular, de consistencia aumentada. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

- a) TAC de cuello
- b) TAC de tórax
- c) Ecografía de cuello
- d) Nasofibrolaringoscopia
- e) Endoscopia digestiva alta

68) Un paciente de 58 años, fumador de 10 paquetes año, consulta por disnea, asociada a tos y expectoración mucosa, de 2 años de evolución. En ocasiones, los síntomas aumentan significativamente, especialmente en relación a la actividad física y cuando presenta infecciones respiratorias. En su examen físico se auscultan escasas sibilancias bilaterales y espiración prolongada. Se solicita una espirometría que muestra:

	Basal		Postbroncodilatador	
CVF	5.928cc	100%	6.106cc	103%
VEF1	4.163cc	76%	5.040cc	92%
VEF1/CVF		65%		73%

Su radiografía de tórax se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia):



El diagnóstico más probable es:

- a) Asma bronquial
- b) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- c) Bronquiectasias
- d) Bronquitis crónica
- e) Enfermedad pulmonar intersticial difusa

69) Una paciente de 43 años presenta obstrucción nasal marcada, asociada a rinorrea de 5 años de evolución, con sensación de presión facial, cefalea e hiposmia. Se solicita radiografía de cavidades paranasales, que muestra velamiento de ambos senos maxilares. La TAC de cavidades paranasales muestra secreciones e inflamación de la mucosa de ambos senos maxilares y de celdillas etmoidales bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Fluticasona nasal
- b) Azitromicina
- c) Cirugía endoscópica nasal
- d) Rinomanometría
- e) Resonancia magnética nuclear de cavidades paranasales

70) Un paciente de 34 años presenta un episodio de tos intensa, con salida de abundante líquido salobre, con presencia de membranas blanquecinas y restos hemoptoicos. Su examen físico es normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar el estudio de este paciente?

- a) TAC de tórax y abdomen
- b) Parasitológico de deposiciones
- c) Radiografía de tórax
- d) Ecografía abdominal
- e) Colonoscopia

71) Un recién nacido nace por parto vaginal a las 40 semanas y pesa 2.600 gramos. ¿Cuál de las siguientes complicaciones se presentará con mayor riesgo en las primeras horas de vida?

- a) Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido
- b) Hiperbilirrubinemia
- c) Anemia
- d) Hiperkalemia
- e) Hipoglicemia

72) Un paciente de 78 años, diabético, en tratamiento con glibenclamida 15 mg/día, presenta convulsiones tónico-clónicas subintrantes desde hace algunos minutos. Hace 3 días se realizó control de exámenes, con glicemia de ayuno de 185 mg/dl y electrolitos plasmáticos dentro de rangos normales. ¿Cuál es la causa más probable de sus convulsiones?

- a) Hipomagnesemia
- b) Hipernatremia
- c) Hipoglicemia
- d) Hipocalcemia
- e) Cetoacidosis

73) Una paciente de 37 años, cursando embarazo de 29 semanas, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, de 75 gramos, que muestra glicemia basal de 86 mg/dl y postcarga de 139 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar dieta hipoglúcida y controlar con glicemias seriadas
- b) Solicitar hemoglobina glicosilada
- c) Iniciar metformina
- d) Repetir el examen a las 32 semanas
- e) Mantener el control habitual del embarazo

74) Una paciente de 23 años, primigesta, cursando embarazo de 13 semanas, se realiza determinación de grupo sanguíneo, que es informada como AB, Rh(-), Du (+). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar doppler de arteria cerebral media fetal
- b) Solicitar Coombs indirecto a las 18 semanas
- c) Administrar Rhogam a las 28 semanas
- d) Determinar grupo y Rh del padre
- e) Mantener control habitual del embarazo

75) Una paciente de 41 años, cursando un embarazo de 11 semanas, se realiza una ecografía transvaginal, que muestra translucencia nuchal de 6 mm (VN: menor a 3 mm) y ausencia de hueso nasal. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

- a) Biopsia de vellosidad corial
- b) Mediciones ecográficas seriadas de fémur
- c) Repetir el examen a las 14 semanas
- d) Estudio genético de DNA fetal libre en sangre materna
- e) Niveles plasmáticos de HCG

76) Un paciente de 32 años presenta dolor cervical intenso, mientras realizaba deporte, que se irradia hacia la cara, zona temporal y se asocia a cefalea intensa. Al examen físico se observa ptosis y miosis derechas. El diagnóstico más probable es:

- a) Parálisis del tercer nervio craneal
- b) Aneurisma cerebral anterior, con compromiso del tercer nervio craneal
- c) Infarto vertebrobasilar
- d) Migraña hemipléjica
- e) Disección carotídea

77) Una paciente de 30 años, con antecedente de embarazo de 7 semanas de amenorrea, se realiza una ecografía transvaginal, que muestra útero con presencia de saco gestacional de 18 mm de diámetro, sin presencia de embrión. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar laparoscopia
- b) Solicitar nueva ecografía en 7 días
- c) Solicitar niveles seriados de HCG
- d) Realizar legrado uterino
- e) Administrar progesterona

78) Una mujer de 52 años presenta reglas irregulares, desde hace 8 meses, asociadas a bochornos frecuentes, con calor, enrojecimiento de la cara, sudoración nocturna y dificultades para dormir. ¿Cuál es la indicación más adecuada para el manejo de los síntomas de esta paciente?

- a) Fitoestrógenos
- b) Terapia de reemplazo hormonal combinada continua
- c) Terapia de reemplazo hormonal combinada cíclica
- d) Estrógenos solos continuos
- e) Progestágenos solos continuos

79) Una paciente de 35 años, multipara de dos, se realiza una cesárea por presentación podálica. Luego de la extracción del recién nacido y del legrado uterino, se observan múltiples miomas uterinos subserosos de variados tamaños. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar miomectomía múltiple
- b) Realizar histerectomía subtotal
- c) Realizar miomectomía selectiva de los tumores mayores a 5 cm
- d) Realizar histerectomía obstétrica
- e) Realizar el cierre habitual de la cesárea

80) Un niño de 12 años, con antecedente de un meduloblastoma de fosa posterior, tratado con quimioterapia y radioterapia cerebral, en remisión completa, desde hace 5 años; consulta por talla baja. Su curva de crecimiento demuestra que ha estado creciendo en una talla equivalente al percentil 2 para la edad y, en su examen físico, presenta desarrollo genital en Tanner 3, con vello púbico en Tanner 4. La talla parental estimada es de 170 cm. ¿Cuál es la causa más probable de su talla baja?

- a) Retraso pubertad
- b) Recidiva tumoral
- c) Hipogonadismo
- d) Déficit de hormona de crecimiento
- e) Talla baja familiar

81) Una paciente de 56 años, en tratamiento con tamoxifeno 20 mg/día, por un cáncer de mama, diagnosticado hace 9 años, presenta metrorragia escasa desde hace 5 días, por lo que se solicita una ecografía transvaginal, que muestra un endometrio de 8 mm, sin alteraciones anexiales. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar terapia de reemplazo hormonal oral
- b) Instalar dispositivo intrauterino medicado
- c) Disminuir la dosis de tamoxifeno
- d) Solicitar biopsia endometrial
- e) Realizar histerectomía

82) Una paciente de 43 años, secretaria, consulta porque, desde hace dos semanas, presenta dolor en el hombro derecho, que es más intenso durante la noche y que empeora con los movimientos del mismo, por lo que ha ido limitando sus actividades normales. El dolor aumenta con la abducción y con la elevación del brazo derecho, por sobre el hombro. Al examen físico tiene movilidad completa del hombro, con dolor en las maniobras descritas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Capsulitis adhesiva de hombro
- b) Tendinopatía del manguito rotador
- c) Disyunción acromioclavicular
- d) Tendinopatía de la cabeza larga del bíceps braquial
- e) Hernia cervical con compresión radicular

83) Un recién nacido de 10 días presenta un hemangioma en el párpado derecho, de 3 cm de diámetro, que cubre parcialmente la visión. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?

- a) Administrar propanolol
- b) Administrar betametasona
- c) Realizar embolización
- d) Derivar a cirujano plástico
- e) Observar evolución

84) 3) Una paciente de 72 años de edad, con antecedente de cirrosis hepática por consumo de alcohol, suspendido hace 5 años acude a control médico. Trae VHBsAg (-) y Anticuerpos anti-VHC (-), Child Pugh clase A, MELDS: 8 puntos, se realiza una ecografía abdominal, que muestra una lesión sólida, en el lóbulo hepático derecho, de 3,5 cm y aspecto hipoecogénico, que en la tomografía se aprecia sólido e hipervascular en la fase arterial. El diagnóstico más probable es:

- a) Colangiocarcinoma
- b) Adenoma hepático
- c) Carcinoma hepatocelular
- d) Quiste hepático
- e) Hemangioma hepático

85) Una niña de dos años presenta un episodio brusco de tos intensa, asociado a cianosis y disnea, que remite luego de pocos minutos. Persiste luego con tos en salvas y expectoración. Al examen pulmonar se auscultan roncus y sibilancias, mayores en el lado derecho. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar PCR para Bordetella pertusis
- b) Solicitar TAC de tórax
- c) Solicitar broncoscopía
- d) Realizar laringoscopia rígida
- e) Iniciar antibióticos

86) Un paciente de 78 años, con sobrepeso, presenta alteraciones de la memoria y dificultades para concentrarse, que iniciaron hace 2 años y que han progresado, asociado a hipersomnia y cansancio. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

- a) Electrocardiograma
- b) Ecocardiograma
- c) Polisomnografía
- d) RMN de cerebro
- e) TAC de cerebro

87) Una adolescente de 15 años se intenta suicidar, ingiriendo 600 miligramos de amitriptilina. ¿Cuál es el examen más adecuado para determinar su riesgo?

- a) Gases arteriales
- b) Bilirrubinemia
- c) Electrocardiograma
- d) Creatinfosfoquinasa
- e) Pruebas hepáticas

88) Una paciente de 43 años presenta vértigo de 5 días de evolución, intenso, asociado a vómitos, lo que limita sus actividades. No tiene síntomas auditivos. El diagnóstico más probable es:

- a) Parálisis cocleovestibular
- b) Vértigo postural
- c) Hídrops endolinfático
- d) Neuritis vestibular
- e) Neurinoma del acústico

89) Paciente de 62 años, diabético diagnosticado hace 3 meses, en tratamiento con hipoglicemiantes orales, como parte de un chequeo se realiza exámenes de chequeo donde se aprecia creatinina de 0,9 mg/dL, hemoglobina glicosilada menor a 7% y un perfil lipídico que muestra triglicéridos: 250 mg/dL, colesterol total: 253 mg/dL, HDL: 51 mg/dL, LDL: 152 mg/dL. No presenta síntomas. El tratamiento más adecuado para disminuir su riesgo cardiovascular es:

- a) Fibratos
- b) Estatinas
- c) Dieta baja en ácidos grasos saturados
- d) Ácido nicotínico
- e) Ezetimibe

90) Un paciente de 35 años está convencido que las vacunas contra la Covid-19 contienen un chip para rastrear a las personas y que hay un acuerdo entre Bill Gates y muchos de los gobiernos para controlar las mentes de la población, tal como lo ha hecho con muchas personas, a las que califica de “borregos”. Cree que la mayoría de los médicos son parte de este complot, porque están financiados por las farmacéuticas y el Gobierno. Si bien se desenvuelve normalmente en su trabajo, ha tenido varios problemas con compañeros de trabajo y con sus familiares, cuando se toca el tema de las vacunas, en el que habla con gran vehemencia y certeza, criticando duramente a quienes le recomiendan vacunarse. También pierde mucho tiempo discutiendo sobre el tema en redes sociales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno delirante
- c) Trastorno del espectro autista en el adulto
- d) Trastorno bipolar
- e) Trastorno de personalidad paranoide

(Nota: pregunta añadida a la reconstrucción)

NOMBRE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

APELLIDO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

APELLIDO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RUT o número P

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	A	B	C	D	E	19	A	B	C	D	E	37	A	B	C	D	E	55	A	B	C	D	E	73	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E	20	A	B	C	D	E	38	A	B	C	D	E	56	A	B	C	D	E	74	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E	21	A	B	C	D	E	39	A	B	C	D	E	57	A	B	C	D	E	75	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E	22	A	B	C	D	E	40	A	B	C	D	E	58	A	B	C	D	E	76	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E	23	A	B	C	D	E	41	A	B	C	D	E	59	A	B	C	D	E	77	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E	24	A	B	C	D	E	42	A	B	C	D	E	60	A	B	C	D	E	78	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E	25	A	B	C	D	E	43	A	B	C	D	E	61	A	B	C	D	E	79	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E	26	A	B	C	D	E	44	A	B	C	D	E	62	A	B	C	D	E	80	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E	27	A	B	C	D	E	45	A	B	C	D	E	63	A	B	C	D	E	81	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E	28	A	B	C	D	E	46	A	B	C	D	E	64	A	B	C	D	E	82	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E	29	A	B	C	D	E	47	A	B	C	D	E	65	A	B	C	D	E	83	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E	30	A	B	C	D	E	48	A	B	C	D	E	66	A	B	C	D	E	84	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E	31	A	B	C	D	E	49	A	B	C	D	E	67	A	B	C	D	E	85	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E	32	A	B	C	D	E	50	A	B	C	D	E	68	A	B	C	D	E	86	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E	33	A	B	C	D	E	51	A	B	C	D	E	69	A	B	C	D	E	87	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E	34	A	B	C	D	E	52	A	B	C	D	E	70	A	B	C	D	E	88	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E	35	A	B	C	D	E	53	A	B	C	D	E	71	A	B	C	D	E	89	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E	36	A	B	C	D	E	54	A	B	C	D	E	72	A	B	C	D	E	90	A	B	C	D	E

RECONSTRUCCIÓN EUNACOM AGOSTO 2021

Dr. Guillermo Guevara Aliaga

SEGUNDA PARTE

Instrucciones:

1. Esta prueba consta de 90 preguntas por parte.
 2. Dispondrá de un tiempo de 105 minutos para responder.
 3. Al final de la prueba, usted cuenta con una hoja de respuestas. Arránquela y conteste en ella, asegurándose de escribir su nombre y su RUT, con letra clara.
 4. Debe responder con lápiz mina HB N°2 o 2B, ennegreciendo completamente la casilla correcta.
 5. Si se equivoca, la única forma de corregir es borrar con una goma y marcar la respuesta correcta.
 6. Solo se corregirá la hoja de respuestas, así que asegúrese de contestarla a tiempo.
 7. Las preguntas incorrectas no descontarán puntaje, por lo que no debe omitir.
 8. Puede rayar el cuadernillo de preguntas. Sin embargo, solo se corregirá la hoja de respuestas.
 9. Al final de la prueba, debe entregar solo la hoja de respuestas. El cuadernillo de preguntas es suyo y puede llevárselo. La prueba será subida a la plataforma web, con su respectiva pauta y explicación. En ese entonces, podrá objetar las preguntas y, si procede, se anularán las preguntas defectuosas.
 10. No se responderán dudas durante la prueba. Debe permanecer en silencio.
 11. Asegúrese de pasar al baño antes de que inicie la prueba, ya que, durante esta, no podrá salir.
 12. La copia está absolutamente prohibida. Tanto copiar, como entregar las respuestas al compañero será considerada una falta grave, que se sancionará con la nota mínima en la prueba y la reprobación automática del curso.
 13. El simple hecho de tener un celular o un smartwatch (reloj inteligente) u otro dispositivo electrónico, a través del cual sea posible copiar o enviar información, será considerado copia y reprobará el curso.
 14. Si termina la prueba antes de que se acabe el tiempo, podrá entregar la hoja de respuestas y retirarse, sin hacer ruido ni hablar, hasta estar lo suficientemente lejos, como para que quienes no han terminado no se vean afectados.
 15. Las notas estarán disponibles en 15 días y les serán entregadas de manera individual, a su correo electrónico.
- ¡Les deseamos el mayor de los éxitos y mucha suerte!

SEGUNDA PARTE

91) Un recién nacido sufre la caída del cordón umbilical, presentado a los pocos días una lesión redondeada y soleantada, no pediculada, de color rosado brillante y aspecto húmedo, de 1 cm de diámetro. ¿Cuál es la conducta más adecuada para su manejo?

- a) Corticoides tópicos
- b) Resolución quirúrgica
- c) Nitrógeno líquido
- d) Aplicación de nitrato de plata
- e) Antibióticos tópicos

92) Un paciente de 76 años, con antecedente de hipertensión arterial, diabetes y dislipidemia, en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida, aspirina, metformina y atorvastatina, fumador de 10 paquetes año, consulta por un cuadro de tos, expectoración y disnea, de 2 días de evolución, por lo que consulta al servicio de urgencia. Al examen físico presenta FR: 25x', PA: 150/100 mmHg, FC: 90x', saturación oxígeno: 86%. Su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar simétrico, con crepitaciones intensas bilaterales, mayores en las bases y algunas sibilancias. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia):



El diagnóstico más probable es:

- a) Neumonía bilateral
- b) Insuficiencia cardíaca descompensada
- c) Bronquiectasias
- d) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- e) Fibrosis pulmonar

93) Un paciente de 28 años consulta por dolor torácico derecho, de 2 días de evolución, que aumenta con la inspiración y con la actividad física. Al examen físico está eupneico, con FR: 15x', saturación de oxígeno normal, se aprecia disminución del murmullo pulmonar mayor en el lado derecho. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación (Fuente: imgur.com):



¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Control radiológico en 24 horas
- b) Solicitar TAC de tórax
- c) Realizar cirugía abierta
- d) Drenaje con tubo pleural
- e) Realizar videotoracoscopia

94) Un niño de 6 años consulta por dolor en el codo derecho, de dos días de evolución, asociado a impotencia funcional y fiebre de hasta 39°C. Al examen físico, se observa codo eritematoso y aumentado de volumen, con dolor intenso a la movilización activa y pasiva.

¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Staphylococcus aureus
- b) Haemophilus influenzae
- c) Streptococcus agalactiae
- d) Neisseria meningitidis
- e) Streptococcus pyogenes

95) Un paciente de 68 años presenta monoartritis de rodilla izquierda, desde hace 48 horas. Al examen físico se observa aumento de volumen con signos de derrame articular, por lo que se punciona, dando salida a un líquido articular poco filante, con 50.000 glóbulos blancos por mm³, sin presencia de cristales. Lo más probable es que se trate de una artritis:

- a) Reactiva
- b) Seronegativa
- c) Reumatoide
- d) Séptica
- e) Psoriática

96) Una paciente de 50 años consulta por artralgiyas y edema de las manos, especialmente en las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y en las muñecas de ambas manos. Refiere fenómeno de Raynaud y rigidez matinal de 1 hora de duración. Además, relata sensación de arenilla ocular, hipolacrimia y xerostomía. Se solicitan exámenes, que muestran hemograma normal, VHS: 52 mm/h, PCR: 2,8 mg/dl, ENA (-), AntiDNA 2h (-) y anticuerpos anti-CCP mayores a 200 UI/ml. La radiografía de manos muestra edema de partes blandas y osteopenia yuxtarticular de los huesos metacarpianos. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus eritematoso sistémico
- b) Artritis reumatoide
- c) Artritis psoriática
- d) Esclerosis sistémica
- e) Síndrome de Sjörgren primario

97) Un paciente de 23 años consulta por dolor lumbar y en la zona glútea, de 1 año de evolución, que es mayor en las mañanas y al dormir y que va cediendo a medida que realiza sus actividades durante el día. Además, ha presentado dolor y aumento de volumen de la rodilla derecha, que luego desapareció espontáneamente. Al examen físico tiene placas descamativas en las rodillas, depresiones ungueales, dolor a la compresión prueba de Lasegue negativa, prueba de Schöbber 2 cm. En sus exámenes destaca ANA negativos y factor reumatoide, dentro de límites normales. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

- a) Radiografía de columna lumbosacra
- b) Tomografía de columna dorsolumbar
- c) Radiografía de tórax
- d) Resonancia magnética nuclear de articulaciones sacroilíacas
- e) ANCA, C3 y C4

98) Una paciente de 23 años presenta aparición súbita de lesiones eritematosas en las mejillas, que iniciaron luego de exponerse al sol y se asocian a malestar general, caída de cabello y artralgiyas de manos. En el examen físico destaca eritema malar y edema de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes que muestran hemograma con hemoglobina: 9,8 g/dl, hematocrito 29%, glóbulos blancos: 3500 por mm³ y plaquetas: 90.000 por mm³, más examen de orina con proteinuria +++ y hematuria. ¿Cuál es el examen más sensible para el diagnóstico de la patología descrita?

- a) Factor reumatoide
- b) Anticuerpos anti-Ro
- c) Anticuerpos anti-Sm
- d) Anticuerpos antinucleares
- e) Anticuerpos antifosfolípidos

99) Un paciente de 26 años, sufre un accidente automovilístico de alta energía, como conductor. Llega a la urgencia entablillado y con hemodinamia estable. Destaca la extremidad inferior derecha en flexión y aducción, dolorosa, con imposibilidad de caminar. Se realiza radiografía anteroposterior de pelvis, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia):



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Fractura de la cabeza femoral derecha
- b) Fractura de zona posterior del cotilo derecho
- c) Luxofractura posterior de cadera derecha
- d) Fractura de pelvis inestable
- e) Fractura extracapsular de cadera derecha

100) Un paciente de 26 años presenta un cuadro de dolor lumbar, asociado a inquietud motora de 5 días de evolución. Hace 2 días se agrega fiebre y compromiso del estado general, más vómitos alimentarios. Al examen físico se aprecia FC: 105x', PA: 100/70 mmHg, Tº: 38°C, puño percusión positiva a izquierda. Se solicita pielotAC que muestra imagen cálcica en el tercio medio del uréter izquierdo, con dilatación de la vía urinaria proximal y edema perirrenal. Su sedimento de orina muestra 40 leucocitos por campo, bacterias y cristales en moderada cantidad. Se inicia tratamiento antibiótico endovenoso y se administran cristaloides. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Litotripsia extracorpórea
- b) Nefrolitotomía percutánea
- c) Extracción quirúrgica abierta
- d) Catéter doble jota
- e) Litotomía ureteroscópica

101) Un paciente de 56 años consulta por disminución del calibre miccional, asociado a disuria de esfuerzos de 3 meses de evolución. Hace 7 días se agrega disuria, polaquiuria y malestar. Se solicita APE, que resulta 14,7 ng/ml (valor normal: menor a 4 ng/ml). El tratamiento inicial más adecuado es:

- a) Tamsulosina
- b) Nitrofurantoína
- c) Ciprofloxacino
- d) Dutasteride
- e) Doxazosina

102) Una paciente de 56 años, diabética tipo 2, de larga data, consulta por dolor y parestesias en ambas manos, mayores en la noche, que se irradian hacia los codos. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de túnel carpiano
- b) Síndrome del opérculo torácico
- c) Neuropatía por atrapamiento del nervio cubital
- d) Polineuropatía diabética
- e) Síndrome de compresión radicular cervical

103) Un paciente sufre una fractura de húmero derecho, que es manejada mediante reducción quirúrgica y osteosíntesis. Al quinto día, evoluciona con parestesias y dolor de la extremidad, asociada a imposibilidad de extender la muñeca. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome compartimental
- b) Compresión del nervio mediano
- c) Lesión del nervio musculocutáneo
- d) Atrapamiento del nervio cubital
- e) Lesión del nervio radial

104) Un hombre de 68 años, diabético mal controlado, consulta por mialgias generalizadas de 2 semanas de evolución, mayores en los muslos, asociadas a debilidad, mayor en la cintura pélvica y astenia. En el último tiempo refiere dificultades para ponerse de pie, desde una silla o desde la cama. Al examen físico se objetiva debilidad muscular de predominio proximal, sin alteraciones sensitivas. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma con hemoglobina: 12,1 g/dl, hematocrito: 37%, blancos: 7.000 por mm³, plaquetas: 250.000 por mm³, VHS: 10 mm/hora. Además, trae glicemia: 150 mg/dl, creatinfosfoquinasa: 1.760 UI/L, LDH: 1.050 UI/L, PCR: 4,3 mg/L, SGOT: 250 UI/L, SGPT: 170 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Polimiositis
- b) Polimialgia reumática
- c) Polineuropatía diabética
- d) Miopatía por cuerpos de inclusión
- e) Síndrome de Guillain Barré

105) Un paciente de 71 años, con antecedente de diabetes, hipertensión arterial y lumbago crónico, en tratamiento con hipoglicemiantes orales, atorvastatina y losartán, presenta un cuadro de 1 mes de debilidad de las 4 extremidades, mayor en los muslos, asociadas a mialgias, que en el último tiempo le han dificultado la marcha. Al examen físico se constata paresia M4 de ambas extremidades inferiores, mayor en los cuádriceps, sin alteraciones sensitivas ni focalidad neurológica. Se solicitan exámenes que muestran hemoglobina: 12,1 g/dl, hematocrito: 33%, blancos: 6.200 por mm³, plaquetas: 180.000 por mm³, VHS: 50 mm/hora, SGOT: 210 UI/L, SGPT: 110 UI/L, CPK: 3.760 UI/L, LDH: 1.050 UI/L, PCR: 4,3 mg/L y hemoglobina glicosilada: 7,5%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Miopatía por estatinas
- b) Polimialgia reumática
- c) Polimiositis
- d) Miositis por cuerpos de inclusión
- e) Raquiestenosis medular

106) Un niño de 4 años, con antecedente de ictericia neonatal, que requirió fototerapia, es traído a la urgencia por dolor abdominal y náuseas de 4 días de evolución. Al examen físico destaca ictericia de piel y mucosas, asociado a palidez y en el examen abdominal se objetiva esplenomegalia, con bazo por 3 cm bajo el reborde costal. Su hemograma muestra hematocrito de 20%, hemoglobina de 6,9 g/dl, VCM: 70 fl, 17% de reticulocitos, blancos: 8.000 por mm³ y plaquetas: 200.000 por mm³. El frotis sanguíneo muestra macrocitosis, poiquilocitosis y anisocitosis. En sus pruebas hepáticas destaca bilirrubina 6 mg/dl, con bilirrubina directa de 0,9 mg/dl. El diagnóstico más probable:

- a) Anemia hemolítica
- b) Leucemia aguda
- c) Anemia ferropénica
- d) Anemia por déficit de vitamina B12
- e) Anemia de Fanconi

107) Un paciente de 28 años presenta un cuadro de cefalea, parestesias, asociado a malestar general e ictericia, que inició hace 48 horas y que ha evolucionado con deterioro del estado general y desorientación. Al examen físico tiene ictericia de piel y escleras, PA: 160/100 mmHg, presencia de múltiples petequias y algunas equimosis en las extremidades inferiores, con edema bimalleolar. Se solicitan exámenes, entre los que destacan bilirrubina total: 12 mg/dl, LDH: 2.100 UI/L, creatinina: 3,5 mg/dl, hemoglobina: 10 g/dl, hematocrito: 29%, plaquetas: 70.000/mm³, blancos: 8.000/mm³, frotis con esquistocitos, poiquilocitos y anisocitosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Púrpura trombocitopénica inmune
- b) Síndrome de Evans
- c) Anemia hemolítica autoinmune
- d) Púrpura trombocitopénico trombótico
- e) Lupus eritematoso sistémico

108) Un paciente de 65 años, diabético, presenta un cuadro de astenia y sensación febril de 4 semanas de evolución, asociado a baja de peso de 3 kilogramos, no explicado. Además, refiere dolor abdominal epigástrico y en el hipocondrio izquierdo. Al examen físico tiene ligera palidez de mucosas y se palpa el bazo por 13 cm bajo el reborde costal. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 32%, hemoglobina: 10,6 g/dl, VCM: 90 fl, blancos: 65.000 por mm³, con 15% de juveniles, 20% mielocitos, 13% promielocitos y 5% de blastos, con plaquetas: 450.000 por mm³. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia mieloide aguda
- b) Leucemia linfática crónica
- c) Leucemia mieloide crónica
- d) Mielodisplasia
- e) Mielofibrosis

109) Un niño de 7 años presenta orinas oscuras, desde hace 5 días, sin otros síntomas. Al examen físico se palpa una masa abdominal en el flanco derecho de 10 cm de diámetro. Se solicitan exámenes entre los que destacan bilirrubina: 1,0 mg/dl, creatinina: 1,1 mg/dl, sedimento de orina con 30-40 glóbulos rojos por campo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Riñón poliquístico
- b) Neuroblastoma
- c) Hapatoblastoma
- d) Tumor de Wilms
- e) Linfoma

110) Un paciente de 25 años presenta un cuadro de 3 semanas de dolor abdominal tipo cólico y diarrea acuosa, que en ocasiones es sanguinolenta. Además, ha presentado úlceras orales recidivantes y ha bajado de peso. Al examen físico tiene abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación profunda y sin signos de irritación peritoneal y con ruidos hidroaéreos conservados. Hace 4 semanas se realizó manejo quirúrgico de una fístula anorrectal. El diagnóstico más probable es:

- a) Colitis parasitaria
- b) Enfermedad de Cröhn
- c) Enfermedad celíaca
- d) Colitis ulcerosa
- e) Colitis pseudomembranosa

111) Una paciente de 23 años, vegetariana estricta, consulta por diarrea de algunos meses de evolución, asociada a baja de peso. Además, trae exámenes, entre los que destaca anemia microcítica e hipoalbuminemia. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Parasitosis intestinal
- b) Enfermedad celíaca
- c) Colitis ulcerosa
- d) Enfermedad de Cröhn
- e) Enteropatía perdedora de proteínas

112) Un paciente de 23 años, con antecedente de relación sexual sin protección, consulta porque hace 3 días notó aparición de una úlcera en el pene, ubicada en el glande, indolora, de 1 cm de diámetro, de aspecto indurado. Además, se palpa una adenopatía inguinal derecha indolora. Se solicita VDRL y FTA-ABS, resultando ambos negativos. El diagnóstico más probable es:

- a) Sífilis primaria
- b) Chancroide
- c) Enfermedad de Behcet
- d) Herpes genital
- e) Linfogranuloma venéreo

113) Una niña de 18 meses de edad presenta un cuadro de diarrea de 3 semanas de evolución, abundante, que ha empeorado en el último tiempo y se ha asociado a náuseas y vómitos alimentarios. Al examen físico está deshidratada y decaída, sin compromiso hemodinámico evidente y su examen abdominal muestra abdomen sensible, con ruidos hidroaéreos conservados. Se solicitan exámenes, que muestran Na⁺: 130 mEq/L, K⁺: 3,4 mEq/L, glicemia: 65 mg/dl, creatinina: 1,2 mg/dl, ferritina: 10 ug/L y hematocrito: 29%, VCM: 70 fl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Diarrea por rotavirus
- b) Crisis celíaca
- c) Hiperplasia suprarrenal congénita
- d) Diarrea crónica inespecífica
- e) Giardiasis intestinal

114) Un niño de 7 años consulta por dolor abdominal y vómitos de 3 días de evolución, con tendencia a la deshidratación. Hace dos meses estuvo hospitalizado por un cuadro similar, para hidratación endovenosa. Al examen físico tiene FC: 110x', PA: 110/70 mmHg, T°: 36,8°C. Se solicitan exámenes, que muestran glicemia: 46 g/dl, sodio: 130 mEq/L, potasio: 5,8 mEq/L, pH: 7,32, bicarbonato: 16 mEq/L. El examen de elección para confirmar el diagnóstico es:

- a) Niveles plasmáticos de cortisol basal
- b) Insulinemia basal
- c) Creatinina plasmática
- d) Amilasemia
- e) Cetonemia

115) Una paciente de 17 años, con antecedente de haber tenido su menarquia a los 16 años, con reglas que ocurren cada 3 a 4 meses. Tiene vello en el mentón, los brazos, el pecho, los muslos y la línea media abdominal, tanto infraumbilical, como supraumbilical, con un índice de Ferriman-Gallwey > 15. Su examen mamario y genital son normales. ¿Cuál es el examen de elección para hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de ovario poliquístico?

- a) Relación FSH/LH
- b) Cariograma
- c) Curva de insulina
- d) Niveles plasmáticos de prolactina
- e) 17-hidroxi-progesterona

116) Una paciente de 40 años, multípara de 3, con el último parto por cesárea hace 1 año, consulta por dolor pélvico, en relación a la menstruación, asociado a flujo más abundante de lo habitual, que ha ido en aumento desde hace algunos meses. Al examen físico y ginecológico, se observan paredes vaginales normales y se palpa útero liso, de tamaño ligeramente aumentado, con anexos normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Miomatosis uterina
- b) Endometriosis
- c) Hiperplasia endometrial
- d) Adenomiosis
- e) Dismenorrea primaria

117) Una paciente de 32 años, nulípara, consulta por atraso menstrual de 7 semanas, por lo que solicita se corrobore si está embarazada. A la especuloscopia se observa moco cervical abundante, transparente y filante. Al tacto vaginal se objetiva útero de tamaño normal con una masa anexial de 7 cm, indolora y móvil. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Embarazo ectópico
- b) Aborto retenido
- c) Quiste folicular
- d) Embarazo molar
- e) Torsión ovárica

118) Un paciente de 85 años, con antecedente de deterioro funcional y cognitivo inicial y diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con metformina 850 mg dos veces al día y glibenclamida 5 mg cada 12 horas, se realiza exámenes de control entre los que destaca una creatinina de 1,0 mg/dL y una hemoglobina glicosilada de 6,9%. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Suspender la glibenclamida
- b) Disminuir la dosis de glibenclamida a 5 mg una vez al día
- c) Suspender metformina
- d) Disminuir dosis de metformina
- e) Mantener el tratamiento sin cambios

119) Un paciente de 60 años, con antecedente de diabetes mellitus 2 insulino dependiente, en tratamiento con insulina NPH 30 U en la mañana y 20 U en la noche, presenta un cuadro de malestar, sudoración y palpitaciones intensas a las 3 de la madrugada, que respondió a la ingesta de azúcar, constatándose un hemoglucotest de 50 mg/dL. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Disminuir la insulina NPH matinal
- b) Modificar los horarios de las insulinas
- c) Disminuir la insulina NPH nocturna
- d) Suspender la insulina NPH nocturna
- e) Disminuir ambas dosis de insulina NPH

120) Un paciente de 26 años consulta por pirosis y regurgitación de varios meses de evolución. Su examen físico no aporta mayor información. Se realiza una endoscopia digestiva alta que muestra mucosa de aspecto normal, línea Z a 28 cm de la arcada dentaria e impresión hiatal diafragmática a 37 cm de la arcada dentaria. El diagnóstico más probable es:

- a) Acalasia esofágica
- b) Hernia hiatal directa
- c) Hernia paraesofágica
- d) Esófago de Barret
- e) Divertículo esofágico

121) Un paciente de 67 años consulta por dolores óseos en múltiples zonas. Se realiza exámenes, entre los que destaca calcemia corregida de 14,4 mg/dl, con pruebas de función renal normales. Además, se solicitan radiografías que muestran imágenes sugerentes de metástasis óseas. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

- a) Calciuria de 24 horas
- b) Niveles plasmáticos de 25-OH vitamina D
- c) Niveles plasmáticos de paratohormona
- d) Cintigrafía ósea
- e) Niveles plasmáticos de calcio iónico

122) Una paciente de 63 años presenta dolor dorsal intenso, que inició hace 5 días, en relación a un esfuerzo en flexión y que ha aumentado, limitando significativamente sus actividades de la vida diaria. Tiene antecedente de una fractura de muñeca hace un año, que requirió tratamiento quirúrgico. Al examen físico se aprecia adolorida, con signos vitales normales, dolor a la movilización activa y pasiva de su columna dorsal, que limita los movimientos de flexo-extensión. A la inspección la curvatura dorsal se observa redonda, sin cifosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hernia del núcleo pulposo
- b) Tuberculosis vertebral
- c) Espondilolistesis dorsal
- d) Espondilosis dorsal
- e) Fractura vertebral

123) Un paciente de 17 años, apendicetomizado hace 6 horas, evoluciona con malestar general y dolor abdominal intenso. Su pulso es regular a 120 latidos por minuto, su presión arterial es 90/50 mmHg y su temperatura es 37,7°C. En el examen abdominal presenta dolor a la palpación profunda y superficial, con signos peritoneales difusos, mayores en el hemiabdomen inferior. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemoperitoneo
- b) Evisceración
- c) Trombosis de la vena porta
- d) Dehiscencia de la base apendicular
- e) Tromboembolismo pulmonar masivo

124) Un paciente de 54 años consulta por dolor abdominal epigástrico intenso, tipo cólico, asociado a náuseas de 6 horas de evolución, por lo que consulta en el servicio de urgencia. Recibe hidratación y analgésicos por vía endovenosa, con respuesta parcial, por lo que es dado de alta. Al día siguiente evoluciona con aumento del dolor, agregándose calofríos y vómitos alimentarios. Al examen físico, tiene FC: 90x', PA: 120/80 mmHg, Tº: 38°C y en el examen abdominal presenta dolor intenso a la palpación del abdomen superior, en especial en el hipocondrio derecho. Sus exámenes muestran hematocrito: 43%, blancos: 13.000 por mm³, GOT: 56 UI/L, bilirrubina: 1,1 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

- a) TAC de abdomen
- b) Endoscopia digestiva alta
- c) Colangiografía
- d) Ecografía abdominal
- e) Radiografía de abdomen simple

125) Una paciente de 40 años, IMC: 30, presenta episodios de dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho, desde hace 3 meses, que cede espontáneamente luego de algunos minutos. Se realiza una ecografía, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia):



El diagnóstico más probable es:

- a) Colelitiasis
- b) Coledocolitiasis
- c) Colecistitis crónica
- d) Cáncer de vesícula
- e) Colecistitis aguda

126) Un paciente de 54 años ha presentado varios episodios de cólico renal, con eliminación reiterada de cálculos urinarios. Su examen físico no tiene alteraciones. En sus exámenes destaca creatinina: 1,4 mg/dl y examen de orina con pH: 7,9, glóbulos rojos: 15 x campo, glóbulos blancos: 15 por campo, bacterias en moderada cantidad y cristales de fosfato amónico magnésico (estruvita). El pieloTAC muestra presencia de cálculos coraliformes bilaterales. ¿Qué germen es el agente etiológico, con mayor probabilidad?

- a) Proteus mirabilis
- b) Klebsiella oxytoca
- c) Pseudomonas aeruginosa
- d) Campilobacter jejuni
- e) Escherichia coli

127) ¿Qué institución del sistema de salud chileno es la encargada de cursar las autorizaciones sanitarias para el funcionamiento de los establecimientos de salud?

- a) Instituto de Salud Pública
- b) Secretaría Regional Ministerial de Salud
- c) Superintendencia de Seguridad Social
- d) Superintendencia de Salud
- e) Servicio de Salud

128) ¿Cómo se financia el Plan de Salud Familiar, ofrecido por el sistema de atención primaria de salud de Chile?

- a) Transferencias por prestaciones otorgadas
- b) Aportes de fondos municipales
- c) Transferencias por plan de salud
- d) Aporte per cápita, en razón del número de inscritos
- e) Copago de los usuarios

129) Un paciente de 35 años refiere sensación de angustia e inquietud, de un mes de evolución, asociado a insomnio de conciliación y cefalea diaria, de localización occipital, que se irradia hacia los hombros. Refiere que los síntomas iniciaron en relación a la necesidad de cambiarse de casa, ya que fue asignado a nuevo cargo en su trabajo, en una ciudad distinta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno por somatización
- b) Depresión mayor
- c) Trastorno conversivo
- d) Trastorno adaptativo
- e) Trastorno disociativo

130) Una paciente de 50 años presenta un cuadro de 5 meses de evolución de dificultades para concentrarse, asociadas a desgano, ánimo bajo y tristeza, síntomas que se acentúan en el periodo premenstrual. Sale muy poco de su casa y ha disminuido la interacción con otras personas, comentando que disfruta poco o nada con las actividades que habitualmente le eran placenteras. Refiere que duerme cerca de 2 horas menos que antes y que ha subido una talla de ropa. Sus exámenes generales descartan patología orgánica. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno adaptativo
- b) Episodio depresivo mayor
- c) Trastorno de angustia generalizada
- d) Trastorno de ansiedad social
- e) Trastorno disfórico premenstrual

131) Una paciente de 75 años, con historia de enfermedad de Alzheimer de 3 años de evolución, con buena funcionalidad presenta un cuadro en que agrede a otras personas y se muestra muy angustiada. Al examen físico le cuesta nombrar algunos objetos, no puede decir los días de la semana de manera invertida y se muestra poco atenta. Además, refiere que su padre ya fallecido está presente en la sala. Se hospitaliza para estudio y manejo y, al inicio, se muestra cooperadora y amable, pero luego exige que la dejen ir e intenta escapar del hospital y agredir al personal de salud. ¿Cuál es el fármaco inicial para el manejo de esta paciente?

- a) Clorpromazina
- b) Diazepam
- c) Mirtazapina
- d) Alprazolam
- e) Haloperidol

132) Una mujer de 45 años, hace 6 semanas mientras compraba, presenta un episodio de opresión en el pecho, disnea, vértigo, temor a morir, palpitaciones, disfagia, sensación de lipotimia, visión borrosa y disestesias de las extremidades superiores, asociado a marcada angustia. Desde entonces ha presentado un episodio de similares características cada semana. No tiene otros síntomas y su examen físico es normal, al igual que sus exámenes generales de laboratorio. ¿Cuál es el tratamiento de elección en el largo plazo?

- a) Inhibidores de la monoaminooxidasa
- b) Benzodiacepinas
- c) Antipsicóticos atípicos
- d) Antidepresivos tricíclicos
- e) Inhibidores de la recaptura de serotonina

133) Un paciente de 20 años, fumador y consumidor de alcohol, desde hace un mes presenta consumo diario de alcohol. Decide suspenderlo hace algunos días, sin embargo, evoluciona con intranquilidad, sudoración, palpitaciones y angustia, asociado a insomnio y malestar general, que han ido empeorando. Sus padres refieren que está muy asustado y que ha fumado marihuana en los últimos dos días, para disminuir su ansiedad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Delirium tremens
- b) Síndrome de abstinencia de alcohol
- c) Síndrome de abstinencia de marihuana
- d) Esquizofrenia
- e) Intoxicación por cannabis

134) 122) Un paciente de 69 años, con antecedente de diabetes, hipertensión e insuficiencia cardíaca, en tratamiento con aspirina, losartán, amlodipino, furosemida y metformina, consulta por sensación de molestias en las extremidades inferiores, las que describe como pesadas e hinchadas. Se aprecia en buenas condiciones generales, no tiene otros síntomas, sus presiones arteriales están dentro de rangos normales, al igual que su hemoglobina glicosilada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Suspender el amlodipino
- b) Aumentar la dosis de furosemida
- c) Disminuir la dosis de metformina
- d) Suspender el losartán
- e) Aumentar la dosis de aspirina

135) Un paciente de 71 años, con antecedente de hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia cardíaca, en tratamiento con losartán, metformina, aspirina, nifedipino e hidroclorotiazida consulta por progresión de su disnea de esfuerzos, que aparece al caminar 1 cuadra. Al examen físico, tiene edema de extremidades inferiores, se palpa el choque de la punta en la línea axilar media y se ausculta ritmo cardíaco regular, sin soplos, con crépitos bilaterales en la auscultación pulmonar. Se realiza ecocardiografía que muestra disfunción ventricular, con fracción de eyección de 23%. ¿Qué fármaco debe suspenderse?

- a) Losartán
- b) Metformina
- c) Aspirina
- d) Nifedipino
- e) Hidroclorotiazida

136) Un paciente de 38 años, diagnosticado de hipertensión arterial, está en tratamiento con enalapril 20 mg c/12 horas, hidroclorotiazida 25 mg/d y amlodipino 10 mg/día. Se realiza control con monitoreo de 24 horas de presión arterial que muestra presiones arteriales diurnas promedio de 152/100 mmHg, con sobrecarga tensional de 60% sistólica y 43% diastólica y presiones arteriales nocturnas de 140/92 mmHg, con sobrecarga tensional de 25% sistólica y 27% diastólica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Aumentar la dosis de hidroclorotiazida
- b) Aumentar la dosis de enalapril
- c) Iniciar inhibidor del receptor de aldosterona y descartar hipertensión secundaria
- d) Reemplazar el enalapril por losartán
- e) Reemplazar la hidroclorotiazida por un inhibidor del receptor de aldosterona

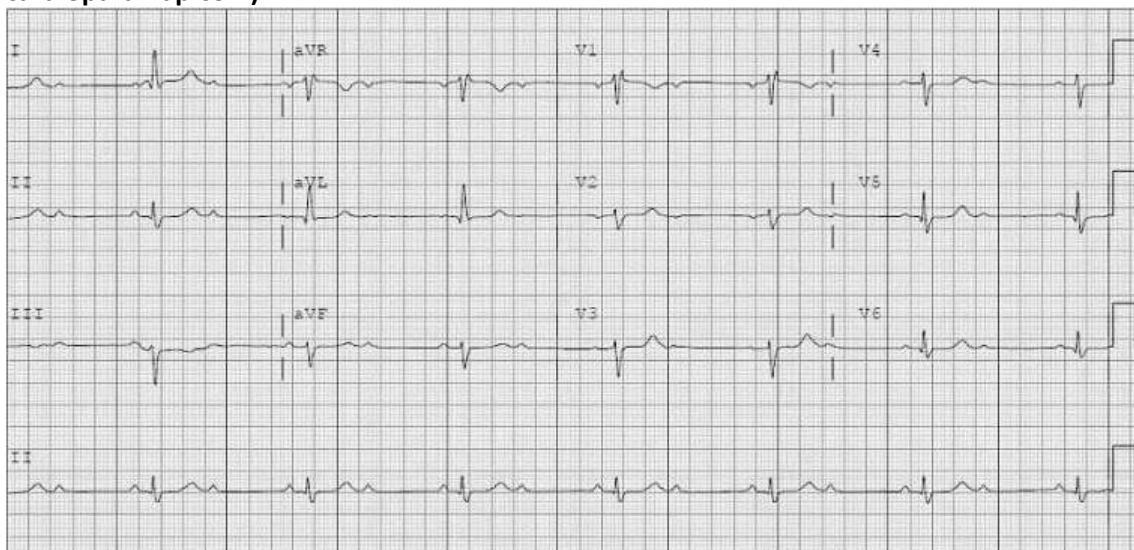
137) Un paciente de 71 años, con antecedente de reemplazo valvular tricuspídeo, secundario a una endocarditis bacteriana, con prótesis biológica in situ consulta por palpitaciones muy intensas, asociadas a disnea. Al examen físico tiene un pulso a 140 latidos por minutos, regular. Se realizan maniobras vagales (masaje carotídeo) y se observa el siguiente electrocardiograma (fuente: slideshare):



El diagnóstico más probable es:

- a) Taquicardia paroxística supraventricular
- b) Fibrilación auricular
- c) Flutter auricular
- d) Síndrome de Wolff Parkinson White
- e) Taquicardia auricular

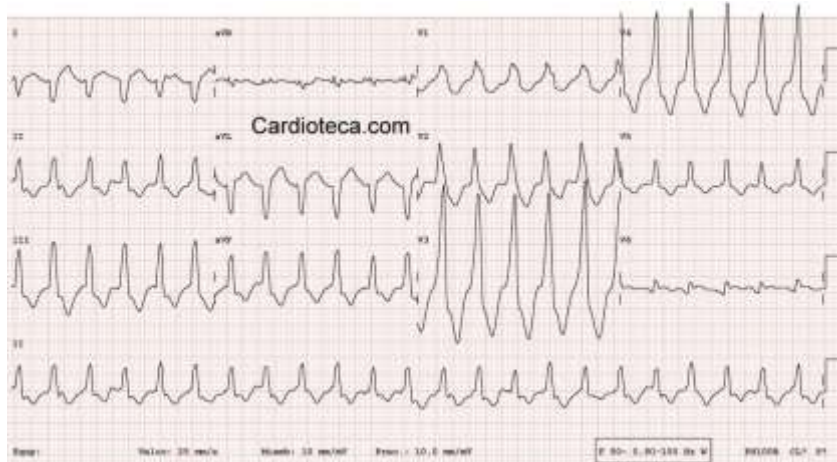
138) Un paciente de 70 años presenta astenia, intolerancia al ejercicio y disnea de 3 meses de evolución. Además, presenta lipotimias luego de levantarse de la cama. Al examen físico tiene FC: 45 x', regular. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: cardioparamap.com):



El diagnóstico más probable es:

- a) Bloqueo aurículo-ventricular de primer grado
- b) Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, Mobitz I
- c) Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, Mobitz II
- d) Bloqueo aurículo-ventricular completo
- e) Enfermedad del nodo sinusal

139) Un paciente de 64 años, con antecedente de un infarto al miocardio de pared anterior, hace 1 año, consulta por dolor torácico y disnea de reposo de 40 minutos de duración, asociado a palpitaciones. Al examen físico presenta FC: 200x' y se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: cardioteca.com):



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Taquicardia paroxística supraventricular
- b) Flutter auricular
- c) Síndrome de Wolff Parkinson White
- d) Taquicardia ventricular
- e) Fibrilación auricular

140) Un paciente de 56 años, hipertenso, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida presenta irregularidad en sus presiones arteriales, por lo que se decide reemplazar el diurético por clortalidona, con buena respuesta. Se solicitan exámenes de control, entre los que destacan creatinina: 1,0 mg/dl, potasemia: 3,3 mEq/L y natremia: 140 mEq/L. La conducta más adecuada es:

- a) Reemplazar el enalapril por losartán
- b) Disminuir cloruro de sodio
- c) Reemplazar la clortalidona por furosemida
- d) Administrar suero fisiológico
- e) Disminuir la dosis de enalapril

141) Una paciente de 29 años, primigesta, cursando un embarazo de 26 semanas, con feto creciendo bajo el percentil 10 para la edad gestacional, se realiza una ecografía-doppler para evaluar el bienestar fetal. ¿Qué alteración obligaría a interrumpir el embarazo de inmediato?

- a) Aumento del índice cerebroplacentario
- b) Aumento de resistencia de las arterias uterinas
- c) Ducto venoso reverso en diástole
- d) Flujo umbilical ausente en diástole
- e) Alteración del índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media

142) Una paciente de 26 años, multipara de 1, con parto anterior por cesárea, está cursando un nuevo embarazo de 33 semanas, acude a control obstétrico, asintomática y presenta presiones arteriales de 140/90, que no descienden luego de 6 horas de reposo. Además, presenta edema de extremidades inferiores. Se solicita un registro basal no estresante, por 20 minutos, el que se informa como no reactivo. Por ello, se solicita un perfil biofísico que visualiza movimientos respiratorios normales y postura adecuada, con un único bolsillo de líquido amniótico, menor a 1 x 1 cm. Se repite el registro basal no estresante, que vuelve a resultar no reactivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar cesárea en este momento
- b) Repetir el perfil biofísico en 7 días
- c) Realizar test de tolerancia a las contracciones
- d) Dejar a evolución espontánea
- e) Inducir el parto con misoprostol

1413) Una paciente de 32 años, cursando embarazo gemelar bicorial y biamniótico de 31 semanas se realiza control con ecografía-doppler, que muestra discordancia de crecimiento de 28%, perfil biofísico tranquilizador y doppler con aumento de la resistencia umbilical y flujo presente en diástole. Ambos fetos se encuentran en posición cefálica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar cesárea ahora
- b) Inducir el parto ahora
- c) Realizar control seriado con doppler fetal
- d) Administrar corticoides antenatales
- e) Repetir el perfil biofísico

144) Un paciente de 63 años, con antecedente de hipertensión y dislipidemia, en tratamiento con losartán, hidroclorotiazida y atorvastatina consulta en el servicio de urgencia por dolor torácico intenso, EVA 9/10, irradiado al dorso. Al examen físico está diaforético y angustiado, con FC: 115x', PA: 220/117 mmHg, examen pulmonar con crépitos escasos bibasales y examen cardíaco con choque de la punta no desplazado y auscultación con ritmo regular, en dos tiempos con ruidos apagados. Se solicita un electrocardiograma que muestra taquicardia sinusal y troponinas plasmáticas, que resultan negativas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Neumotórax
- b) Infarto agudo al miocardio
- c) Taponamiento pericárdico
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Disección aórtica

145) Un paciente de 67 años, usuario de sildenafil, que se automedica como tratamiento de impotencia sexual, presenta dolor torácico intenso, que inició una hora después de haber consumido dicho medicamento. Se solicita un electrocardiograma, que muestra supradesnivel del segmento ST en las derivaciones inferiores. ¿Qué fármaco está contraindicado en el manejo de este paciente?

- a) Clopidogrel
- b) Aspirina
- c) Atenolol
- d) Nitroglicerina
- e) Estreptoquinasa

146) Una paciente de 38 años consulta porque lleva dos años intentando embarazarse, junto a su pareja. Sus reglas son regulares, su examen físico es normal y cuentan con múltiples exámenes hormonales que dan cuenta que tiene ciclos ovulatorios. Su pareja, de 28 años se realizó un espermiograma, que resultó normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

- a) Histeroscopia
- b) Laparoscopia
- c) Histerosalpingografía
- d) Niveles plasmáticos de hormona anti-mülleriana
- e) Seguimiento folicular ecográfico

1417) Un paciente de 67 años, diabético e hipertenso, presenta un cuadro de 2 meses de evolución de tos persistente, con expectoración mucosa, que en ocasiones es hemoptoica, asociado a disnea de esfuerzos. Además, ha bajado de peso 4 kilogramos y presenta dolor torácico, con tope inspiratorio. Al examen físico FC: 110 x', PA: 100/60 mmHg, ritmo regular en dos tiempos, con ruidos cardíacos apagados, asimetría del murmullo pulmonar y crépitos escasos bilaterales, mayores a izquierda. En sus exámenes de laboratorio destaca hematocrito: 30%, hemoglobina: 9,9 g/dl, blancos: 10.000 por mm³, dímero D: 649 ng/ml (valor normal: menor a 100), LDH: 760 UI/L. Se realiza radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: researchgate.net):



¿Cuál la conducta diagnóstica más adecuada a seguir?

- a) Broncoscopia
- b) TAC de tórax
- c) Videotoracoscopia
- d) Baciloscopías de expectoración
- e) AngioTAC de tórax

148) Un paciente de 72 años es hospitalizado por fractura de cadera, manejada con cirugía de prótesis parcial. Al quinto día presenta pérdida de conciencia, luego de ponerse de pie, con recuperación completa algunos minutos después. Luego de ello presenta lipotimias y episodios similares al incorporarse desde la cama. Al examen físico está con FC: 120x', presión arterial: 100/50 mmHg, extremidades inferiores frías y con cianosis distal y ritmo cardíaco regular, sin soplos y murmullo pulmonar presente. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?

- a) TAC de cerebro
- b) Ecocardiograma
- c) RMN de cerebro
- d) Electrocardiograma
- e) AngioTAC de tórax

149) Un paciente de 35 años, en situación de calle, presenta un cuadro de 6 meses de evolución de tos con expectoración mucosa y mucopurulenta, en ocasiones hemoptoica, asociada a malestar general, disnea de esfuerzos, baja de peso y sensación febril. Al examen físico, está enflaquecido, pálido, con T°: 37,5°C, FC: 87x', PA: 110/70 mmHg, FR: 18x'. Su examen pulmonar muestra crépitos bilaterales y algunas sibilancias. Su hemograma muestra hematocrito: 32%, hemoglobina: 10,6 g/dl, leucocitos: 15.600 por mm³, VHS: 60 mm/h, PCR: 120 mg/L y elisa VIH negativo, PCR covid-19 negativa, baciloscopías de expectoración negativas, con muestra hemorrágica y PPD: 20mm. Se realiza una radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente radiopaedia):



¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar TAC de tórax
- b) Solicitar cultivo para bacillus tuberculosis en medio sólido
- c) Solicitar reacción en cadena de polimerasa para tuberculosis en expectoración
- d) Repetir la PCR de covid-19 en muestra nasofaríngea
- e) Realizar fibrobroncoscopia con lavado bronquioalveolar

150) Un lactante de 12 meses ha presentado un exantema eritematoso generalizado, en las dos ocasiones en que se ha introducido huevo a su dieta. No tiene otros antecedentes. ¿Qué conducta es la más adecuada, respecto a la vacuna trivírica?

- a) Administrarla en este momento
- b) Eliminarla de su esquema de vacunación
- c) Administrarla a los 18 meses
- d) Esperar a los 4 años para administrarla
- e) Esperar a que esté en primero básico para administrarla

151) Un niño de 2 meses, con antecedente de haber nacido a las 34 semanas de gestación, acude a control. ¿En qué momento debe administrarse la vacuna antineumocócica conjugada?

- a) En este momento
- b) En 4 semanas más
- c) En 6 semanas más
- d) A los 12 meses de edad
- e) No debe administrarse

152) Un paciente de 42 años consulta por tos de un mes de evolución, sin expectoración. Su esposa está en tratamiento antituberculoso. Su examen físico muestra crépitos escasos bilaterales. Se realizaron baciloscopías de expectoración, que resultan negativas; quantiferón para tuberculosis, que resulta positivo; y radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia):



La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar profilaxis antituberculosa
- b) Solicitar reacción de cadena de polimerasa para tuberculosis en expectoración
- c) Iniciar tratamiento antibiótico antituberculoso
- d) Solicitar cultivo de Koch
- e) Solicitar PPD

153) Un adolescente de 17 años presenta un cuadro de 5 días de evolución de tos con expectoración mucosa, al que se le ha agregado fiebre hasta 37,6°C. Al examen físico está en buenas condiciones, con FR: 15x', saturación oxígeno: 95% y examen pulmonar con murmullo pulmonar presente, auscultándose crepitaciones y sibilancias bilaterales. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Streptococcus pneumoniae
- b) Mycoplasma pneumoniae
- c) Chlamydia trachomatis
- d) Virus influenza
- e) Pneumocystis jiroveci

154) Una niña de 4 años presenta sinequia vulvar que une gran parte de los labios menores, por lo que impide ver el introito y el himen. No tiene desarrollo puberal, ni antecedentes de infecciones urinarias, ni genitales. El resto de su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar lavados con ácido acético
- b) Aplicar corticoides tópicos
- c) Remover las sinequias de manera quirúrgica
- d) Realizar separación manual bajo anestesia local
- e) Indicar lubricación diaria con vaselina

155) Una paciente de 67 años, con antecedente de artritis reumatoide, en tratamiento con metotrexato y prednisona, consulta por dificultades para ver. Tiene historia de cirugía de cataratas hace dos años. Al examen oftalmológico se constata agudeza visual 20/25 a derecha y 20/30 a izquierda y, en la campimetría visual, se observa afectación de la zona medial del campo visual derecho y de la zona superior del campo visual izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Desprendimiento de retina
- b) Lesión del quiasma óptico
- c) Glaucoma crónico
- d) Neuritis óptica
- e) Degeneración macular relacionada con la edad

156) Un paciente de 65 años, con antecedente de revascularización miocárdica hace un año y cirugía de cataratas, consulta porque hace algunas horas dejó de ver su pie derecho. No ha presentado otros síntomas. Al examen físico se aprecia oculomotilidad normal, inspección normal y defecto pupilar aferente relativo en el ojo derecho. La campimetría muestra pérdida del campo visual inferior del ojo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Neuritis óptica
- b) Degeneración macular relacionada con la edad
- c) Accidente vascular encefálico occipital
- d) Edema macular
- e) Neuropatía óptica isquémica

157) Una paciente de 56 años, diabética de larga data, mal controlada, con nefropatía diabética en etapa IV, presenta pérdida súbita e indolora de la visión del ojo izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Glaucoma
- b) Edema macular
- c) Uveítis
- d) Trombosis de la vena central de la retina
- e) Hemorragia vítrea

158) Un paciente de 58 años presenta disnea de medianos esfuerzos y astenia. Al examen físico tiene FC: 70 lpm, PA: 120/80 mmHg, examen cardíaco con choque de la punta en el quinto espacio intercostal, línea medioclavicular y auscultación con un soplo diastólico. Al examen pulmonar se constata murmullo pulmonar presente, con crepitaciones basales escasas. Su electrocardiograma muestra fibrilación auricular, con respuesta ventricular de 70 latidos por minuto. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Insuficiencia aórtica
- c) Estenosis tricuspídea
- d) Estenosis mitral
- e) Comunicación interventricular

159) Un paciente de 67 años, con antecedente de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en tratamiento con broncodilatadores inhalados, evoluciona con aumento importante de su disnea basal, asociado a cianosis y angustia. El paciente está vigil y orientado y en su examen físico tiene FR: 35x', PA: 110/76 mmHg, FC: 110x' y al examen pulmonar se aprecia uso de musculatura accesoria, cianosis, aumento del diámetro anteroposterior y sibilancias y roncus intensos bilaterales. Su radiografía de tórax se muestra más abajo (fuente: radiopaedia). Se ingresa al servicio de urgencia, recibiendo antibióticos y nebulizaciones con broncodilatadores por una hora, sin mejoría clínica. Se solicitan gases arteriales, que resultan PaCO₂: 62 mmHg, PaO₂: 56 mmHg, pH: 7,29 y HCO₃: 27 mEq/L.



La conducta más adecuada, a continuación, es:

- a) Ventilación mecánica invasiva
- b) Aminofilina endovenosa
- c) Oxígeno por cánula nasal de alto flujo
- d) Ventilación no invasiva
- e) Bicarbonato de sodio endovenoso

160) Un paciente de 55 años presenta cambio del hábito intestinal, caracterizado por diarrea acuosa, de 3 meses de evolución, asociada a dolor abdominal ocasional. Además, ha bajado 4 kilogramos de peso, desde el inicio de los síntomas. Se realizan exámenes de sangre, entre los que destacan hematocrito: 30%, Hemoglobina: 9,7 g/dl y VCM: 69 fl, albúmina: 2,8 g/dl y GOT: 40 UI/L. Tiene antecedente de un hijo con enfermedad celíaca. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio en esta paciente?

- a) Prueba terapéutica con dieta sin gluten
- b) Ecografía abdominal
- c) Colonoscopia
- d) Detección de anticuerpos antitransglutaminasa en sangre
- e) Test de sangre oculta en deposiciones

161) Un paciente de 52 años, con una gran cicatriz de una quemadura antigua, de gran tamaño, en el muslo derecho, que cicatrizó por segunda intención, refiere que, desde hace dos años, presenta una úlcera en relación a la cicatriz. Al examen físico se observa una úlcera de 2 cm en medio de la cicatriz. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Tratamiento con nitrógeno líquido
- b) Aseo quirúrgico
- c) Resección amplia
- d) Biopsia incisional
- e) Curaciones con povidona y suero fisiológico

162) Un paciente de 78 años, postrado, presenta una lesión en la zona sacra, de 12 cm de diámetro, que afecta la piel y dermis y que en una zona deja entrever el músculo. Tiene necrosis en el borde y mal olor. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a) Antibióticos tópicos
- b) Debridamiento químico
- c) Curaciones con suero fisiológico
- d) Colgajo
- e) Cámara hiperbárica

163) Una paciente de 22 años es hospitalizada por un cuadro de diarrea, vómitos y dolor abdominal de difícil manejo. Durante la hospitalización es sorprendida ingiriendo laxantes, autoinduciéndose vómitos y adulterando la temperatura del termómetro. Se solicitan exámenes, descartándose patología orgánica. Además, luego de indagar, no se encuentra ninguna ganancia evidente con estos síntomas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno conversivo
- b) Trastorno facticio
- c) Trastorno delirante
- d) Trastorno bipolar
- e) Trastorno de la conducta alimentaria

164) Una paciente de 23 años, usuaria de anticonceptivos orales, desde hace 8 meses, consulta por cefalea intensa premenstrual, de 3 meses de evolución, y que dura hasta el segundo día de la menstruación. Su examen físico y neurológico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Anticonceptivos combinados orales de ciclo extendido
- b) Anticonceptivos combinados con menor dosis de estrógeno
- c) Anticonceptivos combinados con menor dosis de progestágeno
- d) Indicar anticonceptivos orales de progestágeno solo
- e) Indicar anticonceptivos combinados inyectables

165) ¿Qué antecedente es indicación del uso de estrógenos orales solos, en la terapia de reemplazo hormonal?

- a) Cáncer de mama
- b) Dislipidemia
- c) Histerectomía total
- d) Osteoporosis
- e) Menopausia precoz

166) Una mujer de 53 años, con antecedente de reglas irregulares, está en amenorrea desde hace 9 meses. Su examen ginecológico es normal y cuenta con mamografía y Papanicolaou recientes, sin alteraciones. Se realiza una ecografía transvaginal que muestra endometrio fino y miometrio con múltiples nódulos hipoecogénicos subserosos y transmurales de entre 2 y 4 cm de diámetro. La indicación más adecuada es:

- a) Histerectomía total
- b) Tumorectomía
- c) Análogos de GnRH
- d) Anticonceptivos orales
- e) Observar evolución

167) Una paciente de 25 años presenta dolor epigástrico intenso, asociado a vómitos, de 2 días de evolución, que inició luego de comer ceviche. Al examen físico tiene signos vitales normales y su examen abdominal muestra dolor a la palpación epigástrica. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Ascaris lumbricoides
- b) Entamoeba histolytica
- c) Anisakis simplex
- d) Fasciola hepatica
- e) Enterobius vermicularis

168) Una adolescente de 14 años presenta cefalea de una semana de evolución. Es traído al servicio de urgencia, tras presentar una convulsión tónico-clónica de 10 minutos de duración, luego de lo que quedó con confusión postictal. Su examen físico no tiene signos focales y al fondo de ojo, se observa una lesión blanquecina, redonda e hiperreflectante en la retina derecha, de 3 mm de diámetro. Se solicita una tomografía axial computada de cerebro, que muestra dos lesiones quísticas de 1 y 3 cm, ubicadas en la zona frontotemporal. Se realiza una punción lumbar, que muestra líquido claro, con proteínas 60 mg/dl, 70 células por mm³, con 80% de mononucleares y presencia de abundantes eosinófilos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Quiste aracnoidal
- b) Hidatidosis cerebral
- c) Encefalitis por virus herpes simplex
- d) Encefalitis por virus varicela zóster
- e) Neurocisticercosis

169) Una paciente de 43 años, multípara, presenta dolor abdominal difuso, intenso y vómitos, con marcado meteorismo. Al examen, tiene FC: 110x', PA: 100/60 mmHg y al examen abdominal se observa cicatriz de cesárea Pfannestiel, y se palpa abdomen muy doloroso tanto a la palpación superficial como profunda, con distensión de la pared abdominal, pérdida de la matidez hepática a la percusión y abolición de los ruidos hidroaéreos a la auscultación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Obstrucción intestinal
- b) Pancreatitis aguda
- c) Perforación intestinal
- d) Megacolon
- e) Embolia mesentérica

170) Un niño de 9 años presenta otalgia de dos días de evolución, con secreción por el conducto auditivo, sin mal olor. Al examen físico se aprecia dolor a la tracción del pabellón auricular, con conducto auditivo estrecho, que dificulta la otoscopia, siendo imposible visualizar el tímpano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Otitis externa
- b) Tapón de cerumen
- c) Otitis media crónica
- d) Cuerpo extraño ótico
- e) Otitis media aguda perforada

171) Un paciente de 72 años consulta por dificultades en la lectura, que han empeorado en el último mes, a pesar de que realizó un cambio de lentes hace 6 meses. No presenta otros síntomas, tiene agudeza visual 20/80 en el ojo derecho y 20/40 en el ojo izquierdo y refiere que ve algunos objetos deformados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Degeneración macular relacionada con la edad
- b) Glaucoma crónico
- c) Cataratas
- d) Desprendimiento de retina
- e) Edema macular

172) Un paciente de 53 años, diabético mal controlado, presenta una lesión en la pierna derecha, desde hace 2 días, que se ha extendido hasta alcanzar un gran tamaño y se ha asociado a malestar general y fiebre. Al examen físico tiene T°: 39,0°C, FC: 115x', PA: 90/60 mmHg. Además, se aprecia la lesión eritematosa de 20 cm, con zonas violáceas y bulas en su superficie. El diagnóstico más probable es:

- a) Erisipela
- b) Herpes zóster
- c) Pioderma gangrenoso
- d) Fasceítis necrotizante
- e) Celulitis bacteriana

173) Un paciente consulta en el servicio de urgencia, dado que hace 20 minutos le saltó una solución de soda cáustica en la cara, la que entró a los ojos, presentando intenso dolor y dificultades para ver. Al examen físico tiene ojo rojo profundo, córneas opacas y con el ojo derecho solo es capaz de contar dedos, mientras que con el ojo izquierdo tiene agudeza visual 20/80. La conducta más adecuada es:

- a) Ungüento antibiótico y parche ocular
- b) Lavado con suero fisiológico abundante por 30 minutos
- c) Hielo local
- d) Corticoides tópicos
- e) Analgésicos

174) Una paciente de 40 años se realiza una mamografía, que muestra una imagen circular, con calcificaciones gruesas y redondeadas, agrupadas, catalogadas como mamografía Birrads 3. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar biopsia por punción con aguja gruesa
- b) Solicitar nueva mamografía en un año
- c) Solicitar nueva mamografía en 6 meses
- d) Solicitar ecografía mamaria
- e) Realizar biopsia por punción, guiada por rayos X

175) Un niño de 48 horas de vida, con antecedente de Síndrome de Down, presenta vómitos alimentarios explosivos, asociados a irritabilidad y decaimiento. Al examen abdominal se palpa abdomen blando, doloroso, con distensión epigástrica, que desaparece después de vomitar. El diagnóstico más probable es:

- a) Atresia esofágica
- b) Hiperplasia suprarrenal congénita
- c) Enterocolitis necrotizante
- d) Atresia duodenal
- e) Estenosis hipertrófica del píloro

176) Una paciente de 34 años, puérpera hace 15 días, dando lactancia materna, presenta dolor en la mama derecha, de 3 días de evolución, que ha aumentado y se ha acompañado de eritema y malestar general. Al examen físico tiene FC: 78x', PA: 120/82 mmHg, Tº: 38,0°C y se observa mama derecha dolor a la palpación de los cuadrantes superiores, los que se palpan indurados y con aumento de la temperatura local, asociado a eritema de la piel de dicha zona. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar drenaje mamario quirúrgico
- b) Suspender la lactancia materna
- c) Iniciar antibióticos
- d) Indicar analgésicos
- e) Aplicar frío local y luego calor local, alternadamente

177) Un paciente de 23 años consulta por aparición de lesiones dolorosas y pruriginosas en los pies, que aparecieron hace un mes y han aumentado. Al examen físico, se aprecia lo siguiente (fuente: podología priego):



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tiña pedis
- b) Verrugas plantares
- c) Granuloma piógeno
- d) Queratosis seborreica
- e) Molusco contagioso

178) Una paciente de 42 años, hipertensa, presenta cefalea intensa, que inició súbitamente hace 6 horas, mientras realizaba ejercicio y se ha acompañado de vómitos alimentarios. Al examen físico está vigil y orientada, adolorida, con FC: 70x', PA: 140/90 mmHg, en el examen neurológico tiene signos meníngeos presentes, sin alteraciones motoras ni sensitivas. Se solicita TAC de cerebro sin contraste, que muestra hiperdensidad del espacio intercomisural frontal y del espacio subaracnoideo basal. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

- a) Resonancia magnética nuclear de cerebro
- b) Punción lumbar
- c) TAC de cerebro con contraste
- d) Angiografía cerebral
- e) Ecocardiograma

179) Una paciente de 21 años, primigesta, cursando embarazo de 24 semanas, se realiza control ecográfico que muestra feto creciendo en percentil 50 para la edad gestacional, con pruebas de bienestar fetales normales. Cuello uterino de 20 mm de longitud. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar cerclaje cervical
- b) Realizar test de tolerancia a las contracciones
- c) Realizar amniocentesis
- d) Iniciar progesterona
- e) Mantener controles habituales del embarazo

180) Un paciente de 65 años, hipertenso y diabético, consulta por disnea y dolor de precordial, que aparece en relación al ejercicio. Es usuario de aspirina, enalapril, metformina, glibenclamida y atorvastatina. Refiere que le es imposible subir más de dos pisos en su edificio o caminar más de dos cuadras sin detenerse, debido al dolor. Su examen físico es normal, al igual que su electrocardiograma. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Derivar a unidad de salud mental
- b) Solicitar test de esfuerzo
- c) Solicitar troponinas
- d) Indicar programa de ejercicios supervisados, con aumento progresivo
- e) Iniciar anticoagulación oral

Nota: pregunta añadida a la reconstrucción.

NOMBRE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

APELLIDO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

APELLIDO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RUT o número P

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

91	A	B	C	D	E	109	A	B	C	D	E	127	A	B	C	D	E	145	A	B	C	D	E	163	A	B	C	D	E
92	A	B	C	D	E	110	A	B	C	D	E	128	A	B	C	D	E	146	A	B	C	D	E	164	A	B	C	D	E
93	A	B	C	D	E	111	A	B	C	D	E	129	A	B	C	D	E	147	A	B	C	D	E	165	A	B	C	D	E
94	A	B	C	D	E	112	A	B	C	D	E	130	A	B	C	D	E	148	A	B	C	D	E	166	A	B	C	D	E
95	A	B	C	D	E	113	A	B	C	D	E	131	A	B	C	D	E	149	A	B	C	D	E	167	A	B	C	D	E
96	A	B	C	D	E	114	A	B	C	D	E	132	A	B	C	D	E	150	A	B	C	D	E	168	A	B	C	D	E
97	A	B	C	D	E	115	A	B	C	D	E	133	A	B	C	D	E	151	A	B	C	D	E	169	A	B	C	D	E
98	A	B	C	D	E	116	A	B	C	D	E	134	A	B	C	D	E	152	A	B	C	D	E	170	A	B	C	D	E
99	A	B	C	D	E	117	A	B	C	D	E	135	A	B	C	D	E	153	A	B	C	D	E	171	A	B	C	D	E
100	A	B	C	D	E	118	A	B	C	D	E	136	A	B	C	D	E	154	A	B	C	D	E	172	A	B	C	D	E
101	A	B	C	D	E	119	A	B	C	D	E	137	A	B	C	D	E	155	A	B	C	D	E	173	A	B	C	D	E
102	A	B	C	D	E	120	A	B	C	D	E	138	A	B	C	D	E	156	A	B	C	D	E	174	A	B	C	D	E
103	A	B	C	D	E	121	A	B	C	D	E	139	A	B	C	D	E	157	A	B	C	D	E	175	A	B	C	D	E
104	A	B	C	D	E	122	A	B	C	D	E	140	A	B	C	D	E	158	A	B	C	D	E	176	A	B	C	D	E
105	A	B	C	D	E	123	A	B	C	D	E	141	A	B	C	D	E	159	A	B	C	D	E	177	A	B	C	D	E
106	A	B	C	D	E	124	A	B	C	D	E	142	A	B	C	D	E	160	A	B	C	D	E	178	A	B	C	D	E
107	A	B	C	D	E	125	A	B	C	D	E	143	A	B	C	D	E	161	A	B	C	D	E	179	A	B	C	D	E
108	A	B	C	D	E	126	A	B	C	D	E	144	A	B	C	D	E	162	A	B	C	D	E	180	A	B	C	D	E

PRIMERA PARTE

Forma 1 / Forma 1A

Instrucciones:

1. Esta prueba consta de 90 preguntas.
2. Dispondrá de un tiempo de **105 minutos** para responder.
3. Usted cuenta con una hoja de respuestas, la que podría estar al final de la prueba, caso en el que puede proceder a arrancarla. Debe contestar en ella, asegurándose de escribir su nombre y su RUT, con letra clara. **Debe escribir la forma de la prueba (ej. Forma 1)** en su hoja de respuesta.
4. Debe responder con lápiz mina HB N°2 o 2B, **ennegreciendo completamente la casilla correcta**.
5. Si se equivoca, la única forma de corregir es borrar con una goma y marcar la respuesta correcta.
6. **Solo se corregirá la hoja de respuestas**, así que asegúrese de contestarla a tiempo.
7. Las preguntas incorrectas **no descontarán puntaje**, se recomienda **no omitir**, ya que aquello tiende a bajar aún más el puntaje.
8. Puede rayar el cuadernillo de preguntas. Sin embargo, solo se corregirá la hoja de respuestas.
9. Al final de la prueba, debe entregar solo la hoja de respuestas, pudiendo quedarse con el cuadernillo de preguntas.
10. No se responderán dudas durante la prueba. Debe permanecer en silencio.
11. Asegúrese de pasar al baño antes de que inicie la prueba, ya que, durante esta, no podrá salir.
12. La copia está absolutamente prohibida. Tanto copiar, como entregar las respuestas al compañero será considerada una falta grave.
13. El simple hecho de tener encendido un celular o un smartwatch (reloj inteligente) u otro dispositivo electrónico, a través del cual sea posible copiar o enviar información, será considerado copia (en el Eunacom real ni siquiera se puede tener apagado, así que dele cumplimiento).
14. Si termina la prueba antes de que se acabe el tiempo, podrá entregar la hoja de respuestas y retirarse, sin hacer ruido ni hablar, hasta estar lo suficientemente lejos como para que quienes no han terminado no se vean afectados.
15. Las notas serán corregidas por la Universidad y serán subidas a la plataforma, apenas estén disponibles.

¡Les deseamos el mayor de los éxitos y mucha suerte!

(Habrá una segunda parte después de un breve recreo).

1) Una paciente de 51 años, con antecedente de artritis reumatoide de larga data, presenta aumento significativo de sus síntomas, con intenso dolor articular y artritis de múltiples articulaciones en manos, muñecas y tobillos, además de rigidez articular marcada, desde hace cerca de 3 semanas. Maneja sus síntomas con celecoxib, naproxeno y tramadol. Evoluciona hace dos días con malestar general y deposiciones oscuras. Dos días después es encontrada por sus familiares en malas condiciones y comprometida de conciencia. Al examen físico, está soporosa, pálida, con FC: 120x' y PA: 80/40, sin otras alteraciones adicionales. ¿Cuál es la causa más probable de su cuadro actual?

- a) Lesión de Dieulafoy
- b) Intoxicación por opiáceos
- c) Síndrome de Mallory Weiss
- d) Úlcera gastroduodenal
- e) Gastropatía crónica

2) ¿Qué vacuna está contraindicada en un niño con antecedente de anafilaxia en relación a la ingesta de huevo?

- a) Vacuna neumocócica conjugada
- b) Vacuna tríplica
- c) Vacuna antimeningocócica
- d) Vacuna antirrábica
- e) Vacuna contra la fiebre amarilla

3) Un paciente de 28 años, con antecedente de haber sido operado de coartación aórtica cuando niño, consulta por un cuadro progresivo de disnea de esfuerzos y ortopnea, que ha deteriorado significativamente su capacidad funcional. En el examen físico tiene pulso palpable con frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, presión arterial de 155/75 mmHg y frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, saturando 92% a FiO2 ambiental. Al examen cardiopulmonar, tiene ritmo regular en dos tonos, con soplo sistólico eyectivo II/VI en la zona paraesternal, más un soplo diastólico, que se escucha hasta la final de la diástole en el mismo foco. Su padre falleció a los 50 años, de manera súbita. ¿Cuál es el diagnóstico más importante?

- a) Recoartación aórtica
- b) Estenosis aórtica
- c) Insuficiencia aórtica
- d) Insuficiencia tricuspídea
- e) Disección aórtica

4) Una mujer de 54 años, menopáusica hace 2 años, con antecedente de enfermedad coronaria, consulta por sudoración y sensación calor en el pecho y rostro, que ocurre en episodios frecuentes y molestos, mayores en la noche. ¿Cuál es la terapia de elección?

- a) Estradiol tópico intravaginal
- b) Escitalopram oral
- c) Tibolona oral
- d) Terapia hormonal combinada de 17 beta estradiol más drospirenona por vía oral
- e) Estradiol y progesterona combinados por vía transdérmica

5) Una paciente de 48 años consulta por sangrado uterino, que no ha cesado desde su última menstruación, que inició hace dos semanas. Se solicita una ecografía transvaginal que muestra útero de tamaño normal, con endometrio de 19 mm de grosor y sin alteraciones anexiales. Su PAP, realizado hace poco es normal y su test de embarazo en orina es negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Histerectomía
- b) Ácido tranexámico endovenoso
- c) Estrógenos inyectables
- d) Anticonceptivos orales combinados
- e) Biopsia de endometrio

6) Un paciente de 54 años, con antecedente de diabetes mellitus en tratamiento hipoglicemiante oral, hipertensión arterial e hipotiroidismo, suspende sus medicamentos hace 3 meses. Desde hace 2 semanas comienza con malestar general, asociado a letargo y dificultades en sus actividades de la vida diaria, agregándose compromiso de conciencia, por lo que es llevada a la urgencia. Al examen físico tiene facies edematosa, está hiporreactiva, con temperatura 35,1°C, pulso regular a 50x, presión arterial de 150/100 mmHg, arreflexia generalizada y examen cardiopulmonar con ritmo regular en dos tiempos, sin soplo y murmullo pulmonar presente, sin otros ruidos. Sus exámenes de laboratorio muestran glicemia: 270 mg/dl, creatinina: 1,3 mg/dl, sodio plasmático: 129 mEq/L, potasio: 4,7 mEq/L, lo siguiente T4 libre: 0,1 ng/dl, TSH: 100 U/L, hemograma con hematocrito: 36%, hemoglobina: 12 g/dl, blancos: 7.000 por mm³ y plaquetas: 150.000 por mm³, CK: 390 UI/L (VN: 30 a 290) y CK-mb: 30 (VN: 0-25). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cetoacidosis diabética
- b) Síndrome hiperglicémico hiperosmolar no acidótico
- c) Infarto agudo al miocardio
- d) Coma mixedematoso
- e) Accidente vascular encefálico

7) Una paciente de 56 años tiene antecedentes de cáncer de mama, en tratamiento con quimioterapia cuyo último ciclo fue hace 9 días. Consulta porque ha presentado malestar general y fiebre hasta 38,5°C. Al examen físico, se confirma febril, con frecuencia cardíaca 95x', PA: 120/80, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

- a) Hemograma
- b) Radiografía de tórax
- c) Urocultivo
- d) Ecografía abdominal
- e) Mielograma

8) Un recién nacido de 2 meses de edad, presenta un cuadro de tos con expectoración, asociado a taquipnea. Al examen físico, tiene T°: 38,5°C, frecuencia cardíaca de 100 x' y frecuencia respiratoria de 30 por minuto, saturando 91% a FiO2 ambiental. Su examen pulmonar solo muestra crepitaciones bilaterales. Como antecedentes, nació por parto vaginal y sufrió una conjuntivitis neonatal con secreción serosa a los 15 días de vida, la que fue tratada exitosamente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cardiopatía congénita
- b) Infección por estreptococo grupo B
- c) Fibrosis quística
- d) Infección por *Streptococcus pneumoniae*
- e) Infección por *Chlamydia trachomatis*

9) Un paciente de 81 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer, presenta mayor desorientación desde hace dos semanas. Además, hace 4 días comienza con incontinencia urinaria y mayor confusión, con dificultades para dormir y algún grado de agresividad y agitación, especialmente en la noche. Además, de solicitar un hemograma, sedimento de orina y urocultivo, ¿cuál es la conducta más adecuada para el manejo de su cuadro actual?

- a) Contención física
- b) Risperidona 8 a 10 gotas vía oral cada noche
- c) Haloperidol 5 mg intramuscular cada 12 horas
- d) Diazepam 3 mg vía oral, en la noche
- e) Melatonina oral, 3 mg en la noche

10) Un preescolar de 4 años presenta un cuadro de una semana de evolución de fiebre, hasta 39°C, asociada a odinofagia. Además, se ha asociado ojo rojo, que inició en el lado izquierdo y al día siguiente se extendió al ojo derecho. Al examen físico, tiene faringe eritematosa, ojo rojo bilateral, con secreción mucosa escasa y se palpan adenopatías cervicales bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de sus síntomas oculares?

- a) Aseo con suero fisiológico
- b) Corticoide tópico
- c) Ungüento de tobramicina
- d) Colirio de gentamicina
- e) Ungüento de cloramfenicol

11) Un paciente de 78 años ha presentado eliminación de cálculos urinarios a repetición. Se solicitan exámenes de orina que muestran sedimento con 20 glóbulos rojos por campo, 12 leucocitos por campo, bacterias en abundante cantidad y cristales abundantes de fosfato de amonio magnésico. El urocultivo está pendiente. Se solicita una pielotac, que muestra cálculos coraliformes bilaterales. El urocultivo, probablemente resultará positivo, ¿para qué bacteria?

- a) *Pseudomonas aeruginosa*
- b) *Escherichia coli*
- c) *Campylobacter jejuni*
- d) *Proteus mirabilis*
- e) *Enterobacter cloacae*

12) Una mujer de 23 años consulta porque se palpó un nódulo mamario en la mama derecha. Al examen físico tiene un nódulo de 5 cm, que se palpa liso y móvil. Se solicita ecografía mamaria, que muestra un nódulo de aspecto sólido, bien delimitado y encapsulado, de aspecto homogéneo, clasificación US-BIRADS2. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar biopsia estereotáxica
- b) Control con mamografía en un año
- c) Solicitar resonancia magnética nuclear de mamas
- d) Controlar con nueva ecografía mamaria en 6 meses
- e) Realizar remoción quirúrgica

13) Una paciente de 72 años, con antecedente de EPOC, con hábito tabáquico suspendido hace 5 años y que, además tiene antecedente de diabetes e hipertensión arterial, consulta por un cuadro de 7 días de aumento de la disnea basal, la que se ha vuelto de pequeños esfuerzos y se ha asociado a mayor tos y expectoración, a lo que se ha agregado sensación febril. Su examen físico muestra frecuencia cardíaca de 105x', presión arterial de 148/92mmHg, respiración a 37 por minuto, saturación de oxígeno por pulsometría de 87%. La auscultación cardíaca muestra ruidos apagados y el examen pulmonar demuestra aumento del diámetro torácico, con disminución bilateral del murmullo vesicular, asociada a sibilancias, roncus y escasos crépitos bilaterales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: <https://campuskinesico.com>):



Se inician nebulizaciones con salbutamol, más corticoides y antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa y oxígeno por mascarilla al 24%. A la hora siguiente, continúa con apremio respiratorio y taquipnea con examen físico en condiciones similares, además, se reciben los resultados de gases arteriales, que muestran lo siguiente: PaO₂: 56 mmHg, PaCO₂: 62 mmHg, bicarbonato: 21 mEq/L y pH: 7,26. ¿Cuál es la conducta es más adecuada?

- a) Oxígeno por mascarilla al 50%
- b) Ventilación mecánica invasiva
- c) Ventilación mecánica no invasiva
- d) Teofilina endovenosa y nebulizaciones con formoterol
- e) Solicitar TAC de tórax

14) Un paciente de 45 años vive en situación de marginalidad y hacinamiento, tiene antecedente de alcoholismo y tabaquismo activos; consulta por un cuadro de 3 semanas de evolución de tos con expectoración mucopurulenta, que, en ocasiones, es hemoptoica. También, ha presentado fiebre intermitente, ha bajado de peso cerca de 4 kilogramos y refiere sudoración, que es mayor en la mañana y en la noche. Al examen físico tiene T°: 37,6°C, FC: 83x', PA: 110/70 mmHg, FR: 15x', auscultación pulmonar con crepitaciones pulmonares bilaterales, mayores en el lóbulo superior izquierdo y auscultación cardíaca normal. Se tomaron dos baciloscopías, que resultaron negativas y se solicitó una radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: <https://urgenciasbidasoa.wordpress.com>):



¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio de este paciente?

- a) Reacción en cadena de polimerasa para *Mycobacterium tuberculosis*
- b) PPD (prueba de tuberculina)
- c) TAC de tórax
- d) Lavado bronquioalveolar
- e) Ensayo de liberación de interferón gama

15) Una mujer de 62 años acude al servicio de urgencia por dolor abdominal intenso, de dos horas de evolución, difuso, pero mayor en hemiabdomen superior. Además, presentó vómitos alimentarios, en varias oportunidades. El dolor inició tipo cólico, pero luego se hizo permanente. Al examen físico tiene IMC: 32, T°: 36,7°C, FC: 108x', PA: 102/96 mmHg. Examen cardiopulmonar normal. El examen abdominal muestra cicatriz de cesárea Pfannestiel, timpanismo y disminución de la matidez hepática a la percusión y ruidos hidroaéreos muy disminuidos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Obstrucción intestinal
- b) Perforación intestinal
- c) Vólvulo de sigmoides
- d) Trombosis de la vena mesentérica
- e) Embolia mesentérica

16) Una paciente de 28 años, cursando su segundo embarazo de 35 semanas + 6 días, consulta por un cuadro de astenia, malestar general y aumento de volumen en las extremidades inferiores. Además, hace 24 horas ha notado disminución de los movimientos fetales. Sus antecedentes obstétricos solo muestran una cesárea previa por presentación podálica. Se solicita un registro basal no estresante, que resulta no reactivo. Su examen físico muestra edema de las extremidades inferiores, PA: 149/96x', FC: 80x', altura uterina de 31 cm y su tacto vaginal muestra cuello uterino sin dilatación y con índice de Bishop de 3 puntos. Se solicita un perfil biofísico, que muestra tono flexor y movimientos fetales y respiratorios presentes, con líquido amniótico con un bolsillo único menor a 1 cm. Se repite el registro basal no estresante, que vuelve a resultar no reactivo. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar el test de tolerancia a las contracciones
- b) Solicitar Doppler fetal
- c) Repetir el perfil biofísico
- d) Inducir el parto con misoprostol
- e) Realizar cesárea de urgencia

17) Una paciente de 30 años, con antecedente de soplo en la infancia, consulta por un cuadro de disnea de esfuerzos, que ha aumentado en las últimas semanas. Al examen físico, se palpa latido del corazón en la zona para esternal derecha y, en la auscultación, presenta un soplo sistólico eyectivo, asociado a desdoblamiento fijo del segundo ruido. Examen pulmonar demuestra murmullo pulmonar presente, bilateral, asociado a crepitaciones en ambas bases pulmonares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hipertensión pulmonar primaria
- b) Comunicación interauricular
- c) Comunicación interventricular
- d) Ductus arterioso persistente
- e) Coartación aórtica

18) Un hombre de 94 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer, postrado e institucionalizado, es usuario de sonda Foley a permanencia, debido a obstrucción urinaria de causa prostática. Se cambia la sonda cada 30 días, habiéndose realizado el último cambio hace 15 días. Se realiza un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli multisensible. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Cambiar la sonda y solicitar urocultivo de control
- b) Iniciar ceftriaxona endovenosa
- c) Iniciar ciprofloxacino oral
- d) Iniciar cotrimoxazol oral
- e) Mantener los cuidados habituales

19) Una niña de 7 años presenta un cuadro de 9 días de tos disfónica, a lo que, en los últimos días, se agrega astenia, malestar general, dificultad respiratoria y fiebre hasta 38,5°C. Al examen físico está en buenas condiciones, con frecuencia cardíaca: 90x', saturación arterial 95% y T°:38°C. Tiene faringe eritematosa, sin exudado. Al examen pulmonar, se auscultan sibilancias y crepitaciones bilaterales. Se solicita una radiografía, que muestra múltiples infiltrados pulmonares bilaterales, con atelectasias lineales en las bases. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Adenovirus
- b) Virus parainfluenza
- c) *Mycoplasma pneumoniae*
- d) *Streptococcus pneumoniae*
- e) *Bordetella pertusis*

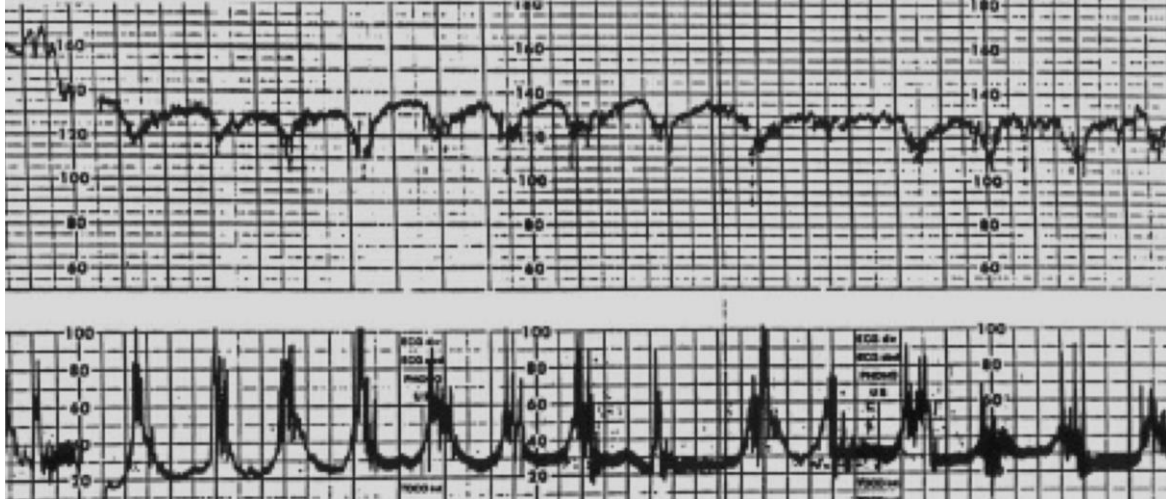
**20) ¿A qué indicador corresponde la siguiente ecuación?
(Muertes en menores de 28 días / nacidos vivos) x 1.000**

- a) Tasa de mortalidad infantil
- b) Tasa de mortalidad perinatal
- c) Tasa de mortalidad neonatal
- d) Tasa de mortalidad neonatal precoz
- e) Tasa de mortalidad postneonatal

21) Usted atiende a un niño de 3 años en el servicio de urgencia, que es traído por su madre, por haber sufrido quemaduras en los dedos y en la espalda, después de haberse apoyado accidentalmente en una estufa. Al examen físico, está agitado y llorando y se observa eritema y flictenas en las zonas afectadas. ¿Cuál es la conducta inicial?

- a) Curaciones
- b) Paracetamol vía oral
- c) Ungüento antibiótico tópico
- d) Analgesia endovenosa
- e) Antibióticos endovenosos

22) Una paciente de 29 años, cursando un embarazo de 36+2 semanas, acude al servicio de urgencia por contracciones uterinas dolorosas y frecuentes. Al examen físico tiene altura uterina: 32 cm, estimación de peso fetal en percentil 25 y se constatan 5 contracciones uterinas cada 10 minutos. El tacto vaginal demuestra dilatación cervical de 4 cm y membranas íntegras. Se auscultan los latidos cardiorfetales a 140x' y se realiza registro fetal, que se muestra a continuación:



¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar cesárea de urgencia
- b) Realizar rotura de membranas
- c) Inducir con misoprostol
- d) Inducir con goteo oxitócico
- e) Controlar en dos horas

23) Un niño de 8 años presenta epistaxis con frecuencia y, además, tiene antecedente de haber presentado sangramiento bucal prolongado, después de una extracción dental. Al examen físico, se objetivan múltiples equimosis en las piernas y rodillas. Como antecedente, su madre refiere que ella presenta reglas abundantes y también cierta tendencia a tener equimosis. Se solicitan exámenes que muestran protrombinemia: 85%, TTPA: 38 segundos, hemograma con hematocrito: 33%, hemoglobina: 11 g/dl, VCM: 88 ft, glóbulos blancos: 8.000 por mm³ y plaquetas: 323.000 por mm³. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hemofilia
- b) Trombocitopenia inmune
- c) Enfermedad de von Willebrand
- d) Síndrome antifosfolípidos
- e) Niño sano

24) Un paciente de 65 años, con antecedente de hipertensión arterial, diagnosticada hace un año en tratamiento con atenolol 50 mg cada 12 horas y enalapril 20 mg cada 12 horas, refiere múltiples tomas de presión arterial con valores sobre 160/100 mmHg. Al examen físico tiene FC: 60x', PA: 158/100 mmHg, sin alteraciones en el examen segmentario. Se solicitan exámenes que muestran creatinina: 1,2 mg/dl, sodio: 143 mEq/L, potasio: 3,4 mEq/L, hemograma normal y TSH: 3,2 UI/L. ¿Con qué examen se debe proseguir su estudio?

- a) Cortisol basal y post dexametasona
- b) Monitoreo de presión arterial de 24 horas
- c) Calcemia y niveles de paratohormona
- d) Metanefrinas y normetanefrinas en orina
- e) Ecografía Doppler de arterias renales

25) Un paciente de 64 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipotiroidismo consulta por dolor abdominal de 2 días de evolución, mayor en el flanco derecho y fosa ilíaca derecha, EVA 8/10 y que se ha asociado a malestar general. Al examen físico tiene FC: 87x', PA: 132/86 mmHg, T°: 37,2°C y examen abdominal que muestra abdomen doloroso a la palpación, mayor en la fosa ilíaca derecha, con signo de Blumberg positivo en la zona y ruidos hidroaéreos presentes, aunque disminuidos. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio en este paciente?

- a) Colonoscopia
- b) Enema baritado
- c) Lapatomía exploradora
- d) Ecografía abdominopélvica
- e) Tomografía de abdomen y pelvis

26) Un paciente de 58 años, desde hace 3 años, presenta pirosis y regurgitación frecuentes. Su examen físico no aporta mayor información. Se realiza una endoscopia digestiva alta, que muestra mucosa esofágica con esofagitis distal moderada, la línea Z a 28 cm de la arcada dentaria y la impresión diafragmática a 37 cm de la arcada dentaria y mucosa gástrica sin alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hernia hiatal directa
- b) Esófago de Barret
- c) Infección por Helicobacter pylori
- d) Acalasia esofágica
- e) Divertículo esofágico

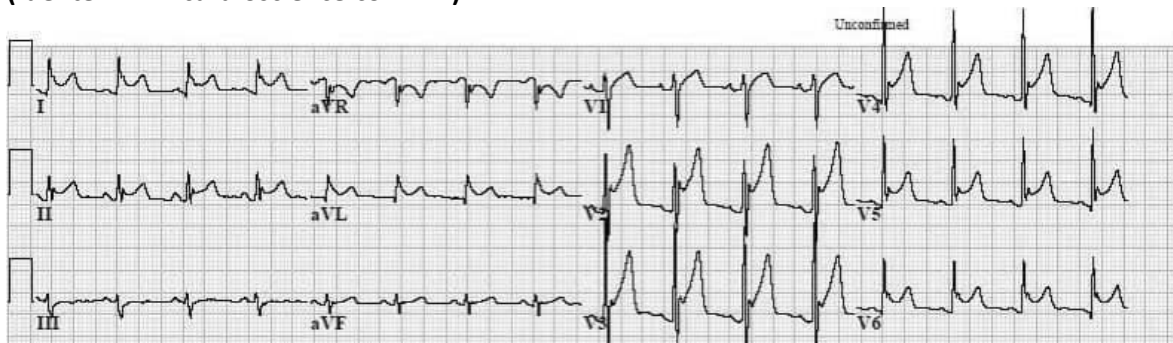
27) Un paciente de 22 años presenta un cuadro de dolor a la fosa lumbar derecha, irradiado al flanco derecho intenso ipsilateral y asociado a vómitos, que ha manejado con analgésicos. Evoluciona dos días después con malestar general y fiebre de 38,8°C. Su sedimento de orina muestra Se solicita pielotAC, que muestra presencia de un cálculo de 9 mm, en el tercio distal del uréter derecho, con presencia de hidroureteronefrosis ipsilateral. Además de iniciar analgésicos y antibióticos, ¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?

- a) Realizar nefrolitotomía abierta
- b) Realizar nefrolitotomía percutánea
- c) Realizar litotripsia extracorpórea
- d) Instalar un catéter doble J
- e) Indicar tratamiento médico expulsor

28) Un paciente de años, desde hace 10 días comienza con angustia y malestar general, asociado a dificultades para dormir y pesadillas. Se ha sentido agobiado y triste. Refiere que ace dos semanas fue testigo de un asalto, en el cual la víctima fue herida con un arma de fuego. Además, ha evitado salir de su casa y el contacto con otras personas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno agudo por estrés
- b) Episodio depresivo mayor
- c) Trastorno de estrés postraumático
- d) Trastorno de angustia generalizada
- e) Trastorno de angustia social

29) Un paciente de 40 años consulta por dolor retroesternal opresivo, irradiado al dorso, que inició después de comer y que tiene una intensidad de 8/10, con tope inspiratorio. Al examen físico tiene FC: 100x, PA: 130/88 mmHg, T°: 37,7°C, examen pulmonar normal, auscultación cardíaca con ritmo regular en dos tonos, sin soplos. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: www.cardioscience.com.mx):



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Pericarditis aguda
- c) Disección aórtica
- d) Infarto agudo al miocardio de pared inferior
- e) Infarto agudo al miocardio de pared anterolateral

30) Un paciente de 39 años es detenido, porque estaba haciendo disturbios en la vía pública. Es llevado para constatar lesiones y, al examen no coopera y se muestra angustiado y agitado, con agresión verbal hacia el personal de salud, sin llegar a la agresión física. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar haloperidol 5 mg intramuscular
- b) Risperidona 1 mg vía oral
- c) Diazepam 5 mg intramucular
- d) Contención verbal
- e) Contención física

31) ¿Cuál de las siguientes instituciones corresponde a un centro de salud secundaria?

- a) Posta de Salud Rural
- b) CESFAM (Centro de Salud Familiar)
- c) COSAM (Centro de Salud Mental)
- d) CECOSF (Centro Comunitario de Salud Familiar)
- e) Hospital comunitario

32) Una niña de 4 años es traída por un cuadro de 3 días de evolución de malestar general, fiebre hasta 38,5°C y, el día de hoy, aparición de un lesiones cutáneas que abarcan tronco extremidades y cara, como se muestra en la imagen (fuente: dortorgo.es):



¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Virus rubéola
- b) Parvovirus B19
- c) Coxsackie A16
- d) Virus herpes simple
- e) Virus herpes 6

33) Una paciente de 32 años se realizó un PAP hace dos años, que fue informado como “probable NIE 2”, sin embargo no tuvo controles posteriores. Hace un mes comienza con genitorragia escasa e intermitente, asociada a mal olor genital. Se realiza una especuloscopia, que visualiza una lesión de 2 cm de diámetro, en relación al cuello uterino, ulcerada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Repetir el PAP en este momento
- b) Realizar biopsia de cuello uterino
- c) Realizar histerectomía radical
- d) Realizar un cono cervical
- e) Solicitar prueba de detección y tipificación de virus papiloma humano

34) Un paciente de 50 años relata que, al llegar a su trabajo en auto, se le “descompuso el cuerpo”, sintiendo rigidez generalizada en todos sus músculos, lo que le impidió entrar a su trabajo y lo obligó a devolverse a su casa. Además, presentó pérdida de conciencia con movimientos repetitivos en su casa, razón por la cual fue llevado al servicio de urgencias. Refiere malestar, angustia y desasosiego de varios días de evolución. Al examen físico tiene un examen neurológico estrictamente normal y su resonancia magnética nuclear descarta lesiones. Sus familiares refieren que siempre ha sido un buen trabajador y excelente padre, por lo que no entienden bien qué le está pasando. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno depresivo
- b) Trastorno conversivo
- c) Trastorno adaptativo
- d) Trastorno facticio
- e) Trastorno disociativo

35) Una niña de 3 años no juega con sus compañeros del jardín infantil, tampoco le responde a la profesora e, incluso, la agredió en un momento, cuando la obligaron a cambiar de una actividad que hacían rutinariamente. Su madre refiere que, en casa, habla poco, le gusta ordenar sus juguetes siempre de la misma forma y no demuestra interés en jugar con los demás niños del barrio y que se lleva frecuentemente las manos a los oídos, especialmente cuando hay ruidos fuertes, como los del secador de pelo o la aspiradora, que le son especialmente molestos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Discapacidad cognitiva
- b) Trastorno del espectro autista
- c) Hipoacusia congénita
- d) Trastorno obsesivo compulsivo
- e) Trastorno por déficit atencional hipoactivo

36) Una paciente de 60 años con antecedente de hipertensión arterial de larga data, en tratamiento con carvedilol 25 mg cada 12 horas e hidroclorotiazida 50 mg/día, presenta presiones arteriales cercanas a 150/95 en la mayoría de las tomas. Además, tiene disnea de grandes esfuerzos y ortopnea, que lo obliga a dormir con una almohada grande. Su examen físico tiene frecuencia cardíaca 66x', PA: 150/96 mmHg, saturación arterial de oxígeno de 97%, examen pulmonar con crepitaciones bibasales, sin otras alteraciones y examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos, sin soplos. Se solicitan exámenes que muestran natremia: 142 mEq/L, potasemia: 4,0 mEq/L, creatininemia: 0,7 mg/dl, con hemograma y pruebas tiroideas normales. ¿Qué fármaco debería agregarse en este caso?

- a) Losartán
- b) Amlodipino
- c) Verapamilo
- d) Diltiazem
- e) Doxazosina

37) Una paciente de 35 años, nulípara, sin antecedentes mórbidos de importancia, consulta porque desde hace 6 meses ha presentado aumento del flujo menstrual. Su examen físico no aporta mayor información. Tiene PAP sin presencia de células atípicas, realizado hace 8 meses. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra la presencia de un pólipo endometrial de 8 mm de diámetro. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar histerosonografía
- b) Realizar histerectomía
- c) Realizar histeroscopia
- d) Realizar legrado uterino
- e) Iniciar anticonceptivos orales

38) Un adulto mayor de 87 años, con antecedente de hipertensión arterial, está en tratamiento con amlodipino 5 mg/día, hidroclorotiazida 25 mg/día y enalapril 10 mg cada 12 horas, presenta presiones arteriales de control de 120/80 mmHg, sin embargo, consulta por edema y sensación de pesadez en sus extremidades inferiores. Al examen físico se objetiva edema moderado bilateral en los tobillos, signos vitales dentro de rango normal y examen cardiopulmonar normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Disminuir la dosis nocturna de enalapril
- b) Reemplazar el enalapril por losartán
- c) Suspender el amlodipino
- d) Agregar furosemida al tratamiento
- e) Aumentar la dosis de hidroclorotiazida a 50 mg/día

39) Una paciente de 21 años, consulta por dolor hipogástrico de 4 días de evolución. Su FUR fue hace 2 semanas. Al examen físico, tiene dolor a la palpación profunda en el hipogastrio, sin signos peritoneales. En el examen ginecológico, tiene dolor a la palpación anexial derecha, sin otras alteraciones. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra endometrio de 15 mm, homogéneo, sin lesiones ni alteraciones anexiales ni líquido libre. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar resonancia magnética nuclear
- b) Solicitar histerosalpingografía
- c) Solicitar laparoscopia exploradora
- d) Iniciar anticonceptivos orales y ácido mefenámico
- e) Solicitar subunidad beta HCG

40) Una paciente de 19 años acude al servicio de urgencia por un cuadro de rectorragia de dos días de evolución, que el día de hoy se volvió mucho más abundante. Al examen físico tiene FC: 117x', PA: 90/60 mmHg, palidez de piel y mucosas y examen abdominal con dolor difuso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. Al preguntar dirigidamente, refiere antecedente de varios episodios de dolor periumbilical recurrente, de tipo urente, que había cedido de manera espontánea. Se solicita hemograma, que muestra hematocrito: 27%, hemoglobina 8,1 g/dl, blancos: 5.000 por mm³ y plaquetas: 230.000 por mm³. También, se realiza colonoscopia de urgencia que muestra abundante sangre en todo el trayecto colónico, que fluye, además, por la válvula íleocecal. ¿Cuál es diagnóstico más probable?

- a) Enfermedad de Cröhn
- b) Pólipo juvenil
- c) Infección por Shigella
- d) Divertículo de Meckel
- e) Adenitis mesentérica

41) Una recién nacida de 27 días de vida presenta 6 hemangiomas superficiales, en el tronco y extremidades. El resto de su examen físico es normal y no tiene antecedentes de importancia. ¿Cuál examen es más adecuado para proseguir el estudio de esta paciente?

- a) Ecografía abdominal
- b) Ecografía cerebral
- c) Resonancia magnética nuclear espinal
- d) Ecografía de partes blandas
- e) Resonancia magnética nuclear de cerebro

42) Un hombre de 92 años que hace un año nota aparición de 3 lesiones puntiformes en la pierna derecha, que han ido en aumento, en especial una de ellas, que ha alcanzado gran tamaño y que se muestra en la siguiente imagen (fuente: www.medigraphic.com/):



¿Cuál es diagnóstico más probable?

- a) Melanoma con satelitosis
- b) Pioderma gangrenoso
- c) Carcinoma basocelular
- d) Granuloma piógeno
- e) Eccema numular

43) Un niño de 11 meses de edad presenta fiebre hasta 39°C, desde hace 3 días, asociado a irritabilidad, que ha sido manejada con paracetamol. El día de hoy presenta lesiones cutáneas papulares eritematosas, generalizadas. El resto de su examen físico no tiene alteraciones ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Virus herpes 6
- b) Parvovirus B19
- c) Virus Coxsackie A16
- d) Virus varicela zóster
- e) Virus de Epstein Baar

44) Una mujer de 32 años, consulta por dolor intenso en el oído izquierdo, que inició después de haberse limpiado con un cotonito (hisopo). No tiene síntomas vestibulares, aunque refiere hipoacusia moderada en dicho oído. Se realiza otoscopia, que muestra presencia de una perforación timpánica triangular, con sangre en el conducto auditivo externo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Lavado de oídos
- b) Ciprofloxacino tópico
- c) Derivar a timpanoplastia
- d) Control en un mes
- e) TAC de oídos

45) Una paciente de 35 años, consulta por dolor de en la zona escapular izquierda, que comenzó hace un día. Además, notó la aparición de una lesión cutánea. Al examen físico, se aprecia una lesión de 10 cm de diámetro, con centro oscuro, como se ve a continuación:



¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) *Loxosceles laeta*
- b) *Staphylococcus aureus*
- c) Estreptococo beta hemolítico grupo B
- d) *Pseudomona aureginosa*
- e) *Latrodectus mactans*

46) Una paciente de 42 años, con antecedente de artritis psoriática e hipertensión arterial, en tratamiento farmacológico, consulta por dolor ocular izquierdo, asociado a fotofobia y disminución de la agudeza visual de dicho ojo. Al examen físico tiene ojo rojo bilateral, mayor al lado izquierdo, con marcada fotofobia en dicho lado, al examen con linterna. Su agude visual es 20/25 a derecha y 20/40 a izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Uveítis aguda
- b) Conjuntivitis viral
- c) Glaucoma agudo
- d) Neuritis óptica
- e) Glaucoma crónica

47) Una paciente de 68 años, consulta por disuria y dispareunia de 5 meses de evolución, que ha ido en aumento. Cuenta con múltiples exámenes de orina y urocultivos, que han resultado negativos. En su examen físico, se constata mucosa vaginal pálida y seca, flujo patológico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Promestireno tópico vaginal
- b) 17 beta estradiol por vía oral
- c) Tibolona oral
- d) Acetato de medroxiprogesterona por vía oral
- e) Estradiol más dienogest por vía oral

48) Un hombre de 49 años presenta un cuadro de algunos meses de evolución de astenia, disminución de la libido y de potencia sexual, además de náuseas, mialgias y malestar general. Refiere, con cierta preocupación, que ha chocado con algunos muebles, por no haberlos visto, mientras caminaba en su casa. Al examen físico, tiene FC: 65x', PA: 108/66 mmHg, T°: 35,8°C, presenta piel seca y fría, disminución del vello corporal, examen cardiopulmonar normal y abdomen sin alteraciones. En el examen neurológico destaca afectación temporal del campo visual. ¿Cuál es el examen de elección para evaluar a este paciente?

- a) Niveles plasmáticos de hormona tiroestimulante
- b) Radiografía de silla turca
- c) Tomografía axial computarizada de suprarrenales
- d) Niveles de testosterona y prolactina
- e) Resonancia magnética nuclear de silla turca

49) Un niño de 5 años presenta un cuadro de 7 días con fiebre alta, que no ha respondido al uso de antipiréticos, alcanzado peaks febriles de hasta 39°C. Al examen físico tiene T°: 38,6°C, pulso regular a 110x', inyección conjuntival bilateral, lengua muy enrojecida, faringe eritematosa, cuello con adenopatías submandibulares y presencia de un exantema eritematoso en el tronco y la zona genital. ¿Cuál es la complicación más probable?

- a) Glomerulonefritis
- b) Pericarditis
- c) Hepatitis
- d) Rotura esplénica
- e) Aneurisma coronario

50) Un hombre de 35 años consulta por deposiciones abundantes y líquidas, que iniciaron hace 2 semanas y se presentan hasta 5 veces al día. Además, refiere malestar general y sensación febril. Dos meses atrás fue operado por una fístula perianal. Al examen físico tiene T°: 37,7°C, FC: 88x', PA: 120/80 mmHg, examen oral con tres úlceras; el examen abdominal muestra abdomen blando, depresible, sensible a la palpación profunda, con negatividad de los signos peritoneales y presencia de ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Infección por Shigella
- b) Colitis ulcerosa
- c) Enfermedad de Crohn
- d) Colitis pseudomembranosa
- e) Infección por Entamoeba histolytica

51) Un paciente de 40 años, con antecedente de hipertensión arterial diagnosticada hace 6 meses, de difícil manejo, acude a control. Toma hidroclorotiazida 50 mg/día, losartán 100 mg/día y amlodipino 10 mg/día. Refiere varias crisis hipertensivas, a pesar de una buena adherencia a su tratamiento farmacológico. En el examen físico, su presión arterial actual es 158/97, que es similar a los valores que habitualmente presenta en su casa; su frecuencia cardíaca es 65x' y su examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en dos tiempos, sin soplos y murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. Trae un monitoreo de presión arterial con presión arterial promedio de 160/101 mmHg, con que muestra cargas tensionales diurnas de 77% sistólica y 63% diastólica y cargas tensionales nocturnas de 67% sistólica y 56% diastólica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Reemplazar el losartán por un IECA
- b) Reemplazar la hidroclorotiazida por un diurético antialdosterónico
- c) Agregar doxazosina al tratamiento
- d) Agregar espironolactona y solicitar exámenes para descartar una hipertensión secundaria
- e) Reemplazar el amlodipino por diltiazem

52) Una paciente de 24 años, cursando un embarazo de 36 semanas, se realiza una prueba de detección de estreptococo betahemolítico grupo B, mediante cultivo obtenido por tórula perineal, el que resulta positivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada para prevenir la infección del recién nacido?

- a) Tratar a la madre con amoxicilina oral por 7 días en este momento
- b) Tratar a la madre con penicilina endovenosa durante el trabajo de parto
- c) Tratar al recién nacido con ampicilina endovenosa durante la primera hora de vida
- d) Inducir el parto en este momento
- e) Realizar operación cesárea al llegar a término

53) Un niño de 4 años lleva 9 días con fiebre, sin otros síntomas. Al examen físico tiene T° 38,5°C, se palpan adenopatías submandibulares y en el examen abdominal se palpa el hígado 2 cm bajo el reborde costal. Se solicita una ecografía abdominal, que muestra múltiples imágenes, compatibles con granulomas hepatoesplénicos vascularizados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Infección por virus de la inmunodeficiencia humana
- b) Infección por *Barthoneella henselae*
- c) Infección por virus de Epstein Baar
- d) Enfermedad de Kawasaki
- e) Brucelosis

54) Un paciente de 50 años, con antecedente de diabetes mellitus, en tratamiento con metformina 1g cada 12 horas y sitagliptina 50 mg cada 12 horas, presenta presiones arteriales de 148/92 mmHg, que se repiten en varios días, con valores entre 140/90 y 150/100. Su examen físico no aporta mayor información. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran creatinina plasmática: 1,5 mg/dl, índice proteinuria/creatininuria: 2,2, electrolitos plasmáticos muestran Na+: 138 mEq/L, K+: 4,2 mEq/L, Cl-: 103 mEq/L; HbA1c: 6,6%. ¿Cuál es el fármaco de elección para el manejo de este paciente?

- a) Doxasocina
- b) Enalapril
- c) Hidroclorotiazida
- d) Diltiazem
- e) Amlodipino

55) Un paciente de 14 años, sin antecedentes de importancia, presenta diarrea desde hace 7 días, asociadas a malestar general y fiebre. Se solicitan exámenes de deposiciones, entre los que destaca DNA Microarray positivo para *Campylobacter jejuni*. ¿Cuál es la tratamiento más adecuado?

- a) Cotrimoxazol
- b) Metronidazol
- c) Azitromicina
- d) Ciprofloxacino
- e) Probióticos

56) Un paciente de 43 años, trabajador agrícola, consulta por un cuadro de tos, asociada a expectoración abundante líquida, con salida de membranas que parecen hollejos de uva. Su signos vitales están dentro de rango normal y su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente, con escasos estertores en el lado izquierdo. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia):



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tuberculoma
- b) Aspergiloma
- c) Cáncer pulmonar
- d) Absceso pulmonar
- e) Hidatidosis pulmonar

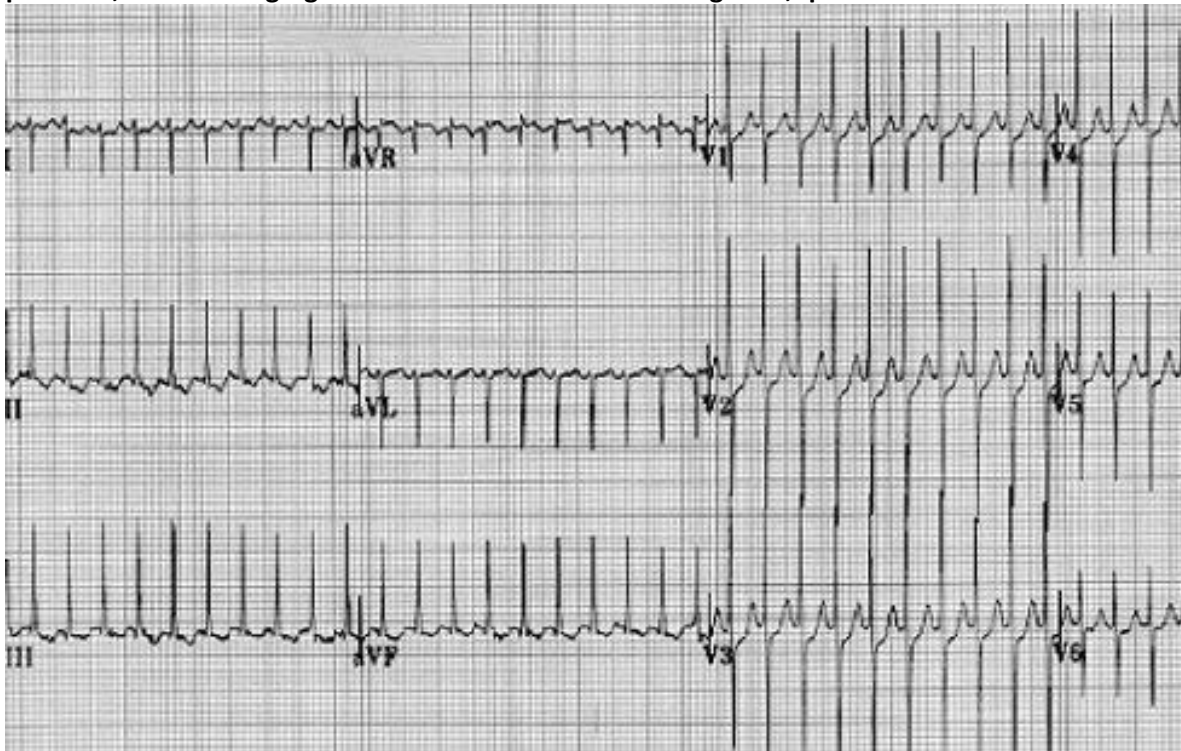
57) Una mujer de 43 años se realiza una mamografía de control, que muestra la presencia de un nódulo mamario, que es catalogado como Bi-Rads 3. Se solicita ecografía mamaria, que no muestra lesiones. Su examen mamario no tiene alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar una mamografía en 6 meses
- b) Solicitar resonancia magnética nuclear de mama
- c) Solicitar estudio de genes BRCA 1 y BRCA 2
- d) Biopsia por punción con aguja fina
- e) Biopsia estereotáxica

58) Una paciente de 77 años de edad consulta porque, desde hace un año y medio, ha presentado dificultades para la lectura, a pesar de haber cambiado de lentes hace 6 meses. Además, en el último tiempo, nota que ha empeorado sus dificultades para ver con el ojo derecho, con deformación de las imágenes de dicho ojo. Al examen físico, la inspección ocular no tiene alteraciones, los reflejos fotomotor y de acomodación son normales, el rojo pupilar está presente y la oculomotilidad está conservada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Glaucoma de ángulo abierto
- b) Catarata
- c) Desprendimiento de retina
- d) Degeneración macular relacionada con la edad
- e) Neuritis óptica

59) Un paciente de 28 años consulta por un cuadro de 3 horas de evolución de palpitaciones intensas, asociadas a disnea. Al examen físico, tiene FC: 160 por minuto, regular, PA: 110/70 mmHg, examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos, sin soplos y murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación:



¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- a) Amiodarona 150 mg endovenosa
- b) Lidocaína 100 mg endovenosa
- c) Adenosina 6mg intravenosa
- d) Diltiazem 25 mg endovenoso
- e) cardioversión eléctrica

60) Un niño de 3 meses de edad, presenta lesiones cutáneas en la zona del pañal, desde hace 2 días, las que se muestran a continuación (fuente: <https://smaciac.wordpress.com/2014/>):



¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Virus herpes simplex
- b) Virus herpes zóster
- c) *Streptococcus pyogenes*
- d) *Candida albicans*
- e) *Staphylococcus aureus*

61) Una paciente de 52 años, cuya tía fue diagnosticada de cáncer de mama, se realiza una mamografía de control, que muestra microcalcificaciones agrupadas, localizadas en el cuadrante superior externo de la mama derecha, informándose como Bi-Rads 4. La inspección y palpación mamaria son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar biopsia por punción con aguja gruesa
- b) Solicitar biopsia estereotáxica
- c) Solicitar ecografía mamaria
- d) Solicitar resonancia magnética nuclear de mamas
- e) Derivar para cirugía mamaria a la brevedad

62) Una mujer de 25 años consulta por dolos abdominal intenso, mayor en la fosa ilíaca derecha y en el hipogastrio, EVA 8/10. Al examen físico tiene FC: 90x', PA: 110/70 y el examen abdominal muestra abdomen blando y depresible, pero doloroso a la palpación de ambas fosas ilíacas. Dos horas después del ingreso a la sala de urgencia, presenta deterioro marcado del estado general, objetivándose que su frecuencia cardíaca de 120x' y presión arterial de 80/40 mmHg. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

- a) Apendicitis aguda
- b) Perforación intestinal
- c) Torsión ovárica
- d) Absceso tubo ovárico roto
- e) Embarazo ectópico roto

63) Una paciente de 29 años, cursando un embarazo de 35 semanas y 3 días, consulta por mareos, cefalea y fotopsias de algunas horas de evolución. Al examen físico, presenta FC: 89x', PA: 164/112 mmHg, FR: 13x', examen cardiopulmonar normal y reflejos rotulianos normales. Los latidos cardiorfetales se auscultan a 130 por minuto y la altura uterina es 30 cm. No presenta dinámica uterina y su tacto vaginal no muestra modificaciones. Loa ecografía obstétrica muestra ILA: 9cm, feto en cefálica con tono y movimientos normales. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Tocolíticos y dexametasona por vía endovenosa
- b) Labetalol endovenoso
- c) Misoprostol intravaginal
- d) Sulfato de magnesio
- e) Hidralacina endovenoso

64) Una paciente de 32 años, puérpera de parto vaginal eutócico de 8 días de evolución, consulta por dolor mamario derecho, mayor durante la lactancia. Al examen físico tiene T°: 38,5°C, FC: 100x', PA: 120/78 mmHg. Ambas mamas se observan eritematosas, con grietas visibles en el pezón y, en el lado derecho, se palpa aumento de volumen doloroso y fluctuante a la palpación, de 6 cm de diámetro, con aumento de la temperatura local y eritema. El examen ginecológico no tiene alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Antibióticos endovenosos más drenaje quirúrgico o por punción guiado por ecografía
- b) Drenaje por punción
- c) Suspender la lactancia materna
- d) Frío local y paracetamol
- e) Amoxicilina más ácido clavulánico vía oral

65) Una paciente de 70 años, con antecedente de enfermedad de Parkinson, presenta un cuadro de 4 días de evolución de disuria e incontinencia urinaria, a lo que se ha agregado malestar general y, desde ayer, ha presentado agitación y desorientación, creyendo que la quieren atacar. Su examen físico muestra T°:38,3°C, FC: 80x', PA: 122/82 mmHg, desorientación en el tiempo y espacio, asociada a angustia, examen cardiopulmonar normal, examen abdominal con abdomen blando, depresible, sin signos de irritación peritoneal. Dolor a la percusión de la fosa lumbar izquierda. Se solicitan exámenes, que muestran hemograma con leucocitosis de 14.000 por mm³ y VHS: 50 mm/h, sedimento de orina con abundantes bacterias, 20 glóbulos blancos por campo y 12 glóbulos rojos por campo y urocultivo que está pendiente. Se inicia ceftriaxona endovenosa, aunque intenta escaparse, ya que permanece agitada. ¿Qué medicamento es más adecuado para el manejo del cuadro actual?

- a) Risperidona
- b) Alprazolam
- c) Quetiapina
- d) Haloperidol
- e) Clorpomazina

66) Un paciente de 72 años, con antecedente de resección transuretral reciente por hiperplasia prostática benigna, lleva 10 horas con dificultades para orinar. Además, hace 8 horas no ha presentado más evacuaciones de orina. Se intenta instalar una sonda Foley, sin embargo, solo se logra cateterizar hasta la uretra bulbar, encontrando un tope infranqueable. Evoluciona con dolor y uretrorragia. Al examen físico, se palpa globo vesical. ¿Cuál es el examen más adecuada para proseguir el estudio?

- a) Ecografía pélvica
- b) Tomografía axial computada de pelvis
- c) UroTAC
- d) Radiografía de pelvis
- e) PieloTAC

67) Un paciente de 86 años acude a control por astenia y malestar general de 2 meses de evolución, asociado a bradipsiquia en el último tiempo. Al examen físico, se aprecia palidez de piel y mucosas y se constatan signos vitales con FC: 110x', PA: 126/76 mmHg, sin alteraciones en el examen cardiopulmonar. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma, con hematocrito 16%, hemoglobina: 5,3 g/dl, VCM: 126 ft, glóbulos blancos: 3.300 por mm³, plaquetas: 108.000 por mm³, bilirrubina: 3,6 mg/dl, con fracción directa de 0,6 mg/dl, LDH: 1.012 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Mielodisplasia
- b) Mieloma múltiple
- c) Anemia hemolítica
- d) Anemia megaloblástica
- e) Leucemia mieloide aguda

68) Una paciente es diagnosticada de Covid-19, con inicio de síntomas hace 10 días, mientras cursaba un embarazo de término, manteniendo solo algún grado de tos. Presentó parto vaginal hace dos horas, con recién nacido sano y su puerperio inmediato ha sido normal hasta ahora. ¿Qué recomendación se debe dar acerca del momento en el que se debe iniciar la lactancia materna?

- a) Posponerla hasta tener la madre una PCR SARS-Cov2 negativa
- b) Posponerla hasta que se hayan cumplido 14 días desde el diagnóstico
- c) Posponerla hasta que se hayan cumplido 28 días desde el diagnóstico
- d) Iniciarla de inmediato con mascarilla
- e) Iniciarla de inmediato sin protección

69) Un hombre de 78 años, acude a control, ya que su esposa refiere que, desde hace algunos meses ha presentado movimientos involuntarios mientras se está quedando dormido, presentando también problemas de memoria que han ido en aumento y se han asociado a algunas ideas paranoides. Además, ha estado más apático y desmotivado, aunque sus dificultades han tenido un curso fluctuante, pero con tendencia a empeorar. En el examen físico se aprecia colaborador y amable, con cierto grado de rigidez en extremidades superiores e inferiores, sin focalidad neurológica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Enfermedad de Parkinson
- b) Enfermedad de Alzheimer
- c) Hidrocefalia normotensiva
- d) Síndrome confusional agudo
- e) Demencia por cuerpos de Lewy

70) Una paciente de 38 años, multípara de 2 con ambos hijos nacidos por cesárea y esterilización quirúrgica durante la última cesárea, consulta porque desde hace 8 meses presenta dolor en relación a las menstruaciones y aumento del flujo menstrual. Al examen físico tiene FC: 72x', PA: 110/70 mmHg, examen segmentario normal. El examen ginecológico se objetiva útero ligeramente aumentado de tamaño, blando y sensible a la palpación, sin otras alteraciones uterinas o anexiales. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica?

- a) Dismenorrea primaria espasmódica
- b) Adenomiosis
- c) Proceso inflamatorio pélvico
- d) Endometriosis
- e) Miomatosis

71) Un paciente de 50 años, sin antecedente de importancia, se realiza una colonoscopia, como parte del screening de cáncer de colon, que muestra presencia de un pólipo de 6 mm de tamaño, ubicado en el colon descendente, el que se reseca y cuya biopsia es posteriormente informada como "adenoma vellosa tubular con grado de displasia moderado". ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar hemicolectomía izquierda
- b) Realizar mucosectomía del lecho del pólipo, por vía colonoscópica
- c) Controlar con nueva colonoscopia en 6 meses
- d) Solicitar test de sangre oculta en deposiciones
- e) Controlar con colonoscopia en 5 años

72) Una paciente de 35 años, usuaria de T de cobre desde hace 5 años, consulta porque, desde hace 8 meses está en amenorrea. Al examen físico tiene galactorrea bilateral a la compresión del pezón, sin otras alteraciones en el examen ginecobstétrico ni en el examen físico general. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

- a) Niveles plasmáticos de HCG
- b) Resonancia magnética de silla turca
- c) Niveles plasmáticos de estradiol, progesterona, LH, FSH y TSH
- d) Ecografía transvaginal
- e) Prolactinemia

73) Una niña nace por parto vaginal de término. Su peso al nacer es 2.500 gramos, que es menor al percentil para la edad gestacional. Su Apgar fue 9-9-10, observándose enflaquecida, pero vigorosa. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la alimentación?

- a) Administrar suero glucosado al 5% endovenoso y controlar glicemia en 2 horas
- b) Administrar suero glucosado al 5% oral
- c) Alimentar con fórmula láctea hasta que la madre produzca leche
- d) Dar fórmula láctea después de cada toma de leche materna
- e) Alimentar inmediatamente al pecho materno y solicitar glicemia a las 2 horas de vida

74) Una paciente de 39 años, multípara de uno, con nacimiento por cesárea, debido a desproporción cefalopélvica, cursa un nuevo embarazo de 38 semanas de edad gestacional. Comienza con trabajo de parto, por lo que es ingresada a la unidad de parto, con contracciones uterinas cada 3 minutos y un tacto vaginal que muestra dilatación cervical de 4 cm. Sin embargo, cesan las contracciones uterinas y se produce salida de sangre escasa por vagina, constatándose que el monitor fetal muestra bradicardia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Placenta previa
- b) Rotura de vasa previa
- c) Rotura uterina
- d) Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera
- e) Acretismo placentario

75) Un paciente de 23 años consulta por aumento de volumen en el cuello, que ha aumentado lentamente de tamaño en los últimos meses. Al examen físico se aprecia aumento de volumen, en la línea media, ubicado entre el mentón y el cartílago tiroides, de 3 cm de diámetro y consistencia blanda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Quiste branquial
- b) Adenitis supurada
- c) Quiste del conducto tirogloso
- d) Adenoma de glándula salival submandibular
- e) Quiste epidermoide

76) Un recién niño de 28 días de vida presenta vómitos, desde hace una semana, que son explosivos, generalmente postprandiales. Además, ha detenido su crecimiento y se encuentra más irritable de lo normal, aparentemente por hambre. Al examen físico, está en buenas condiciones generales, se observa hidratado y bien perfundido, sin alteraciones en el examen segmentario. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir con el estudio de este paciente?

- a) Ecografía abdominal
- b) Intento de instalación de sonda nasogástrica
- c) Radiografía toracoabdominal
- d) Tomografía axial computada de abdomen
- e) Endoscopia digestiva alta

77) Un niño de 4 años, presenta orinas oscuras, desde hace 7 días. Al examen físico se palpa una masa abdominal sólida, en relación al flanco izquierdo, sin otras alteraciones. Se solicitan exámenes de orina, que muestran sedimento con 2 leucocitos por campo, 35 eritrocitos por campo, sin bacterias ni cristales. El urocultivo resulta negativo. Su hemograma es normal y su creatinina es 0,7 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Riñón poliquístico
- b) Neuroblastoma
- c) Hepatoblastoma
- d) Tumor de Wilms
- e) Estenosis pielocalicilar

78) Un hombre de 25 años, con antecedente de esquizofrenia, con mala adherencia al tratamiento oral, inicia tratamiento con flufenazina intramuscular de depósito hace 3 días. Sin embargo, comienza con un cuadro de inquietud, malestar general y fiebre hasta 38,7°C, seguido de obnubilación. Al examen físico tiene FC: 109x', PA: 150/102 mmHg, T°: 38,5°C y, en el examen segmentario, destaca rigidez muscular generalizada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Meningitis bacteriana
- b) Disonía aguda
- c) Infección en el sitio de punción
- d) Síndrome serotoninérgico
- e) Síndrome neuroléptico maligno

79) Un niño de 4 meses acude a control de niño sano. La madre refiere que se cansa al mamar leche, por lo que no ha tenido un adecuado incremento ponderal. Al examen físico, se ausculta soplo holosistólico en toda la zona precordial, de intensidad III-IV sobre VI que se irradia hacia la espalda. En el examen pulmonar se auscultan crepitaciones bilaterales, escasas, sin otros ruidos. Además, en el examen abdominal se palpa el borde del hígado a 3 cm del reborde costal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Comunicación interauricular
- b) Comunicación interventricular
- c) Ductus arterioso persistente
- d) Canal aurículo-ventricular
- e) Soplo funcional

80) Un niño de 9 meses, acude a control. Al interrogar a la madre y evaluar el desarrollo psicomotor, se obtiene que dice disílabos, pero ninguna palabra; gatea, pero no da pasos con apoyo; toma objeto con las manos, utilizando una pinza intermedia; desconfía de los extraños y presenta ansiedad de separación. ¿Cuál es el diagnóstico desde el punto de vista de su desarrollo psicomotor?

- a) Retraso del desarrollo psicomotor
- b) Parálisis cerebral
- c) Trastorno global del desarrollo
- d) Discapacidad cognitiva
- e) Desarrollo psicomotor normal

81) Una paciente de 39 años, inmigrante, VIH positiva sin tratamiento desde hace 2 años, consulta por síntomas respiratorios, que comenzaron hace 3 semanas, consistentes en tos con expectoración mucopurulenta, fiebre y malestar general. Ha utilizado amoxicilina automedicada, sin respuesta. Al examen físico está enflaquecida. El examen pulmonar se auscultan estertores y crépitos en el lóbulo superior derecho. Se solicita PPD, que resulta 5 mm; baciloscopías de expectoración, que resultan negativas; y se toma cultivo líquido MGIT, que resultó positivo a los 15 días. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: Radio):



¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar tratamiento profiláctico para la tuberculosis
- b) Iniciar tratamiento estándar para la tuberculosis
- c) Esperar el resultado del cultivo estándar para mycobacterias
- d) Reiniciar la triterapia antirretroviral
- e) Solicitar PCR para *Mycobacterium tuberculosis*

82) Un paciente de 85 años se realiza un antígeno prostático específico, que resulta 10 mg/dl, razón por la cual es sometido a una biopsia prostática transrectal, que se informa como “presencia de adenocarcinoma prostático, Gleason 3+3, presente en el 0,5% del tejido. El estudio de diseminación resulta negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Prostatectomía radical
- b) Radioterapia
- c) Observar
- d) Braquiterapia
- e) Hormonoterapia

83) Una paciente de 64 años ha presentado, desde hace algún tiempo, conflictos con sus vecinos. Refiere que varios de sus vecinos tienen intenciones de dañarla o perjudicarla de alguna forma. Además, refiere la certeza de que sus vecinos han entrado a su departamento, habiéndose sentado en sus sillones, fumado en su sala e incluso dormido en su cama. Tiene una red de apoyo funcional, con buenas relaciones con sus familiares, quienes se muestran preocupados con este tema. No tiene otros síntomas y su examen de Minimental resulta 29/30. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno delirante
- b) Depresión con síntomas psicótico
- c) Esquizofrenia de inicio tardío
- d) Trastorno de personalidad paranoide
- e) Trastorno esQUIAfectivo

84) Un paciente de 75 años ha presentado varios episodios durante el sueño, en los que tiene movimientos bruscos, actuando sus sueños, llegando incluso a golpear a su a su esposa en una oportunidad, mientras dormía. Cuando despertó comentó que estaba soñando que lo atacaban, por lo que se estaba defendiendo. Se muestra muy preocupado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Sonambulismo
- b) Epilepsia de lóbulo frontal
- c) Enfermedad de Parkinson
- d) Trastorno conductual del sueño REM
- e) Síndrome confusional agudo

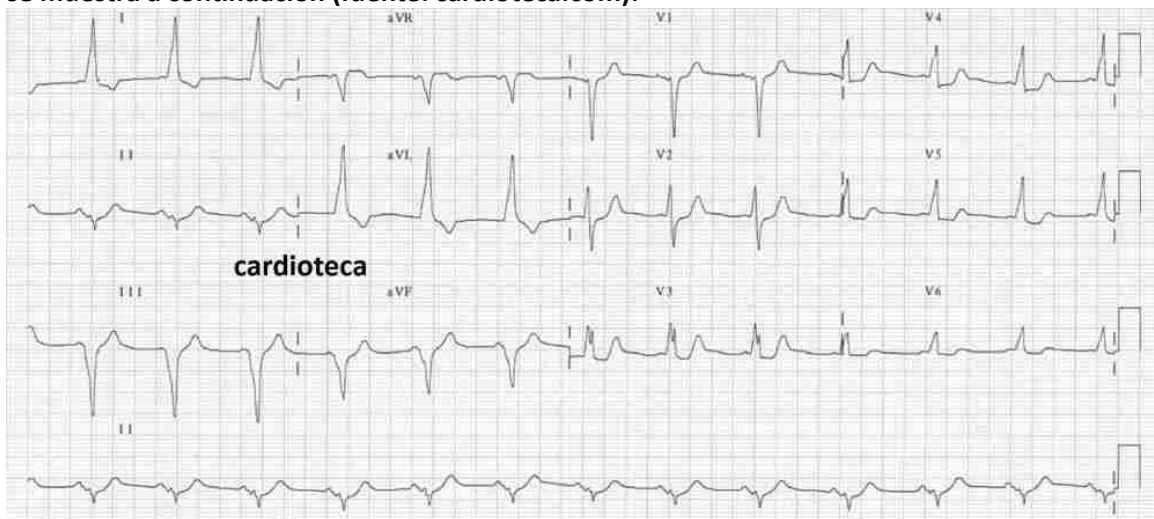
85) Una niña de 9 meses de edad, estuvo alimentada con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, momento en que inició la alimentación sólida. Sin embargo, la madre, vegana estricta, consideró que la niña no toleraba bien los alimentos, por lo que la mantuvo con leche materna exclusiva hasta ahora. Evoluciona con detención del crecimiento, dificultades para sentarse y hablar, además de estar más hipoactiva de lo normal. Al examen físico, se aprecia pálida y letárgica, con signos vitales normales y sin alteraciones en el examen cardiopulmonar ni abdominal. Se solicitan exámenes, que muestran hemoglobina: 7,9 g/dl, hematocrito: 24%, blancos: 3.700 por mm³, plaquetas: 45.000 por mm³, VHS: 12 mm/h, TSH: 1,2 UI/L, creatininemia: 0,5 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Déficit de vitamina B12
- b) Anemia hemolítica
- c) Enfermedad celíaca
- d) Leucemia aguda
- e) Fibrosis quística

86) Un niño de 11 años presenta fiebre de 10 días de evolución, asociado a astenia, cefalea, malestar general y odinofagia. Al examen físico tiene FC: 90x', T°: 37,9°C, faringe congestiva y se palpan adenopatías cervicales anteriores múltiples de 0,5 cm. En el examen abdominal, tanto el hígado como el bazo se palpan 2 cm por debajo del reborde costal. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?

- a) Coprocultivo
- b) Hemocultivos
- c) Serología para *Brucella*
- d) IgM para virus hepatitis A
- e) Anticuerpos heterófilos

87) Un paciente de 22 años consulta por palpitaciones de inicio súbito, rápidas y molestas, que duraron cerca de 30 minutos y desaparecieron con maniobras vagales. Refiere que había presentado episodios previos, pero de menor duración y autolimitados. Actualmente está en buenas condiciones y al examen físico, no presenta alteraciones. Trae un electrocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: cardioteca.com):



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Fibrilación auricular
- b) Síndrome de Wolff Parkinson White
- c) Bloqueo completo de rama izquierda
- d) Flutter auricular
- e) Síndrome de Brugada

88) Un paciente de 30 años, consulta por un cuadro de dos días de evolución de dolor abdominal, localizado en hipocondrio derecho, que se irradia al dorso y se ha asociado a vómitos alimentarios en varias oportunidades y calofríos. Al examen físico se aprecia ictericia de piel y escleras, sus signos vitales muestran FC: 100x', PA: 110/68 mmHg, examen abdominal con abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación del epigastrio y el hipocondrio derecho, sin signos peritoneales y con ruidos hidroaéreos presentes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Apendicitis aguda
- b) Pancreatitis aguda
- c) Coledocolitiasis aguda
- d) Colecistitis aguda
- e) Hepatitis aguda

89) Un paciente de 30 años empieza a trotar hace 2 semanas, sin embargo, refiere que deforma las zapatillas y que presenta dolor en la planta del pie y el antepié. Al examen físico se aprecia arco plantar muy marcado y callosidades en la zona anterior del pie, a nivel de la cabeza de los huesos metatarsianos. ¿Cómo se conoce esta formación del pie?

- a) Pie plano
- b) Pie varo
- c) Pie bot
- d) Pie equino
- e) Pie cavo

90) Un adolescente de 17 años presenta un golpe en la rodilla izquierda, evolucionando con dolor en la cara anterior de la rodilla, que es manejado con analgésicos, sin embargo, no responde adecuadamente, por lo que se solicita una radiografía de rodilla y pierna, que muestra discontinuidad de la cortical de la diáfisis de la tibia, calcificación de partes blandas, reacción perióstica triangular de 2 cm y algunas zonas osteoblásticas con otras osteolíticas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Fractura en maduración
- b) Hematoma calcificado
- c) Osteomielitis aguda
- d) Tumor óseo maligno
- e) Condromalacia

SEGUNDA PARTE

Forma 1 / Forma 1A

Instrucciones:

1. Esta prueba consta de 90 preguntas.
2. Dispondrá de un tiempo de **105 minutos** para responder.
3. Usted cuenta con una hoja de respuestas, la que podría estar al final de la prueba, caso en el que puede proceder a arrancarla. Debe contestar en ella, asegurándose de escribir su nombre y su RUT, con letra clara. **Debe escribir la forma de la prueba (ej. Forma 1)** en su hoja de respuesta.
4. Debe responder con lápiz mina HB N°2 o 2B, **ennegreciendo completamente la casilla correcta**.
5. Si se equivoca, la única forma de corregir es borrar con una goma y marcar la respuesta correcta.
6. **Solo se corregirá la hoja de respuestas**, así que asegúrese de contestarla a tiempo.
7. Las preguntas incorrectas **no descontarán puntaje**, se recomienda **no omitir**, ya que aquello tiende a bajar aún más el puntaje.
8. Puede rayar el cuadernillo de preguntas. Sin embargo, solo se corregirá la hoja de respuestas.
9. Al final de la prueba, debe entregar solo la hoja de respuestas, pudiendo quedarse con el cuadernillo de preguntas.
10. No se responderán dudas durante la prueba. Debe permanecer en silencio.
11. Asegúrese de pasar al baño antes de que inicie la prueba, ya que, durante esta, no podrá salir.
12. La copia está absolutamente prohibida. Tanto copiar, como entregar las respuestas al compañero será considerada una falta grave.
13. El simple hecho de tener encendido un celular o un smartwatch (reloj inteligente) u otro dispositivo electrónico, a través del cual sea posible copiar o enviar información, será considerado copia (en el Eunacom real ni siquiera se puede tener apagado, así que dele cumplimiento).
14. Si termina la prueba antes de que se acabe el tiempo, podrá entregar la hoja de respuestas y retirarse, sin hacer ruido ni hablar, hasta estar lo suficientemente lejos como para que quienes no han terminado no se vean afectados.
15. Las notas serán corregidas por la Universidad y serán subidas a la plataforma, apenas estén disponibles.

¡Les deseamos el mayor de los éxitos y mucha suerte!

(Habrá una segunda parte después de un breve recreo).

1) Una niña de 15 años ha presentado una serie de conflictos con sus familiares en el último tiempo, discutiendo con varios de ellos, de manera intensa. Además, está muy conversadora, incluso con extraños y ha tenido varios problemas en el colegio, debido a que interrumpe reiteradamente las clases y, cuando sus profesores la han hecho callar, responde de forma agresiva y los insulta. Duerme cerca de 5 horas al día, inició su vida sexual recientemente, sin protección y ha consumido marihuana en 3 oportunidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno por déficit atencional hiperactivo
- b) Trastorno de personalidad límite
- c) Esquizofrenia
- d) Trastorno bipolar
- e) Trastorno por consumo de sustancias

2) Una adolescente de 18 años consulta ambulatoriamente porque se siente ansioso y agobiado. Además, refiere sentirse bastante avergonzado del mal rendimiento que ha tenido en su primer año de universidad, por lo que ha pensado en cambiarse de carrera, debido a que siente que ya no le gusta tanto lo que eligió estudiar. Refiere que en el colegio siempre había sido buena alumna, aunque reconoce que le costaba concentrarse y que, actualmente, procrastina sus estudios. Con frecuencia pierde las llaves y su celular y se distrae en las conversaciones cara a cara cuando son muy largas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno bipolar
- b) Trastorno de ansiedad social
- c) Trastorno depresivo mayor
- d) Trastorno por déficit atencional
- e) Trastorno adaptativo

3) Un paciente de 35 años presenta dolor cervical súbito, mayor en el lado derecho, que inició mientras hacía deporte. El dolor es intenso y se irradia a la cara. Al examen neurológico, destaca ptosis y miosis del ojo derecho, sin alteraciones de la sensibilidad ni motilidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cefalea en racimo (cluster headache)
- b) Parálisis del tercer par
- c) Disección carotídea
- d) Malformación vascular cerebral con compresión del tercer nervio craneal
- e) Infarto vertebro basilar

4) Un paciente de 25 años, con antecedente de trastorno bipolar de difícil manejo, en tratamiento con lamotrigina, litio, diazepam, sertralina y clorpromazina, presenta un cuadro de poliuria de cerca de 12 litros diarios, asociado a alta ingesta de agua. Se solicitan exámenes, que muestran creatinina plasmática: 0,7 mg/dl, BUN: 12 mg/dl, sodio: 154 mEq/L, potasio: 4,5 mEq/L, glicemia de ayunas: 80 mg/dl y hemograma normal. ¿Cuál de las siguientes opciones explica sus alteraciones?

- a) Polidipsia psicógena
- b) Consumo de lamotrigina
- c) Consumo de litio
- d) Consumo de clorpromazina
- e) Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética

5) Un paciente de 53 años es hospitalizado por una reacción alérgica grave, recibiendo adrenalina e hidrocortisona endovenosa. Durante la hospitalización se realizan múltiples exámenes, entre los que destacan glicemias de ayuno muy elevadas, en rangos entre 160 y 180 mg/dl. ¿Qué examen es más adecuado para determinar la etiología de esta alteración?

- a) Péptido C
- b) Anticuerpos anti GAD
- c) Hemoglobina glicosilada
- d) Test de tolerancia a la glucosa oral
- e) Tomografía axial computada pancreática

6) Un paciente de 84 años es traído a urgencia por familiares. Refieren que sus síntomas iniciaron hace 7 días, consistentes en tos con expectoración purulenta, sensación febril y disnea de esfuerzos. En las últimas noches se ha levantado algo agitado y anoche estuvo muy agitado, gritando que habían entrado extraterrestres en su casa y que lo querían matar. Al examen físico, tiene T°: 37,9°C, PA: 154/100, FC: 88x', FR: 25x', satura: 93% a FiO2 ambiente, tiene examen pulmonar con crepitaciones en la base derecha y examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos sin soplos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Accidente vascular encefálico
- b) Delirium
- c) Epilepsia del lóbulo temporal
- d) Demencia tipo Alzheimer
- e) Esquizofrenia paranoide

7) Una paciente de 65 años, hipertenso y diabético de larga data, consulta por cefalea intensa de inicio súbito, asociado a dificultades para moverse. Al examen físico tiene una hemiparesia derecha, armónica, sin compromiso de conciencia y con conservación del lenguaje y la sensibilidad. No tiene alteraciones visuales. Como antecedente, ha sufrido golpes por caídas a repetición. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Accidente vascular encefálico por compromiso de la arteria cerebral media
- b) Accidente vascular encefálico por compromiso de la arteria cerebral anterior
- c) Hemorragia de la protuberancia anular o puente de Varolio
- d) Accidente vascular encefálico hemorrágico
- e) Accidente vascular de tipo lacunar

8) Un paciente de 69 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, consulta por dolor torácico intenso EVA 10/10, de carácter lancinante y que se irradia a cuello y dorso. A lo anterior se agregó dolor intenso en la extremidad superior izquierda. Al examen físico tiene FC: 120x', PA: 200/140 mmHg, ritmo regular en dos tiempos, sin soplos, murmullo pulmonar bilateral conservado, sin otros ruidos, extremidad superior izquierda con disminución del pulso radial y frialdad de la mano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Pericarditis aguda
- b) Disección aórtica
- c) Tromboembolismo pulmonar
- d) Infarto agudo al miocardio
- e) Embolias cardíacas

9) Una paciente de 20 años es encontrada inconsciente en el baño por sus familiares, con el piloto del calefont apagado, por lo que es llevada al servicio de urgencia de inmediato, recuperándose parcialmente en el camino. Al examen físico está consciente, responde al interrogatorio y coopera, aunque está soporosa y se queja de muchas náuseas y cefalea intensa. Satura 97% a FiO2 ambiental, tiene frecuencia cardíaca de 90x' y presión arterial 146/92 mmHg. Su examen cardiopulmonar resulta normal. Cuál es el examen de elección para

- a) Radiografía de tórax
- b) Resonancia magnética nuclear de cerebro
- c) Carboxihemoglobina
- d) Gases en sangre arterial
- e) TAC de cerebro sin contraste

10) Una niña de 13 años ha presentado diez episodios de angustia muy intensa, asociadas a sensación de muerte, disnea, vértigo, ganas de ir corriendo a su casa, temor a estar volviéndose loca y llanto descontrolado, todo lo que ha afectado seriamente su calidad de vida. Además. Sus padres han debido ir a buscarla en 3 oportunidades al colegio en las últimas dos semanas, debido a estos síntomas. No presenta síntomas depresivos, aunque su autoestima se ha visto mermada por la situación. Su examen físico es normal ¿Cuál es el tratamiento más importante para esta paciente?

- a) Sertralina
- b) Quetiapina
- c) Ácido valproico
- d) Alprazolam
- e) Diazepam

11) Un hombre de 59 años, fumador, presenta un accidente vascular encefálico, que se maneja rápidamente, por lo que se recupera sin dejar secuelas. Posteriormente, se realiza ecografía Doppler carotídea como estudio de fuente embólica, que no muestra alteraciones arteriales, pero sí identifica la presencia de un nódulo tiroideo de 1 cm de diámetro, de aspecto quístico, bien delimitado y capsulado. Se solicitan pruebas tiroideas que muestran TSH: 2,1 microU/ml (VN: 0,5 a 5,0) y T4 libre que resulta 1,2 ng/dl (VN: 0,9 a 2,2). ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto del nódulo tiroideo?

- a) Realizar punción con aguja fina
- b) Controlar en 6 meses con nueva ecografía
- c) Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
- d) Iniciar levotiroxina
- e) Realizar biopsia excisional quirúrgica

12) Una paciente, con antecedente de tiroidectomía total por cáncer de tiroides, con hipoparatiroidismo postquirúrgico, en tratamiento con levotiroxina 100 ug al día y con calcio 450 mg más vitamina D3 175 UI cada 8 horas, presenta diarrea acuosa, desde hace 4 días, a lo que se ha agregado astenia y debilidad, . Al examen físico se constatan signos vitales dentro del rango normal, examen cardiopulmonar normal, examen abdominal con abdomen blando, depresible, sensible a la palpación profunda, examen neurológico con signo de Chvostek y debilidad de las 4 extremidades, con reflejos osteotendíneos claros. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar calcio intravenoso
- b) Aumentar la dosis de levotiroxina
- c) Administrar suero fisiológico intravenoso
- d) Administrar suero Ringer lactato intravenoso
- e) Administrar bicarbonato de sodio endovenoso

13) Una paciente de 31 años, cursando un embarazo de 28 semanas, presenta síntomas de parto prematuro, por lo que se le deja licencia médica por 2 semanas. Está afiliada a una Isapre y a una Mutual. ¿Qué institución es la encargada del financiamiento de esta licencia?

- a) Fondo Nacional de Salud (Fonasa)
- b) Institución de Salud Previsional (Isapre)
- c) Caja de Compensación
- d) Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin)
- e) Fondo Único de Prestaciones Familiares, con cargo Estatal

14) Una paciente de 73 años, diabética e hipertensa, con insuficiencia renal crónica, en tratamiento con insulina NPH, losartán, amlodipino y atenolol, presenta malestar general, seguido de síncope en varias oportunidades en día de hoy, por lo que es llevada a la urgencia. Al examen físico tiene FC: 30x', PA: 70/36 mmHg, sopor profundo, sudoración, ausencia de signos focales. Se solicitan exámenes de laboratorio entre los que destaca Na+: 130 mEq/L, K+: 8,2 mEq/L, Cl-: 98 mEq/L, pH: 7,29, HCO3-: 18 mEq/L, glicemia capilar: 180 mg/dl. El resto de la analítica está pendiente. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Instalar marcapasos externo transitorio
- b) Administrar gluconato de calcio endovenoso
- c) Administrar atropina
- d) Hemodiálisis de urgencia
- e) Administrar suero fisiológico endovenosos

15) Un paciente de 56 años, diabético en tratamiento con metformina 500 mg/8horas, con hipertensión de reciente diagnóstico, se realiza exámenes de control, que muestran creatinina plasmática: 0,9 mg/dl, BUN: 18 mg/dl, electrolitos plasmáticos: Na+: 141 mEq/L y K+: 4,1 mEq/L, RAC (relación albuminuria / creatininuria): 2,6 y hemoglobina glicosilada: 6,9%. ¿Qué fármaco es el más adecuado para el tratamiento de su hipertensión arterial?

- a) Hidralacina
- b) Espironolactona
- c) Amlodipino
- d) Atenolol
- e) Valsartán

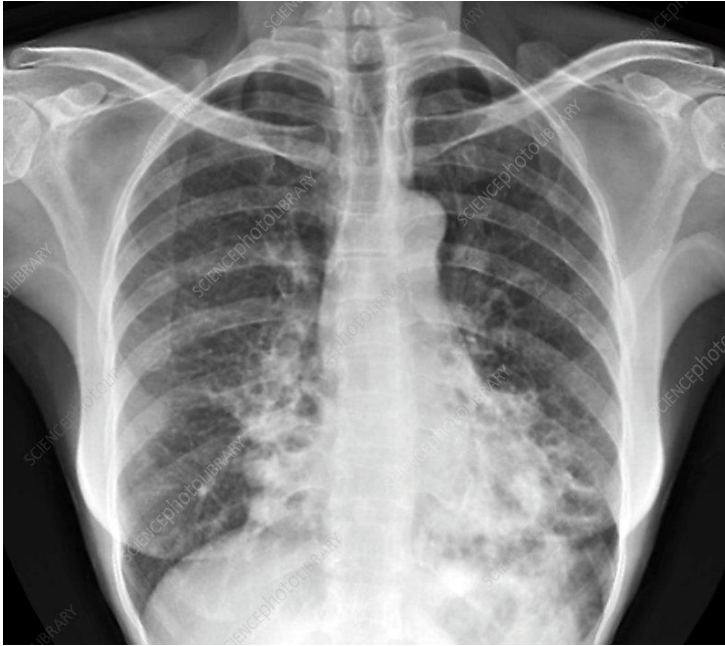
16) Una paciente de 68 años, con antecedente de hipertensión y cardiopatía hipertensiva, en tratamiento con losartán y clortalidona, que, además, tiene fibrilación auricular crónica, en tratamiento con amiodarona y rivaroxabán, consulta por un cuadro de disnea progresiva que se ha instalado en los últimos meses, que actualmente es de medianos esfuerzos y se asocia a tos seca, mayor en la noche. Al examen físico tiene pulso regular a 74x', PA: 130/80 mmHg, examen pulmonar con crepitaciones bilaterales, examen cardíaco: RR2T sin soplos, con abdomen y extremidades sin alteraciones. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia):



¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar salbutamol
- b) Agregar espironolactona
- c) Suspender el rivaroxabán
- d) Suspender la amiodarona
- e) Agregar furosemida

17) Una paciente de 45 años, con antecedente de infecciones respiratorias a repetición en la infancia, presenta broncorrea de cerca de 300cc al día, mayor en la mañana, asociada a disnea de esfuerzos y tos con expectoración. Además, refiere cuadros de exacerbación de sus síntomas que ocurren varias veces al año, por lo que usa antibióticos. Al examen físico tiene signos vitales dentro de rango normal y, en la auscultación pulmonar se objetiva espiración prolongada, además de auscultarse estertores y sibilancias bilaterales. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: www.sciencephoto.com):



¿Cuál es el examen de elección para proseguir con el diagnóstico?

- a) Recuento de inmunoglobulina A, G y M
- b) TAC de tórax
- c) Baciloscopías y cultivo para micobacterias
- d) Lavado bronquioalveolar
- e) Broncoscopía

18) Un hombre de 43 años consulta porque, desde hace 15 días, ha presentado angustia, desasosiego, insomnio y malestar general. Refiere, además, cefalea occipital, irradiada al cuello que es peor en las tardes. Refiere que los síntomas iniciaron después de que le comunicaron en su trabajo que sería trasladado a otra ciudad, por lo que deberá cambiarse de casa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno de somatización
- b) Trastorno de ansiedad generalizada
- c) Trastorno de adaptación
- d) Trastorno de angustia
- e) Episodio depresivo mayor

19) Un paciente de 48 años, que trabaja como operador de maquinaria de la minería, consulta por disnea de esfuerzo de 2 años de evolución, que ha progresado en el último tiempo, asociado a tos con expectoración mucosa ocasional. Al examen físico tiene PA: 108/72 mmHg, FC: 70x', aumento del diámetro anteroposterior del tórax, espiración prolongada y, a la auscultación pulmonar, se oyen sibilancias bilaterales. Se realiza espirometría que muestra lo siguiente:

	VEF1	CVF	VEF1/CVF
Basal	2.532 cc (59%)	4.870 cc (99%)	52%
Postbroncodilatador	2.659 cc (62%)	5.017 cc (102%)	53%

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- b) Asma bronquial
- c) Hipertensión pulmonar
- d) Insuficiencia cardíaca
- e) Fibrosis pulmonar

20) Un hombre de 33 años, sin antecedentes de importancia, despierta con hipoacusia del oído izquierdo, asociado a tinnitus, sin otros síntomas. No ha presentado vértigo y su otoscopia no muestra alteraciones. Su examen neurológico no aporta nueva información. ¿Cuál es el examen inicial para evaluar a este paciente?

- a) Impedanciometría
- b) TAC de oído
- c) TAC de cerebro
- d) Prueba calórica
- e) Audiometría

21) Una paciente de 35 años, con antecedente de 3 abscesos de Bartholino, que han requerido drenaje quirúrgico, consulta por dolor en la zona vulvar de dos días de evolución. Al examen ginecológico, se observa aumento de volumen de 3 cm, en relación al labio menor derecho, a tensión, que es doloroso a la palpación y no presenta signos inflamatorios. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Bartholinocistoneostomía
- b) Evacuación por punción
- c) Vaciamiento por incisión
- d) Antibióticos orales
- e) Baños de asiento y analgésicos

22) Una paciente de 32 años, se realiza citología cervical, que es informada como “presencia de células escamosas atípicas, sugerentes de NIE 3”. Se realiza colposcopia que no muestra lesiones y curetaje endocervical que es informado como “tejido endocervical normal”. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Repetir el curetaje endocervical
- b) Controlar con nuevo Papanicolau en un año
- c) Realizar histerectomía
- d) Realizar conización cervical
- e) Realizar legrado y biopsia endometrial

23) Una paciente de 24 años, usuaria de anticonceptivos orales, cuya última regla fue hace 8 días, consulta por dolor en la fosa ilíaca derecha, de inicio súbito, intenso, que se ha asociado a náuseas y vómitos alimentarios, en una oportunidad. Al examen físico, tiene FC: 88x', PA: 120/78 mmHg, examen abdominal con dolor a la palpación de la fosa ilíaca derecha y del hipogastrio. Al examen ginecológico, además, se palpa una masa anexial derecha de 6 cm. Se solicita ecografía transvaginal, que visualiza útero de tamaño y paredes normales, endometrio de 6 mm de diámetro, presencia de una lesión anexial derecha quística de 6 cm, sin líquido libre, además, no es posible visualizar el apéndice cecal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Absceso tubo ovárico
- b) Apendicitis aguda
- c) Quiste ovárico torcido
- d) Embarazo ectópico
- e) Vólvulo de ciego

24) Un niño de 3 años acude a control sano. Su madre refiere que tiene estrechez del prepucio y, al examen físico, se confirma que el prepucio es irreductible . ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Aplicar ungüento antibiótico
- b) Realizar tracción manual forzada del prepucio
- c) Realizar circuncisión
- d) Aplicar ungüento de corticoide tópico
- e) Controlar en un año

25) Un lactante de 1 mes de vida, acude a control. Al examen físico, presenta estrabismo intermitente y asimétrico de ambos ojos. El resto de la inspección ocular es normal. Su crecimiento pondoestatural es normal, al igual que su desarrollo psicomotor y el resto de su examen físico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Derivar a oftalmólogo
- b) Mantener los controles habituales del lactante
- c) Solicitar RMN de cerebro
- d) Realizar fondo de ojo
- e) Indicar parche ocular alternante

26) Usted evalúa a un recién nacido de término, que está en buenas condiciones, se alimenta con leche materna y tiene examen neurológico normal. Al examen físico segmentario no se palpa ninguno de los testículos en el escroto ni en la zona inguinal. Su pene mide 2 cm de largo. Además de solicitar una ecografía inguinal, la conducta más adecuada es:

- a) Controlar en un mes
- b) Solicitar niveles plasmáticos de testosterona
- c) Realizar exploración quirúrgica en este momento, mediante laparoscopia
- d) Solicitar cariograma
- e) Planificar cirugía de descenso testicular al cumplir un año

27) Un niño de 14 meses presenta fiebre hasta 38,6°C desde hace dos días. El examen físico no identifica un foco, por lo que se solicitan exámenes de orina, con muestra obtenida por recolector, que muestra sedimento con 10 glóbulos blancos por campo, 2 a 4 glóbulos rojos por campo, células epiteliales en regular cantidad, bacterias en moderada cantidad y citoquímico con nitritos negativos, ausencia de glucosuria y proteinuria, ausencia de cristales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar cintigrafía renal
- b) Solicitar ecografía renal y vesical
- c) Solicitar examen de orina por sondeo
- d) Iniciar cefadroxilo oral
- e) Iniciar ceftriaxona endovenosa

28) Un niño de 5 años presenta un cuadro de 7 días de fiebre, cefalea, rinorrea purulenta abundante, descarga posterior y obstrucción nasal. Desde hace poco se agrega mayor fiebre, además de edema y eritema periocular derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Absceso frontal
- b) Conjuntivitis bacteriana
- c) Sinusitis maxilar
- d) Absceso periorbitario
- e) Conjuntivitis viral

29) Una mujer de 24 años, parvularia, cursando embarazo de 18 semanas, estuvo en contacto con un niño, que fue recientemente diagnosticado de varicela. Ella refiere que nunca ha tenido varicela. No presenta síntomas ni alteraciones en su examen físico u obstétrico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar aciclovir a la madre
- b) Solicitar serología para la varicela a la madre
- c) Administrar gamaglobulina hiperinmune contra varicela a la madre
- d) Vacunar contra la varicela
- e) Observar evolución

30) Un paciente de 20 años, con diagnóstico de trastorno bipolar, en tratamiento con risperidona y litio, desde hace 3 meses, consulta por un cuadro de una semana de evolución de náuseas, malestar general y tendencia al sopor. Al examen físico se constata desorientado, con temblor de extremidades superiores. Se solicitan exámenes, entre los que destaca litemia de 2,2 mEq/L (rango normal: 0,6 a 1,2 mEq/L) y creatininemia: 1,3 mg/dl. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Plasmaféresis
- b) Hemodiálisis
- c) Alcalinizar la orina
- d) Administrar suero fisiológico endovenoso
- e) Diazepam endovenosa

31) Un paciente de 37 años es diagnosticado de hipertensión hace un año, en tratamiento con enalapril, atenolol e hidroclorotiazida, a pesar de lo cual ha presentado valores tensionales sobre el objetivo, con varias tomas sobre 160/110 mmHg. Además, aqueja astenia, debilidad de las extremidades inferiores y cefalea frecuente. Se solicitan exámenes generales, que muestran TSH: 6,0 UI/L, creatinina: 1,2 mg/dl, sodio: 142 mEq/L, potasio: 3,1 mEq/L, hemograma normal y glicemia de ayuno: 72 mg/dl. Se solicita TAC de abdomen, que muestra un tumor suprarrenal derecho, de 2 cm de diámetro, sólido y homogéneo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Feocromocitoma
- b) Hipertensión esencial
- c) Hipertensión renovascular
- d) Hipertensión asociada a insuficiencia renal
- e) Hiperaldosteronismo primario

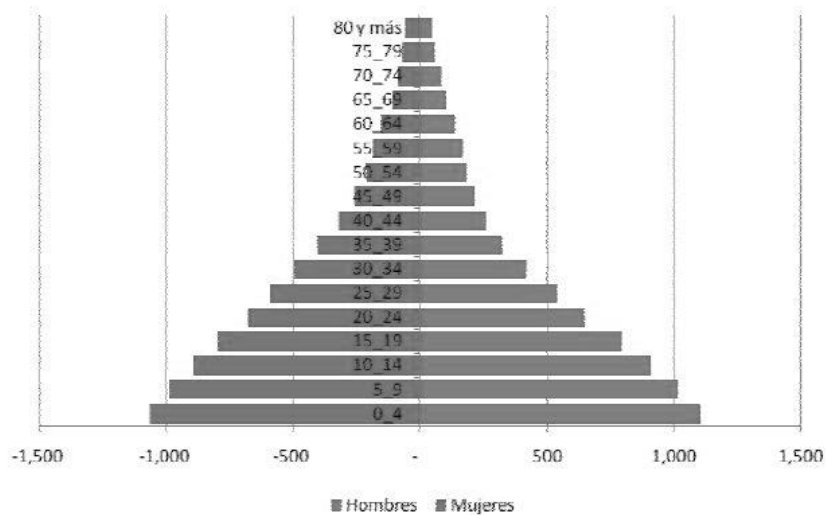
32) ¿Cuál de los siguientes indicadores es de elección para evaluar la efectividad de una campaña de vacunación contra la influenza?

- a) Mortalidad mensual por influenza
- b) Tasa de cobertura de vacunación
- c) Incidencia semanal por influenza
- d) Prevalencia de influenza
- e) Letalidad mensual de la influenza

33) Un paciente de 76 años, con antecedente de cáncer de próstata avanzado, presenta un cuadro de 2 días de evolución de debilidad y malestar general, al que se agrega obnubilación de conciencia y tendencia al sopor. Al examen físico se aprecia desorientado, con sopor profundo, sin focalidad neurológica, tiene FC: 80x', PA: 150/100 mmHg y FR: 16x'. El examen torácico y abdominal no aporta mayor información. Se solicitan electrolitos plasmáticos que muestran sodio: 148 mEq/L, potasio: 5 mEq/L, calcio: 14,8 mg/dl y otros exámenes de sangre que muestran creatinina: 1,4 mg/dl, GOT: 50 UI/l, 2, APE: 200 ng/ml. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Administrar calcitonina endovenosa
- b) Realizar hemodiálisis de urgencia
- c) Administrar ácido zolendrónico endovenoso
- d) Administrar gluconato de calcio endovenoso
- e) Administrar suero fisiológico endovenoso

34) Un país presenta la siguiente pirámide poblacional:



¿En qué tipo de medidas se deben focalizar las intervenciones de salud pública?

- a) Prevenir y tratar oportunamente el cáncer
- b) Prevención del consumo de drogas, cigarrillo y alcohol
- c) Planificación familiar, prevención de la desnutrición, saneamiento básico y vacunación
- d) Fomentar la actividad física y prevenir el sedentarismo y la obesidad
- e) Detección y tratamiento oportuno de enfermedades crónicas no transmisibles

35) Una paciente de 18 años, diabética tipo 1 en tratamiento con insulina glargina e insulina cristalina en esquema intensificado, consulta por un cuadro, que inició hace 2 meses, caracterizado por deposiciones líquidas frecuentes, sin mucosidad, asociadas a malestar abdominal y baja de peso de 4 kilogramos. Al examen físico, se aprecia pálida, tiene signos vitales normales y su abdomen es blando, depresible, sensible a la palpación profunda, sin irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes a la auscultación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Enfermedad celíaca
- b) Síndrome de intestino irritable, asociado a diarrea
- c) Enteropatía perdedora de proteínas
- d) Enfermedad inflamatoria intestinal
- e) Diarrea viral

36) Una paciente de 28 años, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta por dolor epigástrico y en hipocondrio derecho, de dos días de evolución, asociado a náuseas y malestar general. Al examen físico se ve decaída, con FC: 105x', PA: 148/99 mmHg, FR: 15x', examen abdominal con dolor a la palpación del epigastrio y el hipocondrio derecho, sin signos peritoneales. Se solicitan exámenes de sangre que muestran hematocrito: 32%, hemoglobina: 10,9 g/dl, blancos: 6.800 por mm³, plaquetas: 80.000 por mm³, bilirrubina plasmática: 2,0 mg/dl, con fracción indirecta: 1,6 mg/dl y fracción directa: 0,4% GOT: 320 UI/L, GPT: 240 UI/L. La ecografía abdominal muestra presencia de litiasis vesicular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Pancreatitis aguda
- b) Hepatitis viral
- c) Colecistitis aguda
- d) Colestasia intrahepática
- e) Síndrome de HELLP

37) Una paciente de 27 años consulta por deposiciones diarreicas de 3 semanas de evolución, asociadas a mucho pujo y tenesmo rectal. Refiere rectorragia ocasional escasa. Su examen físico muestra T°: 37°C, PA: 122/78 mmHg, FC: 72x', abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación hipogástrica y fosa iliaca izquierda. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

- a) Test de sangre oculta en deposiciones
- b) Parasitológico de deposiciones
- c) Colonoscopia
- d) Tomografía axial computada de abdomen y pelvis
- e) PCR para *Clostridioides difficile*

38) Un paciente de 58 años presenta dolor abdominal intenso, tipo cólico, asociado a náuseas y distensión abdominal. Sus últimas deposiciones fueron hace dos días y no ha eliminado gases por ano desde ayer. Sus signos vitales muestran T°: 36,8°C, FC: 96x', PA: 144/92 mmHg, abdomen distendido, doloroso a la palpación, con signo Blumberg esbozado. En la auscultación abdominal, tiene bazuqueo intestinal y disminución de los ruidos hidroaéreos. Como antecedentes médico-quirúrgicos, es diabético, usa metformina y aspirina y se realizó apendicectomía hace 10 años. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Vólvulo de sigmoides
- b) Isquemia mesentérica
- c) Gastroenteritis aguda
- d) Obstrucción intestinal
- e) Cáncer de colon perforado

39) Una paciente de 35 años consulta por metrorragia abundante de 6 horas de evolución. Al examen físico está orientada, sudorosa, tiene presión arterial: 88/58 mmHg, frecuencia cardíaca: 120x', se observa pálida y tiene frialdad de extremidades. En el examen ginecológico, se realiza especuloscopia que objetiva que la sangre proviene del orificio cervical externo y se palpa útero grávido. Se solicitan exámenes, entre los que destaca beta-HCG, que resulta positiva y análisis hematológico, que muestra anemia con hemoglobina de 10 g/dl. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra contenido endometrial de 19mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo?

- a) Histerectomía
- b) Vaciamiento uterino
- c) Ácido tranexámico intravenosa
- d) Oxitocina intravenosa
- e) Misoprostol intrarrectal

40) Una paciente de 45 años consulta por dolores articulares en muñecas, articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales de ambas manos, asociado a dolor en el codo

derecho y la rodilla izquierda. Además, se queja de rigidez matinal, que dura cerca de 4 horas. Al examen físico se aprecia aumento de volumen, eritema y aumento de la temperatura local de varias de las articulaciones descritas. ¿Cuál es el examen más específico para el diagnóstico de esta patología?

- a) Anticuerpos anti DNA nativo
- b) Anticuerpos anti citoplasma de neutrófilos
- c) Anticuerpos antinucleares
- d) Anticuerpos anti-CCP
- e) HLA B27

41) Una paciente de 62 años sufre una caída a nivel, sufriendo una fractura del extremo distal del radio izquierdo, la que es manejada ortopédicamente, con un yeso braquiopalmar. A las 5 horas, evoluciona con intenso dolor, EVA 10/10, que no responde a la analgesia y se asocia a dificultades para mover los dedos. Al examen físico, se objetivan dedos con llene capilar enlentecido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome de dolor locorregional complejo
- b) Lesión de la arteria radial
- c) Trombosis venosa profunda
- d) Compresión del nervio mediano
- e) Síndrome compartimental

42) Un paciente de 70 años ha presentado 3 episodios de dolor y aumento de volumen de la rodilla derecha, que le impide o dificulta la marcha, pero que ha respondido a analgésicos. Acude nuevamente por los mismos síntomas, objetivándose artritis de rodilla derecha, con signos de derrame articular, por lo que se punciona, dando salida a un líquido articular inflamatorio, con abundantes cristales de pirofosfato de calcio, sin bacterias. ¿Qué fármaco es más adecuado para evitar recurrencias?

- a) Colchicina
- b) Naproxeno
- c) Alopurinol
- d) Hidroclorotiazida
- e) Metotrexato

43) Un paciente de 78 años, consulta por lumbago de un mes de evolución, progresivo e intenso, que no ha respondido bien a analgésicos. En su examen físico se observa con IMC: 20, FC: 75x'. PA: 126/86 mmHg, cabeza y cuello sin alteraciones, cardiopulmonar normal y examen lumbar con limitación de los movimientos, por dolor. Trae exámenes, que muestran hemograma con hematocrito: 30%, hemoglobina: 10,5 g/dl, plaquetas: 88.000 por mm³, glóbulos blancos: 4.300 por mm³, con fórmula diferencial normal, VHS: 78 mm/h, creatinina: 2,2 mg/dl, natremia: 135 mEq/, potasemia: calcemia 10,5 mg/dl, proteínas totales: 8,9 g/dl, albúmina: 2,9 g/dl. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?

- a) Electroforesis de proteínas en sangre
- b) Densitometría ósea
- c) Radiografía de huesos largos y cráneo
- d) Estudio citogenético de médula ósea
- e) Niveles plasmáticos de vitamina B12

44) Un paciente de 70 años, desde hace 2 semanas ha presentado marcado malestar general y astenia, notando aparición de equimosis en las piernas. En su examen físico, se aprecia pálido, con petequias generalizadas y equimosis. Además, se palpan adenopatías en cuello e ingle. Se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 8,1 g/dl, hematocrito: 24%, glóbulos blancos: 45.000 por mm³, con 60% de blastos linfoides. Su otros exámenes muestran glicemia: 160 mg/dl, Na⁺: 136 mEq/L, K⁺: 6,3 mEq/L, ácido úrico: 12,2 mg/dl, fósforo: 7,1 mg/dl, creatinina: 1,3 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Imipenem
- b) Heparina
- c) Hidrocortisona
- d) Sulfonato de poliestireno
- e) Quimioterapia

45) Un recién nacido, presenta un cefalohematoma de gran tamaño, al momento de nacer. Además, presenta hematoma del sitio de punción de la muestra venosa. Sus padres son asintomáticos, pero uno de sus tíos murió en el periodo neonatal por hemorragia intracraneal. Entre sus exámenes, destaca TP: 70%, TTPA: 65 segundos, hemograma con hematocrito 50%, blancos: 8.400 por mm³ y plaquetas: 350.000 por mm³. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

- a) Agregometría plaquetaria
- b) Factores de coagulación VIII y IX
- c) Estudio de trombofilia
- d) Biopsia de médula ósea
- e) Frotis de sangre periférica

46) Un lactante de 15 meses fue sano hasta los 6 meses de edad, pero, después de ello, ha presentado candidiasis oral a repetición, cuatro otitis medias aguda y dos neumonías que han requerido hospitalización. ¿Cuál es la causa más probable de su inmunodepresión?

- a) Inmunodeficiencia humoral
- b) Inmunodeficiencia combinada severa
- c) Alteración de la fagocitosis
- d) Déficit de complemento
- e) Inmunodeficiencia celular

47) Una paciente de 63 años presenta dolor en articulaciones de las manos, mayores en las articulaciones interfalángicas distales y proximales, asociadas a rigidez matinal de 5 minutos. Además, refiere dificultades para las actividades que requieren mayor prensión de las manos. Se realiza radiografía de manos, que muestra disminución del espacio articular, con esclerosis subcondral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Artritis reumatoide
- b) Artritis psoriática
- c) Osteoartritis
- d) Osteoporosis
- e) Artritis reactiva

48) Una paciente de 72 años presenta aumento de volumen, en relación a la cara interna del muslo derecho, que aumentado de tamaño en los últimos meses. Al examen físico, se aprecia una

tumoración de 10 cm de diámetro, de consistencia similar al músculo. Se realiza ecografía, que muestra un tumor sólido de 12 cm, en relación al músculo recto femoral derecho. ¿Cuál es el examen más adecuada para proseguir con el estudio de este paciente?

- a) Radiografía de fémur
- b) PET scan
- c) Hemograma y biopsia de médula ósea
- d) Tomografía axial computada de muslo
- e) Resonancia magnética nuclear de muslo

49) Un paciente de 17 años consulta por un cuadro que inició hace 12 días, consistente en congestión nasal, rinorrea mucosa abundante y odinofagia. En los últimos días la rinorrea se vuelve purulenta y empeoran los síntomas, agregándose sensación febril y tos seca mayor en las noches. En el examen físico se constata fiebre de 38,2°C, FC: 78x', FR: 12x', se observa faringe eritematosa, con descarga posterior y se observa rinorrea purulenta en ambas fosas nasales. Su examen cardiopulmonar es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Amoxicilina oral por 7 días
- b) Claritromicina oral por 10 días
- c) Aseo con suero fisiológico
- d) Corticoides orales por 7 días
- e) Antihistamínicos orales por 7 días

50) Un niño de 3 meses de edad acude a control de niño sano, con una radiografía anteroposterior de pelvis, que muestra ángulo acetabular de 28° a derecha y 26° a izquierda. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Correas de Pavlik
- b) Derivar a traumatología
- c) Usar doble pañal
- d) Mantener el control habitual
- e) Solicitar ecografía de caderas

51) Una paciente de 65 años, con IMC: 34, consulta por dolor progresivo, de una semana de evolución, en la cara lateral de la cadera, que aumenta con la caminata y limita sus movimientos. Además, en el último tiempo, el dolor le impide dormir para ese lado. Al examen físico tiene dolor a la palpación de la cara externa de la cadera y a la rotación externa forzada. El diagnóstico más probable es:

- a) Coxartrosis
- b) Fractura incompleta de cadera por estrés
- c) Hernia del núcleo pulposo, con radiculopatía L2
- d) Bursitis trocantérica
- e) Síndrome de la fascia lata rígida

52) Una lactante de 6 meses, presenta eritema del pañal, desde hace 7 días, que no ha mejorado a pesar de realizar cambios frecuentes del pañal y de aplicar óxido de zinc. Usa pañal desechable

y se alimenta con lactancia materna exclusiva. Al examen físico, se aprecia lo siguiente (fuente: <https://idermumbert.com/dermatologia>):



¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a) Mupirocina tópica
- b) Betametasona tópica
- c) Vaselina tópica
- d) Clotrimazol tópico
- e) Pimetacrolimus tópico

53) Un paciente de 83 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer, institucionalizado, presenta lesiones en las piernas, de 4 meses de evolución, que se muestran a continuación (www.mdsaude.com):

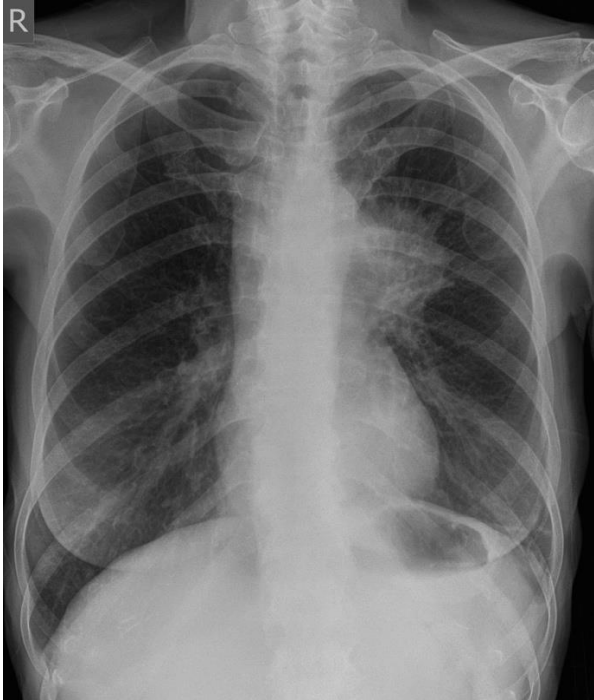


¿Cuál es el la conducta más adecuada?

- a) Mupirocina tópica
- b) Flucloxacilina oral
- c) Vendas elásticas
- d) Biopsiar las lesiones
- e) Vaselina más betametasona tópica

54) Una paciente de 63 años, con antecedente de diabetes e hipertensión mal controladas, fumadora de 40 paquetes años y alcohólica activa, consulta por dolor torácico izquierdo, que aumenta con los movimientos respiratorios, asociado a tos con expectoración mucosa, que, en

ocasiones es hemoptoica. Ha bajado de peso y refiere disnea de esfuerzos desde hace algunos meses. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca: 65x', PA: 150/98 mmHg, saturación de oxígeno por pulsometría: 95% a FiO2 ambiental, examen pulmonar con murmullo vesicular simétrico, con escasos crépitos a izquierda y, además, refiere dolor a la palpación de quinto arco costal izquierdo. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia):



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Absceso pulmonar
- b) Neumonía neumocócica
- c) Tuberculosis pulmonar
- d) Disección aórtica
- e) Cáncer pulmonar

55) Un paciente de 80 años, con antecedente de cáncer de próstata avanzado, en tratamiento con hormonoterapia, presenta deterioro súbito del estado respiratorio, evolucionando con taquicardia y desaturación arterial. Se solicita angioTAC, que demuestra un tromboembolismo pulmonar derecho, por lo que se inicia terapia anticoagulante, sin embargo, evoluciona en malas condiciones generales, cayendo en insuficiencia respiratoria, colapso circulatorio y, finalmente, ausencia de pulso y respiración, por lo que se realiza reanimación avanzada, con múltiples desfibrilaciones y adrenalina, sin respuesta, por lo que se declara la muerte. ¿Cuál de las siguientes debe ser la causa de muerte inmediata en el certificado de defunción?

- a) Cáncer de próstata
- b) Insuficiencia respiratoria aguda
- c) Tromboembolismo pulmonar
- d) Falla multiorgánica
- e) Fibrilación ventricular

56) Una paciente de 27 años consulta por dolor abdominal de 5 días de evolución, asociado a malestar general, astenia y náuseas, a lo que recientemente se agrega ictericia. Al examen físico,

destaca ictericia de escleras, pulso regular a 76x', PA: 110/70 mmHg, abdomen blando, depresible, pero con dolor a la palpación del epigastro e hipocondrio derecho, sin visceromegalia ni signos peritoneales. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran tiempo de protrombinemia: 70%, SGOT: 512 UI/L, SGPT: 356 UI/L, FA: 230 UI/l, GGT: 120 UI/L, albúmina: 3,8 g/dl, bilirrubina total: 4 mg/dl, con 35% de bilirrubina directa. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

- a) Ecografía abdominal
- b) TAC abdominal
- c) Endoscopia digestiva alta
- d) Colangiopancreatografía por resonancia magnética nuclear
- e) Serología para virus hepatitis

57) Un paciente de 80 años presenta una clínica de 3 semanas de evolución de astenia, prurito e ictericia, asociada a malestar epigástrico. Además, refiere que ha bajado de peso en los últimos meses. Su examen físico muestra ictericia de piel y escleras, IMC: 19, signos vitales dentro de límites normales y examen abdominal que no aporta mayor información. Se solicitan exámenes que muestran bilirrubina plasmática: 12,4 mg/dl, con bilirrubina directa: 7,7 mg/dl, GOT: 120 UI/L, GPT: 89 UI/L, fosfatasas alcalinas: 870 UI/L y GGT: 688 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Coledocolitiasis
- b) Cáncer ampular
- c) Cáncer de páncreas
- d) Colangiocarcinoma
- e) Colangitis aguda

58) Un paciente de 56 años es encontrado inconsciente en la vía pública, con hálito alcohólico, con varios golpes. Se hospitaliza para manejo de sus lesiones, sin embargo, a las 48 horas presenta gran agitación, diciendo que lo tienen encerrado en la cárcel y no lo dejan escapar. Se observa desorientado, tembloroso y no coopera con el interrogatorio. ¿Cuál es el fármaco de elección para su manejo?

- a) Tiamina
- b) Haloperidol
- c) Lorazepam
- d) Clorpromazina
- e) Risperidona

59) Un paciente de 82 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina y dieta, acude a control, con glicemia de ayuno de 355 mg/dl, hemoglobina glicosilada de 9,5%. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de su diabetes?

- a) Agregar glibenclamida
- b) Agregar sitagliptina
- c) Iniciar insulina NPH
- d) Iniciar insulina glargina
- e) Iniciar liraglutide

60) Un recién nacido de término, con antecedente de madre con preclamsia, pesa 2.600 gramos al nacer. ¿Cuál es la complicación más frecuente durante las primeras horas de vida?

- a) Hipoglicemia
- b) Sepsis

- c) Hiperbilirrubinemia
- d) Anemia
- e) Distrés respiratorio

61) Una paciente de 26 años, cursando un embarazo de 41 semanas, inicia trabajo de parto. Al examen tienen 4 contracciones cada 10 minutos, dilatación cervical de 6 cm El registro fetal muestra desaceleraciones variables. Al romperse las membranas sale meconio espeso. El nacimiento se produce algunos minutos después, obteniéndose un recién nacido hiporreactivo e hipotónico. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Poner bajo calor radiante, administrar oxígeno, secar y reevaluar en 30 segundos
- b) Realizar intubación orotraqueal y aspirar la vía aérea
- c) Realizar ventilación a presión positiva
- d) Realizar compresiones torácicas
- e) Aspirar el contenido gástrico

62) Una niña de 6 años, desde hace dos horas presenta edema de los labios, más aparición de múltiples lesiones habonosas y pseudopapulares generalizadas. Además, presenta dolor abdominal persistente y náuseas. ¿Cuál es el fármaco que debe recibir inmediatamente?

- a) Prednisona
- b) Clorfenamina
- c) Gluconato de calcio
- d) Salbutamol
- e) Adrenalina

63) ¿Cuál de los siguientes indicadores es una variable de la demografía dinámica?

- a) Tasa de fecundidad
- b) Índice de población urbana / rural
- c) Tasa de masculinidad
- d) Distribución etárea
- e) Tasa de mortalidad infantil

64) Un paciente de 15 años sufre una torsión de rodilla derecha, siendo diagnosticado de un esguince, por lo que se indica inmovilizador de rodilla. Sin embargo, no mejora luego de 10 días, sino que, por el contrario, el dolor ha ido en aumento y no responde bien a la analgesia con naproxeno y ketorolaco. Al examen físico, presenta dolor a los movimientos de flexoextensión de la rodilla y a la palpación en la zona proximal y medial de la tibia derecha, sin signo de bostezo al varo ni al valgo. Se solicita una radiografía de rodilla, que muestra aspecto heterogéneo de la tibia proximal, con reacción perióstica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Osteosarcoma
- b) Fractura
- c) Osteomielitis
- d) Esguince severo de rodilla
- e) Hematoma en organización

65) Un niño de 6 años fue operado de un tumor cerebral hace 7 días. Desde entonces ha presentado volúmenes urinarios aumentados, de 4,5 litros al día. Se solicitan exámenes de sangre, que muestran glicemia de ayuno: 103 mg/dl, Na+: 154 mEq/L, K+: 4,9 mEq/L. Orina con sedimento

normal, densidad 1.005 g/L y osmolaridad urinaria: 100 mOsm/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome perdedor de sal cerebral
- b) Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética
- c) Insuficiencia suprarrenal
- d) Diabetes insípida
- e) Diabetes mellitus

66) Una niña de 2 años comienza con estrabismo, con desviación hacia lateral del ojo izquierdo. A la inspección ocular, se observa leucocoria izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Retinoblastoma
- b) Glaucoma congénito
- c) Catarata congénita
- d) Retinopatía del prematuro
- e) Tumor de órbita

67) Un paciente de 66 años, diabético e hipertenso, con antecedente de un infarto agudo al miocardio, hace 1 año, se realiza perfil lipídico, que muestra triglicéridos: 325 mg/dl, colesterol LDL: 125 mg/dl, colesterol HDL: 30, colesterol total: 220 mg/dl. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el manejo de su dislipidemia?

- a) Atorvastatina 40 mg/día
- b) Fenofibrato 160 mg/día
- c) Gemfibrozilo 600 mg cada 12 horas
- d) Aporte de ácidos grasos omega 3
- e) Rosuvastatina 10 mg/día

68) Un paciente de 67 años, diabético, hipertenso y dislipidémico, fumador activo, consulta en el servicio de urgencia por dolor torácico opresivo e intenso, de 2 horas de evolución, irradiado al hombro derecho y asociado a disnea. Mientras estaba en la sala de reanimación presenta pérdida de conciencia y usted constata que no se mueve, no respira y no tiene pulso. Además de pedir ayuda y activar el código de paro, ¿cuál es la conducta inmediata?

- a) Instalar el monitor cardíaco en modo paletas
- b) Realizar intubación orotraqueal
- c) Solicitar electrocardiograma
- d) Realizar compresiones torácicas
- e) Administrar adrenalina endovenosa en bolo

69) Un paciente de 67 años, cirrótico por consumo de alcohol, es traído por sus familiares, ya que ha presentado deterioro de su estado general y compromiso de conciencia. Al examen físico está en sopor superficial, tiene fétor hepático, y sus signos vitales muestran T°: 38,3°C, FC: 85x'. PA:

130/85 mmHg. El examen abdominal muestra ascitis a tensión. Presenta asterixis, sin focalidad neurológica. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar su estudio?

- a) Hemocultivos
- b) Hemograma
- c) Estudio de líquido ascítico
- d) Tomografía axial computarizada de abdomen
- e) Ecografía abdominal

70) Un paciente de 36 años consulta por sensación de opresión precordial y tos, que son más intensas en la noche. Además, refiere disfonía y rinorrea, que se exacerbó durante la primavera. El examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar omeprazol oral
- b) Iniciar antihistamínicos orales
- c) Iniciar corticoides orales
- d) Iniciar antibióticos orales
- e) Iniciar AINEs orales

71) Una paciente de 65 años, con antecedente de haber sido tratada de una úlcera duodenal hace 20 años, y de un infarto agudo al miocardio hace un año, utilizando aspirina 100 mg al día desde entonces, sufre un esguince de tobillo, por lo que se indica analgesia con diclofenco 100 mg cada 12 horas. En los días siguientes evoluciona con malestar general que va agravándose y se agrega disnea. Al examen físico presenta palidez mucocutánea, FC: 110x', PA: 110/66 mmHg, examen pulmonar normal y examen cardíaco que solo muestra taquicardia. Se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 7,5 g/dl, hematocrito: 23% VCM: 58 ft, plaquetas: 370.000 por mm³, ferritina: 12 ng/ml. El electrocardiograma muestra una taquicardia sinusal, sin signos actuales de isquemia. ¿Cuál es el examen para proseguir el estudio etiológico?

- a) Prueba de antígeno en deposiciones para Helicobacter pylori
- b) Niveles de vitamina B12
- c) Biopsia de médula ósea
- d) Endoscopía digestiva alta
- e) Test de sangre oculta en deposiciones

72) Un paciente de 45 años, presenta polidipsia y poliuria de 4 semanas de evolución, asociado a baja de peso de 4 kilogramos en un mes. Al examen físico, se observa obeso con IMC: 35 y con presencia de acantosis nigricans en el cuello, sin otras alteraciones. Se solicita glicemia de ayuno, que resulta 318 mg/dl.

- a) Iniciar dieta y metformina
- b) Iniciar dieta y controlar
- c) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
- d) Repetir la glicemia de ayuno
- e) Iniciar insulina

73) Una pareja consulta porque hace un año tuvieron una interrupción de un embarazo, debido a que el feto tenía anencefalia. Desde entonces ella ha tomado anticonceptivos, sin embargo, ahora quieren intentar un nuevo embarazo.. Él tiene 38 años y ella 35. Como antecedente ella tiene

diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, sin tratamiento y él tiene un hermano con trisomía 21. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar cariógrama a ambos
- b) Iniciar levotiroxina a la mujer
- c) Solicitar espermiograma al hombre
- d) Iniciar ácido fólico 4 mg al día desde 3 meses antes al embarazo a la mujer
- e) Solicitar anticuerpos antifosfolípido a la mujer

74) Un paciente de 69 años, con daño hepático crónico, por consumo de alcohol, score de Child Pugh B, acude a control. Al examen físico tiene ascitis moderada, ictericia de piel y mucosas, sin encefalopatía. Sus pruebas hepáticas muestran bilirrubina: 3,1 mg/dl, SGOT: 50 UI/L, SGPT: 39 UI/L, albúmina: 3,0 g/dl, FA: 110 UI/L. Se solicita una ecografía abdominal que, además de la ascitis, muestra dos lesiones hepáticas hipoecogénicas de 2,2 cm y 1,6 cm, respectivamente. En una imagen anterior, realizada hace 6 meses, se veían las mismas lesiones, pero de menor tamaño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Nódulos de regeneración
- b) Adenomas hepáticos
- c) Hemangiomas hepáticos
- d) Hepatocarcinomas
- e) Quistes simples hepáticos

75) Una paciente de 73 años presenta dolor abdominal moderado, en hipogastrio y fosa ilíaca izquierda, de 3 meses de evolución, sin otros síntomas. Al examen físico, se palpa una masa en la fosa ilíaca izquierda y, al examen ginecológico, se palpa confirma la masa anexial izquierda, de consistencia dura y 8 cm de diámetro. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

- a) Ecografía abdominal
- b) Ecografía transvaginal
- c) Resonancia magnética de abdomen y pelvis
- d) TAC de abdomen y pelvis
- e) Histerosonografía

76) Una mujer de 17 años, presenta súbitamente desviación de la cabeza hacia la derecha, cayendo al suelo. Su madre presenció el hecho y observó que mantuvo mirada conjugada hacia derecha, tras lo cual presentó hipertonía de todo el cuerpo, seguido de movimientos rítmicos de las 4 extremidades. Se recupera somnolienta y adolorida, con signos de haberse mordido la lengua, con impresión de la arcada dentaria en zona lateral de la lengua. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Crisis convulsiva primariamente generalizada
- b) Crisis focal secundariamente generalizado
- c) Síncope vasovagal
- d) Trastorno conversivo
- e) Trastorno facticio

77) Una paciente se pone un piercing en la oreja, sin embargo evoluciona con dolor y eritema, por lo que se la retira. Al sacar el piercing no ha mejorado y, en cambio, el pabellón auricular se observa eritematoso y aumentado de volumen, como se ve en la siguiente imagen (fuente:):



¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) *Streptococcus pyogenes*
- b) *Staphylococcus aureus*
- c) *Streptococcus agalactiae*
- d) *Staphylococcus epidermidis*
- e) *Pseudomonas aeruginosa*

78) Un paciente de 35 años presenta un golpe en la cabeza, debido a una caída a nivel, hace un mes. Desde entonces ha presentado reiterados episodios de vértigo intenso, de segundos de duración, que aparece con algunos movimientos de la cabeza. No tiene síntomas auditivos y su examen neurológico muestra movilidad coordinada y conservada, sin alteraciones de la marcha ni del examen de pares craneanos. Los síntomas se reproducen con las maniobras de Dix-Hallpike.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Difendol 25 mg al día por 7 días
- b) Betahistina 8 mg cada 12 horas por 1 mes
- c) Solicitar prueba calórica
- d) Solicitar resonancia magnética nuclear de troncoencéfalo y cerebro
- e) Realizar maniobras de reposición vestibular

79) Un paciente de 67 años diabético, dislipidémico e hipertenso, consulta por dolor en ambas pantorrillas, que aparece al caminar dos cuerdas, impidiéndole seguir caminando. Además, refiere dolor urente de extremidades inferiores y, al examen físico, tiene disminución de la sensibilidad

táctil y termalgésica de los pies, con disminución de los reflejos rotulianos y abolición de los reflejos. ¿Cuál es el examen más adecuada para confirmar el diagnóstico?

- a) Ecografía Doppler de extremidades inferiores
- b) Electromiografía de extremidades inferiores
- c) Niveles plasmáticos de B12
- d) Resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra
- e) Resonancia magnética nuclear de cerebro y médula

80) Un paciente de 37 años presenta dolor en el lado derecho de la cabeza, desde hace 2 días. El día de hoy aparecen lesiones en la piel, que se muestran a continuación:



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Aciclovir 400 mg cada 6 horas, vía oral por 7 días
- b) Fluloxacilina 500 mg cada 8 horas, vía oral por 7 días
- c) Prednisona 40 mg al día, vía oral por 7 días
- d) Mupirocina en crema al 1%, aplicar cada 8 horas, por 7 días
- e) Valaciclovir 1 gramo vía oral cada 8 horas, por 7 días

81) Una mujer de 32 años, con antecedente de parto hace 8 meses, sigue dando lactancia materna a su hijo y se ha mantenido en amenorrea. No quiere embarazarse todavía, por lo que pregunta cuál es el método anticonceptivo de elección:

- a) Amenorrea de la lactancia
- b) Anticonceptivos orales combinados de etinilestradiol y dienogest
- c) Anticonceptivos en parches de norelgestromina y etinilestradiol
- d) Anticonceptivos inyectables de medroxiprogesterona y estradiol
- e) Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel

82) Una paciente de 20 años, nuligesta, presentó relaciones sexuales sin protección hace 72 horas. Consulta porque quiere contracepción de emergencia. ¿Cuál es la más efectiva?

- a) Levonorgestrel 0,75 mg por una vez
- b) Levonorgestrel 0,75 mg ahora y 0,75 mg en 12 horas

- c) Método Yuzpe
- d) Anillo vaginal
- e) T de cobre

83) Una mujer de 52 consulta por molestias en la mama izquierda de 4 meses de evolución, caracterizados por eritema y prurito en el pezón y laaréola. Al examen físico se ve lo siguiente (Nota: aréola y pezón están eritematosos):



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Enfermedad de Paget de la mama
- b) Mastitis candidiásica
- c) Cáncer inflamatorio de la mama
- d) Papiloma del pezón
- e) Eccema del pezón

84) ¿En cuál de los siguientes casos se debe indicar una licencia médica tipo 1, por enfermedad o accidente común?

- a) Lumbago mecánica en trabajador de la construcción
- b) Invalidez por accidente vascular encefálico
- c) Fractura de rodilla en trayecto en bicicleta del trabajo a la casa
- d) Amigdalitis bacteriana
- e) Hospitalización por preclamsia a las 30 semanas

85) Una paciente de 45 años, obesa y fumadora consulta por parestesias progresivas en la mano derecha, que la despiertan en la noche, por lo que debe sacudir las manos para que disminuyan y desaparecen cuando frota una mano contra la otra. Refiere, además, dificultades para las actividades en las que requiere fuerza de puño, como amasar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Tumor de Pancoast
- b) Síndrome del túnel carpiano
- c) Enfermedad de Dupuytren
- d) Hernia del núcleo pulposo cervical
- e) Lesión del nervio radial

86) Un paciente de 70 años consulta por aparición de una lesión pruriginosa en el párpado inferior izquierdo, que comenzó como un pequeño nódulo hace un año y que ha crecido al tamaño que se observa en la siguiente imagen (Fuente: <https://hospitaluvrocio.es/>):



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Orzuelo
- b) Chalazión
- c) Melanoma
- d) Carcinoma basocelular
- e) Conjuntivitis bacteriana crónica

87) Se calcula el número de casos nuevos de un determinado cáncer en una población, durante un periodo de tiempo y se relaciona con las personas susceptibles de enfermarse de dicha enfermedad al inicio del seguimiento. ¿A qué concepto corresponde esta descripción?

- a) Incidencia acumulada
- b) Tasa de ataque
- c) Tasa de incidencia
- d) Tasa de prevalencia
- e) Tasa de letalidad

88) Una mujer de 25 años, quien mantuvo relaciones sexuales sin protección hace 3 semanas, consulta porque notó aparición de una lesión genital, que se observa como una úlcera en la horquilla vulvar. Además, se palpa una adenopatía inguinal izquierda. No ha tenido otros síntomas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Tratarla con penicilina benzatina
- b) Solicitar PCR para virus herpes simplex

- c) Tratar con fluconazol oral
- d) Tratar con aciclovir
- e) Tratar con doxicilina

89) Una paciente de 24 años, primigesta de 12 semanas, consulta porque presenta náuseas y vómitos que afectan significativamente su calidad vida. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más adecuado para el manejo inicial de esta paciente?

- a) Corticoides orales
- b) Omeprazol oral
- c) Doxilamina más piridoxina oral
- d) metoclopramida oral
- e) Ondasentrón oral

90) Un paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial e hipotiroidismo, en tratamiento con enalapril y levotiroxina, consulta por dolor torácico intenso, que inició hace 22 horas, inicialmente con EVA 9/10, que se irradiaba al dorso y posteriormente al abdomen. Tomó analgésicos y el dolor disminuyó de intensidad, sin embargo, persiste 5/10, por lo que decidió consultar. Al examen físico, tiene FC: 98x', PA: 170/112 mmHg, pulsos de extremidades superiores conservados y disminución de los pulsos de las extremidades inferiores; examen cardíaco muestra ritmo regular en dos tiempos, sin soplos y examen pulmonar con murmullo vesicular presenta y simétrico, sin ruidos agregados. Se solicita electrocardiograma que muestra una taquicardia sinusal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

- a) Ecocardiograma transtorácico
- b) Angiografía coronaria
- c) AngioTAC de tórax y abdomen
- d) Radiografía de tórax
- e) Troponinas plasmáticas

1. _Un paciente de 50 años, con antecedente de infección de VIH, consulta por una lesión perianal, de larga data, sin tendencia a la cicatrización. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada, de consistencia aumentada, de 4 cm de diámetro, bordes cartográficos y que se introduce por el ano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
 - a) Sífilis
 - b) Enfermedad de Cröhn
 - c) Carcinoma epidermoide x
 - d) Melanoma
 - e) Tuberculosis
2. Un niño es diagnosticado de displasia de cadera a los 6 meses de vida, mediante una radiografía, que muestra la displasia, con luxación del extremo proximal del fémur izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento de elección?
 - a) Doble pañal
 - b) Correas de Pavlik x
 - c) Yeso con fijador
 - d) Osteotomía periacetabular tipo Ganz;
 - e) Reducción abierta y fijación con osteosíntesis no
3. Un paciente de 33 años, consulta por palpitaciones, diaforesis de dos semanas de evolución asociado a sensación febril. Al examen físico destaca glándula tiroides aumentada de volumen dolorosa a la palpación, frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto y presión arterial de 120/80 mm Hg. Se solicitan exámenes que muestran TSH: 0,2 UI/L, T4L: 1,9 ng/mL. ¿Cuál es el tratamiento de elección en esta paciente?
 - a) Propiltiouracilo x
 - b) Diclofenaco
 - c) Prednisona
 - d) Levotiroxina
 - e) Yodo radioactivo
4. Se busca la asociación entre distintos parámetros con el cáncer de tiroides, en un estudio de caso – control, con el Odds Ratio (OR), más un intervalo de confianza (IC) al 95%. ¿Qué factor es más importante en esta asociación?
 - a) Antecedentes familiares: OR: 1,88 ; IC [0,56 – 4,01]
 - b) Edad: OR: 2,6 ; IC [0,95 – 3,17]
 - c) Sexo masculino: OR: 0,56 ; IC [0,33 – 0,87]
 - d) Exposición a radiación: OR: 1,52 ; IC [0,91 – 2,01]
 - e) Tiroiditis de Hashimoto: OR: 4,6 ; IC [0,7 – 6,2] 72) x
5. Paciente acude a consulta por insistencia de su esposa quien refiere que tiene problemas para tener erecciones al momento de su intimidad salvo los momentos en que ella usa zapatos de charol rojo, interrogando refiere que en sus encuentros

pasados con otra pareja solo logra la excitación si utilizan este tipo de zapato. ¿Cual es el diagnóstico en este paciente?

- a) Fetichismo x
 - b) Sadomasoquismo
 - c) Trastorno de Conducta
 - d) Personalidad Narcisista
 - e) Trastorno de Personalidad Evitativo
6. Una paciente de 61 años consulta por dolor articular de ambas manos. Al examen se aprecia aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Se solicita radiografía de manos, que muestra disminución simétrica del espacio interarticular de las articulaciones interfalángicas, con compromiso de la primera articulación carpometacarpiana bilateral, con presencia de quistes subcondrales. El diagnóstico más probable es:
- a) Artritis psoriática
 - b) Artritis reumatoide
 - c) Artritis reactiva
 - d) Condrocalcinosis
 - e) Artrosis x
7. Una paciente de 14 años aún no ha tenido su menarquia. Presenta desarrollo puberal Tanner 4, mamario y pubiano, con vello axilar. No tiene otras alteraciones en el examen físico. La conducta más adecuada es:
- a) Solicitar ecografía ginecológica
 - b) Solicitar cariotipo
 - c) Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, LH y FSH
 - d) Realizar prueba de progesterona
 - e) Controlar en un año x
8. Una paciente de 22 años consulta por amenorrea de 4 meses de evolución, sin otras alteraciones. Se realiza exámenes, que muestran test de embarazo negativo, TSH y prolactina, que están dentro de rangos normales. Se solicita prueba de progesterona, que resulta negativa y prueba de estrógeno y progesterona, que resulta positiva. Además, se solicita LH y FSH, que están normales, dentro del límite bajo. El diagnóstico más probable es:
- a) Prolactinoma
 - b) Falla ovárica primaria
 - c) Embarazo ectópico
 - d) Amenorrea hipotalámica x
 - e) Síndrome de ovario poliquístico
-
9. Una mujer de 22 años consulta por un nódulo mamario, que se autopalpó. Al examen físico se constata un nódulo en la mama derecha, de 2 cm de diámetro,

móvil. No se palpan adenopatías axilares. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de esta paciente?

- a) Mamografía
- b) Ecografía mamaria x
- c) Resonancia magnética nuclear de mamas
- d) TAC de tórax
- e) Biopsia

10. Una paciente de 35 años de edad, con antecedente de ingesta de ACO, se realiza una ecografía abdominal, que muestra una lesión sólida, en el lóbulo hepático derecho, de 3,5 cm y aspecto hiperecogénico. El diagnóstico más probable es:

- a) Metastásis hepática
- b) Adenoma hepático x
- c) Carcinoma hepatocelular
- d) Quiste hepático
- e) Hemangioma hepático

11. Cual de estas enfermedades es de notificacion obligatoria inmediata

- a) Triquinosis x
- b) Hidatidosis
- c) Ascaridiasis
- d) Amibiasis
- e) Chagas

12. Un paciente de 22 años, Dolor torácico de algunas horas de evolución, tipo puntada, muy intenso. Refiere que hace una semana presentó disfagia, dolor abdominal y diarrea. En su examen físico se aprecia adolorido, con FC: 76x', PA: 110/70 mmHg, ritmo regular en 2 tonos, sin soplos. Se solicita un electrocardiograma, que se muestra a continuación:

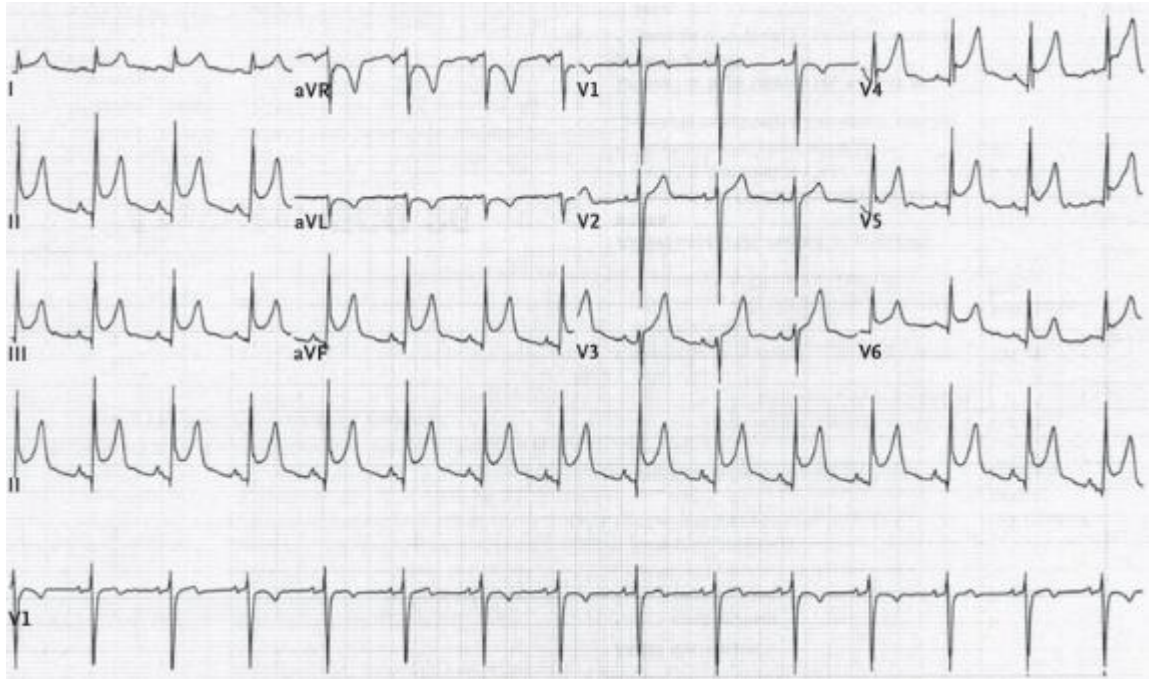
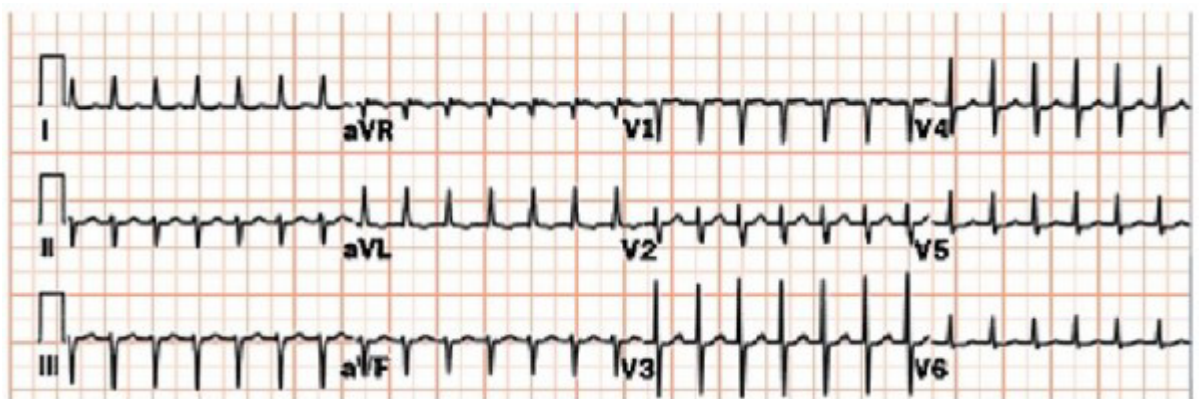


Foto 8 (<https://www.intramed.net/contenido.asp?contenidoID=86115>).

El diagnóstico más probable es:

- a) Pericarditis aguda x
 - b) Espasmo esofágico—+
 - c) Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared lateral
 - d) Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared inferior
 - e) Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared inferolateral
13. Un paciente de 18 años, con antecedente de coartación aórtica, operada en la infancia, consulta por disnea de esfuerzos, que ha ido en aumento, desde hace 2 meses. Además, refiere edema de extremidades inferiores y palpitaciones ocasionales. Al examen físico tiene FC: 88x', PA: 155/55 mmHg, el choque de la punta se palpa hiperdinámico, en la línea media axilar y en la auscultación cardíaca soplo diastólico III/VI, pulso venoso visible. Su examen pulmonar muestra crépitos escasos en ambas bases. El diagnóstico más probable es:
- a) Estenosis aórtica
 - b) Insuficiencia aórtica x...
 - c) Recoartación aórtica
 - d) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
 - e) Miocardiopatía dilatada

14. Un paciente de 20 años, con antecedente de soplo en su infancia, consulta por sensación de opresión precordial, que aparece al caminar, se asocia a disnea leve y que cede rápidamente con el reposo. Al examen físico tiene PA: 150/80 mmHg, FC: 63x', pulso débil, regular, de ascenso lento. El examen cardíaco muestra un soplo sistólico eyectivo, paraesternal, que se irradia al cuello. Su electrocardiograma muestra signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. El diagnóstico más probable es:
- a) Estenosis mitral
 - b) Estenosis aórtica x
 - c) Insuficiencia mitral
 - d) Insuficiencia aórtica
 - e) Miocardiopatía hipertrófica
15. Una paciente de 58 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril, consulta por disnea de esfuerzo que ha empeorado en el último tiempo siendo actualmente de mínimos esfuerzos, presentando además edema de extremidades inferiores. Refiere expectoración rosada en algunas oportunidades. Al examen físico se palpa choque de la punta en el 5° espacio intercostal a la altura de la línea media clavicular. La auscultación cardíaca muestra un soplo diastólico de tonalidad ruda, su frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto, irregular. El diagnóstico más probable es:
- a) Estenosis mitral
 - b) Estenosis aórtica
 - c) Miocardiopatía hipertrófica
 - d) Insuficiencia aórtica
 - e) Cardiopatía hipertensiva
16. Un paciente de 21 años consulta por disnea y palpitaciones de 20 minutos de evolución, que iniciaron súbitamente. Previo a esto había tenido otros episodios similares, pero que duraban mucho menos y se detenían también súbitamente. Su FC es 176 x' que mejoró después de realizar maniobra de Valsalva y su presión arterial es 130/90 mmHg. El resto del examen físico no aporta mayor información. Se solicita un electrocardiograma que muestra lo siguiente:



El diagnóstico más probable es:

Seleccione una:

- a. Fibrilación auricular
- b. Flutter auricular
- c. Taquicardia paroxística supraventricular
- d. Taquicardia ventricular
- e. Taquicardia sinusal

17. Paciente femenina usuaria de Timolol quien presenta edema y descamación a nivel de parpados



Cual es la posibilidad diagnóstica

- a) Dermatitis de contacto
- b) Rosacea Ocular
- c) Blefaritis
- d) Lupus Eritematoso Sistemico
- e) Dermatomiositis

18. Paciente quien refiere aumento de volumen en Brazo derecho



Fig. 2. Lesión cutánea.

Cual es el posible diagnóstico:

- a) Quiste Epidermico
- b) Carcinoma epidermoide
- c) Sarcoma de Kaposi
- d) Angioma
- e)

19. Caso de paciente quien tomo AINES (no recuerdo cual) 2 semanas atras y asoció hematuria anuria y edema

- a) Nefritis Intersticial
- b) Glomerulonefritis postestreptococcica
- c)
- d)
- e)

20. Un hombre de 34 años presenta erección dolorosa, desde hace 8 horas. Al examen tiene cuerpos cavernosos duros, pero con glande y cuerpos esponjosos blandos. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

Seleccione una o más de una:

- a. Aplicar paños fríos en la zona genital
- b. Fenilefrina endovenosa
- c. Vaciamiento quirúrgico de los cuerpos cavernosos.
- d. Drenaje con suero fisiológico frío intracavernoso
- e. Fenilefrina intracavernosa

21. Un recién nacido de 4 semanas de vida presenta un cuadro de vómitos postprandiales abundantes, desde hace una semana, asociada a detención del incremento ponderal. La madre refiere que lo nota hambriento y toma leche ávidamente. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar radiografía de abdomen simple
- b) Realizar tratamiento endoscópico
- c) Observar evolución
- d) Realizar pilorotomía de Ramstedt
- e) Realizar funduplicatura gástrica

22. Paciente masculino con antecedente de colitis ulcerosa, presenta ictericia, dolor en hipocondrio derecho, se realiza bioquímica presentando TGO 125 TGP 120 FA 450 GGT 400, cual es el posible diagnóstico

- a) Colangitis Esclerosante Primaria
- b) Coledocolitiasis
- c) Cirrosis Biliar Primaria
- d) Hepatitis Viral

e) Colecistitis Aguda

23. Un niño de 3 años presenta diarrea de 3 meses de evolución, intermitente, generalmente acuosa, pero que en ocasiones contiene escasos restos vegetales. Ha subido 600 gramos en ese periodo y su talla es 90 cm. Tiene signos vitales normales, se aprecia hidratado y su examen abdominal muestra un abdomen blando, depresible e indoloro, sin visceromegalia ni otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Diarrea crónica inespecífica
- b) Enfermedad celíaca
- c) Enteropatía perdedora de proteínas
- d) Alergia a la proteína de la leche de vaca
- e) Intolerancia a los disacáridos

24. Un lactante de 3 meses de edad pesa 7 kg. Se alimenta con lactancia materna exclusiva a libre demanda. Tiene peso para la edad en +1 DS y el índice peso/talla en +2 DS. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Dar formula de relleno
- b) Amamantar cada 4 horas
- c) Dar agua entre cada toma
- d) Mantener la lactancia materna a libre demanda
- e) Supender la lactancia nocturna

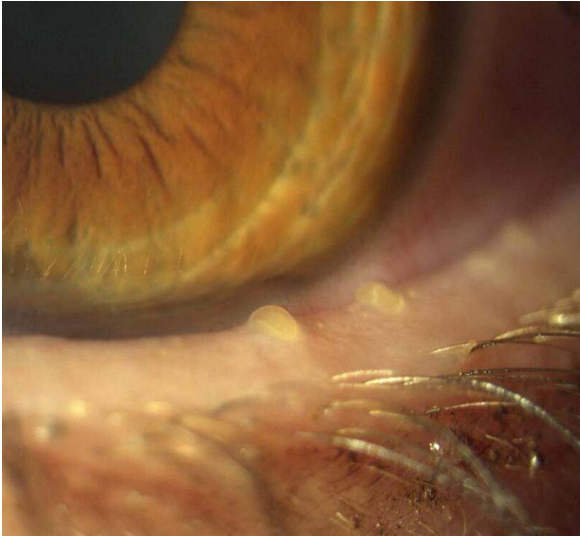
25. Niño de 3 años presenta convulsión febril, usted lo examina y sigue convulsionando, no se ha podido encontrar vía venosa, cual es la conducta.

- a) Aplicar Midazolam intranasal
- b) Fenobarbital IM
- c) Osteoclastosis
- d) Lorazepam EV
- e) Esperar a que ceda la convulsión

26. Paciente masculino de 22 años de edad quien inicia cuadro de dolor torácico súbito, disnea y sensación de diaforesis, al examen físico se encuentra taquipnea, Ruidos respiratorios disminuidos en hemitorax izquierdo, con hipersonoridad a la percusión. Cual es el posible diagnóstico

- a) Neumotorax espontáneo a tensión
- b) Hemotorax
- c) Contusión Pulmonar
- d) Pericarditis Aguda
- e) Tromboembolismo pulmonar

27. Paciente masculino quien presenta ojo rojo desde hace 1 año, asocia prurito ocular hace 3 meses y secreción bilateral desde hace 1 mes.



Cual es el diagnóstico

- a) Conjuntivitis Bacteriana Cronica
- b) Blefaritis
- c) Orzuelo
- d) Chalazion
- e) Endoftalmitis

28. Un recién nacido es atendido al momento de nacer se evidencia taquipnea, abdomen excavado y abolición de ruidos en hemitorax derecho, se indica Rx de Torax y Abdomen.



Cual es el posible diagnóstico

- a) Atresia esofágica
- b) Atresia Duodenal
- c) Hernia Diafragmaticai

- d) Hernia Umbilical
- e) Taquipnea Transitoria del Recien Nacido

29. Paciente femenina tiene sensación repentina de oído derecho tapado, a la otoscopia no se visualiza alteración y la prueba de diapasones el Weber lateraliza a la izquierda y tiene Rinne + en ambos oídos. ¿Cuál es la conducta

- a) Audiometría de urgencia
- b) Maniobras de reposición
- c)
- d)
- e)

30. Adolescente masculino quien presentó infección viral hace 1 mes, presenta dolor a nivel de extremidades proximales y rash violáceo a nivel de párpados, ¿cuál es el posible diagnóstico.

- a) Rabdomiolisis
- b) Polimiositis
- c) Dermatomiositis
- d) Artritis Reumatoide Juvenil
- e) Eritema multiforme menor

31. Una paciente de 67 años, hipertensa, en tratamiento con losartán 50 mg, hidroclorotiazida 25 mg, amlodipino 5 mg, carvedilol 12,5 mg. Presenta edema de las extremidades inferiores, que ha ido en aumento. En su examen físico tiene FC: 57x' regular, con PA: 130/90 mmHg, RR2T, examen pulmonar sin alteraciones y examen abdominal con hígado palpable 1 cm bajo el reborde costal y extremidades inferiores con edema bimalleolar con signo de la fovea. La conducta más adecuada es:

- a) Reforzar la dieta hiposódica e indicar reposo con las extremidades en alto
- b) Suspendir el amlodipino
- c) Subir la dosis del diurético
- d) Suspendir el losartán y agregar doxazosina
- e) Solicitar ecodoppler de extremidades inferiores

32. Una paciente de 25 años fue encontrada vagando por la calle descalza, desorientada y confusa. Hace 5 horas había tenido una discusión con su padre, luego de lo cual salió de su casa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Trastorno disociativo
- b) Trastorno adaptativo
- c) Trastorno conversivo
- d) Trastorno somatomorfo
- e) Trastorno facticio

33. Una paciente de 24 refiere que luego de realizar ejercicios de elongación, presenta dolor súbito en el cuello y en la cabeza, con cefalea en trueno (thunderclap). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a) Cefalea cluster o en racimo
 - b) Accidente isquémico transitorio
 - c) Disección de la arteria basilar o carótida
 - d) Migraña sin aura desencadenada por el ejercicio.
 - e) Hernia traumática del núcleo pulposo
34. Paciente vegana, presenta astenia, palidez y sensación de debilidad, se realiza hemograma que reporta hemoglobina en 9.7 gr/dl, VCM 74 CHCM 60, cual es el posible diagnóstico
- a) Anemia por deficiencia de folatos
 - b) Anemia ferropriva
 - c) Anemia de enfermedades crónicas
 - d) Anemia por deficiencia de Vitamina B12
 - e) Aplasia Medular
35. Un niño de 4 años presenta retraso generalizado del desarrollo psicomotor. Solo dice 4 palabras inteligibles. Además realiza movimientos estereotipados de rotación y manierismo. Juega solo y no muestra interés en hacer amigos ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- a) Distrofia muscular de Duchenne
 - b) Síndrome de Gilles de la Tourette
 - c) Trastorno del espectro autista
 - d) Parálisis cerebral
 - e) Síndrome de West
36. Una paciente de 56 años consulta por cefalea de intensidad fluctuante, de predominio occipital. Además, presenta náuseas y dolor abdominal tipo cólico, con artralgias. En el último tiempo presenta también la sensación de tener un cuerpo extraño al tragar. Se ha realizado múltiples exámenes, los que descartan patología orgánica. El diagnóstico más probable es: Seleccione una:
- a. Trastorno adaptativo
 - b. Trastorno hipocondríaco
 - c. Trastorno conversivo
 - d. Depresión
 - e. Trastorno por somatización
37. Un paciente de 18 años tiene tendencia a tener una coloración icterica de la piel. Al examen físico presenta escleras de tinte subictérico, sin otras alteraciones. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran bilirrubina total: 2,3 mg/dl, bilirrubina directa: 0,3 mg/dl, FA: 70 UI/L, GGT: 50 UI/L, SGOT: 35 UI/L, SGPT: 40 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hepatitis
- b) Anemia hemolítica
- c) Síndrome de Dubin Johnson
- d) Síndrome de Gilbert
- e) Síndrome de Crigler Najjar

38. Paciente masculino de 70 años de edad quien presenta astenia ictericia y pérdida de peso se realiza colangiografía donde se evidencia dilatación de vía biliar en 11 mm sin evidencia de obstrucción de la misma. Cual es el posible diagnóstico

- a) Colelitiasis alitiásica
- b) Hepatitis autoinmune
- c) Colangiocarcinoma
- d) Síndrome de Gilbert
- e) Colangitis Aguda

39. Paciente masculino con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial en tratamiento con metformina y enalapril se realiza análisis de control donde se evidencia LDL 150 Triglicéridos 300 HDL 25. Cual medicamento es más útil para disminuir su riesgo cardiovascular

- a) Atorvastatina
- b) Gemfibrozilo
- c) Ezetimibe
- d) Fibratos
- e) Ácido Nicotínico

40. Paciente femenina de 40 años de edad quien se realiza Mamografía control que reporta BIRADS IV. cual es la conducta a seguir

- a) Mamografía en 1 año
- b) Ecografía
- c) Mamografía en 6 meses
- d) Biopsia por aguja estereotáxica
- e) Biopsia excisional

41. paciente cursando embarazo de 22 semanas acude por presentar escotomas centellantes al examen físico PA 170/110 mmHg, ROT hiperreflexicos, exaltados. Cual es la medicación a conocer:

- a) Labetalol EV
- b) Captopril SL
- c) Sulfato de Magnesio EV
- d) Nifedipino VO
- e) Alfametildopa VO

42. Paciente masculino quien refiere desde hace 3 semanas presenta sensación de palpitaciones, dificultad para dormir y sensación de falta de aire, refiere que todo

inicio posterior a enterarse qué debía vender su vivienda para mudarse de ciudad ya qué iba a ser trasladado en su trabajo. Cual es el diagnostico:

- a) Trastorno de pánico
- b) Trastorno de ansiedad generalizado
- c) Trastorno conversivo
- d) Trastorno adaptativo
- e) Trastorno de Estrés Agudo

43. Un paciente obeso, con antecedente de hígado graso. Luego de una trasgresión alimentaria con abundante consumo de alcohol, presenta cuadro de dolor epigástrico irradiado a ambos costados, asociado a vómitos alimentarios, sensación febril e ictericia. Al examen físico, su presión arterial es de 110/70mmHg, con frecuencia cardiaca 100 por minuto, y al examen abdominal presenta dolor a la palpación de forma difusa, con abolición de ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

- a) Isquemia mesentérica
- b) Colangitis
- c) Pancreatitis
- d) Colecistitis
- e) Coledcolitiasis

44. Un recién nacido de 18 horas de vida, desarrolla ictericia hasta los muslos. Se solicitan niveles plasmáticos de bilirrubina que resulta 15,3 mg/dl, con fracción indirecta de 15 mg/dl. La madre era O-IV Rh positiva y el niño es A-I Rh negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico
- b) Ictericia hemolítica por incompatibilidad Rh
- c) Ictericia fisiológica
- d) Hepatitis neonatal
- e) Ictericia por lactancia materna

45. Paciente femenina portadora de DIU tipo T de Cobre desde hace 2 meses quien asocia desde hace 3 días dolor pélvico, sensación febril, al especuloscopia presenta cuello eritematoso y friable con escasa secreción, dolor a la palpación de anexos y movilización de útero, cual es la conducta a seguir:

- a) Hospitalizar y dar antibióticos endovenosos
- b) Terapia antibiótica trimodal por vía oral y posterior retiro de DIU
- c) Retiro de la T de Cobre
- d) Laparoscopia Exploradora
- e) Realizar Ecografía Transvaginal

46. Paciente femenina con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento con Atenolol refiere que presenta desde hace 1 mes lesiones a nivel de antebrazos y cara anterior de muslos las cuales son pruriginosas, al examen físico se evidencia lesiones del tipo ampolloso engrosadas que no son fáciles de romper al tacto.

- a) Penfigo
- b) Dermatitis de contacto
- c) Penfigoide Buloso
- d) Dermatitis atopica
- e) Herpes

47. Paciente masculino de 65 años de edad quien fue intervenido de una reseccion transuretral y durante el postoperatorio presenta poliuria de 4500 ml, asocia hiperkalemia de 5.8 mEq/L, sodio de 133 mEq/L, Creatinina en 6.2. BUN 100 en estado de deshidratación como haría el manejo de su desequilibrio.

- a) Hemodialisis
- b) Hidratación con Solución Fisiológica
- c) Insulina mas Solución Glucosada
- d) Esteroides
- e)

48. Paciente masculino quien presentó infección por influenza hace 2 semanas, asocia parálisis flácida y debilidad de miembros inferiores, al examen físico se evidencia arreflexia aquiliana e hiporreflexia rotuliana con disminución de fuerza muscular de las extremidades superiores. cual es el posible diagnóstico

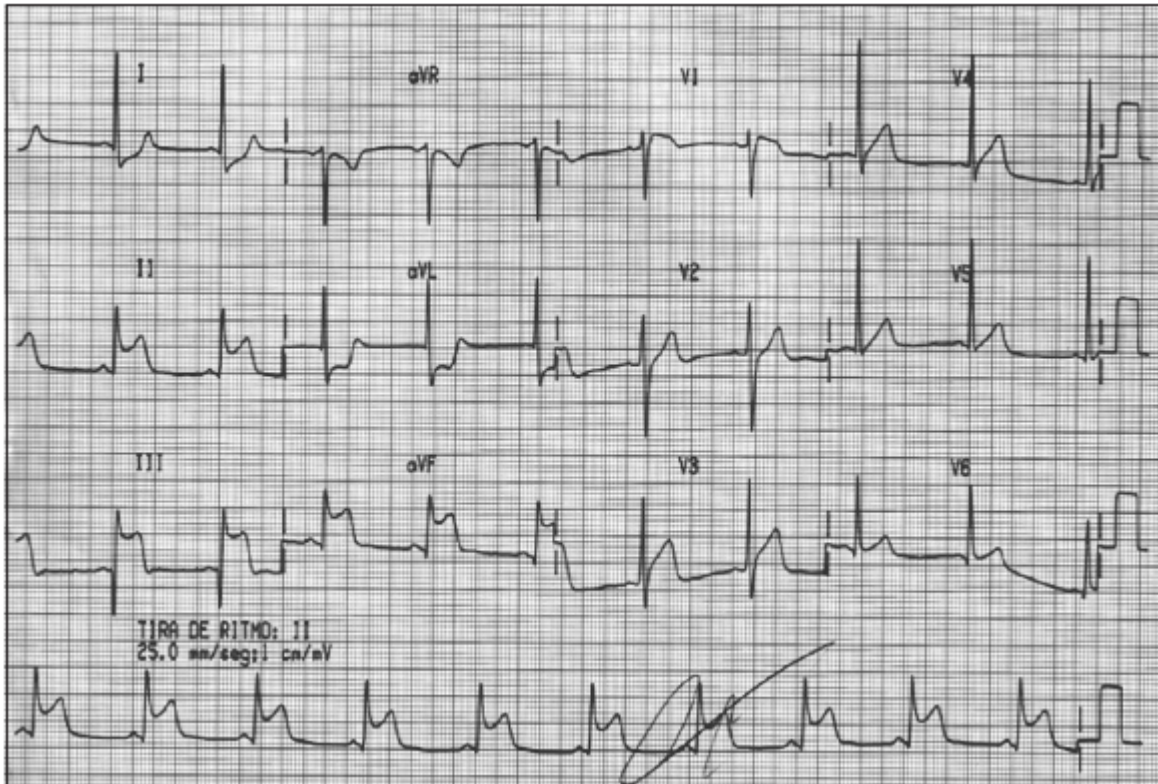
- a) Polineuropatia desmielinizante aguda
- b) Mononeuropatia multiple
- c) Mieloma Multiple
- d) Miopatía
- e) Polimiositis

49. Paciente adulto mayor con antecedente de Artritis Reumatoide en tratamiento con Prednisona larga data, refiere caída a nivel presentando dolor lumbar que no mejora con el reposo, ni con los AINES, se realiza Rx de columna lateral.



- a) Fractura por fragilidad
- b) Degeneración Discal
- c) Espondilosis
- d) Compresión Radicular
- e) Espondilolistesis

50. Paciente femenina con antecedente de hipertensión arterial y diabetes, presenta dolor precordial irradiado a cuello, con sensación de diaforesis, es atendida en el centro donde se constata IAM, aparte de la colocación de ASA, nitroglicerina, oxígeno cual sería la conducta a seguir, tomando en cuenta que no tienes disponibilidad para el traslado inmediato, ni se cuenta para realizar angioplastia en el centro médico.



- a) Colocar Hidratación Parenteral con Cloruro de Sodio
- b) Solicitar Enzimas Cardiacas
- c) Monitoreo continuo
- d) Realizar Trombolisis
- e) Asociar Clopidogrel

51. Paciente Masculino diabético que presenta:
 proteinuria +++, albúmina 2.6 creatinina 3.2, escasos eritrocitos 2 a 4, leucocitos.
 Cual es el posible diagnóstico

- a) Glomerulopatía membranosa
- b) Nefropatía diabética
- c) Nefrosis lipoidea
- d) Nefritis intersticial
- e) Rápidamente progresiva

52. Paciente femenina con antecedente de asma en control con Fluticasona 125 cad 12 horas Salbutamol cada 6 horas quien ha presentado crisis de rinorrea y sibilancias a predominio nocturno sin exposición a alérgenos aparentes. Cual es la conducta adecuada

- a) Aumentar dosis de Fluticasona
- b) Fluticasona intranasal
- c) Budesonida
- d) Asociar inhibidor de los leucotrienos
- e) Mantener tratamiento con control de alérgenos

53. Paciente X con HDL 45, LDL 150, triglicéridos 950. Que tratamiento debe iniciar

- a) Atorvastatina
- b) Gemfibrozilo
- c) Ezetimibe
- d) Aspirina
- e) Ácido Nicotínico

54) Preescolar masculino de 5 años de edad quien acude por astenia, se realiza ecografía abdominal que evidencia presencia de granulomas hepáticos, al examen físico tiene una lesión tipo excoriación en rostro. ¿Cuál es el posible agente etiológico

- a) Streptococcus pyogenes
- b) Staphylococcus aureus
- c) Bartonella henselae
- d) Mycoplasma pneumoniae
- e) Enterococcus

55. Un paciente, con antecedente de rinitis alérgica, presenta marcada obstrucción nasal marcada, asociada a varios episodios de sinusitis en el último tiempo. En la rinoscopia anterior, se visualizan numerosos pólipos en la mucosa, de aspecto pálido y brillante. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar fluticasona tópica
- b) Iniciar prednisona oral
- c) Solicitar TAC de cavidades paranasales
- d) Realizar cirugía endoscópica nasal
- e) Solicitar niveles plasmáticos de inmunoglobulinas

56. Un paciente está en el tercer día de tratamiento con azitromicina, por una amigdalitis con exudado. Consulta por aumento de la odinofagia, asociada a imposibilidad de comer por trismo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Absceso periamigdalino
- b) Angina de Ludwig
- c) Mononucleosis infecciosa
- d) Absceso parafaríngeo
- e) Absceso retrofaríngeo

57. Un paciente de 66 años, hipertenso, presenta dolor retroesternal intenso, irradiado a dorso. En el examen físico presenta FC: 127x', PA: 200/120 mmHg,

SatO₂: 94%, pulsos radiales asimétricos, MP(+), sin ruidos agregados, RR2T con soplo de regurgitación aórtica. El diagnóstico más probable es:

- a) Infarto de ventrículo derecho
- b) Endocarditis aguda
- c) Tromboembolismo pulmonar
- d) Infarto miocárdico con rotura de músculo papilar
- e) Disección aórtica

1	C
2	B
3	B
4	C
5	A
6	E
7	D
8	D
9	B
10	B
11	A
12	A
13	B
14	B
15	A
16	C
17	A, B?
18	A
19	A
20	E
21	D
22	A
23	A (segun una clave de Guevara Julio 2017)
24	D
25	A B C?
26	A
27	B (era lo que mas se aproximaba por la foto)

28	C
29	A
30	C
31	B
32	A
33	C
34	B
35	C
36	E
37	D
38	C
39	A
40	D
41	C
42	D
43	C
44	A
51	A
52	D
53	B
54	C
55	B
56	A
57	E

Preguntas EUNACOM 2024 enero.

1. Lesión en pezón y areola secundario a la lactación, cual es el tratamiento de elección?

- a) **Lanolina**
- b) Corticoides locales
- c) Antibióticos tópicos
- d) Aseo con agua y jabón
- e) Compresas de agua fría



los tratamientos con mejores efectos sobre estimulación del crecimiento epitelial del pezón agrietado son: la lanolina, cremas a base de Dexpantenol y Colágenasa. Los mejores tratamientos para el manejo del dolor son, las compresas de agua tibia y el agua de mentol.

2. Se trata de paciente femenina de 55 años, quien presenta edema discreto de miembros inferiores, parestesias ocasionales y al examen físico tiene varices de ambas extremidades. Que medida inicial se debe tomar con esta paciente?

- a) Elevación de las piernas
- b) Ejercicio Físico
- c) Medias de compresión.
- d) Vendas elásticas
- e) Cirugía

Pauta: según el instrumento de clasificación compuesto por el acrónimo CEAP (Clínica, Etiología, Anatomía y Patofisiología) que facilita la descripción de las formas de IVC el caso es de clase 3 (rango de C1 a C6). El tratamiento conservador es farmacológico y no farmacológico. Inicialmente ejercicio físico 30min/día 3 veces/semana, luego terapia compresiva, con vendajes o medias de compresión y en cuanto a la Terapia farmacológica están los venoactivos: diosmina+hesperidina, calcio dobasilato). Pareciera la correcta el ejercicio físico?

3. Qué tipo de lesiones plantares están presentes en la foto?

- a) **Verrugas Vulgares**
- b) Tiña Pedis
- c) Ca. Basocelular
- d) Pie de atleta
- e) Molusco contagioso



Pauta: Las verrugas plantares se presentan frecuentemente en las zonas de apoyo y pueden ser dolorosas. Pueden ser planas o ligeramente sollevantadas y están cubiertas de piel gruesa hiperqueratótica, que al ser removida o hacer un shaving revela 1 o varios puntos negros característicos, que representan capilares trombosados. Pueden estar en grupo (en inmunosuprimidos) y son llamadas verrugas en mosaico, por su apariencia. (VPH 1).

4. Una lesión ulcerada de gran tamaño 8 x 8 cm, bordes irregulares, con descamación superficial ubicada en la unión de tercio medio e inferior de la pierna derecha de un paciente con DM tipo 2, corresponde a:

- a) **Enfermedad de Bowen**
- b) **Carcinoma espinocelular in situ**
- c) Carcinoma basocelular
- d) Ectima
- e) Úlcera arterial



Pauta: pregunta difícil, las opiniones se dividen entre enfermedad de BOWDEN y CANCER de piel?

La Enfermedad de BOWDEN se caracteriza por parches escamosos o engrosados que se considera un ca in situ a partir del cual puede desarrollarse un Epidermoide. Es una forma de ca. Espinocelular intraepidémico. Topografía mas común: cabeza, cuello y extremidades.

El ectima es una piodermatitis profunda ulcerativa causada habitualmente por estreptococo beta hemolítico del grupo A (Streptococcus pyogenes). Suele presentarse en zonas de piel dañada y en pacientes inmunocomprometidos, y es infrecuente que se acompañe de sintomatología general y bacteriemia.

5. Un recién nacido de 29 días con Síndrome de Down, es traído a la emergencia por presentar respiraciones rápidas, que suda y se cansa mientras recibe lactancia materna, esta creciendo con lentitud y no ha ganado peso. Al examen físico, presenta soplo holosistólico de regurgitación, cual sería el diagnóstico mas probable?

- a) Transposición de grandes vasos
- b) Canal Auriculo Ventricular**
- c) Tetralogía de Fallot
- d) Ducto arterioso
- e) CIV

Pauta: 40 - 60% de pacientes con SD presentan cardiopatía congénita, El SD se presenta en 2,5 de 1.000 RN vivos chilenos. Presentan más anomalías congénitas y comorbilidades que la población general, aumentando su tasa de hospitalización. Presentan mayores índices de anomalías congénitas (AC) que la población general, particularmente cardíacas (54-66%) y digestivas (3-13%).

Las cardiopatías más comúnmente asociadas a SD son aquellas que se derivan de un defecto en el desarrollo de los cojinetes endocárdicos. Existen dos formas principales: un defecto parcial limitado al tabique interauricular que da lugar a una CIA tipo ostium primum (OP) y un defecto completo que da lugar al canal auriculoventricular común (CAV).

6. Cual es el examen a realizar en un paciente masculino de 24 años, con un cuadro de eccema alérgico de 1 año de evolución por aeroalérgenos.

- a) Prueba del parche
- b) Prick test**
- c) Prueba intradérmica
- d) Determinación de Eosinófilos en sangre periférica
- e) Determinación de IgE

Pauta: Las pruebas cutáneas de alergia, son un método diagnóstico consistente en intentar reproducir en la piel una reacción alérgica para identificar la sustancia que puede desencadenar aquella reacción en el paciente. Existen diferentes métodos según los diferentes mecanismos inmunes que generen la alergia: Pruebas cutáneas de punción o prick test es de Hipersensibilidad Inmediata Tipo 1 (método mas apropiado para el diagnóstico en el caso de aeroalérgenos, alimentos y medicamentos).

La prueba intradérmica es más sensible pero menos específica que el prick test.

Pruebas alérgicas de hipersensibilidad tardía (Reacción tipo IV), también llamadas pruebas del parche, pruebas epicutáneas o patch test, se realizan para identificar principalmente sustancias que ocasionan alergias de contacto o dermatitis alérgicas. Por tanto, se solicita frente a: eczema por maquillaje, joyas, metales, de contacto laboral y alimentaria.

7. Paciente puerpera de 1 mes, quien acude para evaluación por presentar fiebre 38,8 grados celsius, aumento de volumen y dolor en mama derecha, al examen físico presenta nódulo renitente en cuadrante superior externo, doloroso sin eritema.

- a) Absceso
- b) Quiste lácteo
- c) Mastitis

- d) Celulitis
- e) Ca de mama

Pauta:

8. Un trabajador de peluquería consulta por presenta lesiones en ambas manos, las cuales se muestran en la foto, cual es el diagnostico mas probable?
- a) Dermatitis de contacto
 - b) Dermatitis irritativa
 - c) Micosis superficial
 - d) Piodermitis
 - e) Dermatitis Alergica

Pauta: La dermatitis de contacto representa la respuesta inflamatoria de la piel a múltiples agentes exógenos. Existen dos subtipos de dermatitis de contacto: la dermatitis de contacto alérgica y dermatitis de contacto irritativa. La irritativa (jabón, detergentes) y de contacto alérgica (productos de cosmética y químicos).

9. Niño de 2 meses de edad, traído por la madre por presentar anorexia, pérdida de peso, decaimiento y vómitos. Al examen físico esta deshidratado, hipoactivo, genitales externos normales, PA 90/60 Pulso 80xmin Na+: 133 K+: elevado. Que tratamiento debe aplicarse?
- a) Hidrocortisona
 - b) Dexametasona
 - c) Iniciar suero hipertónico
 - d) Gluconato de calcio intravenoso
 - e) Dextrosa 5% intravenosa

Pauta: La hiperplasia adrenal congénita es un conjunto de anomalías con herencia autosómica recesiva por el déficit de una de las cinco enzimas necesarias para la síntesis de cortisol en la corteza adrenal. La causa más frecuente es la deficiencia de 21 hidroxilasa, que explica más del 95% de los casos.

10. Mujer de 40 años quien asiste a control por Ginecología se realiza PAP el cual reporta lesión con células glandulares atípicas, presenta colposcopia normal, cual es la conducta?
- a) **Biopsia de endometrio**
 - b) Cono biopsia
 - c) Crioterapia
 - d) Observacion y control anual
 - e) PAP en 2 años

Pauta: en un PAP se indica que hay células glandulares atípicas cuando las células glandulares no lucen normales, pero tienen características que causan inquietud sobre la posible presencia de un cáncer. En este caso, la paciente debe someterse a biopsia de endometrio.

11. Paciente de 28 años con HTA severa desde hace 7 años, tratada con losartan, amlodipino e hidroclorotiazida a dosis máximas, quien presenta cifras promedio de PA de 170/100, cual es el origen de su HTA.
- a) Estenosis de arteria renal
 - b) Feocromocitoma
 - c) HTA Secundaria
 - d) HTA esencial
 - e) Hiperaldosteronismo Primario

12. Paciente con síntomas obsesivos quien ha roto objetos de vidrio en su casa y dice que lo amarren para evitar seguir rompiendo las cosas

- a) Trastorno obsesivo compulsivo
- b) Depresión ansiosa
- c) Ansiedad generalizada
- d) Trastorno de ansiedad
- e) Bipolar

13. Se trata de paciente con erupción cutánea de tipo manchas de color rojo violáceo que parecen moretones en los *glúteos*, las *piernas* y los pies.

- a) **Purpura de Schonlein Henoch**
- b) Leucemia
- c) Trombocitopenia
- d) Purpura trombocitopenica Autoimmune
- e) Hemofilia



14. Escolar de 8 años con sangrado a través de fosa nasal derecha y antecedente de sangrado en anteriores oportunidades, cual es el diagnostico mas probable:.

- a) **Rinitis alergica**
- b) Hemofilia
- c) Leucemia
- d) Cuerpo extraño
- e) Enfermedad de Von Willebrand

15. Paciente de 1 año, con cuadro de congestión nasal, rinorrea, malestar general. Cual medida seria mas adecuada.

- a) **Solución fisiológica nasal**
- b) Esteroides nasales
- c) Vasoconstrictores locales
- d) Antialergicos via oral
- e) Paracetamol

16. Paciente con disnea y palpitaciones, al ex físico presenta taquicardia regular que mejora con valsalva y en anteriores oportunidades ha mejorado con masaje carotideo.

- a) **Taquicardia supraventricular Paroxistica**
- b) Fibrilacion auricular
- c) Fibrilacion Ventricular
- d) Taquicardia ventricular
- e) Flutter auricular

17. Paciente de 74 años con antecedente de tabaquismo 30 cajas por año, quien presenta desde hace 2 meses tos con expectoración mucosa, se solicita Rx Tx con la siguiente imagen: Cual es el diagnostico mas probable?

- a) **Ca de pulmon**
- b) TBC
- c) Absceso pulmonar



- d) Neumonía atípica
- e) Hidatidosis

18. Paciente femenina de 27 años de edad, con nueva pareja desde hace 1 mes, no usa método de protección, presenta disuria, dispareunia y leucorrea amarilla verdosa espumosa de mal olor. ¿Que tratamiento debe indicarse?

- a) **Metronidazol**
- b) Azitromicina
- c) Fluconazol
- d) Albendazol
- e) Nistatina

Pauta: La incidencia de la infección por tricomonas vaginal está asociada con factores de riesgo tales como múltiples compañeros no estables, infección previa por otra ETS como Herpes Virus tipo 2, HIV, sífilis, VB, candidiasis, gonorrea, prostitución, drogadicción, encarcelación y mujeres jóvenes. Puede ser asintomática o manifestarse como vaginitis severa, la cual, se caracteriza por un flujo amarillo-verdoso o amarillo, espumoso, de mal olor el cual se presenta en más del 50% de las pacientes, enrojecimiento y prurito vulvovaginal, dispareunia y/o disuria.

19. Paciente femenina de 34 años, con antecedente de DIU, quien consulta por presentar leucorrea, dolor en hipogastrio y a la movilización del cuello uterino. Cual es el diagnóstico más probable?

- a) **Proceso Inflamatorio Pélvico**
- b) Vaginosi
- c) Candidiasis
- d) Trichomoniasis
- e) Sífilis

Pauta: El efecto adverso más importante del DIU son las infecciones genitales y pélvicas. Se presentan con frecuencia mayor en los primeros 20 días después de la inserción. Si se presenta un PIP, se debe tratar con los antibióticos adecuados, sin que sea necesario retirar el DIU. Si la mujer solicita el retiro, debe hacerlo después de haber iniciado la terapia antibiótica. Si la infección no cede, es conveniente retirar el DIU y continuar el tratamiento, monitoreando cuidadosamente la evolución. En caso de no detectar las guías del DIU se debe: Primero descartar la posibilidad de embarazo (si es posible hacer hCG o ultrasonografía).

20. Paciente de 60 años de edad quien consulto por dolor opresivo precordial EVA 9/10 el cual se inicio 1 hora antes, está sudoroso, inquieto, Pulso: 100x/min TA: 140/100 y el EKG que reporta un IAM, en el centro no se dispone de Unidad para Angioplastia y el Hospital más cercano se encuentra a 3 horas, cual es la conducta más correcta?

- a) Referir al Hospital más cercano
- b) **Trombolisis**
- c) Hospitalizar
- d) Oxígeno
- e) Nitroglicerina, oxígeno y aspirina

Pauta: Evaluar inicio fibrinólisis precoz en pacientes con síntomas < 12 horas, idealmente < 3 horas)

21. Paciente con HTA, tratado con enalapril y hidroclorotiazida y por presentar cifras tensionales altas, promedio de 160/90, se le agrega 40mg de furosemida, posterior a lo cual, presenta cuadro de convulsiones, ingresa somnoliento. Que alteración presenta?

- a) **Hiponatremia**
- b) hipocalcemia
- c) Hipernatremia
- d) Hipercalcemia
- e) Hipercalcemia

Pauta: Los diuréticos pueden provocar hiponatremia hipovolémica. Específicamente las tiazidas reducen la capacidad de dilución renal y aumentan la excreción de sodio. Una vez que el paciente desarrolla depleción de volumen, la secreción de ADH no osmótica estimula la retención de agua y agrava la hiponatremia. La hipopotasemia concomitante desvía el sodio hacia el interior de las células y estimula en forma adicional la secreción de ADH, lo que a su vez empeora la hiponatremia.

22. Niño de 4 años es traído por familiar por presentar edema, los exámenes arrojan una proteinuria de 6grs/24h, creatinina en 1,7 BUN

- a) Síndrome nefrótico
- b) Nefropatía por cambios mínimos
- c) Nefrosis lipoidea
- d) Glomerulonefritis
- e) Glomerulonefritis Post streptococcica

23. Que modificación de tratamiento recomienda en un paciente de 50 años, con DM tipo 2 desde hace 1 año, con IMC 30, acantosis nigricans en el cuello, quien recibe tratamiento con 500mg de Metformina/día y presenta cifras de glucemias elevadas con HbA1C en 7.5%. Cual es la conducta a seguir?

- a) **Aumentar dosis de Metformina**
- b) Agregar sulfonilurea
- c) Indicar dieta
- d) Agregar insulina NPH nocturna
- e) Agregar sitagliptina

24. Un paciente con hipotiroidismo quien recibía 100mcg/día de L-tiroxina y omitió el tratamiento desde hace 6 meses, que es lo que mas frecuentemente puede encontrarse al examen físico.

- a) **Piel seca**
- b) Mixedema pre tibial
- c) Fascies abotagada
- d) Disfonia
- e) Caída del cabello

25. Un paciente de 45 años presenta un nódulo tiroideo de 3 cm. Temblor digital, nerviosismo, proptosis. Se solicita una TSH que resulta 0,02UI/l y T4L de 6,1. La conducta más adecuada es:

- a) **Solicitar cintigrafía tiroidea con yodo radiactivo**
- b) Solicitar punción por aguja fina
- c) Solicitar determinación de calcitonina
- d) Solicitar tiroglobulina y anticuerpos antitiroideos
- e) Realizar tiroidectomía parcial

26. Un paciente de 63 años, con antecedente de gastrectomía por cáncer gástrico, asiste a consulta por presentar debilidad y palidez cutánea, los exámenes arrojan los siguientes resultados plaquetas 120.000, HB 10, Leucocitos 4000. Cual es el diagnóstico más probable?

a) **Anemia por déficit de vitamina B12**

b) Anemia por déficit de folatos

c) Anemia por déficit de hierro

d) Anemia drepanocítica

e) Talasemia

27. Paciente que consulta por lesiones en las uñas de ambos pies, mostradas en la foto, las cuales tienen mas de 1 año de evolución, cual es el tratamiento indicado?

a) Antimicótico local

b) Ketoconazol

c) **Terbinafina oral**

d) Itraconazol

e) Griseofulvina



Pauta: En la onicomycosis el tratamiento tópico se prefiere cuando el compromiso de la lámina ungueal es menor a un 30% o cuando hay menos de 3 uñas comprometidas o en onicomycosis superficial.

Tratamiento Oral de elección: Terbinafina 250mg para onicomycosis por Trycophiton spp., siendo T. rubrum el más frecuente. Si el paciente tiene hemograma y pruebas hepáticas normales, se puede usar Terbinafina 250mg diarios durante 3 meses. El control con pruebas hepáticas debe realizarse al primer mes de iniciado el tratamiento El tratamiento combinado con Terbinafina 250mg + laca ungueal es lo más recomendable en la actualidad.

28. Un niño de 1 año es traído por la madre al consultorio, por haber presentado fiebre de 40 grados celsius de 3 días, la cual cedió para dar paso a un exantema maculo-papular rosado que comenzó en cuello y tronco y luego se generalizo, el agente causal mas frecuente del cuadro es:

a) **Herpes Virus Humano 6 (HHV-6) causante de Roseola infantil (exantema subito)**

b) Virus coxsackie A16

c) Parvovirus B19

d) Enterovirus

e) Herpes virus

Pauta: El exantema súbito es una enfermedad causada por virus que afecta fundamentalmente a niños con edades comprendidas entre los 4 meses y los 2 años. Se transmite por sangre y saliva. Las lesiones dérmicas son puntos rosas o rojos que blanquean con la presión.

29. Una mujer de 29 años se realiza una ecotomografía mamaria que muestra una lesión de 3cmt, bordes regulares, en la mama derecha, informada como Bi-Rads 3. La conducta a seguir es:

a) Solicitar mamografía

b) **Eco mamario en 6 meses**

c) Biopsia por punción

- d) Biopsia estereotaxica
- e) Biopsia quirurgica

Pauta: BI-RADS 3 se refiere a lesiones clasificadas como probablemente benignas que requieren seguimiento radiológico semestral. Hallazgos probablemente benignos (con < 2% de riesgo de malignidad).

30. Un paciente de 9 años es traído por familiar a la consulta presentando odinofagia, coriza y tos seca ocasional. En el examen físico presenta faringe congestiva, aumento de tamaño de las amígdalas con 2 pequeñas vesículas en el paladar blando, adicionalmente se palpan varias adenopatías cervicales. Cual es el agente etiológico mas probable del cuadro?

a) Adenovirus

- b) Virus de Influenza
- c) Streptococo betahemolítico, grupo A
- d) Staphylococo
- e) Bacterias gram positivas

31. Que significa la tasa de mortalidad bruta y como se expresa?

a) Numero de defunciones ocurridas/población estimada a mitad de año x 1000 habitantes

- b) Numero de defunciones ocurridas en un año/población infantil, se expresa por 100.000 habitantes
- c) Numero de muertes antes del mes de nacido/numero de nacidos vivos, se expresa por 1000 nacidos vivos
- d) Numero de muertes maternas/total nacidos por cada 1000 nacimientos
- e) Numero de defunciones ocurridas/población adulta por cada 100.000 habitantes

Pauta: la tasa de mortalidad bruta se calcula en base a la siguiente formula: No. de muertes totales, por todas las causas/Población total a la mitad del año x 1000.

Se utiliza el numero de población a la mitad del año por ser un momento de equilibrio poblacional (entre nacimientos, muertes, migraciones)

32. Un joven de 20 años, deportista, practica ciclismo y sufre caída con golpe directo sobre el hombro derecho, el cual se desplaza hacia abajo y la clavícula hacia arriba, presentando dolor. Al examen físico se observa equimosis y deformidad con signo de la tecla de piano. Que lesión sufrió el paciente?

a) Luxacion acromioclavicular

- b) Lesion del supraespinoso
- c) Ruptura del manguito rotador
- d) Fractura de cabeza humeral
- e) Fractura de la disfisis humeral

Pauta: la mayor parte de estas lesiones se tratan de manera conservadora, mediante una inmovilización sencilla tipo cabestrillo, el tiempo depende del grado de la lesión. En los grados más altos se suele plantear, teniendo en cuenta la actividad habitual del paciente, el tratamiento quirúrgico de la lesión.

33. Se trata de paciente de 55 años, con hábitos tabáquicos de 14 cigarrillos/día y consulta porque desea dejar de fumar, cual seria la conducta a seguir?

a) Indicar Psicoterapia cognitiva conductual

- b) Apoyo nicotínico (parche)
- c) Apoyo nicotínico (chiclet)
- d) Bupropion
- e) Cigarrillo electrónico

Pauta: la base del tratamiento del tabaquismo es la psicoterapia cognitivo conductual, es decir, conocer para actuar, si fuma mas de 15 cigarrillos al día y hace síndrome de abstinencia, debe darse apoyo nicotínico con chicle o parche. Existen fármacos para disminuir el deseo de fumar como tercera opción.

34. Un paciente de 30 años acude a consulta por presentar hormigueo y adormecimiento de los dedos meñique y anular en la mano derecha, igualmente refiere dolor que recorre el antebrazo por la cara interna. ¿Cuál es el diagnóstico?

a) Síndrome de atrapamiento cubital

- b) Síndrome del tunel del carpo
- c) Atrapamiento del nervio mediano
- d) Síndrome de atrapamiento del nervio radial
- e) Tendinitis

Pauta: es un síndrome de atrapamiento cubital. Las posiciones en las que se mantiene el codo flectado (computador, hablar por teléfono), desencadenan los síntomas al comprimir el nervio. La atrofia muscular y pérdida de fuerzas ocurren en casos de compresión severa y por tiempo prolongado. El paciente consulta por entumecimiento y sensación de hormigueo en la zona del dedo meñique y anular, así como en la zona media del antebrazo.

35. Una paciente de 50 años, consulta por presentar nerviosismo y palpitaciones, desde hace 2 meses, concomitantemente presenta sudoración, intolerancia al calor y aumento de las deposiciones a 3 veces/día, Al examen físico presenta discreta retracción palpebral, temblor digital fino, piel tibbia y húmeda FC: 99/min PA: 125/80 mmHg, bocio difuso palpable de consistencia blanda. No se palpan adenopatías cervicales. El diagnóstico más probable es:

a) Enfermedad de Graves Basedow

- b) Bocio Nodular tóxico
- c) Tiroiditis Linfocítica crónica
- d) Cáncer papilar de tiroides
- e) Tiroiditis sub aguda

Pauta: La enfermedad de Graves-Basedow (EGB) es la forma más frecuente de hipertiroidismo autoinmune

36. Un paciente de 60 años quien recibe tratamiento por ITU, es traído a la emergencia por familiares por presentar, diarrea, fiebre alta, agitación y palpitaciones. Al examen físico luce en malas condiciones generales, presenta temperatura de 40 grados celcius, pulso 124 l/min, delirio, la tiroides esta aumentada de volumen, blanda, sin adenopatías cervicales. Los exámenes señalan Glicemia 122, Hipocalcemia, TSH 0,01 T4L: 7 T3L: 6, en el EKG se confirma una taquicardia supraventricular. Que diagnóstico es mas probable?

a) Tormenta tiroidea

- b) Tiroiditis subaguda
- c) Sepsis
- d) Bocio multinodular toxico
- e) Tiroiditis sub aguda

Pauta: Es frecuente la existencia de factores desencadenantes de una tormenta tiroidea, como infecciones, cirugía, traumatismos o fármacos, aunque hasta en un 40-50 % de los casos no se detecta ninguno.

La autoridad que realiza registro de medicamentos y farmacovigilancia en Chile, se denomina:

- A) Instituto de salud pública
- b) Secretaría Regional Ministerial
- c) Superintendencia de Salud

d) FONASA

e) Asociación Chilena de Seguridad o la Mutual de Seguridad

Pauta: El Instituto de Salud Pública realiza labores en diversas áreas de la salud, como evaluación de calidad de laboratorios, vigilancia de enfermedades, control y fiscalización de medicamentos, cosméticos y dispositivos de uso médico, salud ambiental, salud ocupacional, producción y control de calidad de vacunas, entre otros.

37. Paciente de 29 años quien se encontraba haciendo deporte (futbol Am.) y sufre un golpe fuerte en el muslo, por lo cual es llevado a la emergencia donde se diagnostica un desgarro muscular indicándose tratamiento ambulatorio. A las 3 horas regresa por abrupto aumento de volumen en la cara anterior del muslo, parestesias, aumento del dolor y sensación de presión. Cual es el diagnostico mas probable?

- a) Síndrome compartimental
- b) Evolución normal post traumática
- c) Absceso
- d) Trombosis venosa
- e) Desgarro tendinoso

Los signos cardinales del Síndrome Compartimental de la extremidad incluyen las llamadas seis "P" de la isquemia: dolor (pain), parestesia, poikilothermia, palidez, parálisis y ausencia o pérdida del pulso.

38. Un paciente consulta por presentar dolor de fuerte intensidad en el pene, posterior a contacto sexual, cuando presenta estrangulamiento del glande el cual presenta edema y color violáceo, ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar reducción manual
- b) Realizar circuncisión
- c) Hielo local
- d) Analgesia intravenosa
- e) Realizar incisión en la zona dorsal del prepucio

Pauta: Parafimosis, considerada una urgencia médica, es cuando el prepucio se retrae bruscamente y no puede volver a su condición normal. Esto provoca el estrangulamiento del pene. se trata con reducción manual, si falla, se realiza la incisión dorsal en el prepucio, como cirugía de urgencia. La circuncisión se realiza posteriormente.

39. ¿En qué lugar de Chile se producen casos de dengue?

- a) En la Isla de Juan Fernández
- b) **En la Isla de Pascua**
- c) En la zona austral
- d) En la zona norte
- e) En la Antártida

Pauta: Solo en Isla de Pascua habita el mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir el dengue. Además transmite el virus Sika, el Chugueara y la fiebre amarilla (de estos dos último no hay registros en Chile).

40. Una paciente de 48 años, quien fue tratada hace 3 años por ca gástrico mediante gastrectomía, consulta por parestesias y dolor en los miembros inferiores, astenia y palidez. Al examen físico presenta palidez de piel y mucosas, hipoestesia de las miembros inferiores. Los exámenes de laboratorio arrojan los siguientes resultados: hemoglobina: 9 g/dl, hematocrito: 29%, VCM: 115fl, plaquetas: 95.000 por mm³, blancos: 3.000 por mm³, y LDH: 600 UI/L. ¿Cuál es el diagnostico correcto?

- a) Anemia megaloblastica
- b) Deficit de Folatos

- c) Leucemia
Aplasia medular
Trombocitopenia

Pauta: Los pacientes con gastrectomía acaban sufriendo invariablemente malabsorción de la vitamina B12. Además los pacientes pueden presentar malabsorción de hierro y ferropenia, tanto por pérdidas hemáticas como por falta de ácido clorhídrico que facilita su absorción. La anemia post gastrectomía suele deberse a la deficiencia tanto de hierro como de vitamina B12.

41. Un paciente asmático, quien se ha aplicado salbutamol inhalado cada 4 horas consulta por disnea. Al examen físico presenta taquipnea, con FR: 32x', satura: 87% con FiO2 ambiental, usa músculos accesorios y se auscultan sibilancias intensas bilaterales, espiratorias, con espiración prolongada y aumento del diámetro torácico. Además de administrar oxígeno, la conducta inicial más adecuada es:

- a) Salbutamol inhalado
- c) Ipratropio inhalado
- d) Prednisona VO
- d) Dexametasona VIV
- e) Adrenalina VIM

En este caso estamos en presencia de una crisis asmática que no respondió a salbutamol inhalado.

Se tratan de la siguiente manera: oxígeno para saturar más de 93%, salbutamol inhalado y corticoides sistémicos (vo, im o ev. El ipatropio es una buena opción, si no responde al salbutamol o si se tratara de un paciente con cardiopatía.

42. Un recién nacido de 22 días, presenta vómitos frecuentes, que han ido aumentando. Al examen físico presenta un cuadro de deshidratación de moderada a severa. En sus exámenes de laboratorio presenta valores elevados de K+: 6,3 mEq/L y bajos de Na+: 130 mEq/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Atresia duodenal
- b) Estenosis del píloro
- c) Atresia esofágica
- d) Hiperplasia suprarrenal congénita**
- e) Estenosis pilórica

Los electrolitos orientan al diagnóstico de una hiperplasia suprarrenal congénita (hiperkalemia e hiponatremia). Si fuera una estenosis pilórica hipertrofica, presentaría hipokalemia y alcalosis metabólica.

43. Paciente masculino de 69 años, con hábitos tabáquicos y alcohólicos importantes, presenta desde hace 6 meses, sensación de llenura post comidas, vómitos explosivos luego de comer, que se han vuelto más frecuentes, con disminución de peso de aproximadamente 14 kg. El diagnóstico más probable es:

- a) Divertículo esofágico
- b) Cáncer de esófago
- c) Cáncer gástrico**
- d) Acalasia esofágica
- e) Úlcera gástrica

Pauta: El cáncer gástrico es una enfermedad que afecta con mayor frecuencia a los pacientes de edad avanzada y se diagnostica en promedio a los 60 años. Los hábitos tabáquicos y alcohólicos aumentan riesgo de contraer cáncer de estómago.

44. Un paciente de 45 años, consulta por dolor en flanco y fosa iliaca izquierda, nauseas y fiebre de 1 día de evolucion. Al examen físico presenta Temp: 38°C, FC: 102x', PA: 125/80 mmHg IMC en 32, sensibilidad a la palpación en la parte inferior izquierda del abdomen, con marcada resistencia muscular en la fosa iliaca izquierda y disminución de los ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

a) Diverticulitis aguda

- b) Tumor de colon
- c) Apendicitis aguda
- d) Diverticulosis
- e) Colitis ulcerosa

Pauta: La diverticulitis se presenta con mayor frecuencia en pacientes de 40 a 50 años. Los síntomas suelen consistir en dolor y/o hipersensibilidad a la palpación (generalmente en la parte inferior izquierda del abdomen), fiebre, y en ocasiones, náuseas y vómitos.

45. Un paciente de 35 años, presenta un nódulo tiroideo, de consistencia elástica, superficie lisa, sin adenopatías cervicales palpables. Los exámenes arrojan los siguientes resultados: TSH: 0,1 UI/L (VN: 0,3 a 5,0 UI/L), con T4L en 8 UI/L. Se solicita ecotomografía cervical, que muestra un nódulo tiroideo anecoico, quístico, bordes regulares, sin microcalcificaciones, de 2,9 cm de diámetro. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Realizar cintigrafía tiroidea

- b) Realizar biopsia por punción con aguja fina (PAAF)
- c) Observacion y reevaluacion en 1 año
- d) Solicitar niveles de tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina
- e) Realizar Tiroidectomia

Pauta: cuadro de hipertiroidismo (TSH suprimida con T4L elevada) en el contexto de un paciente con bocio nodular, el cual es un quiste por sus características ecograficas (anecoico), primero se estudia el hipertiroidismo se compensa y luego se decide o no biopsia la cual en este caso no tiene indicación por tratarse de un quiste.

46. Se trata de paciente de 68 años que sufrió atragantamiento por bolo alimenticio, lo cual fue resuelto mediante la maniobra de Heimlich aplicada por personal entrenado, posteriormente presenta enfisema subcutáneo supraclavicular, dolor en el cuello, dolor en el torax y ronquera. Que examen esta indicado?

a) Rx de tórax PA y LAT

- b) Tomografia de tórax
- c) Biopsia
- d) RM de tórax
- e) TAC abdomino pelvica

Pauta: La maniobra de Heimlich aumenta la presión intraalveolar, se han descrito complicaciones como fracturas costales, perforación de yeyuno, estómago, esófago, rotura de válvula aórtica, trombosis aguda de aneurisma aórtico abdominal, neumomediastino, herniación diafragmática y disfagia, la hemoptisis es muy rara.

En este caso hay un neumomediastino. La RxTx AP y LAT son primordiales, con una sensibilidad cercana al 100 %, confirman el diagnóstico de NMD y excluyen neumotórax.

El tratamiento del NMD es conservador y sintomático, ya que es una condición benigna y autolimitada, que evoluciona hacia la resolución espontánea en 3 a 15 días sin dejar secuelas.

47. Una paciente femenina de 59 años de edad, con antecedente de Hipotiroidismo, bajo tratamiento y control regular, consulta por presentar desde hace 2 años, dispepsias y malestar abdominal. En los últimos meses se asocia astenia y parestesias en miembros inferiores. Los exámenes muestran: hematocrito: 27%, Hb: 8 g/dl, VCM: 071 fl, HCM: 28, plaquetas: 90.000 x mm3, Globulos blancos: 3.800 x mm3. el diagnostico mas probable es:

- a) Gastropatía Erosiva
- b) Reflujo gastroesofágico
- c) Esofagitis
- d) **Gastritis autoinmune**
- e) Úlcera duodenal

Pauta: Un porcentaje importante de pacientes con gastritis crónica atrófica corporal autoinmune o tipo A, desarrollan enfermedad autoinmune tiroidea (enfermedad de Graves o de Hashimoto) y viceversa, situación conocida como síndrome autoinmune tirogástrico (SAT). También se asocia a enfermedad celíaca y DM 1. El paciente presenta síntomas por anemia megaloblástica. Puede haber anemia ferropriva.

La GAI no tiene una presentación única sino un amplio espectro de manifestaciones digestivas, hematológicas y neurológicas. En el caso se describe una anemia megaloblástica en el contexto de un paciente con tiroiditis crónica y gastritis autoinmune la cual produce aclorhidria.

48. Un hombre de 48 años, consulta por dolor en la parte baja de la espalda, el cual se expande a través de cara anterior del muslo e interna de la pierna, acompañado de parestesias que se irradian hasta el primer dedo de pie derecho, obligando a sentarse con lo que mejora. El diagnóstico más probable es:

- a) Hernia del disco
- b) Estenosis del canal
- c) Lumbago mecánico
- d) Espondilolistesis
- e) Radiculitis

Pauta: La radiculopatía lumbar o dolor radicular se produce por la compresión o inflamación del nervio espinal de la parte baja de la espalda. Cuando el dolor irradia en forma descendente desde la parte posterior de la pelvis y la parte posterior del muslo hasta el pie o la pantorrilla, se suele describir como pinzamiento o ciática.

48. Paciente de 30 años con embarazo de 39 semanas, controlado, quien presentó endometritis en su parto anterior hace 2 años, feto de 3.900 grs, asiste a control, al examen físico sin hallazgos de importancia. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- a) **Controlar en 7 días**
- b) Cesarea de emergencia
- c) Indicar cesarea en una semana
- d) Inducir parto
- e) Indicar cesarea a las 41 semanas.

Pauta: las indicaciones de cesarea por causa fetal son las siguientes:

- *Presentación de tronco. .*
- *Presentación podálica.*
- *Sufrimiento fetal agudo con condiciones obstétricas desfavorables para parto vaginal (dilatación cervical incompleta, insuficiente grado de encajamiento de la presentación).*
- *Macrosomía fetal: aquel feto con peso estimado mayor de 4.500 gramos. El caso no tiene indicación de cesarea por causa materna ni fetal.*

La macrosomía fetal se define arbitrariamente como un peso de nacimiento mayor o igual a 4.000 gramos, independiente de la edad gestacional, y se relaciona con complicaciones maternas y fetales.

49. Paciente de 32 años, con 1 año de amenorrea, consulta por dolor en hipogastrio, al examen físico se evidencia útero grávido y modificaciones cervicales, ¿cuál examen inicial indicaría para proseguir el estudio?

- a) **Eco TV**
- b) A
- c) A
- d) A
- e) a

Pauta:

50. Embarazada de 8 semanas consulta por dolor hipogástrico de inicio brusco y de fuerte intensidad acompañado de metrorragia escasa, se realizó ecografía obstétrica donde no se observa saco gestacional, líquido abundante libre en cavidad pélvica, al examen físico presenta sudoración, FC: 112x/min y PA 100/60. ¿Cuál sería la conducta más apropiada?

- a) **Laparotomía exploradora**
- b) Laparoscopia
- c) Observación
- d) Medir B-HCG en 2 días
- e) Repetir ecografía obstétrica en 1 semana

Pauta: la clínica es de un embarazo ectópico roto

51. Un hombre de 67 años, con antecedente de tabaquismo, hipertenso controlado, consulta por síncope con recuperación espontánea y dolor de comienzo súbito, desde hace 1 hora, intensidad 10/10, que describe desgarrador, referido hacia la región precordial, transfixiante. Al examen físico presenta TA 150/100 FC: 98x/min. Saturación 96%. Luce inquieto, sudoroso. Se le realiza EKG que muestra Hipertrofia Ventricular Izquierda. ¿Qué estudio debe indicarse?

- a) **TAC torax**
- b) EKG
- c) Ecocardiograma
- d) Troponinas
- e) EKG seriado

52. Paciente femenina de 30 años, quien consulta por tumoración vulvar localizada labio derecho con dolor que aumenta al caminar o al estar sentada, la cual se acompaña de aumento de la temperatura local, y dispareunia, hace 8 meses presentó un episodio de menor intensidad y fue tratada con antibióticos, analgésicos y reposo relativo. ¿Cuál es el procedimiento definitivo más adecuado para tratar el cuadro?

- a) **Drenaje y marsupialización**
- b) Antibioticoterapia intravenosa
- c) Analgésicos comunes
- d) Drenaje
- e) Antiinflamatorios intravenosos

53. Paciente masculino de 91 años, con antecedente de osteosarcoma, consulta por disnea, en RXTX de la foto se observa derrame pleural masivo izquierdo, ¿cuál sería la conducta más apropiada?

- a) Videotoroscopia
- b) Toracocentesis
- c) Estudio del derrame pleural
- d) Cuidados Paliativos
- e) Pleurodesis



54. Se trata de paciente de 17 años, traído por los padres quienes están preocupados porque desde hace 2 meses presenta aislamiento, desinterés y dice que escucha voces. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

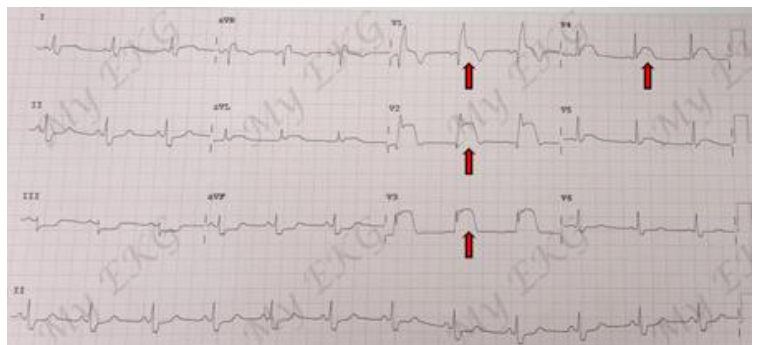
- a) **Esquizofrenia**
- b) Trastorno de personalidad antisocial
- c) Trastorno bipolar
- d) Depresión
- e) Trastorno de personalidad límite

55. Un niño de 7 años presenta mal comportamiento en su casa. Las profesoras de su colegio dicen que no obedece, si se le contradice se molesta en ocasiones no obedece las órdenes en el salón. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de conducta
- b) Déficit de Atención e Hiperactividad
- c) Trastorno generalizado del desarrollo
- d) **Trastorno oposicionista desafiante**
- e) Trastorno del espectro autista

56. Se trata de paciente masculino de 70 años quien presentó parada cardíaca siendo sometido a maniobra de resucitación por personal entrenado, es traído a la emergencia realizándose EKG de la foto. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- a) Amiodarona
- b) Adrenalina
- c) Noradrenalina
- d) Cateterismo cardíaco
- e) Angioplastia



57. Se trata de paciente que fue evaluado con estudio endoscópico diagnosticándose úlcera duodenal sin relación con AINES, el cual presenta epigastralgia dolor urente que disminuye con la comida, tiene test de ureasa negativo, ¿cuál es la conducta a seguir?

- a) Indicar Omeprazol durante 4 a 8 semanas
- b) Indicar triple terapia
- c) Observar evolución
- d) **Erradicar Helicobacter Pylori**
- e) Solicitar test de ureasa

58. Se trata de paciente diabético tipo 2 de 58 años bajo tratamiento con Metformina a dosis máxima, tiene HbA1C en 8% y los promedios de glucemia por hemoglucotest son de 16, ¿cuál sería la conducta a seguir?

- a) Iniciar sulfonilurea
- b) Iniciar Inhibidor de DPP4
- c) Indicar ISGLP2
- d) Aumentar dosis de Metformina

e) Indicar cumplimiento estricto de la dieta

59. Se trata de paciente masculino de 57 años, quien consulta por presentar desde hace 9 meses dificultad para orinar, a lo cual se agrega desde hace 7 días, fiebre, compromiso del estado general, disuria dolorosa y de esfuerzo. Al examen físico presenta Temp 38,2 grados Celsius, puño percusión de fosas lumbares negativa, el tacto rectal es muy doloroso. Presenta valores de PSA en 14. Cual es el tratamiento indicado:

- a) Ampicilina via oral
- b) Hospitalizar, hidratar
- c) Ciprofloxacina**
- d) Colocar sonda vesical
- e) Ceftriaxona intravenosa

60. Niña de 7 años, llevada a la emergencia con politraumatismos por accidente, esta hipotensa fría sudorosa llenado capilar lento TA 70/40 Frec cardiaca 140x/min somnolienta, los padres refieren que por razones de religión se oponen a la transfusión sanguínea. Cual es la conducta a seguir?

- a) Transfundir y simultáneamente solicitar una medida de protección**
- b) No transfundir
- c) Presentar el caso al comité de ética del hospital
- d) Dejar en observación
- e) Denunciar el caso

61. Se trata de paciente masculino de 20 años de edad, quien presentó dificultades de aprendizaje en la secundaria, en la primaria hablaba demasiado según referían las profesoras, actualmente presenta dificultades en la universidad por impulsividad, ya que actúa sin pensar. Cual es el diagnóstico?

- a) Déficit de Atención**
- b) Oposicionismo Desafiante
- c) Ansiedad
- d) Síndrome de Asperger
- e) Trastorno de conducta